

中医肿瘤治疗学

邵梦扬 宋光瑞 主编

天津科技翻译出版公司

中医肿瘤治疗学

邵梦扬 宋光瑞 主编

天津科技翻译出版公司

中医肿瘤治疗学

邵梦扬 宋光瑞 主编

天津科技翻译出版公司

津新登字: 90 (010) 号

责任编辑: 姜凤星

中医肿瘤治疗学

邵梦扬 宋光瑞 主编

特约编辑 关景明

* * *

天津科技翻译出版公司出版

(邮政编码 300192)

新华书店天津发行所发行

郑州市中州印刷厂印刷

* * *

开本: 850×1168 1/32 印张: 18.5 字数: 490 千字

1994 年 9 月第 1 版 1994 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1-3000 册

ISBN7-5433-0733-2

R·215 定价: 15.00 元

内容摘要

本书共分三篇。第一篇总论，全面整体，概括地介绍了中医肿瘤治疗发展史，中医对肿瘤的病因、病机、辨证、治疗、预防的认识，以及详细论述了中医治疗肿瘤的主要法则，常用抗癌中草药。第二篇各论，对 27 种常见癌症的发病、死亡、病因病机、治疗方法等作了全面论述。第三篇附录，主要是刊列一些临床常用的资料和表格。

前 言

恶性肿瘤是一类常见病，多发病。它严重地威胁着人类的健康和生命。全世界每年约有 900 万人发生癌症，700 万人死于癌症，现症病人 1500 万，给家庭和社会带来了沉重的灾难和无法估测的人力、物力和财力的巨大损失。引起世界科学家的广泛关注和国际医学界的高度重视。

癌症研究进展迅速，特别是近二十多年来取得了令人鼓舞的可喜成就，无论在肿瘤病因学、流行病学、生物学、生物分子学、基因工程学、免疫学、细胞学、药理学、诊断学以及综合治疗技术等方面的研究，日新月异，成绩斐然。临床研究表明，目前任何单一手段的治疗均难以彻底治愈癌症。必须采用综合性治疗。中医药治疗作为一种全身性治疗在综合性治疗中的地位，愈来愈显得重要。中国医药学是一座伟大的宝库，它是几千年来劳动人民同疾病作斗争的经验总结，内容丰富多彩，为繁衍中华民族作出了卓越的贡献。当今，世界出现的中医中药热，进一步证明了它的科学性、实用性、先进性，必将在攻克癌症的征途中发挥巨大的作用。

本书概括介绍了肿瘤的病因学、流行病学、病理学、诊断学和治疗学等。详细地论述了中医肿瘤治疗学发展概况，祖国医学对肿瘤病因、病机、辨证、治疗和预防以及辨证论治的法则，古方、验方、单方与现代复方的研究。特别是对常见癌症和抗癌中草药的研究系统地进行了论述。供广大医务人员参考使用，特别是对肿瘤医师尤为适用。由于时间仓促，不妥之处敬请同道批评指正。

编 者

1993 年 5 月

《中医肿瘤治疗学》

编委会名单

主 编:	邵梦扬	宋光瑞		
副主编:	郑玉玲	周宜强	马建中	邵 静
	王 黎	王守章	郭文灿	宋太平
	穆广梅			
编 委:	王孝福	宋增伟	严中平	王树谦
	焦智民	刘素兰	党可军	高加亮
	郑富增	李 康	周浩本	袁希福
	李鑫玉	杜晓玲	杨蔚萱	李永红
	姚亚民	程新超	巩跃生	李天顺
	安书卷	张秀兰	马庆华	宋淑娥
	魏淑娥	高俊梅		

目 录

第一篇 总论	(1)
第一章 中医肿瘤治疗学发展概况	(1)
第二章 祖国医学对恶性肿瘤的认识	(6)
第一节 肿瘤发病因素	(6)
一、外邪因素	(6)
二、饮食因素	(7)
三、精神因素	(8)
四、脏腑功能失调或虚亏	(9)
第二节 肿瘤发病病理	(11)
一、气滞血瘀	(11)
二、痰湿结聚	(11)
三、毒热蕴结	(12)
四、脏腑失调, 气血亏虚	(12)
第三节 肿瘤的中医辨证	(13)
一、四诊合参, 辨别肿瘤	(13)
二、辨证与辨病相结合	(15)
三、辨局部与整体, 握标本缓急	(16)
第四节 肿瘤的中医治疗	(16)
一、辨证施治	(16)
(一) 气滞	(17)
(二) 血瘀	(17)

(三) 痰饮凝聚	(18)
(四) 热毒	(19)
(五) 正虚	(20)
二、辨证论治与单、偏、验方治疗相结合	(20)
三、中医治疗肿瘤的特色	(21)
第五节 肿瘤的预防	(24)
第三章 中医肿瘤治疗常用法则	(30)
第一节 扶正培本	(30)
第二节 清热解毒	(33)
第三节 活血化瘀	(35)
第四节 软坚散结	(38)
第五节 化痰利湿	(39)
第六节 以毒攻毒	(40)
第七节 其它疗法	(43)
第四章 抗肿瘤中药研究	(46)
第一节 抗肿瘤中草药	(46)
一、扶正固本药	(46)
二、清热解毒药	(61)
三、活血化瘀药	(80)
四、软坚散结药	(89)
五、消肿止痛药	(96)
六、利湿逐水药	(111)
七、其它抗肿瘤药	(116)
第二节 抗肿瘤中成药及复方中药	(122)

第五章 现代医学抗肿瘤研究概况	(143)
第一节 病因与流行病学	(143)
第二节 病理学	(147)
第三节 诊断学	(147)
第四节 治疗学	(149)
第五节 护理与康复	(151)
第六节 预防	(151)
第二篇 各论	(153)
第一章 脑瘤	(153)
第二章 鼻咽癌	(166)
第三章 舌癌	(177)
第四章 涎腺肿瘤	(185)
第五章 喉癌	(192)
第六章 甲状腺癌	(201)
第七章 食管癌	(212)
第八章 肺癌	(228)
第九章 胃癌	(243)
第十章 原发性肝癌	(262)
第十一章 胆囊癌	(276)
第十二章 胰腺癌	(285)
第十三章 大肠癌	(292)
第十四章 肾癌	(307)
第十五章 膀胱癌	(313)
第十六章 阴茎癌	(319)

第十七章	睾丸肿瘤	(326)
第十八章	前列腺癌	(335)
第十九章	乳腺癌	(345)
第二十章	子宫颈癌	(356)
第二十一章	子宫体癌	(365)
第二十二章	卵巢癌	(373)
第二十三章	恶性黑色素瘤	(380)
第二十四章	恶性淋巴瘤	(390)
第二十五章	白血病	(406)
第二十六章	多发性骨髓瘤	(414)
第二十七章	骨肿瘤	(423)
第二十八章	肿瘤常见症状的治疗	(443)
第一节	癌痛的治疗	(443)
第二节	癌性发热	(456)
第三节	癌性胸水	(463)
第四节	癌性腹水	(470)
第三篇	附录	(476)
一、	常用抗癌中草药简表	(476)
二、	常用抗恶性肿瘤化学药物简表	(506)
三、	实体瘤的疗效标准	(566)
四、	中草药治疗恶性肿瘤的疗效判断标准	(567)
五、	行为状态评定标准	(568)

第一篇 总论

第一章 中医肿瘤治疗学发展概况

我们伟大的祖国地大物博，历史悠久，是世界文明古国之一。它有着光辉灿烂的科学文化遗产。如从月球上看到的地球上唯一的人工建筑物——宏伟的万里长城；被称为世界上第七大奇迹的秦始皇兵马俑和对人类文明发展起着极大推动作用的四大发明……这些成就无不凝聚着我们祖先的聪明才智，英国著名哲学家、数学家怀德海曾赞叹过：“若使我们把历史时代所有人物的贡献累积起来算一笔总账，则中国的文化要算是最宏大的。”在这浩瀚宏伟的文化长城中，中国医药文化便是其中的一座伟大的宝库。它使千万个史学家们为之赞叹。从古至今，众多医家在大量的文献和临床实践记述积累了大量对肿瘤的理论认识 and 治疗方法，方药。取得了辉煌的成就。世界上一些肿瘤专家预言，攻克肿瘤的希望在中国，因为中国有其独特的优秀的中医学。为了进一步宏扬祖国医学，寻找抗癌之光，我们将从三个方面对中医肿瘤治疗学作出回顾和总结。

一、春秋时期

早在殷周时期，古人对肿瘤就有所发现，殷墟甲骨文上已记载有“瘤”的病名，两千多年前的《周礼》一书中已载有专治肿瘤一类疾病的医生，当时称为“疡医”，负责治疗“肿疡”。说明公元前十一世纪对肿瘤已有了认识，至今在日本和南朝鲜仍将肿瘤称为“肿疡”。

我国成书最早的《内经》就有瘤的记载，《灵枢·刺节真邪篇第七十五》提到肿瘤的病因是由于“邪气居其间。”在不同的部位发为不同的肿瘤，如筋瘤、肠瘤、骨瘤、肉瘤等。《内经·邪

气脏腑病形篇》提到“膈中”及“下膈”之病名，云：“脾脉微急，为膈中，食物入而还出，后沃沫。”说的是饮食进入后又吐出，还吐涎沫，这很象食管癌的症状，又说：“下膈者，食卒时乃出。”这种食物进入经过一定时间后再吐出的症状，与幽门梗阻及晚期胃窦癌相类似。《灵枢》中记述了：“石瘕生于胞中，寒气客于子门，子门闭塞，气不得通，恶血当泻不泻，瘀血留止，日以益大，状如怀子，月事不以时下，皆生于女子。”说明石瘕是子宫内硬块，逐渐长大，形如妊娠，月经不正常，这与子宫肌瘤基本相似。春秋战国以前有关肿瘤方面的认识内容比较丰富，在此不能一一赘述。

二、金元前后时期

中医学的发展大致经历了二个高峰时期，第一个高峰时期是春秋时期，第二个高峰时期是金元前后。如后汉的医圣张仲景，唐代的孙思邈和金元四大家的出现，对中医学的发展起到了不可估量的作用。这个时期众多圣贤对肿瘤学的发展无论是在理论上还是在实践上都有较大的突破。仲景明确提出翻胃、症瘕的病名和病因病机，唐代大医家孙思邈在《千金要方》中描述了典型的宫颈癌症状。宋人窦汉卿《疮疡经验全书》对乳癌描述说：“捻之内如山岩，故名之，早治得生，迟则内溃烂肉见五脏而死。”四大代表医家之一的朱丹溪还明确把噎与膈区别开来。他说：“其槁在上，近咽之下，水饮可行，食物难入，名之曰噎。其槁在下，与胃为近，食虽可入，食从复出，名之曰膈。”（《丹溪心法》）噎者与食管癌的噎食症状相似，而膈症与贲门癌引起的病情相符。

公元1174年宋代陈无择著《三因方》中将瘕瘤分为五瘕六瘤，五瘕是：“坚硬不可移者名曰石瘕，皮色不变者名曰肉瘕，筋脉露结者名曰筋瘕，赤脉交结者名曰血瘕，随忧愁消长者名曰气瘕。”这除包括地方性甲状腺及甲状腺机能亢进症外，还包括甲状腺的良性或恶性肿瘤，其中“坚硬不可移”之石瘕可能是甲状腺癌；六瘤即骨瘤、脂瘤、气瘤、肉瘤、脓瘤、血瘤。并指出五瘕

六瘤都不可随便弄破，按之推移者，可用取法取之。如推之不动者，不可取也。瘤无大小，不识可否而乱取之，必妨人命。”说明古时已比较明确地说到对“推之不动者”，即有固定、有周围浸润粘连等特点的恶性肿瘤不要随便割取，否则易成恶果。当然医学发展到今天，一些恶性肿瘤虽已有局部浸润、固定、能够手术切除者，仍要积极手术切除，这也说明随着医学科学的进步，过去不能医治的肿瘤，今日已能治疗，过去不能手术的，今天也能切除根治了。

三、明清时期

明清以来，随着祖国医药学对癌证认识的日趋深入，对肿瘤的病因病机、辨证治疗等均有更多的论述，分类更细，名称亦更复杂，内容十分丰富。如在肿瘤的病因病机方面，明代大医家张景岳说：“脾肾不足及虚弱，失调的人，多有积聚。”又说：“凡治噎膈大法，当以脾肾为主，治脾者宜从温养，治肾者宜从滋润。”强调脾肾功能失调易引起肿瘤。清代王清任著名的《医林改错》中就指出：“肚腹结块，必有形之血，”说明腹内有形的包块肿疡，多由血瘀所致，故活血化瘀法是治疗癌瘤的主要治则之一。在《医宗金鉴》中还有一病名石疽，所谓石疽即“痈疽肿硬如石，久不作脓者是也。”“生于颈项两旁，形如桃李，皮色如常，坚硬如石，此症初小渐大，难消难溃，皮顽之症也”，极像是颈部的淋巴结转移癌或恶性淋巴瘤。由于历史条件所限，不能象现代肿瘤学及肿瘤病理学那样分类确切清楚，了解全面，有时把良性肿瘤与恶性肿瘤、肿瘤与非肿瘤性疾病混杂一起。但是在数百年前，甚至上溯到一、二十个世纪，祖国医学文献有如此丰富而详细的有关肿瘤病因，发病学、病理学、生理学、证候学及治疗学的记载是难能可贵的，在人类医学史上占有光辉的一页。

近些年来，防治肿瘤已成为全世界医学领域中的重要研究课题和迫切任务。国内外在肿瘤防治研究工作中已取得不少进展，但在许多重要问题上，特别是对中、晚期癌症患者提高治疗效果

方面，还期待着进一步的突破。当前，在癌症治疗中，我国正走着独特的自己拥有的中西医结合治疗的路子，既发挥现代肿瘤治疗学的作用，同时，又运用中医中药的特点，发挥两个优势，使近期与远期治疗效果都有了提高，显示了可喜的开端和巨大的优越性。有关中医治疗肿瘤方面大体归纳为以下几个方面：

一是内治与外治相结合。中医认为恶性肿瘤是全身性的疾病，应立足于以全身治疗，重在以扶正祛邪为基本原则。扶正可以祛邪，祛邪可以帮助扶正。提高或调整人体的免疫功能（包括特异性或非特异性免疫功能），扶植和增强免疫防御系统，以抵抗病邪的侵袭。近年来，在寻找抗癌中草药材时，很重视这类免疫促进剂的研究。但其作用并不在于直接杀灭瘤细胞，而是具有宿主中介性。诸如此类的内治扶正药物还相当多。另外，一些肿瘤生长在体表肌肤或者与外界相通的部位，如子宫颈、阴道、直肠肛门、舌齿龈、口腔等部位的癌肿，都可直接应用外治法，即在局部病灶部位予以各种外治以消除肿物。实践证明，恶性肿瘤的中医治疗中，凡能内治与外治结合进行者，疗效均较好，如中医治疗宫颈癌，则以局部外用药为主（如制癌粉等），配合内服汤药取得一定的疗效。中医在外治法方面有着丰富的经验，目前中医药抗肿瘤方面外治法仍显得十分重要。采用内治和外治相结合的原则效果更好。

二是突出中医辨证。中西医结合疗法治疗肿瘤形成了独特的风格，取得了显著的效果。中医药治疗肿瘤与西医药治疗肿瘤的方法密切结合，充分发挥中西医治疗方法和手段的各自长处，取长补短。中医扶正抗癌药物消除肿瘤包块的作用偏小，存在着针对性差的缺点，而利用现代医学中手术切除，放射线治疗和有效化学药物治疗手段，能消除癌症病灶，控制肿瘤的发展，甚至取得了根治性效果。但这些有效手段在杀伤癌细胞的同时，也损伤增生活跃的器官和组织，产生一系列毒副反应。这时根据中医辨证治疗，就能减轻毒副反应，增强治疗效果。所以把中西医攻补

手段有效地结合起来，就有更好的疗效。值得提出的是中西医结合抗癌并不是简单的拼凑，更不能各自取代，而必须是中西医互相渗透，融汇贯通，扬长避短，突出特色，只有这样才能有希望征服癌症。

第二章 祖国医学对恶性肿瘤的认识

第一节 肿瘤发病因素

中医认为，人体各脏腑组织之间，以及人体与外界环境之间，既对立又统一，它们在不断地产生矛盾而又解决矛盾的过程中，维持着相对的动态平衡，从而保持着人体正常的生理活动。当这种动态平衡因某种原因而遭到破坏，又不能立即自行调节得以恢复时，人体就会发生疾病。破坏人体相对平衡状态而引起疾病的原因就是病因。

导致疾病发生的原因，是多种多样的，诸如气候的异常，疫疠的传染，精神刺激，饮食劳倦，持重努伤，跌仆金刃外伤，以及虫兽所伤等等，均可导致疾病的发生。此外，在疾病过程中，原因和结果是相互作用着的，在某一病理阶段中是结果的东西，在另一阶段中则可能成为原因，如痰饮和瘀血等，既是脏腑气血功能失调所形成的病理产物，反过来又能成为某些病变的致病因素。

祖国医学对肿瘤的病因认识不但强调外因而且更重视内因，特别是精神因素，饮食嗜好因素，先天不足及脏腑功能失调等在发病中的意义。同时从整体观出发，认为肿瘤是外邪、七情所伤、饮食不节、遗传、脏腑功能失调多种病因综合作用的结果。在人体恶性肿瘤的内外两方面发病因素中，祖国医学理论提出的“邪之所凑，其气必虚”的见解，为进一步研究肿瘤的病因指明了方向。

一、外邪因素

中医认为外邪因素，主要是以六淫邪气，即是风、寒、暑、湿、燥、火在正常情况下六淫又称为“六气”，是自然界六种不同

的气候变化。若由于气候变化异常，六气发生太过或不及即称六淫，六淫致病从今天的临床实践看，除了气候因素外，还包括了生物（细菌、病毒）、物理、化学等多种致病因素作用于机体所引起的病理反映在内。综观历代医家所论，癌瘤的发生与外邪侵袭尤关，认为凡人体被外邪所侵，即能积久成病。《灵枢·九针论篇》说：“四时入风之客于经络之中，为瘤病也。”提出了外邪“八风”停留在经络之中而成瘤病”。《灵枢》百病始生篇还说：“积之所生，得寒乃生、厥乃成积也”。隋代巢元方著《诸源候论》提到：“恶核者，内里包有核累累如梅李、小如豆粒……此风邪挟毒所成。”《医宗金鉴》中认为唇癌（茧唇）由“脾胃积火”结聚而成，这些外邪（风、寒、虚邪、热毒、火）都是肿瘤的致病因素，在当时的历史条件下，古代医学家能认识到人体癌瘤的发生与外界的致病因素有关这一点是很可贵的。

二、饮食因素

尽管导致肿瘤发病的某些因素还不太明确，可一些慢性物理性刺激及饮食因素能促使肿瘤的发生已经得到众多医学家的承认。如嗜饮烈酒，偏食辛辣、油炸烟薰之品，进食过快、过热、过粗、过硬之食物易患噎膈之症。《医碥》“酒客多噎膈、好热酒者尤多。”明《外科正宗》还指出：茧唇（唇癌）的产生与过食高热煎炒的肥甘厚味等有关；宋《洛生方》云：“过餐五味，鱼腥乳酪，强食生冷果菜，停蓄胃脘……，久则积结为症瘕。”这些充分说明，恣食肥甘厚味，饮酒过度，加上饮食过热过快等诸多饮食因素均与肿瘤的诱发有关，这与近代的营养与肿瘤发生的观点颇有相似。由于饮食过热可以破坏食管粘膜屏障，过硬、过粗可以损伤食管粘膜，久而久之就可变化为癌。

近些年来不少医家从热量的摄取和肿瘤的关系方面加以研究，从中发现了许多致癌因素，他们发现肥胖的人肿瘤死亡率比瘦弱的人为高，而且还发现男性肥胖者与直肠癌、膀胱癌的发病率相关，女性肥胖者则与乳腺癌发病率相关。高脂肪膳食是诱发

直肠癌的重要因素。

由于饮食因素致癌除了上面谈到的一些原因外，有人发现饮食污染、霉变等因素也是不可忽视的致癌因素，因为这些被污染、霉变的食物中含很强致癌作用的亚硝胺化合物等。所以目前对于食物性化学致癌物质引发肿瘤的研究正在逐步深入，并在动物实验和流行病学调查中得到证实。就以河南太行山区食管高发区的林县来说，近些年来它们调整改变了饮食习惯和饮食结构，食管癌的发病率明显下降。以事实说明饮食因素致癌应当引起人们高度重视。

三、精神因素

喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七种情志活动，在正常情况下，是人体精神活动的外在表现，若外界各种精神刺激程度过重或持续时间过长，造成情志的过度兴奋或抑制时，则可导致人体的阴阳失调，气血不和，经络阻塞，脏腑功能紊乱而发病。情志致病，主要引起五脏气机失调的病证，情志变动首先影响气机。《素问·举痛论》云：“百病生于气也。怒则气上，喜则气缓，悲则气消，恐则气下，寒则气收，炅则气泄，惊则气乱，劳则气耗，思则气结。”说明不同的情志变化，对人体气机活动的影响是不相同的。所致的症候亦不相同。但七情变化在肿瘤病因中占有重要位置。古代医家把一些肿瘤的发生、发展认为与精神因素情志不遂有关，如噎膈（食道梗阻）在《内经》中认为是“暴忧之病”。朱丹溪论乳癌时指出，乳癌是由于“忧悲郁闷，晰夕积累，脾气消阻，肝气横逆”所致，他更提到没有丈夫或矢志于丈夫的女子较多，这些比国外提到寡居者多要早几百年。明代陈实功说：“乳岩由于忧思郁结，所愿不遂，肝脾气逆，以致经络阻塞，结积成核。”李挺在论肉瘤时说：“郁结伤脾，肌肉消薄与外邪相搏，而成肉瘤。”《医宗金鉴》谓失荣证由“忧、思、悲、怒、气郁血逆，与火凝结而成。”这些都认为肿瘤发病与精神因素有关，在七情所伤或其他因素引起脏腑虚亏，正气不足的情况下，致癌

因素成份增加，内外合邪，或正不胜邪，可出现痰凝气滞，瘀毒内结的表现，久之多发肿瘤之疾。

四、脏腑功能失调或虚亏

人体是一个统一的有机整体，它是由脏腑、经络等许多组织器官所构成，各脏腑、组织、器官的功能活动不是孤立的，而是整体活动的一个组成部分，它们不仅在生理功能上存在着相互制约，相互依存和相互为用的关系，而且还以经络为联系通道，在各脏腑组织之间，相互传递着各种信息，在气血津液环周于全身情况下，形成了一个非常协调和统一的整体。所以中医在临床辨证论治过程中，强调从整体出发就是这个道理。人体整体的健康状况和各脏腑功能，在肿瘤发病中有着重要的作用。祖国医学文献中更重视人体整体机能的协调与否，在《诸病源候论》中说：“积聚者，由阴阳不和，脏腑虚弱，受于风邪，搏于脏腑之气所为也。”又云：乳岩（石痈）是由于经乳腺的经络空虚，为风寒之气侵袭，则血液流通较慢，结核如石硬，叫做石痈。明张景岳《景岳全书》说：“脾胃不足及虚弱失调之人，多有积聚之病。”明徐春圃《古今医统》也指出：“气血日亏，相火渐炽，几何不至于膈噎。”以上这些都说明脏腑虚亏，发生功能失调，引起气血发生紊乱，或者先天脏腑虚亏，发生功能失调引起气血发生紊乱，或者先天脏腑禀赋不足，都可以是产生肿瘤的内在因素。人们发现年龄大小与肿瘤发病密切相关，年龄愈大，癌的发病率愈高。明·申斗垣明确指出：“癌发四十岁以上，血亏气衰，厚味过多所生，十有一、二。”（《外科启玄》论癌发）其它古代医家也多指出：“年五十以上”或“五六十岁以后”为高发年龄。明·赵养葵在论噎膈时说：“惟男子高年者有之。”张景岳指出：“少年少见此症，而惟中年丧耗伤者多有之”。说明年龄因素的意义。中医认为，年龄愈大，其“肾气”愈衰弱，肾藏精的功能愈衰退，逐渐出现衰老过程，这时机体脏腑功能活动最易发生失衡状态，防御功能也减弱，机体免疫功能也减退。此时加上致癌因素，故最易发生癌

症。

从现代病因学的观点看，虽然已确定致癌因素有多种，许多肿瘤的病因与外界环境因素有关，但他们对机体致癌的作用方式，最终必须引起机体的本身变化和反应。致病因子长期反复的作用，带来了机体的失调，刺激了易感局部的增生反应，由量变到质变，产生癌症。这一发病过程完全符合辩证唯物主义：“外因是变化的条件，内因是变化的根据，外因通过内因而起作用；决定的因素是内因而不是外因。从临床角度看，许多慢性疾病，癌前病变为局部器官和组织接受外因的作用提供发病条件。癌变过程的最根本的原因还在于患病机体在癌变之前，由于各种原因（如先天性的免疫缺陷、遗传因素，后天性疾病、精神因素，年龄因素、创伤、感染等），引起体内的细胞调节控制系统失调。（这与中医讲的阴阳失调意义相同）。而这种细胞的自动调节控制作用，是维持人体各组织细胞正常的新陈代谢的基本因素，即环境的稳定。如果某些致病因子引起某一组织和某一脏腑的阴阳失衡，也就是体内自制系统失于控制，组织细胞可能也随之而变化，而产生癌症。以外因论为主要的观点不能解释为什么在人群中外界环境条件大致相同，接触的致癌物质的作用也大致相同，但患癌的人必然是少数。另外在一些病例常见二重癌，甚至三重癌，这都说明决定的因素还是由于人的内在防御能力正常，体内存在的免疫监视系统功能也就会正常，那么即使外界存在致癌因子的条件，还是难于致癌发病。这就是中医内虚学说的论点，中医防癌、治癌也正是重视内因学说而取得良好疗效。实践反复证明，中医药在调整人体机能，增强抗癌能力方面的作用是广泛而有效的。显而易见，中医“内虚”学说在肿瘤发病及防治方面相当重要，值得深入加以探讨。

第二节 肿瘤发病病理

祖国医学的核心内容是辨证施治，审证求因，根据发病原因分析推理各种疾病的病理机制。肿瘤的发病机制是多方面的。我们结合临床可大体归纳为以下几个方面。

一、气滞血瘀

气血皆是人体最宝贵的物质，气可以推动人体各种机能活动。血为赤色物质，五脏六腑四肢百骸无不赖以濡养，气和血二者又互相化生，互相依存，关系十分密切。所以有“气为血之帅，血为气之母”之说。在病理上，气病可伤血，血病也可伤气，气行则血行，气滞则血瘀，血之运行要靠气帅之，温之、摄之、推之。气在正常情况下，升降出入，疏畅无阻，循行周身各部。如因某些原因引起气的运行失调，可出现气郁，气滞、气聚，日久成疾。气不行则血不行，这就是通常说的气滞血瘀，血瘀日久而发生肿块。活血化瘀法是治疗各种肿瘤的常用治法，可活血必行气，气行血自通。临床上还要根据偏于气滞、还是偏于血瘀，视其孰轻孰重，正确采用行气活血这一治瘤大法。

二、痰湿结聚

痰湿有广义和狭义之分，广义之痰包括有形和无形之痰，狭义之痰指的是有形之痰咯吐可见。痰湿是脏腑病理变化的产物，可引起多种疾病，因此古人云，百病兼痰，怪症、顽症、奇症多痰。痰饮发病倍受历代医家所重视。

痰饮的产生同源异流，与脾胃关系尤密，盖脾主运化水湿，由于脾虚不运，水湿内聚，结而为痰，痰湿蕴结久而发生肿块，元代朱丹溪首先提出肿瘤的发生与“痰”有关，他说：“凡人身中上下有块者多是痰。”又称：“痰之为物，随气升降，无处不到。”高锦庭也说：“癌瘤者，非阴阳正气所结肿，乃五脏瘀血浊气痰滞而成。”临床上把体表或皮下不痒不痛的，经久不消的肿物，均按

痰施治，多消痰散结，化痰通络法来治疗。现代研究证明，所有化痰散结作用的中药均有抗肿瘤特性，如半夏、山慈姑、瓜蒌、前胡、马兜铃、杏仁等。而祛湿药中具有抗癌作用的则更多，如薏仁、茯苓、泽泻等对呼吸消化系统肿瘤有较好的抑制生长作用。

三、毒热蕴结

热与火毒从某意义上讲是程度上的不同，热极化火，火甚可以生毒。毒热之邪从外而生者少。由内而生者多，毒热结聚多能伤津动血，耗气蕴结。《内经》中有“诸痛疮痒皆属心”的病机。说明热毒之邪是导致疮、痒、痈、疡的主要病机，更是肿瘤的主要病机。因为血遇火热则凝，津液遇火则灼液成痰，气血痰浊壅阻经络脏腑，遂结成肿瘤。中医文献中把许多肿瘤认为是由于感情抑郁，郁而化火，郁火挟血瘀凝结而产生。临床上我们看到癌瘤患者多是热郁火毒之证，如邪热嚣张，呈实热证候，表示肿痛正在发展，属于病进之象。如系病久体虚，瘀毒内陷，病情由阳转阴，成为阴毒之邪，则形成阴疮恶疽，翻花溃烂，经久不愈，皮肉腐黑，流汁清稀。治实热阳证火毒之邪应投大剂清热解毒，滋阴降火之品，而对阴毒之邪则需温补托里，扶正祛邪以调和气血，祛除阴毒之邪。

四、脏腑失调，气血亏虚

脏腑功能失调是恶性肿瘤发病关键，其中以脾肾两脏失调和亏损为主。盖肾为先天之本，脾为后天之本，气血化生之源，脾肾亏虚则气血不足，卫外之气无从以生，引致癌瘤产生。近年来研究结果表明，恶性肿瘤患者大多均有脾虚气亏或肾虚等症，其细胞免疫功能及皮质醇均较正常人为低。通过中药健脾补肾或重点以健脾益气，或重点以补肾固精，均能提高患病机体的细胞免疫功能和调整内分泌失调状态，使“卫气”得以恢复，抗癌能力增强有利于机体的康复，尤其是对晚期恶性肿瘤患者及放化疗后的病人，采用扶正与祛邪相结合，调理脏腑功能，补气养血，调动

和增强机体内在抗癌能力，是当前恶性肿瘤治疗学中发展起来的一种最常用的法则，有着重要意义。

第三节 肿瘤的中医辨证

辨证论治是中医理法方药在临床实际中的运用，它既是指导中医工作的理论原则，又是解决临床诊断治疗等实际问题的具体方法。辨证的过程是认识疾病和治疗疾病的过程。辨证是根据四诊所收集的病情资料，从症状和体征入手，结合体质因素，环境因素，通过分析综合，从而揭示疾病的本质，得出辨证结论，并以此作为治疗的依据。

一、四诊合参，辨别肿瘤

人体肿瘤的临床诊断，基本上和诊断身体其它疾病的方法相类似，即包括病史询问，细心全面的体格检查和常规化验检查与特殊检查（包括必要的生物化学、放射线、内窥镜、细胞学、病理学、同位素、免疫学等项目）的检查。根据中西医结合的观点，把中医望、闻、问、切四诊结合八纲辨证规律的要求，进行检查，然后综合分析，就既能明确诊断肿瘤的部位，临床分期等情况，又能掌握肿瘤患者所反映出来的阴阳、表里、寒热、虚实的辨证类型及气血、脏腑功能失调的状况，做到辨证与辨病相结合，突出中医辨证特点，按照四诊过程。收集辨证依据。在四诊过程中首先是问诊，对肿瘤患者要询问发病经过，治疗情况，自觉症状等，也可按照“十问歌”的内容进行询问，就以肿瘤患者发热而言，是否兼有如突然发热兼有怕风恶寒，用手扪之，手背热甚于手心者是外感所引起，高烧不恶风寒仅而恶热，欲去衣被，午后热甚，是为里实热证，此多由肿瘤患者感染引起，午后发低热，手足心热甚于手背，心中烦热，多由阴虚血亏所引起，病在肺与肝、肾者居多，但也有因湿热之留，内蕴结毒，引起状若阴虚的午后发热。夜间发热，天亮即退的，多为阴亏所致。

临床上大多数肿瘤患者的发热与感染有关，在感染控制之后，发热退净，但有些患者发热原因不明，较常见于恶性淋巴瘤、肝癌、肺癌、骨肉瘤、肠癌及肾癌，或晚期癌瘤患者由于癌瘤坏死分解产物被吸收引起发热，也常是患者一个主诉症状，问诊时必须弄清发热情况，观察不同热型，予以辨证论治。

问口味：口味是口中自觉的味道。口发苦的，多是内里有火有热，口发甜的多为脾胃有湿热，或脾虚水饮上泛所致；口发酸的多是消化不良或肝胃不和；口发淡属气虚，口粘腻感，多有湿浊内蕴。肿瘤患者在放疗化疗中常出现味觉方面的改变，主要有口苦，有的发甜，有口淡无味，不思饮食等，不思饮食是肿瘤患者常见，最早期出现的症状之一。食量逐渐减少，常常是脾胃气虚，顽固性食欲不振是癌症患者病情发展的一个重要标志，如果治疗有效，肿瘤得到控制，食量可增加，但在抗肿瘤治疗期间，化疗药物或放射线都能伤及脾胃功能，使食欲下降，如果给以健脾胃中药则可以提高食欲。

望诊就是通过视觉，去观察患者的精神，色泽、形态和舌苔、皮肤粘膜等变化的一种方法，中医理论认为，人体的内外是紧密相连的，“有诸内，必形于外。”体内发生病变，必然会反映到体表，内经有“望而知之谓之神”之说，例如，目光奕奕，神情爽朗是精神充沛的表现，是谓“有神”。如果目无光彩，神情呆钝或萎靡不振的表现，谓之“失神”。神志淡漠，精神不振，可见于晚期肿瘤病人，有的悲观失望，缺乏信心的忧虑状态，如果病已极晚期，循衣摸床，两手撮空，两目呆视，是神气将绝的先兆。

肿瘤病人还有一些特有的望诊指征，关于这方面报道的资料也比较多，如消化与生殖系统癌患者的下口唇，有时出现紫斑，沿下口唇唇白内侧的紫色斑，大如黄豆，小如绿豆，赤豆，呈不整齐的圆形，数目不等，有时出现在唇粘膜上，排列不整齐，颜色白淡紫或暗紫，随病情发展而加深。有时尚可见舌前半部或舌边出现线条形或若干个不整齐的圆形紫斑，在消化系统，肝癌及

女性生殖系统肿瘤患者较常见。

有的报道，一些消化道肿瘤与女性生殖系统肿瘤患者的手指甲，可出现黑纹或紫纹，黑纹常于拇指甲和中指甲中间或略偏处出现。拇指甲指纹较深，中指甲较淡。其黑纹自指甲根部直接贯指甲尖顶呈直线形，粗细不一，大多见于右手，双者较少见。有时足趾甲亦有同样黑纹。黑纹的形成由淡紫逐渐变黑。拇指、食指两指甲紫纹多见于食管癌、胃癌出现症状的前二三年。食指、无名指甲紫纹见于肝癌，三个指甲均出现紫纹的见于胃癌，这一体征对恶性肿瘤的早期诊断意义尚待进一步验证，其规律性和产生机理也有待进一步探索。

中医对切脉有着丰富的实践经验，切诊是用手直接检查身体各部位和脉象的一种诊断方法。脉诊在肿瘤患者辨证上的意义；癌症属于全身性疾病。它的病理变化必然反映到脉象上来，中医传统脉象有 28 种之多，但肿瘤临床病人常见的还是沉、细、弱、弦、浮、滑、数、涩、促、结（代）脉等。如肿瘤病人患者见到弦滑数或弦数脉时，则常常表示病邪猖獗，病性正在发展恶化的表现。有时在手术后，根治性放疗后的患者，原发病灶已经切除或消失，邪毒已去，理应脉来平和或只显气血亏虚的沉细脉，但这时患者如有滑脉，弦数、细数时，就要高度警惕，是否有余邪未净，此时如果患者有低热，血沉快等现象时，即有肿瘤复发转移之可能，这时肿瘤可能已复发或转移到内脏。

二、辨证与辨病相结合

癌是一类常见病、多发病，西医学认为无论那种癌症都有其一定的生物特性，大致相同的发生，发展规律，有其形态学变化的共同基础及病理生理，生化改变的共同规律，这些都是辨病的基础，我们在辨病的同时一定要结合中医的证来进一步分清该病属于那一个证型，这个证型随时有可能变化，只有做到这些才能更好地辨证施治，以取得更好的疗效。如肺部鳞状上皮细胞癌，但由于患者个体差异和病理不同，可以表现多个不同的类型，如

气阴两虚，痰湿蕴结，毒热内炽，气滞血瘀等型。只有很好的把辨病与辨证结合起来，不但从宏观到微观，从局部到整体，诊断清楚是那种癌症，而且还可进一步分清是哪种类型，气血、脏腑损伤的程度，正邪胜负进退变化，对于掌握治疗与预后非常重要。

三、辨局部与整体，掌握标本缓急

局部与整体，个性与共性是对立统一的辨证关系，病灶虽在局部，可它会影响到整体，引起全身性功能失调和形态变化；反之，全身整体状况的好坏又往往能左右治疗的成败及局部治疗的效果。一个癌症患者整体情况的好坏判断对于局部病灶的正确治疗显得十分重要，全身情况好，局部病灶好转消散就快，在用药上就以攻为主。若只注意整体条件，而忽略局部情况，如大小、种类、发展浸润情况和肿瘤的性质，也是不行的。对于掌握局部与整体的辨证关系，对于指导临床，提高疗效意义重大。如一些晚期癌症患者全身衰弱，或者肿瘤已经很大，或者已广泛转移出现恶病质时，则必须侧重整体机能的维护，当以扶正为主，特别是要调理脾胃，补气养血，以保“后天之本”，增强抗癌能力，可减轻痛苦，延长生命，还有部分晚期癌症患者死里逃生，这也正是中医药抗癌的优势所在。

病有标、本之分。治疗疾病原发过程，消除内外致病因素，调整脏腑功能，疏通气血经络，控制消除肿瘤病变，应当说这都是治本，但临床上在疾病过程中可能会出现一些急危证候，甚至马上就会危及患者生命，这些证候都属于急标证候，应当及时对症治疗，出血的止血，痰多咳嗽者化痰止咳，这正是中医治病法则中急则治标，缓则治本的重要大法。

第四节 肿瘤的中医治疗

一、辨证施治

中医治疗肿瘤的优势在于辨证论治，近年来，有关肿瘤的常见症型的辨证施治大体可归纳为以下几个方面：

(一) 气滞 气为血之帅，亦为津液运行之帅，气是整个机体功能活动的动力，气顺则气血津液皆顺。外感六淫，内伤七情以及痰饮、湿浊宿食、瘀毒等原因均可能影响人体气的正常运行，引起气滞、气郁、气逆等病证，这些病证因部位不同而名异。

1. 肝郁气滞：肝为刚脏，性喜条达，肝气以疏为顺，如因情志不遂，郁怒忧思，易激动，两胁胀痛，少腹气痛，乳房胀痛、阴囊胀痛等结块症状。治以疏肝解郁，方用柴胡疏肝汤加减。常用药如柴胡、青陈皮、香附、郁金、当归、橘叶、夏枯草、八月札、川楝子等，若气滞较甚，可选加三棱、文术、沉香、大白、川朴、枳壳、枳实等破气行滞之药。以上这些药物适用于乳癌初起。肝癌、腹腔肿瘤的早期症状阶段。

2. 胃失和降：胃气以降为顺，以通为行，如胃气不降即可上逆，可见噯气、恶心、呕吐、呃逆、反胃、胃脘作胀、不思饮食等消化系统病证，常见于食管癌、胃癌、贲门癌、肝癌等患者，亦可见于放化疗后的副反应，以及其他恶性肿瘤引起的胃肠症状，治疗常选用和降胃气之法，多选旋复花、代赭石、枳壳、木香、半夏、厚朴、佛手、香橡皮、绿萼梅、沉香、柿蒂、黄荆子、刀豆、甘松、檀香、砂仁、陈皮等品。

3. 腑气不通：六腑以通为顺。泻而不藏，若因寒热侵袭、食积停滞、腑气失通，可见腹胀、腹痛，肠型包块，大便秘结，甚则呕吐，腹中绞痛，脉来弦紧或弦数，治宜通腑化滞，通里攻下，常用承气汤加减，常用药物如莱菔子、山楂、枳实、槟榔、大腹皮、厚朴、大黄、芒硝、火麻仁、郁李仁、番泻叶等。

(二) 血瘀

1. 气滞血瘀：气为血之帅，气行则血行，气止则血停，气滞日久必然会影响血运导致血瘀，气血凝滞不通，积瘀而发肿瘤，

所以从古至今善治肿瘤无不着重从瘀血着手，特别是那些有疼痛而且肿块固定的肿瘤，故治疗常用理气活血软坚散结之法，常选用药物如木香、乌药、降香、八月札、川芎、丹参、桃仁、红花、三棱、文术、泽兰、鸡血藤、牛膝、王不留行、白屈菜、土元、干漆、急性子、水蛭、刘寄奴、马鞭草、苏木、虎杖、乳香、没药、石见穿、喜树根、五灵脂、毛冬青等药。

2. 气虚血瘀：气为血之帅，血为气之母，气不能帅血运行亦可发生瘀血，这在肿瘤患者中更为多见。临床上因为气虚血瘀而致的肿瘤，多是一些中晚期癌症患者，或是手术后，放疗、化疗后的肿瘤病人，可见疲乏无力，纳谷减退，面色萎黄，肚腹结块或其他部位有结块固定疼痛，这种瘀血病人万不可一味采用攻法，盖因虚而致瘀，当以补气活瘀，此所谓“正气不复，瘀血难行”就是这个道理，常用药物如生黄芪、人参、太子参、丹参、赤芍、鸡血藤、红花、益母草、泽兰、平地木、虎杖根、石见穿、喜树根、急性子、乳香、没药、郁金、元胡、三七等。

3. 血瘀症积：血瘀于内，形成症积肿块，胸腹部肿物壅积均有血瘀或死血。《古今医统》描述食管癌时曾说：“凡食下有碍，觉屈曲而下，微作痛，此必有死血。”这些都与血瘀有关。治宜破血祛瘀法，攻坚消积，可投行气破血之药。如桃仁、红花、水红花子、皂刺、穿山甲、水蛭、虻虫、鬼箭羽、喜树根、乳香、没药、土元、蜣螂、斑蝥、鼠妇、苏木、急性子、石见穿、郁金、毛冬青根、干漆、五灵脂等。

（三）痰饮凝聚 痰饮同出一源，异名同类，二者皆为脏腑病理变化的产物，其浊而稠者为痰，清而稀者为饮，且与肺、脾、肾三脏功能失调相关，咳吐可见者为有形之痰，痰注全身无处不到者为无形之痰。古人多“怪病多痰”之说。肿瘤的形成与痰浊关系更加密切，综观历代治肿瘤的专家，以痰论治肿瘤的经验十分丰富。

痰气交阻，痰不见气不结，痰随气升，无处不到，治痰必先

治气，气降痰自降，气行痰自消。痰随气动，犯于肺，可见咳嗽，气喘，喉中痰鸣，胸部痞闷，脉弦滑，舌淡红，白润苔，为痰气结于气道，常见于肺癌偏于痰湿患者。常选用药物有苏子、莱菔子、白芥子、旋复花、陈皮、枳壳、厚朴、葶苈子、牛蒡子、瓜蒌、冬瓜仁、杏仁、生苡仁、桔梗、南星、半夏等，在食管癌亦可见到痰气互结，咳吐痰涎粘冻，胸闷发堵，噎塞不通，饮食不顺。治以化痰降气通道消噎之品，可改善症状。除上述诸药外，常加有丝瓜络、威灵仙、急性子、木鳖子等。

痰不见火不稠，痰火互结，可见于肺癰或肺部感染，表现为咳吐黄痰，粘稠有块，治以解毒化痰，桑皮、瓜蒌、黄芩、鱼腥草、金荞麦、鸭跖草、蒲公英、二花、前胡、马兜铃、青黛、丹皮、知母、生石膏、天花粉、人工牛黄、猪胆汁、竹沥汁、大贝等品。

若痰瘀互结，流注于皮里膜外，表现为瘰瘤、瘰癧、恶核、失荣、石疽等。治宜化痰祛瘀，软坚散结。药用夏枯草、生牡蛎、海藻、昆布、瓦楞子、半夏、桔梗、白芥子、南星、黄药子等。

痰浊阻窍，随气上逆，蒙蔽清窍，证见头痛有定处，头沉、呕恶、吐痰涎、胸膈满闷气短，甚则出现神志不清，见于脑瘤或脑转移癌，脉弦滑，舌暗红，苔白腻或白。治宜涤痰化浊通络开窍。常用药如白苍术、半夏、菖蒲、远志、僵蚕、全虫、天麻、佩兰、蜈蚣、南星、川芎、白芷、灵仙、郁金、全瓜蒌、皂刺。

（四）热毒 肿瘤患者热毒内蕴，常表现为热毒壅盛，如外感时邪亦表现热毒火盛，有时热毒伤阴，灼及脏腑，表现为肺热、心热、肝热、胃热、大肠热、膀胱热等；如热毒燔灼营血则出现气血两燔之证，故热毒为肿瘤患者常见证候之一。可选用清热解毒兼有抗癌作用的药物，如千里光、大青叶、玄参、二花、鱼腥草、紫花地丁、四季青、八角莲、土茯苓、一支黄花，射干、山豆根、马勃、白头翁、马齿苋、穿心莲、三颗针、山慈

姑、重楼、白英、肿节风、蛇莓、白花蛇舌草、凤尾草、苦参、白藓皮。若因毒热蕴久而伤及阴津，引起邪热伤阴症状，可见午后低热不退，心烦不寐，盗汗，舌红少苔脉细数而数，多见于肺癌，头颈部、食管癌放疗后，治宜养阴解毒，选用玄参、丹皮、赤芍、地骨皮、白薇、紫草等。

（五）正虚 祖国医学认为：“邪能伤正”；又认为：“正能胜邪。”肿瘤临床表现多为正虚邪实，如果邪毒不盛而见久病以亏损为主时，则主要表现为正气虚亏，即阴阳、气血脏腑功能的虚损和失调。在古籍文献中，对晚期肿瘤及气血衰败患者大多主张补益气血，调理阴阳脏腑以减轻痛苦，延以时日。笔者认为对于肿瘤患者的治疗必须依靠人体正气，并为祛邪治疗创造条件。只要营养状况好，身体抵抗力强，后天脾胃消化功能好的患者，即是手术后的恢复将更快，更好，而受放射线治疗、化疗药物治疗的能力更大，能接受更大的剂量，这就为祛邪抗癌治疗提供条件。反过来要维护好正气，使不再受病邪的破坏和损伤。关于补气养血，调整脏腑功能活动的药物省略。

二、辨证论治与单、偏、验方治疗相结合

中医辨证论治是传统的治疗方法，治疗肿瘤也不例外，但是在民间还流传着不少行之有效的治疗肿瘤的单方、偏方、验方及中草药，这些方药在一定的效果。一些方药简便易行，就地取材，符合简便有效的原则。但是，单偏验方和单味中草药有它的局限性，它们不可能对所有肿瘤都有效，也不能表示它们对每一个肿瘤患者都治愈。因此，不能单靠一方一药把肿瘤治愈，还要与辨证论治的其他方药相结合治疗。另外，就单、偏、验方和中草药的本身来说，它们都分别具有不同的性、味和功能主治；也要根据患者的不同辨证，即寒、热、虚、实等病型加以选用，不能单纯一味的只管用偏、单、验方，都是大辛大热的药，如果患者毒热邪盛，一派热象，再加上用大热药物，尤如火上加油，必然招致不良后果。又如患者脾胃已受损，而一些单方草药又是大

苦大寒的，一用之下，脾胃更伤，后患无穷。所以必须要把辨证论治原则与单偏验方的运用有机地结合起来，才能达到互相补充，取长补短的目的。

近年来，各地收集了不少治疗肿瘤的单、验方，通过临床试验，有的没有看到疗效，有时确实看到了一定治疗效果。祖国医学中这一部分宝贵的遗产还需要继续努力发掘，加以整理，去伪存真，去粗取精，重复疗效，找出其中一些有效方药来以丰富临床肿瘤治疗学。例如流传在民间治疗皮肤癌有效的农吉利，通过临床观察证实治疗皮肤癌及宫颈癌有效，进一步实验研究找出了主要有效成份是野百合碱（又叫农吉利甲素），在动物移植性肿瘤实验中看到有一定的抑瘤作用。如守宫酒，醋制硃砂，核桃树枝煮鸡蛋治疗食管癌和软组织肉瘤有一定的效果。又如民间广泛流传的斑蝥蒸鸡蛋治疗瘰疬和恶性肿瘤有效，经动物实验研究，证实斑蝥提取物对移植性动物肿瘤有一定作用，其主要成份是斑蝥素和斑蝥酸钠，目前已将斑蝥提取物制成注射剂，临床证实对肝癌、食管癌、乳腺癌均有一定疗效。还有蟾酥制剂等具有广谱抗癌作用。这些制剂吸收了单方、验方中有效的方药，整理研究提高和发展它，使其成为肿瘤治疗学中新的方法和药物。

三、中医治疗肿瘤特色

中医药治疗肿瘤，有其本身固有的特色，加之近几十年来临床研究和实验研究取得了不少经验，已在肿瘤临床的综合治疗和康复治疗中占有重要地位。其特色如下：

（一）中药确有抑癌作用，但缓而弱。

国内外的动物实验、临床观察及药理研究，均已证明中药用于抗癌有肯定的疗效。如白花蛇舌草，动物试验有抑制腹水性肝癌细胞作用，对小鼠肉瘤 S_{180} 的生长抑制率为 57.4%，可使癌细胞的核分裂象显著地受到抑制。又如苦参所含苦参碱及氧化苦参碱对小鼠肉瘤 S_{180} 有明显抑制作用。1966 年美国国家肿瘤化疗中心（CCNS）发表了对 1217 种植物的提取物进行的抗癌药

理研究，其中狭叶苦参的 50% 醇提取物对小鼠移植性肿瘤如路易斯肺癌（Luis Lung Carcinoma）等，表现了抑制活性。

但临床观察，中药用于治疗癌肿（除部分有毒药外），一般作用缓和，常需用药较长时间，方能显示其抗癌效果，且随着疗程的延长，效果会更明显。动物试验也证明了这一点，例如：藤梨根的粗制品，腹腔给药对 EAC（艾氏腹水癌）有明显抑制作用，用药观察 45 天，60 天，对荷瘤小鼠生命延长率分别为 75%（ $P < 0.01$ ）和 116.9%（ $P < 0.01$ ）；用藤梨根所含多糖复合物（ACPS-R）治疗 EAC 小鼠，在停药 45 天后，再次用 EAC 癌细胞攻击，表明治疗后小鼠有明显的抵抗力，25 只小鼠中仅 2 只出现肿瘤，观察 25 天全部存活，对照组小鼠 25 天后全部因长肿瘤而死亡。

（二）具有细胞毒性的抗癌中草药杀伤力强，但只能局部外用。

这些药多属中药学中的腐蚀性药物；能使肿瘤细胞变性、凝固或裂解，肿瘤组织坏死、脱落。内服对机体有毒或腐蚀腔道，引起穿孔，故常作外用。单药如雄黄、轻粉、斑蝥、狼毒、信石、硃砂、雅蛋子等，复方如三品一条枪、白降丹、皮癌净等。

（三）具有全方位调整机体功能作用，间接抗癌，延长生存时间。

动物实验证明，中药的药理作用除广泛的调节免疫功能外，同时对机体的其他系统如神经系统、内分泌系统、造血系统、消化吸收及物质代谢等各方面均有影响。例如健脾益肾、扶正培本中药能提高荷瘤小鼠免疫功能，增加对化疗的耐受性，促进骨髓有核细胞和造血干细胞的增殖，能激活非特异的巨噬细胞和天然杀伤细胞，加速 T 淋巴细胞的分裂，诱生干扰素及调整抑制性 T 细胞及辅助性 T 细胞的比例。一些扶正固本方药具有清除对机体有害的自由基以控制自由基诱发癌变，从而达到治疗肿瘤目的。一些药物可以提高细胞 cAMP 的含量，调整细胞内 cAMP

和 cGMP 的比值。还有些药物可调整机体微量元素的比值，对提高免疫功能有一定作用。具有此效应的药物如人参、黄芩、女贞子及健脾益肾冲剂、六味地黄丸等。

实验证明，活血化瘀中药，除具有直接杀灭癌细胞的作用外（如赤芍、红花、三棱、莪术、水蛭、穿山甲等），还有多方面的作用，如能抑制血小板粘附聚集性能，降低纤维蛋白原含量，扩张血管，增加血流量，增加纤维的溶解，改善血液循环，增加流区含氧量和药物浓度，提高杀伤指数，扼止肿瘤细胞的转移。

（四）治愈后病情稳定，不易复发。

由于中药治疗肿瘤机理与其它疗法不同，中药除有直接杀伤癌细胞作用外，更重要的是通过调整机体脏腑功能，使内环境趋于稳定，改善机体健康状况，使机体保持最佳状态，增强机体自身的抗癌能力，所以一般用中药治愈后不易复发。

（五）能增强其他疗法的疗效。

身体健康状况与肿瘤的疗效密切相关，国际抗癌联盟《临床肿瘤学手册》指出：“已证实无论采用哪一种治疗方法，当健康状况差时，治疗效果也差”。中医药可明显改善人体健康状况，故可增强疗效。

中药与手术相结合，于术前给扶正药治疗，可以改善患者一般营养状况，有利于手术进行。癌症患者术后常表现为气血双亏，或气阴两伤，或脾胃失调，或营养失调，用中药辨证治疗，可以促进机体的康复。

中药与放化疗结合，可增强化疗的敏感性和效果。可提高远期生存率，还具有防止转移的作用。应用活血化瘀药，可改善肿瘤局部血液循环，使肿瘤局部化疗药浓度增加，从而提高疗效。如临床和实验研究均观察到，丹参对环磷酰胺抗肿瘤有明显的增效作用。

中药与免疫疗法配合，也可增加疗效。例如女贞子与白细胞介素Ⅱ合用有协同作用，芦笋原汁能增加白细胞介素Ⅱ的效价

等。

(六) 减轻放化疗的毒副作用。

临床观察及实验研究均证实，中药用于预防和治疗放化疗所致的多种副作用，均有较好效果。例如，用养阴清肺佐以活血化瘀方药可治疗放射性肺炎，能减轻肺纤维化。用清热解毒、凉血止血法佐以清利之品，可以治疗放射性膀胱炎及放射性直肠炎等。化疗时伍用健脾益肾药，可保护机体的免疫功能、造血功能，能使化疗顺利完成。又如用健脾和胃、降逆止呕药可预防和治疗放化疗引起的胃肠道反应。用补肾填精、益气健脾、养血生血药治疗放化疗所致的白细胞减少症，有明显的疗效。

(七) 改善症状，提高生存质量。

中医药对改善肿瘤患者的临床症状，减轻其痛苦，有明显的疗效。例如健脾和胃药可明显改善患者厌食症状，增加食欲，促进消化，调理胃肠功能；补气养血，扶正固本药可纠正患者贫血，减轻倦怠乏力症状，改善各种机能低下状态等有明显效果。其他如治疗慢性疼痛，慢性发热、咳嗽、痰多、喘闷等也有明显效果。应用气功疗法可增强体质，且能明显改善病人精神状态和心理状态，增强战胜疾病的信心。

(八) 毒副作用较少且轻。

除某些有毒药物外，一般中药如扶正固本药、活血化瘀药等副作用较少。清热解毒药虽有苦寒伤胃的副作用，但一般较轻，且临床应用时常用复方，按照君臣佐使配方原则佐以健脾益气药，相辅相成，既提高了疗效，又未见明显的不良反应。

第五节 肿瘤的预防

肿瘤的早发现，早治疗是防治肿瘤的关键一环。祖国医学非常重视早期发现，早期治疗，并正确估计恶性肿瘤的不良预后。公元1687年，明代李惺庵著《证治汇补》中说：“吞酸，小疾

也，然可暂不可久，或以疾小或忽之，此不知其噎膈，反胃之渐也”。说明胃癌应及早治疗慢性胃疾来预防，提高警惕。在治疗上，中医亦主张及早治疗，如《疮疡经验大全》中对乳岩治疗时指出：“未破可疗，已破难治”。又说：“早治则生，迟则内溃肉烂见五脏而死”。在古代医疗条件下，对恶性肿瘤的治疗，虽大多无效，但在实践中应用了许多方法和药物，提出：“治疗得法”可延长生命（带疾终天）。为后人防治肿瘤提供了十分宝贵的资料。

一、预防性普查

肿瘤普查就是在一定的人群范围内，针对某种或多种常见恶性肿瘤进行健康普查，这种普查在目前癌症病因尚未完全明确的情况下是非常必要的，是防治癌症的一种重要手段。

通过普查能早期发现，早期诊断和早期治疗癌症病人，了解某地区的癌症发病死亡情况，发现和治疗癌前病变，发病原因，提供预防资料，建立扩大防癌队伍，提高基层医务人员的技术水平，力争尽早控制和消灭癌症。

二、肿瘤的预防措施

（一）开展防癌宣传

癌症的早期信号或预兆征象很多，但常见而主要的有：①长期无原因的发热、贫血；②长期顽固性咳嗽，痰中带血或声音嘶哑；③进食不畅，胸脘满闷，咽喉异物感；④顽固性溃疡或血性分泌物，经久不愈；⑤无法解释的无痛性肿块（如皮肤、浅表淋巴结、乳房、腹腔等）；⑥长期胃痛，脘满不适，隐痛作胀，顽固性消化不良，服药无效；⑦顽固性难治性疼痛；⑧黑痣色素加深，迅速增大；⑨大便次数异常、变形、下坠、长期反复黑便；⑩无痛性、间歇性血尿；⑪长期鼻涕带血，回吸性血痰；⑫短期内无原因的消瘦；⑬血性白带，绝经后，经期外或性交后阴道出血；⑭乳头常流血性溢液。

（二）坚持锻炼，提高机体抗病能力

坚持锻炼，增强体质，对防癌具有重要意义。恰当而适时地进行传统的各种保健功能锻炼和现代化的体育锻炼，对防病健身具有极为重要的作用。历代长寿老人的宝贵经验，就是一年四季坚持运动，可因人、因时、因地及其它条件的不同，选择适合自己的锻炼项目。如保健功、少林武术、各式太极拳，各种体育活动等。这种锻炼都能增强机体各部功能，疏通气机，改善循环，调整机体的内外环境之平衡，从而达到“正气存内，邪不可干”，预防疾病之目的。

（三）消除或避免致癌因素

1.戒烟：世界卫生组织估计，全世界每 13 秒中就有一人死于烟草，每日死于吸烟的约有 8000 人，90% 的肺癌与吸烟有关。90 年代全球每年有 300 万人死于吸烟，到 2000 年，每年死于吸烟者将增至 1000 万人，平均每天为 2.8 万人。因此，戒烟任务迫在眉睫，各国政府和人民都应该积极采取措施，加以控制。

2.饮食预防：已知人类饮食中有很多类的化学致癌物。樟科与姜科植物香精油中的黄樟素能诱发大鼠肝癌和食管癌。蕨类植物蕨菜中含的莽草酸等能引起动物肺、肠、膀胱肿瘤。食用蕨菜可能与人类癌症有关。因此，人们在饮食生活中必须考虑植物毒素对人的影响。

霉菌种类繁多，广布自然界，与人们关系极为密切。虽可用来作食品酿造、一些工业原料和抗生素生产，但它的代谢产物对动物的神经、消化、泌尿、血液、生殖等系统均可引起毒害，这些代谢产物称为“霉菌毒素”。目前已知约有 200 种霉菌毒素中具有基因性的诱变剂或致癌物就有 40 多种。现已查明有些霉菌毒素对动物有致癌和促癌作用。如黄曲霉素 B₁、B₂、G₁、M₁、杂色曲霉菌毒素、白地霉菌毒素、镰刀霉菌毒素、纯绿青霉素、环氯霉素，对动物有很强的致癌作用。据研究表明，在某些特定人群中，黄曲霉毒素的摄入量与肝癌的发病率呈正相关关系，故认

为黄曲霉素是人类肝癌的病因之一。因此，认真做好防止粮食、油料、种子、肉类等食品霉变、消除霉菌毒素，对预防癌症和保护人民健康具有重要意义。

目前认为饮食中 N-亚硝基化物及其前体的高含量，可能与人类的食管癌、胃癌有关。因此在饮食中防止外源性和内源性亚硝胺的产生，实属重要，切忌常食腌、熏、煎、烤、过分油炸食物。多吃蔬菜、水果、维生素 C 等大有裨益。

多环芳烃是由多个苯环缩合而成的碳氢化合物及其衍生物。它主要来源于有机物的不完全燃烧，如工矿、机动车辆、烟囱、生活中各种燃料的燃烧。生活中食用的粮食、蔬菜、水果等在生长过程中受到多环芳烃类化学物质的污染，渗主叶表面腊质或气孔而进入植物体内，洗涤仅能除去 10% 左右。食物在烟熏、烘烤、烙焦时，食物与燃料合制时产生多环芳烃，污染严重。因此，在生活中必须严格遵守饮食卫生习惯，认真清洗蔬菜、水果等，以防多环芳烃致癌作用对人体的影响。

3.合理营养，配比膳食：合理营养，恰当配给蛋白质、脂肪、糖、维生素（A、B、C、E 等）、蔬菜、水果、矿物质、微量元素等。不饮酒、不偏食、勿暴饮暴食。

4.合理使用药物，特别是抗癌药物，应严谨选用，警惕药物诱发肿瘤。

5.防止和消除物理、化学和慢性炎症等对机体的刺激。

6.精神性预防：精神因素对人的影响至关重要，国内、外医学界均取得了一致认识。心情愉快，气血通畅，机体内环境平衡稳定，中枢神经系统功能健旺，脏腑协调，免疫功能健全，适应外环境变化之能力就强，从而就可防止疾病的发生。

7.癌的化学预防

(1) 癌的化学预防系指用化学药物预防癌的发生或使癌细胞逆传为正常细胞，以期达到预防恶性肿瘤的目的。

国内、外多学者正从事癌的化学预防研究工作，大量实验和

临床研究表明，癌变是一个相当长的渐变过程，由正常细胞——→突变细胞——→癌前细胞——→癌细胞，化学干预是行之有效的，这不仅具有理论意义，而且又有实用价值。回顾历史取得的可喜苗头，预计在未来 10 年内人类癌的化学干预和营养干预等将会引起惊人的进展。

癌的预防通常分为三级：一级预防是病因预防，系指消除或避免致癌因素，降低发病率，如避免或从食物中及环境中摄取致癌物或抑制体内致癌物的形成；二级预防是干预致癌物的代谢或抑制致癌物与细胞 DNA 的结合，防止癌的发生；三级预防是治疗癌前病变，预防癌的发生。目前公认癌预防的最佳办法是抑制癌前病变，或使其逆转为正常细胞。

（2）癌的化学预防药物

癌的化学预防药物目前分为三大类：①对抗致癌的制剂；②抗促癌剂；③兼有抗致癌和抗促癌的制剂。

抗致癌剂：维生素 C 能抑制体内、体外亚硝胺的形成，维生素 E、大蒜及酚类化合物也有同样作用；谷胱甘肽能消除已活化的致癌剂；维生素甲类化合物、硒盐、蛋白酶抑制剂及花生四烯酸代谢抑制物均有致癌抑制作用。

抗促癌剂：酚类抗氧化物、蛋白酶抑制剂、d-二氟甲基鸟氨酸均可抑制促癌作用。

抗致癌及抗促癌剂：维甲类化合物、蛋白酶抑制剂及花生四烯酸代谢抑制物即有抗致癌作用，也有抗 TPA 促癌作用。

（四）保护和改善环境卫生

加强卫生监测，改善劳动条件，防止环境污染，消除和避免接触可能的致癌物质。

（五）积极预防和治疗癌前病变及可能癌变的良性疾病

老年性皮肤角化症，粘膜白斑，经久不愈的慢性溃疡，瘻管，易受磨擦部位的色素痣，皮肤乳头状瘤，多发性神经纤维瘤病，乳腺素性增生症，胃肠道息肉样腺瘤，食管、贲门的粘膜上

皮增生，慢性胃溃疡，萎缩性胃炎及肥大性胃炎，宫颈糜烂，隐
睾，包茎，慢性迁延性病毒性肝炎以及肝硬变等有可能发生癌
变。故应积极治疗这些疾病。

第三章 中医肿瘤治疗常用法则

第一节 扶正培本法

恶性肿瘤是机体全身性疾病的局部表现，祖国医学对肿瘤的认识更重视整体性。从《内经》云：“正气存内，邪不可干”。“邪之所凑，其气必虚”。《医宗必读》云：“积之由也，正气不足而后邪气踞之”，《外源医案》更明确指示：“正气虚则成岩”。癌症的发生与发展，是一个邪正相争的过程。患者整体多表现为正虚，而病灶局部则多表现为邪实。各种外因多在人体正虚的情况下，侵袭机体而发病。运用扶正培本治疗肿瘤，则是祖国医学的一大特色。它是用扶持正气，培植本元的方法来调节人体阴阳气血，脏腑经络的生理功能，提高病人抗病能力，增加免疫机制。其作用原理可归纳为以下几点：①促进实验动物的免疫功能；②改善骨髓造血机能；③提高内分泌及体液调节功能；④调节细胞内环磷酸腺苷（cAMP）含量及其与环磷酸鸟苷（cGMP）之比值，有利于抑制癌细胞的生长；⑤具有双向调节作用；⑥调节机体物质代谢；⑦有些扶正固本方药对肿瘤动物能抑制浸润和转移，同时有可能预防肿瘤和治疗癌前病变。

近几年来，我国对肿瘤的治疗，采取扶正培本法进行了大量的临床研究，并证实了它的临床效果。

一、提高生存率

上海中医学院附属龙华医院曾以随机分组对 122 例晚期原发性非小细胞肺癌进行了中医扶正治疗的前瞻性研究。122 例中，磷癌 60 例，腺癌 62 例；Ⅲ期 70 例，Ⅳ期 52 例，采用中医滋阴、益气、温阳，佐以清热、化痰软坚等法，常用药物为沙参、天麦冬、百合、生地、人参、党参、白术、茯苓、补骨脂、仙灵

脾、金银花、白花蛇舌草、夏枯草等。对照组（化疗组鳞癌用 COF 方案，腺癌用 MOF 方案）按前瞻性设计对比化观察，结果显示肺鳞癌中药组 1、2、3 生存率分别为 66.7%，13.3% 和 3.3%；化疗组 1、2 年生存率为 33.3% 及 3.3%。中位生存期中药组为 465 天，化疗组为 204 天（ $P < 0.05$ ），两组有显著差异。肺癌中药组治疗后 1 年生存率为 53.8%，化疗组为 23.8%，中位生存期中药组为 335 天，化疗组为 192 天（ $P < 0.05$ ），说明中医扶正法有延长晚期癌患者生存期的作用。

中国中医研究院广安门医院对扶正中药合并化疗治疗 200 例晚期胃癌（术后）患者进行了定期疗效观察，其中Ⅲ 103 例，Ⅳ 期 97 例。治疗以党参、白术、枸杞子等扶正中药配合化疗 MFV 方案，每疗程 5~6 周，两年共 4~5 疗程。化疗后予健脾益肾方药佐少量祛邪抗癌中药以巩固疗效。远期疗效统计，Ⅲ 期患者 1、3、5 年生存率分别为 93.06%，70.59% 及 51.65%；Ⅳ 期患者 1、3、5 年生存率分别为 92.06%，23.64%、10%，Ⅲ 期患者 10 年生存率为 42.86%；中位生存期 24 个月；平均生存期为 31.09 个月；Ⅳ 期姑息手术 63 例中死亡 53 例，中位生存期为 23 个月，平均生存期为 22.84 个月；未经手术 34 例全部死亡。与国内外报道的相应期术后生存率相比，明显较优。

二、减轻放化疗的毒副反应

恶性肿瘤患者接受放射或化疗中，常发生耗气伤阴，脾胃受损，影响气血生化和肾主骨生髓的功能，临床上表现为一系列证候，与“虚损”相等。对接受放疗的病人辅以中医扶正培本治疗，能益气养阴，调补气血，滋补肝肾，健脾和胃，对化疗病人则健脾益肾，舒肝和胃，补益心脾。这样不仅可以减轻放化疗的毒副反应，使病人顺利完成疗程，而且对稳定机体的内平衡，具有良好的效果。

中国中医研究院广安门医院用健脾益肾冲剂配合化疗（治疗组）与单用化疗（对照组，用 MFV 方案）随机对照观察胃癌

Ⅲ、Ⅳ期术后患者 326 例。结果显示治疗组 95% 的病人能完成疗程。而对照组完成疗程者仅为 75%。从患者全身情况、体重、消化道反应、外周血象、免疫功能分析，治疗组均优于对照组。

北京中日友好医院采用“扶正冲剂 2 号”对头颈、胸部恶性肿瘤患者放疗反应治疗进行临床观察。治疗组 30 例，其中 28 例顺利完成放射治疗，完成率为 93.3%；对照组（单用放疗）31 例，只有 23 例完成放射治疗，完成率仅 74.2%，治疗组明显优于对照组。

三、提高手术效果

手术是治疗恶性肿瘤的重要手段，但手术也同时造成机体创伤和脏腑功能紊乱，导致某些并发症和后遗症。中医扶正培本治疗提高病人免疫功能，改善术前术后的症状，减轻手术合并症和后遗症。

福州市第一医院用“理胃化结汤”（党参、白术、茯苓、甘草、生黄芪、熟地、黄精、白毛藤、白花蛇舌草、芡实、莲肉、田三七、沙参、枸杞子、大枣）结合手术及化疗治疗胃癌，320 例病人均行根治手术或切除手术，术后从理胃化结汤配合化疗，统计治疗 3、5、10 年生存率分别为 60.5%，47.36% 和 18.42%，均比国内报告的西医治疗为优。

北京中医学院东直门医院用黄芪党参注射液治疗胃癌及大肠癌术后 40 例，经治疗后，患者症状改善，体重增加，巨噬细胞吞噬功能提高，有效地促进了胃癌、大肠癌术后患者的康复。

四、预防肿瘤和治疗癌前病变

应用扶正方案开展肿瘤预防和治疗癌前病变已在各地展开，上海市 1975 年普查 82 万人，对 1097 例 AFP 阳性对象（血凝法）随访一年，有 8.5% 发生肝癌，而对同样情况的 270 例用扶正培本中药治疗，随访一年，仅有 2.6% 发生肝癌，中国中医研究院中药研究所用滋阴益肾的六味地黄丸治疗食管上皮重度增生

(癌前病变)，取得 85% 的好转率。

第二节 清热解毒法

毒热是恶性肿瘤的主要病因病理之一，恶性肿瘤患者常有邪热瘀毒蕴结体内，临床上表现为邪热壅盛，中、晚期患者在病情不断发展时，常见有发热、疼痛、肿块增大、局部灼热疼痛、口渴、便秘、黄苔，舌质红绛，脉数等热性症候。治疗当以解毒为法则。炎症和感染往往是促使肿瘤发展和病情恶化的因素之一，清热解毒药能控制和消除肿瘤周围的炎症和感染，所以能减轻症状，在恶性肿瘤某一阶段起到一定程度的控制肿瘤发展的作用。同时大量筛选出来的有效抗肿瘤中药的药性作用大多属于清热解毒药的范围，所以清热解毒法是恶性肿瘤最常用的治疗法则之一。在颇多文献报道中，常以清热解毒药为主，如龙蛇羊泉汤（龙葵、蛇莓、蜀羊泉），癌零九方（藤梨根 60g，山豆根 15g，水杨梅根 30g，蚤休 15g，凤尾草 30g，野葡萄根 30g，半枝莲 30g，半边莲 30g，白术 10g，白茅根 30g，每日一剂，分二三次服），抗癌乙丸（山豆根、草河车、夏枯草、白藓皮、败酱草、黄药子），清瘤片（草河车、肿节风、山豆根、半枝莲、白花蛇舌草等），在临床上均有一定的疗效。

目前通过药理研究和临床疗效筛选，证明大多数清热解毒药物均有较强的抗癌活性，且已从中分离提取出有效成份（部分成份已能人工合成），做成制剂提供临床应用。例如喜树碱、羟基喜树碱、农吉利甲素、山豆根生物碱、长春花碱、长春新碱、三尖杉总碱、三尖杉酯碱、穿心莲内酯和靛玉红等。临床上常用的清热解毒抗肿瘤药物有：白英、半枝莲、野百合、喜树、龙葵、山豆根、鸦胆子、石上柏、三尖杉、穿心莲、长春花、肿节风、七叶一枝花、白花蛇舌草、金银花、青黛等。而经现代药理研究证实，许多清热解毒抗肿瘤药物对机体免疫功能能产生较大影

响。其中能增强机体非特异性免疫功能的清热解毒药物有肿节风、白花蛇舌草、紫草、枝子、鱼腥草、金银花、大青叶、野菊花、黄连、黄芩、穿心莲、白英、夏枯草、青黛等；增强机体细胞免疫功能的清热解毒药物有山豆根、喜树、青黛、紫花地丁、蒲公英、漏芦等；增强机体体液免疫功能的清热解毒药物有金银花、黄柏和蜀羊泉等。另外鸦胆子油乳剂对造血干细胞有促进作用，能增强白细胞数，白毛根、甘草亦具有升高白细胞作用，龙胆草对干扰素的诱生具有一定的促进作用。总之，清热解毒药物可以从多方面增强机体的免疫功能，尤其是提高巨噬细胞吞噬功能，多而更好地发挥其抑菌、抗肿瘤作用。

安徽医学院附属医院肿瘤科应用中药 64 方（蜀羊泉、红枣）65 方（蜀羊泉、党参、红枣、茜草）等治疗子宫癌 45 例，近期治愈 23 例，显效 4 例，有效 6 例，无效 12 例，总有效率为 73.3%，对糜烂型和菜花型的疗效较好。江西省妇幼保健院应用山豆根制剂治疗恶性葡萄胎 90 例获得临床治愈 79 例（占 87.8%），有效 2 例，治疗绒毛膜上皮癌 10 例，获临床治愈 4 例，有效 1 例。江西医学院附属医院用山豆根制剂治疗白血病 11 例全部有效，其中显效 3 例，好转 3，进步 2 例，稳定 3 例。广东梅县地区人民医院妇产科应用穿心莲注射液治疗绒毛膜上皮癌和恶性葡萄胎共 60 例，治愈 47 例（其中单用穿心莲者 12 例），治愈率达 78.3%。方法：常用 10% 穿心莲注射液 50~100ml 稀释于 5%~10% 葡萄糖溶液内作静脉滴注，每天 1 次，30 天为一疗程。有阴道结节性转移者，作转移结节基底部注射，每次 5~10ml，每日或隔日一次，可使结节完全消失。亦可并用化疗，手术等。

北京中医研究院西苑医院以青黄散治疗 25 例慢性粒细胞性白血病，取得明显效果，完全缓解率达 72%，部分缓解率达 28%。南昌市二医院以白花蛇舌草 75g，白茅根 75g，薏苡仁 30g，红糖 90g，水煎分 3 次服，每日一剂，治疗胃癌患者 81

例，痊愈 15 例，显效 7 例，有效 39 例，总有效率为 75.3%。江西萍乡矿务局职工医院以白花蛇舌草、仙茅各 120，水煎服，每日一剂。治疗直肠癌、乳腺癌，宫颈癌、肝癌、胃癌 10 例，特效、显效和有效各 2 例，无效 4 例。认为对直肠癌和乳腺癌的效果较为显著。河南用山豆根、夏枯草、全瓜蒌、黄芪、白术、丹参、薏苡仁、香缘组成的复方和“抗癌灵”（半枝莲、半边莲、白花蛇舌草）分别与争光霉素、环磷酰胺合用，显效率以单用化疗的 22.2% 分别提高到 44.5% 和 50.0%。

在中医辨证论治中，根据疾病不同的性质，清热解毒药也常与其它治疗法则和药物相结合，如热邪炽盛，耗损津液时，清热解毒药分别与养阴生津药及滋阴凉血药合并应用；如热盛迫血妄行时，则应与凉血止血药合并应用。肿瘤病人一般体质较差，还应注意与扶正药物的有机配合。另外，根据毒热蕴结的不同部位和不同表现，选择恰当的清热解毒药物，如黄芩清上焦肺热，黄连清胃肠热，黄柏清下焦热，山栀子清三焦热，龙胆草泻肝胆之积热，大黄泻肠胃之腑热等。同时，清热法常与利湿法，解毒法与化瘀散结法等同时应用。所以，根据病性，辨证地应用清热解毒药，使之在治疗肿瘤中发挥较好的效果。

第三节 活血化瘀

活血化瘀法是中医学应用活血化瘀药物治疗瘀血证的一种方法，早在二千多年前的《内经》中就有“恶血”的记载，并提出了“血实者决之”的治疗原则，汉代张仲景在《伤寒论》、《金匱要略》中就提出了“瘀血”、“干血”、“蓄血”等病名，并创造活血化瘀方剂。中医学对肿瘤病理病因的认识，瘀血为其中之一。历代医家多指出，症积、石瘕、痞癖、噎膈以及肚腹结块等与瘀血有关。如《医林改错》明确指出：“肚腹结块堵，必有形之血”。故活血化瘀法是治疗肿瘤的重要法则之一。在病因上，许多因素可

导致瘀血，气滞可以形成血瘀；气虚也能引起血瘀；外邪入侵，伤脉伤络，血溢络外，停留经脉，脏腑组织之间形成瘀血，瘀血凝聚形成肿块。肿瘤患者在临床上有如下症状之一者可认为是有瘀血之证。①体内或体表肿块经久不消，坚硬如石或凹凸不平；②唇舌青紫或舌体、舌边及舌下有青紫斑点或静脉怒张；③皮肤黯黑，有斑块、粗糙，肌肤甲错；④局部疼痛，痛有定处，日轻夜重；⑤脉涩滞等。

瘀血的治疗原则是活血化瘀，通过活血化瘀，疏通血脉，破瘀散结，祛瘀生新等治疗，能达到活瘀止痛，利湿消肿，恢复正常气血的运行。活血化瘀法不但能消瘤散结治疗肿瘤，而且对由瘀血引起的发热、瘀血阻络引起的出血、血瘀经络所致的疼痛等症，分别结合清热活血、活血止血、化瘀止痛诸法治疗，能收到一定效果。值得提出的是，肿瘤患者由于长期受癌肿的侵蚀，机体功能下降，临床上以气虚血瘀为表现的并不少见，给以益气培本，活血化瘀相结合的治疗法则，可促进患者机体功能恢复，提高机体免疫力，增强消瘤散结能力，常取得满意的疗效。

目前，经药理学研究证实，多种活血化瘀药物均具有抗肿瘤作用，如川芎、当归、丹参、莪术、三七、大黄、斑蝥、郁金、桃仁、红花、赤芍、延胡索、乳香、没药、山枝、水蛭、虻虫、全蝎、土鳖虫、三棱、鸡血藤、茜草、苏木、丹皮、泽兰，并可调节机体的免疫功能。另外，当归、赤芍、莪术、丹参、大黄、丹皮、蒲黄等，能促进单核吞噬细胞系统功能，由于巨噬细胞吞噬活动对肿瘤细胞的生长扩散能起遏止作用，从而发挥其活血化瘀药物的抗肿瘤能力，此外，丹参、降香尚有一定程度的诱生干扰素作用而抗癌。当归、鸡血藤、莪术、茜草、川芎等并具有升高外周血液白细胞的作用。

经临床血液流变学证明，癌症患者血液高粘状态是比较严重的，而引起恶液质的消化道癌肿及血供丰富的肝癌、肺癌等以及癌转移患者，血液高粘状态显然更为严重，以活血化瘀药物芎龙

汤（川芎、地龙、葛根、三棱、延胡索、益母草、牛膝等）治疗后有一定疗效，有效率为 55.6%~66.7%。如赤芍、丹参、红花、川芎、益母草、当归、姜黄、毛冬青等具有降低血小板表面活性，抑制血小板凝集，提高纤维蛋白溶解酶活性，从而有抗凝作用，可改善癌症患者血液的高血凝、高粘状态。实验室研究还证实活血化瘀药物对小鼠鼠肠系膜实验性微循环屏障有改善作用，作用最好药物为红花、莪术、刘寄奴、延胡索、五灵脂；其次为川芎、益母草、丹皮、没药、山楂、苏木。临床应用活血化瘀药物作放、化疗增敏剂，可收到一定的效果，可能与活血化瘀药物改善痛区的微循环增加血流供给的作用有关。

活血化瘀药物具有能改善结缔组织代谢作用，可使瘢痕疙瘩的皮肤软化，研究表明，当归、赤芍的提取成份如阿魏酸钠、赤芍总甙、赤芍精和毛冬青甲素在体内体外对血小板凝聚素 A_2 (TXA_2) 的活性都有抑制作用，丹参中 (TE-2) 可竞争性抑制 PGF_2 的作用，表现活血化瘀药物可通过 PG 的拮抗作用而发挥其抗炎作用，从而可抑制胶原纤维的生物合成与结缔组织的增生。因此，在临床上，活血化瘀药物合并放射疗法，除可增强放疗的敏感性外，对肺部肿瘤放疗后的并发症——放射性肺炎及肺纤维化亦有一定疗效。这是活血化瘀法在防治肿瘤方面的重要进展之一。

活血化瘀法在肿瘤临床上的作用，应根据中医理论及辨证施治，有瘀血症或有一些瘀血症的客观指标异常（如血液流变学异常，舌及甲皱微循环的改变，结缔组织纤维化改变等）时就可以应用。没有瘀血症的患者如任意滥用，药物则是破血攻瘀之剂，可伤正气，对患者极为不利，有促进癌细胞转移的危险，活血化瘀法对肿瘤的作用原理之一，可能就在于改变肿瘤宿主的部分病理生理变化，并通过改善血液循环，增强机体的细胞免疫能力而调力机体内外的抗癌能力。目前这一治疗法则在肿瘤治疗中的作用，已基本形成共识，相信会给肿瘤治疗学带来欣荣的景象。

第四节 软坚散结

肿瘤质硬如石的称坚，质软的称结。使硬块消散的治法称为软坚散结法。内经中早已指出“坚者削之……结者散之”。“客有除之”，所以对肿瘤的治疗，多用软坚散结法。根据中医药理论及临床经验，一般认为味咸之中药能软化坚块，常用的药物有：硃砂、硼砂、牡蛎、鳖甲、龟板、土鳖虫、瓦楞子、海藻、昆布、海螵蛸、海浮石、青黛、地龙、五倍子、夏枯草、山慈菇、猫爪草、穿山甲、鸡内金等。至于散结则常通过治疗产生聚结的原因而达到散的目的，常用消痰散结法，治疗痰结，如瓜蒌、海浮石、土贝、大贝、川贝、白芥子、半夏、南星、苡仁、皂角刺、山慈菇、黄药子、茯苓、天竺黄、杏仁等；理气散结法，治疗气结如：八月扎、木香、乌药、沉香、降香、丁香、陈皮、青皮、砂仁、枳壳、香附等；温化散结法，治疗寒结，如干姜、良姜、吴茱萸、薤白、艾叶、荔枝核、小茴、川椒、棉花根、铁树叶等；此外还有如解毒散结法治疗毒结，清热散结法治疗热结，化瘀散结法治疗血结，消导散结法治疗食结等。本法药物现已普遍用于肿瘤临床，与其它疗法相结合，可增强消瘤除块的效果。

本法在临床上虽然应用很多，但单独作为主要治则进行临床观察者却很少，虽有个别病例曾以此法治疗为主，但常合并其它治疗肿瘤法则和方药应用。以药物作用来说，具有软坚散结作用的一些中草药，有的经过筛选也有抗肿瘤作用，如僵蚕对 S_{180} 抑制作用，并在体外可抑制人体肝癌细胞的呼吸。牡蛎及海藻提取物对肿瘤细胞有抑制作用，夏枯草对 S_{180} 、 U_{14} 有抑制作用；体外试验证明，土鳖虫对抑制人肝癌、胃癌、慢性淋巴细胞性白血病细胞有效。另外，活血散结药，水蛭味咸苦平，有毒，临床治疗症瘕积块，其注射液可抑制精原细胞分裂，体外用伊红法对瘤细胞亦有作用；对鼠肝癌细胞生长亦有一定抑制作用。总之，

软坚散结方药多与其它攻邪药合用，以增强治疗肿瘤效果，目前，这方面研究不多，有待进一步努力和开发。

第五节 化痰祛湿

痰湿均为人体内的病理产物，作为病因又可作用于病体。中医认为，许多肿瘤是痰凝湿聚所致，如元代医家朱丹溪说：“凡人身，上中下有块者多是痰”。清代医家高锦庭也说：“癌瘤者……及五脏瘀血浊气痰滞而成”。此外，湿毒为患，可浸润生疮，流脓流水或因肿瘤而出现浮肿，胸水和腹水等。通过化痰祛湿法，不但可以减轻症状，某些肿瘤亦可得到有效控制。因此化痰祛湿在肿瘤中医治疗中占有一定的重要性，通过现代实验研究及药物筛选，更进一步证明某些化痰、祛痰药物本身就有抗肿瘤作用如化痰药半夏、天南星、皂角刺、瓜蒌（包括天花粉）、昆布、黄药子等；清热燥湿药苦参、黄连、黄芩、黄柏以及利水渗湿药白术、茯苓、猪苓、薏苡仁、竹叶、木通、泽泻、泽漆、金钱草和瞿麦等。逐水药物大戟、芫花、半边莲、商陆、抽葫芦等，所以结合中医辨证施治原则，合理地运用化痰、祛湿法，将能提高肿瘤的治疗效果。

中医所谓“痰”和“湿”，除了表现为呼吸道感染炎症分泌物所形成的痰外（外痰），更主要的是由于水液代谢和脏腑功能失调，如脾不健运或肝气横逆致湿痰凝聚经络而生的痰核，瘰癧等症（内痰）。此时须用化痰散结法，如与理气药合用则称理气化痰法，选用合理的药物配伍。与清热药合用，或用有清热作用的化痰药，称清热化痰法；与温热药或有温热作用的药合用称温化痰法；与软坚散结药合用，称化痰散结法；与通经活络药合用，称化痰通络法。

湿作为病邪与病因病理，在肿瘤临床上较为常见。湿性重浊而粘腻，阻滞气机运行，阻碍脾胃运化，湿邪有内外之分。外湿

是感受外界湿邪，如气候潮湿，久居湿地或涉水淋雨等的侵袭，且常与风邪、寒邪相并。治疗可用祛风除湿法，常用药物如独活、秦艽、威灵仙、徐长卿、穿山龙、木瓜、菝葜、海风藤、桑枝、寻骨风、络石藤等，并有一定的抗肿瘤作用。内湿是由于脾肾阳虚，不能运化水湿或水湿停聚于内，形成有形之水湿（如浮肿、胸腹水以及皮肤湿毒疮疽），治当祛湿利水法。还应注意的是，临床上常见到无形之湿邪引起的全身各部位功能紊乱，表现为头胀头沉，胸脘痞闷，口淡而粘，食欲不振，口渴而不欲饮，四肢沉乏，大便稀。女子白带多等；特有的体征为苔腻脉滑，可根据湿邪所在部位不同，分别投以芳香化湿（三仁汤），温化水湿（苓桂术甘汤），健脾利湿（实脾饮）等法治之。

虽然化痰、祛湿法在肿瘤临床上运用较广，但系统观察研究很少，虽有个别用化痰法为主治疗肿瘤的报道，但缺乏深入的系统的临床观察和实验研究。化痰或祛湿有效方药的研究则更少，有待进一步探索。

第六节 以毒攻毒

癌瘤已成，不论是由于气滞血瘀，或痰凝湿聚，或热毒内蕴，或正气亏虚，久之均能瘀积邪毒。邪毒与正气相搏，表现为肿瘤患者的各种症候，尽管病情变化错综复杂，邪毒结于病体都是本病根本之一。历代医家及民间流传许多治疗癌症的方法及药物有不少都是以攻毒为目的。毒陷邪深，非攻不克，常用一些有毒之品，性峻力猛，即所谓“以毒攻毒”之法。金元；四大家之一的张子和善用攻法，他说：“夫病之物，非人身素有之也；或自外而入，或由内而生，皆邪气也。邪气入诸身。速攻之可也，速去之可也”。此处所指之邪当为实邪。肿瘤是邪毒瘀积于内，大多表现为阴邪之毒，因此攻毒祛邪多用辛温大热有毒之品，取开结拔毒之效。实验研究证明，这些药物大多对癌细胞有直接的细胞

毒作用。过去，一些有毒之品多作局部外用，但掌握了它的适应症和用法后还是可以内服的，如现在将有毒的蟾酥制成注射液静脉注射，有毒的藤黄、钩吻等都已应用于肿瘤的治疗。

以毒攻毒法应该与药物的毒副反应相区别，例如，通常是无毒药物，有时用到一定量时也能变成有毒的。如马兜铃，一般10~15g，无任何反应，如加至30~45g，则可出现心律不齐等，另外一些以毒攻毒药物的特点是有效剂量与中毒剂量很接近，因此，必须慎重地掌握有效剂量，并适可而止，即中医谓将邪毒衰其大半之后，继之使用小毒或无毒药物以扶正祛邪，逐步消灭残余之癌细胞。正如《素问·五常政大论》说：“大毒治病，十去其六；常毒治病，十去其七；小毒治病，十去其八；无毒治病，十去其九”。“无使过之，伤其正也”。

中药以毒攻毒的药物较多，应用于肿瘤临床的有以下几类：

虫药中有全蝎、蜈蚣、红娘子、守宫、蛇莓、蟾酥、土鳖虫、蜣螂、水蛭及河豚油等。

矿物类药有雄黄、硃砂、砒石、轻粉等。

本草植物类药物有藤黄、藜芦、常山、毛茛、狼毒、蓖麻、马钱子、蛇辛谷、巴豆、干漆、洋金花、石胡荽、生半夏、生南星、生附子、急性子、雪上一枝蒿、乌头、钩吻、六方藤、八角莲、独角莲、芫花、大戟等。

近十余年来，运用有毒类药物以毒攻毒治疗肿瘤，各地进行了一些临床与实验观察，对某些药物也作了一些深入研究，但还不够系统和全面，这只简要介绍一下某些有毒类药物及制剂的临床运用。

有人以蟾皮、儿茶、元胡制成片剂治疗胃癌100例，有效率达69%，三年后随访，有效率仍有15%，旅大市将蟾蜍焙干，研成粉末，以雄黄为衣制成“化毒丹”，以其头、皮、肝、胆、心的水煎液制成肌肉注射的“化毒液”，治疗胃、膀胱、肺癌等22例，临床治愈4例，好转17例，蟾酥是蟾蜍耳下腺分泌物的干

燥品，以蟾酥复方合并化疗治疗成人急性粒细胞白血病 60 例，疗效与单纯化疗相比，有效率从 12.2% 提高到 50%，完全缓解率由 5.27% 提高到 28.33%，平均生存期由 2.1 个月延至 7.1 个月，有人将蟾酥与香油配成蟾酥麻油注射液，配合化疗治疗 48 例肺、鼻咽癌等患者，肿瘤消失 16 例，客观有效率达 85%，据不完全统计，用斑蝥、斑蝥素或以斑蝥为主综合治疗肝癌 386 例，平均有效率 58.6%，主要表现在症状改善，生存期延长，部分病例可见肿块缩小，治疗其它肿瘤 279 例，平均有效率 39.9%。广东有人曾用眼镜蛇、银环蛇、青竹蛇、蜈蚣、全蝎、蟾酥等煎熬成膏，外用治疗乳癌等 8 例，7 例痊愈。福建用眼镜蛇毒注射液治疗 42 例晚期癌痛，注射后疼痛全部消失者 18 例，好转者 22 例，有一定镇痛作用。临床上用安露散 I 号（蜈蚣、全蝎、僵蚕、土鳖虫等，焙干研成粉末口服），每次 0.7g，一日三次，治疗急性白血病 27 例，慢性粒细胞白血病 2 例，初治单用者 4 例，化疗后因血象差而改用或加用安露散 I 号者 25 例，19 例服药后，获得缓解者占 64.71%，有食欲、血象改善者占 65%~80%。

中药“三品”锥切法治疗宫颈癌，“三品饼”是由白砒 45g、明矾 60g、雄黄 72g、没药 36g 组成，江西妇幼保健院等用“三品”锥切法治疗早期宫颈癌 170 例（原位癌 119 例，I a 期 51 例），均达到近期治愈，经严密的定期随访复查，均未见复发，其中随访达 5~8 年者 86 例，均获 5 年以上治愈率。湖南中医学院第二医院报道，外用五虎丹治疗头面、四肢、乳房、阴茎等体表恶性肿瘤 115 例，其中近期治愈 79 例，有效 12 例，总有效率为 79.1%。有人报道，以“皮癌净”（红砒、指甲、血余）为主治疗浅表肿瘤共 200 例，近期治愈 122 例，治疗中可能有有机砷中毒反应，可配用二巯基丙醇、维生素 C 等，民间以醋制砒砂，治疗食管癌噎膈不通，使呕吐痰涎而渐渐能进食，湖北曾报道，用砒砂制剂配合中药及化学药物治疗食管、胃、肺、子宫、直肠、

肝、鼻咽等恶性肿瘤 334 例，总有效率为 62%。

钩吻，广西民间称为断肠草，广东梅县地区医院用断肠草生物碱制剂综合治疗食管癌、肝癌、宫颈癌、肺癌、胃癌、贲门癌、直肠癌及淋巴造血系统恶性肿瘤共 26 例，除 5 例死亡外，绝大部分患者临床症状均获改善，止痛效果明显，藤黄研究协作组在 1974~1981 年间对 190 例各种恶性肿瘤进行治疗，藤黄注射液每支 100mg（江西制药厂），每次 100~200mg，加至 5% 葡萄糖 250~500ml 内静脉点滴，每周 2~3 次，藤黄片，每片 30mg，每次口服 2~3 片，每日三次。此外，尚有软膏外敷体表肿瘤，藤黄栓剂上宫颈管内，隔日换药一次。结果，肿瘤消失者 7 例，肿瘤缩小超过 50% 者 24 例，肿瘤缩小不及 50% 者 80 例，无效 79 例，总有效率 58.43%。其中对皮肤癌、恶性淋巴瘤、软组织肉瘤、乳腺癌宫颈癌等有一定疗效。以毒攻毒类中成药制剂还有蓖麻毒蛋白、鸦胆子乳剂、狼毒制剂及毛茛、独角莲等，正在临床试用，有待进一步研究。

第七节 其它治疗

祖国医学对恶性肿瘤的治疗，通过辨证施治，除以上常用治法外，针灸、外治及气功控制癌肿的发展以致消除癌肿，预防放、化疗毒副反应，增强患者的免疫力，促进患者康复，亦有重要的作用。

一、外治法治疗肿瘤

用外治法治疗痈、疽、疮、疡是祖国医学的一大特色，通过临床实践，应用外治法治疗宫颈癌、皮肤癌及体表肿瘤，已取得一定疗效。如杨学志报道应用祛腐中医方剂“三品一条枪”（明矾、白砒煅制后加雄黄、没药等）并外用作宫颈锥切治疗早期宫颈癌及癌前病变，临床近期治愈 190 例，长期随访（3~10 年），188 例均健在。刘嘉湘应用新型镇痛橡皮膏——蟾酥膏外

贴，双盲对照临床观察肺癌、胃癌、肝癌及胰腺癌等所引起的多种癌性疼痛共计 332 例，有较好的镇痛效果，总有效率达 92.65%，使用方便，无成隐性和毒副反应，具有活血化瘀，消肿止痛功效。

二、针灸治疗肿瘤

针灸治疗方法作为肿瘤治疗的一种手段已逐步开展，针灸可以平衡阴阳和调整脏腑功能，且可增加抗病能力，提高机体免疫功能。据大量临床研究，的确能使血清中丙种球蛋白明显增高，白细胞计数增多，其吞噬功能亦有增强。针刺足三里可使胃酸和胃蛋白酶水平变低，低水平增高，这就是针灸的双向调节作用。

在恶性肿瘤的综合治疗中，针灸对减轻症状，防止放、化疗毒副反应，均有较好的作用。我们在临床中经常遇到放化疗患者白细胞计数减少，不能顺利进行放化疗，常用地塞米松针 5 毫克、维生素 B₆50mg 或维生素 B₁₂500mg 或 654-2 针 10mg，双侧足三里封闭，并行平补平泻法，一般 3~5 天，白细胞计数即可上升至 $4.0 \times 10^9 / L$ 以上。对胃癌及肝癌患者，呃逆不止，诸法无效时，针刺双侧内关穴，得气后各注入 654-2 5mg，配合服解痉合剂，可收到明显效果。

应用电热针可使热辐射深入机体在一定深度，对皮肤癌及乳腺癌等有一定疗效，通过动物实验，小鼠移植性肿瘤治愈率为 50%，完全消退率为 70%。

三、气功疗法

气功疗法是中国医学遗产的部分，古代医家把气功归纳于“养生”，“吐纳”，“导引”之中，气功是强调内因的整体疗法，通过自我身心锻炼以疏通气血，通经活络，调节脏腑，提高机体抗病能力，达到防病治病、养生延年，翟信长初步探讨气功在癌症防治中的作用，认为气功能提高机体免疫功能，改善癌症病人症状，延长其生存率。上海气功研究所用气功综合治疗 100 例各种晚期癌症病人，显示气功能延长癌症病人生存期，肺癌一年存活

率为 83%，5 年生存率为 28%（对照组男性 12%，女性 10%），目前临床常用的功法有：静功、动功、静动功，静功包括内养功、放松功等；动功有太极导引保健功，易筋功、八段锦、五禽戏、太极拳等，静动功是内养功与动功相结合的锻炼法。具体地说，气功可通过以下几点，发挥其治瘤作用。

1、扶正培本：增强机体抵抗力，目前国内外多数肿瘤学家认为，癌症患者免疫系统功能低下，再加上手术、放疗或化疗，使患者体质更加虚弱，免疫功能低下更为突出。由于气功可以增强体质，提高细胞免疫和体液免疫功能，改善肿瘤病人虚弱和免疫功能低下状态，调动机体的内在抗病能力，以达“正气存内，邪不可干”之目的。随着机体内环境的改善和抗病能力的增强，对提高和巩固治疗效果具有重要意义。

2、活血化瘀：疏通气血，气功动中有静，静中有动，练起来全身气血流注合度，周身十四经脉通畅，使人精力充沛，精气旺盛，可预防和治疗疾病。癌症病人多呈高血凝状态，癌瘤区血液循环障碍，乏氧严重，对药物及放疗多不敏感，气功能疏通气血，改善循环，增加瘤区氧含量，提高药物和放疗效果。

3、调节脏腑功能，癌症患者不仅本身虚衰，而且由于放、化疗及手术治疗，常常使脏腑功能紊乱。特别是胃肠功能障碍，使机体更加虚衰。气功可使肺活量增加，心率减慢等一系列生理变化。

4、直接或间接杀灭或抑制肿瘤细胞，气功不仅能增强肿瘤病人体质，消除免疫低下状态，提高免疫功能，增强吞噬细胞的吞噬能力，增强机体的抗病能力，而且还可以疏通气血，旺盛循环，消除癌瘤病人的高血凝状态，增强药物疗效。

祖国医学认为肿瘤的病因是阴阳失去平衡，气血失和，脏腑功能失调以及毒邪侵袭所致，无论何种原因形成的肿瘤，皆表现为正气虚弱，气血不畅等。由于气功能培补正气，平衡阴阳，调节脏腑等，故在治疗肿瘤中有一定作用。

第四章 抗肿瘤中药研究

第一节 抗肿瘤中草药

目前，用于临床治疗肿瘤的中草药较多，其中，许多药物能减轻肿瘤所致的症状，或使肿瘤缩小，或可延长肿瘤患者寿命，动物实验表明有抗肿瘤（抗癌）的活性；部分药物能直接影响肿瘤细胞的代谢或分裂，抑制肿瘤细胞的增生，部分药物能提高机体免疫机能，间接地发挥抗肿瘤作用。

抗肿瘤药物对于肿瘤这类疾病，通常各有一定的适应范围，临床上应当分别选用。同时需根据不同肿瘤的临床表现，辨证施治，适当配伍其它清热解毒、活血化瘀、化痰散结或攻毒消坚等类药物，并且，还应根据肿瘤发展过程早、中、晚期病情的不同，掌握好“攻”、“补”的主次和先后关系，适当配伍补气补血、补阴补阳等扶助正气药物，调整机体阴阳气血虚实平衡，使机体健康状况改善，无论是对单纯中医药临床抗癌的效果，或者是中西医结合综合治疗的效果，都具有非常重要的意义。国外研究已证实，无论何种疗法（包括手术、放疗和化疗），在机体健康状况差时，疗效也差。临床实践亦证明，如果不注意整体观念，抛开辨证原则，单靠一种或数种抗癌药（或某一种治疗方法），往往不能取得较好的疗效。

另外，抗肿瘤中药中，除补益药外，多属攻泻之类，长期应用时应注意其不良反应。其中某些药物尚有一定的毒性（或剧毒）和副作用，如雄黄、砒霜、轻粉、马钱子、生南星、生半夏、斑蝥、蟾酥等，应严格限制剂量。

一、扶正培本药

凡具有扶助正气、培植本元，治疗虚损不足的药物，称之为

扶正培本药。肿瘤患者常有“内虚”，正气不足而后邪气踞之，且它又是一类全身消耗性疾病，常可因病致虚，另外，临床上常见经过手术、化疗、放疗过后，损伤正气，使虚者更虚，故补虚扶正固本，是治疗肿瘤患者的最重要法则之一。

人参

性味：甘，微苦，温。入脾、肺经。大补元气，补脾益肺，生津安神。

临床应用：①重病、久病及大出血后虚脱，冷汗淋漓，肢冷，脉细弱而微，如独参汤、参附汤等。②肺气虚亏，气短而喘，声低息促，行动乏力，动则气喘，常与黄芪、核桃肉、蛤蚧、冬虫夏草等同用。③脾虚气亏，食少便溏配白术、茯苓等。④气血双亏、心悸自汗，失眠怔忡，可配龙眼肉、枣仁、当归等。⑤热伤气阴，汗出口渴，气短神疲，配麦冬、五味子等。⑥各种癌症手术后康复期，放疗及化疗期间，以及肿瘤患者有正气亏虚时及放化疗所致的白细胞减少者均可应用。

现代研究：主根及侧根均含多种人参皂甙。根据皂甙元的不同可分为：人参二醇、人参三醇和齐墩果叶酸等。还含有糖类、低分子肽和多种氨基酸、胆碱、B族维生素、维生素C、 β -谷甾醇、软脂酸、硬脂酸、亚油酸以及葡萄糖甙、锰、砷等化合物。

人参的药理作用是多方面的。①调节中枢神经系统的兴奋和抑制过程，改善兴奋过程，也增强抑制过程，呈双向调节作用。②抗疲劳，能显著延长小鼠游泳的持续时间。抗放射作用，可使大鼠经X线照后的存活时间延长一倍。③增强机体对有害因素的抵抗能力，增强机体的非特异性抵抗力，属“适应原性”药物。④由人参中提取出的一种甾体化合物对小鼠S₁₈₀及腺癌755有抑制作用。国外药理临床研究发现，它的主要有效成份是Prostisol，具有增强机体特异性免疫的能力，为蛋白质合成促进因子，能促进蛋白质、脂质的代谢，提高机体的免疫能力。有人

将 Prostisol 用于癌的临床，研究发现，Prostisol 对腹水肝癌大鼠的肝及脂肪合成有促进作用，能改善癌宿主的脂肪代谢，而对癌细胞的蛋白质、RNA、DNA 及脂肪合成无影响。说明它并不有助于癌细胞的代谢，而可改变带癌宿主的代谢。还有人将 Prostisol 用于胃癌、胰腺癌、结肠癌、甲状腺癌、肉瘤等。多数病例用本品 1~2 周后，食欲增进，体重增加，临床症状改善，腹水减少，转移灶停止增大。根据对患癌宿主和癌细胞有不同作用，将本品用于癌症的治疗，长期给（约三个月以上）对消化道癌（如胃癌、大肠癌）效果较好。⑤调整内分泌功能：兴奋垂体——肾上腺皮质系统，增强肾上腺皮质功能，提高机体对疾病的抵抗力。促性腺作用，所有人参皂甙类都有促性腺活性。⑥调节代谢功能：降低血糖、调节胆固醇代谢、抑制高胆固醇血症的发生；改善消化吸收功能；增进食欲、促进核糖核酸及蛋白质的合成。使骨髓处细胞生成素的含量升高。还有明显的抗利尿作用，有抗过敏作用。⑦能使红细胞和血红蛋白升高，能促白细胞的生成，防治因放射线治疗和化学药物治疗所引起的白细胞减少。能使淋巴细胞数增加，促进淋巴母细胞转化、增加网状内皮系统功能，提高免疫球蛋白的生成。提高晚期肿瘤患者的细胞免疫功能。

用量用法：3~10g，单煎服。或研末服，每日二至三次，每次 0.6~0.9g。

注意：人参大补元气，甘温峻补，有热象者慎用。反藜芦、畏五灵脂。下午四点钟以后服易引起失眠。服人参腹胀者可用莱菔子或山楂解之。

黄芪（黄耆、棉黄芪）

性味归经：甘、微温。归肺脾经。补气健脾，升阳固表止汗，托疮排脓、消肿生肌、利尿消肿。

主治：①脾虚气亏，倦怠乏力，全身酸软，脾虚腹泻、或中气下陷，久泻脱肛，子宫脱垂。②表虚自汗，或手术后化疗后动

则汗出，配浮小麦、煅牡蛎、麻黄根；表虚恶风汗出，配防风、白术。③气血不足，疮疡内陷、脓成不溃或久溃不敛；④肾炎水肿及蛋白尿，高血压，糖尿病，消渴，冠心病。⑤肿瘤患者体质虚弱时作扶正培本，益气健脾，提高机体免疫机能、及肿瘤患者手术后、放射治疗，化学药物治疗中及恢复期。此外，与当归、川芎、桃仁、地龙等活血化药合用有益气活血，通络利痹的功效。

现代研究：黄芪含有糖类、粘液质，胆碱、甜菜碱、数种氨基酸、香豆素及微量硒等。药理作用：①黄芪对正常心脏有加强其收缩的作用，对因中毒或疲劳而陷于衰竭的心脏，其强心作用更加显著。有扩张冠状血管及全身末梢血管、降低血压、改善血液循环及营养状况的作用。口服或注射黄芪制剂均有明显的利尿作用。②对实验性“肾炎”有抑制作用，能消减蛋白尿。③提高肿瘤患者的免疫机能。据报导，黄芪可以促进机体内的体液免疫，促进脾脏抗体的生成；提高网状内皮系统的吞噬功能；还能保护肝脏，增加白细胞。能提高虚证患者血浆中 cAMP（环磷酸腺甙）、IgM（免疫球蛋白 M）、IgE（免疫球蛋白 E）等的水平。黄芪本身无诱生干扰素的能力，但能提高患者白细胞诱生干扰素的能力。黄芪能降低乙型肝炎表面抗原（HBsAg）滴度或使之转阴。可用于各种类型的肝炎病人，尤其适应于细胞免疫功能低下的慢性持续性（迁延性）肝炎（CPH）和慢性活动性肝炎（CAH）的患者，可增进食欲，改善肝功能，增强细胞免疫。提高淋巴细胞转化率，其水提液在体外对淋巴细胞的增殖具有相当程度的促进作用，对正常人淋巴细胞有明显的促分裂效应；增强 T 细胞的酯酶活性，有利于恶性肿瘤患者的细胞免疫，是一种细胞免疫促进剂。能增加末梢循环中的白细胞。

用量用法：生用或炙用，15～30g，水煎服。

白术（冬术、浙术）

性味功用：苦、甘、温。入脾、胃经、健脾益气，祛湿利

尿，固表止汗，和中安胎。

主治应用：①脾胃虚弱，运化失常所致的饮食减少、消化不良、脘腹虚胀、倦怠乏力。②脾虚浮肿、水饮停留、肾炎水肿、妊娠浮肿、及胎动不安。③表虚自汗。④肿瘤患者手术后气虚、脾胃虚弱、或用于防治因放射线治疗及化学药物治疗引起的消化道副作用。白术挥发油可试用于治疗消化道肿瘤。

现代研究：含挥发油，油中主要含苍术酮、苍术醇。尚含倍半萜化合物、氧香豆素类、糖类、树脂及维生素 A 样物质。药理研究表明：①白术有明显而持久的利尿作用，促使电解质特别是钠的排泄。尚有恢复肾功能消除蛋白尿的作用。②能增加消化液的分泌、缓和胃肠蠕动；有抑制宫缩的作用；降低血糖。③有刺激造血系统增进红细胞及血红蛋白、增进网状内皮系统的吞噬功能。对化疗、放射引致的白细胞减少症有升白细胞的作用。尚能提高淋巴细胞转化率和自然玫瑰花形成率，促进 IgG 的明显提高。动物实验表明体重增加，体力增强、机体免疫力加强。④白术挥发油体外实验对食管癌有明显的抑制作用，对 S₁₈₀ 抑制率为 31%~49%。体内对艾氏腹水癌有较强的抑制作用，体外对艾氏腹水癌有杀灭作用。

用法用量：6~15g，水煎服。

注意：对于胃阴不足、舌苔光剥、津液缺少，唇燥口干者不宜应用。

党参（潞党参）

性味功用：甘、平。入脾、肺经。补中益气、养血。

主治应用：①气虚不足所致的各种病症，有类似人参补气的作用，但较弱，尤其在补益元气，挽救虚脱方面远不如人参。②肿瘤患者手术后体虚气亏，特别是消化道癌手术切除后，表现为四肢乏力，食欲不振，贫血等。③肿瘤患者脾胃虚弱，疲乏无力，大便稀溏，下肢浮肿等，可配黄芪、白术、茯苓、扁豆等，以扶正补气。④治疗血虚心悸、健忘失眠，中气不足等。

现代研究：含皂甙、糖类及微量生物碱和微量元素铁、锰、铜等。党参可使兔的红细胞数升高，白细胞下降，嗜中性细胞增加，淋巴细胞相对减少，口服较皮下注射显著，切除脾脏则此作用基本消失。其补血作用可能与此有关。亦可提高血色素。有增强T细胞功能的作用，能显著增强网状内皮系统功能，其作用与卡芥苗相近，与黄芪、灵芝合用，其增强网状内皮系统作用超过卡芥苗。

用量用法：10～20g，水煎服。

注意：反藜芦，糖尿病患者慎用。有些配合化疗药物升血象的方剂中应用党参，但亦有报道党参能使白细胞减少，故在临床上应加以研究观察。

西洋参

性味功用：甘、微苦、凉。补肺益气，养胃生津，清热泻火。

主治应用：肺胃津亏，阴虚内热，病后少气无力，阴虚咳嗽，咯血，肺痿失音。肿瘤患者气虚而有热者适应，亦可配合放疗时服用。临床上常用于因放、化疗所致白细胞减少症，效果较佳。

现代研究：含五种人参皂甙，水解后分得人参二醇、人参三醇及齐墩果叶酸，另含挥发油、植脂等。西洋参（产于美国、加拿大）补气之功不及人参，而以养阴清热为主。我国已移植成功，名“种参”或“种洋参”。通过研究表明，国产西洋参均含人参皂甙，所含人参皂甙元基本相同。原产西洋参总皂甙的含量平均为7.45%，人参皂甙元的含量平均为1.72%，国产西洋参分别为3.95%和0.83%。

太子参（孩儿参、童参）

性味功用：甘、苦、微温。入肺、脾经。补气养血，健脾生津。

主治应用：用于肿瘤患者病后体虚，疲乏无力，食欲不振

等。或作为放疗、化疗时白细胞减少症的防治。另外，肺虚咳嗽，津液不足，口渴尿多，自汗、盗汗、心悸等症也可应用。作用同人参、西洋参、党参而力较弱，但补而不燥，故肿瘤患者有热象或不受人参、党参之补者，均可用太子参。

用量用法：15～30g，水煎服。

甘草（甜草根、蜜草、粉甘草）

性味功用：甘、平、入十二经，健脾益气，清热解毒，润肺止咳，调和诸药。

主治应用：①用于脾胃虚弱，气血不足，食少乏力，便溏气短。②用于疮疡肿毒，咽喉疼痛，以及药物、食物中毒等症。③咳嗽气喘。④胃疼、腹中挛急作痛，胃十二指肠溃疡等症。⑤有减低或缓和药物烈性的作用，古称调和百药。

现代研究：含甘草甜素，主要为甘草酸的钾钙盐，为甘草的甜味成份。甘草酸水解后生产葡萄糖酸和甘草次酸。尚含黄酮化合物：甘草甙等二十余种。还含有甘味质、树脂等。①从甘草中提得的黄酮甙及甙元，具有解痉和抗溃疡作用。甘草甜素有增加胆汁分泌及抑制胆红素升高的作用。②具有肾上腺皮质激素样作用，促进钠、水潴留。③甘草甜素有解毒作用。④甘草有抗炎，抗过敏作用，甘草次酸有明显的中枢性止咳作用，对5-羟色胺等引起的支气管痉挛有保护作用。⑤抗肿瘤作用：甘草次酸对大白鼠移植骨髓瘤有抑制作用。甘草酸单胺盐、甘草次酸钠及其衍生物等的混合物，对小鼠艾氏腹水癌及肉瘤均有抑制作用。甘草酸单铵盐可对抗喜树碱的毒性，但不降低其抗癌作用。

关于甘草的配伍问题，《十八反》中提出“藻戟遂芫具战草”。研究发现甘草芫花合用有相反作用，二者合浸组的毒性较各单味浸出液的毒性显著增加，且芫花的利尿与泻下作用受到抑制。甘草甘遂配伍，小剂量降低其毒性，大剂量有相反作用。并且还发现，甘草等于或小于甘遂时无相反作用，若甘草大于甘遂量，则有相反作用。

甘草使用过量可引起心脏病和高血压。

用量用法：3~10g，入煎剂。

注意：生用偏凉，清热解毒；炙用偏温，善补虚和中。久服量大可引起水肿。

刺五加（五加、南五加）

性味功用：辛、苦、温。入肝、肾经。补虚安神，益气强肾、壮筋骨。

主治应用：①肾虚咳喘。②气虚乏力，食欲不振。③性机能减退。④补虚扶正。肿瘤患者手术后，放疗及化疗后恢复机体功能及增强抵抗力。

现代研究：含多种甙，尚有多糖。刺五加属于适应原性药物，其药理作用有许多基本上与人参相同。①抗疲劳作用。②增强机体对有害因素的低抗力。③小鼠肝脏部分切除后，刺激肝组织的再生，减少肝脏双倍体细胞的数目。④刺五加对药物诱发瘤、移植瘤和癌的转移，以及小鼠自发白血病都有一定的抑制作用，其作用较人参制剂强而稳定，乙醇提取物还能减轻抗癌药物的毒性，与环磷酰胺一起使用，能增加动物的生存时间及存活率。⑤有抗X线辐射作用。⑥增加机体非特异抵抗力。

用量用法：10~15g，水煎服。现已制成糖衣片，每日三次，每次3片。

参三七（田七、滇三七）

性味功用：甘、苦、温。活血止血，去瘀定痛。

主治应用：①各种出血。②跌打损伤。③无名肿痛。④试用于癌症出血及消肿止痛之用。⑤与丹参合用治疗冠心病。

现代研究：含多种皂甙，经鉴定与人参所含皂甙类似。参三七总皂甙水解后，主要得人参三醇及人参二醇，未检出齐墩果叶酸。另含黄酮甙及生物碱。水煎醇提物能增加冠状动脉血流，降低心肌耗氧量。三七A素有强心及收缩血管作用。动物实验，三七能缩短兔血凝时间。

用量用法：研末 1~2g，吞服。或 6~10g 炖服。

枸杞子（土杞子、地骨子）

性味功用：甘、平。入肝、肾经。滋肾补血，养肝明目。

主治应用：用于肾阴虚，遗精、腰膝酸痛，以及头晕、目眩等症，或肿瘤患者贫血，血色素低，或因放疗、化疗引起的白细胞减少症和贫血等症。有报道用枸杞子与人参、大枣伍用，煎汤代茶饮，对化疗后的肿瘤患者的贫血有升高血色素的效果。

现代研究：含甜菜碱，酸浆红色素，玉米黄质、脂肪油及多种氨基酸、多种维生素、矿物质等，并含铜、锌、铁、锰等微量元素。

用量用法：10~15g，水煎服，或泡酒服。

菟丝子（黄丝、无根草）

性味功用：辛、甘、温。入肝、肾经。滋补肝肾，益精明目。

主治应用：①肾虚腰膝酸软、遗尿、尿频、遗精、肾虚耳聋耳鸣，视力减退，眼花，胎动不安，习惯性流产等症。②白细胞减少症。防治因放、化疗所致的白细胞减少症。

现代研究：种子含树脂样的糖甙、糖及淀粉等，尚含胆甾醇、菜甾醇、豆甾醇、 β -香树精，三萜酸类物质， β -谷甾醇。尚含维生素 A。经贵阳医学院实验证明，菟丝子水煎剂有明显促进淋巴细胞转化的作用。

用量用法：10~30g，水煎服。

补骨脂（破故纸、故子）

性味功用：辛、苦、温。补肾壮阳，暖脾止泻，固精缩尿。

主治应用：①用于治疗骨肉瘤、脑瘤、肾癌及骨转移癌，对因放、化疗所致的血象下降，白细胞减少有提升作用。②脾肾阳虚，五更泻泄有效，如四神丸。③白癜风，补骨脂酒局部涂擦。

现代研究：含挥发油，树脂、香豆素及黄酮类化合物。香豆类衍生物有：补骨脂内酯、异补骨脂内脂（白芷素）、补骨脂

定。黄酮类化合物有：补骨脂甲素、补骨脂乙素、补骨脂醛及补骨脂宁等。补骨脂挥发油有抗肿瘤作用，补骨脂乙素对 S_{180} 、艾氏腹水癌有抑制作用。国外用于癌前病变（白斑病的治疗）。

用量用法：6~10g，水煎服。阴虚火旺者，孕妇不宜用。尿血、便秘者、急性泌尿系感染而尿频者不宜用。

淫羊藿（仙灵脾）

性味功用：辛、甘、温。补肾壮阳，强筋壮骨。

主治应用：①肾虚阳痿，遗精早泄，肢冷性凉，腰腿酸软。

②用于防治因化疗所引起的骨髓抑制和免疫抑制。

现代研究：含挥发油、甾醇、淫羊藿甙、脂酸等。提取物有雄性激素样作用，促进精液分泌。有抗病毒及抑菌作用。本品能促进淋巴母细胞的转化作用，提高 T 细胞比值。增强白细胞及巨噬细胞活性，因而提高肿瘤患者的免疫功能。

用量用法：6~12g，水煎服。

百合

性味功用：甘、平。入心肺经。润肺止咳清心安神。

主治应用：治疗肺癌咳嗽、痰中带血，舌红少苔等肺阴不足之证。亦用于乳腺癌、宫颈癌、食管癌、胃癌、皮肤癌、恶性淋巴瘤、白血病等有心烦、失眠者。亦用于肺燥肺热、热病后余热未清、虚烦不寐有所谓“百合病”者。

现代研究：百合含秋水仙碱等多种生物碱，以及淀粉、蛋白质、脂肪。对小鼠 S_{180} 、 U_{14} 有抑制作用。秋水仙碱能抑制癌细胞的增殖，临床上用以治疗癌症，特别是乳腺癌有一定疗效。有镇咳作用，并能对抗组织胺引起的蟾蜍哮喘。

用量用法：15~30g，水煎服。或蒸食、煮粥食用。

玉竹（葳蕤）

性味功用：甘、平、微寒。养阴润燥，生津止渴。

主治应用：治疗各种癌症患者因放疗后出现的阴亏津涸症候。化疗后气阴两虚者亦常用，尤适用于热病伤阴，肺胃阴伤之

证。亦常用于治疗肺癌、鼻咽癌、食管癌、胃癌、白血病、恶性淋巴瘤等具有阴亏液乏者。

现代研究：主要含有粘液质，系多聚糖。本品能调节机体免疫力，增强网状内皮系统吞噬功能，抑制癌瘤生长。

用量用法：10~20g，水煎服。

胡桃

性味功用：涩、甘、温。肉润皮涩。肉及里壳敛肺定喘，固肾涩精，温肺补肾。

主治应用：核桃树细枝条及其各种制剂，试用于多种癌症，如肺癌、食管癌、胃癌、肠癌、乳腺癌、宫颈癌、肝癌及淋巴和造血系统恶性肿瘤。亦用于软组织肉瘤。临床上观察到能改善晚期癌症患者的一些症状，增进食欲，个别有瘤体缩小或控制发展作用。配合放、化疗比单用效果好。民间曾以核桃树枝煮鸡蛋试用于各种癌症。果仁主用于肺肾气虚咳喘者。

现代研究：仁含亚油酸、油酸、亚麻酸甘油酯，蛋白质、碳水化合物及微量元素。外果青皮含胡桃醌、黄酮甙、鞣质及没食子酸等。动物试验胡桃青皮对肿瘤有抑制作用。对肉瘤 S₃₇ 有抑制作用。

用量用法：树枝 15~30g，水煎服。或制成各种制剂。

山茱萸（山萸肉、枣皮）

性味功用：酸、苦、微温。补肝肾，强身体，涩精，敛汗。

主治作用：①肿瘤患者肝肾不足，头晕耳鸣，腰酸目眩等。②放化疗后白细胞减少症，配女贞子、鸡血藤等。③癌性患者盗汗、虚汗不止。

现代研究：含莫罗妨冬甙，当药甙，山茱萸甙，番木鳖甙。尚含熊果酸、酒石酸、草果酸、没食子酸。有明显的利尿作用，降血压作用。抗菌作用。动物实验证明：对放化疗所致白细胞减少有升提作用。体外试验，山萸肉能杀死腹水癌细胞。

用量用法：10~15g，水煎服。敛汗时可用至 30g。治大汗

亡阳，阴虚阳浮或阴阳俱虚引起的暴脱症，因药力较缓，重症宜用较大剂量（50~100g）并与人参、附子、龙骨、牡蛎等同用。

五味子

性味功用：酸、甘、温。敛肺、补肾、养心安神、止汗生津。

主治应用：肿瘤患者体虚多汗、口干、脉弱，特别是肺癌手术切除后的患者，或肺虚咳喘患者。对术后或放化疗后出现气阴两虚时，常配西洋参、麦冬等。对于肝炎或化疗药引起血清转氨酶高，常用五味子粉冲服，有降酶作用。

现代研究：含挥发油、维生素、有机酸、木脂素等多种成份。其中，木脂素系五味子素及它的类似物为本品的有效成份。本品有祛痰、镇咳、抗菌、降转氨酶，提高大脑皮质的工作能力及感受器的感受性能。本品无直接抗肿瘤作用。

用量用法：6~9g，水煎服。降转氨酶时用粉或蜜丸，每日三次，每次约3~5g。

地黄

性味功用：干生地：甘、凉。滋阴养血。熟地黄：甘、微温，养血补肝肾。鲜生地：甘、苦、寒。清热凉血，生津。

主治应用：①肾阴不足，低热盗汗，消渴、手足心热。②阴虚火旺，骨蒸潮热。③贫血。④血热出血、咯血、吐血、衄血、热病热入营血。⑤晚期肿瘤患者有阴虚，肝肾不足及血虚者。凉血止血用鲜品，滋阴降火用干生地，养血补肾用熟地。

用量用法：10~30g，水煎服。本品腻胃，可配砂仁，脾虚慎用。

当归

性味功用：甘、辛、温。补血养肝，活血调经。

主治应用：①凡肿瘤患者有血虚，血滞经闭。②外科用以治痈疽疮疡，能消肿排脓，活血止疼。③血虚肠燥，大便秘结。

现代研究：含挥发油、维生素 B₁₂、 β -谷甾醇、脂肪酸、亚叶酸、菸酸及生物素等。当归对子宫具有双向调节作用，有镇静、镇痛和抗炎作用。有保护肝脏，防止肝糖元减少，抗贫血作用。有补血与活血双重作用。量大则活血，具有免疫抑制作用，用量小则补血，具有免疫促进作用。

用量用法：3~15g，水煎服。

白芍

性味功用：苦、酸、微寒，养血柔肝，敛汗止痛，调和营卫。

主治应用：①肝胃不和，脘腹疼痛。肝阴血虚，肝阳上亢症。②营卫不和，自汗盗汗。

现代研究：含芍药甙等成份。芍药甙对中枢神经系统有抑制作用，具有镇静、解痉及抗炎作用。

用量用法：10~30g，水煎服。反藜芦。

沙参（南沙参、北沙参）

性味功用：甘、苦、微寒。润肺止咳，养阴生津。

主治应用：①肺癌阴虚咳嗽。②肺癌消化道肿瘤手术后气阴两虚，口干舌红光无苔，肺胃阴虚者。③放疗时气阴耗伤，口干舌燥，疲乏无力或放射性肺炎。

现代研究：南沙参含皂甙及香豆素（花椒毒素）。花椒毒素对艾氏腹水癌及肉瘤 45 抑作用最大，花椒毒素稀释至 1:10000 可抑制生长 50%。北沙参含生物碱，南北沙参作用相近，唯北沙参养阴生津力较强，有外感者不宜。南沙参润肺化痰之功较胜，兼有风热感冒肺燥者宜用。二者也可合用。

用量用法：15~30g，水煎服。

女贞子（冬青子）

性味功用：甘、苦、凉。滋补肝肾，乌发明目。

主治应用：①肝肾阴虚所致头晕耳鸣，腰膝酸软，目眩眼花，须发早白等。②放化疗时引起的白细胞减少症。③肾癌、骨

癌、脑瘤、白血病可试用。

现代研究：含女贞子甙、齐墩果甙、齐墩果叶酸等。煎剂有抗菌作用，水浸剂能抑制动物某些移植性肿瘤的生长，水提剂在体外能明显促进淋巴细胞增殖，对肿瘤患者和正常人淋巴细胞引起的大鼠局部移植物抗宿主反应有增强作用。试验及临床证明，对放化疗引起的白细胞减少有提高和保护作用。

用量用法：15~30g，水煎服。

注意：本品性凉，有润肠缓泻作用，脾虚便溏者慎用。

龟板（败龟板、下甲）

性味功用：甘、咸、寒。滋阴潜阳，益肾健骨、退蒸。

主治应用：①阴虚内热或阴虚阳亢、或热病伤阴等症。②龟板胶用于阴血亏少，贫血或血小板减少，白细胞减少症。③肿瘤患者阴虚血少伴有痞块者。

现代研究：含骨胶原，其中有多种氨基酸、甾类化合物及钙磷等。龟板筛取物对 S_{180} 、EAC 腹水型肝癌有抑制作用。龟板还能提高机体的免疫能力，有利于肿瘤患者。

用量用法：15~30g，水煎服。

鳖甲（甲鱼壳、团鱼甲、上甲）

性味功用：咸、平。滋阴潜阳，软坚散结。

主治应用：①阴虚内热，盗汗、贫血、血小板减少等症。②症瘕痞母，肝脾肿大。③癌症患者有阴虚低热者。

现代研究：含量骨胶原、蛋白、碘、钙盐，本品能抑制结缔组织的增生，提高血浆蛋白，延长抗体存在时间，提高机体免疫能力。鳖肉与胶质有滋补强壮营养作用。

用量用法：15~30g，水煎服。

鸡血藤

性味功用：甘、平、微温。补血活血，舒筋通络。

主治应用：①贫血。②放化疗所引起的白细胞减少症。

现代研究：含无羁萜等。对实验性贫血的家兔有补血作用。

有报道鸡血藤在体外对癌细胞有抑制作用。临床研究有提升白细胞的作用。

用量用法：15~30g，水煎服。

天门冬（明天冬、天冬）

性味功用：甘、苦、寒。养阴生津，润肺止咳。

主治应用：①阴虚肝热，干咳少津，痰中带血的肺癌患者。
②放疗时口干津少，或放射性肺炎。③试用于乳腺癌、食管癌、胃癌、肝癌等。

现代研究：块根含天冬酰胺， β -谷甾醇、聚糖类。有抗菌、镇咳、祛痰、平喘及止血作用。对小白鼠 S_{180} 有抑制作用。体外试验表明，对急性淋巴细胞白血病、急性单核细胞白血病及慢性粒细胞型白血病白细胞的脱氢酶有一定抑制作用。

用量用法：10~20g，水煎服。

云芝（白山云芝）

性味功用：甘、平。滋补强壮。

主治应用：各种癌症患者有细胞免疫机能低下者适用。与放化结合可提高疗效。

现代研究：含脂肪、蛋白质、多糖类。云芝中提取的蛋白质多糖类物质 PS-K 对小鼠 S_{180} 有强烈的抑制作用，口服 600ml/Kg 的抑制率达 99.3% 口服或腹腔注射 PS-K，可延长肝癌腹水型 AH-13 大鼠的存活期。作用机制可能是增强机体免疫功能。在体外培养中。云芝多糖能明显地刺激淋巴细胞转化为淋巴母细胞。云芝多糖在体内抗癌谱广，特别能抑制对烷化剂有耐药性的 AH-7974、A-66F、或 L1210、P388 和腺癌 755 瘤株。云芝多糖与放疗合用，可增强对射线的敏感性，减轻射线的副作用。据实验报道，与丝裂霉素 C、环磷酰胺，FT-207、阿霉素等并用，可显著提高疗效，减轻毒副反应。动物实验证明，PS-K 对移植于小鼠皮下的肉瘤有显著的抑作用，对肉瘤₁₈₀ 效果比丝裂霉素 C 和香菇多糖多 10 倍。实验观察到，云芝多糖具

有使荷瘤宿主降低了的免疫力恢复至接近正常的特点，似有消除免疫抑制物质以恢复癌机体免疫功能的作用。是免疫增强剂。

用量用法：云芝多糖注射液，肌肉注射，日本亦有制剂PS-K作临床试用。

二、清热解毒药

凡以清解热邪，祛除肿毒为主要作用的药物，称为清热解毒药。临床常用于治疗各种热毒证，如痈疮、丹毒、斑疹，咽喉痹及毒痢等。肿瘤之成，肿毒淤结，毒热内蕴，化火化热者居多，故常需投以清热解毒之剂，特别是对各种肿瘤并发感染者。这类药目前已经过许多动物筛选或其他实验方法研究，具有一定下的抗肿瘤作用，故在肿瘤临床上应用普遍。

本类药物性味多苦寒，久服能损伤脾胃及阳气，故脾胃虚弱者须慎用，或伍用其他健脾扶正药以制之。

白花蛇舌草

性味功用：甘、淡、微苦、凉。清热解毒，消痈活血，利湿。

主治应用：①用于各种癌症，如胃癌、食道癌、肝癌、淋巴瘤、宫颈癌、喉癌等。②各种感染，如上呼吸道感染，尿路感染、急性阑尾炎、急性肝炎等。③肠痈及疮疖肿毒，咽喉肿痛，毒蛇咬伤等。以上治疗常需与其他药配伍应用。

现代研究：含生物碱，熊果酸、齐墩果叶酸，三萜酸类，多糖及“白花蛇舌草素”等。动物实验，体内体外对多种肿瘤均有显著抑制作用。本品能显著增强机体的免疫力，表现为网状内皮系统的显著增生，巨噬细胞增生肥大，胞浆丰富，吞噬活跃，肠系膜淋巴结、脾脏、肝脏等组织中嗜银物质呈致密化改变，显示机体在免疫过程中防御机能增强，恶性肿瘤其癌巢如果有嗜银物质包裹，则其浸润、转移均较困难，甚至使之不可能，这对肿瘤患者的治疗有较大意义。对机体免疫亦有增强作用。

用量用法：30~60g，鲜品可90~120g，水煎服。亦可制成

其他制剂应用。

半枝莲

性味功用：辛、苦、寒。清热解毒，利尿消肿。

主治应用：①用于各种癌症，配伍其他抗癌中草药应用。②传染性肝炎，肝硬化腹水，肾炎水肿，配伍其他药应用。③热毒痈肿，虫蛇咬伤，内服或外用。

现代研究：含生物碱，黄酮甙，酚类及甾体。体外试验，对动物肿瘤，急性粒细胞性白血病，人体子宫颈癌细胞株系均有抑制作用。

用量用法：30～60g，水煎服。

龙葵

性味功用：苦、微甘，寒。有小毒。归肺、胃、膀胱经。清热解毒，利尿散结。

主治应用：①用于治疗多种癌症：肺癌、胃癌、肝癌、膀胱癌及滋养叶细胞瘤等。对癌性胸腹水有一定疗效。②治疗水肿及小便不利。

现代研究：含甙类甾体生物碱，数种龙葵碱，以及其游离的甙元溴茄胺，并含皂甙，维生素A、C等。动物实验有抗肿瘤作用。还能降低血管通透性及透明质酸酶的活性。对动物的过敏性、组织胺性休克有某些保护性作用；还能促进抗体形成。据报道，久服，量大可引起白细胞下降及肝功能损害。过量还可引起头痛、腹痛、呕吐、腹泻，瞳孔散大，甚至昏迷等毒性反应。

用量用法：15～30g，水煎服。

七叶一枝花（重楼、蚤休）

性味功用：苦、微寒，有小毒，清热解毒，消肿止痛，散瘀定惊，止咳平喘。

主治应用：①用于各种癌症，如肺癌、肝癌、胃癌、乳腺癌、脑瘤、恶性淋巴瘤、白血病等，并止癌痛。常配伍石见穿、半枝莲、龙葵、山豆根等同用。②用于热疔疮肿毒；③毒蛇咬

伤。④咽喉肿痛。⑤小儿高热抽搐等症。

现代研究：含甾体皂甙，其皂甙元为薯蓣皂甙元。有抗菌消炎作用。煎剂或乙醇提取物对组织胺喷雾所致豚鼠气管痉挛有明显保护作用，并有止咳作用，抑制率40%~50%。对实验型肝癌亦有抑制作用。蚤休甙有镇静镇痛作用，薯蓣皂甙及其甙元是合成激素及避孕药的原料。

用量用法：10~15g，水煎服。外用研粉，用醋、酒或水调敷患处。本品有小毒，中毒时恶心、呕吐、头痛，严重时可引起痉挛，可予洗胃、导泻及内服米醋、生姜汁、甘草水等。

土茯苓（仙遗粮）

性味功用：甘、淡、平。归经。解毒消肿，祛湿通络。

主治应用：①试用于泌尿系肿瘤，消化道肿瘤，肝癌等。②用于关节酸痛、筋骨拘挛，风湿性关节炎。③用于湿热疮毒。

现代研究：根茎含多种甾体皂甙，生物碱、挥发油、糖类等。有抑制 S_{180} 及人类宫颈癌细胞生长的作用。并有解毒利尿作用。

用量用法：30~60g，水煎服。外用研末调敷。

了哥王（九倍草、岭南芫花）

性味功用：苦、辛、寒，有毒。入肺经。清热解毒，消肿散结，祛湿化痰。

主治应用：①治疗恶性淋巴瘤、乳腺癌、肺癌，对癌性胸腹水有一定利尿作用。②用于疔疮肿毒。③治疗上呼吸道炎症。④治疗风湿性关节炎。⑤跌打损伤，虫蛇咬伤（外用）。

现代研究：含南芫甙、西瑞香素、羟基芫花素，另含树脂酸、甾醇、挥发油，其树脂有强烈的泻下作用，尚有一种对皮肤有强烈刺激性的成份，有抑菌作用。水煎剂对小鼠淋巴肉瘤I号腹水型、 S_{180} 、 U_{14} 有抑制作用。羟基芫花素有祛痰止咳作用。

用量用法：10~15g，水煎三小时服。外用研末调敷，或用鲜叶捣烂敷患处，或水煎洗。

注意：本品有毒，水煎三小时服，以减其毒性。如出现中毒症状（剧烈恶心、呕吐、腹泻、头晕、咽干等）须及时解救，重则洗胃，饮浓茶、服活性炭或鞣酸蛋白，并大量饮用盐水，或静脉滴注葡萄糖生理盐水及其他对症治疗。

天葵子（紫背天葵）

性味功用：甘、苦、寒，有小毒。清热解毒，消肿散结。

主治应用：①试用于肿瘤，常与半枝莲、白花蛇舌草等合用，治疗肺癌、乳腺癌、食管癌、膀胱癌宫颈癌、恶性淋巴瘤。②痈肿疔疮、急性感染，如五味消毒饮。③淋巴结核。

现代研究：含生物碱、内酯、香豆精类、酚类等。对金葡菌有抑制作用，对 S_{180} 有抑制作用。

用量用法：15~30g，水煎服。本品清热解毒，消肿散结之力强，常用于治疗多种实体瘤及肿瘤患者有并发症感染者。亦常用于泌尿系统肿瘤及癌性胸腹水，因其有利尿作用。

广豆根（山豆根、苦豆根）

性味功用：苦、寒。归经，清热解毒，消肿利咽。

主治应用：①用于癌症，主要用于治疗食道癌、肝癌、喉癌、舌癌等。②用于咽喉齿龈肿痛。

现代研究：根含总生物碱约 0.93%，其中以苦参碱、氧化苦参碱为主，还含有黄酮类化合物紫橐素和三叶豆橐甙及山豆根素等多种化合物。动物及临床观察，对多种癌症有一定抑制作用，对白血病细胞亦有抑制作用。能促使吞噬细胞数增加，同时有抗霉菌及球菌作用。广豆根总碱有对抗多种型心律失常的作用，为“广谱型”抗心律失常药。

用量用法：6~10g，水煎服。一般剂量对胃无刺激作用，超过 30g 能引起中毒而发生呕吐、腹泻、胸闷、心悸等。

水杨梅根

性味功用：苦、涩、凉。入胃、小肠经。清热解毒，散瘀止痛，祛风利湿。

主治应用：①治疗消化道癌，淋巴肉瘤，宫颈癌。常用石见穿、龙葵、白英、半枝莲、藤梨根等伍用。治疗宫颈癌与漏芦、莪术等伍用。

现代研究：根浸膏动物试验对癌细胞有抑制作用。

用量用法：15~30g，水煎服。

凤尾草

性味功用：微苦、寒。入肾、胃经。清热利湿，解毒凉血。

主治应用：①试用于胃肠道肿瘤、肺癌、肝癌、乳腺癌及各种肿瘤。②用于菌痢肠炎、咽喉肿痛、尿血、便血、痔疮出血。③用于癌性发热、癌性感染、癌性胸腹水、癌性出血等有效。④治疗黄疸性肝炎、湿热带下等症。

现代研究：含鞣质、黄酮类、甾醇、氨基酸、酚类物质，有抑菌作用，对小鼠 S_{180} 、 S_{37} 有抑制作用。

用量用法：15~30g，水煎服。

白英（蜀羊泉、白毛藤）

性味功用：微苦、寒，有小毒。归肝、胆、胃经。清热解毒，祛风利湿。

主治应用：①治疗各种癌症，以胃肠道癌及肝癌、肺癌、膀胱癌、乳腺癌、宫颈癌为主，与龙葵、蛇莓合成龙蛇羊泉汤，为治疗各种癌症的基本方之一。②用于治疗湿热黄疸，湿热带下，宫颈糜烂等。③风湿痹痛。

现代研究：含甾体生物碱、白英碱等，对小白鼠肉瘤 S_{180} 和大鼠瓦克氏癌₂₅₆ 有显著抑制作用。对人体肺癌也有抑制作用。有抗菌及抗霉菌作用。

用量用法：15~30g，水煎服。

注意：①剂量过大易引起咽部灼热及恶心呕吐、眩晕，甚至瞳孔散大，肌肉抽搐等中毒反应。②马兜铃科的寻骨风亦称白毛藤，但系两种不同植物，应加以区别。

冬凌草

性味功用：苦、甘、凉。清热解毒，活血化瘀。

主治应用：①用于食管癌、贲门癌、肝癌、乳腺癌有一定缓作用，与化学药物合用可增加疗效。②亦用于治疗急性咽炎、慢性咽炎、扁桃体炎、腮腺炎、气管炎、慢性迁延性肝炎等。

现代研究：含挥发油、生物碱，苦味成份，黄酮及多种萜类化合物，其中分离出冬凌草甲、乙、丙、丁及戊素。本品煎剂及醇剂体外试验证明，有明显的细胞毒作用，醇剂的作用大于煎剂，不论口服或注射动物实验均有明显的抗肿瘤作用。冬凌草制剂对食管癌前病变转变为癌有明显的抑制作用。与丙亚胺、乙亚胺合用，可加强它们在动物实验肿瘤 S_{180} 、 S_{37} 中的抗肿瘤作用，但毒性未见增加。还有明显的抗菌抗炎作用；可降低家兔食管张力，对乙酰胆碱引起的食管痉挛有明显解痉作用，故有一定的止痛作用。

用量用法：生药单用 30~60g，水煎服。也可制成各种制剂应用。少数病人服后有腹痛、腹泻、恶心、呕吐等。

蛇莓

性味功用：甘、酸，寒，有小毒。清热解毒，散结消肿。

主治应用：①治疗多种癌症，常用白英、龙葵合用，适用于癌症之实热型。②颈淋巴结核、疔疮肿毒、蛇虫咬伤。③痢疾肠炎。

现代研究：含有烃、醇和甾醇，种子含亚油酸。动物实验有抗肿瘤作用。对金葡菌和多种杆菌有抑制作用。

用量用法：15~30g，水煎服。

农吉利（野百合）

性味功用：苦、淡、平，有毒。清热解毒，消肿散结。

主治应用：恶性肿瘤。主要外治皮肤癌，阴茎癌、宫颈癌，也用于直肠癌、食道癌、白血病等。

现代研究：含农吉利甲素（即野百合碱），有抗肿瘤作用，对 S_{180} 抑制率为 64%， S_{37} 为 63%，对 W_{256} 疗效更为显著，对

L₆₁₅ 亦有抑制作用。野百合碱口服吸收迅速，由尿中排出，对肝、肺、肾有毒性。半胱氨酸和蛋氨酸对其有解毒作用。农吉利甲素为双调吡咯类，其抗癌作用与烷化剂相似。

农吉利甲素急性毒性试验，小白鼠腹腔注射 LD₅₀ 为 296±51mg/kg，静注可引起肝细胞坏死，肝肿大、黄疸、腹水，甚至死亡；农吉利甲素亚急性毒性试验，主要对消化道、肝、肾有损害，如食欲不振、粪便潜血阳性。大剂量谷丙转氨酶呈进行性升高，小剂量无明显升高。可见尿内出现红、白血球及透明管型。见肾小球、肾小管有不同程度的损害，严重者有坏死现象。

用量用法：10~15g，水煎服。或制成各种制剂用。

注意：肝、肾功能异常者、孕妇忌用。

八角金盘（八角莲）

性味功用：甘、微辛，苦、凉，有小毒。清热解毒，散结祛瘀。

主治应用：①用于癌症，如乳腺癌、皮肤癌及直肠癌等。②治疗瘰癧结核、腮腺炎等。

现代研究：含鬼臼毒素，去氧鬼臼毒素，紫云英甙、金丝桃甙、槲皮素等。其中鬼臼毒素能抑制中期的有丝分裂，对体外瘤细胞和多种移植性肿瘤均有抑制作用，其中包括急性白血病、淋巴肉瘤、腺瘤及黑色素瘤。但毒性大，主要用于皮肤癌。现合成或半合成了一些化合物，毒性较低。其中鬼臼酸乙肼（SP2）用于乳腺癌、膀胱癌、皮肤癌注射用。鬼臼毒苯亚甲基甙（SPG），可口服，用于消化道癌。抗癌作用部分也有溶血作用。

用量用法：3~10g，水煎服。孕妇忌服。外用：研末加酒、醋调敷局部，治疗乳腺癌、皮肤癌。

肿节风（九节茶、草珊瑚）

性味功用：苦、辛、平，有小毒。清热解毒，活血散瘀。

主治应用：①治疗消化道癌、食管癌、胰腺癌、胃癌、肝癌、肠癌及脑瘤等，可使肿瘤体缩小，症状减轻并能延长缓解

期。对妇科肿瘤及何杰金氏病临床效果不明显。②跌打损伤，关节疼痛，与活血药同用。③用于流感、肺炎、急性阑尾炎、胆囊炎、脓肿等与其他清热解毒药同用。

现代研究：叶含挥发油、酚类、黄酮甙、甾甙、香豆素、内酯、鞣酸。本品体外试验，对金葡菌、疾病杆菌、伤寒杆菌、副伤寒杆菌、大肠杆菌及绿脓杆菌均有较强的抑制作用。叶的作用大于枝茎，鲜品强于干品。本品还有祛痰和平喘作用。对实验动物肿瘤 S_{180} 、 W_{256} 、 L_{615} 、 Tm_{755} （腺瘤₇₅₅）有抑制作用。

用量用法：15~30g，水煎服，也可制成片剂或注射剂用。

牛蒡子（牛子、鼠粘子）

性味功用：辛、苦、寒。归肺、胃经。清热解毒，散风利咽，透疹止痒。

主治应用：①用于风热感冒，配合其他疏风清热药用。②用于咽喉肿痛，配豆根、桔梗等清热利咽药。③用于治肿瘤，配其它抗肿瘤药，可用于喉癌，肺癌，食管癌，恶性淋巴瘤等。

现代研究：含牛蒡子甙及脂肪油，维生素 A、维生素 B_1 及生物碱等。对金黄色葡萄球菌，皮肤真菌有抑制作用，有利尿、解热作用，牛蒡甙有通便治疮毒之效。牛蒡子中分离出一种广谱抗癌物质牛蒡酚，对 S_{180} 、 S_{37} 等有一定抑制作用，用 500mg/kg 十天后可抑制小鼠 S_{37} 的 59% 和小鼠艾氏癌的 37% 生长。用 450mg/kg，九天后可抑制 50% 的 NK 淋巴生长。对人子宫颈癌细胞培养株系 JTC-26，体外筛选，有抑制作用，抑制率在 90% 以上。

用量用法：10~15g，水煎服。

注意：气虚便溏有燥痰者、孕妇慎用。

石上柏

性味功用：微甘、平。归肺、大肠经。清热解毒，活血消肿。

主治应用：①常用于鼻咽癌、喉癌，肺癌，绒毛膜上皮癌，

恶性葡萄胎等，与放疗、化疗合用，有协同作用。②用于湿热黄疸，胆囊炎，肝硬化等退黄和改善肝功能。③用于治疗上感，咽喉肿痛等症。

现代研究：含生物碱，甾醇、皂甙及少量还原性物质。对 S_{180} 、 U_{14} 、小鼠白血病 L16 有抑制作用。能延长实体型肝癌小鼠的生存期，并能增强肾上腺皮质功能，增强机体代谢和网状内皮系统的功能，亦有抗菌消炎作用。

用量用法：15~30g，水煎服。有制成各种制剂应用者。

苦参

性味功用：苦、寒。入心、肝、小肠、大肠、胃经。清热燥湿，祛风杀虫。

主治应用：①用于湿热黄疸，泻痢，白带；②用于皮肤瘙痒，脓疱疮，疥癣、麻风诸症。③治疗湿热重的癌症患者，可用于绒毛膜、恶性葡萄胎、宫颈癌、肺癌、肠癌、胃癌、肝胆系统癌及皮肤癌、膀胱癌等。④对急慢性肾炎水肿、心律不齐，有利尿及抗心律失常的作用。

现代研究：含苦参碱，氧化苦参碱等多种生物碱及其他成份。有抑菌作用，苦参碱对痢疾杆菌，大肠杆菌、变形杆菌，金黄色葡萄球菌有较强的抑制作用。对慢性宫颈炎有确定的疗效，对老年阴道炎、滴虫性阴道炎等有一定疗效，对晚期血吸虫病（腹水）有一定疗效。苦参碱在体外和体内对小鼠艾氏腹水癌及小鼠肉瘤₁₈₀均有抑制作用，氧化苦参碱对 S_{180} 有抑制作用，认为：较丝裂霉素大数倍。苦参碱对移植性 S_{180} 的小鼠有延缓死亡的效果。苦参烯碱（槐根碱，槐定、西豆根碱甲）对肉瘤₁₈₀、 U_{14} 及淋巴肉瘤有一定的抑制作用。从苦参碱中提得的总黄酮有抗心律失常的效果。

用量用法：一般 3~10g，重症 24~31g，水煎服。

狗舌草

性味功用：苦、寒。清热解毒，利尿消肿。

主治应用：用于白血病，网织细胞肉瘤，常与猪殃殃、牛舌草、白花蛇草等同用。②用于尿路感染、肾炎水肿等。③用于肺热咳嗽，肺脓疡，疖肿疮疡等。

现代研究：根含生物总碱。在体外试验中，对白血病细胞有较强的抑制作用，故又名血癌草。阔叶狗舌草碱有解毒作用。

用量用法：15~30g，水煎服。

大黄（川军）

性味功用：苦、寒。入脾、胃、大肠、心包、肝经。清热解毒，攻积导滞，泻火凉血，活血祛瘀，利胆退黄。

主治应用：①用于胃肠实热结滞，腹胀，便秘发热苔黄脉数等证候。②用于急性单纯性肠梗阻、急性胆囊炎、急性阑尾炎、急性病毒性肝炎等，配清热除湿药、退黄药及行气止痛药，效果良好。③用于血热妄行之吐血、衄血、皮下出血等配以其他凉血止血药同用。④用于各种瘀血阻滞如产后腹痛、跌打损伤，症瘕积聚等常与活血止痛药伍用。⑤肿瘤患者具有实热毒结者。常用于消化道肿瘤及其所致便秘者。

现代研究：①本品含蒽醌类衍生物（大黄素、芦荟大黄素、大黄酸、大黄去甲醚、大黄酚）及鞣质（葡萄糖没食子鞣甙、儿茶物质、游离没食子酸），还含蒽醌甙、双蒽酮甙。有抗菌作用，对多种致病菌有较强的抑制作用。②有抗癌作用：大黄素及大黄酸每日腹腔注射 50mg/kg，给药 21 天，对大鼠黑色素瘤的抑制率分别为 70% 和 73%，大黄素每日腹腔注射 75mg/kg，对小鼠乳腺癌抑制率为 40%。其抗癌机理是抑制癌细胞的呼吸，对癌细胞的溶解有明显的抑制作用，抑制氨基酸的糖代谢产物的氧化和脱氢，影响供能系统，并与 DNA 结合抑制 DNA、RNA 和蛋白质的生物合成。③大黄有止血作用，使止血时间缩短，吸收热消退快，治疗上消化道出血效果明显，能促进胃肠蠕动全不促进胃和十二指肠蠕动，所以对胃十二指肠溃疡病灶无害，对营养吸收无妨，因此，对腹泻无顾虑，凡不适应外

科手术治疗的内科适应症患者的急性消化道出血均可用大黄止血。肝硬化食道静脉曲张破裂出血者例外。④大黄鞣质对血清和肝组织中的尿素氮的作用，给予后4小时显著降低，8小时后降低30%，其降低血尿素氮（BUN）的作用是由于抑制蛋白的分解以及从氨到谷酰胺生成的再利用亢进的结果。⑤促进胆汁分泌，有利胆排石和增进消化的作用。

用量用法：3~12g，水煎服。

注意：泻热通便用生大黄，后下，出血用大黄炭，缓泻用制大黄。外用研粉末，治跌打损伤用姜汁敷，治痈疽醋调敷，治烧伤烫伤蜂蜜调敷，大量能荡涤肠胃积滞，清泻血分实热。治肿瘤需根据情况配合软坚散结，活血理气药。本品生用泻下，抗癌及泻下力强。本品服后可引起腹痛，尿色红染。孕妇体弱者，产后经寒腹痛、血枯经闭、脾虚便溏者均忌用。

黄芩（枯芩、条芩、黄金茶）

性味功用：苦、寒。归肺、胆、胃大肠经。清热解毒，泻火凉血。

主治应用：本品为清上焦、中焦及肝胆湿热邪火的常用药，以泻肺热为主。①治疗肺热肺痈，血热妄行，疖肿疮疡等症。②用于肺癌、肝癌、肠癌及其它肿瘤具有热毒症候者。③配甘草可防治放射性肺炎。④治疗温病高热、烦渴、湿热泻痢，黄疸等症，可配伍其他药应用。

现代研究：根含黄芩甙、黄芩素、汉黄芩甙、汉黄芩素及黄芩新素等物质。体外抗菌试验对多种细菌、流感杆菌、皮肤真菌有抑制作用，动物试验有解热、镇静、降压、利胆、利尿和降低毛细血管的通透性、抑制肠管蠕动等作用。黄芩素尚有抗肿瘤作用。

用法用量：10~20g，水煎服。

青黛

性味功用：咸，寒。归肝经。清热解毒，凉血消斑。

主治应用：①治疗慢性粒细胞白血病。②热盛出血、咳血、衄血、吐血、丹毒、腮腺炎、带状疱疹、天疱疮等。③肺热咳嗽。④湿热黄疸、肝经实火。⑤口疮、咽痛、舌癌等。

现代研究：主含靛蓝靛甙，另含靛玉红。青黛有抗致病球菌、杆菌和抗病毒作用。无论是实验或是临床都证明了靛玉红是青黛治疗慢性粒细胞白血病的有效成分，另一种成分是靛蓝无抗癌活性。靛玉红中一种新型结构的抗癌药，对慢性粒细胞性白血病的治疗效果较好，毒性不大，骨髓副作用轻微，且不抑制机体的免疫功能。有缩脾降白细胞作用，还可与首选化疗药马利兰相比拟。

研究证明：靛玉红是以抑制慢粒和急粒病人的白细胞及大鼠 W_{256} 癌肉瘤、小鼠腹水肝癌和艾氏腹水癌细胞的 DNA 合成代谢为主要特征，以及由此而派生出的对 RNA 合成的轻微抑制；而对蛋白质的合成则无影响。靛玉红对正常增殖的大鼠再生肝细胞 DNA 合成也有明显抑制作用，但其程度较恶性细胞低。3H-靛玉红试验显示，靛玉红在小鼠体内运转的主要途径是胃肠吸收，肝、胆代谢，再经过消化道排泄，故可观察到靛玉红对消化道系统组织的癌症如肝癌等的作用。原来体液免疫功能低下的人，服用靛玉红亦可恢复正常。

用法用量：0.3~3g，本品难溶于水，宜入丸散剂，或调入汤剂中服之。外用适量涂敷患处。

猪殃殃

性味功用：苦、辛，微寒。清热解毒，利尿消肿。

主治应用：①用于急性白血病，乳腺癌及癌性溃疡、淋巴瘤、肝癌等。②用于疮疖痈毒、尿路感染等。

现代研究：全草含猪殃殃甙、甙元及皂甙、鞣质等。对 S_{180} 有抑制作用，对小鼠白血病 L_{615} 有抑制作用（抑制率为 28.5%），对急性淋巴细胞白血病及急性粒细胞性白血病有效。并有抑菌作用。

用法用量：15~30g，水煎服。

蒲公英（黄花苗）

性味功用：苦、甘，寒。归肝、胃经。清热解毒，利湿。

主治应用：①治疗肝炎、胆囊炎、胃及十二指肠溃疡等有肝胆淤热。②用于肝癌、乳腺癌、肺癌、胃癌等各种癌症。③治疗疮疖痈，急性乳腺炎及各种急性感染，如五味消毒饮中用之。

现代研究：含拒貳。对多种细菌有较强的杀菌作用。对人体肺癌细胞的抑制作用。

用法用量：15~30g，水煎服。

菝葜（金刚藤、铁菱角）

性味功用：甘、酸、平。入肝、肾经。解毒散瘀，利湿祛风。

主治应用：用于消化道癌、鼻咽癌、脑瘤等。②用于疮疖痈，毒蛇咬伤，扁桃体炎等。

现代研究：根茎主要含菝葜皂甙 A、B、C。在体外有抑菌作用。对癌细胞 S₁₈₀ 抑制率为 30%~50%，对吉田肉瘤腹水型，S₃₇ 生命延长率在 50% 以下，对脑瘤 B₂₂ 抑制率在 50% 以上。

用法用量：15~30g，水煎服。

藤梨根（猕猴桃根）

性味功用：苦、涩、凉。归胃、肝、膀胱经。解毒活血，清热利湿，抗癌。

主治应用：①治疗消化道癌，临床多与半枝莲、野葡萄根、白茅根等同用。②用于风湿痹证、筋骨疼痛。③用于湿热小便不利及黄疸等症。④鲜果猕猴桃生食，可润肠助消化，用于肿瘤患者便秘，食欲不振，以及肠癌患者。

现代研究：含猕猴桃碱、维生素 C、糖类、氨基酸。中华猕猴桃多糖复合物（ACPS-R）有抗肿瘤作用，能增强 NK 细胞的溶瘤活性和促进巨噬细胞的吞噬功能。其果汁已证明能阻断致

癌物 N-亚硝基吗啉的形成。其根的粗制品，腹腔给药对艾氏腹水癌（EAC）有明显抑制作用。对小鼠实体肝癌亦有良好疗效，并能提高化疗药物的疗效，减少副反应。

用法用量：根用 30~60g，水煎服。果每日不拘多少，当水果服。

鸦胆子

性味功用：苦、寒。归大肠、肝经。清热解毒，杀虫止痢。

主治应用：①用于治疗胃癌、肺癌、乳头瘤、淋巴白血病、结肠癌、直肠癌、肝癌等。②治疗阿米巴疾病，常用本品装胶囊服用。③治疗肤赘疣、鸡眼等捣仁外敷。

现代研究：含鸦胆子甙，鸦胆子苦味素及鸦胆子醇。还有甾醇、生物碱，酚类，脂肪酸，所含酚类毒性极大。研究发现鸦胆子醇提取物中的苦味素成份具抗癌活性，对人体鼻咽癌（KB）、W₂₅₆ 肉瘤和 P₃₈₅ 淋巴白血病（PS）、Lewis 肺癌及 B₁₆ 黑色素瘤等肿瘤株具有较强的抗癌活性。鸦胆子甙 A 和 B 具有明显的抗艾氏腹水癌、W₂₅₆ 肉瘤、P₃₈₅ 淋巴白血病。10% 鸦胆子乳剂对 W₂₅₆ 抑制率为 47.5%，对小鼠体内腹水型肝癌的细胞数抑制率为 65%。临床观察鸦胆子油静脉乳不仅对宫颈癌有效，且对消化道肿瘤、肺癌、艾氏腹水癌、S₃₇、S₁₈₀ 均有明显的抗癌活性和不同程度的疗效。体外试验发现，鸦胆子静脉乳的小油滴与癌细胞有较好的亲和力，并能在癌细胞的周围粘附较长时间，这将有助于药物与癌细胞的接触，使抗癌剂增加向癌细胞内渗入的机会，产生杀灭或抑制癌细胞的作用。

本品能消除环磷酰胺的降低白细胞的作用。用脾集落法观察到鸦胆子乳剂对小鼠骨髓造血干细胞有明显的促进作用。而对癌细胞内的 cAMP 及 cGMP 无影响。鸦胆子油对皮肤疣赘可使其坏死脱落。此外，有杀死阿米巴原虫和疟原虫的作用。

鸦胆子果壳及种子有毒，其毒存在于水溶性苦味成分中，具有强烈的消化道刺激症状及对肝、肾的毒性。除去苦味质的油脂

部分则无显著毒性，挥发油有局部刺激作用。

中毒表现：恶心、呕吐、腹泻、便血（肠道出血），肾脏充血，肝脏充血及脂肪变性，严重时出现昏迷和惊厥，甚至死亡。

用法用量：10~15粒，用胶囊装，吞服。或用10%鸦胆子乳剂注射静脉滴注，每日10~20ml。

野菊花

性味功用：苦、辛、凉。归肺、肝经。清热解毒，凉血消肿。

主治应用：①应用各种癌症患者伴有热毒壅盛者，试用于肝癌、甲状腺癌、肺癌、恶性淋巴瘤、白血病等。②用于痈肿疔毒，化脓性疮口及流感。

现代研究：含挥发油、菊甙、多糖等。野菊对人子宫颈癌细胞及小鼠艾氏腹水癌有明显抑制作用。有广谱的抗菌作用，对流感病毒在体外有抑制作用。动物试验：对心肌缺血有明显的保护作用；有降低转氨酶作用及降低血压的作用。

用法用量：15~30g，水煎服。

鬼针草

性味功用：苦、平。清热解毒，消肿止泻。

主治应用：用于肿瘤感染（上呼吸道、胃肠道）；肠炎、咽炎；毒蛇毒虫咬伤，用嫩叶捣烂外敷及煎服。

现代研究：含多种微量聚乙炔类化合物及多种强极性炔类化合物，预试全草含生物碱、鞣质及皂甙。三叶鬼针草预试全草含蒽醌甙。三叶鬼针草1%乙醇浸液对金黄色葡萄球菌、枯草杆菌等有抑制作用。

草河车（拳参）

性味功用：苦、微寒，有小毒。清热解毒，消肿凉血。

主治应用：①治疗各种恶性肿瘤，常用于头颈部癌、食道癌、肠癌、肝癌及乳腺癌等。亦用于恶性淋巴瘤和白血病患者。②用于肠炎、疾病、痈疮肿毒，口腔炎症及瘰癧等。

现代研究：根茎含鞣质 15%~25%、没食子酸、儿茶素以及羟基甲基蒽醌、维生素 C 及微量元素。对肉瘤 S₁₈₀ 有抑制作用。

用法用量：10~15g，水煎服，或研末作丸散内服。

鱼腥草

性味功用：辛、微寒。归肺经。有腥气。有小毒。清热解毒，利水消肿。

主治应用：①治疗肺癌、大肠癌、绒毛膜上皮癌，外用治体表恶性肿瘤。对于晚期癌症患者并发感染，本品有清热解毒、镇痛消肿等作用，对改善症状有较好效果。亦用于治疗恶性胸腹水，与利尿药半枝莲、葶苈子、赤小豆等合用。②治疗肺痈，疮痈恶毒，急慢性气管炎、肠炎及尿路感染等。

现代研究：含挥发油，油中有效成份为癸酰乙醛（鱼腥草素）及月桂醛，两者均有特异嗅气。还含有癸酸、四基壬酮、氯化钾、硫酸钾等。叶含斛皮甙。对多种细菌及皮肤真菌有抑制作用，能提高机体某些免疫力；钾盐有利尿作用。

用法用量：15~30g，水煎服，后下。

注意：本品主要有效成份在挥发油，不宜久煎。

白毛夏枯草

性味功用：苦、寒。归肺、肝经。清热解毒，凉血消肿，止咳化痰。

主治应用：①治疗肺癌、鼻咽癌、喉癌、乳腺癌等。②用于肺热咳嗽，痰黄稠而多。③用于咽喉肿痛，热疖痈肿，乳痈以及疾病、肠痈，肺痈等病症。

现代研究：含黄酮甙及皂甙、生物碱，有机酸，鞣质，酸性物质，甾体化合物等。甾体化合物中含杯苋甾酮，蜕皮甾酮。动物试验证明，白毛夏枯草酸醇提取物、黄酮甙等有中枢性镇咳作用，其作用强度约为可待因 1/6。能降低发炎时气管粘膜的渗透性，起消炎祛痰作用。尚有平喘、利尿作用。对多种细菌有较

好的抑制作用。据报道，本品有抑制过敏介质释放及抗组织胺作用。

用法用量：15~30g，水煎服。

肺形草

性味功用：甘、辛，寒。清热解毒，止血。

主治应用：①肺癌、乳腺癌。②肺结核咯血。③肺炎、气管炎、肺热咳嗽。

现代研究：对金黄色葡萄球菌有一定抑制作用，药敏试验对胃癌细胞敏感。

紫草（紫草根）

性味功用：苦、寒。清热解毒，凉血活血。

主治应用：①治疗绒毛膜上皮癌、白血病、肺癌、肝癌、宫颈癌、胃癌等。②疮毒痈肿、吐血、衄血、冻疮、烫伤、传染性肝炎、急性膀胱炎、尿路感染。③紫癜、流感。④斑疹出不透，大便干涩。

现代研究：含紫草素、乙酰紫草素、去氧紫草素等。动物试验对小鼠肉瘤 S₁₈₀ 有抑制作用，对绒毛膜上皮癌及白血病细胞有抑制作用。本品还有对心脏有兴奋强心作用。有避孕效果，并可用于妇女经期综合症。有对抗垂体促性腺激素及对抗绒毛膜促性腺激素的作用，对枯草杆菌、金葡菌及流感病毒有抑制作用。

用量用法：10~30g，水煎服。一般治恶性肿瘤时用量较大，但本品性寒，故脾虚便溏者慎用。对癌性发热及出血有凉血清热作用。紫草亦常入散剂或膏剂中应用。

三尖杉（榧子）

性味功用：苦、涩，寒。清热解毒，祛虫消积，抗癌消瘤。

主治应用：①蛔虫症、钩虫症、食积。②主治白血病。三尖杉酯碱及高三尖酯碱对急性粒细胞性白血病、急性单核细胞性白血病的近期疗效较好，总缓解率达80%以上，高三尖杉酯碱及三尖酯碱对慢性粒细胞性白血病亦有效，但对急性淋巴细胞性白

血病和慢性粒细胞性白血病急变者疗效较差。③用于恶性葡萄胎、淋巴肉瘤、肺癌、嗜尹红淋巴肉芽肿、平滑肌肉瘤、滑膜肉瘤、胃癌、食管癌等。对真红细胞增多症效果较好。

现代研究：叶和枝含生物碱，其中有：三尖杉碱，高三尖杉碱、甲基三尖杉碱、三尖杉酯碱、高三尖酯碱等约二十余种。三尖杉总生物碱 0.2~2.0mg 皮下注射，对小鼠肉瘤 S₁₈₀ 的平均抑制率为 30%~60%；总碱肌注，局部产生硬结，影响疗效。三尖杉酯碱与高三尖酯碱对动物多种实验性肿瘤如小鼠肉瘤₁₈₀、子宫颈癌₁₄、艾氏腹水癌、网织红细胞肉瘤、脑瘤₂₂、白血病₆₁₅、淋巴细胞白血病₃₈₈、白血病₇₂₁₂、瓦克癌₂₅₆ 等均有抑制作用，能延长小鼠生存时间。三尖杉酯碱可使小鼠肉瘤₁₈₀、白血病₁₂₁₀ 的瘤细胞染色体发生变异，有丝分裂指数显著减少。能显著降低正常小鼠及白血病小鼠脾组织及肉瘤₁₈₀ 瘤细胞中核糖核酸含量，抑制蛋白质合成过程。对机体体液免疫及细胞免疫均有明显抑制作用。

三尖杉酯碱对强的松、6-巯基嘌呤、长春新碱、氨甲喋呤、环磷酰胺、阿糖胞甙、喜树碱、马利兰等抗癌药无明显交叉耐药性。

以三尖杉酯碱为主的各种生物制剂，给小鼠一次腹腔注射，其半数致死量 (LD₅₀)，大多在 2~4mg/kg 体重。临床毒性症状为恶心、呕吐、食减、便血；红白两系细胞受抑制，窦房结和异位节律兴奋性改变，传导阻滞和各型 ST-T 波改变。停药可恢复。对肝肾功能无明显影响。

用法用量：生药 12~20g，水煎服。

总碱 2±0.5mg/kg，分两次肌肉注射。

牛黄

性味功用：苦、凉。归心经。清热解毒，化痰开窍，息风镇痉。

主治应用：①治疗各种恶性肿瘤及白血病，如成药犀黄丸即

本品伍用它药治乳腺癌、瘰癧痈毒。牛黄解毒片治疗慢性骨髓增生症（如慢性粒细胞白血病、真性红细胞增多症、原发性血小板增多症、嗜酸性肉芽肿等）。加味犀黄丸治疗各种癌症。②对癌症高热、昏迷亦有效。③治疗小儿高热、神昏、惊厥、抽搐等。④治疗口舌生疮，咽喉肿痛、牙疳、痈肿毒疮等。

现代研究：主要含胆红素、胆酸、胆绿素、胆甾醇、卵磷脂、维生素 D 以及铜铁钙锌镁钠钾等金属盐及多种氨基酸等成份，用牛胆汁或猪胆汁经提取加工而成的药品称之为人工牛黄，其成份与天然牛黄基本相同。

人工牛黄对小白鼠 S_{180} 、 S_{37} 有明显抑制作用。牛胆汁提取物对大白鼠瓦克癌₂₅₆ 有抑制作用，适当剂量可使肿瘤发生广泛而严重坏死。犀黄丸对小鼠梭形细胞肉瘤、肉瘤₁₈₀ 均有抑制作用。

试管试验，牛黄与去氧胆酸钠对乙型脑炎病毒有直接灭活作用。牛黄的疗效大于人工牛黄。人工牛黄对金黄色葡萄球菌有抑制作用，而牛黄无效。

麝香、牛黄、蟾蜍三药合用有协同作用，可抑制肉芽肿形成。

此外有解热、镇静、催眠、抗惊厥、强心利胆、降压等作用。

用法用量：内服 0.15~0.6g，外用适量，只入丸、散而不入煎剂。

熊胆

性味功用：苦、寒。清心平肝，解毒杀虫。

主治应用：①用于肿瘤患者高热惊厥，黄疸。②用于肝癌、食道癌、胃癌等有一定疗效。

现代研究：含胆酸类，水解生成牛磺酸及熊去氧胆酸，尚含少量鹅去氧胆酸。鹅去氧胆酸与胆酸均有对抗硝酸士的宁引起的惊厥作用；有平滑肌解痉作用；有利胆作用及促进维生素 D_3 和

钙的吸收作用。

用法用量：0.15~0.3g，多入丸散服，外用适量。

虎杖（阴阳莲、蛇总管、花斑竹）

性味功用：苦、酸、凉。归肝、心包经。清热利湿，解毒活血。

主治应用：①治疗肝癌、胰腺癌、胆管癌、卵巢癌、癌性胸腹水等。②用于治疗因放化疗所致的白细胞减少症。③用于黄疸湿热，传染性肝炎，烫火伤，蛇咬伤，淋浊带下，症瘕积聚，痔漏下血，痈疽肿毒，骨髓炎，风湿痹痛等。

用法用量：15~30g，水煎服。或入丸散，或作浸膏片。

三、活血化瘀药

凡以活血通经，促进血行，祛瘀消肿为主要作用的药物，称为活血化瘀药。瘀血凝滞，是肿瘤形成的病机之一，所以活血化瘀药是治疗肿瘤的常用药物。现代药理学研究证明，活血化瘀药的作用是多方面的，主要归纳为：①对心血管的作用，一些药物具有扩张冠状动脉作用，还能减少外周血管阻力，增加血流量等。②有改善微循环的作用，加快微循环血液流速，增加毛细血管网，血液流速加快，使进入血流的肿瘤细胞不易靠壁而被吞噬，显示有抗肿瘤转移效应，并能增强化疗药物的疗效。还能提高在高压和低压条件下机体耐缺氧的能力；③其中许多药物具有抗感染作用，它们常常在调节机体反应性的基础上又直接或间接地达到抗菌目的，如与清热解毒药合用，有加强抑菌和减毒两方面的作用。④能促使增生性病变的转化和吸收，对增生病变如慢性肝脾肿大，某些腹腔粘连、疤痕疙瘩等有不同程度的软化和吸收作用；⑤有部分药物能直接抑制肿瘤细胞的生长；有的能调节人体代谢的失调。临床上凡有血瘀症候者，均可选用。

本类药物有破血化瘀，通经活络作用，对妇女月经过多、出血性疾病或有出血倾向者，宜慎用或忌用。

三棱

性味功用：辛、苦平。归肝、脾经。破血祛瘀，行气止痛。

主治应用：①用于症瘕积聚，腹内包块，以及肝脾肿大，气滞作痛等症。②用于肝癌、胃癌、卵巢癌等腹腔肿瘤，血滞经闭，以及饮食积滞，胸腹胀满疼痛等症。

现代研究：含挥发油，淀粉等。对癌细胞有抑制作用。三棱、莪术注射液（30%）对小白鼠肉瘤₁₈₀有明显的抑制作用。有报道对腹腔内良性肿瘤卵巢囊肿有效。

用量用法：10~15g，水煎服。

莪术

性味功用：苦、辛、温。归肝、脾经。行气破血，消积止痛。

主治应用：①用于宫颈癌，外阴癌、皮肤癌、肝癌、胆管癌、胃癌、卵巢癌，肺癌、肠癌、淋巴瘤、白血病等，其中，用1%莪术油治疗子宫颈癌（局部注射），总有效率在56%以上。治疗皮肤癌可用本品的乳剂或挥发油软膏涂擦。②用于气滞血瘀之经闭腹痛及症瘕痞块等证。③用于食积气滞，腹部胀满疼痛等。

现代研究：含挥发油，油中含倍半萜烯醇、莪术醇， α -姜烯、桉油精、 α -茨烯，莪术酮、姜黄素等。

挥发油制剂及莪术醇、莪术酮，对瘤细胞有直接破坏作用。研究表明，莪术油水溶液I、II及莪术乳油剂小鼠腹腔给药，自接种瘤细胞后24小时连续给药7~10次（剂量100~175mg/kg I、II对小鼠艾氏腹水癌（EAC）、小鼠网织细胞肉瘤S₃₇及小鼠肉瘤S₁₈₀等均有明显疗效；乳剂对S₁₈₀腹水型有明显的治疗效果。主要作用机理：使癌细胞变性、坏死，并有吞噬细胞包围肿瘤细胞等免疫反应出现。临床应用可使局部赘生物坏死，逐渐脱落形成溃疡面，然后出现红斑性反应，上皮逐渐修复，如宫颈癌最后恢复到正常外观，而对正常组织无明显影响。

国内用莪术治疗宫颈癌总结数百例，疗效达78%，治疗中

可见癌细胞组织有变性、坏死及脱落，间质呈慢性炎性反应，近期治愈者活检未见癌细胞。

莪术抗癌的主要成份为莪术醇和莪术酮。但由于莪术醇在水中溶解度较低，仅为 0.3%，提高疗效和扩大应用范围均受到限制，为此，合成了莪术磷酸单钠（CP-Na），其在水中的溶解度为 2.5%，较莪术醇提高了 7 倍多。实验证明，CP-Na 在体外对癌细胞有直接作用，此作用强于莪术醇。复方莪术注射液（三棱、莪术）加葡萄糖滴注治疗胃肠癌时，对微循环有一定改善作用，而微循环障碍会导致内脏器管及网状内皮系统功能下降。此外，有升白细胞、抗着床、抗早孕、抗菌、抑制血栓形成等作用。动物试验发现，低浓度能使肠管紧张度升高，浓度高时能使肠管舒张。

用法用量：10～20g，水煎服。有制成注射液局部用或静滴。

桃仁

性味功用：苦、甘、平。归肝、肺、大肠经。破血散瘀，通经消肿，润肠止咳。

主治应用：①用于治疗各种癌症患者具有血瘀症者。②用于痛经、经闭、肚腹结块，跌打损伤。③用于肺痈、肠痈、脉管炎、便秘等症。

现代研究：含苦杏仁甙及杏仁酶，脂肪油，乳糖，维生素 B1 等。苦杏仁甙入胃后经过酶作用，可分解为氰酸和苯甲醛，它们有捕杀癌细胞、对艾氏腹水癌细胞有抑制作用；有抑制机体免疫功能作用；有抑制血凝以及润肠、止咳作用。

用法用量：6～15g，水煎服。

丹参

性味功用：苦、微寒。归心、心包、肝经。活血化瘀，凉血安神。

主治应用：①症瘕积块，肝脾肿大等症。②用于血滞经闭、

痛经、血瘀气滞，心腹诸痛。③用于痈肿疮毒。④用于各种癌症有血瘀症候者。

现代研究：含丹参酮Ⅰ、Ⅱ及异丹参酮Ⅰ、Ⅱ，维生素E等。丹参水溶性成份有协同喜树碱的作用，对L₆₁₅小鼠的生存期有延长作用，显著延长艾氏腹水癌小鼠的存活时间。丹参与环磷酰胺合用对小鼠肉瘤₁₈₀的治疗有增效作用，对小鼠₆₁₅白血病的治疗未显示协同作用，单独应用丹参对艾氏腹水癌小鼠的生存时间反而减少。动物实验证明，丹参可促进Lewis肺癌的自发性转移，及大鼠W₂₅₆癌细胞血行播散。

丹参煎剂对多种革兰氏阳性菌及阴性菌有抑制作用。丹参能改善微循环、扩张冠状动脉，增加冠状动脉血流量，促进组织的修复与再生，抑制凝血，激活纤维蛋白溶解，抑制血小板聚积。能增强吞噬细胞活性。

用法用量：10~15g，水煎服，或制成各种制剂应用。

五灵脂

性味功用：甘、温。归肝经。活血化瘀，消肿止痛。

主治应用：①治疗食道癌、胃癌及妇科恶性肿瘤等患者有血瘀证及一切血症疼痛者。②用于血滞经闭、痛经、产后恶露不下等症。

现代研究：含多量树脂、尿素、尿酸及维生素A类物质等。本品有抗肿瘤作用；对结核杆菌的生长有抑制作用，水浸剂对多种皮肤真菌均有不同程度的抑制作用，动物试验，有缓解平滑肌痉挛作用。

用法用量：3~10g，水煎服。忌与人参伍用。

急性子（凤仙花子）

性味功用：微苦、温、有小毒。活血通经，降气行瘀，散结消肿。

治疗食道癌、贲门癌、胃癌等，近期疗效较好，治疗食道癌、贲门癌噎塞不下时，配伍威灵仙、木鳖子等同用。另外本品

能治鱼骨哽喉。

现代研究：本品含凤仙甾醇、杷萜酸、 β -谷甾醇，药敏试验对胃淋巴瘤细胞敏感。并有广谱抗菌作用。能抑制排卵，促进卵巢萎缩。所含多糖及阿魏酸有抗癌作用。

用法用量：6~10g，水煎服。

注意：孕妇慎用。

水红花子

性味功用：咸，微寒。活血消积，利水散结。

主治应用：①治疗消化道肿痛，如胃癌、肝癌，常与半枝莲、莨菪，八月扎等配伍应用。②用于痞块腹胀，癌性胸腹水，盆腔腹腔肿痛。蓼花熬膏内服及外敷。③瘰癧疮肿（包括恶性淋巴瘤）。

现代研究：含牡荆素、荭草素、槲皮甙等。水煎剂对志贺氏和福氏痢疾杆菌有抑制作用。水煎剂、酊剂或石油醚提取物对艾氏腹水癌（腹水型及实体型）和 S₁₈₀ 有一定的抑制作用。牡荆甙有抗癌活性。

用法用量：15~30g，水煎服。亦可熬膏内服。外用可研末或熬膏。

水蛭

性味功用：苦、咸、平，有小毒。归肝经。破血祛瘀，消征散结。

主治应用：①治疗食管癌、胃癌、直肠癌等有血瘀症状者。②闭经、症瘕、积聚、跌打损伤、瘀血作痛等证。

现代研究：水蛭的唾腺中含水蛭素，是一种多肽，由 15 种 68 个氨基酸组成。水蛭素是凝血酶抑制剂，有抗凝血作用。水蛭素对细菌内毒素引起的大鼠血栓形成有预防作用。且能减少大鼠的死亡率。另外还含有肝素，抗血栓素等。用于治疗心绞痛及下肢动脉血栓等疾病。水蛭素能减轻高血压症状，降低血液粘度，及抗孕作用。水蛭注射液能抑制精原细胞分裂，体外试验用

伊红法对肿瘤细胞有抑制作用，对小鼠肝癌有一定抑制作用。

用量用法：3~15g，水煎服。为末冲服，每次0.3~0.6g，每日二次。

土元（地鳖虫）

性味功用：咸、寒，有小毒。归肝经。破血散瘀，通经止痛。

主治应用：①血瘀经闭，症瘕积聚，腹中痞块。②骨折、外伤瘀血疼痛。③用于治疗骨肉瘤，肝癌，宫颈癌等。

现代研究：美兰试管试验对白血病细胞有抑制作用。能促进骨折新生。

用量用法：6~10g，入煎剂。散剂1~1.5g。

乳香

性味功用：辛、苦、温。归心、肝、脾经。活血止痛，消肿生肌。

主治应用：①用于各种实体癌瘤及良性肿瘤。如古方“犀黄丸”、“醒消丸”均用之。②用于痈疽恶疮肿毒，跌打损伤及气滞血瘀所致的心腹诸痛。

现代研究含树脂、树胶及挥发油等。动物及体外试验证，本品对小鼠肉瘤180有抑制作用。并能提高机体非特异性免疫功能，与5-Fu合用，可以纠正实验动物因化疗所致免疫功能低下。

用量用法：3~9g，入煎剂，或入丸散，外用研末调敷。

威灵仙

性味功用：辛、微苦、温。入膀胱经。消痰散积，通络止痛，祛风除湿。

主治应用：①治疗食道癌，噎膈不通，喉癌，乳腺癌、胃癌、骨瘤骨肉瘤等。②治疗鱼骨哽噎，15~30g，醋适量，水煎取汁频呷。③风湿痹痛，肢体麻木，腰脊劳损。④症瘕积聚，痰核瘰癧等。

现代研究：含白头翁内脂、甾醇、糖类、皂甙等。试验对小鼠肉瘤 180 有抑制作用。近年报道，本品有抑制植物细胞分裂的作用，对一些肺鳞癌，未分化癌及恶性黑色素瘤有效，但对肺部腺癌无效。有兴奋离体肠管，抗组织胺，降低血压及抗利尿、抗菌等作用。

用量用法：治疗肿瘤 30g，水煎服。治疗非肿瘤 10~15g，煎服。亦可浸酒或入丸散用。有报道用本品 50g 水煎服可治疗放化疗所引起的恶心呕吐。

喜树（旱莲木、野芭蕉）

性味功用：苦、涩、寒。有毒。破血化瘀，散结祛痰。

主治应用：胃癌、结肠癌、直肠癌、肝癌、膀胱癌、慢性淋巴性白血病，绒毛膜上皮癌，恶性葡萄胎，淋巴肉瘤、食管癌、牛皮癣。

现代研究：含喜树碱，羟基喜树次碱，；甲氧基喜树碱。另外还分离出喜树次碱等。喜树碱和羟基喜树碱为抗肿瘤的有效成份，目前我国已人工合成。药理试验为广谱抗癌药，喜树碱无论体内外对多种动物肿瘤均有抗癌活性。其衍生物的抗肿瘤谱与喜树碱的抗癌谱基本相同但略有差异。喜树碱对脑瘤₂₂、艾氏腹水癌皮下型、大鼠瓦克癌肉瘤₂₅₆及吉田肉瘤均有明显的治疗作用，抑制率为 33%~60%；喜树碱与消瘤芥及抗菌素 B₅₉₉ 合并应用，对艾氏腹水癌治疗有协同作用。用高温（43.5℃，2 小时）加喜树碱（5ug/ml）对体外培养的人食道癌 109 细胞具有不可逆的协同杀伤作用。羟基喜树碱及甲基喜树碱的抗癌效力高于喜树碱，对 L₁₂₁₀、S₁₈₀、S₃₇、U₁₄、W₂₅₆、艾氏腹水癌、腹水型肝癌、大鼠吉田肉瘤等均有明显抑制作用。喜树碱主要作用于细胞的合成期（S 期），可使 S 期细胞致死，对 DNA 合成前期（G1 期）和后期（G2 期）亦有作用，但不如 S 期细胞明显，并可延缓 G2 期进入核分裂期（M 期）。较高浓度时（10mcg/ml）可抑制核的有丝分裂。对休止期细胞（G0 期）无

作用。

喜树碱对多核苷酸的抑制大于对蛋白质的抑制，它首先抑制癌细胞的 DNA 多聚酶，继而影响 DNA 的生物合成，亦可直接破坏 DNA 或首先与 DNA 结合，使 DNA 易受内切酶的攻击，进而使 RNA 和蛋白质合成受阻，杀伤癌细胞。喜树碱及 10 羟基喜树碱等能使癌细胞发生变性、坏死、核固缩、浓缩、染色质凝聚，胞浆多空泡，巨细胞等形态改变。

喜树碱混悬液还能使甲胎蛋白阴转或降低。果实煎剂有抑菌作用。此外，喜树碱还有抗早孕作用，对牛皮癣亦有较好的疗效。

动物试验：腹腔注射喜树碱后，药物迅速分布于消化道、肝、肾、骨髓、脾等组织，脑中未能检测到喜树碱。在胃肠组织中药物浓度下降缓慢，可能存在药物的肠-肝循环。在体内各组织中多数以原药形式存在。胆汁是喜树碱排泄的主要途径。

喜树碱的给药方案以大剂量冲击对免疫影响最小。毒性反应有出血性肠炎、膀胱炎、肝、肾损害，骨髓抑制等。甘草酸单铵盐对喜树碱有解毒作用。

羟基喜树碱剂量为喜树碱的 $1/30$ 时，与喜树碱有相同抗癌作用。毒性比喜树碱小，极少出现尿血及肝肾功能损害，且抗癌谱广。

用量用法：①煎剂：果或根皮用 6~9g，树根及树枝 15~45g。②喜树碱钠盐静脉注射，每日一次，每次 5~20mg，用生理盐水稀释后立即注射。总量为 150~300mg，一般用至 140mg 左右出现反应。③羟基喜树碱（每支 2mg）注射液，每日或隔日一次，每次 4~10mg，加生理盐水 20ml，静脉注射，60~120mg 为一疗程。本品不宜用葡萄糖等酸性药品稀释，孕妇忌用。另有用喜树果制片剂或丸剂。或喜树果注射液（每支 2ml，相当于喜树果 8g）每日 2~8ml，肌肉注射或静脉注射。喜树碱注射液亦可作瘤体及胸腹腔注射用。

注意：凡肾功能不全、有血尿、尿路感染者缓用；用药后白细胞数低于 $3.0 \times 10^9 / L$ 者停药。

鬼箭羽（卫矛）

性味功用：苦寒。行血通经，化瘀止痉。

主治应用：①治疗乳腺癌、卵巢癌、胃癌、肠癌等恶性肿瘤及癌症疼痛而有瘀血症者。②用于闭经、产后血瘀腹痛、下腹部肿块等。

现代研究：叶含槲皮素、卫矛醇等物质。动物试验证明对小鼠肉瘤₁₈₀ 大鼠 W_{256} 等有抑制作用。水提液中含草乙酸钠，有调节异常代谢过程和增进胰岛素分泌引起血糖下降的作用。此外，还有抑菌作用。

用量用法：10~15g，水煎服。或入丸、散中。

降真香（山橘、山油柑）

性味功用：甘、平。归心经。行气止痛，活血止血。

主治应用：①治疗消化道癌、肝癌、宫颈癌、白血病等。②跌打肿痛，肝胃气痛，风湿痹痛。③吐血咳血等。

现代研究叶含挥发油，油中含 α -蒎烯及柠檬烯。茎皮含三萜类化合物山油柑萜醇及草酸钾，心材含 β -谷甾醇，同属植物鲍氏山油柑含山油柑碱，后者具有广谱抗癌作用，对小鼠白血病₆₁₅ 有明显疗效；对小鼠肝癌、小鼠宫颈癌₁₄、腺癌₇₅₅、 C_{1498} 骨髓性白血病， X_{5563} 浆细胞性骨髓瘤等均有效。目前我国已人工合成山油柑碱。

用量用法：15~30g，水煎服。

按：本品为芸香科常绿乔木植物山油柑（降真香）的叶、根、心材及果。分布于广东、广西、云南等省。豆科植物降香黄檀（花梨母）根的心材，亦称降真香，产于我国海南岛，与豆科植物印度黄檀，同称降真香，又称紫降香。降香黄檀性味辛、温，功能避秽止痉，散瘀止血。每用 3~6g，水煎服。散剂，0.6~1g，冲服。外用止血定痛，消肿生肌。为避免与豆科植物

降真香混淆,《中草药学》将芸香科植物降真香改名为山油柑,而山油柑碱的抗癌作用已经动物试验证明。

四、软坚散结药

凡能使肿核、肿块软化或消散的药物,称为软坚散结药。中医认为,气滞痰凝是肿瘤形成的又一病因病机之一,通过化痰,可以使肿块消散或软化,运用理气药,可促结聚之痰液消散,故本类也是治疗肿瘤的常用药物。

半夏

性味功用:辛、温,有毒。归脾、胃、肺经。燥温化痰,降逆止呕,消痞散结。

主治应用:①用于瘰疬、痰核、瘰癧、痈疽、肿毒。②肿瘤患者有脾不化湿,痰涎壅滞而见咳嗽,气逆,痰稀而多,均可用之。③用于肿瘤患者或放疗后胃气上逆,恶心、呕吐、胸脘痞闷。寒呕可配丁香、良姜等,胃热可配黄连、竹茹等。④用于宫颈癌及其癌前病变有效。其总有效率为77%,近期治愈及显效率为59%,还可用于食道癌、胃癌、鼻咽癌,皮肤癌等。

现代研究:含 β -固甾醇及葡萄糖甙,皂甙、生物碱,水溶性部分含有胆碱,甘露醇、氨基酸及酚类等物质。半夏经药理试验证明有镇咳作用、镇吐作用,对乙酰胆碱有解毒作用。掌叶半夏对实验性动物肿瘤 U_{14} 、 S_{180} 、肝癌实体型以及对海拉细胞均有一定的抑制作用。临床药理观察,对宫颈癌有效,对机体免疫功能无明显影响。

半夏中有毒成份能引起呕吐、难溶于水,经久煎可破坏,不能单纯被姜汁所破坏,而能被白矾所消除。此毒性成份对局部有强烈的毒性作用,生食时可使舌咽、口腔麻木和肿痛、流涎、张口困难等。严重者可窒息。

用量用法:6~15g,水煎服。或入丸散剂。反乌头。

天南星

性味功用:苦、辛、温、有毒。归肺、肝、脾经。燥湿化

痰，消肿散结。

主治应用：①试用于宫颈癌、食管癌、脑瘤、软组织肉瘤、骨瘤等。分别不同情况配伍其他抗癌药。②用于顽痰咳嗽、胸膈胀闷及风痰滞络，中风、癫痫。

现代研究：含生物碱、皂碱、安息香酸， β -谷甾醇。皂甙能刺激胃粘膜，反射性引起支气管分泌物增加，有祛痰作用。鲜南星水提物对海拉细胞有抑制作用，对 S_{180} 、小鼠肝癌实体 HCA、 U_{14} 有明显抑制作用。从鲜南星中提取的结晶 D-甘露醇有同样的抑瘤作用。本品还有镇静、镇痛、抗惊厥作用。生南星有毒，与皮肤粘膜接触，则发生痒肿，用白矾制煮可减其毒性。

用量用法：制南星 3~10g，水煎服，我们有时大量用 30g，先煎两小时，以减其毒性。生南星多入丸散剂 1 次量 0.3~1g。孕妇慎用。

夏枯草

性味功用：苦、辛、寒。归肝、胆经。清肝明目，散结消肿。

主治应用：①用于乳腺癌、甲状腺癌、纵膈肿瘤、淋巴瘤、肝癌等。②用于瘰疬痰核、痰火郁结等症。③用于肝阳上亢，头昏眼花，目赤、乌珠胀痛或夜间疼痛。

现代研究：含皂甙，夏枯草甙，齐墩果叶酸，熊果酸，芸香甙，少量生物碱，苦味质等。动物试验证实，对小鼠肉瘤₁₈₀、小鼠子宫颈癌 14 有抑制作用。煎剂能抑 S_{180} 及艾氏腹水癌的生长。但有报道在治疗期间小鼠食欲减退，体重明显下降，死亡率增高，认为无临床价值。有报道对腺癌、淋巴肿瘤，纵膈肿瘤有作用。

用量用法：15~30g，水煎服。夏枯草膏每服 10g，每日三次，或入丸散。

注意：本品苦寒，量大长期服用可损胃气。并有降血压作

用。

猫爪草

性味功用：辛、苦、平，有小毒。归肺、肝经。化痰散结，解毒消肿。

主治应用：①用于乳腺癌、肺癌、甲状腺癌，恶性淋巴瘤等。②用于痰核瘰癧，淋巴结核，单用或配伍应用均可。此外，又可用于肺癆及咽喉肿痛，恶疮肿毒疼痛等。

现代研究：含氨基酸，有机酸，糖类。对小鼠 S_{180} 、 D_{37} 、艾氏腹水癌有抑制作用。

用量用法：15~30g，水煎服。

黄药子（黄独、黄药脂）

性味功用：苦、辛、寒，有小毒。归心、肝经。化痰散结，解毒消肿，清热凉血。

主治应用：①治疗食管癌、胃癌、肠癌、甲状腺癌、肺癌、宫颈癌等。②治疗甲状腺瘤及甲状腺肿大。③无名肿毒，疮疖脓肿及吐血咳血，百日咳、蛇咬伤等。

现代研究：含黄独萜酯 A、B、C、鞣质、淀粉及薯蓣皂甙元等。动物试验，本品对小鼠 S_{180} 有抑制作用；黄药子油对 U_{14} 癌细胞的抑制作用比较明显，对消化道肿瘤及甲状腺肿瘤也有一定抑制作用，对一些原因不明的甲状腺肿也有一些治疗作用，但对硫尿嘧啶等抗甲状腺药物造成的甲状腺肿无治疗作用。另外，对金黄色葡萄球菌及致病皮肤真菌也有抑制作用。

用量用法：15~30g，水煎服。或制黄药子油，每毫升内含药量相当于生药 0.2g。

注意：本品有毒，剂量过大时可引起口舌喉部烧灼而痛，并流涎，恶心呕吐、腹痛、腹泻、瞳孔缩小等反应，严重时可出现昏迷，呼吸困难和心脏麻痹而死亡。长期用药发现能引起肝功能严重损害。

山慈姑（山茨菇）

性味功用：甘、微辛、寒。归肝、胃经。有小毒。化痰散结，解毒消肿。

主治应用：①治疗乳腺癌，何杰金氏病，白血病，胃癌，食管、肺癌等，其中乳腺癌效果最好。②风湿性关节炎，痛风。③瘰癧结核，疮痈肿毒，蛇咬伤及良性肿物。④黄疸性肝炎，胆囊炎，慢性肾炎等。

现代研究：鳞茎及叶、茎、种子含秋水仙碱，可使细胞有丝分裂停止于中期，阻断DNA合成。秋水仙碱对多种动物肿瘤有抑制作用。我国将秋水仙碱14位上甲氧基用胺基取代而得具有抗癌活性较高毒性较低的衍生物——秋水酰胺，对小鼠肉瘤S₃₇、S₁₈₀、SAK、腹水肝癌（实体型）的抑率分别为36.7%、49.8%、26.5%。对淋巴肉瘤，大鼠₂₅₆癌瘤有不同程度的抑制作用。秋水仙碱有细胞毒作用，分裂越旺盛和代谢速度越高的细胞最易受到攻击。对正常增殖或肿瘤细胞皆有拟辐射作用。可减少进入有丝分裂的细胞数。

秋水仙碱能直接作用于骨髓，引起暂时性白细胞减少。此外尚能增强和延长催眠药作用，降低体温，增加对中枢抑制药的敏感性；抑制呼吸中枢，增强对拟交感神药的反应；收缩血管和通过对血管中枢的兴奋作用而引起高血压；还能通过神经原的兴奋作用，加强胃肠活动，改变神经肌肉的功能。

用量用法：3~10g，水煎服。秋水仙胺注射液：静脉滴注或推注，每次10~20mg（每支1ml，内含秋水仙胺10mg）每日或隔日一次，用葡萄糖注射液或生理盐水稀释，总剂量200~300mg为一疗程。复方秋水仙碱注射液（每支2ml，内含主药秋水仙碱1mg），每次2~4ml，用5%葡萄糖注射液稀释后缓慢静脉滴注，2小时以上滴完，每日一次，总剂量40~80ml为一疗程。

土贝母（大贝母、土贝）

性味功用：苦、凉。散结解毒，清消痈肿，化痰敛疮。

主治应用：①用于治疗鼻咽癌、乳腺癌、淋巴瘤、白血病、胃癌、大肠癌等。②用于瘰癧痰核、疮疡肿毒初起。

现代研究：鳞茎含糖类。动物试验证明土贝母结晶 D 对小鼠肉瘤₁₈₀、艾氏腹水癌和肝癌有一定抑制作用。土贝母注射液能降低甲基胆蒽的宫颈癌诱发率，对照组为 85%，给药组为 53%，肿瘤平均体积前者为 2.3cm³，后者为 0.1cm³。

用量用法：10~30g，入煎剂，或入丸散剂。

天花粉

性味功用：甘微苦、微寒。归肺、胃经。清热生津，消肿排脓。

主治应用：①治疗绒毛膜上皮癌及恶性葡萄胎、食管癌、喉癌等。②用于治疗放射治疗时的副反应。③用于疮疡肿毒，肺热燥咳，消渴病等。

现代研究：含皂甙、蛋白质及淀粉等，对 U₁₄、S₁₈₀ 和艾氏腹水癌细胞有抑制作用。本品可抑制绒毛膜促性腺激素 (HCG)，有中程引产作用。

用量用法：10~15g，水煎服，或作丸散。

栝蒌（瓜蒌）

性味功用：甘、寒。清热化痰，宽胸散结，排脓消肿，润燥滑肠。

主治应用：①治疗乳腺癌、肺、胃、胰腺癌，淋巴肉瘤等，亦用于治疗食管癌，大肠癌有痰热便燥者。②用于乳痈，乳中结硬，肺痈吐黄痰。③用于胸痹胁疼，心前区痛。

现代研究：含三萜皂甙，有机酸，树脂、糖类、脂肪油，色素等。瓜蒌仁含脂肪油、皂甙、有机酸、树脂等。瓜蒌对多种细菌有抑制作用，对部分皮肤真菌亦有不同程度的抑制作用。瓜蒌体外试验有抗癌作用，瓜蒌皮、仁都有效，而瓜蒌皮的功效比瓜蒌仁好；种壳、脂肪油都无效。以 60% 醇提取抗癌作用较强。动物试验，瓜蒌有显著的增加冠状脉流量作用。瓜蒌并有降血脂

的作用。用量用法：15~30g，水煎服。或加酒煎服。

海藻

性味功用：苦、咸、寒。归肝、胃经。清热消痰，软坚散结、利尿。

主治作用：主要用于瘰疬瘰癧，痰核及各种癌症。

现代研究：含海藻胶酸，碘、粗蛋白，甘露醇，钾及多糖类。研究证明，有许多糖特别是多聚糖，具有显著的抗癌活性。这些糖主要是以 D-葡萄糖通过 β -1-3 甙链相互缩合而成，用量 2~15mg/kg 在小鼠体内就能发挥抗肉瘤 S₁₈₀ 的作用，报告有效率达 90%，毒性很低。多糖体已在抗肿瘤免疫治疗中显示促胸腺体液反应，具有“宿主中介作用”，刺激网状内皮系统，提高对癌细胞的特异抗原免疫反应力。多糖是细胞的组分，故有强化正常细胞抵御致癌物的浸蚀，提高机体抗病力的作用。此外尚有抗流感病毒作用。

用量用法：15~30g，水煎服。

注意：忌辛辣酒，反甘草。据报道：“海藻不反甘草”，“十八反”中曾提到“海藻反甘草”，临床上以海藻、甘草合用治疗多种病，都取得了不同程度的疗效；用海藻甘草同煎给家兔灌服，也无明显毒性。通过调查，了解到春季期间，正值河豚鱼产卵，大量河豚鱼卵附于藻类上，服用此时采的藻类，将会出现中毒现象。

我们在临床上治疗肿瘤，常以海藻甘草同用，亦未见毒性反应。

昆布

性味功用：咸、寒。化痰利水，软坚散结。

主治应用：①用于治疗甲状腺癌，食管癌、子宫体癌、恶性淋巴瘤、肺癌及淋巴结转移癌。②用于治疗瘰癧、瘰疬、噎膈、疝气，水肿，睾丸肿痛，症瘕积聚等。

现代研究：含藻胶酸（褐藻酸），半乳聚糖，维生素 B₁、

B₂、C 及碘、钾、铁、钙等及海带聚糖。经小白鼠试验，藻胶酸能与鼠体内的放射性物质锶、镭结合，形成不溶解的化合物，阻止锶在肠道的吸收。服用藻胶酸有预防白血病的作用。有报告其抗肿瘤活性只在体内实验时，才能检测出，故推测昆布的抗肿瘤作用是通过宿主介导的免疫反应。也有人发现昆布的热水提取物对体外的 KB（鼻咽癌病毒）癌细胞培养有明显的细胞毒作用，可杀死 50% 以上的癌细胞。小鼠口服海藻、昆布、全蝎、蜈蚣等复方煎剂，对艾氏腹水癌有抑制作用。本品含碘，能促进炎性渗出物的吸收，并能使病理组织崩溃和溶解。可以纠正因缺碘而引起的甲状腺机能不足；海带聚糖有抗血脂作用；藻胶酸钠可作为免疫刺激剂，提高机体细胞免疫功能。5% 藻酸钠水溶液作粘膜保护剂，治疗消化性食管炎有卓效，对消化性溃疡有改善症状和有效止血作用。

用量用法：10～30g，入煎剂，或适量入丸散剂。

穿山甲（鱗鯉甲、山甲片）

性味功用：咸、微寒。入肝、胃经。消积散结，通经下乳，消痈排脓，活血止疼。

主治应用：①用于治疗乳腺癌、食管癌、肝癌、皮肤癌、白血病，及恶性淋巴瘤等。②乳痈、痈疽恶疮，乳汁不通，疳积腹痛，消化不良，颈淋巴结核，风湿痹痛。③用于白细胞减少症。

现代研究：含穿山甲碱等。能增强机体的免疫机能，有升高血小板和白细胞的作用。有止手术、创伤出血及尿血的作用。

用量用法：6～10g，入煎剂，或入丸散剂。

阿魏

性味功用：苦、辛、温。归脾、胃经。消积、杀虫、解毒、破征。

主治应用：①试用于治疗食管癌、肝癌、卵巢癌及多种恶性及良性肿瘤。②肚腹痞块，症积、食积、虫积、疟积等。

现代研究：含挥发油、树脂和树胶。油中含多种有机硫化合

物，含硫 17%~38%，为本品蒜臭的原因。试验证明，对小鼠肉瘤₁₈₀及人类宫颈癌细胞抑制率较高。有抗癌辐射及升白细胞和血小板的作用。有增加血中肝素样物质，产生抗凝作用。并有镇痛、镇静、催眠作用。还可增强巨噬细胞的吞噬功能。

用量用法：0.9~1.5g/日，不入煎剂，只入丸、散内服，或入膏药外敷。

硃砂

性味功用：咸、苦、辛、温，有毒。归肺、胃经。软坚散结、消积祛瘀，祛腐蚀疮，化痰利咽。

主治应用：①用于食道癌、胃癌、直肠癌等消化道肿瘤，以及乳腺癌、外耳道和皮肤良性肿瘤等。②用于恶疮肿毒，目翳胬肉等证。③用于顽痰，咳嗽痰稠，以及咽痛喉痹等。

现代研究：白硃砂主要含氯化铵和铁、钾、钙、镁和硫化物；紫硃砂主要含氯化钠及少量铁、镁、硫化物和硫酸盐，有祛痰、利尿作用，动物试验证明有抗肿瘤作用。

用量用法：0.3~0.6g/日，入丸散剂。外用适量，孕妇忌用。肝肾功能不全者慎用。

五、消肿止痛药

凡使肿物消散，减轻和制止疼痛的药物称为消肿止痛药。肿瘤患者，体内多有癌毒结聚，特别是后期癌症患者，毒陷邪深，非攻不克。本类药多为有毒之品，以毒攻毒，药性峻猛，使肿结消散，疼痛减轻或消除。临床应用必须严格掌握用量和炮制方法，保证用药安全。

临床常用的以毒攻毒药物，除个别外，多数列入本类药。

狼毒

性味功用：辛、平、有大毒。入肝、脾经。破积攻坚，祛痰散结，杀虫、止痉、止痛、利尿。

主治应用：①治疗消化道癌、乳腺癌、宫颈癌等。②淋巴结核、疥癣、痈肿恶疮，痰积、食积、虫积等。

现代研究：含植物甾醇，狼毒甙，脂肪酸，酚类化合物，以及扩微量生物碱、皂甙、鞣质等。动物试验证明对肿瘤细胞有一定抑制作用，能促进机体正常代谢功能，抑制异常旺盛的组织，毒性大，动物口服每次给予 1g/kg 体重，可致死亡。

用量用法：0.3~2.4g，入煎剂。或入丸、散剂，外用适量。

有报道用狼毒与鸡血藤、薏苡仁、半枝莲等制成复方狼毒注射液（每支 5ml 内含药量相当于生药狼毒 1g，鸡血藤 2g，薏苡仁 2g，半枝莲 4g）每日一次，每次 10~20ml 可于 5% 葡萄糖注射液内缓慢静脉滴注。或狼毒片（每片重 0.5g，内含药量相当于生药狼毒 1g，鸡血藤 2g，半枝莲 4g，莪术 2g）口服，每日三次，每次 2~4 片。治疗 20 例晚期胃癌，在术前用药可以缓解症状，为手术创造条件，手术后用药可稳定病情。用药后一般有止痛，增进食欲等作用。常见副作用有恶心、呕吐、头晕、轻度腹泻及白细胞轻度下降。在治疗剂量下未发现心、肝、肾功能损害。

本品有毒，一般多作外用，内服一定注意用量。外用刺激皮肤。

马前子（马钱子、番木鳖、方八）

性味功用：苦、寒、有大毒。入肝、肾、脾经。消肿散结，通络止痛。

主治应用：①用于多种癌症，特别是胃癌等。经严格加工炮制后，再配以甘草等解毒药制成丸剂应用。成药如平消片，临床上有一定近期疗效，能改善症状，稳定效果。②用于风湿所致的筋骨拘挛，麻木瘫痪，坐骨神经痛以及跌打损伤，面神经麻痹，重症肌无力等。③用于疔疽肿毒，喉痹肿痛，瘰疬恶疮等症。

现代研究：含生物碱，番木鳖碱（土的宁），马钱子碱（布鲁生），异番木鳖碱， α - β -可鲁勃林，番木鳖次碱，马钱子新碱，多糖类、绿原酸，棕榈酸等。

本品中番木鳖碱有兴奋脊髓，脑神经作用，提高味、触、听、视觉等感官的功能，中毒剂量时可产生强直性惊厥而致窒息。动物试验证明有抗肿瘤作用，对小鼠 S_{180} 及白血病细胞有抑制作用。所含绿原酸有升白细胞作用，临床上也可用于治疗化疗所致白细胞减少症。

用量用法：内服一日量不超过 0.5g。炮制后入丸散应用。炮制方法及程度要恰当，炮制过重则效力大减，炮制过轻则毒性大。

中毒解救：①轻者香油一盞，白沙糖 30g，加开水灌服。②重者用肉桂 6g 煎水急服。③巴比妥类静注或水合氯醛灌肠。④高锰酸钾洗胃。

藤黄

性味功用：酸、涩、辛、温，有大毒。破瘀散结，消肿止痛，攻毒蚀疮，杀虫止痒。

主治应用：①用于治疗各种恶性肿瘤，以乳腺癌、恶性淋巴瘤、胰腺癌、宫颈癌、肝癌等为主。一般用药后 7~10 日开始生效，表现为食欲增加，腹胀减轻和瘤体不同程度的缩小。②用于痈疽肿毒及跌打损伤。

现代研究：含藤黄酸，别藤黄酸，次藤黄酸和树胶等。藤黄注射液 100ug/日×10，腹腔注射，对小鼠腹水型肝癌，艾氏腹水癌、肉瘤₁₈₀、肉瘤₃₇ 的抑制率为 35.6%~80%，与对照组相比，有显著差异（ $P<0.05$ ）。另外，对 U_{14} 、 M_{737} （小鼠乳腺癌瘤株）有一定抑制率。藤黄酸单体 50ug/ml 浓度，30 分钟内能直接杀灭癌细胞。藤黄酸，别藤黄酸在体外对人体肝癌细胞（BEL-7402）及海拉细胞均有不同程度的杀伤作用。静脉注射后，家兔的肝、肾、肺脏病变较明显。毒性反应与用药方式关系密切。

用量用法：0.09~0.15g，入丸剂，不入煎剂，外用适量。藤黄注射液，每支 100mg，每次 100~200mg 加入 5% 葡萄糖液

250~500ml 内，静脉滴注，每用 2~3 次；藤黄片，每片 30mg，每日三次，每次 2~3 片，口服。

注意：本品有大毒，应严格掌握用量，不可多服，以免中毒。

雷公藤（断肠草）

性味功用：苦、大毒，消肿止痛。

主治应用：①恶性淋巴瘤、肝癌。②类风湿性关节炎。

现代研究：含多种生物碱及二萜化合物、雷公藤内脂二醇、雷公藤内脂酮，卫矛醇等。雷公藤内脂醇、雷公藤内脂二醇对小鼠白血病 L₁₂₁₀、P₃₈₈ 有抗肿瘤活性，其有效量为 0.1mg/kg。雷公藤内脂醇对人鼻咽癌 KB 细胞有抑制作用。对心血管有毒性，中毒时产生恶心、呕吐、腹痛、腹泻，血压下降，心脏及呼吸抑制，甚至死亡。

用量用法：雷公藤片剂（每片相当于生药 3.3g）每日三次，每次 3 片。昆明山海棠片，每日三次，每次 2~3 片。

注意：本品有大毒，应用切勿过量。

全蝎（全虫）

性味功用：咸、辛、平、有毒。入肝经。解毒散结，熄风止痉，通络止痛。

主治应用：①用于晚期癌症疼痛。脑瘤，脑转移癌等。②疮疡肿毒，瘰疬结核。③急慢性惊风，中风面瘫，破伤风等痉挛抽搐等证。④顽固性偏正头痛，风湿性痹痛等证。

现代研究：含蝎毒素，三甲胺、甜菜碱，胆甾醇、牛黄酸、铵盐等。本品有抗惊厥作用，蝎毒素有溶血及麻痹呼吸中枢作用，全蝎制剂有抗癌、降压、镇静等作用，其水提物对结肠癌细胞，醇提取物对人肝癌细胞有抑制作用。

用量用法：3~10g，水煎服。研末吞服，每次 0.5~1g。外用适量。

注意：本品有毒，用量不可过大，血虚生风者慎用。

蜈蚣（百足）

性味功用：辛、温、有毒。归肝经。解毒散结，熄风止痉，通络止痛。

主治应用：①用于脑瘤及脑转移癌，骨癌或晚期癌症剧痛者。②疮疡肿毒，瘰癧溃烂，虫蛇咬伤。③惊风、癫痫、痉挛、头痛及关节肿痛。

现代研究：含组织胺样物质及溶血蛋白质，蚁酸、胆甾醇、酪氨酸、亮氨酸、脂肪等。蜈蚣连用三天以上有抗惊厥作用。蜈蚣对 S_{180} 、 L_{160} 、 D_6 、艾氏腹水癌、 W_{256} 有抑制作用。蜈蚣在体外对人肝癌及胃癌细胞有抑制作用，对小白鼠肝癌瘤体亦有抑作用。

本品所含组织胺具有扩张血管、增加毛细血管通透性和促进胃液分泌等作用。对脑皮层有抑制作用，对小脑有兴奋作用。有增强网状内皮系统细胞机能的作用，但长期应用对肝脏有损害。

用量用法：1~3g，入煎剂。或研细末，每次服 0.5~1g。或每日 1~3 条，焙干研粉。外用适量。

蟾酥

性味功用：甘、辛、温，有毒。入胃、心经。解毒开窍，止痛消肿。

主治应用：①治疗肺癌、肝癌、宫颈癌及消化道癌。②疗毒痈肿，咽喉肿痛，扁桃体炎。③用于放、化疗引起的白细胞减少症。

现代研究：含蟾蜍毒素。加工过程中可被分解为多种甾体化合物及其他产物，如华蟾毒精、蟾毒它灵，沙蟾毒精、蟾毒季胺、蟾力苏、5-羟色氨等。蟾毒配基对鼠 W_{256} 抑制率较高。蟾皮提取物对小鼠肉瘤 S_{180} 和兔 B、P 瘤都有较满意的效果。用美兰试管法及呼吸法，对白血病细胞有较强的抑制作用。对小鼠精原细胞、腹水细胞、肝癌无抑制作用，但能延长其生存期，并增强网状内皮系统细胞的功能。与环磷酰胺等抗肿瘤药物合用对肿

瘤有抑制作用。

蟾蜍所含多种成份均有强心作用。有呼吸兴奋及升压作用，其中以脂蟾毒配基作用最强。有抗炎、升高白细胞、抗辐射作用。

用量用法：内服一次量为 15~30mg，入丸散中。本品毒性
强，需严格掌握用量，以免中毒。

麝香（元寸，当门子）

性味功用：辛、温、芳香，入心脾经。开窍醒神，活血散结，通络止痛。

主治应用：①试用于多种肿瘤及癌痛。②用于热病神昏痉厥，中风痰厥，惊痫等闭症。③内服或外用于疮疡肿毒，血滞经闭、腹中包块，症瘕、跌打损伤及痹痛等。④用于胎死腹中或胞衣不下等症。

现代研究：含麝香酮 0.5%~2%，我国已人工合成。此外尚含麝香酮，麝香吡啶，还有许多雄烷衍生物，如雄甾酮等，以及胆甾醇类化合物，蛋白质、氨基酸、脂肪、尿素、铵盐等。本品对中枢神经系统具双相调节作用，小剂量兴奋，大剂量抑制；有抗炎及抗菌作用，天然和人工麝香酮的不同制剂对小鼠艾氏腹水癌，小鼠肉瘤 S₃₇ 及肉瘤 S₁₈₀ 细胞的呼吸亦有一定作用。但在动物体内未能观察到治疗效果。动物实验证明，麝香对 U₁₄（小白鼠子宫颈）、小鼠肝癌有一定抑制作用。经免疫学试验，认为能提高机体一定免疫力。麝香能增加异丙肾上腺素等对 β -肾上腺素能受体有直接兴奋作用。对离体子宫有兴奋和收缩作用。

用量用法：0.1~0.15g，入丸散中用，不入煎剂。外用少许敷贴患处。

僵蚕（白僵蚕、姜虫、天虫）

性味功用：咸、辛、平。入肝、肺经。化痰散结，息风镇痉，消肿止痛。

主治应用：①治疗白血病，恶性淋巴瘤、肺癌、喉癌、肝

癌、脑瘤等。②疮疡肿毒，瘰癧结核，中风失语，癫痫等。③发热抽搐，头痛头风，目赤咽喉肿痛等。

现代研究：含蛋白质、脂肪、体表白粉中含草酸铵。对硝酸盐的宁引起的惊厥有明显对抗作用。以蚕蛹经白僵菌发酵制成僵蛹，其煎剂对小鼠 SI_{180} 有抑制作用。所含蛋白质有刺激肾上腺皮质的作用。

用量用法：6~10g，水煎服。或入丸散中用。

守宫（壁虎、天龙）

性味功用：咸、寒、有小毒，熄风镇痉，散结止痛。

主治应用：①治疗各种恶性肿瘤，试用于食道癌有开道关作用。②用于治疗瘰癧结核，恶疮漏管，癫痫惊风，关节疼痛等。

用量用法：1.5~4.5g，水煎服。或焙黄碾粉，每日2~3次，每次1~2g，黄酒冲服。或活守宫浸酒，治疗食道癌。

现代研究：含蛋白质，有毒物质及组织胺样物质。体外试验证明水溶液可抑制人体肝癌细胞的呼吸；对结核杆菌及常见致病真菌也有抑制作用。

蜂房（露蜂房、马蜂窝）

性味功用：甘、平、有毒。入肝、胃经。祛风解毒，消肿止痛，止血杀虫。

主治应用：①用于胃癌，特别是溃疡型，食道癌等，配以蛇退，血余，陈棕炭等同用。其他可用以治疗鼻咽癌、乳腺癌、骨肉瘤、肺癌等。②用于乳腺炎、淋巴腺炎，腮腺炎等。③用风火牙痛，龋齿痛，痈痛，瘰癧、风痹疥癣等。现代研究：含挥发油（蜂房油），为有毒成份，尚含铁、钙、蛋白质等。体外试验证明能抑制肝癌细胞；对胃癌细胞亦有抑制作用。本品浸出液皆能增强心脏运动，有利尿、促进血凝（止血）等作用。本品毒性强，能致急性肾损害。

用量用法：3~10g，入煎剂。或烧存性研末，每次0.6~1.5g服。

徐长卿

性味功用：辛、温、有小毒，气香。归心、肝、胃经。镇静止痛，解毒消肿，祛风止痒，行气化湿。

主治应用：①各种癌症，常用于肺癌，肠癌，恶性淋巴瘤等。对癌症患者疼痛有止痛作用。②用于牙痛、胃肠痛、胆绞痛等。③亦可用于风湿性皮炎、荨麻疹、湿疹、带状疱疹、顽癣、牛皮癣、皮肤瘙痒等症，止痒优效，为治皮肤病之要药。④用于泄泻、痢疾、湿脚气、水肿、腹水等证。

现代研究：含丹皮酚、黄酮甙、氨基酸等。有镇痛作用，使小鼠痛阈提高。并有解痉作用，对抗氯化钡、组织胺、乙酰胆碱引起大白鼠离体回肠的强烈收缩。有抑菌作用。

用量用法：6~15g，水煎服。用于止痛时用量常达30g。

两面针

性味功用：辛、苦、微温，有小毒，散瘀止痛，解毒消肿，祛风活络。

主治应用：①试用于癌症疼痛。②用于风湿痛，跌打损伤疼痛。③蛇咬伤。④烧伤烫伤。

现代研究：含两面针碱，氧化两面针碱，布枯甙，叶含挥发油等。氧化两面针碱有抗肿瘤作用，对小鼠 P-388、L₁₂₁₀ 白血病及艾氏腹水癌均有显著活性。低剂量（20mg/kg）时，48 小时对艾氏腹水癌细胞或 S 期细胞均无杀灭作用，但能抑制其 DNA 合成，细胞合成蛋白质的能力也受到一定的抑制，药物使细胞阻断于 G₂ 期。被阻于 G₂ 期的细胞可不经 M 期而直接合成 DNA，然此种合成能力较正常细胞弱；大剂量（40mg/kg）氧化两面针碱对 S 期细胞可能直接杀灭作用，并使受阻于 G₂ 期的细胞失去合成 DNA 的能力。

此外，有局麻、镇咳及较强的镇痛作用。

用时用法：根 10~15g，水煎服，粉末 1.5g 水冲服。本品有毒，不宜常服。

苍耳草

性味功用：辛、苦、温，有小毒。入肺经。通鼻窍，祛风湿止痛，杀虫止痒，解毒散结。

主治应用：①治疗鼻咽癌、脑瘤、甲状腺癌、骨肉瘤、鼻腔及副鼻窦癌。常与蚤休、贯众、鹅不食草配伍应用。②慢性鼻窦炎，过敏性鼻炎，头痛，风湿痛。③疥疮及皮肤性感染等。

现代研究：子含苍耳子甙， β -谷甾醇，豆甾醇，脂肪油。种仁有毒，有毒成份报告不一。叶含苍耳内醇，隐苍耳内醇及胆碱等。全草含挥发油，咖啡酸、奎尼酸，黄酮和氢醌。

根的甲醇提取物对小鼠肉瘤₁₈₀有抑制作用，对艾氏腹水癌有抑制作用。种仁浸液的毒性作用主要为肝脏、肾脏受损害，肺和脑水肿，引起惊厥，反应迟钝，以致呼吸困难而死亡。

用量用法：苍耳子 3~9g，苍耳草 9~15g，水煎服。

白屈菜

性味功用：苦、寒，有小毒。消肿止痛，利水止咳。

主治应用：①试用于胃癌，肝癌及肿瘤疼痛。②治疗急慢性胃炎，胃溃疡及脘腹疼痛。③用于痰热咳嗽或久咳无痰及湿热黄疸、水肿、皮肤疣鸡眼、湿疹、疥疮、虫咬伤等症。

现代研究含多种生物碱，如白屈菜碱、原阿片碱等物质。白屈菜碱对小鼠移植性腹水癌细胞呈显著的阻断分裂作用。原阿片碱亦有抗癌作用。40%白屈菜甲醇提取物有明显的抗癌活性，有谓白屈菜提取物对小鼠淋巴白血病 L-1210 及大鼠 W₂₅₆ 并无抑制作用，但在组织培养中对 PKB 鼻咽癌细胞呈细胞毒作用。白屈菜的纯甲醇提取物对小鼠肉瘤₁₈₀ 和小鼠艾氏腹水癌有明显抑制作用，毒副作用较小，连续给药 7 天，总剂量 350 和 700mg/kg 时，对小鼠肉瘤的肿瘤指数为 0.44~0.55，对小鼠艾氏腹水癌的肿瘤指数为 0.44~0.52。

用量用法：10~15g，水煎服。本品有小毒，不宜用量过大。临床上常用于消化道肿瘤，因含有镇痛成份，故常用于癌性

疼痛，亦用于癌性胸腹水。

寻骨风（白毛藤）

性味功用：苦、平。入肝经。祛风湿通经络，消肿止痛。

主治应用：①试用于肺癌、胃癌、骨肿瘤、宫颈癌及癌性疼痛。②用于风湿痹痛，肢体麻木，筋骨拘挛和跌打损伤疼痛等。此外，本品的止痛作用尚可用于胃痛、牙痛、疝痛等。

现代研究：含生物碱，挥发油及内脂等。本品全草的粉末混于饲料中喂小鼠，对艾氏腹水癌和腹水总细胞数有明显抑制作用，对艾氏腹水癌皮下型瘤亦有明显效果。煎剂内服也有效。煎剂对风湿性关节炎，类风湿性关节炎有较好的止痛、消肿，改善关节功能的作用。能使红血球沉降率明显下降或恢复正常。

用量用法：15～30g，水煎服。

雄黄

性味功用：辛、温，有毒，入肝、大肠经。燥湿祛痰，解毒杀虫，化瘀消肿，止痛止痒。

主治应用：①主要用于慢性粒细胞白血病。亦可用于皮肤癌，子宫颈癌、唇癌、阴茎癌、乳腺癌等。②用于疮疖疔毒，疥癣及虫蛇咬伤等症。对疮毒的解毒作用极强，并能止痒。③古方常用于预防时疫，疟疾、泄痢等。

现代研究：主含硫化砷（ As_2S_2 ），含砷约75%，硫24.9%及其金属盐。雄黄对小白鼠肉瘤₁₈₀有抑制作用，对人子宫颈癌细胞培养株系有抑制作用，抑率在90%以上。砷化物与组织中蛋白质中的SH基结合，使蛋白质失去活性，因而抑制白血病细胞的过分增殖，起到治疗慢性粒细胞白血病的作用。此外，有杀菌作用，对多种皮肤真菌有抑制作用。对鼠疟有抑制疟原虫作用。

用量用法：内服每次0.2～0.4g，入丸散剂，外用适量。

注意：切忌火煅，煅烧后即分解氧化为三氧化二砷（ As_2O_3 ），有剧毒。雄黄能从皮肤吸收，故局部外用亦不能大面

积涂擦及长期应用。

石蒜（老雅蒜、蒜头草、野毒蒜）

性味功用：辛、甘、温，有毒，消肿散结，解毒杀虫，催吐祛痰，镇静镇痉。

主治应用：①治胃癌、肝癌、食管癌、肺癌、淋巴瘤，卵巢癌、宫颈癌及头面部恶性肿瘤。②用于淋巴结核，疔疮疖肿，风湿性关节炎、蛇咬伤。③用于食物中毒，痰涎壅塞、黄疸、水肿、腹水等。④用于肌无力，肌营养不良、脊髓灰质炎后遗症，神经系统感觉运动障碍，多发性神经炎，脊神经根炎等。

现代研究：含多种生物碱，主要为石蒜碱，加兰他敏，石蒜伦碱，多花水仙碱，石蒜胺碱，伪石蒜碱等。药理作用：石蒜碱对小鼠肉瘤₁₈₀抑制率达40%~50%，伪石蒜碱及其盐类对大鼠W₂₅₆的生长有明显的抑制作用，对小鼠肝癌，艾氏腹水癌皮下型，肉瘤₁₈₀的抑制不明显，但能延长Rausohen白血病小鼠的生存期，其作用高于环磷酰胺和长春新碱。将石蒜碱进行结构改造，制成石蒜碱内胺（氧化石蒜碱AT₁₈₄₀）对多数动物肿瘤有显著的抑制作用。临床表明：AT₁₈₄₀对胃癌、肝癌、头面部恶性肿瘤等有效，且无血象副作用。

此外，有镇静作用，石蒜碱镇静作用不强，但能增强吗啡、延胡索镇痛能力。尚有解热、催吐、抗炎等作用。石蒜碱对胆碱脂酶有抑制作用，但较加兰他敏弱。还有祛痰作用。

全草有毒，以根毒性大，主要有毒成份为生物碱，如石蒜碱、加兰他敏（雪花莲胺碱）伪石蒜碱，多花水仙碱、石蒜伦碱，石蒜胺碱等。中毒表现：流涎、恶心、呕吐、腹泻、大便呈水样便或血便，惊厥或四肢痉挛，血压下降，休克。重者呼吸麻痹。中毒的治疗：①3%~5%鞣酸或1:2000高锰酸钾洗胃，洗胃完毕，内服硫酸镁或硫酸钠导泻。②阿托品口服或皮下注射。③补液对症治疗。

用量用法：石蒜碱内胺盐注射液，每日或隔日1次，每次

100~150mg (10~15ml) 加入 5% 葡萄糖注射液 250~500ml 中静脉滴注, 总量 1500mg 为一疗程。

巴豆

性味功用: 辛热, 有大毒。归胃、大肠、肺经。泻下冷积, 逐痰行水, 蚀疮攻毒, 利咽散结, 截疟。

主治应用: ①用于食管癌、胃癌、宫颈癌, 皮肤癌及癌性胸腹水。②喉痹, 恶疮疥癣。③肠梗阻及胆绞痛。

现代研究: 本品含巴豆油, 毒性蛋白, 巴豆树脂, 生物碱, 巴豆甙等。巴豆油中含多种油酸的甘油酯; 油中还含有强烈刺激肠壁引起峻泻作用的物质和致癌成份。巴豆毒蛋白有抗肿瘤作用, 对小鼠肉瘤实体型和 S_{180} 腹水型, 小鼠宫颈癌 U_{14} 实体型和 U_{14} 腹水型以及艾氏腹水癌皆有明显的抑制作用。巴豆注射液在试管内有杀灭癌细胞的作用。巴豆醇二脂对小鼠淋巴细胞性白血病 $P-388$ 有一定的抑制作用。巴豆油乳剂给大鼠移植性皮肤癌内注射, 能引起瘤体退化, 并延缓皮肤癌的发展。因而认为巴豆中含有抗癌活性物质。但巴豆油及其成份十四烷酰巴豆脂的乙酸盐可致小鼠皮肤增生, 巴豆醇酯 C 能改变小鼠胚胎纤维母细胞膜的结构和通透性; 巴豆油和牛的丙种球蛋白抗原一起给豚鼠注射, 能抑制抗体的生成, 并延长抗原反应, 巴豆醇免疫抑制作用比巴豆油更强, 此种免疫抑制作用亦可能是促使肿瘤发生的原因之一。

用量用法: 作丸、散剂服多用巴豆霜, 一次量: 0.1~0.3g。取净巴豆仁捣碎, 用多层吸油纸包裹加热微烘, 压榨去油, 余渣碾细末称为巴豆霜。

注意: 本品毒性大, 巴豆 8~10 粒给狗灌胃可致死; 人服巴豆油 1g 约 20 滴亦可中毒致死。服用此类丸散时, 中病即止, 切勿过量。外用或局部治疗时, 多以煎油涂患处。但亦不可久用, 以免刺激伤面或中毒。畏牵牛。

信石 (白砒、砒石)

性味功用：辛、大热。有剧毒。归肝、肺、胃经。外用蚀疮祛腐，解毒杀虫，内服截疟，劫痰平喘。

主治应用：①治疗皮肤癌、宫颈癌、唇癌、阴道癌、乳腺癌等。②痔瘘、瘰癧、痈疽、牙疳等。③治疗诸癣及截疟。

现代研究：信石为砷华矿物或毒砂、雄黄等含砷矿物制成。主要含三氧化二砷。质地纯净者为银白色晶体，性脆有光泽，称白砒。红砒为不纯品，除含 As_2O_3 外，尚含有二硫化砷与三硫化砷及铁、钴等杂质，其色粉红，故称红砒，不宜入药。生砒经反复炼制升华后，得纯净的 As_2O_3 ，成白色粉末，即砒霜，其毒性更大。

砷为细胞原生质毒，有杀灭活体细胞的作用，亦能杀灭所有接触的恶性肿瘤细胞，对小白鼠肉瘤 S_{180} 有抑制作用。对细菌、原虫、螺旋体均有杀灭作用。能麻痹毛细血管、抑制含硫基酶的活性。毒性极大，对人体的肝、肾、毛细血管的损害极为显著。急性中毒可致血压下降及循环衰竭，肝肾细胞变性坏死，慢性中毒可引起内脏器官变性，末梢神经炎，皮肤及粘膜营养障碍。

用量用法：外用适量。内服每次 0.002~0.004g。

注意：肝肾及心功能障碍者慎用，孕妇忌用。

轻粉（汞粉）

性味功用：辛、寒、燥，有毒。归肝、胃、肾经。攻毒杀虫、止痒敛疮、逐水通便。

主治应用：①主要用于治疗皮肤癌、宫颈癌、乳腺癌、淋巴肉瘤等体表肿瘤，常制成复方散、膏、栓、钉等外用。②用于疥癣、黄水疮、臁疮及梅毒恶疮等症，为强有力的攻毒药，并能止痒。③内服有利尿作用，又能刺激肠蠕动，有通便作用，用于水肿及大小便不利之实证。

现代研究：主要含氯化亚汞（ Hg_2Cl_2 ），能直接作用于肾脏而有利尿消肿作用，能刺激肠壁增加其反射性蠕动，促进肠液分

泌而发生腹泻；部分患者有腹痛及里急后重等刺激反应。局部应用对蛋白质有凝固作用，对某些真菌有抑制作用。汞是一种原将毒，汞化物对人体具有强烈的刺激性和腐蚀性作用。汞在体内与各种酶的巯基具有特异性的亲和力，能抑制许多酶的活性，引起中枢神经和植物神经功能紊乱。汞离子与各器官组织蛋白质结合成汞蛋白，从而导致细胞发生营养不良性改变，甚至坏死。临床中毒表现为坏死性肾病，急性腐蚀性胃肠炎，周围循环衰竭等。慢性中毒表现以神经衰弱症候群为主。

用量用法：外用适量。内服每次 0.1~0.2g，一天不超过两次，多作丸剂或装入胶囊内服，服后要漱口，防止刺激口腔引起糜烂。肾炎水肿忌用。过量易导致流涎，口干、腹痛等症状。

斑蝥（芫青、花壳虫、章瓦）

性味功用：辛、寒、有大毒。入肝、胃、肾经。破血散结，攻毒蚀疮发泡，破症瘕积聚，抗肿瘤。

主治应用：①用于肝癌、食管癌、贲门癌、胃癌、肺癌、乳癌等恶性肿瘤。②用于症瘕积聚，有破症散结作用。③用于瘰癧，恶疮死肌及顽癣瘙痒等。

现代研究：含斑蝥素约 1%~1.2%，尚含挥发油，蜡样物质，蚁酸等。我国合成了斑蝥酸钠，羟基斑蝥胺，其治疗指数较斑蝥素高而毒性低。斑蝥的水、酸或丙酮提取物体外试验，能抑制海拉（HeLa）细胞和人的食管癌、贲门癌、胃癌、肝癌细胞的代谢。斑蝥素或斑蝥提取物对小鼠移植性肿瘤的生长也明显抑制作用。实验观察到斑蝥素主要影响了癌细胞的核酸和蛋白质的合成。甲基斑蝥胺对动物实体瘤作用优于斑蝥素，毒性则较低对肝脏毒性小，但对肾脏仍有一定的毒害。斑蝥酸钠对 S_{180} 、 U_{14} 、艾氏腹水癌及肝癌腹水型有明显抑制作用。用于食管癌和贲门癌有一定意义，癌组织周围淋巴样细胞有改善。对原发性肝癌、肠癌、肝炎、肝硬化等也有一定疗效。对 L_{615} 白血病无效。羟基斑蝥胺的毒性仅为斑蝥素的 1/500，对原发性肝癌有

一定的疗效，对贲门癌、胃癌及肠癌略有疗效。

斑蝥素可由皮肤吸收，由肾脏排泄，可引起出血性尿路炎症。毒性试验证明对心、肝、脾、肺、肾均有不同程度的损害。其治疗量与中毒量相距较近。

用量用法：30~60mg（1~3只），炮制后水煎服。或研末入丸、散用。

本品为剧毒药，中毒量约为1g，致死量为3g，斑蝥素致死量约为30mg。服斑蝥制剂后如尿血，腹痛不止，应立即停药，重者立即洗胃，并内服牛乳、鸡蛋清或用绿豆50g，甘草9g，黄连3g水煎服。服药期间多饮开水或绿茶以减轻泌尿系统反应。本品宜饭后服用。

蜣螂

性味功用：咸、寒、有毒。破瘀解毒，消肿止痛。

主治应用：①用于食管癌、贲门癌、胃癌等。②用于噎膈，反胃、症瘕、血痢、恶疮等。

现代研究：含蜣螂毒素约1%，蜣螂的醇提取物对人体肝癌细胞有抑制作用。蜣螂毒素对神经肌肉有麻痹作用，对家兔肠管及子宫有抑制作用。

用量用法：1.5~3g，入煎剂，或入丸散中服。外用碾粉撒患处。

注意：本品性猛有毒，孕妇忌服。

雪上一枝蒿

性味功用：苦、辛、热，有大毒。活血止痛，祛风散结。麻醉。

主治应用：试用于胃癌、食管癌、肺癌及癌性疼痛。用于跌打损伤、风湿痹痛，泡酒外敷可止痛。

现代研究：含一枝蒿素A、B、C、D、E等。有的含乌头碱，海帕乌头碱。本品能提高小鼠痛阈47%。本品有抗肿瘤作用，试用于肺癌，消化道肿瘤。

用量用法：本品有剧毒，内服每次用量不得超过 30mg，注射液每毫升相当于原药 25mg，每次 10~25mg，日总量不得超过 50mg，肌肉注射。口服安全剂量为 150mg 以内。已有制成片剂应用者。

六、利湿逐水药

凡以通利水道，祛湿逐水为主要作用的药物称为利湿逐水药。痰湿凝聚是肿瘤形成的病机之一，在治疗上，除以化痰散结、行气开郁外，还需配合健脾利湿药，使痰湿有所出路，甚者亦可给以逐水利湿之品，使湿邪得以消除。但本类药多服久服能耗伤阴液，临床上应根据病情与其它药物配合应用。

茯苓（云苓、白茯苓）

性味功用：甘、淡、平。归心、肺、脾、膀胱经。利湿消肿，健脾和中，宁心安神。

主治应用：①用于肿瘤患者有脾虚证或在化疗期间作健脾益气扶正之用。②用于水湿停滞，食欲不振。③惊悸、失眠。

现代研究：含茯苓聚糖、茯苓酸、蛋白质，组氨酸，胆碱、 β 茯苓聚糖酶，麦角甾醇、钾盐等。茯苓聚糖本身无抗肿瘤活性，若切断其支链，成为单纯的 β 葡萄糖聚糖，称为茯苓次聚糖，则有明显的抗肿瘤活性，对 S_{180} 抑制率可达 96.88%。据报道，茯苓聚糖能显著增加环磷酰胺、氟尿嘧啶，长春新碱等对动物肿瘤的抑制作用。对动物免疫有促进作用，有利尿、强心、镇静等作用。

用量用法：6~18g，水煎服。

附根而生者称为茯神，性味同茯苓，但宁心安神力强，茯苓皮则专利水消肿。

猪苓（野猪粪、粉猪苓）

性味功用：甘、淡、平。归胃、膀胱经。利水渗湿，消肿。

主治应用：①猪苓提取物与抗化学药物结合治疗各种癌症，或单用以提高患者免疫功能。②水湿停留，水肿、小便不利，泻

泄、淋证、胸水腹水等。

现代研究：茵核含麦角甾醇、粗蛋白、水溶性猪苓多糖，无机物及维生素 H。猪苓提取物对小鼠 S_{180} 的瘤体抑制率达 50~70%，瘤重抑制率在 30% 以上；对荷瘤小鼠有丝分裂旺盛的正常组织 DNA 生物合成无抑制作用；猪苓提取物能增强荷瘤小鼠的免疫功能，使单核巨噬细胞系统活性正常，脾脏抗体形成细胞增多，腹腔巨噬细胞吞噬活力提高；并可增强荷瘤小鼠脾淋巴样细胞对瘤细胞的杀伤作用。还能提高 S_{180} 腹水型癌细胞内 cAMP 的含量。本品无毒性损害和副作用。据报道，猪苓多糖有轻微的增加环磷酰胺药物效用；对 Lewis 肺癌瘤体生长无抑制作用；而对自发性肺转移有一定影响；对放射治疗，猪苓多糖无增强敏感的作用。临床观察到与化学药伍用对原发性肺癌治疗能改善一般状况，增进食欲，增加体重，能明显提高肺癌患者的细胞免疫功能，减轻因化疗引起的免疫抑制和某些副作用。猪苓有利尿作用，能抑制肾小管对电解质的重吸收。作用较茯苓为佳。

用量用法：15~60g，水煎服。

猪苓多糖针，每日一次，每次 40mg，肌肉注射，20~30 日为一疗程。

薏苡仁（苡米）

性味功用：甘、淡、微寒，归脾、胃、大肠经。健脾利湿，清热排脓，除痹舒筋，止泻。

主治应用：①用于治疗胃癌、肺癌、肠癌、宫颈癌。②湿热内蕴，发热、便溏、小便短赤，纳少苔腻及水肿、脚气，常与叩仁、滑石、茯苓等同用。③肺痈、肠痈等。④皮肤疣及湿疹。⑤风湿性关节炎，筋脉拘挛等证。

现代研究：含薏仁酯，薏仁素，蛋白质，炭水化合物，甾醇，氨基酸、维生素等。薏仁脂对艾氏腹水癌有明显抑制作用，对胃癌有延长存活期效果。能明显延长动物的存活时间。据报道，苡仁丙酮提取物对小鼠子宫颈癌 $U-14$ （U-14）与 HCA（小鼠

肝癌实体)有明显抑制作用。薏仁素有镇静解热、镇痛等作用。

用量用法: 15~30g, 水煎服。

石苇

性味功用: 苦、微寒。归肺、膀胱经。利水通淋, 凉血止血。

主治应用: ①肺癌咳嗽、痰多胸痛等症; 膀胱肿瘤的尿血, 放化疗所致的血象下降及膀胱炎等。②用于尿路感染, 淋漓涩痛, 血淋等。

现代研究: 含绵马三萜、 β -谷甾醇, 庐山石苇含异芒果素, 延胡索酸及咖啡酸。并含有皂甙, 黄酮类及鞣质。石苇有提升白细胞作用, 对化疗或放疗所引起的白细胞减少有提升作用。能提高网状内皮系统局部吞噬能力。能增强机体抗病力。临床观察到石苇, 特别是异芒果素有镇咳、祛痰作用。石苇煎剂对金黄色葡萄球菌等有抑制作用。

用法用量: 15~30g, 水煎服。

半边莲

性味功用: 辛、平, 全草有小毒。入肺、肝、小肠经。清热解毒, 利水消肿。

主治应用: ①治疗肺癌、胃癌、卵巢癌、肾盂癌、膀胱癌等及癌性胸腹水。②用于肝硬化、肾炎、大腹水肿, 面目浮肿等。③用于毒蛇咬伤, 蜂蝎刺螫, 以及疮疮初期肿痛, 以本品外敷或内服。

现代研究: 全草含I-山梗菜酮碱、异山梗菜酮碱及皂甙, 黄酮, 氨基酸等。动物试验证明, 对小鼠肉瘤₃₇细胞有明显抑制作用, 半边莲碱 15mcg/kg 浓度时, 抑制小鼠腹水癌细胞对氧的呼吸, 浸剂对大鼠有强而持久的利尿作用, 煎剂及粗生物碱给麻醉狗静脉注射有兴奋呼吸, 增加支气管分泌, 降低血压和利尿作用。此外, 有抗菌、抗蛇毒的作用。

用法用量: 15~30g, 水煎服。常与半枝莲、白花蛇舌草、

龙葵、天胡荽、石打穿等伍用，治疗多种恶性肿瘤。特别是用于癌症患者有胸腹水或水肿时。本品过量服用，可引起中毒，主要有毒成份为山梗菜碱，山梗菜酮碱。

石打穿

性味功用：苦、辛、微寒。清热利湿，解毒消肿。

主治应用：①用于消化道癌，如食管、胃癌、肠癌、肝癌，亦用于治疗鼻咽癌、肺癌。治疗食管癌，贲门癌之噎可配以急性子、威灵仙，治疗胃癌，肠癌可以配菝葜、藤梨根、白英、龙葵等。治疗肝癌时可配以半枝莲、半边莲、金钱草等。②用于黄疸、痢疾、水肿、乳糜尿等。

现代研究：本品含花耳草素、三萜类化合物。另外还含 β -谷甾醇、 γ -谷甾醇、油酸等。对小鼠子宫颈癌₁₄有抑制作用。

用法用量：15~60g，水煎服。或鲜品捣汁服。

乌骨藤

性味功用：苦、微寒。通乳利尿、止咳平喘。

主治应用：①用于治疗各种癌症，均有不同程度的疗效。其中对宫颈癌、何杰金氏病、食管癌、胃癌的近期疗效较好，主要表现在症状明显缓解，促进食欲、消除痛苦，使病灶稳定或缩小。亦用于治疗淋巴肉瘤及白血病。②支气管炎及喘息性支气管炎。③乳汁不通，小便不利等。④外用治疗痈肿疔疮。

现代研究：藤茎中含生物碱与甾体皂甙，后者水解后所得甙元中主要为肉珊瑚甙元。另外，尚含多糖类、色素、树脂及油脂等。

对小鼠肉瘤₁₈₀有抑制作用。体外试验表明，乌骨藤溶液对肿瘤细胞有明显的抑制作用。其苦味甾体皂甙预防因组织胺喷雾引起的支气管痉挛，有一定的平喘作用。有报道本品对中枢神经系统具有毒性。

用量用法：15~30g，水煎服。乌骨藤片（每片0.5g，相当于生药2.5g）每日三次，每次3~5片，口服。乌骨藤注射液：

每毫升含药量相当于生药 0.5 或 2g，肌肉注射：每日 1~2 次，每次 2~4ml；静脉滴注，每日一次，每次 20~30ml（相当于生药 10~15g）加入 5% 或 10% 葡萄糖注射液 500ml 内，一个月为一疗程。

马鞭草（铁马鞭、退血草）

性味功用：苦、微寒。利尿消肿，破血通经，清热解毒，截疟杀虫。

主治应用：①治疗肝癌、子宫体癌；卵巢癌、恶性淋巴瘤、白血病、癌性胸、腹水等。②黄疸、肝硬化腹水、白喉、疟疾。③症瘕、闭经、血淋。④痈肿疮毒。

现代研究：全草含马鞭草甙，水解后得马鞭草醇和 D-葡萄糖；另含苦杏仁酶及鞣质。叶含腺甙及 β 胡萝卜素。动物试验马鞭草对小鼠子宫颈癌₁₄、肉瘤₁₈₀ 均有抑制作用。此外，水溶性提取物有消炎、镇痛作用。并对白喉杆菌、伤寒杆菌有抑制作用。对子宫平滑肌有兴奋作用。

用量用法：15~30g，水煎服。或入丸、散。外用：捣烂敷患处。

天胡荽

性味功用：辛、平。清热利尿，解毒消肿。

主治应用：①治疗肝癌、肾癌、肾盂癌、膀胱癌、白血病等。②急性黄疸型肝炎，急性肾炎，尿路结石及血尿。③带状疱疹、丹毒等，多用鲜品捣烂取汁搽涂或乙醇浸剂外涂。

现代研究：含黄酮甙、酚类、氨基酸、香豆精及挥发油。体外试验表明对白血病细胞有抑制作用，用荧光显微镜法抗白指数为 84.8%，另外有较强的抑菌作用。

用量用法：10~15g，水煎服。外用：鲜品捣汁或捣烂贴敷。

瞿麦（野麦、石竹）

性味功用：苦、寒。归心、小肠经。清热利尿，祛湿通淋、

止血。

主治应用：①用于食管癌、直肠癌、膀胱癌。②小便淋沥涩痛，尿血及膀胱湿热等证。

现代研究：全草含皂甙；花含挥发油。油中主含丁香酚、苯甲酸苄酯、苯乙醇、水杨酸甲酯等。据研究，瞿麦根、子、体外试验，抑癌率为90%以上。特点是对癌细胞有强烈的抑制作用而对正常细胞抑制较弱。对子宫颈癌细胞培养体系-26体外抑率在90%以上。并有兴奋肠管及降压、利尿等作用。对大肠杆菌、绿脓杆菌、伤寒杆菌等有抑制作用。

用量用法：5~10g，水煎服。治疗癌症用鲜石竹根30~60g（干根20~30g）水煎服。

七、其他抗肿瘤药

本类药是经现代研究有抗肿瘤作用或在临床上常辅佐其他药，用于抗肿瘤治疗的药物。

长春花（日日新、雁来红）

性味功用：微苦、凉。消肿散结，平肝降压。

主治应用：长春花碱适用于单核细胞白血病、恶性淋巴瘤、乳腺癌及支气管癌，精原细胞瘤和睾丸胚胎瘤。长春新碱适用于急性白血病，恶性淋巴瘤、乳腺癌前列腺癌、绒毛膜上皮癌、肾母细胞瘤和尤文氏瘤。常与其它抗癌药合并使用。

现代研究：全草含生物碱64种，其中二聚引哚类化合物24种：如长春碱（VLB）、长春新碱（VCR）、异长春碱（VRD）、环氧长春碱、长春文碱等。有抗癌作用。长春碱及长春新碱（VCR）对多种小鼠及大鼠肿瘤均有抑制作用，长春新碱抗癌谱更广，主要抑制有丝分裂。试验证明，还能抑制核酸的合成，对L₁₅₃₄、艾氏腹水癌，S₁₈₀腹水癌都有100%的抑制作用。有报告发现它能强烈抑制依赖DNA的RNA聚合酶的合成。谷氨酸能阻断长春碱、长春新碱对动物的抗癌作用和毒性作用。天门冬氨酸使动物免遭毒性而不影响其抗癌作用。主要毒性

有骨髓抑制、神经毒性、胃肠道反应、脱发、局部刺激及体位性低血压等。

其它生物碱尚有降压、利尿、降血糖、抗病毒等作用。

用量用法：单纯全草煎服用抗癌无效。只有提取的长春花碱和长春新碱制成注射剂，才显示抗癌效果。硫酸长春花碱粉针剂，每支 10mg，用 20ml 生理盐水稀释，静脉注射或在静脉注射时于胶皮管中静脉冲入每周一次。硫酸长春新碱针剂，每支 1mg，用 10ml 生理盐水稀释溶液后静注，或注于正在静滴的胶管中。每周 1~2 次。

注意：注射时二种药物切勿漏至皮下，以免皮下坏死。恶病质及全身明显衰弱者不宜使用。白细胞低于 $4.0 \times 10^9 / L$ 的患者亦不宜使用。

珍珠菜

性味功用：辛、微涩，解毒散结，祛瘀消肿。

主治应用：①治疗多种恶性肿瘤如消化道癌，肝癌、甲状腺癌、宫颈癌、白血病及淋巴瘤等。②用于瘰癧、乳痈、月经不调等。

现代研究：珍珠菜根含黄酮甙、皂甙等。种含多量脂肪油。动物试验发现，本品所含黄酮甙有较广的抗癌谱：对小白鼠淋巴瘤 1 号腹水型转实体（L1-皮下型）、网织细胞肉瘤腹水型的抑制作用较显著，对肝癌腹水型转实体、肝癌、肉瘤₃₇、肉瘤₁₈₀、子宫颈癌₁₄、艾氏腹水癌及其转实体、肉瘤₁₈₀ 腹水型、大白鼠 W₂₅₆ 等均有显著抑制作用。抑制作用主要是通过对瘤细胞有丝分裂相的抑制而实现的。珍珠菜黄酮甙对小鼠白血病₆₁₅ 有明显抑制作用，每日每公斤用 500~600mg 时，延长生命率 260.68%。珍珠菜毒性低。小白鼠一次腹腔注射珍珠菜黄酮甙的 LD₅₀ 为 1450mg/kg 体重。死亡均在 6 小时内发生，可有心、肝、脑、肺、肾的充血肿胀，血管内凝血等。

用量用法：20~30g，水煎服。

铁树（苏铁、凤尾蕉）

性味功用：叶：甘温。收敛止血，止痛消肿。种子有毒。固精涩带。

主治应用：试用于胃癌、肺癌、肝癌、宫颈癌及鼻咽癌等。此外，尚可用于肿瘤患者出血、疼痛。

现代研究：叶含双黄酮化合物，如苏铁双黄酮，扁柏双黄酮等。种子及叶均含氧化偶氮类甙：苏铁毒甙、新苏铁毒甙 A-G 等。有毒成份为毒甙类。动物试验证明，苏铁制剂对多种癌细胞有明显抑制作用，苏铁毒甙类有抑制肿瘤细胞增殖的作用。幼大鼠喂以掺有苏铁毒甙的饲料可使肝内 RNA 明显下降，葡萄糖-6-磷酸脂和 5-核苷酸酶活性降低，全部磷脂质下降，胆固醇和中性甘油酯升高，肝中央小叶的碱性磷酸脂以及血浆的胆碱脂酶活性升高。连续喂饲 2~3 周后，可诱致大鼠肾脏及肝脏肿瘤，其致癌作用系其甙元在体内使核酸碱基甲基化，因而引起染色体变型和实变所致。种子因含苏铁毒甙为主，故有致癌作用及其他毒性。肿瘤临床上常用其树叶。

苏铁毒甙只有在肠道内被细菌酶分解成苏铁毒甙元才产生毒性，故苏铁毒甙注射给药的毒性低于口服和灌胃。苏铁毒甙灌胃对小鼠和豚鼠的 LD_{50} 分别为 $1.67g/kg$ 和 $1.0g/kg$ 。动物的致死原因多为呼吸麻痹。动物死后解剖，可见肝呈脂肪性变、脾、肾、肾上腺及肺均呈退行性变化。

用量用法：叶 10~30g，水煎服。苏铁片：每片重 0.3g，内含药量相当苏铁叶生药 3g。

注意：种子和茎顶部树心有剧毒，采制宜慎。

乌头（川乌）

性味功用：辛温，有大毒。入肝、脾、三焦、膀胱经。祛风除湿，温经止痛。

主治应用：①治疗胃癌、肝癌、淋巴肉瘤、乳腺癌以及各种癌性疼痛。有的晚期胃癌腹腔转移疼痛难忍，以乌头碱注射液肌

肉注射，有止痛及延长生命的作用。②用于阴寒内盛所致的心腹剧痛、疝痛、阴疽肿毒。③痛风历节，风寒湿痹以及头风头痛等。

现代研究：川乌含多种生物碱，（海帕乌头碱、乌头碱、新乌头碱、塔拉地萨敏、川乌头碱甲、乙等。）其中主要是乌头碱，乌头碱毒性很大，但在烯酸或沸水中很容易水解为乌头次碱，进一步分解为乌头原碱。乌头次碱毒性为乌头碱的 $1/50$ ，乌头原碱约为乌头碱的 $1/200$ ，乌头若与含有机酸的药物（如乌梅）配伍，有机酸与生物碱结合成盐，有使其易溶于水而提高疗效。

乌头碱对肝癌细胞有抑制作用，还有强心、抗炎症作用，对垂体-肾上腺皮质系统有兴奋作用。有兴奋迷走神经、减慢心律，使心肌代谢及兴奋性发生改变；乌头碱对各种神经末梢及中枢先兴奋后麻痹，为麻醉、止痛的有效成分。乌头碱有剧毒，小鼠皮下注射的 LD_{50} 是 0.32mg/kg ，人口服乌头碱 $3\sim 5\text{mg}$ 即有中毒致死。

用量用法： $3\sim 9\text{g}$ ，久煎服，若作散剂或酒剂，应减为 $1\sim 4.5\text{g}$ ，外用适量碾末调敷，多用生草乌。

注意事项：

(1)本品生药药力较猛，毒性亦大，内服要经过炮制后（以黑豆、甘草加水共煎煮至乌头熟透，切片，晒干。）一般要先煎 $1\sim 2$ 小时，以减其毒。

(2)本品毒性大，用量不宜过大，也不宜久服。生川乌只供外用，但皮肤破损者不宜用。

(3)乌头中毒，唇舌发麻，恶心、手足发麻，继之运动失灵，呕吐、心慌、面白、肤冷，烦躁，痛觉减退，心律慢而弱，血压下降，呼吸缓慢，吞咽困难，言语障碍，呼吸中枢抑制。中毒重者应及时输液，给氧，注射呼吸兴奋剂及阿托品解救。

甜瓜蒂（苦丁香）

性味功用：苦、寒、有小毒。归胃经。涌吐宿食，破积污水，退黄祛痰。

主治应用：①治疗肝癌、胰腺癌、胃癌、贲门癌等。②急性肝炎及肝硬变。③热痰壅盛、咽喉闭塞、宿食内停、四肢浮肿及痫病癫狂等。

现代研究：本品含四环三萜类苦味质。其中分离出葫芦素 B、E、D、异葫芦素 B、葫芦素 B 葡萄糖甙。葫芦素、E 混合物称喷瓜苦素。抗肿瘤成分为葫芦素类化合物。体外实验证明：葫芦素类化合物能抑制某些人癌细胞和多种移植物肿瘤的生长，如对人体鼻咽癌细胞及子宫颈癌细胞均有直接的细胞毒作用；亦可引起艾氏腹水癌、固体黑色素瘤及腹水癌细胞变性。动物试验亦证明有抗癌作用。此外，葫芦素 B、E 和 B 葡萄糖甙对四氯化碳所致动物肝脏的急慢性损害有明显的保护作用，能有效地控制肝细胞的变性、坏死，使谷丙转氨酶活力下降，增加肝糖元积蓄，葫芦素 B 能加速组织的修复，抑制脂肪肝及肝纤维组织的增生，还可能有促进纤维组织重新吸收的作用。葫芦素能提高机体 T 细胞免疫功能，增强机体的抗病能力，有人认为葫芦素在逆转细胞免疫缺陷和激发细胞免疫功能等方面，都有类似转移因子 (TF) 的作用。

喷瓜素、甜瓜蒂粉或煎剂等，均能刺激胃肠道粘膜，引起呕吐及腹泻，甚至消化道出血，但静脉注射及皮下注射时则无此反应。甜瓜蒂有毒，大量应用可引起消化道、胰及其他脏器出血或瘀血，心肌纤维断裂，循环衰竭，呼吸麻痹而死亡。

用法用量：煎剂：每日 0.5~1.0g。散剂：研细末，吹鼻内少许治急性黄疸型肝炎及肝硬化，每日三次，每次间隔 40 分钟，每次吸入 20~30mg，两周内只用药一天为一疗程，一般用一至三个疗程。

葫芦素 BE 片：每日三次，每次 0.1~0.2mg，逐渐增至 0.6mg，用量以患者能适应为度。治疗肝炎、肝硬变时，每日三

次，每次 0.1~0.2mg。

注意：体虚弱者、孕妇忌用。治疗肝炎应注意肝炎合并心脏病。有心脏病者忌用。在治疗过程中严禁饮酒、吃刺激性食物（辣椒、生葱、大蒜）。

蝉蜕（蝉衣、蝉退）

性味功用：甘、微咸、凉。归肺、肝经。疏风清热、退翳透疹，止痒解毒。

主治应用：①治疗喉癌、鼻咽癌、甲状腺癌、肺癌等。亦用于脑瘤头痛抽搐者。②外感风热或温病初起，咳嗽音哑，疹出不畅，目翳惊痫、疔疮肿毒等。③小儿惊风和破伤风，夜啼等。

现代研究：本品主要含大量甲壳质；另含异黄质蝶呤及赤蝶呤。试验证明对人体子宫颈癌细胞培养株系有抑制作用，抑制率 95% 以上，对癌细胞抑制强，对正常细胞抑制弱，并有解热镇静作用。

用法用量：3~10g，水煎服。或入丸、散中。

白矾（明矾）

性味功用：酸、涩、寒，归肺、大肠、肝经。收敛止血，燥湿止痒，涩肠止泻，祛风痰。

主治应用：①治疗皮肤癌，乳腺癌及体表肿瘤之已破溃成恶疮者及宫颈癌、膀胱癌等。多入复方散、膏、丹、栓、钉剂中外用及熏洗。②用于风痰壅盛而发癫痫或痰阻心窍、精神失常之证。③治疗痔瘕、诸溃疡、阴蚀瘙痒、顽癣，衄血及金伤出血等。

现代研究：主要含硫酸钾铝，低浓度明矾有收敛、防腐作用；高浓度能腐蚀肌肉引起溃烂；对人型、牛型结核杆菌、金黄色葡萄球菌、伤寒杆菌有抑制作用。

用法用量：1.5~3g。外用适量。

第二节 抗肿瘤中成药及复方中药

近十几年来，国内医学界对历代医家千百年来治疗肿瘤的方剂、以及民间流传的抗癌单、验方和现代肿瘤临床上的经验方，进行了大量的研究和整理，取得了可喜的成果。现将临床研究证实有效的抗癌中成药和单验方选录如下。

复方天仙胶囊

方药组成：人参、黄芪、蟾蜍、蜈蚣、天南星、蛇蜕、没药、青黛、土元、枯矾、蜂房、斑蝥、乳香、天花粉、威灵仙、麝香、牛黄、冰片等。

功能：清热解毒，散结止痛。

适应证：食管癌、胃癌等。

用法用量：每日3次，每次服3~4粒。2个月为一疗程，疗程间隔1个月。

注意事项：无明显毒副反应，少数病人服后轻度恶心、食欲不振，纳差、腹泻、胸骨后及胃脘灼热不适，饭后服用可预防。

平消片（胶囊）

方药组成：枳壳30g，炒干漆6g，五灵脂15g，郁金18g，白矾18g，仙鹤草18g，火硝18g，制马钱子12g。

功能：攻坚散结，去腐生肌，解毒强心，利气止痛等。

适应证：肺癌、胃癌、食管癌、肝癌、恶性淋巴瘤等。

用法用量：每日3次，每次6~8片。

冬凌草

方药组成：由冬凌草提取的有效成分。

功能：清热解毒，活血祛瘀，消炎去肿。

适应证：食管癌、胃癌、肝癌、肺癌、胆囊癌、胰腺癌、鼻咽癌、喉癌。

用法用量：糖浆：每日3次，每次服30~50ml，每毫升含

生药 1g。

片剂：每日 3 次，每次 6~10 片，每片含生药 5g。

针剂：隔日 1 次，每次缓慢静滴 75~100ml，3000~4000mg 为一疗程。

鸦胆子乳剂

方药组成：鸦胆子中提取的有效成分。

功能：解毒清热，消积化湿，提高免疫功能。

适应证：食管癌、肝癌、肺癌。

用法用量：乳剂：每日 3 次，每次服 20ml，30 天一疗程。

针剂：每日 1 次，每次静脉滴注 10% 鸦胆子乳剂 30ml 加 5% 葡萄糖注射液 500ml，每分钟 30~50 滴，1 个月为一疗程。

注意事项：该药对胃肠道有刺激，影响肝肾功能，应用中注意观察。

玉枢丹

方药组成：山慈姑 60g，续随子（千金子）霜 30g，红芽大戟 45g，五倍子（去外毛内垢）60g，麝香 9g，腰黄 9g，朱砂 9g。

前四味研细末过箩，后三味分别研细末与上药拌匀，糯米面 100g 蒸糊压片切块，市售每锭 3g。

功能：消肿散结，避秽解毒。

适应证：胃癌、食管癌、淋巴肉瘤。

用法用量：口服，每次 1~3 锭（6~9g），开水化服。

注意事项：小量服。大量易引起恶心、呕吐、腹泻、白细胞下降。服药两周查血常规，白细胞低于 $4.0 \times 10^9 / L$ 以下，停药，白细胞即可回升。

华蟾素

方药组成：由蟾蜍中提取的有效成分。

功能：消肿散结，解毒排脓，通窍止痛。

适应证：胃癌、肝癌、肺癌、乳癌等。

用法用量：肌肉注射：华蟾素注射液 2~4ml，肌肉注射，每日 1~2 次。15~30 次为一疗程。静脉注射：华蟾素 10~20ml 加入 5% 葡萄糖 500ml 中静脉点滴，每日或隔日 1 次，2~4 周为一疗程。

注意事项：①本品使用安全，一般无副作用，个别病人如用量过大或两次用药间隔不足 6~18 小时，用后 30 分钟左右可能出现发冷现象，但 10 分钟后即恢复正常；②本品使用时应注意病人的心脏功能，避免与剧烈兴奋心脏的药物如氨茶碱，异丙基肾上腺素等配伍。

胡芦素片

方药组成：由甜瓜蒂中提取的有效成分。

功能：护肝、抑癌、抗癌、抗纤维化、增强和提高免疫功能。

适应证：肝癌。

用法用量：每日 3 次，每次服 0.4~0.6mg，2~3 个月为 1 疗程。

注意事项：本品有小毒，临床应用中必须严密观察病情变化。

复方木鸡冲剂

方药组成：木鸡、菟丝子、山豆根、核桃树皮。

功能：补肝肾、扶正固本，清热解毒，消症积。

适应证：肝癌及其它癌。

用法用量：煎剂：四味各 30g，每日 1 剂，分头道、二道煎服。冲剂：每日 3 次，每次服 1 袋（每袋重 25g）。

注意事项：本品可长期服用。

石上柏

方药组成：石上柏提取物。

功能：清热解毒，活血消肿，止血抗癌。

动物试验：对 S₁₈₀（小白鼠肉瘤），U₁₄（小白鼠子宫颈

癌)、L₁₆₀ (小白鼠白血病模型) 有抑制作用, 并有增强机体代谢和网状内皮系统功能。

适应证: 肺癌、鼻咽癌、喉癌、绒癌、恶性葡萄胎。

用法用量: 煎剂: 每日 30~60g, 分头道, 二道煎服。片剂: 每日 3 次, 每次服 7 片, 每片含生药 3g。

注意事项: 石上柏片制法: 取石上柏 300g 洗净加水煮 2 次, 每次各加水 1000ml, 煮 3 小时, 合并煎液过滤浓缩, 加醇至含醇量为 80% 静置 24 小时, 过滤去沉淀物, 滤液回收乙醇, 再浓缩成膏状, 加入适量淀粉使成软材制粒, 干燥, 压片, 制成 1000 片。

乌头制剂

方药组成: 川乌、草乌提取的有效成分。

功能: 除风祛湿, 温经止痛, 抑制肝癌细胞生长。

适应证: 肝癌等。

用法用量: 煎剂: 3~6g, 每日 1 剂煎服。针剂: 乌头碱注射液 100~300 μ g, 静脉滴注, 每日 1 次; 高乌甲素注射液 8mg, 静脉滴注, 每日 1 次, 连用 15~30 日。

注意事项: 乌头碱有毒, 临床应用必须慎重。中毒表现: 唇舌、手足发麻、恶心呕吐, 心悸、呼吸中枢抑制, 甚者中毒死亡。解救办法: ①甘草 30g, 绿豆 100g, 白糖 50g 煎服; ②白糖浓茶饮频服; ③静注阿托品或 654-2 注射液, 剂量根据中毒程度酌定; ④必要时输液、输氧、利尿等。

消癌平

方药组成: 乌骨藤中提取的有效成分。

功能: 清热解毒, 通乳利尿, 止咳平喘。

适应证: 肝癌、胃癌、胆囊癌、胰腺癌、肺癌等。

用法用量: 片剂: 每日 3 次, 每次服 4~6 片, 每片 0.5g, 相当于生药 2.5g。糖浆: 每日 3 次, 每次服 30~50ml, 每毫升含生药 0.5g。针剂: 肌肉注射每日 1 次, 每次 2~4ml, 每毫升

含生药 0.5g 或 2g。静脉滴注：每日 1 次，静滴 100ml，每毫升含生药 0.5~2g。1 个月为 1 疗程，疗程间隔 1 个月。

注意事项：一般无反应，个别患者静滴后出现游走性肌肉疼痛，轻度浮肿，颜面潮红。有时低烧，但连续静滴几次后自行消失。本品制剂商品名称消癌平。

大黄虻虫丸

方药组成：大黄 300g，生地 300g，黄芩、赤芍、水蛭、虻虫、蟅虫各 60g，桃仁（去皮）、杏仁（去皮）各 120g，干漆 30g，甘草 90g，虻虫 15g。

上药共研为极细面，炼蜜为丸，每丸重 3g。

功能：活血化瘀，消肿散结，清热解毒。

适应证：肝癌、卵巢癌。

用法用量：每日 2 次，每次 1~2 丸。

注意事项：饭后服可减免胃肠道反应。

消症益肝片

方药组成：蛭螂中提取的有效成分。

功能：破瘀化积，消肿止痛。

适应证：肝癌。

用法用量：每日 3 次，每次 8 片，每片含总氮量 25mg，1 个月为 1 疗程。有效者可长期服用。

注意事项：饭后可减免消化道反应。

安宫牛黄丸

方药组成：牛黄、郁金、犀角、黄连、黄芩、栀子、雄黄、朱砂各 30g，麝香、冰片各 8g，珍珠 15g。

诸药共研为极细面，炼蜜为丸，每丸重 3g，金箔为衣，蜡皮封存。

功能：清热解毒，开窍安神。

适应证：肝癌（热毒型）。

据报导，临床运用安宫牛黄丸治疗肝癌有以下体会：①安宫

牛黄丸近期疗效显著，有肯定的退热、退黄、镇痛和止血作用。
②该药对炎症型肝癌病人疗效较强，对硬化型及单纯型疗效略差。③反复使用，仍有疗效，远期疗效待进一步观察。④可使肝癌患者生存期显著延长，食欲、精神状态均显著好转，生存质量有了明显提高。⑤该药无明显毒副作用，但药性偏苦寒，使用中应兼顾脾胃功能。

用法用量：每日 2~3 次，每次 1 丸，体虚者配洋参汤服，热甚者配二花汤服下。

注意事项：虚寒证不宜服用。

化症回生丹

处方：人参 186g，安南桂 62g，两头尖 62g，麝香 62g，片姜 93g，公丁香 93g，川椒炭 62g，虻虫 62g，京三棱 62g，蒲黄炭 31g，白芷花 62g，苏木 93g，桃仁 93g，苏子霜 62g，五灵脂 62g，降香 62g，干漆 62g，归尾 124g，没药 62g，白芍 124g，杏仁 93g，香附 93g，吴茱萸 62g，元胡 62g，水蛭 62g，阿魏 62 两，小茴炭 62g，川芎 26g，乳香 62g，良姜 62g，艾炭 62g，益母草 248g，熟地 124g，鳖甲胶 1000g，大黄 248g。

上药共碾为细面，高米醋斤半熬浓晒干，再加醋熬晒干，如此反复 3 次，晒干为末，炼蜜为丸，每丸重钱半，用蜡封皮。

功能：消症癖，化瘀血。

适应症：肝癌、胰腺癌等。

用法用量：每日 1 次，每次 1 丸，黄酒送服或温开水送服。

注意事项：孕妇忌服。

莲花片

方药组成：半枝莲、七叶一枝花、蜈蚣、柴胡、莪术、山慈菇、仙鹤草、田三七、牛黄。

功能：疏肝凉血，破积消症。

适应症：肝癌。

用法用量：每日 3 次，每次 6 片（每片含生药 3g），连用数

月至1年。

注意事项：广州中药三厂制。

六神丸

方药组成：麝香 4.5g，汉牛黄 4.5g，冰片 3g，珍珠粉 4.5g，雄黄粉 3g，蟾酥 3g，水丸，芥子大，百草霜为衣。

功能：清热解毒，消肿止痛。

适应证：喉癌、舌癌、扁桃体癌、牙龈癌及鼻咽癌、白血病等。

实验证明，六神丸尚可提高 L₇₂₁₂ 小鼠白血病抑制率，提高其 GMCFC 产率，减低白血病引起的染色体畸变。

用法用量：每次 10 粒，每日 2~3 次含化。

注意事项：不宜多服，若超过 10 粒，口腔麻木，胃满恶心不舒。

梅花点舌丹

方药组成：乳香、没药（均醋炙）各 90g，海南沉香 45g，血竭 90g，白梅花 410g，葶苈子 90g，硼砂 90g，生石决明 54g，雄黄粉 90g，蟾酥粉 180g，汉牛黄 45g，珍珠粉 27g，冰片 45g，麝香 45g，熊胆 27g（熬汤打丸用），朱砂 90g。

制法：前 8 味共研细末，过 130 孔罗，混匀，后 7 味分别研细，与上药混合研均匀。用熊胆水泛丸，每百粒重 6g，每瓶内装 10 粒。

功能：清热解毒，消肿止痛。

适应证：喉癌、食管癌、舌癌、口腔癌、牙龈癌、乳腺癌。

用法用量：口服，每服 2~3 粒，每日 2 次，先饮水一口，将药放在舌上，以口麻为度，再用温黄酒或温开水送下，外用：用醋化开，敷患处。

注意事项：应按说明服，多服易引起恶心呕吐、纳差、少服影响疗效。

小金丹

方药组成：白胶香、草乌、五灵脂、地龙、木鳖子各 45g，乳香、没药、当归各 22g，香墨 4g，共为细末，另研麝香 9g，糯米粉 40g，水泛为丸，如芡实大。

功能：祛瘀散结，化痰通络。

适应证：乳腺癌。

用法用量：口服，每次 1~2 粒，每日 2~3 次。用黄酒或温开水送下。

注意事项：服后若有恶心、纳差，可每服 1 丸，每日 2 次，反应即可消失。

犀黄丸

方药组成：犀牛黄、麝香、乳香、没药等。

功能：清热解毒，消肿散结，活血化瘀，通经止痛。

适应证：肝癌、乳腺癌、肺癌。

用法用量：每日 2 次，每次 3g，也可同时配用阿霉素等化疗药物应用。

注意事项：此药持续久服易伤胃气，应间断服用，或与和胃健脾药合用。

天花粉注射液

方药组成：天花粉中提取物。

功能：通月水，消肿毒，排脓生肌。

适应证：子宫颈癌，绒毛膜上皮癌。

用法用量：天花粉注射液 10ml，加入生理盐水 500ml 中，静脉滴注，约 4~6 小时滴完。3~5 次为一疗程。（两次注射间隔 6~7 天）。

莪术注射液

方药组成：莪术中所提取的有效成分。

功能：活血化瘀，行气破血。

适应证：子宫颈癌，卵巢癌。

用法用量：病灶局部注入 10~30ml，每日一次，三个月为

一疗程。

注意事项：此药行气破血，唯体虚之人慎用，或配以参、芪、白术等同用。

复方抗瘤粉

方药组成：蜈蚣 6 条，三七 1.5g，土元、僵蚕、川芎、全虫、花粉、石菖蒲、寒水石、石决明、蝉衣、菊花各 6g，藏红花 1g，胆南星 2g。

上药共研极细面装瓶备用。

功能：活血祛瘀，化痰散结，镇肝熄风，清热醒脑。

适应证：脑瘤。用法用量每日 3 次，每次服 20g。

注意事项：忌辛辣刺激性食物。

复方斑蝥散

方药：斑蝥 30 个，大红枣 30 个，水蛭 60g，枯矾 9g，三七粉 60g，生薏苡仁 60g，倒退虫 30g。

大枣去核，斑蝥去头足、翅膀，将斑纳入大枣内，1 个枣装 1 个斑蝥，真丝线或头发捆扎，与后 5 味烘干为极细面，分为 90 包装瓶备用。

功能：破血逐瘀，排脓消肿，化痰散结，解毒开关。

体外实验斑蝥的水，醇或丙酮提取物能抑制海拉细胞和人的食管癌、胃癌、肝癌等细胞的代谢，主要作用是阻断核酸和蛋白质的合成，对小鼠 S_{180} 有抑制作用；水蛭注射液能抑制精原细胞分裂，体外试验对肿瘤细胞有抑制作用，对小鼠肝癌细胞有一定抑制作用；生薏苡仁对艾氏腹水癌有明显抑制作用。

适应证：食管癌、贲门癌、肝癌。

用法用量：每日 3 次，每次 1 包，浓白糖水送服。

注意事项：食管、胃十二指肠有溃疡者禁用。

复方天龙散

方药：天龙 30 条、水蛭 90g，刀豆 180g，僵蚕 180g，制南星 60g，田三七 120g，生薏仁 180g，儿茶 60g，蜈蚣 60 条。

前四味用小米炒至酥焦，后 5 味烘干，共研极细面，装瓶备用。

功能：活血化瘀，软坚散结，利湿化痰，排脓消肿。

天龙体外试验水溶液抑制人体肝癌细胞呼吸，具有抗癌作用；僵蚕煎剂对小鼠 S_{180} 有抑制作用；鲜天南星水提物对海拉细胞有抑制作用，对 S_{180} 、小鼠肝癌实体型 HCA、 U_{14} 有明显抑制作用，提取物结晶——甘露醇也有抑瘤作用。

适应证：食管癌、贲门癌、肝癌、肺癌等。

用法用量：每日 3 次，每次 6~10g，蜂蜜适量调服。

注意事项：经济条件好者可入人参 90g，冬虫夏草 60g。

牛虎散

方药：牛胆 1 个，壁虎 30 条，公蜥蜴 30 只，月石 30g，枯矾 30g，水蛭 30g，全虫 60g，蜈蚣 60 条，羊哀（羊胃结石）30g，地龙 60g，三七 60g，沉香 15g，木香 15g。

蜥蜴用清水泡 1 昼夜（每 2 小时换 1 次水）后晒干，再用白酒浸泡 1 周，晒干与其它药一起烘干，共研为极细面，装瓶备用。

功能：清热解毒，理气活瘀，化痰散结，利湿通络。

壁虎（天龙）水提取液可抑制肝癌细胞的呼吸；蜥蜴醇提取物对人体肝癌细胞有抑制作用；全虫水提取物对结肠癌细胞、醇提取物对人肝癌细胞有抑制作用；蜈蚣水提取物对 S_{180} 、 L_{160} 、 W_{256} 、艾氏腹水癌有抑制作用，对人肝癌及胃癌细胞有抑制作用，并能增强网状内皮系统的机能。

适应证：食管癌、肝癌、胃癌。

用法用量：每日 3 次，每次 5g，用黄酒 50ml 或蜂蜜 50ml 送服。2 个月为一疗程，休息 1 个月再用第二个疗程。

注意事项：根据个体耐受情况，剂量可灵活增减。

菝葜煎

方药：菝葜 100g，龙葵 30g，八月扎 30g，刀豆子（杵）

60g, 白花蛇舌草 60g, 制南星 10g, 陈皮 15g。

功能: 行气活瘀, 化痰消肿, 解毒抗癌。

白花蛇舌草体外试验对急性粒细胞性白血病细胞, 急性淋巴细胞性白血病细胞及慢性粒细胞性白血病细胞均有缓解作用, 体内试验对大鼠瓦克氏肉瘤₂₅₆、小鼠宫颈癌 U₁₄、小鼠肉瘤₁₈₀、肝癌实体型、艾氏腹水癌腹水型均有抑制作用。蛇舌草既能直接抑杀癌细胞, 又能提高机体免疫功能, 且无毒副作用。

适应证: 食管癌, 贲门癌、肝癌。

用法用量: 每日 1 剂, 分头道、二道煎服。

注意事项: 制南星必须先煎 2 小时以去其毒, 服后无舌发麻可渐渐增至 30g。

龙蛇羊泉汤

方药: 龙葵 30g, 蛇莓 30g, 蜀羊泉 30g。

功能: 清热解毒, 活瘀消肿。

蛇莓动物实验有抗肿瘤作用。

适应证: 食管癌、肝癌、胃癌。

用法用量: 每日 1 剂, 分头道、二道煎服。

注意事项: 有肠反应时加木香、砂仁。

急灵仙方

方药: 急性子 10g, 威灵仙 30g, 制木鳖子 1g, 法半夏 10g, 瓜蒌 30g, 郁金 10g, 刀豆 15g, 山豆根 10g。

功能: 解毒化痰, 消噎降逆, 活瘀止痛。

急性子体外药敏试验对胃淋巴肉瘤细胞敏感; 掌叶半夏对实验性动物肿瘤 U₁₄、S₁₈₀、肝癌实体型及海拉细胞均有一定抑制作用; 20% 全瓜蒌煎剂体外试验对艾氏腹水癌有抑制作用, 动物体内试验对肉瘤作用较强; 山豆根中提取的苦参碱, 氧化苦参碱对小鼠 S₁₈₀、艾氏腹水癌、S₃₇、U₁₄、大鼠实体型和腹水型吉田肉瘤, 腹水型肝癌均具有抑制作用, 对网状内皮系统有激发作用, 能提高机体免疫功能。

适应证：食管癌、肝癌。

用法用量：每日1剂，分头道、二道煎服。

注意事项：食管癌梗阻明显时酌加开关散或珠宝散。

抗癌乙丸

方药：夏枯草 30g，山豆根 30g，白藓皮 15g，败酱草 15g，黄药子 10g，草河草 30g。

上药共研为细面，炼蜜为丸，丸重 9g。

功能：清热解毒，软坚散结，活血消肿。

适应证：食管癌、食管癌癌前（食管上皮重度增生）的阻断性治疗，预防食管癌的发生；对贲门癌，胃癌、大肠癌、肺癌亦有一定疗效。

体外实验证明：本方及其所含六味中药均具抗致突变作用和抗促癌作用；多年实践证明，本方对食管癌、贲门癌等有一定的缓解作用；动物实验证明本方可明显抑制大鼠食管粘膜的白斑恶变为口腔癌的作用；大量病例观察证实本方可治疗食管癌前病变，预防食管癌的发生。

用法用量：每日3次，每次1~2丸。

珠宝散

方药：煅珍珠 3g，马宝 9g。

两药共研为极细面装瓶备用。

功能：化痰消肿，去腐生肌，开关通道。

用法用量：每日3次，每次徐徐含咽 3g，梗阻解除停服。

注意事项：汤水难入的患者服药必须得法，舌舔药面，徐徐含咽，半小时含化完。若口干用温水漱口后舌舔药面徐徐含咽。含化后2小时试进水或流质，若仍梗阻不下，继续含药，2~3次后不效改用其它开关法。

开关散

方药：牛黄 3g，麝香 3g，煅珍珠 3g，炒僵蚕 6g，枯矾 3g，煅蒙石 3g，紫硃砂 3g，煅龙骨 3g。

共研极细面装瓶密封备用。

功能：芳香透窍，化痰散结，消肿解痉，破瘀攻坚，开关通道。

适应证：食管、贲门癌梗阻。

用法用量：每日4~5次，每次2~3g，徐徐含咽。

注意事项：开关散必须徐徐含咽才能发挥药效，病处有溃疡者禁用，以免穿孔。

加减小金丹

方药：马钱子0.5g，当归、制乳香、制没药各6g，白胶香、地龙、五灵脂、丹参、制草乌、陈皮、厚朴、木香各9g，砂仁4.5g，加工成片剂，每片含生药0.5g。

功能：祛瘀散结，理气和胃。

适应证：中晚期胃癌术后，以延长生存期，提高生存率。

用法用量：中晚期胃癌手术后1个月起口服，每次4片，每日3次。

注意事项：据报道：服用该药时，同时服用FT-207（喃氟啉），每次100~200mg，每日3次，服药5天间隔2天。维生素B、C、E均按常规量口服，与对照组相比，在其他条件相同的情况下用本方能明显提高胃癌患者1年、2年生存率；降低紫舌阳性率；改善AFⅢ、Fn、Fa和VⅢR：Ag等血凝指标。动物实验显示该方可以改善S₁₈₀小鼠高凝状态，抑制肿瘤生长。

健脾益肾方

方药：黄芪、党参各15~30g，山药15g，白术、地黄、山萸肉、女贞子、枸杞子、菟丝子、补骨脂各10~12g，半夏10g，丹参10~15g，木香3~6g，草豆蔻6~9g。并随症加减。

功能：益气健脾，益肾补血。

适应证：Ⅱ、Ⅲ期胃癌根治切除术后，用本方配合化疗，以扶正固本。

用法用量：水煎，每日1剂，分头道、二道服，于化疗期

间，直到疗程结束后一直服用。

注意事项：实验研究证明，本方具有促进机体免疫功能，改善骨髓造血功能，提高内分泌调节，以及双向调节作用。临床观察表明，化疗过程中应用本方扶正培本，除血象下降缓慢、波动小、骨髓机能受抑轻外，其他消化道及全身毒副反应亦较轻，较其他对照组有明显差异。

三根汤

方药：藤梨根 90g，野葡萄根 60g，水杨梅根 90g，半枝莲 60g，半边莲 60g，白茅根 15g，凤尾草 15g。

功能：清热解毒，抗癌。

适应证：胃癌、肠癌。

用法用量：每日一剂，早晚各煎服 1 次。

注意事项：服药期间忌食生冷、酸辣、鱼腥、红糖、芋头、豆制品等。

化痰解郁汤

方药：苏子 10g，莱菔子 10g，贝母 10g，生牡蛎 30g，半夏 10g，夏枯草 30g，海藻 10g，天南星 10g，苍术 10g，白术 10g，儿茶 6g，藤梨根 30g。

功能：化痰散结，温中软坚。

适应证：胃癌。

用法用量：每日一剂，早晚服。

注意事项：①此方适用于呕吐痰涎，腹胀便溏，胸闷隔满，痰核累累等。②勿食大肉大油，以免影响胃口。

消痰复肝灵

方药：菝葜 30~60g，蛇舌草 60g，藤梨根 60g，白英 30g，石上柏 30g，生熟苡仁各 30g，海藻 30g，炒元胡 15g，八月扎 30g，广木香 10g，猪苓 30g，穿山甲 20g，甘草 6g。

功能：清热解毒，行气活瘀，软坚散结，利湿消癥。

适应证：肝癌、胃癌。

用法用量：每日1剂，分头道、二道煎服，每周服5日。2个月为1疗程，疗程间隔1个月。

杀癌一号煎

方药：半枝莲 30g，半边莲 30g，黄毛耳草 30g，苡仁 30g，天胡荽 60g。

功能：清热解毒，抗癌。

适应证：肝癌。

用法用量：每日一剂，早晚服。

注意事项：江西医科大学附属第二医院报道，用本方近期治愈12例。

加味犀黄丸

方药：牛黄 3g，麝香 3g，制乳香 30g，制没药 30g，三七粉 30g，刀豆子 30g，生薏苡仁 30，熊胆 3g，人参 30g，元胡 30g，八月扎 60g，炮山甲 30g，鸡内金 30g，菟丝子 30g，山豆根 30g，云芝 60g。共为极细末装胶囊备用。

功能：清热解毒，利湿排脓，消肿止痛，活血通络，益气扶正。

适应证：肝癌、乳腺癌、肺癌、淋巴瘤等。

用法用量：每日3次，每次服4~6粒。

注意事项：①乳香、没药必须炮制；②用量可逐渐增加至适度。

加味龙蛇羊泉汤

方药：白花蛇舌草 30g，白英 30g，龙葵 30g，红藤 15g，公英 30g，槐角 30g，半枝莲 30g，忍冬藤 30g，生地榆 30g，败酱草 30g，儿茶 10g，槐花炭 30g。

功能：清热解毒，消肿止血。

适应证：结肠癌、直肠癌。

用法用量：每日1剂，分头道、二道煎服。

注意事项：服药后有轻微恶心、胃痛不适，可分次频服，即

可减少反应。

解毒化痰汤

方药：黄药子 12g，昆布 12g，海藻 12g，元参 12g，大贝母 10g，夏枯草 30g，蛇莓 15g，蛇六谷 12g，地龙 12g。

功能：凉血解毒，化痰散结。

适应证：甲状腺癌

用法用量：口服，每日一剂，水煎服。

注意事项：黄药子对肝功有一定影响，故肝功能损伤者忌服。若久服，2个月复查一次肝功能，若肝脏无损害可继续服用。

醒消丸

方药：乳香、没药各 30g，明雄黄 15g，麝香 4.5g。共研细末，每 30g 药面，取黄米面 10g 为糊，搅匀制丸，如绿豆大。

功能：解毒消肿，活血散瘀

适应症：乳腺癌。

注意事项：个别患者服药后有恶心、呕吐，或胃满不适，应饭后服，减为每次 2g，服药反应即可消失。

三品一条枪

方药：白砒 45g，明矾 60g，雄黄 7.2g，乳香 3.6g。

制法：将白砒、明矾研成细面，入小罐内煅至青烟尽白烟起上下通红，去火，取罐置地上一宿，取出研末约 30g，再加雄黄、乳香，共研细末，厚糊搓线，阴干备用。

功能：腐肉蚀疮。

适应症：子宫颈癌，皮肤瘢痕癌。

用法用量：外用。用时将药条插入患处。

注意事项：注意消毒，若疮痈可少用，或每周上药两次。

有报道将本方研粉用于皮肤瘢痕癌效好，用呋喃西林液棉球清拭局部，将药粉 0.3~0.6g 撒布于癌灶，用凡士林纱布覆盖，加纱布后固定。每天换敷料 1 次，3~5 天上药 1 次。上药 3~8

次可将癌组织全部腐蚀，待坏死组织全部脱落后，多点取活体组织送病理检查，证实局部无癌组织存在时，改用四环素软膏涂布，使新生肉芽组织形成鳞状上皮覆盖。

催脱丁合蜈蚣粉

方药组成：①催脱丁：山慈菇、枯矾各 18g，蛇床子、硼砂、冰片各 3g，雄黄 12g，炙砒 9g，麝香 0.9g。②蜈蚣粉：轻粉 6g，冰片 1.5g，麝香 0.3g，蜈蚣（去头足）4 条，黄柏 30g，雄黄 3g。

适应症：宫颈癌。

用法用量：催脱丁制法：将药混合研成粉末，加适量江米糊（每料药大约用 9g 江米粉）分制成长 1cm 左右，一头尖一头粗（直径 0.25cm 左右）类似钉子状的钉剂，置阴凉处风干备用。蜈蚣粉制法：将药物混合研碎成粉末备用。

每次上药前以 1:1500 新洁尔灭溶液灌洗阴道。对宫颈鳞状上皮细胞非典型增生，原位癌或局部病变不突出的浸润癌病例，采取对宫颈管内插“钉”，每次 1~2 枚，对局部肿瘤明显突出的菜花型病例，采取对瘤体插“钉”，“钉”与“钉”间隔 1cm。根据肿瘤大小决定插“钉”数目，多者可达 10~20 枚。经插“钉”后均以撒有适量（1g 左右）蜈蚣粉的带尾大棉球填塞于宫颈表面，24 小时后由患者自己取出。隔日上药 1 次，每周 3 次，1 个月为 1 疗程。

注意事项：因上药后宫颈局部坏死，分泌物堆积，局部解剖境界不清楚，故宜停药一周后再行妇科检查，宫颈刮片细胞学检查及宫颈活体组织（对一部分患者是在阴道镜检查下采取）病理学检验等。在采取宫颈活体组织后，如立即继续“插钉”治疗，容易促使局部出血，所以，均在一周后再继续上药。一般复查项目结果不影响连续治疗，通常均须连续作 2~3 个疗程（对非典型增生病例要求至少作 2 个疗程）之后，进行初步总结，如有效而未治愈者可以继续治疗，对治愈者可停药而随诊观

察，病情较重者辅加放射线治疗。

据报道用本法治疗宫颈癌临床观察 96 例，仅 16 例未愈而改用其他疗法。一般局部或全身反应轻微，少数病例初用时有轻微恶心、头晕、无力、腹胀，腹下坠感，但很快消失。治疗期间及较长期随诊均未发现引起血液或肝、肾病变。个别患者经催脱丁治疗并发药物腐蚀阴道溃疡，阴道上段或宫颈口粘膜闭锁。未发现其他严重的并发症。

慈菇金盘汤

方药：①内服药：八角金盘 12g，蜂房 12g，山慈菇 30g，石见穿 30g，八月扎 30g，皂角刺 30g，黄芪 15g，丹参 15g，赤芍 15g。②外敷方：雄黄，老生姜。将雄黄置于等量老生姜内，放在陈瓦上文火焙干至金黄色，凉干研细，过 80 目筛即得。

适应症：乳腺癌。

用法用量：内服方，水煎，每日一剂，早晚服。外敷方 2~3 天换药 1 次。

复方龙葵汤

方药：龙葵 15g，苡仁 15g，天花粉 15g，紫草 15g，白英 15g，丹参 15g，山豆根 30g，半枝莲 30g。

适应症：子宫绒毛膜上皮癌、恶性葡萄胎。

用法用量：每日一剂，水煎服。

注意事项：据报道，近期治愈率 83%。

喜树仙鹤汤

方药组成：仙鹤草 90g，蛇六谷 60g，白花蛇草、半边莲、半枝莲各 30g，喜树根、败酱草根、蛇莓、白毛藤、大青叶、三棱、莪术、赤芍、红花各 10g，生薏苡仁 12g。

加减变化：阴虚阳亢、湿热内蕴者加黄芪 10g，黄柏 10g，知母 10g，丹皮 10g，生地 10g，山栀 9g，玉竹 12g；胃失和降者加陈皮 6g，姜半夏 6g，竹茹 6g，鸡内金 10g，山楂 9g；气血两虚者加黄芪 30g，党参 15g，当归 10g，生地 10g，熟地 10g，

黄精 10g。

功能：清热解毒，祛风通络，活血消肿，抗癌止痛。

适应证：多发性骨髓瘤。

用法用量：水煎，每日 1 剂，煎 2 次，分 2~3 次服。

注意事项：采用本方结合化疗治疗多发性骨髓瘤 10 例，其中获显效者 2 例，缓解 3 例，稳定 5 例。存活最长时间 5 年的 1 例。多发性骨髓瘤的预后较差。临床单纯用化疗效果不理想。本方以清热解毒、祛风通络、活血消肿止痛为大法，尤为重用有一抗癌作用的仙鹤草，结合化疗，的确取得了一定的疗效。

慢粒丸

方药组成：黄芩、苦参、黄柏、雄黄、当归、地丁草、青黛、诃子肉、猫爪草各 1 份，土鳖虫、水蛭各半份，做成蜜丸，每丸含生药量 3.0g。

用法用量：治疗剂量每日 4.5~9.0g，维持剂量每日 3~6g，分次口服。

适应证：慢性粒细胞白血病。

临床疗效：以本丸治疗 12 例慢性粒细胞白血病，其中完全缓解 6 例，部分缓解 1 例，进步 4 例，无效 1 例，总有效率为 91.7%。治疗后白细胞下降时间为 20~42 天，平均 30.1 天。白细胞下降至 $10 \times 10^9 / L$ 以下需时间为 31~180 天，平均 78.6 天。

经验体会：以本方治疗慢性粒细胞白血病，经临床观察，效果较好。因本丸含雄黄，长服用可引起慢性砷中毒，故应做尿砷测定，必要时可进行驱砷治疗。

益气养阴方

方药组成：黄芪 30g，党参 20g，黄精、枸杞子、天冬、玄参、当归各 15g。

加减变化：出血明显，加紫草、旱莲草、仙鹤草各 15g；有感染者，加黄芩、黄连、黄柏各 15g；其它随证加减。

用法用量：水煎服，每日1~2剂。并配合化疗。

适应证：急性白血病。

临床疗效：以本方配合化疗治疗急性白血病13例，完全缓解8例（61.5%），部分缓解2例（15.4%），缓解率达76.9%。

临床观察发现：急性白血病患者多有面色苍白、头晕、乏力、心慌气短、口干、盗汗、手足心烦热等气阴两虚证候。本方以黄芪、党参、黄精益气，天冬、玄参、枸杞子、当归滋阴。由于本病多合并感染或出血，故加用三草以止血，三黄以抗感染。

药理实验证明：天冬体外试验对急淋、慢粒、急单患者WBC的脱氢酶有一定抑制作用，并能抑制急淋白血病细胞的呼吸；紫草也有抗肿瘤作用；黄芪有促进造血干细胞生长的作用；党参可使正常兔的RBC和Hb增加；黄精、玄参、天冬、当归、紫草等均有不同程度的抗菌作用，三黄抗菌作用更强，仙鹤草可促进血液凝固，收缩周围血管，并使血小板上升，这个方剂除符合辨证用药外，也有实验依据，用之临床，也确有疗效。

肝区疼痛方

方药组成：铁树叶60g，白屈菜15~30g，铁包金30g，炒元胡30g，金剪刀30g，制乳香12g，制没药12g，蜈蚣6条，川楝子10g，全虫10g，野艾30g。

功能：活血祛瘀，消肿散结，解毒止痛。适应证：肝癌及各种癌性疼痛。

用法用量：每日1剂，分头道、二道煎服，痛止停用。

注意事项：白屈菜、全虫、蜈蚣均系有毒之品，不宜久服。

加味推气散

方药组成：姜黄、枳壳、桂心、当归、红藤、厚朴、蜈蚣、郁金、柴胡、丹参各30g，制南星、半夏、大黄各18g，白芍60g，炙甘草12g，诸药共研细末。

适应证：肝癌晚期疼痛。

用法用量：每日3次，每次12g。痛甚者，每次可用16g，

并用丹参、生姜各 6g，白术、茯苓、桃仁各 9g，大枣 9 枚，水煎送服。

临床疗效：以本方治疗肝癌晚期疼痛患者 44 例，均获良效。经治 2 天疼痛消失 9 例，3 天疼痛消失者 14 例，4 天疼痛消失者 11 例，6 天疼痛消失者 10 例，并且病人的食欲均有不同程度的增加。

治癌性腹水方

方药组成：龙葵 30g，半边莲 30g，水红花子 30g，虎杖 30g，猪苓 30~120g，茯苓 15~30g，泽兰 15g，泽漆 15g，防己 15g，车前草（子）30g，马鞭草 30~60g，泽泻 30g，丁哥王 30g，葫芦 30g，商陆 6~10g，薏苡仁 30~100g，玉米须 30~120g，石苇 30g，茵陈 30g。

功能：活血散瘀，利水消肿。

适应证：癌性胸、腹水。

用法用量：每日 1 剂，分头道、二道煎服。每周 5 日为 1 疗程，休息 1 周再用。

注意事项：癌性胸、腹水系癌症晚期，治疗除选用上述药物外，必须根据个体辨证灵活配用它药。

第五章 现代医学抗肿瘤研究概况

第一节 病因与流行病学

【概述】

人体的肿瘤种类繁多，不仅发生的部位不同，引起的临床症状也不一样，而且肿瘤本身的结构，肿瘤细胞的分化程度与生长特性也各有特点。目前认为，它是属于多种原因引起的一类疾病，它的病因和发展条件也很复杂。

病因是指一个癌瘤发生的原始动因，没有它，癌瘤就不会发生，但并不是说，有了病因，癌瘤就一定发生，除了病因之外，还需要其它一定条件，这就是癌的发病条件。

正常细胞转变为癌细胞的过程叫做“癌变”。这个转变过程的本质、原理及经过，叫做“癌变原理”，不同种类的致癌病因可能具有不同的或相同的癌变原理。

目前已清楚，一个癌瘤在临床上的出现，要经过三个阶段，①首先少数正常细胞转变为癌细胞（癌变、癌的发生）；②瘤细胞不断生长繁殖，直到临床上能被认出（癌的形成）；③癌的发展（浸润与转移）。但并不是任何一个癌瘤都要完成这三个阶段，有的可以停留在第一或第二阶段，而不继续发展，甚至在罕见的情况下可以自动消退。

肿瘤的病因有内源性与外源性之分。外源性因素来自外界环境，与人类的自然环境和生活条件密切相关，目前主要考虑化学、物理和生物等方面的因素。内源性因素来自肌体内部包括身体内部结构与功能的深刻变动，与遗传因素和神经体液调节作用紧密联系，在发病方面又受到机体的免疫反应性、代谢与营养等多种因素的影响。

一个强烈的致癌因素的单独作用可以引起肿瘤。但实际上人们在患肿瘤之前的长期内，常常接受了一个以上的病因或者同时与先后接受了多种内外源性病因的作用，因此我们还要注意肿瘤发生的病因综合作用问题。

肿瘤的发病条件是指至发生所需的辅助因素，是肿瘤发生的次要因素，不是必不可少的，而病因都是不能缺少的，这就是说，一个肿瘤的发生必定有相应的病因，但同时可能伴随着多个发病条件的相辅作用。

有关人类癌瘤病因的资料主要来自三方面的研究：

1. 通过肿瘤流行病学研究，找出可能的病原因子分布的差异；

2. 实验研究，在确定人类环境是某一特定因子时实验的致癌作用，以及复制癌发生过程的一连串现象。

3. 确定病因性质的研究和确定环境中鉴定这种病因的方法的研究。通过科学家长期大量的科学研究，目前认为以下因素与癌瘤的发生有密切关系。

一、外源性因素

1. 化学因素 通过流行病学调查，估计 60%~90% 的人类肿瘤是由于接触环境中致癌物质引起的，人类肿瘤与生活方式、居住环境、劳动条件等有密切关系。目前已知约有 1100 多种化学物质可以使细胞发生恶性转化或继发肿瘤，其中与人类肿瘤关系比较密切的有数十种。德国的国际肿瘤研究机构 (IARC)，从 1971 年开始对化学致癌物质与人类致癌危险性问题进行评价，1977 年，在他们公布的 16 卷材料中，列举了 36 种化学致癌物，其中黄曲霉毒素、氨基联苯、砷化物、石棉、碱性槐黄苯、联苯胺、双氯甲醚、镉及氯化镉、氯霉素、氯甲甲醚、铬盐、环磷酰胺、乙烯雌酚、赤铁矿 (氢)、异丙醇、苯丙酸氮芥、氮芥、萘胺、镍精炼、二氯乙酰二萘胺、沥青、焦油等多种物质，经动物实验证明与人类肿瘤的发生有关系，根据化学致癌

物进入机体以后与细胞内氧化酶系统的反应，把它们区分为直接烷化物质与间接烷化物质，无机致癌物三大类。

2. 饮食因素 饮食中的致癌物质，人类怀疑生活环境中有致癌因素在 200 年前就已提出，但经动物实验证实则只有 70 余年，而证明化学致癌物可经消化道（或呼吸道）进入机体诱发肿瘤才 30~40 年。实际上有很多化学致癌物极微量而广泛存在于各种食物中，在人类没有意识到的情况下，进入机体。据估计人类 40%~60% 肿瘤的发生与饮食有关，而且消化道，是外界致癌物进入机体的主要途径之一，如果长期或过多地摄入并超过了机体的需要，就可能发生肿瘤，食物在被摄入人体之前的各个环节，如土壤、水质、施肥、农药、储藏、制作、烹调、运输、包装等过程中都有可能被化学致癌物污染或产生化学致癌物。

肿瘤流行病学是研究人群中恶性肿瘤的分布，阐明分布的原因，并采取相应对策和措施的一门科学。恶性肿瘤在人群中具有地理分布的差别，有高、低发地区，不同年龄、性别、职业、发病率和死亡率的区别，这些都为恶性肿瘤的病因研究和预防提供了重要的线索和依据。研究观察的对象人群，其中包括患病者，和健康者以及他们的结合，对他们的年龄、性别、职业特征、活动方式、疾病状态进行比较、鉴别，找出特点。

肿瘤流行可总结出 3 个重要方面：①宿主：在某些人群中自身携带有易突变的边缘基因，如个别儿童具有显性视网膜母细胞基因要比没有上述基因的儿童患视网膜母细胞瘤危险度大 10 万倍。又如有多发性结肠息肉基因的比没有的患结肠癌机会多 10000 倍。②环境：环境由生物环境、理化环境、社会环境三大部分所组成。生物学环境包括人们所处的生态环境，动植物环境。如非洲海拔 1520 米以上，平均气温 15.60℃ 以下，降雨量 762mm 以下的地区为 Burkitt 淋巴瘤高发区。又如不同食物来源，不同的温度和湿度下，黄曲霉素的生成条件不同，对人群发生肝癌的作用亦不一致。人们所处的理化环境更为复杂，生活在

不同纬度由于紫外线的不同，皮肤癌的发病率不一样，不同职业、不同劳动条件可能发生不同职业性肿瘤，铺路工由于长期与柏油打交道，肝癌的发生率较高。③病因：不同的社会环境中，肿瘤的发病有区别，如由于生活习惯、卫生条件差、农村妇女宫颈癌的发病率较城市妇女高。肿瘤的病因和其它疾病一样可分为传染因素、化学因素、物理因素和营养因素。与肿瘤有关的传染因素有乙型肝炎病毒感染（原发性肝癌）、日本血吸虫病（直肠癌）、埃及血吸虫病（膀胱癌）、乳头状瘤病毒（宫颈癌）、EB病毒（Burkitt's 淋巴瘤）等。

人类的生存，无不与化学物质相接触，化学给人类带来了巨大的财富，同时也带来了灾难。国际癌症中心（IARC）十几年来对 442 种化合物对人体的危害进行了研究，目前已确定 18 种与人类肿瘤有关，另外有 18 种可能与肿瘤有关，1,4-氨基联苯、砷化物、石棉、金胺、苯、联苯胺、萘胺、双氯甲醚、氯甲甲醚、铬和铬化物、二乙基乙烯雌酚、赤铁矿、异丙醇、左旋苯丙酸氮芥、芥子气、 α -萘胺、镍精炼、煤及煤焦油、氯乙烯、黄曲霉毒素、铍及铍化合物、镉及镉化合物、苯丙酸氮芥、环磷酰胺、镍及镍化合物、非那西汀、噻替哌、丙烯腈、杀草强、苯胺染料、四氯化碳、氯化二甲基、氨基甲酰、硫酸二甲酯、氧化乙烯、葡聚糖铁、多氯联苯。

物理因素包括各种电离辐射线的影响（如 X 线、紫外线、高频电流、微波等），机械性损伤可导致癌症发生，长期生活在噪声中的实验动物，肿瘤发生率较高。

营养因素，如果长期缺乏某种维生素、微量元素，就可导致某种癌症的发病率升高，如：视黄醇的缺乏导致肺癌发病率高，缺硒造成肝癌及其他肿瘤发病率高，亦有过高的方面，如高脂肪摄取与乳腺癌、结肠癌发生可能有关。

第二节 肿瘤病理学

肿瘤的诊断，从目前来讲，生化、免疫和影象诊断已有了长足的进展，但要确定肿瘤的性质，仍然依靠病理学诊断。其不仅可以判断肿瘤的良、恶性及其预后，而且还能根据世界卫生组织制订的《肿瘤国际组织学分类》中标准化指标进行分类，以寻求肿瘤诊断和命名的统一，有利于国际交流。肿瘤病理是外科病理学的一个重要分支，包括组织病理学和细胞病理学两大部分。人们通过活检组织和细胞经过一系列的技术处理，先用低倍镜观察一般结构，再用高倍镜进一步详察细微结构，做到全面细致，根据镜下所见，结合肉眼诊断和临床情况，作出诊断。目前，根据临床实践的需要，各专科病理先后建立，由此说明病理诊断学对于肿瘤病临床确诊，有着极其重要的位置。

第三节 诊断学

疾病的早期正确诊断，是施行合理治疗和治疗成功的基础。对于恶性肿瘤，早期作出正确诊断，是每个医生的重要责任，亦为采取正确治疗获得治愈机会的先决条件，对于恶性肿瘤来讲，早期诊断显得尤为重要。早期癌瘤一般指的是人体器官、组织的细胞所发生的体积较小的原位癌和表浅浸润癌。目前随着病因流行病研究的不断发展，大面积的人群普查，恶性肿瘤患者的早期诊断率较过去不断提高。人体肿瘤的临床综合诊断，基本上和诊断身体其它疾病方法相类似，即包括病史询问、细心的全面的体格检查和常规化验检查与特殊的检查（包括化验、X线、内腔镜、细胞学、病理学、放射性同位素、超声波、免疫学等检查中必要项目）。将所获得的各项资料，进行细致的综合分析和评价，从而推论作出诊断。

1. 肿瘤标记物 近几年来在肿瘤学中发展较快, 被肿瘤学家十分关注的一个热门话题就是肿瘤标记物的研究。肿瘤组织产生可以反映肿瘤自身存在的化学物质, 这种物质就叫肿瘤标记物。肿瘤标记物一般是指肿瘤组织和相应的正常组织相比, 增高特别明显而有显著意义的化学成份。如用免疫组织化学法检测出一个特定的肿瘤标志对肿瘤的组织学诊断和分型(如高分化、低分化、未分化等)有十分重要的价值。肿瘤标记物的连续动态测定不但有助于良恶性疾患的鉴别, 对一个已确诊的病人来说, 还可用于对预后及疗效的观察。目前临床上常用的有: 甲胎蛋白、癌胚抗原、CA₁₅₋₃ 和米蛋白样相关抗原、CA₁₂₅、酸性铁蛋白、蛋白酶抑制剂、胰癌胚抗原、前列腺特异抗原、组织多肽抗原。另外还有一些重要酶类及其同工酶的肿瘤标记物, 如: 酸性磷酸酶、碱性磷酸酶及其同工酶, α -L 岩藻糖苷酶、去 γ -羧基凝血酶原、半乳糖转移酶 II、 γ -谷氨酰转肽酶及其同工酶, 胎盘型谷胱甘肽 S-转移酶、糖酵解酶类同工酶、5'-核苷酸二酯酶同工酶 V、胸腺嘧啶核苷激酶, 还有鞘糖脂类肿瘤标志、激素类肿瘤标志等。

2. 影像学诊断 自 1895 年伦琴发现 X 线来, 医学影像学有了惊人的发展, 介入放射学、核医学、超声医学、CT 和 MRI 等, 相继出现, 使得肿瘤的早期诊断率大大提高, 从而肿瘤的治疗率亦随之提高。随着科学技术的进步和兄弟学科的发展, 肿瘤影像学一定对肿瘤的直接显示有重大突破, 为预防和早期诊断肿瘤提供更好的形态学以至功能改变的信息, 使肿瘤的治疗率有更多、更快的提高。

3. 内腔镜诊断 内腔镜问世已 100 年, 经历了硬式与软式两大阶段, 近代发展成纤维内镜和电子内镜。两者均能深入外通式管道器官(如消化道、呼吸道、腹腔、关节腔)进行观察诊断, 活体取材, 同时兼能腔内手术(如肿瘤摘除, 疏通癌性梗阻、胆囊截除、Oddi 括约肌切开等), 应用了新技术(如激光、微波

等)开展介入治疗,还具有摄影、录像或放大和处理图象等电脑智能化多种功能,为现代新颖的高精技术诊疗设备。目前内镜已用于临床,胃癌、肺癌、食管癌、大肠癌的诊断可靠性,是其他学科诊断无法比拟的,尤其对早期癌的及时检出,并能在术前作出病理确诊。同时还能通过内镜直接对腔内肿瘤进行治疗,特别是对那些临床采用多种方法治疗无效者,可通过内镜采用激光将肿瘤缩小,尚能缓解症状,延长寿命,改善生存质量。

第四节 治疗学

恶性肿瘤的主要治疗手段有以下三种:手术、放疗、化疗。随着肿瘤临床研究进展,中医中药治疗恶性肿瘤已逐渐被广大的临床工作者所认识接受,在不远的将来将成为一种独立的治疗手段运用于临床。另外免疫治疗在肿瘤的预防治疗、康复治疗中,有其独特的效应,它是通过刺激机体的免疫系统产生具有手术、放射治疗、药物治疗的效果,随着免疫学的研究进展,免疫治疗将成为第五种治疗手段。

手术治疗是肿瘤治疗中最古老的方法之一,目前仍是对某些肿瘤的最有效的治疗方法,约60%的肿瘤以手术为主要治疗手段,同时有90%的肿瘤应用手术作为诊断及分期的工具。手术切除肿瘤不受生物学特性的限制,既无潜在的致癌危险,对大部分尚未播散的肿瘤常可用手术治愈,同时术后亦可了解肿瘤的正确部位,得到正确分期。但手术亦有一定缺点,如需同时切除一定的正常组织,术后有一定的后遗症及功能障碍。

放射治疗,继x线和镭元素发现后,在本世纪20年代Regard和Cowtard等即开始用深部x线治疗喉癌,用镭治疗宫颈癌。此后,由于放射设备的改进和对放射物理特性的了解,加上放射生物学、肿瘤学以及其他学科发展的促进,使放射肿瘤学不断发展,放射治疗在肿瘤治疗中的地位也逐渐改变。至今大约

60%~70%的肿瘤患者在病理不同时期因不同目的的需要接受放射治疗。

恶性肿瘤的化学治疗，已堪称为能与手术治疗及放射治疗并列，成为恶性肿瘤治疗的三大主要手段之一。化学治疗远非仅仅作缓解症状的一种姑息疗法或辅以手术或放射治疗的一种辅助疗法，而已成为一种根治性治疗的手段和方法。化学治疗在下述几个方面优于手术及放射治疗。①手术及放射治疗只是局部治疗，尤其是手术治疗对造血系统以及发生转移的实体肿瘤等的全身治疗无能为力，而化学治疗能起到全身治疗的效果；②手术治疗和放射治疗往往难于彻底消灭亚临床的癌细胞，治疗后常有复发；辅助化学治疗可提高手术及放疗的治愈率，减少复发。③手术治疗和放射治疗需要特定的手术条件和昂贵的设备，而化学治疗不受上述条件限制，只要各科临床医师能合理使用抗癌药物，即可实施，便于普及。

近代肿瘤化学治疗始于本世纪40年代，采用单味药氮芥、氨甲喋呤治疗白血病或淋巴瘤患者，取得了短暂的缓解，同时开始采用内分泌药物乙烯雌酚治疗前列腺癌及乳腺癌。50年代，通过大量的动物试验，筛选出了不少有效的化疗药物，并按药理学分为六大类。①烷化剂：氮芥、环磷酰胺、马利兰、L-甲酰溶肉瘤素、苯丙氨酸氮芥等。②抗代谢药：氨甲喋呤、6-巯基嘌呤、阿糖胞苷、5-氟脲嘧啶等；③抗生素类：更生霉素、阿霉素、博来霉素等；④植物类：长春花碱、长春新碱、鬼臼乙叉甙、三尖杉酯碱等；⑤激素类：强的松、雌激素、雄激素、孕激素、三苯氧胺等；⑥杂类：顺氯胺铂、卡铂、羟基脲、甲基苄肼等。肿瘤化学在60年代的另一发展是人们开始认识肿瘤细胞动力学及化疗药药代动力学的重要性，从小鼠L₁₂₁₀白血病的实验性治疗，导致了临床上几种化疗药的联合治疗。到60年代末，象急性淋巴细胞白血病、睾丸肿瘤、Hodgkin等少数肿瘤病种已可通过化疗治愈。70年代，更多的肿瘤病有了比较成熟的、

固定的联合治疗方案，80年代，在此基础上肿瘤治疗学又有了更进一步的发展。研究如何以生物反应修饰剂等药物来提高化疗药疗效，并探索肿瘤对化疗药产生抗药物性而使化疗药失效的原因。

第五节 护理与康复

肿瘤病人的护理较其他病人的护理有特殊之处，要求护理人员具备广博的知识去解决肿瘤及其治疗引起的医药学、社会学、心理学、伦理学、营养学等问题。因此护理工作对肿瘤预防、诊治、康复中的作用，已从直接的护理人员扩展到教育者和研究者。肿瘤的预防包括三级，护理工作应从这个方面了解肿瘤的发生病因和危险因素，指导高危人群自我防护，指导人们如何进行自我监测，自我查体。对恐癌症患者，护士应耐心解释，消除其疑虑，并对其高度警惕性和积极求医予以鼓励，同时宣传肿瘤知识，对高危人群定期随访，积极为随访提供便利措施，并宣传三早的重要性。

在肿瘤病人治疗期间，护士应积极主动接触病人，了解病人的过去史、家属史、个人史、经济状况等，参与医生的检查和观察，制定护理计划，采取护理措施，掌握肿瘤三大治疗的特点，做好临终关怀工作，使病人无痛苦地度过人生最后时刻。

病人经过阶段性治疗，肿瘤得以控制，护士将在病人康复中起关键性作用。帮助病人制定健康作息表，协助病人消除心理障碍，重建适应社会的能力，争取重返工作岗位，教会病人自我监测，一旦复发争取及早就诊。

第六节 预 防

恶性肿瘤可分成三级预防措施：一级预防措施是搞清病因，

提高机体防癌能力，防患于未然；二级预防措施是筛选癌前病或早期癌症病例，做到早发现、早诊断、早治疗；三级预防措施是对已患癌症患者，减少其并发症，防止致残，提高治愈率，改善存活质量，使更多的癌患者达到无癌或带癌长期愉快生存。

三级预防措施是3道防线，第一道防线是人人所期望的减少生癌机会，提高自我保健能力。第二道防线是已经生癌者，使他们早日发现并及时得到诊治。越早治疗，治愈的机会越大。第三道防线是挽救劳动力，提高生存率和生存质量的工作。

一级预防包括防止空气、饮水、食物和工作场所的致癌剂和可疑致癌剂的污染，另外，改变生活方式中的吸烟、饮酒以及其他不良习惯。

二级预防主要是给予早期生癌者，尽快治疗。在这里就显示出肿瘤的早期发现的重要性。

三级预防是指癌症晚期病人的治疗护理，康复。恶性肿瘤是进行性发展性的疾病，一旦发病，病人的状况往往迅速恶化，治疗一般亦无过多的回旋余地。病期越晚，治疗越棘手。因此早期诊断，早期治疗在预防学方面有其重要的意义。

第二篇 各 论

第一章 脑 瘤

【概述】

生长于颅内的肿瘤通称为脑肿瘤，包括起源于颅内各种组织的原发性肿瘤和由身体其它部位转移到颅内的继发性肿瘤。其发病率无明显地域性差异，原发性脑瘤为每年 10 万人口中 2~10 人，约占全身肿瘤的 2%。在儿童因身体其它部位的肿瘤较少，故颅内肿瘤的相对发病率较高，约占全身肿瘤的 7%。转移性脑肿瘤即转移癌约占颅内肿瘤的 9.2%~11.6%，占恶性肿瘤尸检资料的 18%~30%，脑瘤可发生于任何年龄，但以 10 岁左右和 30~40 岁为两个发病高峰。脑瘤好发部位在儿童以小脑幕下为多，常见有小脑的星形细胞瘤，小脑中线的髓母细胞瘤，第四脑室的室管膜瘤，蝶鞍部的颅咽管瘤等。在成人以小脑幕上为多，常为大脑半球的额叶胶质瘤，额顶部位脑膜瘤、垂体腺瘤、转移瘤及听神经瘤等。小脑幕上肿瘤占 70%，幕下肿瘤占 30%。

现代医学对脑瘤的病因尚不明了，但认为并非单纯一种因素引起，已知的发病因素有：①脑胚胎组织发育异常，如颅咽管瘤、畸胎瘤、脊索瘤、皮样囊肿、表皮样囊肿等。②遗传因素：一些胶质瘤、听神经瘤和脑膜瘤有家族遗传倾向，少数巨细胞型星形细胞瘤及一些神经纤维肉瘤属显性遗传。③化学因素：致癌物甲基胆蒽在昆明种小鼠脑内接种可诱发脑瘤，甲基亚硝脲或乙基亚硝脲口服或静脉注射都可诱发出动物的脑胶质瘤和室管膜瘤。④病毒：一些病毒能在多种动物身上诱发出脑瘤来，但在人身上并未证实。

脑瘤的病理学分类很复杂。由组织发生来源不同，有由神经

胶质成分发生的；有由脑脊膜成分发生的；有由脑脊髓神经及其神经鞘发生的；有由颅内器官发生（如垂体瘤）；有由血管成份发生，还有由胚胎残余和异位组织发生的肿瘤。此外，还有颅外肿瘤侵入颅内或肺癌、绒毛膜上皮癌等的脑转移等。现一般将由外胚叶发生的肿瘤统称为胶质瘤，占颅内肿瘤的 43.85%，且半数以上为恶性，可发生于脑内任何部位。

由脑瘤发生的部位、病理类型、原发与继发、良性和恶性、儿童与成人及个体差异的不同，而临床表现各种各样，但综合起来可归纳为一般症状（即颅内压增高症状）和局部症状。颅内压增高症状：①头痛对 90% 以上患者来说为早期症状，幕上肿瘤出现较晚较轻，幕下肿瘤出现较早较重。初起轻，为间歇性，以后渐重转为持续性、进行性。②约有 60% 的患者发生呕吐，呕吐呈喷射状，随头痛加重而呕吐次数增多。③视力障碍。约 80% 患者有视力障碍，视野缺损和眼底改变。④其它症状有头晕、耳鸣，嗜睡也常见。瘤灶引起的局部症状：局部症状有定位价值，特别是发病初期更有意义。如额叶肿瘤导致精神障碍、进行性智力迟钝、眼球震颤、癫痫发作；额叶后部中央前回受压导致对侧偏瘫；大脑顶叶肿瘤出现感觉障碍，感觉定位和感觉区别能力消失；大脑颞叶肿瘤、颞上回后部肿瘤导致感觉性失语症、耳聋、耳鸣、幻听；大脑后部深处肿瘤可导致视野同侧偏盲、视幻觉；钩回和海马回肿瘤可致幻味、幻嗅；大脑枕叶肿瘤，上部表现为两眼上视无力，上睑下垂，下部表现为两眼下视不全麻痹；小脑半球肿瘤可致眼球震颤、言语不清、枕区疼痛及小脑共济失调症状；桥脑肿瘤典型表现为交叉性偏瘫，交叉性感觉麻木及眼球垂直震颤等；蝶鞍部肿瘤常导致内分泌失调和局部压迫症状。

脑肿瘤患者的生存期因肿瘤的部位、发病的早晚及肿瘤的病理类型不同而有较大差别。如脑胶质瘤呈浸润性生长，与正常组织无明显界限，生长迅速，肿瘤切除后复发率较高，且恶性程度较前更高，而神经纤维瘤和脑膜瘤呈非浸润性生长，多属良性。

由于脑内无淋巴结构，瘤细胞不易蚀破血管，在其它器官内亦无生长适应能力，因此很少发生颅外转移。其综合治疗的5年生存率大致如下：髓母细胞瘤 25~50%，多形性胶质母细胞瘤 10%以下，星形细胞瘤 50%，少枝胶质细胞瘤 53%~85%，室管膜瘤 50%~70%。而对脑转移瘤如不治疗，多在1~2个月死亡，单纯手术和放射治疗可生存3~6个月，综合治疗生存期为6个月。

由于历史条件的限制，我国古代中医文献中无脑瘤的明确记载，但散在地提到一些脑肿瘤的主要症状。如《金匱要略·中风历节病脉证并治》中有：“邪在于络，肌肤不仁；邪在于经，邪重不胜；邪入于腑，即不识人；邪入于脏，舌即难言”的记载。《灵枢·厥病篇》：“真头痛，头痛甚，脑尽痛，手足寒至节，死不治”以及“厥逆”、“头风”等。以后历代中医文献中，有关脑肿瘤的症状如头痛、呕吐、癫狂、痫、痰饮、中风等记录较详细，但有这些症状并不一定就是脑肿瘤，故应根据中医理论来指导脑瘤的中医中药治疗。

【病因病机】

祖国医学认为“邪之所凑，其气必虚”，肿瘤是正气虚弱所致。脑肿瘤也是“正虚邪入，阴阳失调，寒热相搏，毒积脏腑，营衍壅塞”所致。头为诸阳之会，手足三阳经均交会于头面，是属阳；“肾主骨，骨生髓”，“诸髓者属于脑”，脑为髓海，奇恒之腑，是属阴。在正常情况下，阴平阳秘，邪不得入，清阳之气上升，浊阴之气下降，升降有序，健而无疾。如若内伤七情，郁闷暴怒，或神志失司，辛劳过度，更兼外感六淫，寒湿阻络，则气血瘀结，痰毒凝聚。正气虚弱，邪气乘虚而入，导致清阳不升，浊阴不降，格于奇恒之腑的脑内，肿大成积，发为肿瘤。

脑居头巅而及全身，脑肿瘤时也可影响到五官四肢，使其发生各种相应症状，对心、肝、肾三脏的关系尤为密切。如心主神明，藏神，为精神之所舍。脑瘤时，气血瘀结，脾肾阳虚，致痰

湿内滞，痰迷心窍，出现意识障碍，头痛昏迷，语无伦次，狂躁不安；邪遏心阳，出现胸中烦热，眩晕呕吐；气滞血瘀导致头痛，面部及肢体麻痹。

肝藏血，开窍于目。脑瘤时，肝阴不足，肝阳上亢，可出现头痛、眩晕、耳鸣、耳聋、视力下降。肝血不足以濡筋，出现肢体震颤麻木。肝风内动，轻则眩晕欲仆，重则项强抽搐，口眼歪斜，语言困难，半身瘫痪。

晚期肿瘤患者，常因虚致病，又因病致虚，形成恶性循环；经手术、放射治疗或化学药物治疗后更是气阴大伤，从而表现出一派正气不支的临床症状。

总之，脑瘤由于其种类及部位不同，表现各不相同，病因病机亦不相同。但不外内因为正气不足，脾肾阳虚或肝肾阴虚；外因寒气、邪毒入侵及形成痰湿、瘀毒所致。

【治疗】

一、辨证论治 脑瘤的症状因部位、性质不同而各异，临床可分的类型较多，但以肝风内动较多，其中以胶质瘤、脑膜瘤、听神经瘤为主，转移癌亦多见；痰毒凝聚亦见于胶质瘤、脑膜瘤及转移癌，兹辨证分型如下：

1.肝风内动型

【主证】头痛头晕，耳鸣目眩，视力障碍，恶心呕吐，肢体麻木，失眠健忘，烦躁易怒，咽干颧红，抽搐震颤，舌强失语，昏迷项强，眼吊复视。舌红少苔，脉弦细而数。

【分析】此型多由素体肝肾阴虚，先天不足，水不涵木，阳亢化风，肝风内动所致。

【治则】滋阴潜阳，镇肝熄风。

【方药】杞菊地黄丸加减。常用生熟地各 25g，山萸肉 30g，山药 12g，泽泻 10g，云苓 10g，菊花 10g，怀牛膝 10g，勾藤 15g，白芍 15g，元参 10g，生牡蛎 30g，枸杞子 20g，生龟板 20g，女贞子 15g，生赭石 30g。

【方解】上方以杞菊地黄丸为基础，滋阴补肾，养肝明目，加女贞子、白芍、玄参以滋阴敛阳，怀牛膝、勾藤、生牡蛎、生龟板、生赭石以潜阳熄风。在上方中并可选加全蝎、蜈蚣、地龙、僵虫以加强镇肝熄风之效。

2. 痰毒阻络型

【主证】头痛头晕，肢体麻木，半身不遂，身重倦怠，舌强呕吐，语言蹇涩，视物模糊，痰多胸闷。舌胖，苔白腻，脉弦滑。

【分析】此型当责之于痰毒内阻，浊阴凝积于脑、脾、肾三脏功能失调，聚而生湿，变为痰饮。《丹溪心法》谓：“痰之为物，随气升降，无外不到。”致清阳之气不升，水湿上泛，蒙蔽清窍；流注经络，络阻不通，重则阻遏心窍而出现本证。

【治则】化痰解毒，通络开窍。

【方药】涤痰汤加减。常用半夏 15g，陈皮 10g，威灵仙 30g，云苓 10g，胆南星 10g，枳实 10g，苍白术各 10g，菖蒲 10g，郁金 1g，竹茹 10g，青礞石 15g，瓜蒌 30g，猪苓 45g。

【方解】半夏、陈皮、苍术、白术、云苓、健脾燥湿；威灵仙、胆南星、青礞石、瓜蒌祛痰通络；竹茹和胃；枳实下气，气顺而痰降；菖蒲、郁金开窍醒脑；猪苓利湿解毒。如病情较重，可投牛黄清心丸镇惊安神，化痰熄风。

3. 瘀毒内结型

【主证】头痛头胀，如锥似裂，面红耳赤，口干尿黄，便干燥结，唇暗色紫，月经不调。舌暗红或降红，苔黄或白，脉弦数。

【分析】此型为肝胆实热，瘀毒内结所致。六淫七情所伤，肝脏气机失调，郁而化火，导致气血上逆而现诸证。

【治则】清热泻火，解毒化瘀。

【方药】龙胆泻肝汤加减。常用生地 20g，赤芍 10g，胆草 10g，黄芩 10g，泽泻 15g，木通 10g，牛膝 15g，栀子 10g，当

归 10g, 夏枯草 20g, 野菊花 30g, 蛇六谷 20g (先煎 2 小时), 车前草 30g。

【方解】胆草、黄芩、栀子、夏枯草、野菊花泻肝清火，解毒清热；生地、泽泻、木通、牛膝、车前草导火下行；当归、赤芍活血化瘀；蛇六谷化痰攻毒，亦可合用清瘟败毒饮化裁。并酌加大剂量水牛角片、石决明、蛇舌草、延胡索等化瘀攻毒。

4. 气血郁结型

【主证】头痛头胀，胸痛胁胀，面色晦暗，口干气短，视物模糊，口唇青紫。舌质紫暗，边有瘀斑，脉象细涩。

【分析】此证当属气滞血瘀，郁结不散而聚积成瘤。脑为元神之府，依气血正常运行具主宰神明之功。机体若因寒热温凉失调，情志抑郁不舒或受痰饮、湿浊、瘀毒之侵犯则可出现“气塞不通，血壅不流”。由于气滞而血行不畅，阻塞经脉，聚而不散，肿大成积，首脑部位必先受其害，而出现本证。

【治则】活血化瘀，软坚散结。

【方药】血府逐瘀汤。常用桃仁 10g, 红花 10g, 当归尾 15g, 生地 10g, 川芎 20g, 赤芍 15g, 牛膝 10g, 桔梗 6g, 柴胡 6g, 枳壳 10g, 甘草 3g。

【方解】当归、川芎、赤芍、桃仁、红花活血祛瘀；牛膝祛瘀血，通血脉，并引瘀结下行；柴胡疏肝解郁，开达清阳；桔梗、枳壳开胸行气，使气行则血行；生地凉血润燥，配当归又能养血润燥，使祛瘀而不伤阴血，甘草调和诸药。因此型常伴大便秘结，故可加通便药。

5. 脾肾阳虚型

【主证】精神不振，腰膝酸软，形寒肢冷，阳萎不举，气短懒言，倦怠无力，多饮多尿，肌肤痿软，头晕头痛，目眩耳聋，视力障碍等。舌淡苔白润，脉细弱无力。

【分析】此型多见于蝶鞍部肿瘤，颅咽管瘤及垂体瘤。肾为先天之本，脾为后天之本，脾主运化，肌肉四肢的发达有赖脾阳

的温煦；肾主骨生髓通于脑。肾阳充则脑府精明。今脾肾阳虚，脑虚髓空，故尔出现以上诸证。

【治则】温补脾肾，补脑填髓。

【方药】金匱肾气丸加减。常用熟地 15g，山萸肉 15g，云苓 10g，菟丝子 10g，益智仁 10g，泽泻 10g，附子 6g，肉桂 6g，牛膝 10g，鹿角胶 10g，补骨脂 10g，白术 10g。

【方药】本方以金匱肾气丸温补肾阳。方中补阳药与补阴药并同。取《景岳全书》“善补阳者，必于阴中求阳，则阳得阴助而生化无穷”之义。加鹿角胶、补骨脂、白术、益智仁等以温脾肾，益精填髓。若出现小便不利可用济生肾气丸加减。在上方基础上并可酌加软坚散结及抗癌中草药。

【按语】脑瘤除上述各型外，当合并多种兼证，则可根据不同的兼证用药。如湿困脾阳，有头沉头痛，眩晕，肢体水肿沉重，食少腹胀，渴不欲饮，舌淡脉滑或缓者，可予健脾利湿或温阳利水药，用五苓散、五皮饮、疏凿饮子等，或加用车前子、木通、金钱草、冬葵子、白茅根等。如颅内压增高严重，出现脑疝等危险症状者，则可用攻逐水饮药物及峻下药物，如巴豆霜、大戟、甘遂、商陆、二丑等。气滞血瘀者加桃仁、赤芍、水蛭、虻虫。神志不清者加苏合香丸、清开灵、局方至宝丹。抽搐震颤者加全蝎、蜈蚣、钩藤、天麻、僵蚕、晚蚕砂等。有大便秘结者可给予大黄、芒硝、郁李仁、番泻叶，以涤荡胃肠燥结之热毒，减低颅内压和腹内压。

二、单方、验方、成方（药）

（一）单方

- 1.冬凌草 60~120g，煎服。或片剂，每日三次，每次 10~15 片。
- 2.苍耳草 30g，水煎服。
- 3.重楼 30g，水煎服。
- 4.猪苓 30g，水煎服。

- 5.刀豆子 30~60g, 水煎服。
- 6.夏枯草 30~60g, 水煎服。
- 7.野菊花 30g, 水煎服。
- 8.蛇六谷 30g, 水煎三小时, 分三次服。
- 9.鲜金剪刀适量加食盐少许捣烂外敷肿瘤部或用鲜仙人掌捣烂外敷。

(二) 验方

1.在脑瘤的严重头痛, 呕吐, 抽搐及视力障碍者, 可以服用石决明 15g, 菊花 30g, 牡蛎 15g, 钩藤 15g, 威灵仙 30g, 晚蚕砂 10g, 蜂房 9g, 地龙 9g, 蜈蚣 3 条, 全蝎 6g。亦可服用生石决明 30g, 姜虫 15g, 地龙 30g, 蝉蜕 10g, 木贼 20g, 生鳖甲 10g, 钩藤 15g, 蜂房 10g, 牡蛎 15g, 丝瓜络 15g, 全虫 15g, 甘菊花 25g。

2.白花蛇舌草 30g, 蛇六谷 30g, 贯众 30g, 菝葜 30g, 野菊花 30g。水煎服, 每日一剂。

3.白僵蚕 3g, 蝉衣 3g, 壁虎 1.5g, 牛黄 1.5g, 血竭 1.5g, 儿茶 1.0g, 全虫 1g, 蜈蚣 1g, 泽泻 20g, 刀豆子 3g, 鱼脑石 3g, 山羊角粉 1.5g, 猪苓 20g。共为研面, 半月量, 装囊服或冲服。

4.夏枯草 30~60g, 重楼 30g, 猪苓 30g, 苍耳草 30g, 赤芍 15g, 生石决明 30g, 昆布 30g, 海藻 30g, 生苡仁 30g, 薄荷 3g, 水煎服, 日一剂。

5.胆南星 10g, 清半夏 10g, 川贝母 15g, 海藻 60g, 紫草根 30g, 姜虫 15g, 蝉衣 30g, 陈皮 15g, 茯苓皮 30g, 泽泻 10g。水煎服, 日一剂。

6.炒苍耳子、远志、石菖蒲、白蚤休各 60g, 白花蛇舌草、蛇六谷、夏枯草各 100g, 冰片 20g。加水适量, 小火煮沸约 10 分钟, 将药液装入两个杯子中, 放在患者头部两侧, 使其自然吸入药气。

7.白蚤休、浙贝母、黄药子、蒲公英、莪术各 100g。研末，用布袋装作枕头。另用冰片 100g，麝香 1g，研匀，制成小药袋，一并放入枕中，令患者枕头部。

麝香外用有较强的渗透作用，用于脑瘤患者有解毒化瘤之效，但个别病人亦可导致肿瘤扩散，临床慎用之。

8.白头翁黄酒汤：白头翁 120g，黄酒 120ml。将白头翁浸于黄酒，4 小时后，加水 80ml，煎约 40 分钟，余至 600ml，每日服 2~3 次，每次服 200ml。

9.蟾酥解毒丸：蟾酥 6g，轻粉 3g，寒水石 15g，铜绿 3g，醋灸没药 3g，醋灸乳香 3g，胆矾 3g，雄黄 6g，朱砂 10g，活蜗牛 60g。除蜗牛、蟾酥外，其余药物共为细末，然后将蜗牛捣烂，再用蟾酥合研调糊，加入药末，捣均匀后为丸。如绿豆大小，阴干，贮存。每日服二次，每服 3 丸，温开水送下。

10.消瘤止痛散：大生姜 120g，雄黄 120g，冰片 1g，元寸 1g。将姜掏洞将雄黄粉装入，姜片封口置瓦上，文火焙成棕红色为度，再将冰片、元寸与上药共研极细末，装瓶备用。用时将药物 1g 撒胶布上或伤湿止痛膏上，贴敷疼痛处即可缓解疼痛。

11.脑瘤汤：夏枯草 30g，海藻 30g，石见穿 30g，野菊花 30g，生牡蛎 30g，昆布 15g，赤芍 15g，桃仁 9g，白芷 9g，蜈蚣 9g，全蝎 6g，蜂房 12g，天南星 9g，王不留行 12g，天龙片 15 片。水煎服，每日一剂，煎两次分服，天龙片分三次随汤药吞服。

12.脑瘤丸：红粉 240g，郁金 240g，血竭 120g，蛤粉 120g，雄黄 120g，卤砂 120g，芥穗 30g，急性子 30g，川芎 30g，没药 30g，朱砂 30g，杜仲 30g，山甲 30g，蜗牛 30g，槐米 30g，全蝎 30g，黑芝麻 30g，丁香 30g，天麻 15g，白芨 15g，煅青礞石 15g，炒巴豆仁 150g，苍术 60g，银珠 60g，琥珀 60g，炮姜 60g，白芷 90g，川军 90g，蝉蜕 9g，元寸 9g，蜈蚣 10 条，斑蝥 30g，上药共为细末，枣肉为丸，每丸重约 3g，

口服，每次 2~4 丸，每日一次。

13.消瘤膏药：香油 580g，铅粉 165g。将香油用武火加温至起泡，不停搅动，扇风降温，至满锅全是黄泡时，取下稍放片刻，再置火上加温，约 300ml，在冷水中使香油能滴水成珠时，取下稍冷片刻，再放火上，后将铅粉均匀缓缓倒入，以木棒不停搅动至满锅均为深黄色大泡时，即刻取下，继续搅拌数分钟，后用冷水一碗，沿锅边倒入，去毒收膏，后摊贴在准备好的膏药纸上。

应用时，取膏药一张，烘烤至软，靠膏药中心部撒上一层“消瘤散”，后贴于肿瘤部位，药粉面积要在肿瘤区，每两天换药一次，1~3 个月为一疗程，必要时可继续用之。

14.消瘤散：老姜 100g，雄黄 100g，主治脑瘤、肝癌、淋巴瘤、骨肉瘤。

制法：取老姜刷去泥砂，去除叉枝，用小刀挖一小洞，掏空中心，四壁仅留 0.5cm 厚，填入雄黄粉，以挖出的姜渣封口，置陈旧瓦上用木炭火焙烤 7~8 小时，至呈金黄色，不焦为度，离火放冷，研细末，过 80 目筛，剩余姜渣可一并焙干研细，拌入粉内，即得。

用法：取安庆膏药以微火烘软，均匀撒上药粉，可按瘤块大小、痛点、穴位，结合选定贴敷部位，隔日换药一次。

（三）成方（药）

1.复方抗癌粉北京宣武医院用此治疗脑瘤 47 例，6 例肿瘤基本消失，10 例肿瘤缩小，11 例肿瘤无变化，4 例增大，16 例未复查。

2.菊黛丸每服 6g，日二次。可治疗脑瘤有严重头痛、呕吐、抽搐及视力障碍者。

3.右肢体有感觉异常、消失，眩晕欲倒或精神错乱以及进行性痴呆时，则可服磁朱丸，每服 3g，日二次。

4.在脑瘤初起，有头痛、呕吐，可服仙脑丸，每服 9g，日

二次。或平消丹，每次 1.5~6g，日三次，开水送下。

5.肝肾亏虚，若偏于阳虚，可用金匱肾气丸，每服 18 丸，每日三次；偏于阴虚，可用杞菊地黄丸，每服 18 丸，每日三次。

6.若肝阳上亢，虚风内动，出现中风症状者，可用安宫牛黄丸，每服 1g，2~3 次/日。

三、中西医结合治疗

(一) 中医药与手术相结合 脑瘤良性病例，手术切除可治愈，如属恶性，则手术后易复发，故术后要结合放疗、化疗及中医药综合治疗。中药常选用白花蛇、乌梢蛇、全蝎、蜈蚣、姜虫、地龙、山甲、三七、三棱、莪术、黄药子、山豆根、菖蒲、女贞子、山萸肉、补骨脂、威灵仙等，结合中医辨证论治以抗癌抑癌，消毒散结，滋补肝肾，促进肿瘤消散，恢复机体抗肿瘤能力，杀灭残余癌细胞，即“正气存内，邪不可干”。如有颅内压增高症状，需要同时进行脱水或减压治疗，除西医学常规治疗外，可加服车前子、白茅根、大戟、甘遂、芫花，攻逐水饮，降低颅内压，争取时间进行其他方法治疗。

(二) 中医药与化疗相结合 化疗药物对脑肿瘤有一定的作用，由于脑肿瘤所处部位的特殊性，许多化疗药物均不宜透过血脑屏障，对局部肿瘤的杀伤力大为减低。常需加大化疗药物的剂量，须配合中药，临床习用旋复花、代赭石、姜竹茹、清半夏、威灵仙、陈皮、焦白术、菟丝子、黄精等，以减轻毒副作用，促进化疗疗效的提高。在常规化疗的同时，我们在临床常配服中药汤剂：黄药子 30g，急性子 20g，半枝莲 30g，蛇舌草 30g，全虫 15g，蜈蚣 7 条，山豆根 15g，炮山甲 50g，生鳖甲 30g，清半夏 10g，姜竹茹 15g，九节菖蒲 20g，郁金 15g，白芷 10g，每日一剂。对缓解症状，延长生存期，提高化疗效果，有积极的促进作用。

(三) 中医药与放疗相结合 对脑肿瘤的治疗，放疗常在以

下情况时应用:①手术无法彻底切除的胶质瘤,在手术后辅以放疗,能延迟复发,延长生存期。②对一些不能手术的部位肿瘤,如脑干或主要功能区的肿瘤,放疗是主要治疗方法。③对放射线敏感的个别脑瘤,如髓母细胞瘤。放疗效果较手术为佳。④垂体瘤、松果体瘤可施以放疗。⑤对放射线敏感的脑转移癌,如来自肺部的小细胞未分化癌,放疗可控制病情,获得缓解。脑部放疗时应配合中药治疗,以和胃降逆,益气养阴,健脾利水为主,可减轻放疗副反应,明显提高患者的生存期和生存质量。常用太子参 30g,白术 15g,茯苓皮 20g,玄参 30g,麦冬 15g,陈皮 10g,姜半夏 10g,姜竹茹 15g,车前子 10g 等随证加减。

脑瘤临床用药体会:头痛甚者伴剧烈呕吐用四石汤(生石膏、寒水石、西滑石、代赭石)镇潜肝胃气分之热,以止痛。若因痰火上扰,颅内压增高的头痛,,用土茯苓小量 30g,中量 60g,大量 80g 配益母草,清热解毒,降火祛痰,活瘀利尿以止头痛。若热毒蕴结,头痛伴喷射性呕吐,面红目赤,用犀角地黄汤凉血解毒,火退痛止。若眼底乳头水肿,重用川贝母(小量 10g,中量 20g,大量 30g)生石决明、草决明、白茅根,降乳头水肿疗效较佳。头痛伴瞳孔扩大,复视,用磁朱丸加石决明、代赭石、五味子平肝潜阳以敛神光。

四、综合治疗 对于恶性脑瘤,单纯用手术、放射治疗、化学治疗等均不能彻底根除及杀尽肿瘤细胞,如能在手术切除后辅以放疗、化疗或放疗加化疗及中医中药治疗,对延长病人生命和改善生存状态都有益处。目前临床广泛而疗效比较满意的有日本学者提出的“BAR”疗法。“B”代表溴化尿嘧啶(Br-UDR)是一种放射增敏剂;“A”为抗代谢类药物;“R”为放疗,其具体方法:在开颅手术后 2~4 周,经颅内动脉插管,持续滴注 5-溴尿嘧啶 600~1000mg/m²。同时用 MTX0.5~3.0mg/d,以颈动脉或椎动脉持续滴注;脑室系统或鞍区肿瘤,应用动脉内或脑室同时滴注,脑室内滴注的剂量为动脉给药剂量的 1/10~1/5。采用

动脉给药时，以肝素 1000 单位 / d，抗凝。动脉内给药 7~14 天开始放疗， ^{60}Co 外照射 45~60Gy。BAR 疗法收到良好效果，大多数胶质瘤的平均生存期明显延长。

由于脑瘤病人颅内压增高，致颅内压增高，循环障碍而发生不同程度的脑水肿，类固醇和脱水药的运用，能迅速缓解颅内高压症状，为其他治疗创造条件。其具体治疗可按内科常规处理。这里需要特别提到激素的运用，地塞米松对于维持细胞的功能，改善血管的通透性，减轻脑水肿的理论，已得到证实。其作用强，而水钠潴留较少，且大剂量运用，还能够延长肿瘤细胞的分裂时间而抑制肿瘤生长。很多学者认为术前应用地塞米松可以顺利使病人度过手术期，而术后因为充分减压可以停用或用维持量。在放疗或化疗中则应常规应用，以减轻不良反应而保证化疗和放疗顺利进行。据报道及我们临床观察，病人在用药后精神、意识、语言和运动功能改善较明显。

第二章 鼻咽癌

【概述】

鼻咽癌发生于世界许多国家和地区，发病率较低，但东南亚地区发病率较高。在我国为常见恶性肿瘤之一，全国调查死亡率为 $1.88/10$ 万人口，占全部恶性肿瘤死因的 2.81% ，居第 8 位。尤以我国南方地区发病率最高，占全身恶性肿瘤的 $8\% \sim 35\%$ 。其发病率随年龄增长而上升， $50 \sim 60$ 岁为发病最高峰，好发于男性，男女之比为 $2 \sim 10:1$ 。

鼻咽癌发生于鼻腔与口咽之间的鼻咽部，以顶部为最常见，侧壁、前壁次之，底部最少，且解剖部位隐蔽，症状和体征多变，易被病人和医务人员疏忽而误诊。来诊时多属中、晚期。目前仍公认放疗是鼻咽癌最有效的治疗方法。此病病因未明确，可能是多因素综合作用的结果，经大量研究结果表明：鼻咽癌与 EB 病毒感染有密切关系。具有种族易感性和家族聚集倾向，环境中微量元素镍的含量高对此病发生有直接影响。其它因素如维生素 A 缺乏，长期吸入致癌气体及食用含亚硝胺化合物的食品（咸鱼、腊肠、熏制品）有关。鼻咽癌病理学大体形态，原发癌呈结节型、菜花型、粘膜下型、浸润型和溃疡型。组织学分为未分化癌、低分化癌、较高分化癌（鳞癌和腺癌）三类。临床上分为四期：

I 期：肿瘤局限于鼻咽腔一个部位者。

II 期：肿瘤扩展到二个部位者，或单侧或双侧颈淋巴结肿大、活动，大小在 $3 \times 3\text{cm}$ 以内者。

III 期：肿瘤侵犯出鼻腔外，包括①邻近的软组织和腔窦。②颅底骨质破坏以第 I、II、III、IV、V、VI 颅神经侵犯；或单侧或双侧颈淋巴结肿大、固定，大小在 $8 \times 8\text{cm}$ 以下。

Ⅳ期：鼻咽肿物超腔，侵犯邻近组织，并有颅底骨质破坏及颅神经损害者；或颈淋巴结肿大，大小在 $8\times 8\text{cm}$ 以上，或锁骨上窝淋巴结有转移者；或有远处转移者。鼻咽癌的预后，自然生存期最短3个月，最长69个月，平均18.7个月。国内经放疗患者的平均5年生存率为19.6%~49.5%。

临床表现：

鼻咽癌古称“**颇颡**”。在祖国医学文献中所记载的“**失荣**”、“**控脑砂**”、“**真头痛**”、“**上石疽**”、“**耳鸣**”、“**鼻渊**”、“**瘰癧**”、“**喉岩**”等证与鼻咽癌的临床表现各有相似。其临床主要症状：

1.鼻部症状：鼻衄或血涕（占73.3%）为早期症状，多为回吸涕带血或经口咯血或从鼻孔流出。古人云：“……鼻中淋漓腥秽血水……”。鼻塞（占48%）也是早期症状之一，开始为单侧，当肿瘤增大浸润对侧时，可成为双侧。向口咽部侵犯，可于口咽侧壁、扁桃体周围、软腭等处发现病灶。

2.颈部恶核：鼻咽癌患者约有40%以颈部恶核为首发症状，但已属晚期淋巴结转移表现。恶核大小、数量不一。逐渐扩大融合成块，其特点是逐渐坚硬，最后“**坚如石**”，“**至牢有根**”，“**皮核相亲**”，“**推之不移**”，“**按之不到**”。

3.头痛：约57%的病人有头痛，常为病侧，部位较固定呈间断性。晚期较重，常呈持续性，如颅底骨或颅神经受侵犯时，头痛更剧烈。古人云“……**头眩虚晕而痛**……”。及《灵枢·厥病篇》所描述的“**真头痛，头痛甚，脑尽痛，手足寒至节，死不治**”即为本证的最好注释。

4.耳鸣、听力减退：耳鸣（62.6%），听力减退（占49.9%）也是鼻咽癌的早期症状之一。主要是因肿物阻塞络脉，蒙闭清窍，可出现音低声大之耳鸣，有胀闷堵塞感之听力减退。现代医学认为是由于肿瘤生长在咽隐窝或侧壁引起耳咽管堵塞所致。

癌肿发展，以致脉络阻塞。临床常见症状有目瞳不转，口眼

喎斜，眼睑下垂，面瘫麻痹，舌蹇语涩，吞咽困难，筋脉拘弛，食入反呛。由于其损害的颅神经不同，而出现不同的临床症状。

表 1 各对颅神经受侵犯的主要症状和体征

颅神经	出颅部位	症状和体征
I.嗅神经	颅前窝筛孔	嗅觉减退
II.视神经	视神经孔	黑蒙、失明
III.动眼神经	眶上裂	复视，眼球活动受限（只能往外往下运动），眼睑下垂瞳孔扩大
IV.滑车神经	眶上裂	复视，眼球向外，下运动障碍
V.三叉神经		
第1支上眼神经	眶上裂	眼眶周围皮肤感觉减退，麻木，角膜反射减退
第2支上颌神经	圆孔	上颌部感觉异常，神经痛，硬腭减退
第3支下颌神经	卵圆孔	下颌部麻木，口底和舌前2/3感觉减退，咀嚼肌麻痹，下颌骨运动不对称，不能向前
VI.外展神经	卵圆孔	复视，眼内斜，外展麻痹
VII.面神经	内耳门	面神经麻痹，单侧面瘫，额纹消失，眼闭合不灵，鼻唇沟浅，鼓腮动作不灵，叩齿不能
VIII.听神经	内耳门	神经性耳聋，眩晕
IX.舌咽神经	颈静脉孔	舌唇1/3感觉异常，软腭麻痹可致吞咽困难
X.迷走神经	颈静脉孔	咽喉感觉丧失，进食呛咳，声音嘶哑，声音麻痹
XI.副神经	颈静脉孔	外支受侵使斜方肌，胸锁乳突肌萎缩，耸肩无力
XII.舌下神经	舌下神经管	舌肌萎缩，伸舌时舌尖偏向患侧
颈交感神经		瞳孔缩小，眼睑下垂，眼球内陷，同侧无汗

【病因病机】

祖国医学认为该病的形成与先天素质、外界毒邪侵袭以及七情所伤有密切关系。如《医学入门》：“郁结伤脾，肌肉消薄，与外邪相搏，而成肉瘤”。兹分述如下：

一、鼻咽部为呼吸之通道，肺开窍于鼻，肺气通于鼻，咽属肺系，鼻咽癌始于肺热，肺气不宣则上焦热盛，迫血离经出现鼻衄，继而气血凝滞，津液结停，致鼻塞而变生癌肿。

二、因于体内外各种致病因素，如情志不遂，悲怒忧思，以致肝脾受伤，肝伤则肝气郁结，疏泄失常，气机不宣，肝藏血，肝气失调，则气血滞留；脾受伤，则运化失健，水湿内停，痰浊内生，阻于脉络，久则气血凝聚，痰浊困结，积结而成肿块。

三、机体脏腑功能失常，或老年元气虚弱，肾精亏损，而为邪毒（六淫、过食厚味）所犯，正气既不足，邪气则居之，渐渐积聚而成癌肿。故《景岳全书》云“少年少见此症，而惟中年虚衰耗伤者多有之。”《外科启玄》亦说：“癌发，四十岁以上，血亏气衰，厚味过多……”。

四、饮食内伤，长期过食辛辣炙博及刺激性物品，以致脾胃受伤，热毒蕴积，上升颅颞，结聚而致。

【治疗】

一、辨证论治 鼻咽癌中医辨证分型论治各家报告不一，根据临床结合有关报告分型治疗如下。

1.痰瘀互结型

【主证】颞颥部见癌瘤多呈块状或结节状隆起，色淡红或暗红，血丝缠绕，粘液附着，颈项有恶核，全身并见头重坠，偏头痛，耳胀闭，鼻塞，痰涕带血，痰多胸闷，胁胀痛，郁闷烦躁。舌质紫暗，边有瘀点，苔腻微黄，脉弦滑等。

【分析】素情志不遂，郁思忧怒，久伤肝脾，使气机不利，运化失常，致气血瘀滞，痰湿结聚，气血痰瘀互结，上遏颞颥，阻滞经络，蓄积日久，结为癌瘤，并出现以上诸证。

【治则】行气活血祛瘀，化痰软坚散结。

【方药】清气化痰丸合逍遥散加减。常用半夏 10g，胆星 10g，菱仁 30g，陈皮 12g，枳实 15g，山慈菇 20g，三棱 10g，莪术 10g，当归 15g，白芍 12g，柴胡 10g，薄荷 6g，党参

30g, 茯苓 15g, 白术 12g, 甘草 6g。

【方解】当归、白芍和肝活血，助柴胡、薄荷以疏肝解郁，且薄荷并有升提诸药之功用；党参、茯苓、白术、甘草健脾渗湿；半夏、胆星、薤仁、陈皮行气化滞祛痰浊，以枳实、山慈菇消积散结聚，配三棱、莪术活血逐瘀，攻坚消结之力更强。

【加减】鼻塞涕血多者加辛黄花、仙鹤草、侧柏炭，以通窍止血；痰多，颈部恶核大者，宜配合四生散，以攻坚逐瘀。

【变证】

(1) 肺热型（症属早期，症状不多）

主证：涕中带血，鼻塞或微咳，口苦咽干，头痛，脉滑而有力，舌质正常，苔薄白。

辨证：肺热伤阴，痰火凝滞。

治则：宣肺清热，消痰散结。

方药：石上柏 30g，苍耳子 10g，草河车 15g，射干 10g，山慈菇 15g，白茅根 30g，山豆根 10g，瓜蒌 20g，茜草根 10g，胆南星 10g，半夏 10g，白芷 10g。

(2) 气郁型（颈淋巴结转移为主）

主证：烦躁易怒，口苦咽干，耳聋耳鸣，头痛，梦乱纷纭，唇色红绛，颈部肿核，脉弦滑，舌边尖红，黄白苔。

辨证：肝郁气逆，痰火上扰。

治则：清肝泻火，消肿散结。

方药：野菊花 20g，勾藤 10g，桑叶 10g，夏枯草 15g，龙胆草 10g，丹皮 10g，茅莓 30g，石上柏 30g，苍耳子 10g，玄参 10g，赤芍 10g，七叶一枝花 15g。

2. 火毒困结型

【主证】颞颥部见癌瘤多呈菜花状，溃烂，渗血，腐物附着，臭秽，颈项恶核甚大或有疼痛；全身并见头痛剧烈，烦躁易怒，耳胀耳鸣，口苦咽干，痰涕带血，夜寐难眠，小便赤，大便结。舌质红，苔黄厚，脉弦滑数。

【分析】癌瘤日久，气血痰瘀，久郁化火，火毒困结，阻塞清窍，且腐肉损脉蚀骨伤筋，势不可遏，则致癌瘤破溃走窜而现诸证。

【治则】泻火解毒，散肿消坚。

【方药】当归龙荟丸加减。常用当归 60g，胆草 15g，栀子 30g，黄连 10g，黄柏 10g，黄芩 10g，大黄 10g，芦荟 3g（冲服），青黛 2g（冲服），龙葵 30g，天花粉 30g，海浮石 30g，山豆根 20g。

【方解】当归龙荟丸备举大苦大寒之药直泻火毒以二便而出；龙葵清热解毒，活血消肿利尿；海浮石清肺热，软坚散结；山豆根清热解毒，并利咽；天花粉清热生津，消肿排脓；重用当归活血消肿而不伤正。全方泻火解毒，散肿消坚，共奏治疗之功。

【加减】出血多者，加仙鹤草、白茅根、藕节以清热止血；腐物增多者加马勃、山慈菇以祛腐除秽；头痛剧烈甚者加露蜂房、三七、五灵脂、沉香以行瘀止痛；口眼歪斜，视一为二，伸舌不正，言语不清者，要辨明虚实，实者宜配合牵正散以祛痰息风止痉；虚者当更方治之。

3. 邪困正衰

【主证】颞颥部见癌瘤多呈菜花状，破溃不堪，活血淋漓难尽，恶臭难闻，颈项恶核坚如磐石，全身并见头痛剧烈，无可休止，精神萎靡，形体消瘦，倦困乏力。恶病质等。舌质淡，苔薄白或白腻，脉细弱无力。

【分析】癌瘤日久，邪困正衰，伤阳耗气，损精耗血，使脾肾亏虚，元气大衰，则致癌瘤破溃难敛，临床并见一派元气虚衰之象，最后元气耗尽而卒。

【治则】补益脾肾，扶正祛邪。

【方药】八珍汤。常用人参 10g，白术 15g，白茯苓 15g，当归 15g，川芎 6g，白芍 10g，熟地 12g，炙甘草 6g，生姜 6g，

大枣5枚。

【方解】方用人参、熟地为主，甘温益气养血；辅以白术、茯苓健脾燥湿，当归、白芍养血和营；炙甘草和中益气；川芎活血行气，使补而不滞；生姜、大枣调和脾胃之气。合以气血双补，则诸症可除。

【加减】放疗或化疗后可致阴阳气血俱虚，口干咽燥，舌上无津者，宜用增液汤合大补阴丸，以养阴生津润燥；头晕目眩，心悸怔忡，四肢麻木者，宜用归脾汤加减，以健脾养心补血；眩晕耳鸣，腰膝酸软者，宜用桂附八味丸加减，以温补肾阳；面色㿗白，食少便溏，食多则吐者，宜用参苓白术散加减以健脾益气。

二、单方、验方、成方（药）

（一）单方

- 1.紫草根 30g，每日煎服一剂。
- 2.冬凌草 120g，每日煎服一剂。
- 3.辛夷花 15g，泡茶饮用。
- 4.鹅不食草 30~60g，每日煎服一剂。
- 5.菝葜 30~120g，每日煎服一剂。
- 6.葵树子 30g，同瘦肉 60g，共煮，吃肉喝汤。
- 7.石上柏 30g，煎服，每日一剂。

（二）验方

1.鹅不食草 30~60g，野菊花 30g，辛荑 15g（后下），石上柏 30g，葵树子 30g。水煎服，日一剂。

2.苍耳草 30g，铁树叶 30~60g，重楼 30g，鱼脑石 15g，菝葜 60g，白芷 15g，公英 60g，水煎服，日一剂。

3.夏枯草 60g，苍耳草 30g，白花蛇舌草 30g，紫草 30g，山豆根 30~60g，白毛藤 30g，辛夷 15g，牛黄 0.5g（冲）。水煎服，日一剂。

4.麝香 1g，牛黄 10g，猴枣 1g，白蜡 0.5g，珍珠 2g，凤凰

衣 3g, 辰砂 3g。共研细末, 每日三次, 每次 0.5g, 冲服。

5. 半枝莲 60g, 山慈菇 30g, 苡仁 30g。水煎服, 日一剂, 分 2 次服。

6. 鼻上方: 适用于鼻咽部肿块明显的鼻咽癌。勾藤 12g, 蜈蚣 3 条, 蜂房 10g, 莪术 15g, 走马胎 12g, 葵树子 30g, 山慈菇 12g, 半枝莲 15g, 桑寄生 15g。鼻下方: 适用于淋巴结转移较明显者。川楝子 10g, 石菖蒲 10g, 白芍 12g, 夏枯草 30g, 生牡蛎 30g, 元参 12g, 生硼砂 5g (冲), 瓜蒌 15g, 皂刺 15g。

(中山医学院肿瘤研究所方)

(三) 成方 (药)

1. 大蒜注射液, 静脉滴注, 每日一次, 每次 75ml 加 1~%G-S500ml, 连用 15 天为一疗程, 休息 7 天可再用。

2. 20% 醋制碘砂溶液滴鼻, 每日 4 次及口服粉剂, 每次 1.2~1.5g, 每日三次; 同时肌注 20% 溶液 2ml, 每日一次。

3. 颈部恶核 (未破溃者) 用如意金黄膏加麝香散外敷。

4. 鼻咽灵片, 每日三次, 每次 8 片口服。

5. 千柏鼻炎片, 每日三次, 每次 8 片口服。

6. 莲柏治癌片, 每日三次, 每次 6 片口服。

7. 去甲基斑蝥素钠 10mg, 静滴每日 1 次, 30 天为 1 疗程。

三、中西医结合治疗 由于鼻咽部位置的特殊性, 因此对于鼻咽癌的治疗, 手术难以彻底根除。当首选放射治疗, 并辅以化学药物治疗。但放疗、化疗期间以中医药结合治疗, 能提高疗效, 减轻毒副反应。

(一) 中医药与放疗相结合 放射治疗是目前治疗鼻咽癌的首选方法, 如果病情尚早和治疗得当, 可取得满意的效果。在两者综合中, 放疗是直接杀伤肿瘤细胞, 控制局部癌灶而中医药则是除通过辨证论治具有扶正固本, 增强抗癌能力外, 还可治疗、减轻放射线的毒副反应。如放射中患者常出现咽干喉痛, 口渴欲饮, 心烦便秘, 溲赤等热毒伤津之象, 有的因反应严重而无法接

受继续放疗。临床我们习用银花、连翘、元参、生地、沙参、麦冬之类养阴清热解毒，可收到较好的治疗效果。

放射线和化学药物一样对机体缺乏选择性，即在杀灭癌细胞的同时，对放射野以内的正常组织也会带来较大的损伤，首先是头颈及口腔部的大部分腺体遭到破坏，失去了正常的分泌功能，临床上表现为严重的口舌干燥等阴液亏损的现象，常用沙参麦门冬汤合大补阴丸加减，长期服用，有促进和保护腺体分泌功能的恢复。

中医药对放射线并有增敏作用，据《癌症》杂志曹兆振等报道：以川红注射液对鼻咽癌放疗增敏观察 40 例。采用川红注射液放疗前静脉滴注（5mg）后半小时内作放疗，每周 5 次，直至肉眼观察鼻咽癌原发灶消失则停药，但仍继续完成放疗，共治疗 40 例；对照组仅作常规放疗，亦治疗 40 例。结果：川红组放射总剂量为 3609~8015rad，平均为 $4387.5 \pm 164.5\text{rad}$ ；对照组为 2796~6896rad，平均为 $5312.5 \pm 233.8\text{rad}$ 。经统计学处理 t 值为 3.244， P 值 < 0.01 有显著性差异。认为表明川红注射有一定放疗增敏作用。

另据潘明继等对用扶正生津汤（麦冬 12g，天冬 12g，沙参 10g，元参 9g，生地 10g，白茅根 12g，玉竹 9g，银花 9g，蛇舌草 30g，白毛藤 20~30g，党参 12g，茯苓 10g，白术 10g，丹参 12~15g，甘草 3g，并随证加减）配合放疗治疗鼻咽癌 150 例远期疗效观察，证明中药确能减轻放疗副反应，减少远期后遗症，5 年生存率可达 58%，10 年生存率达 30.8%，比国内同期报道的单纯放疗病例疗效提高，观察并证明生存率的高低，与病期的早晚、中西医结合治疗是否及时，服药时间的长短呈正相关。

郁仁存《中医肿瘤学》载：针灸配合鼻咽癌放射治疗，每三天外灸一次，以手捻轻刺激为主，每次留针 15 分钟左右，观察原发灶全消率较单纯放疗组高，穴位选择：

主穴三组：足三里，合谷；足三里，上巨虚；足三里，关元

配穴：曲池、列缺、听宫、听会、迎香等。

(二) 中医药与化疗相结合 本疗法一用于鼻咽癌已有远处转移或放疗后复发不宜行放疗的晚期病人。其中化疗直接杀灭癌细胞而控制病灶的发展，中医中药的目的在于扶正固本和增强抗癌力量，用来治疗、减轻和预防化疗的毒副反应，并进一步促进化疗药物的作用。广东肿瘤防治载：用中药汤剂合环磷酰胺每日 0.2g (总量 6.28g)，争光霉素每日 15~30mg (总量 300~450mg)，三生滴鼻水 (生半夏、生川乌、生南星等量混合用酒提取，每毫升含生药 1g)，每 2 小时滴鼻一次，每日四至六次，中西医结合治疗鼻咽癌 19 例，显效 4 例，有效 2 例，缓解 11 例，无效 2 例。后用上法治疗 2 例放射线治疗后复发及肋骨转移者，均获疗效。有人报道，使用嘧啶苯芥合并中医辨证治疗 200 例鼻咽癌，近期有效率 75%，其中显效率 25%。

五、综合治疗 鼻咽部位狭小，邻近重要器官甚多，而绝大多数的鼻咽癌病理类型属于低分化癌和未分化癌对放疗最为敏感。因此，放射治疗仍是目前治疗鼻咽癌的首选方法。但是，由于肿瘤恶性程度高，浸润生长快，容易较早发生颈部区域淋巴结转移或远位转移，以及尚有部分患者放疗后复发，所以化疗在综合性治疗鼻咽癌，尤其是晚期癌、复发转移病例中，作为较重要的治疗措施，可使部分病人症状得到缓解，肿瘤有所缩小。手术治疗对鼻咽癌的适应证很少，对复发和转移的肿块，可考虑手术切除或姑息性放疗，尽可能使实体瘤的负荷量在化疗前最大程度地减少，使更多的癌细胞进入增殖期，并针对病人机体的状况选择合理的化疗方案，有效地发挥化疗作用。如何掌握放疗和/或化疗、手术的时机，将取决于病理组织类型和临床分期及患者的体质、营养状况，这是提高综合治疗疗效的关键。而中医中药的运用绝不可忽视，临床实践证明鼻咽癌在放疗、化疗中及治疗后，给予益气养阴、生津润燥、调理脾胃、滋补肝肾等中药治疗，对提高患者的免疫功能，增强抗癌肿的能力，改善患者体质

和营养状况，减轻和防止放、化疗毒副反应及后遗症，控制癌肿的发展，减少复发和转移。延长生存期和提高生存质量等方面，均起到积极的作用。

第三章 舌 癌

【概述】

舌是固有口腔内的肌肉器官，以人字沟为界，舌前 2/3 称为舌体，舌后 1/3 为舌根部。舌粘膜被覆复层鳞状上皮。舌癌是口腔癌中发病率最高的恶性肿瘤。舌癌位于舌体称舌体癌；位于舌根称舌根癌。舌癌发病与烟酒嗜好有一定关系，根据河南医科大学资料，106 例舌癌中，吸烟者占 93.1%，嗜酒者占 51.2%。舌癌中，侧缘癌发病居首位，它与锐利牙尖、残根、冠或不良修复体的慢性刺激有关。因内外不少文献报道，舌癌可由癌前病变如白斑、红斑等恶变而成。其中以舌背白斑癌变较多见。非均质型白斑为恶变倾向，较均质型明显。舌癌的恶性度最高，占人类恶性肿瘤死亡率的 1% 左右。据国内文献报道，口腔癌中舌癌占 32.3%~50.6% 而居首位，占头颈部恶性肿瘤的 5%~7.8%，占全身恶性肿瘤的 0.8~1.5%。舌癌男性好发，男与女之比约为 1.2: 1。高发年龄为 41~60 岁，占 64.1%。

舌癌的临床表现中，其肿瘤形态多为凹陷性溃疡型，浸润性强，占 61.86%；其次是外突浸润型，浸润性较轻，占 29.66%。其生长方式多呈浸润性生长。其临床症状为舌癌病灶渐大，伴发自发性剧痛，亦极易出血伴发恶臭。病灶累及舌肌，出现咀嚼、语言等功能障碍。当肿瘤侵犯全舌时，舌则完全硬结固定，出现开口困难。随后出现恶病质。其转移性高，舌的血供及淋巴丰富，活动度大，所以舌癌区域淋巴结转移率可高达 60%~80%。其病理形态学，据国内资料报道，舌癌中鳞状细胞癌占 90% 左右，少数为淋巴上皮癌、淋巴肉瘤、腺样囊性癌及未分化癌。

舌癌即祖国医学所说“舌岩”、“舌菌”、“舌疳”。因肿起成块，

坚硬如岩石故名舌岩；有时形似菌状，故又名舌菌；若溃烂后形成高低不平的溃疡，则称为舌疳，亦称为舌痔、舌芝者。本病是一种常见的口腔岩症。在中医文献中对本病的论述颇详。元·朱震亨《丹溪心法》中，首先见到有舌岩的记载，其曰：“焮肿突如泛莲，或状如鸡冠，舌本短缩，不能伸舒，言语时漏臭涎，再因怒气上冲，忽然崩裂出血不止，久久烂延牙龈，即名舌岩”。又“甚至透舌穿腮汤水漏出，是以名翻花岩也”。清·吴谦《医宗金鉴》名舌疳，书中曰：“舌疳其证最恶，初如豆，次如菌，头大蒂小，又名舌菌，疼痛红烂无皮，朝轻暮重。……久久延及项颌，肿如结核，坚硬痠痛，皮色如常”。描述了晚期累及颈颊而出现硬块等特征。清·邹岳《外科真诠》曰：“舌岩，舌根腐烂如岩”。清·王秉均《疡科心得集》曰：“久之延烂牙龈，即名牙岩”。对舌岩的临床症状及转移均有较详的叙述。清·尤乘《尤氏喉科秘书》叙述了舌岩的病因，说：“舌菌属心经火多，因气郁而生”。清·张宗良《喉科指掌》曰：“此一证，百无一生，纵施药饵，不过苟延岁月而已”。限于当时医疗条件，对此病的预后进行了记述。清·包永泰《图注喉科指掌》亦有：舌疳之症恶非常，心脾火毒积中央，初如豆大渐如菌，暮重朝轻饮食妨，怒则崩裂透腮舌，串延项颌核滋昌，名为瘰癧风难治，百人患此百消亡”。说明了本病颇为难治。

【病因病机】

舌为心之苗，心脉系舌本，脾脉终舌旁，散舌下，肾脉亦系舌本，终于会厌。故舌岩多由机体元气虚弱，正不胜邪，邪犯心脾而致。外感六淫入里化火；或七情郁结，心烦烦扰则生火；思虑伤脾则生郁，心脾内伤，郁久化火，火毒循经上升，结于舌体，经脉阻滞，气血凝聚，积聚成块。若火毒久灼，伤肌败络，溃烂翻花，而成本病。病久可耗伤体内气血阴阳，出现阴虚火炽，气血两虚等症。

【治疗】

一、辨证施治 对于舌癌的治疗，在《外科真诠》中就认为：“本症最恶，难以调治”。故宜早期发现，早日治疗，初起以根治切除为宜。近年来，随着中医药的辨证配合治疗，使疗效明显提高，显示出中医药的巨大潜力。根据证象及文献资料，我们将舌癌分为如下四型。

（一）心脾郁火型

【主证】病之初起，常在舌边见肿物突起如豆，或如菌状，触之较硬，或有糜烂溃疡。久治不愈，疼痛难忍。舌向患侧歪卷，流涎腥臭。伴心烦、口渴、失眠、尿黄、舌质红，苔薄黄，脉弦数。

【分析】患者七情郁结，心脾两伤，郁久化火，火毒循经上结于舌体，脉络痹阻，瘀血凝滞，火毒瘀结聚成块，故舌生肿物，质硬而痛，若肿物外有损伤，或火毒腐肉或可见糜烂溃疡；脾主涎，脾有伏火毒结，则流涎腥臭；心烦、口渴、失眠、尿黄、舌质红，脉弦数皆为心脾郁火之象。

【治则】泻火清心，化瘀解毒。

【方药】导赤散加味。

生地 24g，木通 12，淡竹叶 6g，川连 9g，车前子（布包）9g，山豆根 15g，草河车 15g，蒲公英 15g，甘草 6g，赤芍 9g，海藻 9g，僵蚕 9g。

【方解】方中重用生地清心凉血滋阴，竹叶清热除烦，木通、车前子、川连导心火外出，山豆根、草河车、蒲公英、甘草、赤芍、海藻、僵蚕解毒化瘀消肿。通览全方结构，乃一标本兼治之方。

【加减】疼甚可加细辛、青黛或含服六神丸；若有气郁表现者加柴胡、黄芩、香附、佛手。

（二）火毒炽盛型

【主证】舌癌硬结增大，边缘不整，破后味臭难闻，溃疡出血，咀嚼吞咽困难，舌觉短而不灵，碍食难言，伴见身热、口

渴、便秘、溺黄、舌红绛、苔黄腻、脉滑数。

【分析】郁火滞恋，致生火毒，火毒瘀滞，灼伤肌肉，损伤络脉，则见舌癌肿块增大，溃烂出血，臭而难闻；舌为发言及吞咽之辅助器官，舌生癌瘤，肿僵而痛，则有碍食言。身热、口渴、便秘、尿黄、舌红绛、苔黄腻、脉滑数皆为火毒内炽、耗津伤血之明征。

【治法】清热泄火，解毒散结。

【方药】黄连解毒汤加味。

黄芩 12g，黄连 9g，黄柏 9g，山栀子 15g，制大黄 9g，金银花 30g，知母 12g，白花蛇舌草 15g，夏枯草 15g，草河车 15g，山豆根 15g，半枝莲 15g，蒲公英 12g，薏苡仁 12g。

【方解】方中黄芩、黄连、黄柏、山栀子、制大黄、金银花有较强的清热泻火之功。知母清热滋阴，以助泻火之功。白花蛇舌草、夏枯草、草河车、山豆根、薏苡仁、蒲公英、半枝莲等共成解毒散结，抗癌消肿之功。

【加减】舌疼甚者加梅花点舌丹局部含化，溃烂出血者加苦参、白茅根、紫草根、五倍子、仙鹤草、生地以凉血止血。

（三）阴虚火旺型

【主证】舌体癌肿溃烂，其边缘隆起，易出血。疼痛剧烈难忍。伴有午后潮热，骨蒸盗汗。舌质红，无苔，脉细数。

【分析】火毒热邪久延不除，势必耗伤肾中阴精，肾脉系舌本，终于会厌，使肾中虚火循经上窜，更灼舌伤络腐肉，则癌瘤溃烂易于出血；阴虚舌体失于濡养，加之火毒伤络腐肉，则疼痛难忍。阴虚则阳亢，迫津外出，故盗汗。午后潮热，骨蒸，舌质红无苔，脉细数为阴虚火旺之征象。

【治则】滋阴降火，解毒散结。

【方药】知柏地黄汤加味。

知母 9g，黄柏 9g，熟地 24g，山萸肉 12g，山药 12g，泽泻 9g，茯苓 9g，丹皮 9g，竹叶 15g，山豆根 15g，龙葵 12g，青黛

15g, 半枝莲 15g, 野百合 15g。

【方解】上述方药中含知柏地黄汤原方，意在加强泻虚火滋肾阴之力；加竹叶、野百合、龙葵、山豆根、青黛、半枝莲以解毒散结，消肿止痛。全方扶正为主，兼以祛邪消癌。

【加减】阴虚之象明显者加入玄参、石斛、麦冬以增强滋阴增液之效；盗汗甚者加入浮小麦、麻黄根以敛汗；剧痛难忍可加丹皮、赤芍、细辛，同时含服梅花点舌丹或六神丸。

（四）气血亏虚

【主证】舌癌溃烂，触之易出血，甚则可见透舌穿腮，项及颌下肿块累累，形体消瘦，面色苍白，头晕目眩，气喘心悸，舌淡苔腻，脉虚细而数。

【分析】舌癌晚期，邪毒久延，瘀毒痼结，伤肌败络，损气耗血，气血衰败，则见肿溃烂，易出血；癌瘤破溃转移，播结于项及颌下，故见项下颌下肿块累累。形瘦，心悸气喘，面色苍白，头晕目眩，舌淡苔腻，脉虚细而数为气虚血亏无了上荣之征象。

【治则】补气养血，解毒散结。

【方药】八珍汤加味。

党参 9g, 白术 9g, 茯苓 12g, 甘草 3g, 熟地 15g, 当归 12g, 白芍 12g, 川芎 6g, 黄芪 12g, 仙鹤草 15g, 败酱草 12g, 蜀羊泉 12g, 青黛 12g, 山豆根 12g, 蚤休 9g, 竹叶心 15g, 夏枯草 15g。

【方解】方中参、术、苓、草、地、归、芍、芎为八珍汤方，为补气养血之方祖，加黄芪以加强补气之力。竹叶心、败酱草、仙鹤草、蚤休解毒散结，青黛、蜀羊泉、夏枯草消肿抗癌。

【加减】畏寒肢冷，小便不利或小便过多者加炮附子、桂心、鹿茸、菟丝子、沙蒺藜等以温肾助阳；喘促气急，动则欲脱者加人参、胡桃、百合。

二、单方、验方、成方

(一) 单方

1. 蚯蚓方：蚯蚓 1 条，以盐化水后涂之。
2. 黄柏方：黄柏末时时点之。
3. 甘草方：用甘草煎成浓汤，热漱，随时吐出液汁。
4. 一枝黄花方：一枝黄花 15g 加水 500ml，煮沸。日日漱口。
5. 苡仁方：生苡仁 60~120g，水煎服。

(二) 验方

1. 苓母汤：土茯苓 30g，土贝母 30g。水煎含服。
2. 莲木汤：莲子芯 20g，青木香 15g。水煎含服。
3. 二芦方：漏芦、藜芦各 150g。浸于 95% 的乙醇 500ml 中，72 小时后过滤。用棉花球或软布浸药液后涂洗患处。
4. 麝虫方：麝虫七枚（微炒），盐 45g。以水一大盏，同煎 5~7 沸。含漱后吐出，勿咽，日 3~5 次。
5. 龙蛇点舌汤：白花蛇舌草 30g，野菊花 9g，蒲公英 9g，生牡蛎 12g，龙葵 15g，象贝 9g，车前子 9g，生大黄 9g，梅花点舌丹 2 粒。水煎服，日 1 剂。梅花点舌丹每次 1 粒，每日 2 次，随汤药吞服。
6. 鳖虫薄荷方：地鳖虫和生薄荷研汁，涂患处。
7. 丹皮黄柏方：牡丹皮 15g，黄柏 15g，麦冬 15g，栀子 15g，羊蹄根 15g，蛇蛇草 30g，龙胆 15g，马尾黄连 15g，赤芍 15g。水煎服。

(三) 成方

1. 六神丸。每日 4 次，每次 15 粒，含化。
2. 梅花点舌丹。每次 1 粒，每日 2 次，含化。
3. 青吹口散或锡类散吹于患处。

三、中西医结合治疗

(一) 中医药与手术治疗相结合 早期舌癌在舌体前 2/3

者，以外科手术切除及放射线治疗效果较好。在切除后或放疗期间配以中医药益气养血或滋阴清热，可以减少并发症，减少复发。

中、晚期舌癌，手术及放疗效果都差，有的在中医药及放疗治疗后再手术广泛切除。此时则充分显示了中西医结合的优越性。特别对于已转移，身体极度衰弱，服用中药可以增强患者免疫力，减少痛苦，提高生存质量。

（二）中医药与放疗相结合 各期舌癌都可采用放射治疗，但是因其毒副反应常限制它的使用。如常见的消化系统功能障碍，机体虚衰，以及一些阴伤燥热症象。根据表现或选用健脾和胃如香砂六君子汤、四君子汤等加减；或选用清胃热降胃逆如橘皮竹茹汤加减；或选用温中散寒之丁香柿蒂散加减；或滋补肝肾；或清热解毒，活血化瘀等，使患者能够顺利完成放疗。

（三）中医药与化疗相结合 近年来舌癌的治疗，除了采用以外科手术治疗和放射治疗为主外，中医中药和化疗药物治疗亦越来越受到重视。化疗作为手术前的辅助治疗，以使肿瘤缩小后利于手术切除；此外化疗也适用于有远处转移的晚期患者。大多数抗癌药物均能直接损伤癌细胞，抑制肿瘤细胞的增殖，特别是干扰核酸的代谢。但它严重的毒副作用，常常给治疗带来困难。提高癌组织对化疗的敏感性，保护正常组织免受化疗损害从而减轻毒副反应，无疑是提高肿瘤治疗效果的重要途径。多年来，运用中医药防治化疗毒副反应和增高癌细胞对化疗敏感性的研究中，已取得不少进展。使用扶正培本、益气养阴、生津润燥、健脾和胃等方药的运用，不但能使舌癌患者顺利完成化疗疗程，且有明显的减毒增效作用。

四、综合治疗

1. 术前放疗+中药+手术根治+术后放疗或化疗。

术前放疗适用于体积较大的舌鳞癌或舌根部未分化癌。放疗及中药治疗目的是为了缩小肿瘤，以提高手术切除率，降低术后

复发率。术后放疗或化疗的目的在于：①消灭肉眼不可见的残余癌灶。②癌瘤切除后，微小转移灶的增殖细胞生长加快，须追加放疗或化疗或中药治疗，予以消灭。③较大癌瘤切除后，中心乏氧区消除，进而提高了化疗或放疗的敏感性。

2. 术前化疗+根治性手术+术后放疗或化疗+术前后中药治疗。

术前化疗作用在于降低肿瘤转移机会，杀灭微小转移灶；并使原发灶缩小，便于切除。中药治疗贯穿其中，以对化疗、放疗增效减毒。

第四章 涎腺肿瘤

【概述】

涎腺包括腮腺、颌下腺、舌下腺以及很多分布在口腔腭、颊、唇、舌等处的小粘液腺。

唾腺肿瘤较常见，国内资料患病率为 0.63 / 10 万人口，占全身恶性肿瘤的 0.7%~1.6%，占头颈部恶性肿瘤的 2.3%~10.4%，占口腔颌面部恶性肿瘤的 0.5%~3%。大唾腺肿瘤 80%~90% 发生在腮腺，颌下腺次之，舌下腺最少。其中以腮腺混合瘤最多，良性多于恶性。小唾腺肿瘤 60%~70% 发生在腭部，30% 在颊部。唇和舌部很少。大小唾腺肿瘤病理相同，均分为良性和恶性。良性以混合瘤（多形性混合瘤）最多。恶性有粘液表皮样肿瘤、腺样囊性癌、乳头状囊腺癌、腺泡细胞癌、恶性混合瘤、未分化癌、腺癌及鳞状细胞癌等。本病的预后，5 年存活率，恶性混合瘤为 40%，低度恶性的粘液表皮样肿瘤为 85%~100%，高度恶性的粘液表皮样癌为 20%~56%，腺泡细胞癌为 80%，鳞状细胞癌及未分化癌为 20%。国外资料，腺样囊性癌 5、10、15 及 20 年生存率分别为 63%、39%、26% 及 21%。

在中医学文献中对涎腺肿瘤虽无明确的分类记载，但有关相似的疾病仍可见到。其中对舌下腺囊肿的记载最详，可见舌腺囊肿确为一常见病。中医称舌下腺囊肿为“舌下痰包”，对其症状与治法叙述颇详。此外中医书籍中关于“失荣症”（亦称“失荣疽”）的记载颇似腮腺、颌下腺恶性肿瘤并伴的颈部转移；当然也可能包括其它转移性癌，特别是不能排除鼻咽癌的颈部转移；如单以部位及症状而论，颈部恶性淋巴瘤亦应属此症。另一颇似腮腺恶性肿瘤的疾病被称为“耳后发”发于左侧者又称“天疽”；发于右侧

者则称为“锐毒”。至于小涎腺肿瘤很可能大部分包含在口腔癌的记述中。

中医书籍中关于类似涎腺肿瘤的记载主要见于明、清文献，论述也最详。《外科正宗》谓：“痰包乃痰饮乘火流行，凝注舌下……流出黄痰，若蛋清粘稠难断……”，这后一句，清楚地点出了舌下腺囊肿的症状特征。

关于“失荣症”的发生，中医认为系由“忧思、悲怒、气郁、血凝与火凝结而成”。“耳后发”的形成也多由于“积想在心，谋虑不决，致火旺而又郁，郁而又旺，以成此痰也”。可见与其它恶性肿瘤的病因相似，涎腺恶性肿瘤的病因亦均以内伤七情为主。

古代中医对涎腺肿瘤的临床观察亦甚为详尽，描述简练传神。如《外科正宗》对于“耳后发”的叙述说：“发生于耳后一寸三分致命之处，诚为险毒恶候。……形多坚硬，头多隐伏，未溃先黑，令人多不知觉，及其知觉，毒已入内矣……”。这一番论述酷似现代医学中腮腺癌病例。《外科大成》对“失荣症”的描述谓：“失荣症生于肩项、耳前、耳后等处。初起如痰核，久渐大，坚硬如石，推之不动，按之不移。一年半载方生阴痛。气血渐衰，形容消瘦。破烂紫斑，渗流血水。或如泛莲，兼多秽气，愈久愈大，越溃越坚……乃百死一生之症……”。这是对晚期病例症状的形象化的归纳。

在诊断方面，中医主要凭临床经验总结。涎腺恶性肿瘤辨证多属中气虚衰；按经络脏腑则属肝气郁结，少阳胆经之症（特别是腮腺肿瘤），气血失调，失于荣养，故有“失荣症”之称。

【病因病机】

一、痰结湿聚 患者后天之本不足，或长期过食辛辣，以及烟酒等刺激物，使脾胃受损，升降失司，水湿痰浊积滞，久而积聚成块，发生肿瘤。

二、情志郁结 《丹溪心法》指出：“忧怒郁闷，听久积累，脾气消阻，肝气横逆，遂成隐核”。《医宗金鉴》谓失荣由“忧

思、悲怒、气郁、血逆与火凝结而成”。说明情绪与精神因素对肿瘤的发生发展有着一定的关系。

三、热毒痰浊淤阻 火郁日久生毒，热结内蕴，与痰聚结而成肿瘤。朱丹溪认为：“凡人身上有块者，多是痰”。又谓：“痰之为物，随气升降，无处不到”。高锦庭认为：“癌病者，非阴阳正气所结肿，乃五脏瘀血浊痰气滞而成”。可见热毒气滞血瘀痰浊既是病理产物，也是致病因子，与恶性肿瘤的形成关系密切。

四、正虚邪实 《景岳全书》论及肿瘤时指出：“少年少见此症，而惟中年衰耗伤者多有之”。《外科启玄》认为：“癌发四十岁以上，血气亏衰，厚味过多，所生者，十全一二”。李中梓认为：“积之成者，正气不足，而后邪气踞之”。《外证医编》指出：“正气虚则成癌”。可见中医早就发现年老之虚弱或失调，与恶性肿瘤的发生有着一定的关系。

【治疗】

一、辨证施治 唾腺有大小两类，又各有多种。其临床表现虽不尽一致，但总体辨证分型基本相同，这里主要以腮腺肿瘤为主，分如下四型论述。

（一）痰结湿聚型

【主证】初起微肿，皮色不变，不痒不痛不热，久不能消，少气懒言，纳呆，四肢倦怠，舌淡苔白腻，脉濡弱无力。

【分析】患者中气虚弱或饮食不节，使脾气虚，不能运化水谷，则水湿不化，津液不布，致生内湿，湿聚为痰，痰湿结聚于腮而生肿块；肿块皮色不变，不痛不痒不热，久久不消，在临床上常按痰施治。正如元代朱丹溪说：“凡人身上中下有块者多是痰”。少气懒言，纳呆，四肢倦怠，舌淡苔白腻，脉濡弱无力皆中气虚内生痰湿之象。

【治则】健脾利湿，化痰散结

【方药】参苓白术散加减。

党参 15g，白术 10g，白茯苓 15g，甘草 3g，山药 15g，白

扁豆 12g, 莲子肉 15g, 陈皮 12g, 薏苡仁 24g, 砂仁 9g, 桔梗 6g, 山慈菇 15g, 土贝母 12g, 干青果 9g, 半夏 9g, 猫爪草 15g。

【方解】方中参、苓、术、甘草、山药、莲子、扁豆、苡仁补脾渗湿；陈皮砂仁调气行滞，芳化湿浊；桔梗升清合苡仁、茯苓以降浊。山慈菇、土贝母、青果、半夏、猫爪草化痰散结，解毒消癌。

（二）肝火痰阻型

【主证】肿块渐大，漫肿，痒痛，烦躁易怒，口苦咽干，便秘，舌红苔黄腻，脉弦滑。

【分析】患者情志不畅，忧恚郁怒，使肝气郁滞，化火灼津为痰，痰火循经上结于颌腮而成肿块，日渐增大，火盛则痒，痰阻经络痹则痛。烦躁易怒，口苦咽干，便秘，舌红苔黄腻，脉弦滑即为肝火痰阻之征象。

【治则】清肝泻火，消肿散结。

【方药】龙胆泻肝汤加减。

龙胆草 9g, 生地 15g, 当归 9g, 柴胡 9g, 泽泻 9g, 车前子（布包）12g, 栀子 9g, 黄芩 12g, 甘草 3g, 蛤壳 15g, 皂角刺 9g, 牡蛎 30g, 炮山甲 9g。

【方解】龙胆草泻肝胆实火为主药；黄芩、栀子助主药泻肝胆之火；泽泻、车前子助主药清利湿热。生地、当归、滋阴养血，以防津伤；甘草解毒和中；柴胡条达肝气。蛤壳、皂刺、牡蛎、山甲软坚化痰散结消瘤。

【加减】便秘难下者加生大黄、杏仁；痛甚加白芷、全蝎、元胡。

（三）热毒蕴结型

【主证】头面漫肿焮红，面颊红肿坚硬，表面凸凹不平，或难以张口进食。身热，头痛，唇红，口苦，耳灼，便秘溲赤，舌质红绛，苔黄燥，脉滑数。

【分析】患者热（火）毒内蕴，血遇火热则凝，津液遇火热则为痰，气血痰浊壅阻于腮舌，遂结成肿瘤，焮红漫肿坚硬，表面不平；热毒内盛，循经上冲则身热、头痛、口苦、唇红耳灼；便秘溲赤乃热盛津伤之征；舌红绛，苔黄燥，脉滑数为热毒实火之明征。

【治则】清热解毒，消肿散结。

【方药】清瘟败毒饮加减。

生地 12g，黄连 9g，石膏 45g，栀子 9g，黄芩 12g，连翘 30g，知母 12g，丹皮 15g，赤芍 12g，玄参 30g，竹叶 12g，甘草 6g，桔梗 9g，野菊花 15g，半枝莲 15g，天花粉 12g，夏枯草 15g，白花蛇舌草 15g，蒲公英 15g。

【方解】方中知母、竹叶、甘草、石膏清热生津；地黄、丹皮、赤芍、丹参凉血救阴；芩、连、栀、翘清热解毒；桔梗引药上行；野菊花、半枝莲、天花粉、夏枯草、白花蛇舌草、公英清热解毒，消肿散结。

【加减】痛甚加大青叶、紫花地丁；肿甚加银花、青黛、生地。

（四）正虚邪实型

【主证】肿瘤后期，颈部淋巴结转移，肿块破烂，流水流血，表面紫暗，形容瘦削，倦怠少食，心悸，失眠，多梦，舌淡苔白或白腻，脉细涩。

【分析】癌肿晚期患者，邪毒久久留恋不除，使正气不足，耗精伤血，损伤元气，故形容枯瘦；正气虚，邪气尚存，癌肿失于气血滋养而破溃，正气无以遏邪则癌瘤走窜转移；脾主气统血，脾气虚则倦怠少食，失于统摄则流水流血；心主血，心血不足，心体失养则心悸、失眠多梦；舌淡苔白脉细涩为正虚邪滞之象。

【治则】益气养血，祛邪消肿。

【方药】归脾汤加减。

太子参 15g, 党参 15g, 茯神 12g, 黄芪 20g, 白术 10g, 龙眼肉 15g, 枣仁 15g, 远志 6g, 甘草 6g, 木香 3g, 当归 12g, 七叶一枝花 15g, 丹参 15g, 露蜂房 15g。

【方解】方中参、芪、术、草补脾益气，归、茯、龙、枣、远志养血安神，少佐木香醒脾和胃。丹参、蜂房、七叶一枝花化瘀消肿祛邪。

【加减】潮热盗汗加鳖甲、龟板、女贞子；出血淋漓不止者加参三七、茜草、藕节炭；食滞不化者加焦三仙、砂仁；腹胀者加厚朴、大腹皮。

二、单、验方，成方

(一) 单验方

1. 见穿牡蛎汤：夏枯草 30g, 王不留行 30g, 生鳖甲 30g, 石见穿 30g, 生牡蛎 30g, 天花粉 24g, 海藻 15g, 丹参 15g, 瓜蒌仁 15g, 苦参 15g, 昆布 12g, 桃仁 12g, 生地 12g, 蜂房 12g, 干蟾皮 9g。日 1 剂，水煎服。治疗中晚期腮腺癌。

2. 海藻牡蛎汤：海藻、牡蛎、黄药子各 30g, 昆布、猫爪草各 15g。日 1 剂，水煎服。治疗腮腺癌。

3. 腮腺癌方：莪术、板蓝根各 30g, 银花、山豆根各 15g。日 1 剂，水煎服。

4. 马兰草根方：马兰草根、野胡葱头各适量，捣烂外敷。

5. 生苡仁 120g, 水煎服。

6. 猫爪草 120g, 煎水取黄酒 60g 内服。

7. 大青叶 30g, 板蓝根 30g, 水煎服。

8. 牛蒡子 30g, 重楼 30g, 半枝莲 60g 水煎服。

9. 八角莲 30 然，山豆根 30g, 青黛 60g, 雄黄 6g, 共为细末，蜂蜜调和外敷。

(二) 成方

1. 巴蜡丸。每次 5~6 粒，每日 2~3 次，口服。

2. 小金丹。每次 1~2 粒，每日 2 次，用黄酒送下。

3.犀黄丸。每次 6g、每日 2 次，陈酒送下。

三、中西医结合治疗 涎腺肿瘤的治疗，目前仍以外科手术切除为主，同时辅以放疗、化疗及中医药治疗，在手术前后及放、化疗前后可根据“审证求因”、“辨证施治”的原则，合理选用中医药治疗。特别是近年来，中医药的参与治疗即中西医结合治疗涎腺肿瘤已引起医家的重视，通过临床观察，疗效的确优于单纯的西医药治疗。中医药对改善术前病人状况，促进术后恢复，提高机体免疫力已初步显露出独特的优势。对于涎腺肿瘤进行放射治疗者，可明显减轻放疗的毒副作用，提高放射治疗的增效作用。对于进行化疗的涎腺肿瘤患者，可提高化疗的远期疗效，促使癌细胞对化疗敏感性以及对化疗毒副作用的防治的研究，都已取得了一定的进展。常选用的中医方药有归脾汤、小柴胡汤、六味地黄汤、一贯煎等。

四、综合治疗 涎腺肿瘤中腮腺肿瘤应以手术切除治疗为主。良性肿瘤对放射治疗及化学药物治疗均不敏感，术后可以中药治疗为主。恶性肿瘤中约有半数对放射治疗敏感，可采用手术加术后放疗或术后化疗加中药治疗。而对于舌下腺及小粘液腺的恶性肿瘤，有的不便于手术或失于手术机会者可以放疗、中药治疗和 / 或化疗为主要手段的综合治疗。

第五章 喉 癌

【概述】

喉位于颈前部正中，约相当于第4~6颈椎水平，上连舌骨，下通向气管，与口咽相通。靠喉内肌肉和神经调节声带张力，控制声门开闭。两侧紧邻颈部气管、神经及甲状腺。喉以声门为界，分为声门上、声门、声门下三个区域。

喉部恶性肿瘤中，绝大部分是鳞状细胞癌，其死亡率约占所有恶性肿瘤的2%。本病男多于女，男：女大约是7：1~10：1；近年来女性发病率似有增高趋势。患者年龄在40岁以上，50~60岁是发病的高峰期；30岁以下者罕见。

喉癌的转移一般都比较晚，其转移方式一般以淋巴道为主，血道转移少见。淋巴结转移一般与肿瘤所在部位的淋巴回流相符，先转移到同侧的颈淋巴结，对侧或双侧转移者少见。喉癌患者颈淋巴结转移率与癌细胞的分化程度有关；分化良好者约10%有转移，中等分化者20%有转移，分化差者50%有转移。晚期病人舌骨下、喉前、下颌、耳下、耳后等处淋巴结都可出现转移。血行转移主要到肺、肝、纵隔等器官。有人认为喉的坏死组织脱落后吸入下呼吸道，有可能引起支气管与肺的转移。声门上区癌转移早，预后差；声门区癌约占喉癌的60%，最为多见，但少有转移，预后较佳；声门下区癌预后较声门癌差。

喉癌为何多见于男性？有人认为男性常在野外及工业部门工作，易受各种刺激而发生慢性咽炎。有人观察到远离癌旁的慢性炎的粘膜上皮常有异型增生，在这种异型增生的基础上可以恶变为癌。有些人认为喉癌的发生与吸烟有关，但是从1960~1980年20年中，肺癌的死亡率增加了420%，而喉癌的死亡率仅增加20%，由此可知，吸烟可能只是一个辅助因子。还有认为酗

酒、病毒感染、讲话劳累、接触石棉、某种食物的缺乏、局部放射治疗等均与喉癌的发生有关。

本病位置隐蔽，早期症状不明显，难于发现。因此要求凡中年以上患者，声嘶超过三周，或咽喉部有异物感、不适感，都必须进行严格喉部检查，即可早期发现癌肿，并经活体组织检查而确诊，配合X线检查了解癌肿侵犯情况，以指导治疗。本病须与声带小结、喉乳头瘤、喉结核、喉部腺瘤、喉息肉、喉软骨瘤、喉室脱出或喉气囊肿等进行鉴别。

在祖国医学中，由于受到喉部解剖生理及检查器械的限制，没有查到中医文献关于喉癌的专门记载。根据本病临床上以喉部生肿物如菌，溃腐难敛为主要表现的特点，属于中医学中“喉菌”、“喉百叶”、“喉疳”等病症范畴。《喉科指掌》谓喉菌“生于喉内，状如浮萍，略高而厚，色紫”。《咽喉脉症通论》说“上蒸于喉，结成如菌，面厚而紫，软如猪肺，或微痛，或木而不痛，梗塞喉间，饮食有碍”。描述了喉癌的一些临床特征。《囊秘喉书》称喉百叶是“咽喉中有生肉，层层相叠，渐肿，有孔出具气者”。《医宗金鉴》载喉疳“此症一名阴虚喉疳，初觉咽嗑干燥，如毛草蒂刺激喉中，又如硬物溢于咽下。呕吐啜出甜涎，淡红微肿微痛。日久其色紫暗不鲜，颇似冻榴子色，……肿痛日增，破烂腐衣，叠若虾皮，声音嘶哑，喘急多痰，臭腐蚀延，其痛倍增，妨碍饮食，胃气由此渐衰，而虚火益成，……其证投方应或者十全一、二，否则难救”。

【病因病机】

一、痰浊结聚 患者素体脾肺气虚，或被损伤，致使水谷失于正常的输布运化，聚湿生痰，搏结于喉，阻滞气机，络脉痹阻，日久结为癌肿。

二、气滞血瘀痰阻 患者情志不遂，郁怒忧思，久伤肝脾，使气机不利，运化失常，致气血瘀滞，痰湿胶结，气血痰瘀上遏喉窍，阻滞经络，蓄积日久而为癌瘤。

三、火毒瘀结 癌瘤日久，气血痰瘀久郁化火，火毒困结，腐肉损脉，势不可遏，则致癌瘤破溃走窜。

四、邪困正衰 癌瘤日久不祛，伤阴耗气，损精耗血，使脾肾大亏，元气竭殒，终致癌瘤破溃难敛，元气耗绝而卒。

【治疗】

一、辨证施治

(一) 痰浊结聚型

【主证】声音嘶哑，咽中梗阻不利，咳嗽痰多，时带血丝。喉内可见声带部或声门下有白色菜花状新生物。胃纳不佳，胸闷腹胀，舌苔白腻，脉滑或濡。

【分析】脾肺气虚，内生痰湿，痰浊之邪结聚于喉，则生癌瘤；声带受累，声门失司，故声音嘶哑；肺为贮痰之器，肺中痰阻，失于宣降，故咳嗽胸闷痰多；脾胃虚弱，中焦枢机不利，纳运失常，则纳差，腹胀；舌苔白腻，脉滑或濡细乃痰湿聚结之象。

【治则】健脾化痰，消肿散结。

【方药】六君子汤加味

党参 15g，白术 9g，茯苓 12g，甘草 3g，陈皮 6g，半夏 9g，杏仁 9g，山慈菇 15g，半枝莲 15g，白毛藤 15g，海蛤壳 30g，土茯苓 15g，胖大海 4.5g。

【方解】方中党参大补脾肺元气；白术健脾除湿；茯苓甘淡渗湿，使参术更能发挥其补益作用；甘草调中益脾；陈皮、半夏、杏仁理气化痰止嗽；胖大海解毒利咽；山慈菇、半枝莲、白毛藤、海蛤壳、土茯苓皆有化痰散结，解毒消肿，祛湿通络之功。

【加减】咳嗽胸闷痰多者加桔梗、薤白、枇杷叶；痰中带血者加地榆、藕节。

(二) 痰气瘀阻型

【主证】喉梗阻感，言语如口含物，咳嗽，痰中带血，饮食

时喉刺痛不适，舌质红暗有瘀点，舌苔白腻，脉弦滑。检查见会厌呈半球状或球状，表面有溃烂出血，组织嫩脆。头颈部可扪及肿大质硬固定的淋巴结。

【分析】患者忧思郁怒，气机不畅，肝脾损伤，运化失司，致使气滞血瘀痰浊内生，阻遏于喉，气道不通，则见喉梗阻感，言语如口中含物，喉中刺痛；喉为肺之门户，喉中邪毒下伤肺络，故咳嗽、痰中带血；舌质红暗有瘀点，舌苔白腻，脉弦滑乃气滞血瘀痰阻之明证。

【治则】理气活血化瘀，化痰软坚散结。

【方药】二夏白芥子散（经验方）

夏枯草 15g，生半夏 9g，半枝莲 15g，桃仁 15g，当归 9g，赤芍 9g，白芥子 9g，神曲 15g，藕节 15g，地榆 15g，白芨 9g，川楝子 15g，柴胡 9g。

【方解】方中夏枯草、生半夏、半枝莲、白芥子化痰软坚，散结消肿，佐以神曲以开胃和中，加强化痰软坚之功效；柴胡、川楝子、当归、赤芍、桃仁理气活血化瘀止痛。

【加减】消瘦纳呆，气虚明显者加黄芪、首乌、山药、白扁豆；喉痛明显者加胖大海、山豆根、元胡。

（三）火毒瘀结型

【主证】声音嘶哑，咽喉剧痛，局部肿胀触痛，吞咽疼痛困难，呼吸不畅，口干苦，烦躁易怒，大便干，小便黄，颌下及颈部淋巴结肿大，有蚕豆至核桃大小。舌质红有瘀斑点，舌苔黄燥，脉滑疾。

【分析】癌瘤滞留不去，久而化火，火毒困结于喉，腐肉灼络，声门不利，则声音嘶哑，喉剧痛，吞咽困难，呼吸不畅；癌瘤破溃走窜，则见颌下及颈部淋巴结肿大；大便干、小便黄为火毒内结伤津；口干苦，烦躁易怒为肝火毒扰及心神；舌质红有紫斑，苔黄燥，脉滑疾皆为火毒内炽，瘀血阻遏之象。

【治则】泻火解毒，化瘀软坚，消肿散结。

【方药】当归芦荟丸加味。

龙胆草 30g, 青黛 (水飞) 15g, 芦荟 15g, 栀子 9g, 黄连 9g, 黄芩 9g, 黄柏 12g, 大黄 (酒浸) 9g, 当归 15g, 龙葵 9g, 天花粉 15g, 海浮石 15g, 山豆根 15g, 牛蒡子 9g, 板兰根 30g, 七叶一枝花 15g, 干青果 6g。

【方解】方中龙胆草、芦荟、青黛、栀子、黄芩、黄连、黄柏等大苦大寒之品, 直折火毒之邪, 挫其猖獗之势, 大黄泻下通腑, 以开火毒下行之通路; 当归活血化瘀; 山豆根、龙葵、牛蒡子、板兰根泻火解毒利咽喉; 干青果化痰解毒; 天花粉软坚消肿散结, 兼养阴生津; 七叶一枝花清热解毒, 散瘀止痛消癌瘤。

【加减】出血多者加血余炭、侧柏叶、仙鹤草以清热止血; 痰涎臭秽物多者加马勃、山慈菇以化痰祛腐除秽, 声嘶甚者, 配以清音丸以利喉开音。

(四) 邪困正衰型

【主证】声嘶甚或失音, 咳吐鲜血, 痰涎污秽, 呼吸困难, 面色苍白, 心悸怔忡, 四肢倦怠, 头晕目眩, 少气懒言, 舌质淡, 苔白, 脉细弱无力。

【分析】癌瘤阻喉, 气道受阻, 声带受累, 故声嘶或失音, 呼吸困难; 癌瘤邪毒损伤脉络, 加之癌瘤破溃腐烂, 故咳吐鲜血, 痰涎污秽; 癌瘤邪毒留恋日久, 势必耗气伤血。少气懒言, 四肢倦怠, 舌淡苔白为气虚之象; 心悸怔忡, 头晕目眩, 面色苍白, 脉细弱无力为血虚之象。

【治则】益气养血, 消瘤散结。

【方药】八珍汤加味

党参 9g, 白术 9g, 茯苓 12g, 甘草 3g, 熟地 15g, 当归 12g, 白芍 12g, 川芎 6g, 山豆根 15g, 马勃 9g, 山慈菇 12g, 石上柏 30g。

【方解】方中四君子汤补气健脾, 四物汤补血调肝, 两方合用气血双补。加山豆根、马勃、山慈菇、石上柏以利咽解毒, 祛

腐除秽。

【加減】咳吐鲜血量多者加入血余炭、灶心土、参三七补虚止血；失音者宜配合诃子饮，以利喉开音。

【按语】

我们根据临床证型，并参考文献资料，将喉癌分为上述四个主型，旨在从整体上将喉癌进行辨证分型，以期起到提纲挈领的作用。但在实际临床中，证情往往较为复杂，当灵活辨治。

对于喉癌的治疗，在遵循辨证施治之前提下，还应根据病情发展的不同阶段，分别施以软坚、解毒、补虚这三种方法。

1.软坚：肿物已明显增大，生长迅速，坚硬未溃，无颅内和内脏重要器官转移，但已有颈淋巴结转移，正气尚存者，此时应慎用大量的活血化瘀药物，以防肿瘤的进一步扩散。可在辨证施治的前提下，选用软坚散结之药物，如昆布、海藻、海带、夏枯草、山慈菇、七叶一枝花、威灵仙、猫爪草、礞砂、射干、礞砂、牡蛎、蛤粉、白矾、核桃仁、蜈蚣、鸡内金、露蜂房等。

2.解毒：肿物已开始破溃，邪气实而正气尚未衰败，正邪相争，有发热、口干，纳差，便秘，脉数、舌红等热象；或经放疗、化疗后有全身或胃肠道反应；或已有颅内及内脏重要器官之中期转移，但尚未出现恶病质者，可采用清热解毒法。可于辨证施治前提下，选用天花粉、无花果、白花蛇舌草、山豆根、猕猴桃根、半枝莲、蒲公英、土大黄、鱼腥草、三七、大小蓟、黄药子、白药子、了哥王、孩儿茶等药物。

3.补虚：晚期喉癌，原发肿瘤溃烂出血，有颅内或内脏器官转移，范围广泛，正气已虚，甚至气血衰败，阴精涸竭（相当于恶病质）。此时需采取扶正抑癌之补法，禁用活血化瘀之品，以防癌瘤进一步扩散转移，动血耗血。可在辨证施治前提下，选用人参、太子参、西洋参、党参、黄芪、白芍、生薏苡仁、五加皮、女贞子、山萸肉、香蘑菇、茯苓、天花粉、三七、沙参等。

二、单方、验方、成方（药）

(一) 单方

- 1.冬凌草 120g 或冬凌草片每日三次，每次 10~15 片。
- 2.雪里青（咽喉草）120g，水煎分服。
- 3.白猫眼草 30g，水煎服。
- 4.牛蒡子 30g，水煎服。
- 5.夏枯草 60~90g，水煎服。

(二) 验方

1.鹅不食草 30g，野菊花 15~30g，胖大海 10g，白僵蚕 10g，陈皮 15g。

2.生苡仁 60g，刀豆子 60g，白茯苓 30g，淡竹叶 30g。

3.巴豆 2 粒（去油）、大枣肉 3 枚、葱白 2 根。共捣如泥，大梨 1 个（去皮）。把梨切开去核将上药泥放入空心，梨合好置碗内蒸熟，去药嚼梨渴汤。

4.黄连 6g，黄芩 6g，天花粉 10g，银花 15g，连翘 10g，赤芍 6g，玄参 10g，羚羊角粉 0.3g（另吞服）。日 1 剂，水煎服。

5.蜈蚣 5 条（去头足），全蝎 30g，白僵蚕 30g，虻虫 30g，鸡蛋 40 个。

上药分别用瓦焙干研细末，混匀分为 40 包。每包放入 1 个鸡蛋摇匀，面糊封口，置碗内蒸熟吃。早晚各 1 枚。

6.牛蒡子 1.8g，马兰子 1.8g。为散。每空腹温水冲服。另以牛蒡子 90g，盐 60g，研匀炒热，包熨喉外。

7.老月石 30g，乌梅肉 15g，桔梗 15g，海浮石 15g，胆星 23g，白花蛇粉 10g，炼蜜为丸，每丸重 3g，口含化，每日 3~4 次。

(三) 成药

1.六神丸。每服 10 粒，每日 2~3 次。

2.梅花点舌丹。每日服 2~3 粒，每日 2 次。先饮水一口，将药放在舌上，以口麻为度，再用温黄酒或温开水送下。外敷用醋化开，敷患处。

3.紫雪散、消瘤碧玉散、八宝珍珠散等吹撒患处。

三、中西医结合治疗

(一) 中医药与手术治疗相结合

喉癌外科治疗中，在考虑保存生命的同时，尽可能减少痛苦，保存喉功能，减少术后并发症。近年来，采用术前及术后中医药结合治疗，能较理想地达到以上要求。首先在术前，根据患者得知患癌后，情绪极其紧张或低落，对此类患者除了情志转移外，保证睡眠，调理精神也极其重要。常用养心安神法维护大脑的平衡功能，用“速眠茶”（丹参 30g，酸枣仁 15g）。睡前代茶饮。一般服用 30 分钟后即可达到镇静入睡的目的。另服以“通关药酒”（元胡、蟾皮、黄酒等组成），可以缩小癌灶，缓解局部疼痛。以上措施都为手术提供了良好的条件，提高手术的成功率。术后患者身体虚弱，用益气养血，健脾和胃等方法能明显提高患者的免疫功能，加速患者体力恢复。

(二) 中医药与放疗相结合

放射治疗也是治疗喉癌的主要措施之一，它适用于术前，以减少全喉切除术，保留较多的生理功能；手术切除后残留复发等。但放疗常引起炎症反应、消化功能障碍、机体免疫力下降、舌脉异常等副反应。中医认为出现上述证候的原因，乃放疗后造成机体内热毒过盛，以致津液受损，气血损伤，脾胃失调和肝肾亏损所致。因此运用凉补气血、健脾和胃和滋补肝肾以扶正培本；清热解毒、生津润燥、活血化瘀以解毒生津止痛。可选用的凉补气血药有：生黄芪、沙参、西洋参、大生地、丹参、三七、鸡血藤等；健脾和胃药中用香砂六君子汤、逍遥散、橘皮竹茹汤等加减；滋补肝肾方用两地汤、大补阴丸等；常用清热解毒药有银花、连翘、山豆根、蒲公英、板兰根等。

四、综合治疗

目前喉癌的治疗方法，主要有外科治疗、放射治疗、化学治疗、中医药治疗等，都可用于组成综合治疗方案，两种以上的结

合无疑比单一疗法效果为好。具体组合方法，应根据不同病理类型及不同分期，结合患者身体情况，具体制定合理可行的方法。但中医药可以贯彻运用于整个治疗过程中，根据辨证，可以和放疗、（或）化疗相结合，起到明显的增敏增效及减毒作用，提高临床疗效及远期存活率。临床中常用的综合方法有：放疗+中药治疗+手术+术后放疗（或）化疗；手术+放疗+化疗+中药治疗；放疗+手术+术后放、化疗+中医药等方法。

总之，喉癌的中西医结合综合治疗要有计划有目的的进行，不仅要根据临床分期，病理类型，是否转移，还要根据患者的具体条件而制定不同的治疗方案。而在一些不具备手术、放疗的偏远地区，化疗及中医药也就成了主要的治疗方法，鉴于化疗的疗效差，毒副反应大，充分发挥中草药就地取材的特点就更为重要。但有条件的地区，就要充分发挥各种治疗手段和方法的长处，协同治疗，争取较好的疗效。

第六章 甲状腺癌

【概述】

甲状腺癌的发病率约为 $2/10$ 万~ $3/10$ 万人口，占全部肿瘤的 $1.2\% \sim 3.2\%$ 。男女比例约为 $1:2$ 。7~20 岁和 40~45 岁时，发病率较高。甲状腺癌的病理类型有乳头状癌、滤泡癌、髓样癌、未分化癌、鳞状细胞癌、梭形细胞癌、腺样囊性癌、粘液腺癌及嗜酸性腺细胞癌等。 $1/4$ 的病人曾患结节性甲状腺肿。甲状腺癌的发生似乎不是在萎缩的结节内部，更像是发生于周围的甲状腺组织。甲状腺癌潜伏期可长达 30 年。如第二次世界大战时美国在日本广岛投放原子弹后，当地居民由于受辐射影响，甲状腺癌发病率增加。

甲状腺癌有时呈单个结节状肿瘤，和良性病变十分相似；有时为浸润性生长的硬块，切面呈白色；有时则可见到乳头状结构、囊性变和钙化。乳头状甲状腺癌多为中心性的，50% 患者肿瘤在对侧腺叶内，显微镜下显示微小病灶，可向局部淋巴结转移，但血行转移时间较缓慢，可在若干年后才出现。滤泡性甲状腺癌为单灶性的也较少见淋巴结转移，但具有淋巴结转移倾向。

甲状腺癌生长及浸润其它组织较为缓慢，转移其它部位也是缓慢的，这类癌大部分预后较好。转移到淋巴结或肺以后，其病变范围仍能保持多年，所以比较稳定。乳头状和滤泡性腺癌，老年患者比青年患者病情更加恶劣，但在组织形态上并无明显不同。

恶性最高的甲状腺癌占癌症患者的 10%，它包括小细胞型、梭形细胞癌和分化最差的巨细胞癌等型，其生长速度快，局部浸润和远处转移也早，治疗效果差，很少治愈。对甲状腺孤立性结节，临床经常争论的绝大多数是非癌性病变问题。但有时对

甲状腺诊断、区分有很大困难，因癌细胞和正常细胞很相似，只有在看到包膜和血管受侵后才能作出恶性诊断。

常见甲状腺癌在病变早期就诊并得到治愈，但也见到一些晚期患者在就诊时，已发现喉、气管、食道、颈动脉鞘、喉返神经以及深部组织、皮肤等已受侵，颈下、颈中、颈深和上纵膈淋巴结有单个或双侧转移，甚或见到有肺、骨、脑、肝等处转移，癌细胞侵入到甲状腺静脉、颈内静脉内。有些患者因颈部淋巴结转移灶生长相当大而原发灶还是很小，所以在临床上很难查出来。滤泡性癌仍有甲状腺功能，在罕见的情况下还出现甲亢等情况。

中医古籍有关“瘰瘤”的记载很早，很多，早在公元1174年，宋代陈无择著《三因方》对瘰瘤就予以分类：“坚硬不可移者名石瘰；皮色不变者即名肉瘰；筋脉露著者名筋瘰，赤脉交络者，名曰血瘰；随忧愁消长者，名气瘰”。其中的石瘰与甲状腺癌相似。《诸病源候论》说：“瘰者由忧恚气结所生”。《养生方》说：“诸山黑水中流出泉流者，不可久居，常饮食令人作瘰病，动气增患”。说明古人已认识到瘰的发生与地区的水质有关。宋·《圣济总录·瘰瘤门》说：“瘤之为义，留滞而不去也。气血流行不失其常，则形体和平，无或余赘。及郁结壅塞，则乘虚投隙，瘤所以生。初为小核，寢以长大，若杯盂然，不痒不痛，亦不结强，方剂所治，与治瘰法同，但瘰有可针割，而瘤慎不可破尔”。论述了其表现及治则。《证治准绳·外科准绳·瘰瘤》曰：如推之不动者不可取也。瘤无大小，不量可否而妄取之，必妨人命，俗云瘤者留也，不可轻去”。《杂病源流犀烛·颈项病源流·瘰瘤》说：“瘰瘤者，气血凝滞，年数深远，渐长渐大之症”。《外科正宗·瘰瘤论》说：“夫人生瘰瘤之症，非阴阳正气结肿，乃五脏淤血，浊气痰滞而成”。“初起自无表里之症相兼，但结成者，宜行散气血。已成无痛无痒，或软或硬色白者痰聚也，化痰顺气。已成色红坚硬，渐大微痒微痛者，补肾气，活血软坚”。《济生方·瘰瘤证治》：“夫瘰瘤者，多因喜怒不节，忧思过度，而成

斯疾焉。大抵人之气血，循环一身，常欲无滞留之患，调摄失宜，气凝血滞，为瘰为瘤”。

【病因病机】

一、病因 引起甲状腺癌的主要病因是情志内伤及饮食失调，体质因素也有比较重要的作用。其病与肝关系密切。气血津液运行失常，气滞痰凝，日久引起血脉瘀阻，以致气、痰、湿、毒、淤合为患，壅结颈前而成。

（一）情志内伤：由于长期忿郁恼怒或忧愁思虑，使气机郁滞，肝气失于条达。津液的正常循行及输布，均有赖于气的统率，气机郁滞，则津液易于凝聚成痰。气滞痰凝，壅结颈前而为病。

（二）饮食失调：饮食失调，一则影响脾胃功能，使脾失健运，不能运化水谷，聚而为湿为痰；二则影响气血的正常运行，痰气淤结颈而成。

（三）体质因素：妇女的经、孕、产、乳等生理特点与肝经气血有密切关系，遇有情志、饮食等致病因素，常引起气郁痰结，气滞血瘀以及肝经化火等病理变化，故女性易患甲状腺癌。此外，素体阴虚之人，痰气淤滞之后易于化火，更加伤阴，也易发病。

二、病机 甲状腺癌主要由情志内伤，饮食失调等原因损伤肝脾。体内阴阳乖戾，痰结血瘀化毒是甲状腺癌的病理基础。《诸病源候论》曰：“瘰者由忧恚气结所生”。《外科正宗》曰：“夫人生瘰瘤之下，非阴阳正气结肿，乃五脏瘀血，浊气、痰滞而成”。两书都强调了气、痰、瘀壅结是构成瘰瘤的物质基础；忧恚气结是瘰瘤始发的诱因。在分析甲状腺癌的发病机理时，两方面因素不可偏废。事实上，仅仅有气机郁结而不深入发展到痰湿凝聚，痰气交阻化毒，血循不畅，血脉淤滞的严重阶段，本病是不可能出现“瘰肿如石”，“坚硬不可移”以及阻扼气道，气阴双亏这样复杂局面的。阻于气道则声音嘶哑气粗。若郁久化火，灼伤

阴津则见烦躁、心悸、多汗。若病程日久，耗精伤血，气血双亏则见全身消瘦乏力，口干纳差，精神不振等症。

【治疗】

一、辨证施治

(一) 肝郁痰阻型

【主证】颈部单发瘰癧，质硬，随吞咽上下，活动受限，胸闷、太息，胸胁窜痛，病情随情志波动而加重，舌淡红苔白，脉弦。

【分析】患者情志不畅，气郁痰阻，痰气壅结颈部，则见颈前肿块；肝气郁滞，肝经不舒，则胸闷、太息、胸胁窜痛；郁则气滞，故情志不畅，病情加重；脉弦为肝气郁滞之象。

【治则】理气消瘿，化痰散结。

【方药】四海舒郁丸加减。

昆布 15g，黄药子 9g，海藻 15g，猫爪草 30g，陈皮 9g，木香 9g，海蛤壳 30g，海螵蛸 30g，夏枯草 15g，柴胡 9g，郁金 9g，海带 15g，半枝莲 15g。

【方解】柴胡、郁金、木香、陈皮舒肝理气；海带、海藻、昆布、黄药子、夏枯草、猫爪草软坚散结化痰，解毒消瘿；半枝莲、海螵蛸、海蛤壳化痰软坚消肿。

【加减】胸闷、胁痛加香附、枳壳疏肝理气；胸闷发憋加菖蒲、厚朴、瓜蒌开郁散结；咽喉不适及声音嘶哑酌加桔梗、牛蒡子、射干、木蝴蝶利咽消肿。

(二) 痰结血瘀型

【主证】颈前肿块增大迅速，质硬，结节状高低不平，胸闷、纳差，舌质紫暗或有瘀点、瘀斑，苔白腻，脉弦或涩。

【分析】气郁日久，木乘脾土，致生瘀血，痰浊，痰瘀毒结，搏结颈前，血脉痹阻，故见颈前肿块、质硬；脾失健运故胸闷纳差；舌质紫暗或有瘀斑及瘀点，则血瘀毒滞之征；苔白腻，脉弦或涩为内有痰湿及气滞血瘀之象。

【治则】理气化痰，解毒消肿。

【方药】海藻玉壶汤加减。

海藻 15g，昆布 15g，黄药子 9g，山慈菇 15g，蛇莓 9g，天葵子 30g，半枝莲 60g，炮山甲 9g，青陈皮各 9g，半夏 9g，贝母 9g，连翘 30g，当归 9g，川芎 9g，莪术 6g。

【方解】本方为治疗痰结血瘀癭瘤的一个良好基础方，功能理气活血，化痰消肿；海藻、昆布化痰软坚，半枝莲、炮山甲、天葵子、蛇莓、山慈菇、黄药子解毒化痰，消肿散结；青皮、陈皮疏肝理气；半夏、贝母、连翘以助化痰散结之力；莪术、当归、川芎活血通络。

【加减】胸闷不舒加郁金、香附、枳壳理气开郁；烦热，舌红，苔黄，脉数加夏枯草、玄参、丹皮清热泻火，并可增强原方消癭散结的作用。便溏、纳差加苡仁、茯苓、怀山药以健脾益气。

【变证】若患者肝火亢盛，烦热，急躁易怒，面部烘热，口干苦，多汗，舌红，苔黄，脉弦数，可予栀子清肝汤合藻药散治之，以清肝泄火，消肿散结。

（三）心肝阴虚型

【主证】颈前轻度或中度肿大，或放疗、化疗之后，心悸不安，心烦少寐，眼干目眩，手指颤动，消瘦乏力，月经量少或闭经，或阳萎，舌质红，脉弦细数。

【分析】痰气壅结颈前，则见颈前肿块；热久伤阴，或放疗、化疗后损伤阴液，致使心悸不宁，心烦少寐；肝阴不足，则眼干目眩；阴虚风动则手指颤动；精血亏虚，不能充养形体，则消瘦乏力，月经量少或闭经，或阳萎。舌质红，脉弦细数为阴虚有热之象。

【治则】滋养阴精，宁心柔肝。

【方药】天王补心丹加减。

生地 12g，玄参 15g，麦冬 15g，天冬 15g，红参 6g，茯苓

12g, 当归 9g, 丹参 15g, 远志 12g, 五味子 12g, 柏子仁 12g, 酸枣仁 12g, 野菊花 15g, 夏枯草 15g, 生牡蛎 30g。

【方解】生地、玄参、麦冬、天冬滋阴清热；红参、茯苓、当归益气生血；丹参、酸枣仁、柏子仁、远志、五味子养心安神；生牡蛎、夏枯草、野菊花平肝潜阳。

【加减】阴虚风动者加白蒺藜、白芍平肝熄风；便溏、呕恶加砂仁、山药、白术健脾；耳鸣、腰膝酸软加龟板、桑寄生、菟丝子、牛膝滋补肾阴；女子闭经或男子阳萎加山茱萸、熟地、枸杞子、制首乌补益正气，滋养精血。

（四）气血双亏型

【主证】甲状腺癌后期，或放疗后复发者，全身乏力，形体消瘦，精神不振，声音嘶哑，口干欲饮，纳差，舌质淡，苔白，脉沉细弱。

【分析】患者久病气血双亏，形体失养，故形瘦，精神不振；血虚津伤，无津上荣，则声音嘶哑，口干欲饮；脾气虚则纳差；舌淡苔白，脉沉细弱为血气亏虚之象。

【治则】补气生血，兼以解毒。

【方药】当归补血汤加味。

黄芪 30g, 当归 6g, 太子参 30g, 沙参 30g, 赤白芍各 15g, 石斛 30g, 白术 10g, 夏枯草 30g, 草河车 15g, 白芷 6g。

【方解】黄芪、当归、太子参、赤白芍、白术补益气血；沙参、石斛养阴生津；白芷、夏枯草、草河车解毒散结。

【加减】畏寒肢冷，溲清长加肉桂、鹿角霜；气短气喘加胡桃仁、附子。

二、单、验方、成药

（一）单、验方

1. 海藻 30g, 昆布 30g, 牡蛎 30g, 黄药子 30g, 猫爪草 30g, 蛇莓 30g。水煎服，日 1 剂。

2. 黄药子 30g, 海藻 30g, 山慈菇 9g, 夏枯草 30g, 蒲公英

30g，薄荷 6g。

3.白花蛇舌草 30g，白英 30g，夏枯草、野牡丹 60g，浙贝母 30g。

4.土茯苓 30g，土贝母 30g，猫爪草 30g。

5.瘰疬神方：海带、海藻、昆布、海螵蛸、海浮石各 30g，紫背天葵 60g，夏枯草 60g，带子连翘 60g，贝母 30g，桔梗、天花粉各 30g，皂刺 15g。共为细面，炼蜜为丸，梧桐子大，每次百丸，饭后白汤送下。

6.琥珀黑龙丹：琥珀 30g，血竭 60g，京墨、五灵脂、海带、海藻、南墨各 15g，木香 10g，麝香 3g。研细末，炼蜜为丸，每丸重 3g，每服 1 丸，以热酒送下。

7.白花蛇舌草 100g，蜈蚣 10g，樟脑 15g，浙贝母 80g，山豆根 100g，黄药子 30g，黄芪 100g，水煎沸，以鼻吸药气；另以蟾酥皮外敷。

8.蒲公英 30g，玄参 15g，海藻 30g，甘草 3g，昆布 15g，山豆根 15g，炮山甲 6g，浙贝母 9g，连翘 15g，僵蚕 9g，蜈蚣 2 条。日 1 剂，水煎服。

9.外敷膏：生马钱子 30g，蜈蚣 50g，冰片 10g，乳香 60g，黄药子 80g，生大黄 100g，白芷 50g，姜黄 60g。上药共研极细末，每用药粉适量（视癌肿大小而定）加蜂蜜，米醋调成糊状，布包外敷患处。数小时后取下 1 次，以防皮肤受药物刺激而引起溃烂。

10.黄药子酒：以黄药子 120g，用米酒 7000ml，煮一小时半，置七天后，早晚饮用，服完为度。（注：黄药子的有效成分为醇提取物，但需注意此药对肝脏有损害，肝功异常者慎用）。

11.消瘰汤：昆布 12g，海藻 12g，夏枯草 15g，牡蛎 30g，生地 30g，三棱 10g，莪术 10g，炒山甲 10g，甘草 3g（加减：热则加牛子、连翘、地丁、板兰根；痰多加法夏、陈皮、茯苓；热痰加浙贝、冬瓜仁、瓜蒌、口干咽痛加元参、花粉；气虚加黄

芪、党参、茯苓；血虚加首乌、归身、黄精、大枣)。日1剂，水煎服。

12. 椒菊糊剂：华南胡椒（全株）2份，野菊花1份，生盐少量。一起捣烂，隔水蒸热，待温度降至适中时，外敷于患处。1剂可用多次。

内服消癭汤配合以外敷“椒菊糊剂”，临床应用于200余例病人，均收满意疗效。

13. 二仁汤：夏枯草、昆布、海藻、桔核、生牡蛎各15g，赤芍、甲珠、泽兰各9g，桃仁、留行子各12g，苡仁30g。日1剂，水煎服。

14. 二虫合剂：银花6g，生鳖甲60g，生牡蛎30g，天花粉30g，白花蛇舌草30g，蒲公英30g，连翘15g，三棱9g，莪术9g，海藻9g，昆布9g，生大黄3g，天龙粉（冲）3g，全蝎4.5g，蜈蚣5条。水煎煮，共煎4次，每次取药汁500ml。口服，以上药量共2日分6次服完。

14. 龙菇汤：龙葵草60g，夏枯草30g，海藻15g，昆布15g，山慈菇15g，射干15g，法半夏9g，桔梗6g，升麻4.5g。日1剂，水煎服。

15. 补藤汤：女贞子30g，旱莲草30g，补骨脂30g，骨碎补30g，透骨草30g，鸡血藤30g，络石藤30g，海藻30g，肉苁蓉30g，山药15g，牛膝15g，木瓜15g。日1剂，水煎服。

16. 柴夏莪甲汤：北柴胡9g，莪术9g，三棱9g，广木香9g，桃仁9g，红花9g，牡丹皮9g，栀子12g，川郁金12g，赤芍15g，夏枯草30g，鳖甲30g，煅牡蛎30g。日1剂，水煎服。

17. 复方玄参汤：玄参30g，白芍12g，制香附12g，夏枯草30g，海浮石30g，白芥子12g（加减：喉痛喉塞加藏青果4.5g，射干6g；显效不著者加蛇舌草30g，猫爪草30g）。日1剂，水煎服，连服3个月为1疗程。

(二) 成药

- 1.活血消炎片。每次3片，每日2次。
- 2.清瘤丸、化瘀丸。每次各1丸，每日2次。
- 3.夏枯草膏。每次15g，日2次，热开水冲服。
- 4.犀黄丸。每次6g，日3次，陈酒送下。
- 5.消瘿气瘰丸。每次9g，日2次，口服。

三、中西医结合治疗

(一) 中医药与外科手术治疗相结合

目前国内外甲状腺癌外科手术治疗，传统的术前准备和术后处理，在某些方面存在着一些缺点和不足，但因无更好的替代措施，长期一直沿用至今。近年来在手术前后广泛地应用中药，较好地解决了尚存在的某些缺点和不足，同时提高了中医药对外科治疗的参与率。术前根据患者情况，如患者因长期的癌性消耗，身体虚衰者，可用黄芪、人参、党参、熟地、枸杞等扶正之品，来提高机体应激能力，能明显提高巨噬细胞的吞噬功能，增进患者的免疫功能，为保证手术的顺利进行作好准备。术后如见气血亏虚者，予当归补血汤补气生血；如见气阴两虚症候者，予生脉散益气养阴，生津敛汗；如见肾阳不足，腰膝酸冷，小便不利，益肾气加温肾补阳等，可以明显改善术后状况，减少并发症，缩短康复时间，减少复发。

(二) 中医药与放射治疗相结合

针对甲状腺癌患者所出现的常见毒副反应，如毒热伤阴，脾胃失调等表现，临床上常用银花、连翘、山豆根、蒲公英、黄柏等清热解毒；大生地、元参、麦冬、石斛、花粉、芦根等养阴润燥；四君子汤等调理脾胃，取得了明显疗效，保证放疗的顺利完成。如中日友好医院近年来采用扶正解毒冲剂（黄芪、生地、银花、黄连、石斛、麦冬、炒陈皮、内金、竹茹、枸杞子等），对减轻甲状腺癌131例在放疗中副反应的临床观察中，中西医结合组71例，其中60例顺利完成了放疗，放疗完成率为84.5%，

而对照组（即单纯放疗组）中的 60 例病人，38 例顺利完成了放疗，放疗完成率为 63.3%。为了探讨扶正解毒冲剂对放射线减毒效应的机制，中日友好医院对该方进行了实验研究，结果表明，本冲剂保护血象及免疫功能与其提高骨髓和脾脏造血与免疫功能有关。扶正解毒冲剂，不但在临床上减轻癌症病人在放疗中的副反应，同时对辐射损伤也有一定的保护作用。

中国中医研究院广安门医院采用扶正增效方（生黄芪、枸杞子、女贞子、太子参、炒白术、天冬、红花、苏木）对甲状腺癌放射增效作用的临床研究表明，本方配合放疗能加速肿瘤消退，提高放疗近期疗效。

（三）中医药与化学药物治疗相结合

中医药配合化疗能够延长肿瘤患者的生存期，提高远期生存率，达到单纯化疗所不能达到的治疗效果，显示中医药在化疗中应用的重要性。甲状腺癌化疗后如果出现白细胞及免疫指标的下降，容易发生细菌及病毒的感染，这时如提前给以抗菌素预防感染是否有效尚有争议，但能早期给予养阴、补血、益气类中药扶助正气，提高免疫功能及白细胞计数，便会对预防感染发挥作用。

临床研究发现，某些中药对化疗具有增敏作用，使化疗见效快，效力增加。如用扶正类中药配合以化疗治疗甲状腺癌其疗效出现快，且症状控制明显。如茯苓提取物与环磷酰胺的合用对动物肿瘤的抑制率较单用环磷酰胺的抑瘤率明显提高。

消化道反应及骨髓抑制也是甲状腺癌化疗中常见的主要毒副作用。用健脾益气、滋补肝肾法，可以防治化疗的毒副作用。如生白宝、参芪注射液等应用于临床均被证实具有良好的作用，不但能使患者顺利完成化疗疗程，且有明显的减毒增效作用。

四、综合治疗

甲状腺癌的综合治疗，要仔细地分析整体与局部的关系。因甲状腺癌肿块明显，就整体与局部而言，则以侧重局部的手术及

放、化为主，而全身经化疗及免疫疗法或中药治疗等整体治疗为辅助措施。但在一定情况下这些辅助措施，又显得非常必要了。如术前患者身体状况极差，不堪经受手术治疗者，就要先从中医药扶正之品来扶助正气，恢复体力，提高免疫能力，保证手术的顺利进行，减少术后并发症。术后根据临床分期、病理类型、分化程度、是否转移来决定具体方案。如甲状腺癌病理细胞分化较好者，周围淋巴结未见转移，间质反应和组织细胞反应较明显，而全身情况和细胞免疫功能尚好者，术后一般可不作放疗、化疗，单用中药调理即可。临床可选用四物汤或八珍汤。如果上述情况仅细胞免疫功能低下者，可予免疫治疗及中医药扶正治疗相结合，即手术后加免疫治疗加中药治疗的综合治疗。

如果病变已非早期的甲状腺癌患者，周围淋巴结已有转移或周围组织已有浸润，而其病理类型又于未分化型的甲状腺癌患者，对放疗、化疗敏感者，以手术加术后放、化疗加中药的综合治疗方法。其目的在于消灭癌残留，提高生存时间，降低复发率。中医药可以防治放、化疗引起的毒副反应，同时又可起到增敏、增效作用；如果病理类型分化良好，如滤泡状或乳头状甲状腺癌等，则对放、化疗不敏感，也应以中药及免疫治疗为主；如病已至晚期，未做根治术或已失去手术切除可能的，若一般情况尚好的，病理分型又属于化疗或放疗有效的，可作化疗或放疗，配合以中药治疗，可延长生存期，提高生存质量。

第七章 食管癌

【概述】

食管癌占有所有恶性肿瘤的 2%，是消化道常见的恶性肿瘤，亦是世界上发病率较高的恶性肿瘤之一。目前在世界上发病率较高的国家有苏联、土耳其、伊朗、美国、法国、瑞士、巴西、日本等。美国年龄标化发病率为 12/10 万~24/10 万人口，法国某些地区此率为 10/10 万~36/10 万人口，瑞士 3/10 万~10/10 万人口，巴西 13/10 万~26/10 万人口，日本 6/10 万~14/10 万人口。过去 10 年中美国的食管癌死亡率有所增加，但同时在地那维亚国家及瑞士，其死亡率却见下降。

我国食管癌发病率也较高，据卫生部统计资料，我国食管癌死亡率在男性仅次于胃癌而列第二位；在女性仅次于胃癌和宫颈癌而列第三位，本病发病率男高于女。男：女为 1.3：1~2.7：1。高发地区一般发病率年龄在 40 岁以下，而低发地区则多在 50 岁以上。

食管癌的确切病因目前尚不清楚，根据病因学及流行病学调查，可能与以下因素有关：饮食因素（经常进食粗糙、过硬、过热以及酸辣、辛香等食物和烈性酒刺激食管粘膜），环境因素（亚硝胺类化合物含量高，微量元素失调），以及遗传因素等。

食管癌根据其进展情况可分为早期食管癌和中、晚期食管癌。早期食管癌病变范围限于食管上皮或粘膜或粘膜下层，无转移。因其症状有时与情绪波动有关，因而常被忽视或误诊为功能性。中、晚期食管癌病变范围已侵入肌层或外侵，有局部或远处淋巴结转移及器官转移。

早期食管癌症状主要表现为咽下时的梗阻感，并可自行消失，随后又反复出现，但不影响进食。其次是胸骨后的烧灼或针

刺样轻隐痛，痛与食物性质有关，进粗硬或过热等食物较为明显，而进流质则较轻。当病情逐渐发展至中晚期（一般约经6~7个月），咽下困难缓慢加重，起初仅为固体食物不能通过，随后发展到半流质或流质也难通过。随着肿瘤不断发展，因局部炎症与水肿，使食物通过更加困难，随之近段食管逐渐扩张，食物常滞留而发生食物反流。反流物常为粘液及无酸味的食物，有时为血性。后期由于进食受阻，逐渐出现失水、营养不良及恶病质。

食管癌部位以中段最为多见，下段次之，上段最少。根据食管镜及标本的肉眼观察，早期食管癌可表现为下列四种类型：隐伏型、糜烂型、斑块型、乳头型。中、晚期食管癌也分为四型：髓质型、蕈伞型、溃疡型、缩窄型。中晚期食管癌以髓质型最为多见，蕈伞型次之。食管癌绝大多数为鳞状细胞癌，少数为腺癌。食管扩散方式以淋巴管转移为主，多转移至左锁骨上窝淋巴结，也可转移至其他淋巴结。晚期则由血行播散至肝、肾、肾上腺与骨、脑等处。

在祖国医学文献中，虽然没有“食管癌”的病名记载，但有与食管癌临床一致或相似的病证论述。

食管癌早期在临床上出现咽下时有梗阻感，并可自行消失，随后又反复出现，但不影响进食等表现。祖国医学认为多属“噎膈”。《诸病源候论》中说：“此由脏气冷而不理，津液涩少，而不能传行饮食，故饮食入则噎塞不通”。《脉因证治》记载：“大概因血液俱耗，胃脘亦槁，在上近咽之下，水饮可行，食物难入，间或可食，入亦不多，名曰噎”。这些论述与食管癌早期症状相似。食管癌中、晚期的临床表现除咽下困难进一步加重，甚者流质也难通过外，还可出现食物反流、吐血、营养不良及恶病质等表现。这一阶段在祖国医学除属“噎膈”外，还属“呕吐”、“吐血”、“虚劳”等范畴。《脉因证治·噎膈》中说：“其槁在下，与胃为近，食虽可入，难尽入胃，良久复出……”。这与食管癌

中，晚期出现食物反流的表现一致。《五鬲气侯》中说：“热膈之为病，脏有热气，五心中热，口中烂生疮，骨烦四肢重，唇口干燥，身体头面手足或热，腰背皆疼痛，胸痹引背，食不消，不能多食，羸瘦少气及癖也”。这与食管癌中、晚期出现营养不良等表现相一致。

在祖国医学历代文献中，虽然可以较全面地把食管癌的临床表现包括在内，而且在病困、病机、治则、方药等方面也有许多极有参考价值的论述。但是，由于历史的原因，历代医学不可能对食管癌有一个系统、深入的认识。因此，上述病证虽然包括有食管癌，但也含有其它疾病，我们在参阅历代文献中必须认真区别，临床治疗上也必须详查病情，在现代医学确诊的基础上，根据具体表现以治病求本，辨证施治。

【病因病机】

食管癌的病因很多，祖国医学将其分为三类：外因、内因、不内外因。外因主要是感受寒、热之邪；内因多为忧思暴怒；不内外因多为饮食伤脾胃和房劳伤肾。其中忧思暴怒、饮食所伤是导致本病的主要原因，内在正虚亦是重要因素。从临床来看导致本病发生是多种病因综合作用的结果。正如《济生方·五噎五膈论治》中说：逸则气神安，劳则气神耗，倘或寒温失宜，食饮乖度，七情伤感，气神俱耗，使阳气先结，阴气后乱，阴阳不和，脏腑生病，结于胸膈，则成膈；气留于咽嗑，则成五噎”。《景岳全书·噎膈》中说：“噎膈一证，必以忧愁思虑，积劳积郁，或酒色过度损伤而成，盖忧思过度则气结，气结则施化不行；酒色过度则伤阴，阴伤则精血枯涸。气不行，则噎膈病于上；精血枯涸，则燥结病于下”。《证治汇补》中说：“噎膈”有气滞者，有血瘀者，有火炎者，有痰凝者，有食积者，虽有五种，总归七情之变，由气郁化火，火旺血枯，津液成痰，痰壅而食不化也。……有因色欲过度。阴火上炎，遂成膈气，宜作死血治”。从以上历代文献的一些论述中可以看到，本病的病因是多方面的，多种病

因作用于机体后，则产生一系列病理变化，最后导致食管癌，兹分述如下。

一、外感邪毒 六淫邪毒内侵，正气不足以祛邪，致使外邪入于胸膈，扰乱气机，阻于食管，随发噎膈。《素问·阴阳别论》中说：“一阳发病，……其传为膈”。“三阳结谓之膈”。

二、忧思暴怒 忧思则气结伤脾；暴怒则气逆不降。气结则津、血不行，生痰、生瘀，伤脾则脾失健运，聚湿生痰；气逆则血逆，久则气滞血瘀。以致气、痰、瘀阻塞食道而发本病。正如《素问·通评虚实论》说：“膈塞闭绝，上下不通，则暴忧之病也”。《诸病源候论·五膈气候》中说：“忧膈之为病，胸中气结烦闷，津液不通，饮食不下，羸瘦不为气力。悲膈之为病，心下苦实满，噫辄酢心。食不消，心下积结，牢在胃中，大小便不利。气膈之为病，胸胁逆满，咳逆，腹上苦冷，雷鸣绕脐痛，食不消，不能食肥……”。《鸡峰普济方》亦认为本病的成因为“神思间病”等，说明本病的发生与精神因素密切相关。

三、饮食所伤 脾胃主司受纳饮食，运化水谷，故饮食所伤主要伤及脾胃。或恣食辛辣燥热之品，津伤血燥，以致食道干涩，食物难下，而发噎膈；或嗜酒无度，过食肥甘，则湿热蕴结，津伤痰阻，而发噎膈。《济生方·五噎五膈论治》明确指出“食饮乖度”是造成五噎病发生的原因之一。《景岳全书·噎膈》中说：“凡人之脏气，胃主受纳，脾主运化，……今既食饮停膈不行，或大便燥结不通，岂非运化失职，血脉不通之为病乎？而运行血脉之权，其在上者，非脾而何？”《金匱翼·膈噎反胃统论》中说：“夫膈噎，胃病也，始先未必燥结，久之乃有大便秘少，若羊屎之证。此因胃中津气上逆，不得下行而然，乃胃病及肠，非肠病及胃也”等，均说明饮食伤脾胃，脾胃病运化失司造成本病发生。

四、房劳伤肾 房劳过度，精血亏耗则诸脏受累，因肾为人体阴阳之根，水火之源，化生之本。若肾阳不能温煦脾阳，则

精微化生无源，水湿不得正常运化，聚湿生痰，阻于食道，而发本病；若肾阴亏涸，食道失润，日久干涩，则饮食难以下咽，而发本病。《景岳全书·噎膈》中说：“酒色过度则伤阴，阴伤则精血枯涸，精血枯涸，则燥结病于下”。《医贯·噎膈论》中说：“盖肾主五液，又肾主大小便，肾与膀胱一脏一腑，肾水既干，阳火偏盛，熬煎津液，三阳热结，则前后闭涩，下既不通，必反于上，直犯清道，上冲吸门咽喉，所以噎食不下也”。

总之，中医认为食管癌的病因是多方面的，其病位虽在食道，但与内脏亦密切相关。尤其是内脏胃、脾、肾、肝等脏之经络直接与食道联系。所以在上述因素作用下，造成胃、脾、肾、肝功能活动失常，气、痰、瘀血阻于食道或津液不能正常润养食道，均可致本病发生。本病发生后，病程愈久，正气愈伤。因饮食是机体营养物质生化之源，是生命活动之根本，随着本病发生，饮食难下，饮食减少，则阴、阳、精、气、血、津液等精微物质生化减少，脏腑功能活动因之而虚弱。本病病程愈久，则正气愈伤，终至脏气衰败，阴阳衰竭，形体羸瘦，成为危候。所以正气虚弱亦是本病发展变化的核心所在。因此，本病临床上多虚实错杂，虚实各异，临床治疗当明辨虚实。正如《金匱翼·噎膈反胃统论》中说：“噎膈之病，有虚有实……不可不辨也”。

【治疗】

一、辨证施治

（一）痰气交阻型

【主证】吞咽梗阻，胸膈痞满，噯气，或呃逆、精神郁闷，或呕吐痰涎，大便不畅，舌淡红苔薄腻，脉弦滑。

【分析】本型辨证要点是噎膈初起，吞咽梗阻，胸膈痞塞，苔腻。因痰气交阻，闭塞胸膈、食道，故吞咽梗阻，胸膈痞满；痰气交阻，气机不畅，故精神郁闷；气机不畅，升降失司，胃气上逆，故噯气、呃逆，或呕吐痰涎；肠道气机不畅，故大便不畅；舌淡红苔薄腻，脉弦滑均为痰气交阻之征。

【治则】理气解郁，化痰畅膈。

【方药】启膈散加减。

【方解】启膈散源于《医学心悟》。方中郁金、砂仁壳理气解郁；川贝化痰畅膈；荷叶蒂、杵头糠升清降浊；沙参润燥养阴；茯苓渗湿健脾以杜生痰之源；丹参化瘀散结以防气滞血瘀。

【加减】痰阻甚，呕吐痰涎多者，加姜半夏、橘红；气郁甚加枳壳、青皮；呕吐或呃逆重加旋复花、代赭石；暖气明显加沉香、陈皮；大便不畅明显加大白。

【变证】

1.痰热内扰 痰气交阻，日久不解，易于化热，致痰热内扰。证见心烦失眠，口苦目眩痰多黄稠，胸闷恶心，舌质偏红，苔黄腻，脉滑数。治宜理气解郁，清化热痰。方用清火涤痰汤加减（丹参、橘红、胆星、姜蚕、贝母、菊花、麦冬、茯神、竹沥、姜汁、郁金）。

2.胃阴不足 气郁化热，灼伤胃阴。证见胃脘灼热，嘈杂隐痛，口燥咽干，五心烦热，舌红少苔，脉弦细数。治宜养阴润燥，理气降逆。方用麦门冬汤（麦冬、半夏、人参、甘草、粳米、大枣）加减。

3.瘀血阻络 痰气交阻，血行滞涩，久则瘀血阻络。证见胸骨后疼痛，痛处固定，或见吐血，舌质紫暗或有瘀点、瘀斑，脉弦或涩。治宜活血化瘀。方用手拈散（五灵脂、没药、元胡、香附）加减。

4.痰饮内阻 痰气交阻，阳气不运，聚水生痰，痰饮留聚。证见呕吐痰涎清水，胸脘痞闷，不思饮食，头眩心悸，舌苔白腻，脉弦滑。治宜温化痰饮。方用二陈汤（制半夏、陈皮、茯苓、炙甘草）合苓桂术甘汤（茯苓、桂枝、白术、炙甘草）加减。

（二）瘀血内结

【主证】吞咽梗阻，胸膈疼痛，食不能下，甚则滴水难进，

进食即吐，大便坚硬如羊屎，或吐下如赤豆汁，或便血，面色灰黯，形体羸瘦，肌肤甲错，舌质紫暗少津或舌面有瘀点瘀斑，舌下静脉怒张，脉细涩。

【分析】本型辨证要点是血瘀食道，出现吞咽梗阻，胸膈疼痛，固定不移，舌质紫暗。瘀血内结，阻于食道，食道狭窄，甚则闭塞不通，故吞咽梗阻，食不能下，甚则滴水难进，进水即吐；瘀血内结，不通则痛，故胸膈疼痛；瘀血内结，饮食不入，日久阴虚肠燥，则大便坚硬如羊屎；瘀血内结，血不循经，故吐下如赤豆汁或便血；瘀血内结，饮食不入，气血生化无源，形体肌肤面色失于正常营养，故面色灰黯，肌肤甲错，形体羸瘦。舌脉均为瘀血内结之象。

【治则】活血化瘀，消肿散结。

【方药】通幽汤加减。

【方解】通幽汤源于《兰室秘藏》。方中桃仁、红花、当归、活血化瘀，消肿止痛；生地、熟地滋阴润燥；炙甘草益气和，调和诸药。

【加减】血瘀甚者加水蛭、土鳖、灵芝以破瘀散结；大便坚硬如羊屎甚者加滋阴润肠丸以逐瘀通便；服药即吐，难于下咽者可先服玉枢丹以开通降逆，然后再服煎药。

【变证】

1.久瘀化热 瘀血内阻，日久化热。可兼见口燥咽干，五心烦热，舌红有瘀斑苔黄，脉弦数。治宜活血化瘀，清热消肿。方用通幽汤配服六神丸。

2.痰瘀互结 瘀血内阻，水津运行受阻，凝聚为痰，致痰瘀互结。可兼见呕吐痰涎，胸膈痞塞，舌苔白腻或白滑。治宜活血化瘀，化痰散结。方用手拈散加海藻、昆布、姜半夏、莱菔子。

（三）阴津亏乏

【主证】吞咽梗涩，饮水可下，食物难进，形体消瘦，肌肤

枯燥，口干咽燥，欲饮凉水，五心烦热，或潮热盗汗，性情急躁，大便干结，舌嫩红而干，或有裂纹，少苔，脉弦细而数。

【分析】本型辨证要点是吞咽梗涩，口干咽燥，五心烦热。可由气郁化火伤津，或恣食辛辣炙膏伤津，或热病后伤津，或素体肾阴不足所致。阴津亏乏，食道失于濡润而干涩，故吞咽梗涩，饮水可下，食物难进，口咽干燥，欲饮凉水；阴津亏乏，形体失养，故形体消瘦，肌肤枯燥；阴虚生内热，故五心烦热，或潮热盗汗，性情急躁；阴津亏乏，肠道失润，则大便干结；舌脉均为阴津亏乏之象。

【治则】滋养阴津，润燥畅膈。

【方药】六味地黄汤合五汁安中饮。

【方解】六味地黄汤源于《小儿药证直诀》，五汁安中饮为验方。肾主五液，藏元阴，五脏之阴非此不能滋，故用六味地黄汤补肾阴以治根本；用梨汁、藕汁、牛乳以养胃生津，润燥增液；用生姜汁和胃降逆，化痰畅膈；用韭菜汁活血行瘀，降逆除噎。

【加减】肠燥便秘者加生首乌、当归、黑芝麻以润肠通便；若大便秘结，腹中胀满甚者可暂用大黄甘草汤通腑，中病即止。

【变证】

1. 饮食停滞 阴津亏乏，肠胃失濡，胃之纳化失常，易致饮食停滞。证见胃脘胀满，疼痛拒按，噎腐吞酸，或呕吐不消化食物，吐后较舒畅，不思饮食，大便不爽，舌淡红嫩苔厚腻，脉细略滑。治宜消食行滞，养阴益胃。方用保和丸（神曲、山楂、茯苓、半夏、陈皮、连翘、萝卜子）合益胃汤（沙参、麦冬、玉竹、生地、冰糖）加减。

2. 阴虚燥热 阴津亏乏，燥热内生。证见口渴饮冷，口气觉热，小便短赤，舌苔黄干。治宜滋养阴津、润燥清热。方用六味地黄汤加知母、玄参、生石膏。

（四）气虚阳微

【主证】久噎不已，吞咽受阻，饮食不下，面色㿠白，精神疲惫，形寒气短，泛吐涎沫，面浮足肿，腹胀，舌淡胖苔薄白，脉细弱或沉细。

【分析】本型辨证要点是久患噎膈，面色㿠白，精神疲惫，形寒气短。气虚阳微，中焦运化衰减，饮食无以受纳和运化，浊气上逆，则吞咽受阻，饮食不下，泛吐涎沫；气虚阳微，机体失于阳气温养，故面色㿠白，精神疲惫，形寒气短；气虚阳微，水气不化，故面浮足肿；气虚阳微，运化迟滞，则腹胀不舒；舌脉均为阳气虚弱之征。

【治则】补气温阳。

【方药】理中汤加减。

【分析】理中汤源于《伤寒论》。方中用人参、炙甘草补气；干姜温运阳气；白术健脾燥湿和胃。本方重在温补中焦阳气，增进脾胃运化功能。因脾胃为后天之本，阴阳气血化生之源，脾胃阳气得补，则阳气生化有源。本方药味少，治病较单纯，对食管癌日久者，因证情复杂，此方显得功效单一，故常随证加减。

【加减】气虚重者重用西洋参加黄芪；阳虚重得加肉桂、鹿茸；呕吐者加姜半夏、丁香；面浮足肿明显者加泽泻、车前子；腹胀者加木香、砂仁；便溏者加肉豆蔻、诃子。

【变证】

1.痰饮内生 气虚阳微，水饮不化，聚湿生痰，痰饮内生。证见泛吐痰涎，或呕吐清水痰涎，胸膈痞满，心悸头晕，舌淡苔白滑腻，脉沉细。治宜补益阳气，温化痰饮。方用理中汤合苓桂术甘汤加减。

2.瘀血阻络 阳气虚弱，推动血液运行无力，血行迟滞，日久瘀阻。证见胸膈疼痛，固定不移，舌暗红，舌有瘀点或瘀斑。治宜温补阳气，活血化瘀。方用理中汤加丹参、韭汁。

3.阴阳两虚 阳气虚弱日久，功能活动减弱，精微物质生

化减少，阴虚由生。证见气怯神疲，形体瘦弱，头晕目眩，耳鸣耳聋，舌淡苔白少津，脉细弱。治宜阴阳双补。方用右归饮（熟地、山药、山萸肉、枸杞、甘草、杜仲、肉桂、制附子）加减。

【按语】 我们根据临床所见，并参考有关文献资料将食管癌分为四个主要证型和十一个次要证型，因受我们临床的局限，加之本病证候的错综复杂性，以上所概括证型不可能覆盖全部食管癌患者，也不可能覆盖每个食管癌患者的全过程。因此，仅供临床辨证施治参考。

辨证施治仍是目前中医治疗食管癌的核心手段。临床上在辨证时，除要明辨证候之外，还要注重辨其轻重，辨其顺逆。一般来说，噎膈病轻者，仅有吞咽不顺，胸胁胀闷，情绪舒畅时可减轻，全身症状亦不明显，工作起居影响不大；噎膈病重者，吞咽时胸膈疼痛，汤水难下，或食物随即吐出。甚至吐出物如赤豆汁。形体日渐消瘦憔悴，精神疲惫。噎膈病顺者，多为噎膈新发，仅有吞咽不顺，全身症状不明显，工作起居影响不大；噎膈病逆者，多为噎膈病久，吞咽时胸膈疼痛，汤水难下，或食入即吐出，脉涩数，大便秘结如羊屎，口吐白沫，吐痰如蟹沫，胸痛如刀割。临床上在治疗时，应针对证候主次，证候轻重，合理筛选方药。一般来说，噎膈初期以标实为主。标实多与气郁、痰阻、血瘀有关，治疗宜开郁行气、化痰散结、活血化瘀；噎膈中期则为本虚标实，治宜攻补兼施；噎膈后期多以本虚为主，治宜培补正气。中医治疗噎膈，历史悠久，历代医家多有独到之处。如张仲景主张调气润血，降火化痰。刘河间主张清凉下火。朱丹溪主张润养津液，降火散结。张锐主张调顺阴阳，化痰下气。赵献可主张滋养肾水。李中梓主张化痰行瘀等等，均可参考。另外，治疗食管癌临床以早期疗效较好，故强调早期治疗。

二、单方、验方、成方（药）

（一）单方

1.牛口内之回嚼草，不洗，煮水频频饮之。

2.蛭螂放新瓦上焙干，研细末，每服 1.5g 至 3g，红枣 5 枚煎汤下，日服三次。

3.柞树花，烧灰存性，研细末，每服 6g，日三次（柞树民间称檬子树）。

4.生白鹅血不放盐，乘热饮。

5.白鹅尾管毛烧灰存性，研细末，每服 3g，米汤送下。（生鹅血之功优于鹅毛灰，如无鲜血时，本方可代用。）

6.鹅毛烧炭，每服 3g，姜汁送服。此方治噎膈呕吐物如赤豆汁者。

7.黄鳝鱼 1 条，置黄酒中炖（黄酒以盖过鱼身为度），酒干后将鱼放在瓦上焙干存性，研细面后每服 10g，黄酒送服，日服三次。

8.壁虎 3 只，粮食酒 500ml，将活壁虎放酒中，封口 7 天后可用。适用于噎膈晚期汤水不入时，此方有通关作用，俗名守宫开道酒。

9.山慈菇（整个破开）200g（洗净），蜂蜜 200g，用清水煎山慈菇至道，加入蜂蜜收膏，每日服 2 次，每次 25g。

10.蜒蚰 20 条，瘦肉数片，煮汤，调以味，徐徐服之。

11.守宫若干，煨存性为末，每次 2~3g，每日三次，开水送服。

（二）验方

1.猪肺管 120g，鲜藕 120g（无鲜者以干藕节 30g）、旧罗筛底（要黄色者）1 个。三味于新瓦上焙干研末，再以生姜 30g 捣汁，白糖 30g 合匀，每次用药末 10g，加糖姜汁适量，开水冲服。初服药易吐，吐后再服，三、四次后，渐渐不吐，服药期间忌食豆腐、豆芽等一切豆类制品。

2.三宝启膈丹：鸡宝（鸡胡椒，即长于鸡皮内之结石）6g，狗宝 7g，马宝 6g，麝香 1.5g，沉香 1.5g。共研极细末，每服 1g，渐加至 2g。

3.瓜蒌 15g、郁金 15g、丹参 15g、白术 15g、茯苓 10g。水煎服。每日二次。适用于吞咽梗阻，但食物还可入胃者。

4.三乳汤：牛乳、人乳、羊乳等份少量频服。适用于固体食物难下，但汤水可入者。

5.四汁饮：梨汁、生姜汁、韭菜汁、葡萄汁等份频饮。适用于固体食物难下。但汤水可入者。

6.甘蔗汁、萝卜汁等份频饮，吐后再饮。

7.海藻 30g，水蛭 6g，共研细末，黄酒冲服，每日 2 次，每次 6g，连续服用，至症状消失为止。

8.山豆根 250g、鹿角 200g、麝香 3g。将山豆根文火炕干，研细末过箩，炼为丸，每丸 10g，每次 1 丸，1 日 3 次。鹿角用锉刀锉末，每服 5g，1 日 3 次。麝香每次 0.3g，一日 3 次，温开水冲服。适用于噎膈属湿热者。

9.鲜山慈菇 500g，白花蛇舌草 500g。水煎服 / （服后有反应时可将山慈菇减量）

10.猪心、肺各 1 具，皂角、威灵仙另煎，混合频频服之。

11.黄芪 20g，三棱 25g，莪术 25g，海螺 12g，海蜇 12g，昆布 10g，白花蛇舌草 15g，山豆根 15g，延胡索 10g，木香 10g，海螵蛸 10g，水煎服。

12.三棱 12g，莪术 12g，大枣 15 个，斑蝥 30 个。每一个枣去核装 2 个斑蝥，再用白面包裹焙干，与三棱、莪术共为细末，分为 21 包，每日 1 包。（服用本方忌酒、不生气，可暂缓症状，斑蝥有毒不可久服）。

13.儿茶 45g，硃砂 6g，冰片 2g，滑石 12g，神曲 9g，甘草 2g，共为细末，每日服 3 次，每次 6g，温开水送服。适用于噎膈，口舌生疮，咽喉糜烂。

14.鲜鸡内金 2 个，广木香 3g，丁香 3g，海南沉香 3g，大枣肉适量。将鸡内金用湿纸数层包裹，外用泥封固，炭火段 1 小时，去泥及纸灰，用三香共为细末，枣肉为丸，如梧桐子大。每

日3次，每次7丸，噙化服。适用于噎膈，忌酒肉油腻等物。

15.平鲫丸：大鲫鱼一条，去内脏留鳞，以大蒜切片，填鱼腹内，湿纸包，黄泥固，慢火煨熟，去鳞骨，入平胃散末，捣丸如梧子大，每服30~50丸，空心米饮吞下。

16.八仙膏：藕汁、姜汁、梨汁、萝卜汁、甘蔗汁、白果汁、竹沥、蜂蜜等分和匀蒸熟，任意食之。

17.蟾酥一只，蜒蚰20条，石上柏90g，煎六小时后，一次服。

18.穿心莲10g，白花蛇舌草30g，浙贝母12g，玄参24g，夏枯草12g，海藻10g，水煎服。

19.龙葵30g，蛇莓15g，蜀羊泉30g（又名白毛藤）。石打穿15g，半枝莲15g，威灵仙15g，盲肠草15g，枸橘叶15g，水煎服，每日一剂。适用于食管癌、胃癌、梗阻严重，吞咽困难，或呕吐。

20.北沙参15g，丹参15g，川贝母10g，麦冬10g，广郁金10g，全瓜蒌18g，桃仁泥10g，油当归10g，荷叶蒂2g，杵头糠（即大米之软皮）一撮，蜂蜜30g。适用于噎膈胃阴不足者。

21.食道饮：半枝莲30g，白花蛇舌草30g，刘寄奴30g，金佛草10g，代赭石30g，柴胡10g，香附10g，郁金10g，炒枳壳10g，清半夏10g，丹参10g，水煎服。

22.开道散：醋柴胡硃砂1000g，紫金锭1000g，冰片10g，麝香1g，共研细末，装瓶备用。每次1g，日3次。

23.北沙参12g，麦冬12g，瓜蒌仁12g，火麻仁18g，柏子仁12g，枳实9g，当归24g，旋复花15g，制半夏9g，冬葵子9g，水煎服。另以韭汁一杯冲服。适用于阴津枯涸，腑热燥结之噎膈。

24.人参10g，半夏9g，白蜜50g，先将半夏用淘米水浸15分钟，取半夏煎水1小碗，人参另煎水1小碗，和匀，再加白蜜，分2次服完。适用于气虚引起的饮食不下，或食入即吐，泛

吐清涎之噎膈呕吐。

25.菱角、诃子、薏米各 9g，田七 3g。水煎服，每天 1 剂，常期服用。

26.旋复花 9g，莱菔子 9g，薏米 30g，沙参 15g。将旋复花、莱菔子、沙参用纱布包煎汤，去渣后与薏米煮粥食。每天一剂，15~20 天为一疗程。

27.熟地 15g，当归 12g，桃仁 9g，红花 6g，海带 20g，猴头蕈 30g。调料适量。将前四味药煎汤去渣，入海带、猴头蕈煮熟，加调料调味服食。每天 1 剂，连服 20~30 剂。

(三) 成方(药)

1.平消片：治疗肺、肝、胃、食管癌和骨肿瘤 180 例，总有效率达 64.5%。

2.攀枝花制剂：治疗 29 例，其中症状消失 19 例，减轻 2 例，X 线检查病变范围明显缩小近效与争光霉素疗效相似，5 年生存率 33.5%。

3.复方破石合剂：口服治疗晚期胃、食管、宫颈、乳腺、直肠癌 31 例，近期有效率 77.42%。

4.抗癌乙片：治疗食管上皮重度增生 72 例，治疗后好转率占 61.8%。

5.“494”冲剂：治疗 65 例，治疗后病理形态学改善明显。

6.梅花点舌丹：治疗 10 例晚期食管癌、贲门癌患者，治疗后 6 例吞咽困难减轻。

7.复方天仙胶囊：本品具有明显抗癌作用，尤其对食管癌、胃癌、肠癌效果更佳，完全缓解率为 1.2%，部分缓解率为 9.3%，瘤体稳定率为 70.2%。每日三次，每次 2~4 粒，饭后用蜂蜜水或温开水送服。（吞咽困难者可将药粉倒出溶水服用）每个疗程为一个月，停药 3~7 天再继续服用。（孕妇禁忌）

【按语】 上述单方、验方源于中医古籍和现代医学书籍及杂志报道。由于均未经现代科学研究，所以其疗效不可避免会存

在偶然性、局限性、主观性、片面性。上述成方因观察例数较少，所以其疗效的客观性尚有待进一步研究。因此，上列诸方仅供临床参考。

三、中西医结合治疗

(一) 中医药与手术治疗相结合 食管癌的手术治疗目前仍是首选方法。目前已证实：手术治疗对食管癌早期、病灶局限没有转移者疗效较好；而对晚期病人、病灶较长、或已有转移者疗效则较差。对于中、晚食管癌患者，如与中医药相结合可提高疗效。术前用药可改善症状、增强体质、缩小病灶、提高切除率。河北医学院报道，术前应用中药“494”冲剂，连用14天。用药结束后经复查行手术探查，切除肿瘤标本病理观察，结果肿瘤标本病理形态学改变明显。提示“494”对癌组织有一定损伤作用，对提高机体免疫功能达到抑癌的效果可能有一定作用。

(二) 中医药与化疗相结合 对食管癌应用化疗方法虽可使一部分病例获得短期效果，但副作用较多，总体效果差。国内报道对食管癌单用5-Fu的有效率为11%、单用MMC的有效率为15%、单用博来霉素的有效率为17%；国外报道对食管癌单用5-Fu的有效率为17%。显然，单药对食管癌的疗效很不理想。采用联合化疗方案治疗食管癌可使有效率提高到27%左右。而化疗与中医药相结合，可明显提高治疗效果，减轻化疗毒副作用。江苏省盐城市第一人民医院采用MOFⅢ方案加服中药扶正抗癌汤治疗32例晚期食管癌、贲门癌。结果完全缓解2例；部分缓解11例；稳定16例，恶化3例；总有效率为40.6%。治疗后平均生存时间7.2月。河北省医科院肿瘤研究室用中医药合小剂量化疗相结合治疗60例食管贲门癌。结果：44例早期生存5年以上者4例，4年以上者26例3年以上者6例，2年以上者8例；16例中、晚期生存5年以上者1例，4年以上者4例。中晚期患者平均生存时间为28.6月。

(三) 中医药与放疗相结合 食管癌的放射治疗至今无肯定

资料，与中医药相结合的现代研究也较少。目前初步提示：部分中药可减轻放疗反应、提高放疗效果，纠正放疗副作用的作用。河北省峰峰矿务局第一医院肿瘤科用西医方法（手术、放疗、化疗）与补肾中药相结合治疗 67 例食管癌与贲门癌患者。其中报道一例放疗与化疗、中药结合治疗的病例，结果生存期达 6 年半以上。中国医学科学院和北京中医医院应用扶正中药治疗 13 例因放射治疗所致白细胞降低的患者。结果：服药 10 天以内白细胞升至 4000 以上者 11 例，服药 11~31 天白细胞升至 4000 以上者 2 例。有效率 100%。

四、综合治疗

综合治疗可以明显提高食管癌的临床疗效及远期生存率，尽管如此，对食管癌的治疗效果，目前仍然比较差。近些年所采用的食管癌综合治疗方案大致如下。

早期食管癌，采用手术根治性切除+中医药；或手术根治性切除+免疫治疗。

中期食管癌，采用放疗+手术根治性切除+中医药；或姑息性切除+化疗+中医药；或放疗+化疗+中医药。

晚期食管癌，采用放疗+手术+中医药；或化疗+手术+中医药；或中医药+化疗（放疗）+中医药等。

综合治疗的目的是提高疗效，原则上，在早、中期要尽可能为根治性切除创造条件，达到干净地清除癌细胞，以期彻底治愈；在食管癌晚期不能进行根治性切除者，治疗主要目的是改善或消除症状，延长生存期。总之，综合治疗要达到充分发挥各自疗效之优势，以提高食管癌的疗效，延长生存期。

第八章 肺 癌

【概述】

原发性支气管肺癌简称为肺癌，是目前最常见的恶性肿瘤之一。近几十年来，无论是在工业发达国家或是在发展中国家，肺癌的发病率及死亡率均以惊人的速度上升，目前世界上至少有35个国家的肺癌已居男性恶性肿瘤死亡原因之首。我国近20年来肺癌的发病率，尤其是城市也有明显上升。如上海市统计，1976年上海市肺癌死亡2830人，占全市恶性肿瘤死亡的20%，1963年肺癌死亡率为9.81/10万人口，1987年为37.3/10万人口。在多数大城市和工矿区如北京、上海、天津、沈阳、鞍山等已居常见肿瘤之首位。

目前对肺癌的发病因素还不十分明确。但由于肺是一个开放性器官，与皮肤一样与外界有直接接触，所以很容易受外界致癌物质的影响。我们知道，职业癌很多都是肺癌。因此，目前全世界肺癌流行的主要原因为吸烟和空气污染。

吸烟与绝大多数肺癌（80%以上）的发生有关，通常所指的是鳞状细胞癌和小细胞癌。近来的研究表明，长期处于吸烟的环境中可能也增加患肺癌的危险性。非吸烟者也可能发生肺癌但通常为一特定的类型（腺癌）。几种职业因素，如石棉、铬、镍、砷及接触煤制品等化合物可导致肺癌已被人们认识，接触石棉与吸烟在肺癌的发生中有明显协同作用。

祖国医学文献中虽无肺癌的病名，但类似肺癌症候的记载不少。如《内经》“肺咳之状，咳而喘息，甚则唾血……而面浮气逆”。又说：“大骨枯槁，大肉陷下，胸中气满，喘息不便，内痛引肩项，身热”。《难经》称：肺之积，名曰息贍，在右胁下，复大如杯，久不已，令人洒淅寒热，喘咳，发肺壅”。后世《济生

论》论述：“息贲之状，在右胁下，复大如杯，喘息奔溢，是为肺积，诊其脉浮而毛，其色白，其病气逆，背痛少气，喜忘目瞑，肤寒，皮中时痛或如虱缘，或入针刺”。金元时代李东垣治疗肺积的息贲丸，所治之证均类似肺癌症状。明朝张景岳说：“劳嗽，声哑，声不出或喘息气促者，引肺脏败也，必死”。这同现代晚期肺癌出现纵隔转移压迫喉返神经以致声哑相同，并指出预后不良。至于其发病原因，正如《杂病源流犀烛》中说：“邪积胸中，阻塞气道，气不得通，为痰……为血，皆邪正相搏，邪既胜，正不得制之，遂结成形而有块”。说明正气虚损以后，外邪乘虚袭肺，郁结胸中，肺气贲郁，宣降失司，积聚成痰，痰凝气滞，淤阻脉络久而成块。由此可以看出祖国医学认为肺癌的发病多与邪毒犯肺，痰湿内聚、气滞血瘀、正气内虚邪毒内结有关。

肺癌的组织学类型。肺癌的组织学类型很多，但通常分为以下四类。

1.鳞状细胞癌为常见型占 40%~45%，多为中心型，男性较多，可分高分化鳞癌及低分化鳞癌。

2.腺癌占 25%~30%，多为周围型，恶性度高，病程短，转移早，对放疗敏感性差。与其他类型相比，腺癌与吸烟的关系不密切。

小细胞癌是第三种常见的类型占 20%~25%。病情进展迅速，病程短，转移早，对放、化疗均较敏感。几乎总是伴有播散性病变，故应特殊处理。小细胞肺癌与吸烟关系密切，预后最差。小细胞来自支气管粘膜的内分泌细胞，经常分泌多肽进入血液，导致各种各样的非特异性综合征。

第四类大细胞癌仅占 10%，可分为中心型，亦可为周边型。

其中不常见的类型为支气管肺泡癌（周边性缓慢生长型，常为多发结节）；类癌（伴或不伴类癌综合征）和粘液表皮样癌（有时被误认为转移性胃肠道肿瘤）。

肺癌的诊断要从五个方面考虑。首先是一般临床表现：肺癌症状常和一般肺部疾病相似，如咳嗽、痰中带血、胸痛、发热、胸闷气短等，故易误诊。有的患者因出现呼吸困难，头颈部浮肿，颈及胸壁静脉怒张等上腔静脉压迫综合征而就诊。有时肿瘤压迫喉返神经而声哑；有的出现胸水；有的甚至以脑占位病变而就诊；老年人反复出现肺部感染或肺不张时要警惕肺癌的可能。

其次为X线检查：X线检查对肺癌的诊断价值很大，其准确率可达80%以上。通过胸透胸部正侧位片可发现肺癌肿块或阴影。局限性肺气肿、肺不张、肺炎、胸腔积液以及膈肌的矛盾运动等，均有重要意义。也可用X线断层摄影和必要的CT扫描检查进一步观察块影的轮廓、形态有无分叶、毛刺、空洞、支气管分叉角度有无改变，管腔有无狭窄、阻塞、管壁有无受浸润等。

第三是细胞学检查：脱落细胞学检查是诊断肺癌的重要方法之一。可以从痰液、支气管镜吸出物、支气管镜下直接涂片从胸水中查癌细胞。以取痰液最为简便易行，并且可以反复多次检查。根据肿瘤的细胞学特点及肺癌生长部位的关系以鳞癌及小细胞未分化癌检出率高。临床上见到过痰细胞学阳性，而胸片、气管镜以及CT扫描均未发现病灶的隐匿型患者。

第四是纤维气管镜检查：支气管检查尤其对中心型肺癌的检出率很高，气管镜不但可以直接观察气管、支气管受压情况，隆突增宽，局部粘膜充血、水肿、增生、溃疡、出血等情况，还可以在病灶处刷取痰液，活检作病理细胞学检查。

最后为活体组织检查：对颈部、锁骨上、腋下肿大淋巴结、皮下结节、胸膜及剖胸探查时活检可取得病理组织学的确诊。

临床还要对肺癌进行鉴别诊断，肺癌的鉴别诊断包括慢性非特异性肺炎、慢性化脓性疾病、结核和良性肿瘤等。

【病因病机】

祖国医学认为肺为娇脏主气、司呼吸、主宣发肃降、通调水

道。由于肺有主一身之气而司呼吸的功能，所以，当人体正气虚弱或肺气虚时气机不畅，加之吸入外界致病邪气入侵犯肺，引起肺气壅遏，进而出现气滞气郁，气郁不畅血液鼓动无力，则出现血瘀。又由于肺主宣发肃降，通调水道，所以当有外邪入侵加之肺气虚，故亦可见痰湿蕴结之象。病久则实邪伤正，又可见阴虚热结，气阴两虚等全身衰竭之候。

气滞血瘀：外感六淫等邪毒入侵肺脏或内伤致使肺失宣肃，气机不畅，肺气郁结，阻塞气道，淤阻络脉，进而引起血瘀瘀久成块为瘤。

痰湿蕴结：外邪通过气道侵犯于肺，引起肺失肃降，水湿积聚为痰，痰邪郁久为块而表现为痰湿蕴结症状。

阴虚热结：邪毒郁（瘀）结，久则损正伤阴，阴虚热盛，热灼津液，故表现为阴虚热结之候。

气阴两虚：由于肿瘤瘀邪久滞体内不消，耗气伤津，因此，晚期肺癌病人主要表现为气阴两虚等正气亏虚之象。

总之，肺癌是因外感邪毒，内伤气血而引起正虚于内，邪实于外的本虚标实证。虚为整体性的，实为局部性的，实则主要表现为气滞血瘀、痰凝、毒聚；虚则表现为肺气虚、肺阴虚。

【肺癌的治疗】

一、辨证施治

肺癌的中医治疗应在辨证与辨病相结合的理论指导下，分清邪正虚实，予以正确治疗，临证要掌握局部与整体，抗癌与扶正及各种综合治疗（手术、放疗、化疗）后病人出现和可能出现的各方面情况与变化。肺癌早期，多见气滞血瘀、痰湿毒蕴之征，以邪实为主，治当行气活血，化瘀软坚和清热解毒、利湿化痰；肺癌中期和晚期，多见阴虚热结、气阴两虚之证，以正虚为主，治宜扶正祛邪，采取养阴清热、解毒散结及益气养阴、清化痰热等法。

气滞血瘀

【主证】咳嗽气急，咳嗽不爽，痰中带血，胸闷胸痛，或胀痛走窜，或痛如锥刺固定不移，大便正常或秘结，唇甲紫黯不荣，舌质红暗或有瘀点，紫斑，苔薄白或薄黄，脉弦或涩。

【治法】行气活血，软坚散结。

【方药】血府逐瘀汤加减。

当归 15g，枳壳 10g，瓜蒌仁 15g，赤芍 20g，郁金 10g，桃仁 10g，杏仁 10g，鳖甲 15g，生薏仁 30g，海藻 30g，薤白 10g，降香 10g，鱼腥草 15g。

痰湿蕴结

【主证】咳嗽较甚，痰多而粘或白或黄白相间或吐脓痰或见黑痰，胸闷气短，胸肋疼痛，纳呆便溏，神疲乏力，舌质淡或暗，舌体胖边有齿痕，苔白腻或黄腻，脉弦滑。

【治法】化痰散结，益肺健脾。

【方药】二陈汤加减

陈皮 10g，姜半夏 10g，茯苓 30g，制南星 10g，杏仁 10g，远志 10g，龙葵 30g，白花蛇舌草 30g，生薏仁 30g，党参 30g，白术 10g，海藻 30g，牡蛎 30g，象贝 15g，百部 15g。

阴虚热结

【主证】咳嗽声频，无痰或咳少量粘稠痰，痰中或带血丝，甚或咯血不止，气短神疲，颜面潮红，胸痛不减，低热盗汗或热势壮盛久稽不退，口干声哑，大便干结，舌质红，苔薄黄或少苔或无苔，脉细数。

【治法】养阴清热，解毒散结

【方药】百合固金汤加减。

百合 15g，玄参 15g，生地 30g，麦冬 30g，沙参 15g，鱼腥草 30g，生薏仁 30g，蛇舌草 30g，炙鳖甲 15g，半枝莲 30g，黄芩 10g，石斛 30g，生蛤壳 30g，蒲公英 15g，百部 10g，贝母 10g。

气阴两虚

【主证】咳嗽气短，动则喘促，咳声低微，咳痰无力，形瘦恶风，面白神疲，倦怠乏力，自汗或盗汗，口干少饮，舌质淡或红，脉沉细弱。

【治法】益气养阴，解毒化痰。

【方药】沙参麦门冬汤加减。

辽沙参 30g，麦冬 15g，五味子 6g，山药 15g，蛇舌草 30g，贝母 10g，夏枯草 30g，山慈菇 15g，补骨脂 10g，全瓜蒌 10g，生薏仁 30g，黄芪 20g，蛇莓草 15g。

二、单验成方

肺癌方

处方组成：丹皮 12g，生地 12g，鱼腥草 30g，蒲公英 30g，丹参 12g，王不留行 12g，野菊花 12g，五味子 9g，夏枯草 15g，海藻 15g，海带 15g，石见穿 15g（加减：止咳平喘加麻黄、百部、枇杷叶；滋阴润燥加沙参、天麦冬、元参、花粉；清热解毒加银花、连翘、红藤、败酱草；软坚消征加徐长卿、蜀羊泉、望江南；培补气阴加太子参、黄芪）。水煎服。每日一剂，早晚各服一次。

临床应用：本方应用 20 多年来，总结治疗 502 例肺癌的临床观察，证明其疗效肯定，不仅能使症状消失或改善，生存期延长，而且能使癌灶消失，缩小或稳定。

肺癌良方

处方组成：当归、赤芍、川芎、枳壳、桔梗、桃仁、红花、牛膝、三棱、莪术各 12g，生地、浙贝母、百部各 15g，蚤休 30g，甘草 5g，柴胡 10g（加减：伴有咯血者加鲜茅根 40g，白芨 12g；有胸水者加葶苈子 15g，大枣 3 个），水煎服，每日一剂早晚各服一次。

临床应用：本方用于治疗肺癌有效。

垂盆草白英方

处方组成：垂盆草、白英各 30g，水煎服，每日一剂。

临床应用：本方用于治疗肺癌有效。

泻肺逐饮汤

处方组成：甜葶苈 9g，白芥子 9g，龙葵 15g，瓜蒌 15g，白花蛇舌草 15g，陈胆星 9g，守宫 3g，十枣丸 3g（1次吞服），（加减：肺脾两虚加党参 12g，黄芪 20g，白术 9g，淮山药 9g，气阴两虚加太子参 15g，北沙参 15g，麦冬 12g，黄芪 12g，百合 12g），水煎服，每日一剂分2次服。

临床应用：本方治疗癌性胸水 11 例，平均服三周后，有 5 例症状缓解，X 线胸透检查胸水吸收者 3 例，胸水少量者 2 例。

马氏肺癌方

处方组成：八角金盘 10g，干蟾皮 12g，黄芪 30g，蛇莓 30g，八月扎 30g，半枝莲 15g，鱼腥草 15g，七叶一枝花 15g，丹参 15g（加减：脾虚痰湿者加党参、白术、茯苓、清半夏 9g，陈皮各 15g；阴虚内热者加沙参、生地各 20g，地骨皮 15g，麦冬 10g；气滞血瘀者加桃仁、红花、三棱、莪术、皂刺、赤芍各 10g；气阴两虚者加党参（或人参 9g）30g，沙参 30g，麦冬 10g；咳血者加阿胶（炖冲服）10g，大小蓟各 15g，血余炭 10g，藕节炭 15g，或服云南白药；胸水者加石上柏 30g，葶苈子 20g，冬瓜子 25g）。水煎服，每日 1 剂，3 个月为一疗程。一疗程后 3 日 1 剂以巩固疗效。

临床应用：本方用于治疗各型肺癌有效。

清毒利肺汤

处方组成：①南北沙参各 30g，天麦冬各 15g，桃杏仁各 9g，川贝、浙贝各 9g，地骨皮、夏枯草各 15g，蛤壳、全瓜蒌各 30g，前胡 9g，紫苑 12g，白花蛇舌草、半枝莲、草河车、石斛各 30g，（加干蟾皮 9g，野百合、泽漆、铁树叶各 15g，山海螺、鱼腥草、猫爪草各 30g，马兜铃 12g）；②胆南星 9g，桑皮 15g，瓜蒌、鱼腥草、生薏仁各 30g，云苓、半夏、马兜铃、前

胡、白术、黛蛤散、桔红各 9g，夏枯草 30g，厚朴 6g，半枝莲 30g，蛇舌草 30g。水煎服，每日 1 剂，煎 2 次分服。①方适应于阴虚毒热型肺癌；②方适应于痰湿蕴毒型肺癌。

临床应用：以本方为主，中西医结合治疗肺癌 58 例，有效 34 例，无效 24 例，总有效率为 58.6%。

复方铁树叶汤

处方组成：牡蛎、夏枯草、海藻、银花、连翘、紫草极、白毛藤、白花蛇舌草、蜀羊泉、铁树叶各 30g，半枝莲 60g，海带 12g，制鳖甲 12g，炮甲珠 12g，留行子 12g，全瓜蒌 12g，麦冬 15g，桔核 15g，桔叶、北沙参、鱼腥草、干蟾皮、藤梨根、山豆根各 15g，五味子 9g，川贝母 9g。水煎服，每日一剂，煎 2 次分服。

临床应用：本方用于治疗肺癌多例，均有良好的效果，但不能根治，疗效尚须进一步提高。

解毒泻水汤

处方组成：葶苈子、鱼腥草、蒲公英、徐长卿、蜀羊泉、铁树叶、石见穿、石打穿、白花蛇舌草各 30g，川贝 9g，象贝母 12g，七叶一枝花 15g，王不留行 12g，丹皮 6g，泽泻、猪苓、茯苓、桑白皮各 15g，猫人参 60g（加减：胸胁胀满、气急者加五味子、炙苏子、莱菔子、白芥子、郁金、全瓜蒌；低热起伏加红藤、败酱草、银花、连翘；胸胁疼痛加丹参、赤芍、桃仁、延胡索；口干乏力加石斛、生地、芦根、太子参、黄芪，咳嗽痰粘者加麻黄、紫苑、款冬花、枇杷叶、淡竹沥；胸水加猫人参、葶苈子、大枣、桑白皮）。水煎服，每日一剂，分 2 次服用。

软坚解毒汤

处方组成：鱼腥草、生薏仁、石上柏、蛇舌草、石见穿、生牡蛎各 30g，瓜蒌皮、八月扎、山豆根、夏枯草、龙葵、赤芍各 15g（加减：阴虚痰热者加南沙参、北沙参、天冬、麦冬、炙百部、山海螺、葶苈子、干蟾皮、白毛藤；气阴两虚加黄芪、党

参、白术、北沙参、天冬、生南星、五味子；脾虚痰湿者加党参、白术、茯苓、陈皮、半夏、石打穿、扁豆、半枝莲、焦山楂、焦六曲、补骨脂；阴阳两虚者加仙灵脾、肉苁蓉、锁阳、黄精、天冬、北沙参、山豆根、王不留行、三棱、莪术；咳嗽加前胡、杏仁、象贝、川贝、紫苑、款冬花；痰多加生南星、生半夏、白芥子、礞石；黄痰加桑白皮、黄芩、开金锁、海蛤壳、淡竹沥；痰血加黛蛤散、白芨、芦根、藕节炭、血见愁、血余炭、生地榆、花蕊石、芦根、参三七；喘咳加炙苏子、蚕蛹、黑锡丹；胸痛加望江南、徐长卿、元胡、失笑散、全蝎、蜈蚣；胸水加葶苈子、龙葵、米仁根、猫人参、控涎丹；低热加银柴胡、地骨皮、青蒿、竹叶；高热加生石膏、寒水石、银花、牛黄）。水煎服。每日一剂，分2次服用。

临床应用：本方结合辨证治疗经细胞学或组织学证实的原发性肺癌310例（Ⅲ、Ⅳ期占70%），治后生存一年以上为134例，一年生存率为43.23%；二年生存率为11.29%；3年生存率为5.16%；4年生存率为1.61%；5年生存率为0.64%。治后中位生存期为11.2个月，平均生存期为12.6个月。其中以鳞癌治后生存率为最高，其次为腺癌及未分化癌。治后肿瘤缩小1/2以上，持续稳定半年以上作为显效，其6例；缩小不到1/2或癌灶稳定1年以上者为有效，其146例；无效158例，总有效率49%。治后巨噬细胞吞噬功能、E玫瑰花结形成率、T细胞转化率3项免疫指标检测均显著上升。

化痰散结丸

处方组成：红参、田三七、穿山甲、浙贝母、淫羊藿、射干各200g，菟丝子、破故纸、龟板、黄精、茯苓、巴戟、威灵仙、金樱子各400g，生半夏、生南星、七叶一枝花各300g，天竺黄、海马、五味子、陈皮各100g，上药共研细末，蜜丸，每丸10g，口服每次1丸，每日3次。

临床应用：本方用于中晚期肺癌有效。

平消方

处方组成：仙鹤草 15g，枳壳 18g，净火硝 18g，白矾 18g，郁金 18g，干漆 6g，五灵脂 15g，制马钱子 12g。制成片重 0.45g 片剂，每服 4~8 片，1 日 3 次，3 个月为 1 疗程。

临床应用：治疗 60 例肺癌，显效 8 例，有效 34 例，无效 18 例，总有效率为 70%。

常用于肺癌的中草药

土贝母、生半夏、瓜蒌、半枝莲、白花蛇舌草、生南星、白英、龙葵、山海螺、蜀羊泉、蛇莓、生薏仁、葶苈子、徐长卿、蚤休、礞石、马兜铃、前胡、百部、夏枯草、蟾蜍、生牡蛎、冬虫草、八月扎、石打穿、山慈菇、鱼腥草、守宫、薤白、藤梨根、山豆根、陈皮、野菊花、枳壳、海藻、蜂房、蚕蛹。

三、中西医结合治疗

肺癌的综合治疗是提高疗效的重要手段，经临床实践证明，中西医结合可以互相取长补短，充分发挥各种治疗方法在疾病过程各阶段中的作用。做到在提高机体免疫的前提下，最大限度地抑制或消灭肿瘤细胞。

1. 中药配合手术治疗 肺癌的手术治疗目前仍然是十分重要的治疗方法，但是即使手术方法不断地创新改进，但治疗效果仍不够满意，尤其是术后复发转移等仍威胁患者的健康和生命。所以，手术后配合扶正固本，化瘀消瘤中药，如人参（党参）、黄芪、黄精、山药、冬虫夏草、沙参、天冬、麦冬、五味子、薏仁、南星、半夏、茯苓、蟾蜍、守宫、山豆根、瓜蒌、石见穿、土元、蛇莓、徐长卿、蛇舌草、山海螺、藤梨根、蜀羊泉等辅助治疗可提高生存率及生存质量。

2. 中药配合放、化疗 放射治疗及化学药物治疗也是肺癌治疗的重要手段，对不适合手术治疗和虽经手术切除而未能彻底根治的病人，均可选用放疗或化疗予以补救治疗，同时辅以中药治疗，则可减轻其不良反应及一些并发症从而提高放、化疗疗效。

(1) 局部反应 局部组织损伤有放射性和化学性(化疗药物)两种。

放射性皮肤损伤:放疗可引起局部皮肤反应或损伤,由于程度不同,可出现红斑、脱屑或充血、水肿、水泡、糜烂、溃疡、组织坏死等,且溃疡难以愈合。处理方法:除放射区衣着勿过紧、过硬,避免摩擦与挤压,勿日光曝晒,保持干燥外,对于轻度反应者可用五石散涂撒以消减红肿和止痒。皮肤溃烂或坏死之重度者,可用2%龙胆紫溶液外涂或用生肌败毒散外撒(配方:煅石膏30g,煅龙牡各30g,煅白矾30g,马勃30g,煅珍珠3g,象皮10g,白芨20g,冰片3g,牛黄2g,元寸2g,共为细末,装瓶密封备用),或用冰片蛋清液外涂(一个蛋清+0.5g冰片粉调匀)或外用金黄散、生肌散。

化疗性组织坏死:化学性抗癌药物,对局部组织多有较强的刺激性,注射时不慎漏于皮下,可引起疼痛、肿胀及组织坏死,尤其如氮芥、长春新碱、阿霉素、西艾克、丝裂霉素等为甚。处理方法:对刺激性较强的药物应用时,应先输液,后将药物冲入。一旦出现药液溢出血管外,应立即用生理盐水局部皮下注射加以稀释。如为烷化剂漏于皮下,可用1/6N硫代硫酸钠溶液皮下注射,并用冰袋敷6~12小时。氢化考的松油膏外敷。中药可配合解毒散外敷(青黛30g,煅石膏30g,煅瓦楞子30g,炒土茯苓30g,乳香10g,没药30g,梅片6g,共为细末,蜂蜜或香油调和外敷)。

(2) 全身性反应 消化道反应:此种反应极为普遍,烷化剂和抗生素多引起上消化道反应,且出现早,抗代谢剂常引起上消化道反应,主要症状是饮食减少,口淡无味,恶心、呕吐,腹痛腹泻,胸闷,腹胀,嗝气,呃逆等,舌苔白腻或黄腻,脉滑。此乃邪毒内侵,损及脾胃,致清阳不升,胃气不降所致。治疗可选用旋复代赭汤、香砂六君子汤、藿香正气散等辨证加减治疗,主要药物有:旋复花、代赭石、姜半夏、川厚朴、姜竹茹、生薏

仁、茯苓、佩兰、藿香、陈皮、木香、山楂、六曲、砂仁等，若出现气滞血瘀型脐周围阵发性剧痛或持续性隐痛，大便不通，舌苔腻，质暗，脉弦者可行理气活瘀，选用逍遥散合膈下逐瘀汤加减，常用当归 10g，白术 9g，香附 10g，白芍 24g，炒元胡 15g，炒枳壳 10g，桃仁 10g，川芎 10g，灵脂 10g，蒲黄 10g，青陈皮各 10g。

预防或减轻反应可睡前或空腹服药，并给予镇静剂如安定片 2.5~5mg 一日三次内服。

造血系统反应：造血系统反应为放疗特别是化疗中最常见的反应。机体因受放、化疗毒性影响，骨髓被抑制。主要症状为头昏、头晕、乏力、懒动、白细胞减少，血小板减少，甚或呈全身性贫血，中断治疗，严重者并发感染。辨证治疗，气血两虚，主证：面色㿠白，头晕眼花，心悸不宁，倦怠乏力，毛发脱落，舌胖质淡苔腻脉细无力。治则：补气养血，方药归脾汤加减，常用黄芪 15g，党参 15g，当归 15g，白芍 15g，鸡血藤 30g，虎杖 30g，女贞子 15g，西杞果 30g，陈皮 15g，茜草 30g，补骨脂 10g，红枣 5 枚。脾肾阳虚：主证：头昏乏力，腰肢酸软，面、肢浮肿，纳差，便溏，毛发脱落，舌淡胖，脉沉细。治则，温补脾肾。方药：肾气丸加减。常用仙灵脾 10g，补骨脂 15g，山萸肉 15g，五味子 15g，党参 10g，黄芪 10g，鸡血藤 30g，虎杖 30g，熟地 30g，鹿角胶 15g，红枣 5 枚，山药 30g。肝肾阴虚，主证：头晕耳鸣，心烦不眠，腰酸腿软，五心烦热，颧红盗汗，口干尿赤，舌质红少苔，脉细数。治则，滋补肝肾，方药大补阴丸或一贯煎加减。常用沙参 30g，生地 15g，女贞子 15g，旱莲草 30g，黄精 30g，山萸肉 15g，知母 10g，寸冬 15g，阿胶 10g，玄参 10g，鹿角胶 10g，龟板胶 10g，鲜石斛 15g。

(3) 其他炎症反应 口腔、咽喉炎，主证：口腔、咽或喉部疼痛，粘膜溃烂，口干，欲饮冷水，大便干，小黄赤，舌质红，苔黄腻或干燥，此属热毒上炎，灼伤津液所致，治以清热解毒，

养阴生津，常用沙参 30g，麦冬 15g，生地 15g，元参 15g，花粉 15g，丹皮 15g，焦栀子 15g，二花 15g，公英 15g，地丁 15g；或用六神丸 3 次/日，10 粒/次；或喉症丸 3 次/日，10 粒/次。或用冰硼散、锡类散外用，或用复方五倍子散：漱口（五倍子 10g，枯矾 10g，薄荷冰 10g，开水溶化 100ml，每日数次漱口），或用溃疡散（珍珠粉 2g，煅白矾 3g，煅龙牡各 3g，象皮 3g，马勃 3g，白芨 3g，梅片 3g，共为细面装瓶备用），外撒 2~3 次/日，还可用水片 2g 枯矾 4g，小磨油 100ml，混合外用。

直肠炎：主证为下腹部疼痛，里急后重，形似痢疾，小便短赤，舌质，苔黄腻，脉数。此属下焦热毒蕴结，湿热下注大肠所致。治以清热燥湿。方药：白头翁汤加减。常用白头翁 15g，秦皮 15g，黄连 9g，黄柏 9g，木香 9g，赤芍 9g，地榆 30g，金银花 15g，马齿苋 60g，败酱草 24g，白芍 15g，焦山楂 15g，乌梅 10g；或用香连丸 3 次/日，3~6g/次；或穿心莲片 3 次/日，6 片/次；或元胡止痛片，3 次/日，2~3 片/次。

膀胱、尿道炎（放疗、斑蝥、喜树碱、环磷酰胺等化疗药物均可引起），主证有小腹疼痛，排尿不畅，尿急，尿频，尿痛，尿烧灼感，尿血等似尿路感染，舌红，苔黄腻，脉细数，此属热毒蕴结下焦，湿热下注膀胱所致。治以清热利湿通淋。方药八正散合导赤散加减。常用篇蓄 30g，瞿麦 24g，生地 15g，木通 10g，海金沙 15g，滑石 15g，甘草梢 10g，白茅根 60g，金钱草 30g，小蓟 30g，琥珀 3g（冲），郁金 9g，白芍 18g，元胡 10g，旱莲草 30g；或用白糖 30g，绿豆衣 60g，煎水内服；或用马齿苋 60~120g，白茅根 60~120g，甘草 10g，煎水加白糖内服。

肺及纵隔炎：肺癌患者在接受放疗时可引起“放射性肺炎及纵隔炎；平阳霉素化疗可引起急性化学性肺炎及慢性肺纤维化”。临床主要表现为咳嗽、胸痛、发热、紫绀、哮喘、呼吸困难等，舌质红，苔黄腻，此为热毒伤肺，肺失肃降所致。治以清

热解毒、养阴润肺。方药：养阴清肺汤加减，生地 10g，麦冬 10g，元胡 12g，丹皮 10g，天冬 15g，贝母 12g，生百合 30g，天花粉 15g，鱼腥草 30g，白花蛇舌草 30g，生薏仁 30g，苇茎 15g，茯苓皮 30g，白茅根 30~60g，瓜蒌皮 30g，赤芍 15g。或用麻杏石甘汤加减，还必须配合西医药治疗。

脊髓炎：放射线可损伤脑和脊髓神经，引起放射性炎症，氟脲密啶、光辉霉素、长春新碱、秋水仙碱、鬼臼毒类对周围神经有明显毒性，二者均可引起瘫痪、感觉减退、腱反射低下、肠麻痹、便秘、小脑共济失调、位置性低血压等。辨证治疗，肝肾阴虚：主证为起病缓，肢体逐渐软弱失运，腰膝酸软，肌肉萎缩，头晕眩，舌红少苔，脉细数，治以补益肝肾、滋阴清热，方药：虎潜丸加减，常用熟地 15g，知母 10g，黄柏 10g，龟板 15g，锁阳 10g，牛膝 10g，虎骨 10g，当归 10g，白芍 15g，首乌 15g，鸡血藤 30g，鹿角胶 10g。湿热浸淫：主证为肢体痿软无力，微肿、麻木、胸闷烦热，身重困倦，发热，小便少黄，舌质红苔黄腻，脉濡或数。治以清利湿热。方药以二妙散加味，苍术 10g，黄柏 10g，防己 10g，萆薢 15g，龟板 15g，牛膝 12g，秦艽 10g，当归 10g。脾气虚弱，主证为精神不振，不思饮食，肢体软弱，肌肉萎缩，舌淡苔白，脉细弱。治以健脾益气，方药选用补中益气汤加减。常用黄芪 30g，党参 15g，白术 10g，当归 12g，陈皮 10g，升麻 6g，柴胡 10g，甘草 6g。肾阳不足，主证有下肢痿软发凉，肌肉消瘦，舌淡少苔，脉沉细。治则温补肾阳，强壮筋骨，方药可选用金刚丸加减，常见菟丝子 30g，肉苁蓉 24g，萆薢 15g，木瓜 10g，牛膝 15g，杜仲 15g，党参 15g，附子 10g，或用复方灵芝片每次 6 片，每日三次口服，或用启痿丸内服治疗（人参 30g，黄芪 30g，补骨脂 30g，肉苁蓉 30g，菟丝子 30g，虎骨 30g，薏米 60g，核桃仁 30g，百合 30g，杜仲 30g，狗脊 30g，白术 30g，当归 30g，灵芝 60g，鸡血藤 60g，赤芍 30g，牛膝 30g，紫河车 60g，鹿茸 6g，贝母 30g，冬虫草

30g，红枣肉 30g，黑芝麻 60g，刀豆子 30g，黑豆 60g，王不留行 30g，制马钱子 10g，山萸肉 30g，炮山甲 30g，山药 30g，共碾细面，炼蜜为丸，每丸重 10g，每日三次，每次 2 丸。

【预后】

影响肺癌预后的因素很多很复杂，主要与患者精神状态，肺癌的病理组织学类型，肿瘤生长部位和生长速度以及治疗方法均有关。总之，目前死于肺癌的人多于任何其他型癌，治疗方法和早期发现的努力还未得到令人满意的结果。控制肺癌的长期研究计划应包括控制吸烟这一初级预防。

第九章 胃 癌

【概述】

胃癌是世界上发病率较高的恶性肿瘤之一，据国际抗癌联盟估计全世界年发病人数约 68 万。其中发病率较高的国家有日本、智利、哥斯达黎加等国，而美国、澳大利亚、新西兰等国发病率较低。胃癌调整死亡率最高的国家是日本达 39.29 / 10 万人口。其中男性为 54.51 / 10 万人口，女性为 27.50 / 10 万人口。美国胃癌死亡率最低，仅 4.98 / 10 万人口，男性 7.05 / 10 万人口，女性 3.42 / 10 万人口。

我国胃癌发病率也较高，据卫生部统计资料，我国胃癌调整死亡率为 15.41 / 10 万人口，其中男性 20.93 / 10 万人口，女性 10.16 / 10 万人口。每年死于胃癌者约 16 万人，占有恶性肿瘤死亡率的 23.03%，居全部恶性肿瘤之首位。我国幅员辽阔，各省之间胃癌调整死亡率差异很大，青海省最高为 40.62 / 10 万人口，广西最低为 5.16 / 10 万人口。胃癌死亡率在不同年龄组差异很大，随年龄呈上升趋势。20 岁以下少见，70~75 岁最高，平均死亡年龄为 61~62 岁。死亡性别比在 25 岁以前差异不大，25 岁以后男性高于女性，比值在 1.8~3.28 之间。

胃癌的病因目前尚不清楚，但研究认为主要与以下因素有关：慢性胃部病患（胃酸缺乏、萎缩性胃炎、胃溃疡、胃息肉、肠上皮化生），饮食习惯（嗜食熏制和腌制食物，少食蔬菜），环境因素（硝酸盐和二级胺含量高，微量元素失调），以及情绪因素和遗传因素等。

胃癌根据其进展情况可分为早期胃癌和进行期胃癌，早期胃癌不易发现，我国临床早期胃癌发现率约占所有胃癌病例的 5%，一般所说胃癌主要是指进行期胃癌。早期胃癌又称表浅型

胃癌凡癌限于粘膜内及粘膜下层者均为早期胃癌。癌灶发展超过此范围者，则为进行期胃癌。

早期胃癌症状主要表现为不太明显的上腹痛，有时会伴有较轻的腹胀、反酸、消瘦、食欲不振等症状。当病情发展到进行期时，原有症状随之加重，其中上腹痛和消瘦最常见，另外还会出现恶心、呕吐、黑便等症状。到晚期则可出现贫血、腹水、恶病质等。由于早期胃癌症状不明显甚至没有症状，当病变进展到一定程度后才出现明显症状，但亦非胃癌特有，常与慢性胃炎、胃溃疡相似，极易引起误诊、误治，当出现胃癌的典型症状时，往往已到晚期。因此，临床医生应在症状不明显时或从一般胃病症状中，警惕胃癌的存在，尽可能早期诊断，早期治疗。

胃癌从早期发展到进行期，目前平均时间为 37 个月，平均 5 年生存率约 64%，平均生存时间为 77 个月。而进行期胃癌从发病到死亡自然生存期为 12 个月，从就诊到死亡率平均生存期为 4.2 个月。

胃癌发病部位以胃窦部最多见，占 50%，胃体小弯侧占 25%，胃体其它部位和胃底占 15%，贲门部占 10%。胃癌（进行期）大体分型为六型：结节蕈伞型，盘状蕈伞型，局部溃疡型，浸润溃疡型，局部浸润型和弥漫浸润型。组织病理分类较多，其中 90% 以上为腺癌，包括乳头状腺癌，管状腺癌，粘液腺癌，印戒细胞癌。其它类型可见腺鳞癌、鳞癌、类癌、未分化癌等。胃癌扩散方式以直接蔓延和淋巴道转移为主，晚期常见血行转移。胃癌的器官转移以肝脏最常见达 38.1%~46.5%，肺脏次之为 20%~32.2%，其它也常见胰脏、肾上腺、骨等器官转移。

在祖国医学历代文献中，虽然没有见“胃癌”的病名记载，但有许多与胃癌临床表现一致或相似的病证论述。

胃癌早期在临床上出现的较轻微的上腹部胀满、隐痛、食欲不振等症状，祖国医学认为多属“胃胀”、“痞满”、“胃脘痛”、“心

痛”、“腹胀”等病证。《素问·至真要大论》中说：“阳明之复，清气大举，甚至心病痞满，腹胀而泄，呕苦，咳哕烦心，病在鬲中。”《灵枢·胀论》中记载：“胃胀者，腹满胃脘痛，鼻闻焦臭，妨于食，大便难”。这些论述，与胃癌早期症状颇相一致。胃癌中期的临床表现除原有症状加重外，还可出现消瘦、恶心、呕吐、呕血、黑便、腹泻等症状，有些病在胃底贲门部还出现咽下困难的表现。在此阶段，可与“胃风”、“反胃”（胃反、翻胃），“噎膈”等病证相应。《素问·风论》：“胃风之状，颈多汗，恶风，食欲不下，鬲塞不通，腹善满，失衣则瞋胀，食寒则泄，胗形瘦而腹大”。这与胃癌发展到中、晚期的症状较一致。《金匱要略》中说：“趺阳脉浮而涩，浮则为虚，虚则伤脾，脾伤则不磨，朝食暮吐，暮食朝吐，宿谷不化，名曰胃反”。这种情况可在胃窦癌梗阻幽门时出现。《素问·六元正纪大论》中说：“木郁之发，民病胃脘当心而痛，上支两胁，鬲咽不通，食欲不下”。表现出贲门胃底癌阻塞贲门时症状。胃癌晚期以上症状日渐加重，同时大多可扪及上腹部肿块，并伴有腹水、水肿等表现。对此，中医将其归入“积、聚、症、瘕”，“鼓胀”，“水肿”等病证的范畴。《难经》中记载：“心之积，名曰伏梁。起脐上，大如臂，上至心下，久不愈，令人病烦心”。“脾之积，名曰痞气，在胃脘，覆大如盘，久不愈，令人四肢不收，发黄疸，饮食不为肌肤。”这与晚期胃癌肿块日益增大的表现相似。《灵枢·水胀》中说：“鼓胀如何？歧伯曰：腹胀身皆大，大与肤胀等也”，色苍黄，腹筋起，此其候也。”《医门法律》中指出：“凡有症瘕、积聚、痞块，即是胀病之根，日积月累，腹大如箕，腹大如瓮，是名单腹胀”。如胃癌晚期侵犯其它脏器，或远处转移，则根据表现，当纳入相应的病证中。

在祖国医学历代文献中，虽然可以全面、详尽地把胃癌的各种临床表现包括在内，而且在病因、病机、治则、方药等方面也有许多极有参考价值的论述。但是，由于历史的原因，历代医学

不可能对胃癌有一个系统、深入的认识。因此，上述病证中固然包括有胃癌，但也含有许多其它疾病，我们在参阅历代文献中必须认真区别。临床治疗上也必须详查病情，在现代医学确诊的基础上，根据具体表现给予治疗，只有这样才不失祖国医学辨证施治之精髓。

【病因病机】

胃癌的病因很多，祖国医学将其分为两大类。外因以六淫邪毒和饮食不节为主；内因则常见情志所伤，烦劳过度，久病大病，误治伤正和禀赋不足等几个方面。其中外感邪毒、饮食不节和情志所伤是导致本病的主要原因，内在病因是正虚。导致发病则是多种病因综合作用的结果。早期胃癌常见胃脘痛，朱丹溪在《脉因证治》中论述其病因说：“劳役太甚，饮食失节，中气不足。或寒邪乘虚而入客之，或久不散郁而生热，或素有热，虚热相搏，结郁胃脘而痛。或有实热痰饮，或气与食相郁不散，停结胃口而痛。”随着病情进展，胃癌出现“积聚”、“反胃”时，往往已成中晚期。巢元方在《诸病源候论》中说：“积聚痼结者，是五脏六腑之气已积聚于内，重因饮食不节，寒温不调，邪气重沓，牢痼盘结者也，若久即成。张介宾在《景岳全书》中也认为：“积聚之病，凡饮食气血风寒之属，皆能致之。”对于“反胃”张仲景在《金匱要略》中说：“……以发其汗，令阳微，膈气虚，脉数，数为客热，不能消谷，胃中虚冷故也。脉弦者虚也。胃气无余，朝食暮吐，暮食朝吐，变为胃反。”《诸病源候论》中也指出：“荣卫俱虚，其血气不足，停水积饮在胃脘则脏冷，脏冷则脾不磨，脾不磨宿食不化，其气逆而成胃反也。”由以上历代文献的一些论述中可以看到，本病的病因是多方面的，多种病因作用于机体后，则产生一系列病理变化，最后导致胃癌，兹分述如下：

一、外感邪毒 六淫邪毒内侵，正气不足以祛邪，致使外邪久留不去，伤及脏腑，阻滞气机，气血不畅，痰湿内生，瘀血留滞，而成积聚，发为本病。《灵枢·五变篇》中说：“肠胃之间，

寒温不次，邪气稍至，蓄积留止，大聚乃起，由寒气在内所生也，血气虚弱，风邪搏于脏腑，寒多则气涩，气涩则生积聚也。”张介宾在《景岳全书》中也认为：“风寒外感之邪，亦能成积，如经云虚邪之中人也，留而不去传舍于肠胃之外，募原之间，留著于脉，息而成积。”而且他还进一步指出：“风以致积，积成而证已非风。故治此者，当治其所留。”明确了肿瘤发生的因果关系和治疗方向。

二、饮食不当 脾胃主司受纳饮食，运化水谷，故饮食不节，最易伤脾胃。饮食不节归纳起来有三种：过饱过饥，饮食不洁和饮食偏嗜。这三种情况均可损伤脾胃，使胃不受纳，脾失健运，运化失司，不能输布水谷精微，反而溢生水湿之邪，湿浊内停，聚而成痰，痰湿阻滞气机，血行不畅，脉络壅塞，瘀血内停，痰浊与气血搏结成块，发为积聚，积聚在胃而成胃癌。《素问·痹论》中说：“饮食自倍，脾胃乃伤。”《太平圣惠方》中认为：“夫人饮食不节，生冷过度，脾胃虚弱，不能消化，与脏气相搏，结聚成块，日渐生长，盘牢不移。”在《圣济总录》中也指出：“脾胃虚弱，饮食累伤，积久不去结在肠内，与正气交争则心腹鞭痛，妨碍饮食，肢体消瘦，以手按之，积块有形。”以上论述指出，无论是饮食不节引起的脾胃虚弱，还是脾胃虚弱在先饮食伤于后，均可导致本病的发生。

三、情志所伤 人的精神情志活动，祖国医学以“七情”概括之，即喜、怒、忧、思、悲、恐、惊。并认为长期或强烈的精神刺激，可造成机体气机紊乱，脏腑失调，气血不畅，引起痰湿瘀血内停，进而导致本病的发生。正如《素问·疏五过论》中所说：“离绝菀结，忧恐喜怒，五脏空虚，血气离宗”。《重订严氏济生方》中也指出：“有如忧、思、喜、怒之气，人之所不能无者，过则作乎五脏……传克不行，乃留结而为五积”。在七情中，思、怒、忧三种情志失常与胃癌的发病关系较密切。《素问·阴阳应象大论》中说：“思伤脾。”《素问·举痛论》中又说：“思则气

结。”“思则心有所存，神有所归，正气留而不行，故气结。”指出了思虑过度可导致气结而伤脾。怒则伤肝，横克脾土。正如《素问·六元正纪大论》中所说：“木郁之发，民病胃脘当心而痛。”《景岳全书》也说：“必先怒时挟食，致伤脾胃，故但有所犯，即随触而发，此肝脾二脏之病也，盖以肝木克土，脾气受伤而然”。忧则包括忧思、忧郁，忧思过度则气结伤脾，忧郁过度则气郁伤肝，这些因情志失调而致的气机紊乱，则可产生一系列病理变化，最终可能导致胃癌。《诸病源候论》中在论及“痞噎病”时说：“此由忧恚所致，忧恚则气结，气结则不宣流，使噎。”《太平圣惠方》中也认为：“喜怒气逆，思虑伤心，致使阴阳不和，胸膈痞塞，故名膈气。”《金匱翼》中也说：“气滞成积，凡忧思郁怒，久不得解者，多成此疾。”《吴少怀医案》对其病机作了简明而又肯的阐述：“积是由于气郁而湿滞，湿郁而生热，热郁而痰结，痰郁而血凝，血郁而食不化，食积而积成，此六者相因而致病。”总之，情志内伤可致气机紊乱，脏腑功能失调，进而使气血津液失常，或因水湿运化失司而生痰聚，或以血脉壅塞不畅而成瘀血，痰湿、瘀血搏结于胃，则发为本病。

四、正气虚损 祖国医学认为，人之所以发病与正气虚损直接有关。正如《素问》中所说：“正气存内，邪不或干。”“邪之所凑，其气必虚。”胃癌的发病也是这样。《医宗必读》中说：“积之成也，正气不足，而后邪气踞之。”《中藏经》中也说：“积聚症瘕杂出者，皆五脏六腑真气失而邪气并，遂乃生焉。”虚损是以脏腑元气亏损，阴阳精血不足为主要病理过程的一类慢性虚衰性病证的总称。《医碥》中认为：“虚者，血气不中也，久则肌肤脏腑亦渐消损，故曰虚损。”虚损病因很多，《景岳全书》中认为：“色欲过度者多成劳损”。“劳倦不顾者多成劳损。”“少年纵酒者多成劳损”。“疾病误治及失于调理者，病后多成虚损。”其病因概括起来大抵有以下三种：体质因素（包括先天不足和年高体衰）、生活因素（包括劳倦过度、饮食不节和情志内伤）、疾病因素（包括

大邪伤正，调护不当和误治失治)。一种或多种病因作用于机体，致使脏腑气血亏虚，进而虚邪内侵，留滞不去，则气机紊乱，痰浊瘀血内生，痼结不散，发于胃及脏而成胃癌。《诸病源候论》中说：“积聚者，由阴阳不和，脏腑虚弱，受于风邪，搏于脏腑之气所为也。”《景岳全书》中也认为：“脾肾不足及虚弱失调之人，多有积聚之病。”《活法机要》中指出：“脾胃怯弱，气血两衰，四时有感皆能成积”。总之，胃癌病因虽多，但正气虚损无疑是核心所在。

由以上论述可以看到，胃癌的病因是多方面的，而且常常是多种病因综合作用的结果。机体在多种病因的作用下，产生一系列病理变化，出现痰浊、瘀血，进而凝聚成块，发为胃癌。我们通过对其病理变化过程的分析发现，无论何种病因，均先导致痰凝或瘀血而后发病。现代中医认为，痰湿和瘀血是“第二病因”或称为“继发性病因”。是机体病变过程中的病理产物，这种病理产物不仅可以使原有病情加重，更能够进一步导致其它多种疾病。胃癌的产生正是痰湿或瘀血，或是两者共同作用的结果。正如《灵枢·百病始生篇》所说：“六输不能，湿气不行，凝血裹里而不散，津液涩渗，著而不去，而积皆成矣。”明确提出积聚的产生是痰湿、瘀血直接作用的结果。《丹溪心法》中也说：“凡人身上中下有块者，多是痰。”《临证指南医案》中也认为：“胃痛久而屡发，必有凝痰聚瘀。”

综上所述，在胃癌的发生过程中，外邪、饮食和情志等因素是直接病因，而痰湿与瘀血则是关键，正气虚损是其核心。

【治疗】

一、辨证施治

(一) 肝胃不和型

【主证】胃脘胀痛，攻撑两胁，食少纳呆，暖气陈腐，或呃逆呕吐，舌质淡红，苔薄白，脉弦。

【分析】本型辨证要点是肝郁气滞。肝喜条达，恶抑郁，肝

气郁结则横逆犯胃。气机郁滞故胃脘胀满；郁阻不通故疼痛；两胁为肝之分野故气郁攻撑两胁胀痛；肝克脾土，脾失健运故食少纳呆，暖气陈腐；若胃失和降，胃气上逆则可见呃逆、呕吐；舌淡红，苔薄白，脉弦为肝郁气滞之征。

【治则】舒肝和胃，降逆止痛。

【方药】柴胡疏肝散合旋复代赭汤加减。

【方解】柴胡疏肝散源于《景岳全书》，旋复代赭汤源于《伤寒论》。方中柴胡、枳壳疏肝解郁，调畅气机；川芎、香附和血理气止痛；芍药、甘草酸甘柔缓，舒肝和中止痛；旋复花、代赭石降逆止呕。

【加减】气机郁甚，疼痛较重者，加川楝子、元胡；腹胀者加大腹皮、川朴；食少纳呆甚者，加白术、焦三仙。

【变证】

1.气机化热：肝郁气滞，日久不解，最易化热，证见胃脘疼痛，胸痞胁胀，嘈杂泛酸，口干口苦，烦躁易怒，便秘溲赤，舌红苔黄，脉弦数。治宜清热解郁，和中止痛。方用化肝煎加减（丹皮、栀子、白芍、青皮、陈皮、泽泻、贝母），或用丹栀逍遥散加减（丹皮、栀子、柴胡、当归、白芍、白术、茯苓、甘草）。

2.胃热伤阴：肝郁化热，灼伤胃阴。证见胃脘灼热，嘈杂疼痛，痞满吞酸，食后痛增，口干咽燥，五心烦热，大便干结，舌红少苔而黄，或舌红绛无苔，脉细数或滑数。治宜清热养阴，和胃止痛。方用麦门冬汤（麦冬、人参、半夏、甘草、粳米、大枣）或竹叶石膏汤（淡竹叶、生石膏、半夏、麦冬、人参、炙甘草、粳米）加减。

3.气滞痰凝：肝郁气滞，脾失健运，水湿运化失调，痰气互结于胃脘。证见胃脘闷痛，恶心痞满，口淡厌食，有时呕吐痰涎，腹胀便溏，舌苔白腻，脉弦滑。治宜解郁化痰，和胃止痛。方用越鞠丸（苍术、香附、川芎、六曲、山栀）加二陈汤（半

夏、陈皮、茯苓、甘草) 加減。

4. 气滯血瘀：肝郁气滯，血行滯澀，久而成瘀。证见胃脘疼痛，胀痛或刺痛，痛点固定，心烦易怒。嗳气频频，舌红有瘀点或瘀斑，苔白，脉弦或澀，治宜疏肝理气，活血通络。方用手拈散（五灵脂、没药、元胡、香附）加減。

（二）瘀毒内蕴

【主证】胃脘刺痛，心下痞硬拒按，食后痛增，吐血便血，肌肤甲错，舌质暗紫，或见瘀斑，苔少或黄，脉沉细澀。

【分析】本型辨证要点是血瘀胃络，或气滯，或寒凝，或热伤均可导致血瘀胃脘。瘀血为有形之邪，瘀于胃脘，故胃脘刺痛，心下痞硬拒按；饮食入胃，触动瘀邪故食后痛增；瘀伤胃络故吐血便血；瘀阻中焦，运化失职，气血乏源，肌肤失于濡养故肌肤甲错；舌质紫暗，有瘀斑，苔少或黄，脉沉细澀均为血瘀胃络之征。

【治则】解毒祛瘀，活血止痛。

【方药】膈下逐瘀汤加減。

【方解】膈下逐瘀汤源于《医林改错》。方中桃仁、红花、五灵脂，活血化瘀；赤芍、丹皮凉血活血，当归、川芎养血活血；乌药、元胡、枳壳理气解郁止痛；甘草调和诸药而和中。

【加減】吐血便血甚者加三七、仙鹤草、藕节炭；腹满便秘者加大黄、麻仁；食后痛剧者加砂仁、川楝子。

【变证】

1. 瘀毒化热 血瘀胃络，日久化热。可兼见五心烦热，口干欲饮，或胃脘灼热刺痛，舌红有瘀斑，苔黄，脉沉细数。治宜清热凉血，活血化瘀。方用清胃散（黄连、当归、生地、丹皮、升麻）合失笑散（五灵脂、蒲黄）加減。

2. 痰瘀互结 或痰凝中焦，气滯血瘀；或血瘀胃络，水凝成痰，致痰瘀互结。其证可兼见脘腹胀满，呕吐宿食不化，挟有痰涎，苔白滑或白膩。治宜活血化瘀，化痰散结。方用失笑散合

二陈汤加減。

（三）气虚血瘀

【主证】胃脘疼痛，心下痞满，食欲不振，有时食入反出，体倦乏力，心悸自汗，吐血黑便，肌肤甲错，舌淡有瘀点或瘀斑，苔薄白，脉细涩无力。

【分析】本型辨证要点是气虚而血瘀。或血瘀日久，耗气伤正，或高年久病体衰而气虚，使血运无力，瘀于胃络。脾失健运，胃不受纳，运化无力，故心下痞满，食欲不振，食入反出；脾胃虚弱，生化乏源，真气不足或体倦乏力，心悸自汗；气虚不能摄血，血溢常道，故吐血便血；气血乏源，肌肤失于濡养故肌肤甲错；舌淡有瘀斑、瘀点，苔薄白，脉细无力等均为气虚血瘀之征。

【治则】益气健脾，活血止痛。

【方药】四君子汤合当归须散加減。

【方解】四君子汤源于《和剂局方》，当归须散源于《原病论》。四君子汤中人参补气健脾，使运化有力；白术健脾燥湿，使运化无碍；茯苓健脾渗湿；甘草补中和胃；共奏益气健脾之效。当归须散中当归、桃仁活血养血而润燥；红花、赤芍、苏木活血化瘀，通络止痛；乌药、香附理气活血而止痛。诸药合用则建活血止痛之功。

【加減】血虚者加熟地、首乌、阿胶；胸胁痛者加郁金、木香；食入复出者加旋复花、代赭石；脾肾阳虚者加附子、干姜。

【变证】

气虚痰凝 脾运无力，水湿凝聚。主证除气虚证外，兼见胃脘闷痛，恶心痞满，呕吐痰涎，舌淡，苔白滑腻，脉弦滑。治宜益气健脾化痰。方用四君子汤合二陈汤加減。

（四）脾胃虚寒

【主证】胃脘隐痛，喜按喜温，脘腹胀满，时呕清水，或朝食暮吐，暮食朝吐，面白无华，神疲肢冷，便溏浮肿，舌淡体

胖，苔白滑润，脉沉缓或沉细。

【分析】本型病机要点是脾虚胃寒。脾胃虚寒，中焦失于温养故胃脘隐痛，喜按喜暖；中焦运化无力，枢机为之痞塞故脘腹胀满；水运失调，寒饮内停于中焦故时呕清水；脾失健运，胃失和降，不能腐熟运化水谷而止逆，故朝食暮吐，暮食朝吐；脾胃虚弱，水谷精微不得运化，气血乏源，营卫俱虚故面白无华，神疲肢冷；脾阳不足，水湿运化失常，故便溏浮肿；舌淡体胖，苔白滑，脉沉缓或沉细等均为脾虚胃寒之征。

【治则】温中散寒，健脾和胃。

【方药】理中汤加減。

【方解】理中汤源于《伤寒论》。方中干姜温运中焦以振脾阳；人参补气健脾以司运化；白术健脾燥湿和胃；炙甘草补脾和中，调和诸药。临床单用此方略嫌不足，常随证加減。

【加減】阳虚较重者加附子、肉桂；常吐清水痰涎者加吴茱萸、半夏、陈皮；呕吐甚者加旋复花、代赭石；腹胀甚者加木香、砂仁；便溏甚者加炒薏苡仁、柯子肉；浮肿者加木通、金钱草；神疲乏力甚者加黄芪、山药。

【变证】

1.脾肾阳虚 脾阳久亏，累及肾阳亦虚；或年高、久病肾阳已衰，无力温煦脾阳。证见胃脘隐痛，泛吐清涎，朝食暮吐，暮食朝吐，吐出物澄彻清冷，完谷不化，形寒畏冷，腰膝冷痛，面色泛白，神疲欲寐，或腹胀飧泄，舌淡，苔白，脉沉细或微细沉迟。治宜温补脾肾。方用六味回阳饮（人参、炮附子、炮干姜、熟地、当归、炙甘草）加減。

2.寒饮内停 脾胃虚寒，不能温化水湿，寒饮停于中焦。证见胃脘隐痛，食入复出，挟带痰涎，或呕吐清水痰涎，脘痞食少，心悸头晕，口渴不欲饮，舌淡，苔白滑腻，脉弦滑。治宜温阳化饮。方用茯苓泽泻汤加減（白术、生姜、茯苓、泽泻、桂枝、甘草）。

（五）气血双亏

【主证】胃脘疼痛，肿块增大，食欲甚差，面黄无华，唇甲色淡，乏力懒言，心悸气短，头晕目眩，虚烦不眠，自汗盗汗，脉沉细无力，舌淡苔少。

【分析】本型病机要点是气血俱虚，久病不愈，耗气伤血。故邪盛与气虚血虚证并见。病邪日盛，故胃脘疼痛加重，肿块日渐增大；气虚可见乏力懒言，食欲甚差，心悸气短，自汗等证；血虚可见面黄无华，唇甲色淡，头晕目眩，虚烦不眠，盗汗等证；舌淡苔少，脉沉细无力为气血双亏之征。

【治则】补气养血

【方药】八珍汤加减。

【方解】八珍汤源于《正体类要》。方为四君子汤与四物汤配合而成。方中以四君子汤之人参、白术、茯苓补气健脾；以四物汤之熟地、当归、白芍、川芎养血调血；以炙甘草调和诸药。共达补气养血之效。

【加减】纳呆甚者加焦三仙、木香、砂仁；口燥而渴者加石斛、天花粉腹水者加猪苓、车前子、大腹皮；偏于气虚者加黄芪、山药；偏于血虚者加首乌、阿胶；兼见肢冷畏寒等阳虚证者加附子、肉桂、巴戟天；兼见五心烦热等阴虚证者加生地、沙参、地骨皮；兼见胸脘痞满、呕吐痰涎等痰湿证者加南星、半夏、川贝。

【变证】

1. 中气大亏 气血俱虚，中气亏甚。主证除气血俱虚外，兼见少腹坠胀，便溏或泄泻。治宜补中益气养血。方用补中益气汤（黄芪、人参、白术、炙甘草、当归、陈皮、升麻、柴胡）合四物汤加减。

2. 干血虚劳 气血双亏，瘀血内结。证见胃脘疼痛，肿块坚大拒按，羸瘦腹满，或见腹水，肌肤甲错，面目黧黑，食少纳呆，乏力气短，头晕目眩，自汗盗汗。或午后潮热，舌暗或青

紫，有瘀斑，苔少，脉细涩。治宜益气养血，活血化瘀。方用百劳丸（人参、当归、水蛭、土元、桃仁、大黄、乳香、没药）加减。

3. 阴阳俱虚 本证为气血双亏的进一步恶化，阴阳两衰，五脏俱虚。可兼见精神萎靡，形寒肢冷，小便清长，下利清谷，骨蒸劳热，汗出不止，甚者神情木然，或昏迷，脉沉细微弱或脉微欲绝。病急当先回阳救逆，参附汤加减。病缓则应益气养血，滋阴壮阳，培补五脏。方用补天大造丸加减（人参、黄芪、白术、当归、枣仁、远志、白芍、山药、茯苓、枸杞子、熟地、紫河车、鹿角胶、龟板胶）。

【按语】 我们根据临床征象，并参考文献资料将胃癌分为五个主要证型和十二个次要证型，希望以此从整体上把握胃癌的辨证分型治疗，起到提纲挈领的作用。但是，由于客观条件不同，患者个体差异较大，临床情况千变万化，以十几个证型概括全部胃癌是不可能的。因此，临床上仍以辨证施治为原则，在以上证型的基础上，具体情况具体对待。

以上辨证分型治疗是一般常规用药，临床治疗时还要加入抗癌药物以增强抗癌祛邪作用，提高疗效。常用治疗胃癌的抗癌中药有：龙葵 20~30g，半枝莲 30~40g，蛇舌草 30~40g，苦参 10~30g，草河车 30~50g，漏芦 10~15g，藤梨根 20~50g，大黄 3~10g，天龙 1~3g，水蛭 1~3g，石见穿 15~30g，急性子 10~30g，莪术 10~30g，铁树叶 10~30g，斑蝥 1~3g，海藻 15~30g，半夏 15~30g，瓜蒌 10~30g，黄药子 15~60g，石打穿 15~30g，半边莲 30~60g，薏苡仁 30~60g，八月扎 10~30g，马钱子 1~3g，菝葜 30~60g，蜣螂 3~10g，蟾皮 10~15g 等。可根据其性味、功效辨证加减用药。

在胃癌的治疗过程中，应时时把握好扶正与祛邪的轻重关系。在进行期（包括Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ期）胃癌中，肝胃不和型多在Ⅱ期中出现。瘀毒内蕴型在Ⅱ、Ⅲ期多见。此时正邪关系多呈正强

邪弱的状态。治疗应以攻邪为主，扶正为辅。气虚血瘀型在临床上最常见，以Ⅲ期为主，Ⅱ、Ⅳ期中也可见到。此时正邪常呈均势，治疗则应攻补兼施。脾胃虚寒型在Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ期均可见到，以Ⅳ期居多，气血双亏型则多为Ⅳ期。胃癌发展至此已属晚期，呈邪盛正虚状态。治疗也应扶正为主，攻邪为辅，甚至暂不攻邪。中医分型与胃癌分期有一定的内在联系，但在临床上并非如此明晰。因此，在临床上应以辨中医证型为主，同时参考胃癌分期以把握其发展趋势。

二、单方、验方、成方（药）

（一）单方

- 1.向日葵杆白芯：每日6g，煎汤代开水饮用。
- 2.断肠草（胡蔓藤）：每日30g，煎汤代开水饮用。
- 3.藤梨根：每日80g，加1000ml，文火煎3小时，每日早期分服。
- 4.柘木：每日30~100g，水煎服，每日早期分服。
- 5.白鹅血：将白鹅头斩掉，患者即口含鹅颈吸吮热血，5~10日服1次。若无白鹅可用白鸭代替。
- 6.斑蝥鸡蛋：将鸡蛋上方凿一小孔，现将斑蝥一只（去翅）塞入鸡蛋中，纸封口，蒸熟或用火煨熟，每日服一个。连用30天为一疗程。如每日一个无毒副作用，可每日服二个。此方用于体质尚好者，体虚者禁用。
- 7.壁虎鸡蛋：将斑蝥鸡蛋中斑蝥改为壁虎一条（小者二条），制法用法同斑蝥鸡蛋。

（二）验方

- 1.参赭培气汤：生赭石30g，太子参15g，生山药20g，天花粉20g，天门冬15g，生桃仁10g，红花6g，土元5g，三七6g（冲服）水煎服，每日早期分服。
- 2.人参四虫和阳散：桔络、炮姜、生半夏各64g，生南星、仙灵脾、炒白术、茯苓、生牡蛎、鱼鳔（炒）、人参、补骨脂、

土元、水蛭、全蝎、蚕茧各 128g，共研末备用。每次 3g，与白蜜 10ml 调糊，每日按 7、11、17、21 时咽服，服后一小时内禁止任何饮食，治疗期间忌食生冷、饮酒及不易消化食物。

3. 攻坚三丸：马钱子 6g，蜈蚣 4 条，带子蜂房 1 个，活蜗牛 6 个，全蝎 3 个，乳香 10g，没药 10g，共研细面，水合为丸如黄豆大，每次 10 粒，早期各一次。

4. 实证攻方：二丑各 10g，三棱、莪术、陈皮各 6g，茵陈、枳壳、槟榔、青皮各 12g。上药水煎，冲米醋二匙，每日一剂。

5. 黄药子酒：黄药子 300g，虻虫 30g，全蝎 30g，蜈蚣 30g，白酒（60 度）1500ml，密封浸泡，埋入地 7 天后取出服用，每次服 10~30ml，每日 3 次。

6. 加味漏芦：漏芦 30g，土茯苓 15g，党参 15g，白术 30g，云苓 30g，丹皮 15g，升麻 15g，黄芪 9g，吴茱萸 10g，制半夏 50g，生甘草 10g，水煎三遍去渣，药汁兑合再浓缩至 300ml，每日分 3、4 次加三味散 1.5g，冲服（三味散：炒土元 30g，炒全蝎 30g，红参 30g 共研细末）。

7. 胃癌粉：乌蛇 60g，螃蟹 60g，鹿角霜 60g，晒干共研细末，每次 5g，每日 3 次。

8. 加味狼毒饮：北狼毒 6g，半枝莲 30g，鸡血藤 30g，生薏苡仁 30g，水煎服。每日一剂早晚分服。

9. 加味牛黄消征散：牛黄 10g（天然最好），雄黄 10g，乳香、没药、三七、山慈菇、砂仁、薏苡仁各 30g。共研细末，瓶装密封，每次服 2g，每日 3 次，饭后服用。

10. 加味犀黄散：犀角 3g，麝香 6g，真牛黄 10g，乳香、没药、三七、山慈菇、砂仁、薏苡仁、鸡内金、党参各 30g。研面装瓶，每次 2~3g，每日 3 次，饭后服用。

（三）成方（药）

1. 农吉利制剂：治疗 101 例，显效 4 例，有效 28 例，有效率 32%。

2. 肿节风制剂（片、注射液）：治疗 108 例，有效率 67.6%。
3. 蛇舌草注射液：治疗胃癌 33 例，显效 3 例，有效 9 例，有效率 36.3%。
4. 蟾皮注射液：治疗 17 例，有效 11 例，有效率 64.7%。
5. 棉酚片：治疗 31 例，有效率 61%。
6. 羟基斑蝥胺注射液：治疗 13 例，有效率 38.4%。
7. 喜树碱注射液：有效率 50%~60%。
8. 野艾制剂：治疗 22 例，显效 2 例，有效 10 例，有效率 54.5%。
9. 消癌平（乌骨藤）注射液：有效率 20%~39%。
10. 平消片：治疗包括胃癌在内恶性肿瘤 180 例，有效率 64.5%。
11. 锦棉片：治疗包括胃癌在内恶性肿瘤 358 例，有效率 55.6%。
12. 复方天仙胶囊：治疗胃癌 177 例，显效 2 例，有效 2 例，稳定 140 例。

【按语】 单方、偏方是在中医古籍中记载，或在民间广泛流传的方药，大多数均有其临床实践基础，治疗有效的个案报道各地均有，而治疗无效也时见报道，但从未见系统、科学、前瞻性的临床研究报道。因此，我们在临床应用上应以科学、客观的态度进行研究整理，准确、客观地评价其治疗效果。验方中，一类是近人在临床实践中整理总结的有效方药，另一类是近人对中医古籍中一些方药的临床再实践而有效者。因此，验方常以此为基础随证加减，应用。成方（药）则是在有效率单方、验方基础上加工生产而成。由于疗效肯定，并且方便携带，服用方便，因此在临床上被广泛应用。但是，成方（药）的疗效一般不如临床辨证施治的效果好，如有条件应根据成方（药）的功能，主治和患者情况辨证选药，并可辨证加服汤药。

三、中西医结合治疗

(一) 中医药与手术治疗相结合

胃癌的手术治疗目前仍是首选治疗手段。如与中医药相结合可提高疗效，术前用药可改善症状，增强体质，缩小瘤灶，提高切除率，缩短术后恢复期，减少术后并发症和后遗症。术后用药可提高免疫功能，改善生存质量，减少复发率和转移率，提高远期生存率。中医研究院广安门医院报道，术前给予黄芪注射液，连用 7~10 天，可明显提高白细胞和 T 淋巴细胞数，增强患者的细胞免疫功能，减少术后并发感染。浙江胃癌协组报道用人参香茶菜片治疗中、晚期胃癌（术后）患者 101 例，1 年生存率 61.11%，而对照组（术后化疗组）为 16.66%，两组差异显著（ $P < 0.01$ ）。福州市第一人民医院采用中西医辨证治疗中、晚期胃癌，使五年生存率达到 35.1%。湖北省肿瘤医院采用健脾和胃抗癌中药治疗晚期胃癌术后患者 30 例，一、三、五年生存率分别 90%，63.3% 和 55.3%，提高了远期生存率，改善了生存质量。

(二) 中医药与化疗相结合

晚期胃癌患者单用化疗疗效差，缓解率约 20%~30%，五年生存率几乎为 0。若化疗与中医药结合可提高疗效，减轻化疗毒副作用，改善生存质量，提高远期生存率。上海瑞金医院采用扶正抗癌方配合化疗治疗晚期胃癌 56 例，三、五年生存率分别为 41.03% 和 30.61%，明显高于单用化疗者。中医研究院广安门医院报道用健脾益肾方合并化疗治疗Ⅲ期胃癌术后患者 103 例，一、三、五年生存率分别为 99.3%，79.41% 和 55.32%，高于术后单用化疗组。上海铁道医学院等报道胃癌术后化疗加中药治疗组五年生存率为 43.9%，中位生存期为 38 个月；而术后单用化疗组五年生存率为 19.6%，中位生存期为 14 个月，两组结果经统计学处理有显著性差异。中药配合化疗还可防治化疗毒副作用。中医研究院广安门医院报道，用健脾益肾方合并化疗治疗

晚期胃癌术后患者，加用健脾益肾方组 95% 可顺利完成全疗程，单用化疗组仅 75% 可顺利完成化疗。河南省肿瘤医院报道，用益肾护髓方治疗化疗引起的白细胞减少症有效率达 90%。北京中医院报道，化疗时配合中药治疗，绝大多数患者一般情况良好，能够顺利完成化疗，其中以健脾补肾法最好。通过对患者免疫功能、植物神经功能状态、血清胃泌素、末梢血细胞等指标的检测，发现化疗时若配合中药治疗前后无差异，说明中医药具有防治化疗毒副作用，保护和调节机体内环境的作用。

（三）中医药与放疗相结合

胃癌的放射治疗自高能粒子放疗方法开展后才有较大发展。但中药配合放疗的临床研究尚不充分。初步临床实践证明，部分中药具有放射增敏作用，能够提高放疗疗效。采用健脾益气，养阴和胃法配合放疗可减轻放疗反应，增强体质，改善生存质量。

四、综合治疗

综合治疗可大幅度提高胃癌的临床疗效和远期生存率，已逐步在临床广泛应用。当前所采用的胃癌综合治疗方案大致如下：

I 期属早期胃癌，采用外科根治性切除，或配合中医药加免疫治疗，但不用化疗或放疗；

II 期属中期胃癌采用根治性切除+化疗（放疗）+中医药治疗或免疫治疗；

III 期已属晚期胃癌，采用根治或姑息性切除+化疗（放疗）+中医药治疗，或化疗（放疗）+手术+化疗（放疗）+中医药治疗。

IV 期属甚晚期胃癌，采用化疗+放疗+中医药治疗，或中医药+化疗（放疗）+中医药治疗。

综合治疗在不同病期有不同的应用原则。对于 I、II 期和部分 III 期胃癌（根治性切除者），主要目的是尽可能干净地清除癌细胞，提高远期生存率，以期彻底治愈。因此，在治疗上手术根治要彻底，化疗、放疗治疗量要充足，中医药治疗用药时间要

长，一般应在三个月以上，免疫治疗可采用大剂量，全疗程治疗。对于部分Ⅲ期胃癌（姑息性切除者）和Ⅳ期胃癌，主要目的是改善或消除症状，延长生存期。因此，应根据病期、体质状况等因素，适当地选用不同的治疗手段。化疗与放疗的治疗量要适当，不可过分；中医药治疗以对症处理为主，免疫治疗不应采用。同时还要加强护理和静脉营养给药。

综合治疗不是多种治疗手段的堆砌，而是根据具体情况，科学、合理、有计划、按步骤地应用多种治疗手段，充分发挥不同治疗手段各自的优势，使之尽可能地提高胃癌疗效，延长生存期。

第十章 原发性肝癌

【概述】

根据 1983 年世界卫生组织的肝癌预防会议资料和 1984 年 Parkin 等的癌症统计数字，肝癌发病率居世界上主要癌症的第 8 位。在亚洲和非洲地区的发病率明显高于欧洲和美洲；有色人种明显高于非有色人种。莫桑比克的络伦索马贵斯是全世界肝癌发病率最高的地区，在 15~44 岁年龄组中，肝癌的标准化年发病率高达 164.6/10 万，而在欧洲意大利等 15 个国家同年龄组的标准化年发病率只有 0.4/10 万。

我国是世界上原发性肝癌高发地区之一，年发病率高于 10/10 万，每年约有 10 万人死于肝癌，占全部恶性肿瘤死亡的第 3 位。高发年龄为 30~60 岁，男性多于女性，男与女之比约为 3:1。由于肝癌的病程较短，发展迅速，症状急剧，当患者出现症状而到医院就诊时，大多已到中晚期，不仅失去了手术切除的时机，也缺乏其它有效的治疗措施。近年来，虽然广泛应用甲胎蛋白作为肝癌的普查方法和临床诊断方法，大大提高了对肝癌的早期诊断率和早期手术的机会，但是，肝癌和其它部位的癌瘤相比，还存在着手术切除率较低及远期疗效不够满意等问题。此外，肝癌病人死亡很快，死亡率极高，预后十分恶劣。

肝癌大体上可分为巨块型、结节型和弥漫型。巨块型占多数，以右叶多见，此型较少伴发肝硬化，但易引起肝破裂、出血等并发症。结节型亦多见，约占 48%，大多数伴有严重的肝硬化。弥漫型较少见，分布弥漫，伴有肝硬变。组织病理学分类以肝细胞型多见，约占 4/5，胆管细胞型肝癌约占 7%，混合型较少见。临床分型为单纯型（临床及化验无明显肝硬化表现）、硬化型（有明显肝硬化表现）、炎症型（病灶发展快，肝功能明

显障碍，伴有高热、疼痛等症)。肝癌的临床分期较难掌握，Ⅰ期无明显肝癌症状和体征；Ⅱ期为超过Ⅰ期标准而无Ⅲ期证据者；Ⅲ期为有黄疸，腹水，恶病质或肝外转移之一者。

在祖国医学文献中，类似肝癌症状及体征的记载是不少的，分别隶属于“脾积”、“症积”、“黄疸”等范畴。2000多年前，祖国医学对肝癌已有认识。《难经·五十六难》记载：“肝之积，名曰肥气。在左或右胁下，如覆杯，有头足（指边界清楚），久不愈，令人咳逆（指肺转移）瘕虐（指有寒热感）”。《难经》中还记载：“脾之积，名曰痞气，在胃脘，复大如盘，久不愈，令人四肢不收，发黄疸，饮食不为肌肤”。明·李时珍《医学入门》载：“脾积，胃脘稍右曰痞气，言阳气为湿所困也，令人黄疸倦怠，饮食不为肌肤”。这些都说明脾积（痞气）的位置在胃脘稍后，即肝区，有肿块，引起黄疸、乏力、消瘦、食欲减退，与肝癌临床有相似之处。隋代巢元方《诸病源候论》中记载：“诊得肝疾，脉弦而细，两胁下痛，邪走心下，足胫寒，胁下痛引小腹，男子积疝也，女子瘕淋也，身无膏泽，喜转筋，爪甲枯黑，春痿秋剧，色青也”。又描述说：“水饮停滞，积聚成癖，因热气相搏，则郁蒸不散，故胁下满痛，而身发黄，名为癖黄”。宋代《圣济总录》中记有：“积气在腹中，久不瘥，牢固推之不移者，症也，此由寒温失宜，饮食不节，致脏腑气虚弱，饮食不消，按之其状如杯盘牢结，久不已，令人身瘦而腹大，至死不消”。这些描述与肝癌临床表现的胁下肿块、消瘦、纳差、腹水等相似，并指出其预后不良。又记载：“肝黄，病人目如丹赤，口燥热渴，气力衰劣，身体青黄，眼中血出，气息急者，不堪医，先灸肝俞，服知母汤（知母、柴胡、茵陈、鳖甲、常山）及灸烙百会”，“血黄，鼻中出血，大小便亦下血，心间烦闷，腹中有块；痛如虫咬，吐逆喘粗，服茅根汤（茅根、生地、刺蓟），治血黄烦闷，心腹痛，结块，心烦吐逆”。还提到：“肝气壅盛，胁下结块，腹内引痛，大小便赤涩，饮食减少”。对肝癌的临床症状和治疗作了记

述。

【病因病机】

祖国医学认为，肝藏血，主疏泄，喜条达，恶抑郁，体阴而用阳。肝属足厥阴经，与胆相表里。中医文献中涉及类似肝癌的记载颇多，归纳起来，引起“痞气”、“脾积”、“积症”、“癖黄”等病因病机主要是外受寒邪，湿浊及湿热等邪侵袭人体，加之饮食不节，脾胃损伤，或因情志抑郁，肝气郁滞，气滞血瘀，结而成积；脾阳为湿邪所困，湿郁化热，郁蒸而生黄疸。正如《灵枢经》百病始生篇所说：“风雨寒热，不得虚，邪不能独伤人”；“虚邪之中人也，始于皮肤……入则抵深……留而不去，传舍于肠胃之外，募原之间，留著于脉，稽留不去，息而成积”。“温气不行，凝血蕴裹而不散，津液涩渗，著而不去，而积皆成矣”。又曰：“积之始生，得寒乃生，厥乃成积也”。认为肝癌早期与湿阻、气滞有关，而体质常以脾虚为主。肝癌与脾的关系最为密切，随着病情的发展，可以出现气滞、血瘀、湿热、热毒的表现，后期常以阴虚、津亏的症状为主。根据邪在肝，邪气郁则胁痛，有结块；若犯脾胃则出现胃纳差，脘腹胀闷，恶心，大便不调等肝木乘犯脾土之象。如肝脾俱病，升降失司，运化失常，水谷清浊不分，水湿困留，则成臌胀。综上所述，肝癌的发生，是在脏腑气血亏虚，脾虚湿困、气滞血瘀的内因基础上，复受六淫邪毒，内伏结聚的外因作用下，日久而成，是内因和外因相互作用的结果。

【治疗】

一、辨证施治 肝癌的临床表现不一，病情复杂，并发症多；不同病程阶段有不同的表现，故辨证类型也不完全一样，现归纳其常见的几种类型，以期对临床辨证起到提纲挈领之作用。

（一）肝气郁结型

【主证】两胁痛，右胁胀痛，坠痛，胸闷不舒，生气后加重，纳差不欲食，肝大有肿块，舌苔薄白，脉弦。

【分析】肝主疏泄，性喜条达，肝气不疏，阻于胁络故见胁胀痛；疏泄失常气机不畅，而胸闷不舒；木郁乘土，脾运失司，故纳差不欲食；气滞则血瘀，故可见胁部肿块。

【治则】疏肝理气。

【方药】逍遥散加减。

柴胡 12g，当归 12g，杭芍 15g，白术 10g，云苓 10g，郁金 10g，香附 10g，八月扎 30g，甘草 4g，沙苑子 15g，青皮 10g。

【方解】方中以柴胡、郁金、香附、青皮疏肝理气，解郁止痛；当归、杭芍、沙苑子柔肝养血；八月扎理气活血；白术、云苓、甘草健脾和中。

【加减】恶心呕吐者加半夏、竹茹；腹胀者加木香、厚朴、大腹皮。

（二）气滞血瘀型

【主证】胁下痞块巨大，胁痛如刺，痛引腰背，固着不移，入夜更剧，舌质紫暗，有瘀点、瘀斑，脉沉细或涩。

【分析】气郁日久，必生瘀血，阻于肝络，不通则痛，故肿块日大，胁痛如刺，痛处不移；肝藏血，血为阴，入夜则阴主令，故瘀血入夜则剧痛。舌质紫暗，有瘀斑点，脉沉细或涩，皆为瘀血阻滞之表现。

【治则】行气活血，化瘀消积。

【方药】膈下逐瘀汤加减。

降香 10g，元胡 10g，三棱 10g，莪术 10g，八月扎 20g，赤芍各 10g，郁金 10g，炮山甲 15g，土鳖虫 10g，生牡蛎 30g，白屈菜 15g，当归 10g，桃仁 9g，红花 6g。

【方解】方中以三棱、莪术、赤芍、土鳖虫、桃、红活血破瘀；降香、元胡、郁金、八月扎、白屈菜理气行血止痛；当归、白芍柔血养肝；炮山甲、生牡蛎养阴软坚消积。

【加减】低热不退者加青蒿、乌敛莓、银柴胡；黄疸加金钱草、虎杖、茵陈；疼甚加乳香、没药、徐长卿；腹水者加猪苓、

泽泻、半边莲。

（三）湿热结毒型

【主证】痛势加剧，发热出汗，心烦易怒，口干口苦，身黄目黄，胁肋刺痛，腹胀满，恶心纳少，便干尿赤，舌质红绛而暗，舌苔黄腻，脉弦滑或滑数。

【分析】肝郁气滞日久，气有余便是火，故气郁日久化热化火，火热蕴于肝胆，循经上窜，扰乱心神，故见口干口苦，烦躁易怒；湿热结阻胆道，胆汁溢外而身目发黄；热结津伤则便干尿赤；湿热郁滞，中焦气逆故见腹胀满，恶心呕吐；舌质红绛而暗，舌苔黄腻，脉弦滑或滑数均显瘀毒火热之症。

【治则】清热利胆，泻火解毒。

【方药】龙胆泻肝汤合茵陈蒿汤加减。

胆草 30g，黄芩 12g，栀子 9g，泽泻 9g，车前子 12g，甘草 6g，茵陈 30g，生大黄 6g，厚朴 12g，莱菔子 15g，虎杖 30g，蒲公英 30g，羊蹄根 20g。

【方解】胆草、黄芩、栀子、虎杖、蒲公英、羊蹄根清肝凉血，泻火解毒；茵陈、泽泻、车前子退黄利湿；甘草调中以防伤胃；生大黄泻火导滞；厚朴、莱菔子行气消胀。

【加减】若高热、大汗、口渴、脉洪大者加石膏、知母、梗米，以清热生津；黄疸甚加金钱草、姜黄；疼痛甚者加降香、苏木、两面针；腹水加玉米须、二丑。

（四）肝阴亏虚型

【主证】胁肋隐痛，绵绵不休，纳少消瘦，低热盗汗，五心烦热，头晕目眩，黄疸尿赤，或腹胀如鼓，青筋暴露，呕血、便血，皮下出血。舌红少苔，脉虚细而数。

【分析】毒热之邪属阳，阻于肝胆易于耗伤肝阴，日久肝血亏虚，气阴两伤，故胁肋隐痛；阴虚内热，兼以邪毒蕴内，故见烦热、低热、黄疸及出血诸症；肝气横逆，则脾虚不运，水湿不化，清浊不分，停滞腹内，致腹胀如鼓，肢肿；舌红少苔，脉虚

细而数皆阴虚内热之明征。

【治则】养阴柔肝，益气养血。

【方药】滋水清肝饮加减。

生地 20g，白芍 15g，当归 10g，女贞子 15g，旱莲草 30g，生龟板 20g，生鳖甲 20g，丹参 15g，嫩青蒿 10g，山萸肉 15g，生山药 10g，沙参 30g，生黄芪 20g，云苓皮 30g，半边莲 30g。

【方解】方中生地、女贞子、旱莲草、生龟板、生鳖甲、山萸肉滋阴清热；白芍、当归养血柔肝；丹皮、嫩青蒿清虚热；生黄芪、云苓皮、生山药健脾益气利水；沙参益气养阴；半边莲清热利湿。

【加减】高热者加寒水石；出血加白茅根、侧柏叶、仙鹤草、血见愁、水牛角、三七粉、云南白药；腹胀加大腹皮、焦槟榔、枳实；腹水加泽漆、猪苓、云苓、玉米须；恶心呕吐加竹茹、赭石、玉枢丹；腹泻便溏加儿茶、苍术、炒扁豆等。

【按语】

1. 中医药适应范围：①可适用于各期各型的肝癌患者。②对不适合手术切除和放射治疗的患者，常可作为首选的方法。③作为手术、放射、化学药物综合治疗的一部分。

2. 中医药治疗期望达到的目的：①控制或治愈肿瘤。在一定时期内使瘤肿控制或稳定者，常可见到，但治愈较少。②改善症状或体征，一般常易达到这项要求。③延长生存期，约半数以上，可达到此项目标。④改善生存质量，多数患者可达到此项目标。

3. 辨证施治要与辨病用药相结合：辨病自然要以肝癌为主。鉴于目前常用的化疗药物对肝癌大都效果不理想，因此探索和寻找治疗肝癌的有效药甚为迫切必要。寻措途径可来自古代的记载，或来自民间的流传，或现代药理的发展。目前正在探索中的药物有半枝莲、猪殃殃、虎杖、小叶金钱草、半边莲、白英、龙葵、蛇莓、干蟾皮、藤梨根、八月扎、冬凌草、喜树果、茵陈、

莪术、土鳖虫、肿节风、板兰根、降香、斑蝥。此外，中医传统的丸剂，如大黄廑虫丸、鳖甲煎丸等对肝癌也有一定疗效。各个地区还有其特色的药物。本类药物的特点是民间习用，已有一定基础；缺点是疗效并不很可靠，副作用有时较大。

4. 几种辨证施治观点的探索：肝癌的辨证论治可概括分为三类，即“症瘕积聚”、“热毒”和“脾胃”论治。其中按“脾胃”论治治疗效果较好，也适用于综合治疗。

①症瘕积聚论。它的根据是，在肝癌产生临床表现后，肝区肿块，肝脾肿大是一些主要症状和体征。因此，对于这些有形的肿块，质地坚硬，按之不动，属于症瘕积聚的范畴。治疗以软坚散结、破症逐瘀的方法来攻伐。具体以张仲景人参鳖甲煎丸及大黄廑虫丸之类化裁为代表。如有的以三棱、莪术为主，有的用穿山甲、鳖甲、牡蛎为主，或以宋·王璆《百一选方》中的金蟾护命丹为主，推其本源，莫不祖于仲景。

尤在泾说：“其邪必假血依痰，结为症瘕，僻处胁下，将成负固不服之势，故宜急治。鳖甲煎丸，行气逐血之药颇多，而不嫌其峻，一日三服，不嫌其急，所谓乘其未集而击之也”。尤氏指出了几点：“第一，这类方剂是峻剂，攻伐之功甚强。第二，适宜于急治。一般认为，对于早期或部分中期，体质颇健，肿块不大，应用可以“不嫌其峻”、“不嫌其急”。但在医学发展的今天，这类早中期患者，手术切除和放射治疗有较好的疗效。对于中期晚期患者，体力极弱，或肝硬化严重，或有出血倾向，则土药慎勿轻用。

②热毒论。有的作者认为，肝癌的主要病因是热毒。因此不论肝癌患者的症象如何，均以清热解毒类药物为主。从目前的动物抗癌筛选资料来看，不少具有抗癌活性的中草药，确实颇多为清热解毒类。因此，这个治法也有它一定的理论根据，也有一些临床有效的报道。但是，这种治法也仅适用于一部分有热毒征象的患者。而且应用时要注意“若寒败胃”的问题。长期服用清热解

毒之品，会损害脾胃，引起或加剧消化道的症状。

③脾胃论。肝癌的常见症状，并不是中医“肝”的症状，而多属“脾胃”的表现。如腹胀，食欲减退，恶心、呕吐，腹泻，便秘等。但问题是，肝区疼痛，上腹肿块，发热能否按“脾胃”来辨证。据李东垣的论述：“脾病，当脐有动气，按之牢若痛，动气筑筑然坚牢如有积而硬，若似痛也，甚则亦大痛，有是则脾虚病也”。又如：“胃病者，腹臌胀，胃脘当心而痛”。“痞气者，邪结心下”等。可见，肝区疼痛，上腹肿块，是可以按“脾胃”来辨证的。痛分虚实，肝癌的肝区疼痛并非实证，也有表现为虚证的。因此，一看到肝区有肿块，即以攻伐之，势必犯“虚虚之戒”时，还当详加辨析。

肝癌发热，有的表现为体温测试正常，惟患者自感内热或肝区大热；有体温明显升高者；此外也有寒热往来者等。都可以按“脾胃”内伤发热来辨治。如东垣所谓：“胃病，则气短，精神少而生大热”。“有所劳倦，形气衰少，谷气不盛，上焦不行，下脘不通，而胃气热，热气熏胸中，故内热”。

二、单方、验方、成方（药）

（一）单方（单味中草药）

1.断肠草 120g，水煎服。

2.冬凌草

糖浆：每毫升含生药 1g，每次 30ml，每日 3 次，口服。

片剂：每片含生药 5g，每次 5~10 片，日 3 次，口服。

冬凌草素混悬剂：每支 30ml，每次 30ml 溶于 5% 葡萄糖液 500ml 中，静脉滴注，日 1 次，30~60 天为 1 疗程。

针剂：冬凌草素注射剂，每支 25mg，每次 75~100mg，溶于 5% 葡萄糖溶液 500ml 中，缓慢静注，隔日 1 次，50~60 天为 1 疗程。

3.斑蝥

斑蝥素片：每次 0.25mg，日 3 次，口服。

羟基斑蝥胺片：每次 25~100mg，日 3 次，口服。

羟基斑蝥注射液：每次 50ml，日 1 次，静注。

4. 葵蕊茶

向日葵杆内之蕊，适量切片，泡茶频频饮之。

5. 天性草根汤

天性草根 90g，水煎上午服；野芥菜根 90g，水煎下午服。

6. 甜瓜蒂（苦丁香）提取物制成片剂，每片 0.1mg，每次服 0.3~0.6mg，日 3 次。

7. 消症益肝方

蟑螂提取物制成的片剂。每日 3 次，每次 6~8 片。

8. 肿节风

针剂：每支含生药 10g 或 20g，每次 1~2 支，日 1~2 次，肌注。

片剂，每片含生药 2.5g，每次 4 片。日 3 次，口服。

（二）验方 近年来，在专方专药治疗肝癌方面，积累了很多经验，大体可分为扶正类，即增强了免疫功能，具有类似非特异性免疫作用；二是祛邪类，即抑癌抗癌作用。

1. 益气补肾方 生晒参、炙黄芪、枸杞子、何首乌、女贞子、楮实子、枸杞子、肉苁蓉、杜仲、炒白术、炙甘草。日 1 剂水煎服。

2. 消积软坚汤 半枝莲、白花蛇舌草、铁树叶、三棱、莪术、土元、鳖甲、党参、当归、白芍、白术、枳实、苡仁。日 1 剂，水煎服。

3. 抗肝癌方 当归 9g，赤白芍各 9g，桃仁 9g，漏芦 9g，丹参 9g，八月扎 9g，郁金 9g，川楝子 9g，香附 9g，夏枯草 15g，海藻 15g，海带 15g，白花蛇舌草 30g（加减：脾虚可加四君子汤、黄芪；利湿可加薏仁、车前子；黄疸可加茵陈、平地木、田基黄；瘀重加王不留行、三棱、莪术；软坚消结还可加石见穿、蜀羊泉、铁树叶）。日 1 剂，水煎服。

4.消癌散 白术 20g, 当归 30g, 山慈菇 30g, 昆布 12g, 海藻 12g, 半边莲 30g, 白花蛇舌草 25g, 三棱 10g, 太子参 30g。水煎服日 1 剂。

5.黄天二莲汤 半枝莲 30g, 半边莲 30g, 黄毛耳草 30g, 天胡荽 60g, 薏苡仁 30g。日 1 剂, 水煎服。

6.肝 1 号煎 当归 9g, 丹参 9g, 白蒺藜 9g, 扁豆 9g, 红花 6g, 香附 6g, 漏芦 12g, 瓦楞子 18g, 石燕 18g, 半枝莲 60g。日 1 剂, 水煎服。

7.抗癌 1 号胶囊 红粉 30g, 轻粉 30g, 血竭 60g, 蜈蚣 90g, 川乌 90g, 草乌 60g, 全蝎 60g, 乳香 90g, 没药 90g, 当归 90g, 肉桂 60g, 元胡 90g, 田三七 60g, 蟾蜍皮 20 个, 玳瑁 60g, 胎盘粉 90g。为末装入胶囊, 每服 4 粒, 日服 2 次。

8.扶正抗癌汤 ①太子参 15g, 夏枯草 30g, 红花 9g, 柴胡 9g, 佛手 9g, 木香 9g, 紫草根 30g, 苡仁 30g, 野菊花 30g, 白茅藤 30g, 当归 12g; ②八月扎 9g, 柴胡 9g, 木香 9g, 炒白术 9g, 制甘草 9g, 丹参 24g, 当归 12g, 莪术 15g, 党参 15g, 半枝莲 30g, 平地木 30g, 白花蛇舌草 30g, 生牡蛎 60g; ③党参 9g, 地黄 9g, 白芍 9g, 白术 9g, 茯苓 9g, 陈皮 9g, 泽泻 9g, 鳖甲 15g, 龟板 15g, 全当归 18g, 黄芪 12g, 七叶一枝花 30g, 白花蛇舌草 30g。水煎服, 每日 1 剂, 分 2 次温服。①方用于扶正活血、疏肝解毒。②方用于软坚化瘀, 调理脾胃。③方用于补气养阴柔肝、健脾和胃、清热利湿。每方连服 3 剂, 循环交替使用, 如病人全身情况较差, 可多服③方。

9.芪棱汤 黄芪 30g, 三棱 30g, 党参 10g, 白术 10g, 炙甘草 10g, 生蒲黄 (包) 10g, 五灵脂 10g, 茯苓 15g, 莪术 30g, 鳖甲 30g, 大枣 30g。水煎服, 日 1 剂。

10.凌霄郁金汤 太子参 9g (或朝鲜白参 1.8g) 黄芪 9g, 丹参 9g, 郁金 9g, 凌霄花 9g, 桃仁 9g, 八月扎 9g, 制香附 9g, 炙鳖甲 12g。日 1 剂, 水煎服。另加全虫液 4ml 口服或全虫

散 6g 吞服，每日 1 次。

11. 五虫丸 水蛭、虻虫、地鳖虫、壁虎、蟾皮。仿古方“大黄虻虫丸”制备。口服，每次 9g，每日 2 次。

12. 参耳三七方 麝香 3g，人参 15g，三七 15g，银耳 15g，生苡米 100g，土茯苓 50g，牛黄 3g，熊胆 3g，乳香 15g，没药 15g。研末，每服 1.5g，日 3 次。

(三) 成方(药)

1. 肝益煎流浸膏：每瓶 500ml，每日 2 次，每次 20~40ml。

2. 鳖甲煎丸：吞服，每次 6~9g。

3. 大黄虻虫丸：吞服，每次 6g。

4. 小金丹：每次 1~2 丸，用黄酒或温开水送下，日 2 次。

三、中西医结合治疗

中西医结合治疗原发性肝癌是我国的独创，是最常用的方法。中医重视整体观，重视审证求因，审因论治，或攻或补，或攻补兼施，进行全面调理，西医常用手术、放疗、化疗强攻，以致副反应较大，治疗难以持久。故主张中西医结合取长补短，发挥各自的优势。实践证明，可提高病人的生存时间和生存质量。

对中晚期肝癌不论是否手术切除或经放射治疗和化学药物治疗，如果再配合固本，健脾理气和辨病辨证治疗，常可收到满意的效果。

(一) 中医药与手术治疗相结合 对于巨块型肝癌的Ⅱ、Ⅲ期，如病变局限，全身状况好，肝功能代偿好的，可争取手术切除，手术后有长期存活的病例。术后尽管手术彻底，也应长期服用中药，以健脾理气扶正为主。术后需长期服药，因为肝癌的远期生存情况多年来并无明显改观，长期服用中药后，有可能提高五年生存率。小肝癌的患者，手术切除后的再生长，或原有未曾切除病灶的发展，颇不少见，也需长期服中药。

手术切除不彻底者，如切缘有癌，或在小血管内已有癌栓，或虽将主要病灶切除，但仍残存较小病灶，术后均应继续用药。

可用中药、放射及化学药物治疗，仍可获得较好的预后。

(二) 中医药与放射治疗相结合 由于肝癌多合并肝硬化，故放疗受到限制。肝癌局限，位置不易手术者，可作放疗，以中小剂量，长疗程移动条全肝照射，取得一定的效果，适合放疗的肝癌患者(Ⅱ期)放疗后一年生存率可达26%~45%，有的在中药配合下可延长存活期。在临床实践中体会到中医辨证可作为适应症选择时参考，凡属脾虚胃弱、肝郁气滞型者疗效较好，阴虚内热者则放疗反应重，疗效差。放疗期间加用中药可减轻反应，提高疗效，中药主要应以健脾理气，滋补肝肾中药为主，佐以活血中药。如果放疗期间单用活血破瘀中药以攻癌者，生存期反而缩短，说明不能中西医同时攻伐。

(三) 中医药与化学药物治疗相结合 对肝癌单用化疗的疗效甚差，一年生存率仅5.4%。对不宜手术或放疗的患者及术后患者，可用化疗和中医药治疗。目前治疗肝癌有效的化疗药物5-氟脲嘧啶、顺氯氨铂或卡铂、噻替派、消瘤芥、抗瘤新芥、丝裂霉素、阿霉素、长春新碱、氨甲喋呤和喜树碱混悬液等。联合化疗效果较好，应用化疗后可有胃肠道反应和骨髓抑制等毒副作用，采用中药来补养气血、健脾和胃、滋补肝肾及清热解毒来减轻副反应，以保障化疗的顺利进行。

(四) 关于晚期肝癌的中西医结合治疗

1. 巨大癌块的治疗：肝癌肿块有时发展十分巨大，肝可在脐平线以下，甚至达盆腔。如全身情况尚可，仍可考虑中药加姑息性放射治疗。可用移动条法，如不能忍受全肝放射，可选择肝癌肿块局部发展最快或疼痛等症状最明显的部位，予以局部小野放射。有时可获得较好的姑息效果。

2. 肝癌快速发展的治疗：癌肿发展十分迅速时，可予中药加化疗药物。化疗药物采用消瘤芥，每天40mg，静脉注射，连续三天。或再予长春新碱1~2mg，5-氟脲嘧啶500mg，静注1次。中药宜用清热解毒类药物。

3.腹水：肝癌伴有腹水为一常见的现象。少量腹水可单纯用中药治疗。常用方：党参、白术、茯苓皮、乌药、降香、大腹皮、车前子、芦笋、地枯萝等常可有效。在肝癌治疗中，对于气胀需特别注意，每为少量腹水之预兆，适当增用理气利水之品，可阻止腹水之大量产生。对于中量以上腹水，可用双氢克尿塞 25~50mg，安体舒通 20~40mg 或甲氨喋呤 50~100mg 同用，3~4 次/日，口服。可长期服用，但通常习惯在利尿剂药有效后即予停药，但对肝癌腹水来说，常用此而腹水再起，再用上药治疗已难以奏效。西药利尿剂运用之时，配合中药理气健脾，使清浊泌别，水浊有去路，从而进一步巩固疗效。对于因肝门静脉癌栓或下腔静脉癌栓所引起的腹水，中西药均无效果，可考虑 Le-Veen 管的应用。

4.黄疸：肝癌伴黄疸不一定是晚期的表现。肝癌早期黄疸，可用茵陈、赤芍、山栀子、神曲、麦芽、茯苓、车前子、半枝莲、田基黄等治疗。放射治疗过程见黄疸，而肿块缩小，甲胎蛋白浓度下降，说明放疗有效，黄疸可能为放射所引起。用上方治疗亦可获效。若为癌肿浸润蔓延入胆道系统者，中药、放疗均无效。

5.转移：肝癌常易肺转移，可用化疗。少数病例肺转移灶可全部消失。因此，有肺转移者，仍应积极治疗。骨转移可局部放射治疗，有姑息止痛的价值。

6.肝破裂或肝包膜下出血：常有急腹症的表现。如肝癌尚系早期，可争取手术切除。如为中晚期，则不宜剖腹，可以腹部包扎，中西药物止血治疗，每可缓解。有时看到因肝破裂而导致迅速死亡者。

7.上消化道出血：肝癌并发上消化道出血者，常因食管（或）胃底静脉曲张破裂出血所致。也可有因药物或应激因素而引起弥漫出血。

大呕血时应禁食，中药也禁用，如呕吐稍止，或稍有缓势，

可口服中药止血药，如云南白药、三七粉等；冰水中加去甲肾上腺素等药物，也可采用三腔二囊管。

8.肝昏迷：西药抗肝昏迷药外，中药可视不同情况予以化痰开窍，凉血清心等药物。

四、综合治疗

(一) 药物-手术-药物、免疫或放疗综合治疗

1.术前：中药-通常用冬凌草制剂或黄芪、当归、生地、熟地、黄柏、苡仁、仙鹤草、大黄等。化疗-用常规量的 $1/2$ 后手术，以控制或杀灭转移病灶，提高手术切除率。

2.术中：可酌情用化疗药物对肿瘤切除后的创面进行冲洗或敷浸。肝断面有肿瘤残留时，可作金属标记，以便术后放疗时定位。

3.术后：①中药：术后第 $1\sim 2$ 天可以胃管中注入加味小承气汤，以促进肠蠕动的恢复。然后可根据情况用生脉散加减、六君子汤加减、膈下逐瘀汤、青蒿鳖甲汤加减以健脾和胃，扶正培本，控制发热和感染。②免疫治疗在术后 10 天开始。③化疗术后 4 周开始，用量应小于常规剂量；一般在术后一年内要化疗 3 个疗程。④放疗：在身体情况基本恢复后进行局部放疗。

(二) 放射-手术-药物、免疫综合治疗

1.术前放疗剂量一般为常规组织量的 $1/3\sim 1/2$ 。并同时加用中药。

2.术后免疫治疗、药物治疗方法同上。

(三) 药物-放射-免疫综合治疗

在放疗前、中、后均可用健脾和胃、清热解毒的中药。在放疗中可用小剂量的化疗如 5-氟脲嘧啶 500mg，静滴，每日 1 次，连用 10 日，可提高疗效；对放疗不敏感的肝癌用长春新碱 1mg、氟脲嘧啶 250~500mg、噻替哌 10mg，每周或 10 天 1 次，可增加放疗敏感性。放疗后可接着用免疫治疗。

第十一章 胆囊癌

【概况】

胆囊癌的发病率，据统计约占所有恶性肿瘤的 2%~6%，占消化道癌肿的 8.5%，仅次于胃、结肠、直肠、食道及胰腺癌，居消化道肿瘤的第六位。临床观察，近年来有上升的趋势。

胆囊癌多原发性，胆囊的转移癌较少见。胆囊癌多发于高龄女性，以 50~70 岁老年人较多，男女之比为 1: 3.3。

胆囊癌的病因目前尚未彻底查明，但据资料报道看，胆囊癌与饮食、细菌感染、寄生虫、胆囊息肉、胆结石以及情绪因素等密切相关，尤其是结石的存在，对胆道上皮细胞经常机械性的刺激，可导致上皮细胞的增生和癌变。胆囊癌的形成，多数人认为是综合因素，如结石、炎症、胆固醇代谢失调和胆汁的刺激作用，尤其是胆汁中含有类似甲基胆蒽的化学物质。以前曾有人将少量甲基胆蒽放入猫的胆囊内，结果 83% 的猫发生了胆囊癌，而且癌细胞侵及到邻近器官。

胆囊癌多发于胆囊底部和体部，以腺癌最多，约占 80%，鳞状细胞癌不到 10%，肉瘤极少。腺癌可分浸润型（硬化型）、粘液型和乳头型三种，浸润型腺癌较多，占腺癌的 70%，这种癌胆囊大小多正常，囊壁增厚变硬，囊壁中发生纤维组织增生，呈交织样，杂以癌细胞，胆囊癌的转移较为广泛，不但可转移到肝（占 30%~40%），而且可侵及胰、肾上腺等器官。胆囊癌的淋巴转移为多见，一般先累及胆囊周围和门静脉周围淋巴结，逐渐转移到胰头部和腹膜后淋巴结，血行转移者较少。

胆囊癌开始多无特殊表现，主要为胆囊炎胆石症的症状，如右上腹疼痛，食欲不振，腹胀、恶心、乏力或低热，有的可伴有轻度黄疸。胆囊癌伴有急性胆囊炎或胆石症时，可急性发作，表

现为右上腹剧痛，畏寒发热，恶心呕吐，黄疸，右上腹肌紧张，压痛明显，有时可触到胆肿块，病程较长时，可出现消瘦乏力，肝脏肿大，腹水，深度黄疸或恶病质，有人报告胆囊癌的临床表现男女患者有一定差异，如腹痛、发热、肿块及黄疸的程度以女性为重，男性为轻。

祖国医学文献中虽无“胆囊癌”病名，但与此病类似病因证治的描述早有记载，如《素问·缪刺论》云：“邪客于足少阳之络，令人胁痛不得息，咳而汗出”。《难经·五十二难》说：“积者，五脏所生，聚者，六腑所成也。积者阴气也，其始发有常处，其痛不离其部，上下有所终始，左右有所穷处……。”说明了邪侵于足少阳胆之络脉其痛甚，邪气留恋日久不去，气血凝滞，而致积聚之证。又如《景岳全书·黄疸》中提出：“胆伤则胆气败，而胆液泄，……”。临床观察到胆囊癌患者1/3~1/2出现黄疸，黄疸的出现多为癌肿晚期扩散的征象。从以上的论述来看，胆囊癌多属于祖国医学的“积聚”、“黄疸”、“胁痛”等病证范畴。

【病因病机】

胆囊癌的形成与肝胆的疏泄功能失常密不可分，肝与胆相表里，胆附于肝，二者经脉相连，胆汁来源于肝，受肝之余气而成，注之于小肠，为消化饮食不可缺少的物质。《医学衷中参西录》说：“胆汁者，原由肝中回血管之血化出而注之于胆，实得甲乙木气之令，是以在小肠中能化胃中不能化之食。”，肝胆疏泄功能正常，胆汁不但能正常分泌，同时贮藏于胆囊内的胆汁也能适时疏泄而下，注之于肠道，以助消化吸收，人体就能气血冲和，健康无恙。若某些因素，如情志不调，饮食不节，感受毒邪及虫积和地理水土等因素，可致肝胆疏泄失职，胆汁的分泌和排泄发生障碍，以致胆汁郁滞，气血受阻，毒邪乘虚而蕴结胆腑，即可发而为病。其详细病理机制，分述如下。

一、情志不调 《济生方·积聚论治》篇中指出：“忧、思、喜、怒、悲之气，……过则伤乎五腑，……留结而为五积。”《金

《医翼·积聚统论》篇也云：“凡忧思郁怒，久不得解者，多成此疾。”肝胆之性喜疏泄条达而恶抑郁，人体的情志变化，肝胆最受影响，若情志不畅，暴怒伤肝或悲哀气结等，使肝气郁结，气机逆乱，气血郁滞，肝胆疏泄失常，胆汁不能正常分泌和排泄，胆汁壅滞，郁而化热，湿热蕴结，易召致和助长毒邪，如果再加饮食不节或感染虫积等因素，癌毒之邪就易侵入或萌发。

二、饮食不节 饮酒失控，饥饱失宜，损伤脾胃，运化失常，痰湿内生，郁而化热，湿热熏蒸肝胆，肝胆疏泄失职，胆汁郁滞。或过食辛辣肥甘，助湿生热，影响脾胃气机升降，中焦壅滞，妨碍肝胆疏泄，也致胆汁郁滞。胆汁郁滞容易导致毒邪而发病。另外，饮食不节湿热、痰浊内生，气血运化不畅，以致气、血、痰、热互相搏结于胆腑，亦可诱发本病。

三、毒邪内侵 感受毒邪，或感湿热、暑湿之邪，或感寒湿之邪郁久化热，湿热毒邪郁而不化，由表达里，内阻中焦，留着胆腑，致使脾胃运化失常，肝胆疏泄失职，气血郁滞，痰浊内生，毒热之邪与痰浊交织，热壅血瘀，而成本病。

四、黄疸、胁痛、虫证等 病证经久不愈，邪气留恋胆腑，肝胆疏泄失职，气血运行不畅日久也可导致本病。正如西医所认识的，胆囊癌与胆囊慢性感染，结石的机械刺激等有一定关系，临床统计，胆囊癌同时伴有结石者占65%~95%，胆囊结石有胆囊癌肿者占2%~4%，认为其发病的过程，是一个由于胆囊慢性感染，产生乳头状生长或某区域的过度增生；亦可由于结石而发生溃疡。原发部位多在胆囊底部或颈部。胆囊粘膜憩室、感染或胆固醇沉淀的慢性刺激，亦可能是造成恶变的一个因素。

五、地理水土因素 居住潮湿或冒雨涉水或恣食瓜果生冷之物，致使湿邪内停，脾土受困，运化受阻，脾不运化而影响肝胆疏泄（土壅木郁），胆汁郁滞，日久为病；或湿邪郁久而化热，湿热蕴结脾胃，肝胆受其熏蒸，肝胆受其煎熬，日久也可发病。胆囊癌的发生与地区因素有一定的关系，有人报道，在我国胆囊

癌多发生于西安地区，该地区的胆囊结石患者约占全国 46%，且大都为胆固醇结石。因此，认为胆固醇结石可能有一定致癌因素，值得进一步研究。

总之，本病的病因虽有上述数种，他们往往相互夹杂，混合致病。其病机主要为肝胆疏泄失职，胆汁郁滞，以致血瘀、湿热、痰浊、毒邪等壅滞胆腑，热壅血瘀，日久发病。本病的病机演变，一般初病多实，久则多虚实夹杂，后期为正虚邪实，气虚血瘀更甚，则癌肿发展更快，脾气日衰，气血生化乏源，正气愈虚，癌肿留著愈不易消散。由于毒邪留于胆腑气滞血瘀脉络受阻，热壅血瘀，故疼痛不止；胆失疏泄，胆液不循常道而外溢，则出现黄疸，肝胆失于疏泄条达，不能疏土（木郁土壅），脾不健运，胃失和降，则出现恶心呕吐，饮食不振。后期脾土衰败，气血亏虚，出现消瘦、乏力等恶病体质。

【治疗】

一、辨证施治 对胆囊癌的治疗应首先辨清初、中末三期的虚实不同情况，《医宗必读·积聚》篇认为：“初者，病邪初起，正气尚强，邪气留浅则任受攻；中者，受病渐久，邪气较深，正气较弱，任受且攻且补，末者，病魔经久，邪气侵袭，正气消残，则任受补。”临床应根据病程长短，邪正盛衰，以及伴有症状等辨明虚实主次。若气滞血瘀者，当理气活血；血瘀为主者，当活血化瘀散结；正虚瘀结者，应采用补正祛瘀；若病人正气大虚，则又当补益气血，培本为主。另外，还应辨清标本缓急，在胆囊癌的病程中，由于病变的发展，常可出现一些危急症候。如毒邪壅滞，气血凝聚，而发生剧痛；因肝胆郁滞，胆汁不能循其常道而外溢出现黄疸；因肝胆失疏，胃失和降，胃气上逆，而出现剧烈呕吐等。这些证候对于胆囊癌来说，属于标证，应按急则治标或标本兼治的原则及时进行处理。

（一）气滞血瘀型

【主证】胆囊癌初期胆囊区固定胀痛，时轻时重，口苦，恶

心，食欲不振，或有寒热，舌苔薄白，脉弦。

【分析】气滞血瘀，胆腑郁滞，脉络失和，故胆囊区固定胀痛；口苦，恶寒发热，脉弦，为邪在少阳胆经的表现；肝胆郁滞，横逆犯胃，故恶心，食欲不振；时轻时重，舌苔薄白为病属初期。

【治则】疏肝理气，活血消积。

【方药】柴胡疏肝散合大七气汤加减。

【方解】柴胡疏肝散源于《景岳全书》大七气汤源于《济生方》。方中柴胡、白芍、青皮、陈皮、香附、枳壳疏肝理气止痛；川芎、三棱、文术活血化瘀，消积散结。

【加减】若疼痛重者，加川楝子、元胡、蒲黄、灵脂等以行气化瘀止痛；恶心、食欲不振明显者，加姜半夏、麦芽、谷芽、鸡内金等和胃消食，伴有胆囊结石者加金钱草、郁金等以利胆排石。

【变证】

(1) 肝郁血虚 肝郁日久，脾失健运，生化乏源，而出现肝郁血虚，证见右胁隐痛，头痛目眩，口燥咽干，神疲食少，月经不调，脉弦而虚者，治宜疏肝解郁，健脾养血，方用逍遥散加减（柴胡、当归、白芍、白术、茯苓、薄荷、生姜、甘草）。

(2) 气郁食滞 肝郁日久，脾失健运，饮食停滞，证见右胁疼痛，脘腹胀满胀痛，恶食呕逆，暖腐吞酸，舌苔黄腻，脉弦滑，治宜疏肝健脾，消食和胃，方用柴胡疏肝散合保和丸（山楂、神曲、半夏、茯苓、陈皮、连翘、萝卜子）加减。

(二) 湿热型

【主证】右上腹或剑突下持续性疼痛，甚则绞痛，硬满拒按，口苦，咽干，恶心呕吐，不欲饮食，畏寒发热或寒热往来，目黄，身黄，小便黄赤，大便秘结，舌质红，苔黄腻，脉弦滑或脉弦数。

【分析】毒邪蕴结胆腑，阻遏气机，气血瘀阻故疼痛拒按；

湿热阻于少阳经，则口苦，咽干，畏寒发热或寒热往来；湿热中阻，胃失和降，则恶心呕吐，不欲饮食；湿热毒邪壅阻胆腑，胆汁不循常道而外溢，出现目黄、身黄、小便黄赤；湿热阻于大肠，大肠传导的失职，则大便秘结；舌质红，苔黄腻，脉弦滑或弦数，均为湿热毒邪内盛之象。

【治则】清肝胆利湿热，攻里通下。

【方药】大柴胡汤合茵陈蒿汤加减。

【方解】大柴胡汤源于《金匱要略》，茵陈蒿汤源于《伤寒论》。方中柴胡配黄芩、白芍、枳实、芍药、茵陈清肝胆湿热；半夏、厚朴、枳实行气消胀，和胃降逆；大黄通里攻下泄毒热。

【加减】若毒热内盛，神明被扰，出现神昏谵语者，可服安宫牛黄丸，以清热开窍解毒若湿热阻滞，气血瘀阻，疼痛较甚者，加灵脂、蒲黄、元胡、青皮等化瘀行气止痛。

【变证】

毒热炽盛，毒邪蕴结胆腑，瘀血内结，日久化热，毒热炽盛，气血更加受阻。证见右上腹持续剧痛，毒热郁蒸，热壅血瘀，内腐血败，而成痈脓，则上腹或右上腹硬满拒按，或触及包块；毒热熏蒸，胆汁外溢而见黄疸；毒热之邪耗津伤阴，故见烦渴，舌苔黄燥，或干枯无苔；毒热之邪上扰神明，可见神昏谵语；若毒之邪与正气相争，正不胜邪，正虚邪盛可见大汗淋漓，四肢厥冷，精神萎靡，脉微欲绝的阳脱之证。治疗，对于毒热炽盛者，宜清热凉血解毒，通里攻下，方用大柴胡汤、茵陈蒿汤合犀角地黄汤加减。对于阳气欲脱者，治宜扶正祛邪回阳救逆，用参附汤（人参、炮附子）加减。

（三）瘀血内结

【主证】胆囊明显肿大，硬痛不移，面黯消瘦，纳差乏力，时有寒热，女子月经不调或闭经，舌质紫暗或有瘀点，脉细涩。

【分析】毒邪蕴结胆腑日久不去，气血凝结，脉络阻塞，血瘀日甚，故见胆囊肿大，硬痛不移，面黯；由于脾胃失调，气血

乏源，营卫不和，故见纳差乏力，消瘦，时有寒热；女子经闭，舌质暗紫，脉细涩均为瘀血内结之象。

【治则】祛瘀软坚，兼理脾胃。

【方药】膈下逐瘀汤合鳖甲煎丸加减。

【方解】膈下逐瘀汤源于《医林改错》，鳖甲煎丸源于《金匱要略》。方中鳖甲、桃仁、丹皮、赤芍、当归、川芎、红花、灵脂、元胡共奏活血化瘀，软坚消症之效；赤硝、大黄、虻虫、蜣螂、蜂房、鼠妇以攻逐破血，解毒消症；柴胡、黄芩、白芍和解少阳而条达肝气；厚朴、枳壳、香附、射干、葶苈子、半夏行郁气而消痰癖；干姜、桂枝温中与黄芩相伍，辛开苦降而调寒热；人参、阿胶补气养血以扶正气；瞿麦、石苇利水祛湿。综合诸药，两方合用乃攻补兼施、寒温并用之剂，对于毒邪内结，症瘕积聚，实有攻邪而不伤正，气畅血行，征积内消之功。

【加减】若体质不甚虚弱，可加三棱、莪术以增强祛瘀消坚之力。若正气亏虚明显，可同服六君子汤以补气健脾，扶正以助祛邪。

（四）肝肾阴虚

【主证】右胁部隐痛，遇劳加重，口干咽燥，午后潮热或五心烦热，头晕目眩，舌红少苔，脉弦细或细数。

【分析】毒邪蕴结胆腑，日久化火伤阴，或病久体虚阴血亏耗，肝络失于濡养，故右胁部隐痛，遇劳加重；阴虚而生内热，故口干咽燥，午后潮热或五心烦热；阴血亏少，不能上荣于脑，则头晕目眩；舌红少苔，脉弦细或细数均为阴虚内热之象。

【治则】养阴柔肝。

【方药】一贯煎加减。

【方解】一贯煎源于《柳州医话》。方中生地、杞果滋养肝肾；沙参、麦冬、当归养阴柔肝；川楝子、枳壳疏肝行气以顺其肝胆之特性。全方共有养阴柔肝、疏肝行气之功。

【加减】午后潮热或五心烦热明显者，加青蒿、白薇、地骨

皮、知母等以清热退蒸；潮热盗汗明显者，加牡蛎、龟板、五味子等以育阴潜阳敛汗；头晕目眩重者，加熟地、黄精、女贞子、菊花等以滋肾清肝；毒邪盛者，加半边莲、蛇舌草、公英、地丁等以解毒清热；大便秘结者，加玄参、生首乌等以滋阴通便。

（五）脾肾阳虚

【主证】胆囊区隐痛，神疲畏寒，目黄身黄，黄色晦暗，脘闷纳呆，口淡不渴，大便溏薄，小便清长，舌质淡，苔白腻，脉濡缓或沉迟。

【分析】本型属黄疸病的“阴黄”范畴。由于毒邪蕴结胆腑日久，正气亏损，阳气受伤脾阳不振，寒湿内阻，胆失疏泄而发病。

寒湿郁遏，阻于胁络，故胆囊区隐痛；阳气不足，气血亏虚，则神疲畏寒；寒湿阻滞，胆液不循常道而外溢则见身发黄；黄色晦暗，寒湿困脾，胃失和降则脘闷纳呆，口淡不渴；脾胃阳虚，湿从寒化则大便溏薄，小便清长；舌质淡，苔白腻，脉濡缓或沉迟均为阳虚寒湿内阻之象。

【治则】温阳祛湿，疏肝健脾。

【方药】茵陈术附汤加减。

【方解】茵陈术附汤源于《医学心悟》。方中茵陈、附子并用温化寒湿以退黄疸；白术、干姜、甘草健脾温中。可加柴胡、郁金、厚朴、茯苓等疏肝行气利湿之品。

【加减】黄疸日久，气滞血瘀，肿瘤增大，右胁部刺痛拒按，可加鳖甲煎丸（见瘀血内结型）。若肿瘤胀痛，固定不移，舌质暗，脉弦细，乃属气血两虚浊邪瘀阻脉络，可加硝石矾石散（硝石、明矾）。若脾胃虚弱明显，可服香砂六君子汤（人参、白术、茯苓、甘草、陈皮、半夏、香附、砂仁）以健脾和胃。

总之，胆囊癌的治疗虽分以上诸型，但总不外祛邪和扶正两大法则。癌症日积月累，非伊朝夕，攻伐之品亦当有迨，过则伤正，正气伤不能运化，而邪反固，不可不慎。临床上应根据病人

具体情况，在不同阶段或以攻为主，以补为辅；或以补为主，以攻为辅；或先攻后补或先补后攻，或二攻一补，或二补一攻；或寓攻于补，或寓补于攻。当攻而畏缩不前，病无由去，则留而为患，但也不可攻其一点不计其余，否则会病未去而人已不支。《内经》云：“大积大聚，其可犯也，衰其大半而止，过者死”实属经验之谈。

另外，胆囊癌不论各期均可选虽下列抗癌之品，以加强解毒抗癌的效能。常用治疗胆囊癌的抗癌中药有：三棱、莪术、公英、连翘、蛇舌草、大黄、料姜石、蜂房、全虫、半边莲、三七参、龙葵、黄精、硃砂等。

不论胆囊癌各期均可在局部敷阿魏膏（羌活、独活、玄参、官桂、赤芍、穿山甲、苏合油、生地、大黄、白芷、天麻、红花、麝香、木鳖子、黄丹、芒硝、阿魏、乳香、没药）或水红花膏（红蓼子、大黄、朴硝、山桃、石灰酒酵）以助消积散瘀，软坚散结之作用，可提高疗效。

二、单、验方

1. 全虫 15g，蜈蚣 15g，雄黄 30g，水蛭 6g，白石英 15g，三棱 9g，莪术 9g，郁金 15g，茵陈 30g，白芍 12g，当归 12g。每日一付，若白血球和血小板降至正常值以下时，应停药，待回升后再用药。

2. 升白方：主治化疗引起的白细胞减少及其它原因的白细胞减少症。

处方：补骨脂 30g，淫羊藿 15g，胎盘粉 15g，女贞子 60g，山萸肉 15g，黄芪 30g，当归 15g，大枣 30g，丹参 15g，鸡血藤 60g，三七粉 9g，虎杖 30g 制成每片含生药 1.85g 的片剂。

3. 茵陈 30g，三棱 15g，莪术 15g，白芍 20g，蜂房 15g，全虫 12g，瓦楞子 30g，牡蛎 30g，料姜石 60g，郁金 15g，虎杖 30g，半边莲 30g，水煎服。

第十二章 胰腺癌

【概述】

胰腺癌是常见消化系统恶性肿瘤之一，多发生于 40~70 岁，男性比女性多 10 倍，据临床报导，近年来发病率有不断增高趋势。

胰腺癌多发生在胰头部（约占 80%），仅少数发生在胰体和胰尾。胰腺癌发生迅速，常早期转移，胰头癌可直接蔓延，常累及胆总管下端十二指肠，使胆道扩张，胆囊、肝脏肿大，并出现阻塞性黄疸。胰体和胰尾部癌向前蔓延至腹膜部位。胰腺癌的淋巴结转移；胰头癌先转移至胃幽门下，或肠系膜上动脉附近淋巴，再至腹腔淋巴结，体部和尾部癌早期转移至脾门或直接侵犯腹腔淋巴结，胰腺癌可转移至局部淋巴及肝脏。胰腺癌亦可经血液转移至肝、胆、肺、胸、腹腔、脊椎等。

胰腺癌的病因目前尚不明确，有人认为与一些相关的疾病有关，特别是邻近的脏器如胃、胆的一些疾病，以及直接影响胰腺功能长期紊乱的因素，都可能造成胰腺发生病变。另外肝、胆、胃等腹腔脏器的癌肿常浸润或转移到胰腺。饮食不节和饮食不洁常常是胰腺癌发生的诱以因素。

胰腺癌早期多无明显症状，发展到一定程度即可出现症状。初期症状大多为上腹痛、黄疸和消化道症状。腹痛为初发症状，多数患者相当长的时间以腹痛为主症，疼痛在上腹中间，有时偏左或偏右，开始为隐痛，在夜晚较白天明显。阵发性疼痛提示，并发胆道或十二指肠的不全梗阻；持续性疼痛提示神经受累或伴胰腺慢性炎症；背脊痛提示腹腔神经丛受累。严重时疼痛可昼夜不止。黄疸为胰头癌和弥漫性癌的主要症状，黄疸一般是进行性加重，可伴有搔痒，有时可随胆管炎症的消长而黄疸稍有波动，

但总的趋势是逐渐加深。肝和胆囊均可因胆汁瘀滞而肿大。当癌肿完全阻塞胆道时，大便可呈陶土色。消化道症状有食欲不振、腹胀、消化不良、腹泻等，恶心呕吐或呕血便血，提示癌瘤侵入胃、十二指肠。

胰腺癌的治疗目前仍不理想，西医以手术治疗，平均生存期只有半年左右。近年来临床报告中医以辨证论治原则治疗胰腺癌，取得了一定的效果，显示了中医在治疗胰腺癌方面具有一定优势。

在祖国医学文献中，虽无“胰腺癌”病名，但有关类似症治的描述却屡见不鲜。如《内经·五常致要大论》记载：“少阳司天，火气下临，肺气上从……心涌胃脘痛，厥逆膈不通”。《难经·五十六难》云：“心之积，名曰伏梁”。《金匱要略·五脏风寒积聚病》中说：“积者，脏病也，终不移……”《诸病源候论·急黄候》曰：“脾胃有热，谷气郁蒸。因为热毒所加，故卒然发黄，心满气，命在倾刻，故云急黄也。”《伤寒论》里的“结胸”、“发黄”、“膈痛”、“心痛”等疾病都和胰腺癌相类似。综上所述，胰腺癌多属祖国医学的积聚、黄疸、胃痛、胁痛等病证范畴。

【病因病机】

胰腺癌的形成与肝胆的疏泄条达功能失常密不可分，所谓“条达”亦即调达，是指人体气机调和畅达，阴阳平衡之意。肝胆疏泄条达正常，则气机调畅，升降有序，阴阳平衡，才能保持各脏腑组织的正常生理功能。若肝胆疏泄条达失职，气机不畅，升降失常，阴阳失调，即可出现脏腑器官的病理改变，胰液就不能正常分泌和排泄，而致胰液郁滞。《素问刺法论》云：“正气存内，邪不可干”，《素问评热病论》云：“邪之所凑，其气必虚”。在脏腑器官出现病理改变（胰液郁滞）的情况下，胰腺癌的癌毒之邪即可乘虚而侵入人体，或即可萌发。影响肝胆疏泄功能的因素，多见于情志不调，饮食不节，感受毒邪，以及感染虫积等。

1. 情志不调 肝胆之性喜疏泄条达而恶抑郁，人体的情志变

化肝胆最受影响，若情志不调，暴怒伤肝，或悲哀气结等，使肝胆疏泄失常，气机郁滞，胰液不能正常分泌和排泄，胰液壅滞，若再加饮食不节或感染虫积，癌毒之邪即可侵入人体。

2.饮食不节 饮食不节，恣食肥甘厚味或过食辛辣之品，脾胃受伤，运化失常，湿浊内生，郁而化热，湿热熏蒸肝胆，肝胆疏泄失职，胰液郁滞，也利于癌毒之邪的孳生和发展。

3.感染湿热毒邪 外感湿热或暑湿之邪或寒湿之邪郁久化热，湿热不解，内阻中焦脾胃运化失常，湿热不得泄越，肝胆受其熏蒸以致疏泄条达失职，胰液郁滞，癌毒之邪即可乘虚侵入人体，或萌发孳生。

4.感染虫积 饮食不洁或脾胃不健，以致肠道寄生虫侵人体，虫积可助生热，而浊热又利于虫体寄生。虫性喜钻孔乱窜，可由肠窜入胆道，并带进不洁之物，扰乱气机，使肝胆疏泄失职，致使胰液郁滞，癌毒之邪亦易乘机侵入或萌发孳生。

总之，胰腺癌的病因虽有以上数种，但疾病的形成往往是多种因素综合。肝胆疏泄功能失职，脏腑功能失调，人体正气虚弱，以致气滞血瘀，痰湿等病理因素的产生，这些因素、即是癌毒侵入和萌发孳生的关键。

【治疗】

一、辨证施治 胰腺癌的治疗与其它癌肿一样，也必须分清初、中、末三期，初期虽属邪实，但正气尚未大虚，治宜祛邪为主；中期邪气盛而正气渐弱，邪盛正虚，治宜攻补兼施；后期属正虚邪恋，以扶正培本为主。另外，也应辨清标本缓急，在胰腺癌的病程中，常出现危急症候，如癌肿的压迫或阻塞，胆汁和胰液分泌排泄障碍，出现急黄；毒邪蕴结，气血阻滞不通，出现持续绞痛，癌毒灼伤脉络而出现胃肠道出血等危急症状。应按急则治标或标本兼治的原则，及时处理。

胰腺癌临床常见有湿热毒盛，气血瘀滞、脾虚湿阻和阴虚内热等四型，现分述如下。

（一）湿热毒盛型

【主证】食欲不振，上腹部胀满，胁部刺痛，黄疸呈黄绿色，皮肤搔痒，恶心呕吐，大便秘结或呈灰白色，小便短赤，舌苔黄腻，脉弦数或弦滑。

【分析】湿热毒邪阻遏脾胃，运化失常，故食欲不振，恶心呕吐，上腹部胀满；湿热毒邪熏蒸肝胆，肝胆疏泄失职，胆汁、胰液不循常道而外溢，故黄疸呈黄绿色，皮肤搔痒；癌肿压迫或阻塞致使胆汁、胰液不能到肠帮助消化则大便灰白色，小便短赤，舌苔黄腻，脉弦数或弦滑均为湿热毒盛之象。

【治则】清热解毒利湿。

【方药】茵陈蒿汤合黄连解毒汤。

【方解】茵陈蒿汤源于《伤寒论》，黄连解毒汤源于《外台秘要》。方中茵陈清利湿热以退黄疸；栀子通泻三焦之火，导湿热下行而从小便出；大黄泻热逐瘀。通利大便，黄连泻心火兼泻中焦之火；黄芩清肺热，泻上焦之火；黄柏泻下焦之火。两方共有清热利湿、泻火解毒之功。

【加减】毒热炽盛加山豆根、蜀羊泉、地丁等以助清热解毒之效；癌肿坚硬，发展迅速可加莪术、瓦楞子、料姜石等以软坚散结；疼痛明显者加灵脂、元胡、三七参等以活血化瘀行气止痛。

（二）气血瘀滞型

【主证】上腹或左上腹部痛，夜晚痛甚，或伴恶心呕吐，纳食减少，或触及癌肿包块，面色黧黑，消瘦乏力，舌苔厚腻，舌质暗紫，脉细涩或弦细。

【分析】癌肿阻滞，气血瘀阻，痹阻脉络，故上腹或左上腹部痛，夜晚痛甚；癌肿蕴结，脾胃受伤，湿热不化，生化乏源故恶心呕吐，纳食减少，舌苔厚腻，消瘦乏力；触及包块，面色黧黑，舌质暗紫，脉细涩或弦细均为瘀血内停之象。

【治则】活血化瘀，软坚消症。

【方药】膈下逐瘀汤合鳖甲煎丸。

【方解】膈下逐瘀汤源于《医林改错》，鳖甲煎丸源于《金匱要略》。方中鳖甲软坚消症；赤硝、大黄、虻虫、蛭螂、鼠妇功逐破血消症；柴胡、白芍、黄芩和少阳而条肝气；厚朴、射干、葶苈子、半夏、香附、枳壳、乌药行气解郁而消痞癖；干姜、桂枝温中，与黄芩相伍，辛开苦降而调寒热；人参、当归、阿胶补气养血而扶正气；桃仁、川芎、赤芍、灵脂、红花、丹皮、元胡、紫葳、蜂房活血化瘀解毒而去干血；瞿麦、石苇利水祛湿。综合诸药，乃攻补兼施，寒温并施之剂，对于胰腺癌气血瘀滞型，实有攻邪而不伤正，气畅血行，症积内消之功。

【加减】癌肿坚硬，可酌加三棱、莪术、硃砂、白矾等软坚散结，消坚硬之积；正气虚弱明显者可加黄芪、党参、白术等益气健脾之品；食欲不振加鸡内金、神曲、山楂、麦芽等以助消化。

（三）脾虚湿阻型

【主证】神疲乏力，胸脘胀满，纳差，便溏，舌苔白腻，脉缓或濡。

【分析】胰腺癌病久脾气耗伤，以致脾胃运化和受纳失职，气血乏源，故见神疲乏力，胸脘胀满，纳差，便溏；舌苔白腻，脉缓或濡均为脾虚湿阻之征。

【治则】健脾化湿和中。

方药：香砂六君子汤加减。

【方解】香砂六君子汤源于《医方集解》方中人参、白术、茯苓、半夏、陈皮健脾益气和胃，脾胃健则浊邪去；木香、砂仁理气健胃醒脾。全方共具健脾益气化湿和中之效。

【加减】若见面白、肢冷阳气虚衰者加炮附子、肉桂等补肾助阳；疼痛明显者加川楝子、元胡等行气止痛。

（四）阴虚内热型

【主证】低烧不退，精神疲惫，上腹隐痛，咽干口燥，舌红

少津，脉细弱或细数。

【分析】毒邪蕴结日久，灼津耗液阴虚则内热，故低热不退，咽干口燥，舌红少津，脉细弱或细数；肝肾阴虚，精血亏少，故精神疲惫；肝阴亏虚络脉失养，则上腹隐痛。

【治则】一贯煎加减。

【方药】一贯煎源于《柳州医话》。方中生地滋阴养血以补肝肾；沙参、麦冬、当归、杞果配生地滋阴养血生津以柔肝；川楝子疏泄肝气顺肝之性。全方共奏滋阴养肝清热之功。

加减：舌红而干加石斛，以助养阴之效；肿块胀痛，按之坚硬加鳖甲、龟板、牡蛎、瓦楞子等以软坚散结育阴；口渴加天花粉、生石膏、知母以养阴生津止渴；疼痛加生白芍、甘草以敛阴止痛。

胰腺癌的治疗，虽分以上几型，但由于该病例发展快，病情重症状复杂，临床上要时刻注意病情的发展，根据症状的变化认真细致的辨证论治，才能收到好的效果。另外，不论各型，在治疗时均可加入常用的抗癌中药以提高疗效。常用的治疗胰腺癌抗癌中药的：莪术、三棱、半边莲、龙葵、鳖甲、全虫、蜂房、料姜石、瓦楞子、公英、金银花、连翘、昆布、海藻、白花蛇舌草、大黄等。

二、单方、验方

1. 鸡内金 30g，青黛 15g，野菊花 60g，草河车 30g，三七参 30g，人工牛黄 15g，紫金锭 10g。共研细面，一次 2g，每日 3 次，温开水冲服。

2. 蜘蛛 7 个，鸡蛋黄 7 个（鸡蛋煮熟，去清）。二者混合，放锅内炒炭出油，然后吃鸡蛋。

3. 皂角 60g，鸡 1 只。二味共煮（不加调料），吃肉喝汤。

4. 猫一只。煮熟吃肉（不加调料）。另外猫头焙干研面冲服。

5. 铁树牡蛎汤：煅牡蛎 30g，夏枯草 15g，海藻 15g，海带

12g, 漏芦 12g, 白花蛇舌草 30g, 铁树叶 30g, 当归 12g, 赤芍 12g, 丹参 18g, 党参 15g, 白术 12g, 茯苓 15g, 川楝子 9g, 郁金 9g, 水煎服。

6. 牡蛎首乌汤: 牡蛎 20g, 夏枯草 20g, 贝母 12g, 玄参 15g, 青皮 15g, 党参 30g, 炒白芥子 30g, 首乌 30g, 白术 10g, 当归 10g, 赤芍 10g, 胆草 10g, 半夏 10g, 木通 7g, 白芷 7g, 台乌药 7g, 水煎服。

第十三章 大肠癌

【概述】

大肠包括结肠和直肠两部分。大肠癌为我国的常见消化道恶性肿瘤，发病率仅次于胃、食管癌而居第三位。据近年来一些省市统计，其死亡率在恶性肿瘤中占第一至六位，值得注意的是本病发病率正日渐上升。以上海市为例，1963~1976年这14年间直肠癌的发病率增加了101%，结肠癌的发病率则增加至158%。性别在国外差别不大。我国据上海、北京、杭州等地1564例分析男女之比为1:2。年龄据上海226例统计分析：最小13岁、最大76岁，其中位年龄45.3岁，较欧美文献报告的发病率年龄提前12~18岁。世界各地大肠癌发病率不同，在欧美为高发癌之一。根据国际癌症研究机构1982年对世界105个国家和地区统计，大肠癌发病率居第4位。而亚、非国家发病率偏低。

1974年在世界肿瘤流行病学调查统计，本病在北美、澳大利亚、新西兰以及西欧的大部分地区高发，在中美洲、加勒比海、非洲的撒哈拉沙漠地带、东地中海、南亚及日本则较低发。大肠癌在美国十分常见，而且发病率不断上升，目前已超过肺癌而成为最常见的内脏癌肿。1977年全美101,000人患大肠癌，推算每诞生25个婴儿日后就将有一人患大肠癌。因此美国对本病的研究非常重视。但本病在非洲十分少见，据21个非洲国家医院统计，最多一医院每年可见到4例大肠癌，其它医院每年只见到1例，甚至无一例大肠癌病可见。

Stewdrt指出：虽然莫桑比克、乌干达黑人大肠癌发病率为世界最低，但美国黑人的发病率却与美国白人一样高，移居美国夏威夷的日本人大肠癌发病率也与当地白人相同，而远超过日本

本土的人。移居夏威夷的中国人大肠癌的发病率甚至还超过了当地的白人。上述移民流行病学研究资料表明：大肠癌的病因中，饮食、环境因素的重要性大于遗传、种族因素。

我国大肠癌流行病学的特征

1.发病年龄明显提前：国内文献报告中大肠癌患者的年龄中位数在 45 岁左右，较欧美报道的提前 12~18 年。Bdcon 等报告欧美大肠癌患者中年龄 30 岁以下者仅占 0.005%~7%。但国内文献中年龄 30 岁以下者占 11.6%~14.3%，可见年青患者并不少见。部分作者认为发病年龄提前与合并血吸虫相关，但从近年浙江省的资料看，并非完全如此。上海肿瘤医院 404 例直肠癌手术标本中发现合并血吸虫病患者的中位数年龄为 39.3 岁，比无血吸虫患者年轻 8 岁。但 226 例结肠癌患者中合并血吸虫病患者的中数年龄无大区别（分别为 45.1 岁与 44.6 岁）。总之，我国大肠癌发病年龄明显提前的原因尚需加以研究。

2.低位大肠癌多见：Lee 指出目前美国大肠癌中，直肠癌只占 23%。Berg 发现目前美国的大肠癌中，仅 12%可被直肠指检发现（距肛门 6cm 以下）。国内大肠癌中，直肠癌占的比例在 43%~65%，而直肠癌中 81%~98%可用直肠指检发现。国内低位大肠癌多见的原因待查，可能与癌前病变大肠腺瘤的防治重视不够有关。

3.合并血吸虫病患者多见：从已有的流行病等研究资料说明，血吸虫病与大肠癌二者关系密切。国内血吸虫流行区，大肠癌经常常合并血吸虫病为其特点。

【病因病机】

祖国医学认为肿瘤是全身性疾病的局部表现，是一类病而不是一个病。祖国医学对大肠癌的记述散见于“脏毒便血”、“肠覃”、“症瘕”、“锁肛痔”等疾病的范围之内。如《外科大成》中说：“锁肛痔，肛门内外如竹节紧锁，形如海蛇，里急后重，粪便

细而带偏，时流臭水……”与大肠癌症状颇为相似。其致病因素是比较复杂的。祖国医学比较重视病因，认为本病是由于下述原因致成：忧思郁怒、饮食不节，久痢久泻，脾失健运，气机不畅，毒邪侵入，湿热蕴结，下注大肠，滞留积聚，凝结成积。如《灵枢·水胀》“肠覃者，寒气客于肠外，与卫气相搏，气不得荣，因有所系，癖而内著，恶气乃起，息肉乃生……”是指机体失调，再加上外因，是诱发大肠癌的原因之一。然邪毒侵入主因是正气虚弱，即“邪之所凑，其气必虚”。《医宗必读》中所说：“积之成也，正气不足，而后邪踞之”。这说明人体正气不足，机体阴阳失调，引起气滞、血瘀、痰凝、热毒、湿聚等互相交结，再加外来因素，以致形成肿瘤的发生。

1.气滞：正常情况下，气在全身运行，无处不到。如寒热温凉失调，情志抑郁，以及痰饮、湿浊、瘀血、宿食等，均可影响到气的正常运行，引起气滞、气郁、气逆或气陷等病理现象，日久不解，气滞血瘀，长期蕴积不散，而逐渐形成肿块。《内经》说：“百病皆生于气”。在临床中，常遇到肿瘤患者发病之前，有情志抑郁、气滞、气郁的表现，在发病后，亦有气滞、气郁等症状。如应用理气药治疗，往往能收到一定效果，所以气滞气郁是引起肿瘤的因素之一。

2.血瘀：气为血帅，血随气行。气滞则血瘀，因此，气机不利常引起气滞血瘀，蕴结日久，聚结肿块。在临床上，根据瘀血凝滞的理论，采用活血化瘀进行治疗，常可收到比较好的疗效。所以，中医认为，瘀血凝滞是引起肿瘤发生的重要原因之一。

3.痰凝：痰是由于体内水湿不化，津液不布，郁滞不通，凝滞而成。或由邪炼津，凝结成痰，痰可以影响脏腑的气机升降和气血运行，导致气血凝滞，停聚在不同部位，如胸胁膈上，或积聚在肠间，病情演变到一定程度，都可形成积聚肿块。在临床上，应用化痰软坚的方法治疗肿瘤，往往可收到肿块逐渐缩小或柔软的效果。因此认为，痰凝在体内，日积月累，可影响身体各

部分的功能活动，也是诱发肿瘤的因素之一。

4.热毒：热毒是指郁火及邪热郁结日久而成的热毒。热毒内蕴机体脏腑、经络，郁久不散，可导致营卫不和，经络阻隔，气血瘀滞等症状，如热毒郁结较甚，或气血虚弱，不能透毒外出，以致毒滞难化，积聚不去，渐成症瘕积块。火毒炽盛往往是癌肿晚期症状。应用疏肝解郁、泻火解毒、清热利湿等治疗后，可收到比较明显的效果。所以认为热毒郁火也是肿瘤发病因素之一。

5.湿聚：湿属阴邪，性质重浊而粘腻。湿邪侵入机体，导致脾胃运化减弱，而更助长湿的凝聚。湿浊之气郁积日久，便成湿毒、湿聚，湿毒反复发作也是肿瘤的诱发因素之一。因此在临床中，对湿聚之症常用健脾化湿等法进行治疗。

6.正虚：虚是指正气不足，实是指病邪盛实。虚症的出现，多因体质虚弱，久病伤正，或因出血、大汗、失精或因外邪侵袭，伤及正气等，从而形成“精气夺则虚”的虚症。抵抗力低下，不能抵御外邪的侵袭，从而导致疾病的发生。《内经》说：“正气存内，邪不可干”，“邪之所凑，其气必虚”。古人认为，肿瘤的形成与正气虚弱，脏腑功能失调，客邪留滞而气滞血瘀，痰凝湿聚，互相搏结，蕴郁于内，有着极其密切关系。

上述六种病因病机，在临床上常是几种因素相互交叉出现，互为因果，相互联系。如气滞血瘀，痰凝湿聚、痰瘀互结、邪实正虚等。但其主要是机体阴阳失调，正气虚弱，抵抗力低下，这是发病的主要因素，即内因。所谓外因，是指各种邪气，邪毒等因素长期不断侵袭，时而久之，导致肿瘤的发生。这说明，正气虚弱是形成积聚症瘕的内在根据。在一定条件下，外因也能起决定性作用，但主要还是需要通过内因而起作用。因为癌症是全身性疾病的局部表现，因此，在治疗癌肿时，除应用理气、活血、化痰、软坚、清热、利湿等病因疗法外，还必须从整体观念出发，调整脏腑、经络的机能，扶正祛邪，调动机体的内在因素，来达到消除肿瘤的目的。

现代医学认为，高脂饮食，低纤维素饮食，土壤环境中缺钼，大肠炎性疾患等与发癌有一定的关系。

【临床表现】

大肠癌患者的临床表现，主要取决于癌的位置、大小、类型、生长速度和病程长短等情况而异。

(一) 右侧结肠癌

1.消化不良症状(60%)：表现上腹不适、恶心、呃逆及饭后上腹胀气。局部可有压痛与病变部位一致。

2.中毒症状(30%)：由于右半结肠吸收能力强，所以中毒症状明显。表现消瘦、全身乏力、继发性贫血、恶液质等。贫血程度与癌肿大小有关，高度贫血者局部多可触及包块，贫血机制不明，可能因肿瘤坏死溃破合并感染，产生大量的毒素，吸收后影响骨髓造血功能或慢性失血所致。

3.包块(占10%)：患者多不自知，往往在体检时发现。一般为结节状、坚硬。当合并继发感染时，可伴轻度压痛。早期包块可活动，晚期因肿瘤浸润粘连而固定。

4.梗阻：甚少见。因右半结肠肠腔较大，肠内容物为流质。且癌肿多在肠壁一侧向肠腔突出，故不易发生梗阻。但肝曲结肠癌因肠腔较窄，管道变曲固定，同时该处肠管内容物亦较稠，而易于发生梗阻，表现下腹隐痛，肠蠕动亢进，便秘，或腹泻与便秘交替出现。

5.大便中带血：便中带血者可达80%，常因出血量甚少且与粪便混合均匀，故不易由肉眼看出，但潜血试验则常属阳性。

(二) 左半结肠癌

1.梗阻为主要症状(占87%)：因左半结肠肠腔狭窄，肠内容物已为半固体或固体，同时该部癌肿多为浸润癌，极易引起肠腔狭窄。形成急、慢性肠梗阻。常见腹胀不适，肠蠕动亢进，阵发性腹痛、便秘，或便秘腹泻交替出现，约有1/4患者有持续性腹泻，次数多而便量少，排出物含粪便、血液及粘液，称为假

性腹泻。有时患者因饮食不慎，或钡餐检查，可导致急性肠梗阻。

2.便血（75%）：脾曲以下病变的便血多为鲜红色或暗红色，约有1/4患者肉眼可以看到粘液血便。

3.中毒症状：因癌肿体积较小，即使有溃疡坏死，也无大量毒素吸收，故贫血、消瘦、恶液质等现象多不明显。

4.包块：一般不易触及。

5.穿孔：急性穿孔较少见。此时表现为腹膜炎（急性）。但因慢性穿孔而引起粘连和脓肿者较多。

（三）乙状结肠癌及直肠癌

1.排便习惯改变，常为早期症状（占50%），并伴便秘（55%）及假性腹泻（20%），或便秘腹泻交替进行。肠管狭窄时大便可成带状或水样便。如位置较低，每有排便不净，里急后重等症状。

2.便血最多见（80%~90%）：1/3患者以便血为初发症状。血色鲜红，量多少不定。当癌肿局限于粘膜时多不出血，只有侵犯粘膜下层血管时，始发生出血。故便血为初发症状，但并非早期临床表现。

3.中毒症状：晚期症状明显，有消瘦，全身乏力、贫血、恶液质等症状。

4.疼痛不适：半数以上病例有不同程度的疼痛，并且不因排便而消失。当癌肿侵犯直肠邻近组织器官时，可引起持续性疼痛，侵犯骶前神经丛时，可在直肠或骶前部有剧烈性持续性疼痛，并放射至下腹、腰部或下肢。侵犯骨骼时可出现坐骨、骶骨腰痛，并放射至髋关节及股部。病变如果累及前列腺或膀胱时，可出现尿频、尿血、排尿不畅等症状。如侵犯腹膜时，可出现腹部包块及腹水。此外，直肠癌周围的组织被侵犯合并感染，常形成脓肿及瘘管，偶见直肠尿道痿。

【诊断】

大肠癌早期症状轻微或不明显，易被患者所忽略。医务人员也常因经验不足，容易误诊为内痔或痢疾而贻误治疗。由于本病发展较慢，如能提高警惕，对于疑为大肠癌的患者能及时进行必要的检查，早期确诊一般并无困难。因此提高早期诊断的关键，首先应提高患者和医务人员对大肠癌的警惕性。凡 30 岁以上患者，有下列现象即疑有大肠癌的可能：

1. 正常排便习惯改变，有便秘、腹泻或便秘、腹泻交替出现及排便不尽等现象。

2. 大便中带血液及粘液。

3. 近期腹部持续不适、胀气或隐痛者。

4. 有原因不明的进行性贫血、消瘦、乏力现象。

5. 腹部可扪及肿块。

对上述大肠癌的可疑患者，除进一步询问病史和体格检查外，应立即进行下列检查或选择性检查，以期确定诊断：

1. 直肠指诊。

2. 肛门镜检查。

3. 结肠乙状结肠内窥镜检查。

4. X 线检查。

5. B 型超声扫描检查。

6. CT 扫描检查。

7. 细胞学检查。

8. 大便潜血试验检查。

9. 癌胚抗原检查。

10. 放射性同位素检查等。

【治疗】

一、中医药治疗

1. 湿热型：腹部阵痛，大便夹血，或里急后重，肛门灼热，恶心，胸膈等症，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

【治则】清热利湿。

【方药】槐花地榆汤或清肠饮加减。槐花、地榆、白头翁、败酱草、马齿苋、黄柏、苦参、生苡仁、黄芩、赤芍、炙草。

2.瘀毒型：烦热口渴，腹痛泻下脓血色紫暗量多，里急后重等，舌质紫或有瘀点等症，脉涩滞或细数。

【治则】化瘀解毒。

【方药】膈下逐瘀汤或桃红四物汤加减。

归尾、红花、桃仁、赤芍、丹参、生地、川芎、生苡仁、半枝莲、藤梨根、败酱草、炮山甲。

3.脾肾阳虚型：面色苍白，少气无力，畏寒肢冷，腹疼，五更泄泻。苔薄白，舌质淡，脉沉细无力。

【治则】温补脾肾。

【方药】附子理中汤，四神丸加减。

附子、党参、白术、茯苓、生苡仁、补骨脂、诃子、肉豆蔻、吴茱萸、干姜、陈皮、炙甘草。

4.气血两虚型：面色苍白，唇甲无华，少气无力，神疲懒言，脱肛，下坠，苔薄白，舌质淡，脉沉细无力。

【治则】补气养血。

【方药】八珍汤，当归补血汤加减。

党参、当归、茯苓、黄芪、熟地、白芍、川芎、升麻、白术、炙甘草、丹参、陈皮。

5.肝肾阴虚型：形体消瘦，五心烦热，头晕耳鸣，腰酸盗汗，遗精带下，舌质红或绛，少苔，脉弦细。

【治则】滋阴益肾。

【方药】知柏地黄汤加减。

郑州市大肠肛门病医院以滋阴益肾为治则。采用内服和灌肠并用的方法治疗中晚期大肠癌 35 例，根据 1978 年全国大肠癌科研协作会议订的大肠癌疗效评定标准。显效：触及可以测量之肿块（包括 X 线造影所见）消失或缩小一半以上能维持一个月以上者或症状明显好转，客观指标检查稳定维持半年以上，本组

30 例占 57.2%。无效：5 例占 14%。

二、中医药对放、化疗毒副反应的制约，由于放、化疗损伤机体正气，加之个体耐受性不同，常出现各种不同的毒副反应。

1. 副反应的主要症候和中医辨证

据国内外文献报道，在临床上常见的放、化疗副反应症候主要有：炎性反应；消化障碍；骨髓抑制；机体衰弱等。

以上诸症按照中医的辨证机理，主要是由于外来的毒邪侵入人体后造成机体内部热毒过盛，致使津液受损，气血不和、正气受损及肝肾亏虚等病理变化。

2. 主要治疗原则

(1) 放疗副反应的治疗原则。癌症患者在放疗中因出现的副反应症候群热象较重，热毒伤阴的症候较多，因此其主要治疗原则为：①清热解毒；②生津润燥；③凉补气血；④健脾和胃；⑤滋补肝肾。

(2) 化疗副反应的治疗原则：化疗副反应主要表现为损伤气血，脾胃失调及肝肾亏损等证候，而热毒及伤阴之症不如放疗反应严重，因此其主要治疗原则为：①补气养血；②健脾和胃；③滋补肝肾；④清热解毒。

3. 常用药物

(1) 清热解毒：银花、连翘、山豆根、射干、板兰根、蒲公英等。

(2) 生津润燥：生地、元参、麦冬、石斛、天花粉、芦根等。

(3) 补气养血：①凉补气血：生黄芪、沙参、西洋参、生地、丹参等。②温气养血：潞常参、太子参、红人参、白人参、全当归、熟地、鸡血藤、阿胶、三七粉、紫河车、龙眼肉、红枣等。

(4) 健脾和胃

①食欲减退：a.脾胃虚寒，饮食不香，以香砂六君子汤加

减。b.胸胁窜痛、胃脘饱胀等肝胃不和之症，以逍遥散加减。②恶心呕吐：a.呕吐苦水、酸水者多属胃热之症，以橘皮竹茹汤加减。b.呕吐清水、凉水者多为脾胃虚寒之症。以丁香柿蒂散加减。c.腹泻者参苓白术散及四神丸等加减。

(5) 滋补肝肾：枸杞子、女贞子、何首乌、山萸肉、菟丝子、杜仲、补骨脂等。

4.常用处方

(1) 恶心呕吐：处方：①半夏 12g，竹茹 12g，代赭石 30g，茯苓 12g，陈皮 9g，苏梗 12g，枳壳 9g，木香 9g。②刀豆壳或刀豆子 30g。③紫金粉二分（吞）。

(2) 食欲不振

处方：木香 9g，砂仁 3g，白术 12g，鸡内金 6g，陈皮 9g，山楂 12g，六曲 12g，麦芽 16g。

(3) 腹泻

处方：白术 12g，茯苓 12g，木香 9g，石榴皮 12g，甘草 3g。

(4) 血尿

处方：大小蓟各 15g，白茅根 30g，荠菜花 30g，瞿麦 15g，茜草根 30g。

(5) 血细胞及血小板减少

处方：①黄芪 12g，党参 12g，当归 12g，首乌 12g，熟地 12g，补骨脂 12g，女贞子 12g，墨旱莲 12g，炙甘草 3g。②茜草 30g，小茴香 3g。③花生衣炒干研末，每日 3 次，每次 30~90g。④刺五加片，每日 3 次，每次 3~5 片。

(6) 放疗后口干咽燥舌红

处方：石斛 9g，玄参 12g，麦冬 12g，天花粉 15g，知母 9g，芦根 30g，茅根 30g，石豆兰 15g。

(7) 放疗后便血

处方：①槐花末 30g，生地炭 30g，地榆炭 30g，伏龙肝

30g, 椿根皮 15g, 诃子 9g, 白术 9g, 陈皮 6g, 甘草 3g。②继木叶 30g。

三、单、验、复方治疗

1. 中医研究院广安门医院肿瘤科, 采用清热解毒, 扶正培本的治则, 配合化疗对中晚期大肠癌(术后) 62 例进行临床观察, 5 年生存率为 72.5%。10 年生存率为 75%。根据化疗副反应症候群辨证分型用药:

脾胃不和: 治则, 健脾和胃: 党参、白术、茯苓、陈皮、清半夏、生苡仁。

心脾两虚: 治则, 补益心脾: 党参、生芪、茯苓、当归、枣仁。

脾肾两亏: 治则, 健脾益肾: 党参、白术、枸杞子、女贞子、故纸、菟丝子。

若出血者, 加血余炭、仙鹤草、侧柏炭、三七粉等;

若疼痛重者, 加赤白芍、元胡、徐长卿、香附等;

若大便秘结者, 加瓜蒌仁、郁李仁、火麻仁等;

若大便溏泻者, 加熟薏仁、焦山楂、诃子肉、儿茶等。

2. 广州军区 157 医院肛肠外科, 采用中药熏洗治疗低位直肠癌、原位肛门重建术后, 出现肛门搔痒、干燥、湿疹、脓疱、肛门处粘液及大便次数增多等, 取得了较好效果, 显效率为 70%, 有效率为 25%。

方药: 苦参、地肤子、黄柏、五倍子各 30g; 干燥型加白鲜皮 30g; 潮湿型加冰片 10~15g。熏洗方法: 将上药加水 3000ml, 煮开后煎至 1000ml。滤出渣, 将药液倒入盆内, 每次熏洗 30 分钟, 边洗边训练缩肛, 然后再用药液外洗。每日二次或多次。

3. 中医研究广安门医院史兆歧采用 FA867 (五倍子) 等中药提取液, 直接注射直肠癌及周围组织, 治疗 31 例进展期和晚期直肠癌患者, 肿瘤明显缩小, 粘液、血便、大便次数明显好转。

适于直肠癌手术的晚期直肠癌可多次注射，本疗法对减轻患者临床症状，提高生存质量，延长生存期，提供了中药治疗的新途径。

4.成都痔瘘专科医院邓景隆等，自拟扶正抗癌方药“扶抗合剂”药味有：潞党参、黄芪、白术、白花蛇舌草、半枝莲、山楂、建曲、白芍、鸡血藤、麦芽、红枣。

5.湖南省中医药研究院，眭勋华采用菝葜合剂：菝葜 50g，桃仁 10g，红花 10g，川芎 10g，白花蛇舌草 30g，枳壳 15g，黄药子 30g，败酱草 30g，黄芪 60g，当归 10g，半枝莲 20g，穿山甲 10g，鳖甲 15g，酒军 10g，红梅消 30g。治疗肛管直肠癌 31 例，疗效满意。

6.作者经验：早期宜清热利湿和营解毒：方用：白头翁 60g，当归 5g，白芍 12g，丹参 12g，槐花 9g，白花蛇舌草 30g，地榆 15g，枳壳 12g，土茯苓 30g。后期体虚，加黄芪 60g。

7.《四川中医》1989 年第四期，任文俊经验：①熏洗方：蛇床子、苦参各 30g。加水 1000ml，煮沸后加入生军 10g 熬 2 分钟，将雄黄、芒硝各 10g 放入盆中，再将煮沸的汤药倒入盆内搅拌，乘热气上冒之际蹲于盆上，熏蒸肛门处，待水变温换为坐浴，每晚一次，3 个月为一疗程。②灌肠：鸭胆子 15 粒，白芨 15g，苦参、白头翁、徐长卿、乳香、没药各 30g。加水 1000ml 熬至 300~500ml，凉温后用空针抽取，由远侧端造瘘口推入，隔日一次，3 个月为一疗程。治疗 12 例（男 8，女 4）后，10 例肛门疼痛减轻；分泌物减少，精神好转，饮食增加；2 例因治疗过程症状加重，而中止灌肠。

8.通幽消坚汤（《浙江中医》1990 年第 4 期）：白花蛇舌草、槐角、槐花各 35g，龙葵、仙鹤草、地榆各 20g，当归、生黄芪、败酱草各 10g，穿山甲、昆布各 15g，三七参、生军各 5g，黄药子 30g。每剂煎取 400ml，每日早、中、晚 3 次分服。

加减法：便血不止加茜草、阿胶各 10g；大便不爽加炒莱菔子 30g、麻仁 15g；肿块不消加皂角刺 10g、农葵藜 15g；小腹坠胀加生黄芪 30g、木香 6g；脱肛不收加莲子 30g、刺猥皮 10g；小便涩滞加猪苓 30g、海金沙 10g；淋巴转移加黄药子、石上柏各 10g；子宫转移加农葵藜、半枝莲各 20g；肺转移加鱼腥草、全瓜蒌各 30g；肝转移加铁树叶 30g、刘寄奴 10g。方②槐花汤保留灌肠：槐花、鸦胆子各 15g，皂刺、血竭各 10g，白花蛇舌草、生军、败酱草各 40g。水煎，将 2 次药液混合，取汁 2000mg 每次灌肠保留 1~2 小时，每 7 日一次。方③掌心握药：全鲜大葱 9 根，大枣（去核）21 枚，巴豆（去壳）21 粒，黑砒霜 10g，将上药混合，捣成药饼，分成 3 个，每次用 1 个握手心，男左女右，外用净白布缠扎固定，每握 6 小时，休息 3 小时，日夜连续使用，隔天换药饼，分 7 天用完，休息一周后如上法再治再用。握药期间有发烧，口干反应，若手掌起泡即停止使用。以上三方同时使用，30 日为一疗程。治疗直肠癌 72 例，有效 20 例，无效 20 例；显效 13 例；经手术再用上法治疗 19 例，显效 3 例，有效 6 例，无效 10 例。

9. 抗癌 9 号（《浙江中医》1981 年第 12 期）：八角金盘、生山楂各 12g，石见穿、山慈姑、八月札、黄芪、鸡血藤各 30g，败酱草、党参、丹参各 15g，生军 6g，枳壳 10g。加减法：便血加槐花炭、侧柏炭；里急后重加黄连、木香、赤芍；大便不通加瓜蒌仁、皂角子等。每日 1 剂，水煎服，30 日为一疗程。方②抗癌栓 4 号：蟾酥、雄黄各 20g，白芨粉 15g，颠茄浸膏 5g，甘油明胶 65g，甘油 75g。以上量共制成栓剂 100 粒。制法：蟾酥、雄黄、白芨粉之，取细末加颠茄浸膏、甘油研成糊状物，另将甘油明胶烊化后，再将上述蟾酥等糊状物加入，不断搅拌均匀，倾入已涂过润滑剂的栓模内（鱼雷形），冷凝后取出蜡纸包装备用。用法：嘱患者取俯卧位，将栓剂一粒轻轻塞入肛门内，深达 10cm 左右，俯卧半小时，每日 2 次，30 日为一疗程。治

疗 47 例，存活期达 1 年 4 例，2 年 6 例。

10.《上海中医药》1988 年第七期，钱伯文经验：方①消瘤净：三七、壁虎、桂枝、地龙等制为片剂，每片含生药 1.5g，每日三次，每次 2~3 片，饭后服用，连服六个月为一疗程。方②石见穿、地榆、党参、茯苓、生苡仁、七叶一枝花、苦参、昆布、壁虎。水煎服。加减用药，枳壳、败酱草、丹皮、仙鹤草、白花蛇舌草、白术等。

四、化疗 结、直肠癌化疗适应证：

1.临床上认为原位癌、粘膜下浸润癌行根治性切除，病理切片证实肠系膜淋巴结无转移，肠管切口断末端发现癌细胞者，不需化疗。

2.临床上认为是根治性切除，但有肠系膜淋巴结转移或癌已浸润邻近器官和组织已切除者，可在手术恢复后（术后 3~4 周）开始化疗。

3.姑息性切除术后，可系统地应用联合化疗，第一年用 2~3 个疗程，第二年用 1~2 个疗程，以后根据情况决定。

4.晚期已有远处转移，或有局部浸润不能切除时，如患者全身情况良好，可作系统地化疗；全身情况差，应以中医中药治疗为主，酌情应用化疗。

五、放疗 放疗可提高治愈率和癌肿切除率。例如直肠癌作手术前放疗，能提高五年生存率 10%~15%，局部复发率降低 10%~15%。

六、加热治疗 加热治疗虽有一百年的历史，但七十年代以来此疗法才被重视。我国七十年代进行加热治癌的研究与临床应用。临床应用的加温方法：在国内加温治癌所使用的治疗机有超短波、微波和超声波。此外还有用热水灌注，利用太阳能加热等。最近也有用红外线加热和电热针加热的，除了用加热治疗机从体表向深部透入以外，腔内如食管，阴道，直肠的腔内辐射器已经应用。

用加热治疗直肠癌有一组报道。此组病例用腔内加热 43~46℃ 加体外放射治疗 24 例，其中 9 例加热与放疗（4000~4300 拉德）后做根治手术，2 例肿瘤基本消失，病理检查无癌，7 例肿瘤明显缩小，病理检查癌细胞退变部分坏死，张文满等单纯用微波加温治疗 13 例直肠癌，其中显效 3 例，有效 10 例。

七、冷冻治疗 冷冻治疗不仅能破坏癌组织，而且在复温后残余肿瘤组织可产生免疫物质，抑制肿瘤的生长。有学者用冷冻治疗中晚期肛管直肠癌其 5 年、3 年、1 年生存率分别为 34.1%、56%、90%，认为本疗法对晚期病人有减轻痛苦和延长寿命的作用。

八、预防

（一）积极治疗癌前病变——大肠腺瘤。

（二）合理饮食：适当降低膳食的脂肪和肉类含量，增加新鲜蔬菜、纤维素食物和水果。

（三）积极防治结肠慢性炎性疾病，对慢性溃疡性结肠炎、大肠炎、大肠克隆氏病要定期进行纤维结肠镜检查。积极防治与消灭血吸虫病。

（四）对大肠癌高发人群和地区定期进行普查。

（五）开展大肠癌致病因子抑制的研究。

（六）对五十岁以上的患者，应多做大便潜血及指诊检查。

第十四章 肾 癌

【概述】

肾脏肿瘤发病率较低，占各种肿瘤的1%以下，但肾脏一旦发现肿瘤，则大多数为恶性（约占85%），以肾癌和肾盂癌为常见，肾癌约80%发于肾实质，肾盂癌的20%发于肾盂的移行上皮，发病年龄多在40~60岁，男多于女3:1。欧美肾癌占全部恶性肿瘤的1.9%~3.4%，丹麦、新西兰、挪威发病率较高。

肾癌的转移差异很大，有的瘤体巨大，却无远处转移，有的瘤体很小却有远处转移，这可能是由于癌细胞的恶性程度不同所致。肾癌可向内、外扩展，内侵肾髓质和肾盂，外达肾周围组织，如癌细胞侵入静脉，则可能血行转移播散，最常见的部位为肺、骨、淋巴结，其次为肝；胰腺、脑等。肾盂癌由于与输尿管、膀胱同属移行上皮，又处于同一的致癌因素作用下，所以肾盂癌可同时伴有输尿管或膀胱癌。因早期诊断困难，故治疗后5年生存率为40%~50%，10年生存率为20%。肿瘤的大小、数目、部位、病理级别和浸润范围等都直接影响预后。

【病因病机】

根据祖国医学的理论，认为本病是肾气不足，水湿不化，湿毒内生，或外受湿热邪毒，入里蓄积，内外合邪结于水道所致；多见于年龄较大者肾气衰弱之人，易为邪毒所侵。肾虚不能摄血而溺血尿；腰为肾之府，肾虚则腰背痛；湿热毒结于内，日久气滞血瘀而形成肿物包块。

现代医学对肾癌和肾盂癌的病因亦尚不明，认为可能与致癌物质长期刺激作用有关，如吸烟者肾癌发病率较高，长期服用解热止痛药如非那西汀药物等常发生肾盂炎，肾盂癌的发病率亦有所增加。一些化学致癌物质在动物实验中也可能诱发肾肿瘤。

但是，外来化学致癌物质是个条件，著者认为：外因通过内因而起作用，由于患者本人的肾气不足，体内代谢失常，机体将有害物质转化为无害物质的能力减退，使排泄物中含有的致癌物质作用于尿路而引起。这方面很值得进一步研究探讨，对预防本病的发生将发生很大的作用。

（一）临床表现：肾癌和肾盂癌的三大主要症状是无痛血尿、腰部或上腹部肿块、腰痛。

血尿是肿瘤侵及肾盂溃破后出现，所以肾盂癌出现血尿多早，占就诊主诉的 90%；肾癌则只有 56% 患者有血尿，而且也不是早期信号。血尿的特点是无痛性、间歇性血尿，如临床出现以上症状者，均必须要追查，以便及早诊断。触及到肿块时，显示病已非属早期，肾盂癌出现被触及的肿块者较肾癌为少；腰痛常因肿瘤增大，造成拉牵及压迫周围组织而引起，晚期患者也可出现贫血、消瘦及恶病质等。

（二）实验室检查：应多次检查尿液，如发现血尿而又无明确原因者，均应高度重视进一步检查。尿的脱落细胞学检查，对早期诊断有一定的意义。必要时通过膀胱镜分别收集两侧肾盂尿作细胞学检查，膀胱镜检查还能排除膀胱肿瘤所引起的血尿和细胞学阳性。

（三）X 射线检查：腹部平片观察肾形大小、形状和位置。静脉或逆行泌尿系造影是传统的检查方法，对肾肿瘤诊断有重要意义。近年来，应用静脉注射显影剂作 CT 扫描摄影，及核磁共振扫描断层摄影，又进一步提高了对肾肿瘤的诊断水平。

【治疗】

一、辨证施治

（一）湿热伤肾

【主证】腰部疼痛，坠胀不适，尿黄带血或有低热，食少纳呆，肢体困重，腰腹部肿块，舌苔黄腻，脉象滑数或弦数。

【分析】本型主要病机是湿热下注，肾气受伤。由于过食肥

甘，嗜酒厚味，蕴湿生热，湿热内蕴下注，伤及肾气，灼伤血络，故腰痛坠胀，尿血，或有低热。湿浊伤及脾胃，运化失健，故食少纳呆，肢体困重。湿蕴生痰，痰浊凝聚，瘀血阻滞，久之产生积块，故腰腹部出现肿块。舌苔黄腻，脉滑数或弦数皆为腹部出现肿块。舌苔黄腻，脉滑数或弦数皆为湿热之象。

【治法】清热利湿，解毒化瘀。

【方药】小蓟饮子加减。

【方解】小蓟饮子源于《济生方》。方中滑石、木通、竹叶、栀子清热利湿；小蓟、藕节、蒲黄、生地凉血止血，并能祛瘀，其中生地又能养阴益胃益肾；当归养血和血，引血归经；甘草缓急止痛，调和诸药。

【加减】加白花蛇舌草、土茯苓、生薏苡、赤芍等解毒化瘀抗癌；痛甚者加白芍配甘草缓急止痛。

（二）肾亏余毒型

【主证】肾癌或肾盂癌已作手术切除，病灶周围有粘连，或淋巴管，小静脉内发现癌栓者，腰部酸痛，身体虚弱，神疲乏力，偶有低热者，舌质淡红，苔薄白，脉细滑或沉滑。

【分析】本型主要病机是肾亏气虚，余毒留恋。毒邪伤肾，又加手术后气阴耗伤，以致肾气亏虚，故腰部酸痛，神疲乏力，体质虚弱；术后毒邪未尽，故偶有低热等症状。

【治法】滋肾补气，解毒化瘀。

【方药】大补元煎源于《景岳全书》方中熟地黄、山药、枸杞子、山茱萸、杜仲滋肾阴补肾气；人参、炙甘草益气健脾；当归养血和血。

【加减】加生黄芪、白术、茯苓以增强补气健脾之功。加土茯苓、半枝莲、瞿麦、丹参以解毒利湿化瘀。低热不退者加地骨皮、鳖甲以清退虚热。

（三）湿热瘀毒型

【主证】久病尿血不止，腰痛加剧，腰部或腹部肿块日渐增

大，伴有发热口渴，饮食减少，恶心呕吐，舌苔黄腻，舌质暗红，脉滑数或弦滑。

【分析】本病主要病机为湿热毒结，瘀血阻滞。病久不愈，湿热蕴结成毒，血络损伤，故尿血不止，发热口渴；瘀阻气滞，湿浊瘀血凝结，故腰部或腹部包块渐增大，腰痛加剧；湿热毒邪伤及脾胃，浊气上逆，故食少，恶心呕吐；苔黄腻，质暗红，脉滑数均为湿热瘀毒之征。

【治法】清利湿热，解毒散结。

【方药】琥珀散加减。

【方解】琥珀散源于《医方集解》。方中滑石、木通、扁蓄清利湿热；琥珀化瘀止血；当归引血归经；郁金、木香行气散结止痛。

【加减】加白英、龙葵、蛇莓、半枝莲、土茯苓解毒抗癌；加大小蓟、仙鹤草以加强清热止血之功。加黄柏、瞿麦、竹叶以增加清利湿热之力；加元胡以增强止痛之功；恶心呕吐甚者加竹茹，代赭石降逆止呕。湿热伤阴，脉细数者，去木通加生地、阿胶养阴血。

（四）气虚血亏，毒热瘀结。

【主证】气短乏力，面色苍白，心悸心烦，形体消瘦，肿块或病灶日见增大增多，包块疼痛，口干，低热，舌苔白或黄白，舌质淡有瘀点，脉沉细数或虚大而数。此时病已至晚期。

【分析】本型病机要点是正虚瘀结，毒邪肆虐。病至晚期，气血大亏，正气衰退，故气短乏力，面色无华，心悸心烦，形体消瘦；毒热瘀结，故见肿块日渐增大，病灶日见增多，包块疼痛，低热，口干；脉舌表现均为正虚毒邪瘀结之象。

【治法】补气养血，解毒化瘀。

【方药】十全大补汤加味。

【方解】十全大补汤源于《太平惠民和剂局方》。由四君子汤和四物汤加黄芪、肉桂组合而成。方中黄芪与四君子汤补气健

脾：四物汤养血调血；少佐肉桂以助生血之气。

【加减】加干蟾皮、半枝莲、瞿麦、猪苓解毒利湿抗癌；加赤芍、僵蚕、土元化瘀散结止痛；加鳖甲、地骨皮以软坚、退虚热。食少纳呆加砂仁、鸡内金、麦芽；恶心呕吐加竹茹；肾阴耗伤，易熟地为生地。

【按语】以上辨证分型是治疗肾癌的一般辨证施治规律，临床病情变化复杂，可随症辨证加减用药。肾癌常用的抗癌中草药有蛇莓、白英、龙葵、草河车、半枝莲、土茯苓、海金沙、猪殃殃、鸭跖草、干蟾皮、斑蝥、瞿麦、扁蓄、猪苓、木通、黄柏、苦参等。

二、单方、验方

（一）单方

- 1.马鞭草：每日 60~120g，水煎分三次服。
- 2.生苡仁：每日 120g，水煎分早晚两次服。
- 3.活蟾蜍：每日 2 只，纱布包煮烂，取汁每晚睡前内服，连服三天停数日，防止中毒反应。

4.刀豆子 30~60g，生苡仁 60g，赤小豆 60g，水煎分早晚二次服。

5.小蓟 30~60g，瞿麦 30g，菝葜 30g，石打穿 30g，白花蛇舌草 30g，薜荔果 30g，京赤芍 15g，炮山甲 15g，补骨脂 10g，川断 30g，牛膝 30g。水煎分早晚二次服。每日一剂。

（二）验方

1.龙蛇羊泉汤：龙葵 30g，白英 30g，蛇莓 30g，海金沙 15g，土茯苓 30g，灯心草 3g，白花蛇舌草 30g，威灵仙 15g。水煎，每日早晚分服。

三、中西医结合治疗

肾癌和肾盂癌目前仍以手术切除治疗为主。但由于发现较晚，大多数肾癌确诊时已有广泛局部浸润及淋巴结转移，或有远处转移而未能切除；有些病例虽已作手术切除，但仍容易发生远

处转移，所以仍需与放疗、化疗、激素治疗和中医药治疗等结合，采用综合治疗以提高疗效。

由于肾癌对放射线多不敏感，单纯放疗效果不好，但作为手术后放疗，或已有局部浸润、肾静脉中有瘤栓及局部淋巴结已有转移的病例，能延长手术后生存率，放疗过程中，辨证地配合中医药治疗，可减少放疗反应。对孤立的远处转移灶亦可作姑息性放疗。

化疗对肾癌的作用较差，对晚期肾癌部分病例有一时效果，有的对肺转移灶经化疗后阴影缩小、稳定，延长了生命。除烷化剂外，近年来试用阿霉素、羟基脲、环己亚硝脲等。凡属于肾癌手术切除后病理发现有瘤栓的患者，手术后给予多程联合化疗加中药，常能减少复发和转移。在手术后放疗、化疗期间给予中医药扶正治疗，在放疗、化疗结束后或两程化疗之间应以扶正祛邪中医药治疗，对延长生命是有益的。

激素治疗：由于考虑肾癌和内分泌有关，故临床曾对晚期肾癌试行激素治疗。孕激素治疗肾癌有效率为14%~20%。安宫黄体酮，每日三次，每次100mg，口服。用药6~8周后，如不效可改用丙酸睾丸酮，每次肌注100mg，一周3~5次，如仍无效，再改用乙烯雌酚，每日三次，每次5~10mg，仍无效时，最后改用强的松，每日四次，每次5~10mg。有的患者用安宫黄体酮期间有低热，停药后即可恢复正常。

第十五章 膀胱癌

【概述】

膀胱癌是泌尿系统最常见的肿瘤之一。占全部恶性肿瘤的3%。据调查，我国年发病率男性为4.021/10万人口，女性为0.929/10万人口，男性多于女性，约3.2:1。发病年龄多在50~70岁之间，罕见于30岁以前。在一些国家里，膀胱癌占男性恶性癌症死亡的第7位，占女性的第13位。在美国占男性恶性肿瘤的第5位，占女性第11位。

膀胱癌90%以上是移行上皮细胞癌，而鳞状细胞癌和腺癌均属少见，不到10%。呈乳头状型（80%~90%）和浸润型（10%~20%）生长，多为单发。膀胱三角区最多，侧壁次之，膀胱颈部、后壁、顶部、前壁更次之。晚期可侵犯子宫或直肠，或前列腺，亦可经淋巴管向髂窝淋巴和腹主动脉旁淋巴结扩散。经血液可转移至肝、肺、骨、肾上腺、结肠等。患者若不治疗从出现症状到死亡平均只能生存16个月，约42%的病人生存1年，16%生存2年，生存5年仅占5%。

膀胱癌患者绝大多数在50岁以上，说明肾亏体虚是发生本病的根本原因。膀胱为州都之官，气化而利小便，肾为水脏，主气化、肾虚气化不利，水湿不化，郁积成毒，湿毒化热，蕴结膀胱，灼灼血络，迫血妄行，而致尿血。或脾肾亏虚，不能摄血，导致尿血。或外受湿热邪毒，下注膀胱，灼伤血络，而致血尿。若经久不愈，气滞血瘀，尿液潴留，毒邪腐肉，阻塞膀胱，导致尿痛，发烧乃至贫血，衰竭等征象，而形成本病。

现代医学对膀胱癌的病因学进行了深入研究，认为与接触2-萘胺、1-萘胺、联苯胺、环己氨基酸钠等化学致癌物质有关。还认为膀胱癌与内源性的色氨酸及菸酸代谢异常有关，而慢

性感染，病毒和慢性刺激（结石、血吸虫卵）使膀胱上皮失去正常防御功能，也可能与发病有关。另外，有材料表明，膀胱肿瘤与吸烟有关系。

【诊断要点】

（一）临床表现：血尿为膀胱癌最常见的起始症状，且多数为肉眼血尿。而且多为反复出现的无痛性、间歇性全血尿，严重时可出现血块。肿瘤本身浸润较广较深，或并发膀胱炎时，可出现尿急、尿频、尿痛等膀胱刺激症状。晚期肿瘤坏死，感染时可有腐肉样物质排出，肿瘤本身或血块的堵塞可造成排尿困难，产生尿潴留，或尿失禁，甚至发生尿毒症。全身症状出现恶心、食欲下降、发热、消瘦、贫血、衰弱、恶病质、类白血病反应等。

（二）膀胱镜检查：是确定膀胱肿瘤诊断的重要方法。可直接看到肿瘤生长部位，大小，形状，数目，有无蒂及浸润范围并可作活组织检查。

（三）尿脱落细胞检查：膀胱癌病人约85%以上在尿中可查到癌细胞，方法简便，阳性率高。只有少数呈假阳性。

（四）膀胱双合诊检查：有助于了解肿块的性状、大小、硬度及浸润深度等。

【治疗】

一、辨证施治

（一）肾虚不固型

【主证】无痛性血尿，呈间歇性，腰膝酸软，神疲体倦，头晕耳鸣，舌质淡红，脉沉细无力。

【分析】本型病机要点是肾气不固，气不摄血。肾气不足，不能固摄，故小便反复出现间歇性无痛性血尿；腰者肾之府，肾亏气虚故腰膝酸软，神疲体倦；肾虚不能上充于脑，故头晕耳鸣；脉沉细无力，为肾亏之象。

【治法】补肾益气，固摄止血。

【方药】无比山药丸加减。

【方解】无比山药丸源于《太平惠民和剂局方》。方中熟地、山药、山茱萸、淮牛膝填精补肾；菟丝子、杜仲、巴戟温补肾气；五味子、赤石脂益气固摄，泽泻清泄以防滋腻。

【加减】可加生黄芪、仙鹤草、血余炭补气止血；必要时再加牡蛎、补骨脂固涩止血；畏寒神怯，腰脊酸痛者，或加鹿角片、狗脊温补督脉。

【变证】阴虚火旺：肾阴亏虚，虚火内炽，灼伤脉络。证见小便不畅，短赤带血，腰部酸痛，头晕耳鸣，潮热颧红，形体消瘦，苔薄，质红尖绛，脉细数。治宜滋阴降火，凉血止血。方用知柏地黄丸（知母、黄柏、生地黄、山茱萸、山药、丹皮、泽泻、茯苓）合大补阴丸（知母、黄柏、熟地黄、龟板、猪脊髓）加减。

（二）湿热下注型

【主证】尿血鲜红，尿道灼热疼痛，尿频尿急，少腹作胀，或有低热，舌苔黄腻，舌质红，脉象滑数。

【分析】本型病机要点是湿热毒邪，下注膀胱。湿热下注膀胱，热盛伤络，迫血妄行，以致小便涩痛带血；膀胱气化不利，故尿急尿频，少腹作胀，苔黄腻，脉濡数，皆为湿热之象。

【治法】清热利湿，解毒通淋。

【方药】八正散加减。

【方解】八正散源于《太平惠民和剂局方》。方中扁蓄、瞿麦、木通、车前子、滑石清热利湿通淋；大黄、栀子、甘草清热泻火解毒。

【加减】加大小蓟、白茅根以加强凉血止血的作用，加龙葵、土茯苓、白英、蛇莓、海金沙解毒抗癌；血多痛甚者，可吞参三七、琥珀粉。舌质紫黯有瘀者，加桃仁、赤芍、当归。

（三）瘀毒蕴结型

【主证】尿血，有时尿出血块，甚则尿出腐肉，恶臭，排尿困难或癃闭，少腹坠胀疼痛，可伴尿急尿频，舌质暗紫，脉沉弦

或弦滑数。

【分析】本型病机要点是瘀毒内阻，蕴结膀胱。热毒蕴结膀胱，灼伤血络，故尿血或带血块；热毒腐肉，随尿而出，故甚则尿出腐肉恶臭；膀胱气化不利，故可出现排尿困难，甚则癃闭。气滞血瘀，肾气受伤，故少腹坠胀疼痛。舌质紫暗，脉沉或弦滑数，均为瘀毒之象。

【治法】清热解毒，活瘀化症。

【方药】龙蛇羊泉汤加减。

【方解】龙蛇羊泉汤源于《上海第一人民医院》。方中龙葵、白英、蛇莓、土茯苓、白花蛇舌草、蜀羊泉解毒抗癌。威灵仙、海金沙、灯心草化症通淋。

【加减】可加黄柏、苦参、赤小豆、车前子、连翘清热解毒利湿。加当归、赤芍活血化瘀；发热者，加大青叶、蒲公英、二花；尿血不止加三七粉、云南白药，仙鹤草、血见愁、大小蓟、白芨、阿胶；尿混浊者，加草薢、瞿麦、扁蓄、射干；大便秘结者，加大黄或番泻叶。膀胱癌常用的抗癌中草药见肾癌肾盂癌。

二、单方、验方

（一）单方

- 1.金钱草：每日30~60g，水煎服。
- 2.石苇：每日30~60g，水煎服。
- 3.瞿麦：每日30~120g，水煎服。
- 4.过路黄30g，木通15g，泽泻15~20g，泽兰15g。水煎服，每日一剂，分早晚两次服。
- 5.刀豆子60g，生苡仁60g，赤小豆60g，水煎服，每日一剂，分早晚两次服。

（二）验方

- 1.白龙汤：白花蛇舌草60g，龙葵30g，瞿麦30g，茜草30g，野葡萄根30g。
- 2.天土汤：天葵子15g，土茯苓30g，土贝母30g，石苇

30g, 瞿麦 30g, 丹皮 15g, 生薏苡 30g。

3. 王元甲汤: 王不留行 30g, 威灵仙 30g, 小蓟 30g, 猪苓 30g, 赤芍 15g, 败酱草 30g, 炮山甲 15g, 甜菜 60g, 元胡 15g, 瞿麦 30g。

4. 枯痔液局部注射: 在膀胱镜下, 应用枯痔液行瘤蒂及根部粘膜下注射。治法是注射 6~10 ml, 两周后作膀胱镜检查, 如肿瘤未坏死脱落, 可重复注射一次。适用于单发蒂与非浸润型膀胱肿瘤。对于多发肿瘤 4 个以内者亦可采用此种疗法。有的肿瘤缩小之后加电灼而愈。

三、中西医结合治疗

(一) 中医药加手术治疗

膀胱癌的手术治疗仍是目前首要的治疗手段, 包括经尿道切除或电烙术; 膀胱切开电烙或肿瘤局部切除合并电烙术; 膀胱部分切除术; 膀胱粘膜剥脱术及全膀胱切除术, 近年来, 主张早中期保留膀胱, 手术后配合药物治疗; 手术前可作放疗, 疗效较单纯手术者有所提高, 手术后以中药扶正祛邪法维持治疗, 可以减少复发。中药不仅能抑制癌细胞, 而且能提高患者的细胞免疫功能, 以及改变和调整机体内环境, 使不利于瘤细胞再发和生长。

(二) 中医药与化疗相结合

膀胱癌患者单用化疗疗效较差, 常用来配合手术, 作电灼术后局部灌注, 常用的灌注药物有噻替哌、喜树碱、三甘醇甘油二酸酯醚等。化疗若与中药结合则疗效可大为提高。有人报导用山豆根浸膏片口服, 喜树碱局部灌注及中药煎剂扶正抗癌方治疗 53 例膀胱肿瘤, 总有效率为 86.8%, 肿瘤全消率 3.8%, 显效 62.2%, 有效 20.7%, 无效 13.2%, 在显效和有效的 44 个病例中, 有 37 例经加用膀胱电灼或电刀切除, 获得临床治愈者占全组病例的 70%。

膀胱癌全身性抗癌治疗常用噻替哌、氟脲嘧啶、丝裂霉素、环磷酰胺、氨甲喋呤、阿霉素、喜树碱、顺铂、卡铂等。为了减

轻或避免毒副反应，或合用健脾益肾，补养气血等中药。如中医研究院升血一号方（太子参、白术、茯苓、当归、黄芪、橘皮、竹茹、枸杞子、女贞子、何首乌、石苇、大枣等）。又如中国人民解放军总医院用扶正抗癌一号方（党参、黄芪、茯苓、女贞子、桑寄生、白花蛇舌草），或服扶正抗癌二号基本方（沙苑子、山慈姑、寄生、猪苓、白花蛇舌草）配合化疗，都起到了提高疗效，增强免疫功能，减轻毒副反应的作用。

（三）中医药与放疗相结合

放疗多用于中晚期不适于手术或作为姑息性治疗以缓解出血和疼痛。根治性放疗对较早期的患者效果好，现在用于手术前放疗与膀胱部分切除术后，对中晚期患者尚可取得较好疗效。但中药配合放疗的临床研究较少，初步认为部分中药具有放射增敏作用，能够提高临床疗效。采用益气滋肾，清热利湿通淋等方法配合放疗，可减轻放疗反应，增强体质，改善生存质量。

第十六章 阴茎癌

【概述】

阴茎癌是男性泌尿生殖系常见肿瘤之一，其发率与卫生条件有密切关系。据有关文献报道，欧美各国发病率较低仅占男性全部恶性肿瘤的1%，而第三世界原来卫生条件较差的国家，阴茎癌的发病率是相当高的，牙买加人和南非班图人发病率最高，加拿大和以色列发病率最低。亚洲各国也高达20%，中、日两国较多。例如在50年代我国阴茎癌的发病率占全部泌尿生殖系肿瘤的44.4%~51.6%，但至70年代末期，发病率已明显下降。发病年龄大多在40~60之间，亦有报道为60岁以上。现代研究发现，阴茎癌的发生与包茎及包皮过长有非常密切的关系。包皮垢淤积于包皮腔内长期刺激，导致该部细胞增殖过度而发生癌变。犹太男婴出生后2~3星期内，即根据宗教要求作包皮环切术，所以极少发生阴茎癌。伊斯兰教徒，在3~14岁内作包皮环切术，发生阴茎癌亦少见。这说明儿童早期行包皮环切术是预防阴茎癌的有力措施。然而瑞典男性极少作此手术，亦很少发生阴茎癌，有关专家认为这很可能与他们注意阴茎局部卫生有关，当然确切的原因还有待于研究。

阴茎癌的病理一般分为乳头状型和浸润型。乳头状型多由丘疹或疣状病变开始，表面呈多叶状，高低不平，时有溃疡，其上有奇臭的分泌物，最后呈典型的菜花样；浸润型多由湿疹或白斑样病变开始，表面呈结节状，灰白色，质较硬，体积不大，但其基底可深入海绵体，生长较快。晚期肿瘤可侵入尿道，甚至累及全阴茎。阴茎癌要注意与阴茎尖锐湿疣、阴茎乳头状瘤、硬下疳、干燥性闭塞性阴茎头炎相鉴别。其病理组织学分类几乎全部为鳞状上皮癌，阴茎腺癌罕见。国内资料统计，阴茎癌发生于阴

茎头为 44%~73.9%，包皮为 9.4%~41%，冠状沟为 9.4%~12.5%，包皮系带 4.4%，阴茎体部为 2.9%。阴茎癌的恶性程度取决于癌细胞的分化程度，Broders 根据细胞分化程度将阴茎癌分为四级：Ⅰ级：75%以上为分化良好的鳞状细胞。Ⅱ级：50%以上鳞状细胞分化良好。Ⅲ级：25%以上鳞状细胞分化良好。Ⅳ级：为未分化癌，细胞分化不到 25%。

其临床分期多采用 Jackson's 法，将阴茎癌分为四期。Ⅰ期：肿瘤局限阴茎头及包皮。Ⅱ期：肿瘤浸润阴茎干，无转移。Ⅲ期：肿瘤局限于阴茎干，有腹股沟转移。Ⅳ期：肿瘤超出阴茎干之外，有淋巴结转移，不可切除，或有远处转移。阴茎癌主要经淋巴结及髂外脉管淋巴结，也有少数病例经血运转移到肝、肺、心、肾、肋骨等。阴茎癌恶性度较低，转移较晚，早期治疗，预后颇佳。如无淋巴结转移者五年治愈率为 20%~40%。如不经有效治疗，多于 2~3 年内死亡。

阴茎癌祖国医学称“肾岩”。因其后期溃烂，翻花若石榴子样，故又称“肾岩翻花”，俗名“翻花下疳”。按此则本病既可归属于“岩”证范畴，又可从“疳疮”论治。本病始见于清代高秉钩所著《疡科心得集》中，对阴茎癌的症状及病因病机有详尽的描述。据病变的进程可分为三期。

初期：感包皮内刺痒，内热或疼痛，在冠状沟附近生一硬结，如竖肉之状，或有奇臭脓液，或有血性分泌物流出。

中期：1~2 年后，阴茎肿胀，竖肉增大，如果穿包皮或突出包皮口，可见翻花石榴状。

晚期：龟头破烂，凹凸不平，触之易出血，气味异臭，痛苦不堪，有时突然鲜血如注，但少有影响便溺，腹股沟部可触及肿块，坚硬如石，根脚不活，甚至大腿肿胀，皮色褐红，状如丹毒。伴有饮食无味，形瘦神萎，体力不支等症状。

【病因病机】

祖国医学认为本病的发生原因与机理，既有内部的因素，又

有外部的原因。《疡科心得集·辨肾岩翻花绝症论》说，本病“由其人肝肾素亏，或又郁虑忧思”而发；《马培之医案》更进一步指出肾岩乃“肾脏阴虚，火郁心肝，二脏之火，复会于此”所致。现代中医学家对肾岩病因病机的认识有较大发展，其中当代著名外科医家施汉章先生在《中医外科学·肾岩翻花》中论述最为精要。

一、秽毒侵染

包皮过长，包茎长期垢秽痰浊淤积，侵染龟头，聚结不散，则“蓄积留止，大聚乃起”，发生癌变。西医学也认为阴茎癌与包皮、包茎有密切关系。马腾骧等报道阴茎癌 92.1% 有包茎、包皮过长史，潘天明报道为 100% 包茎包皮过长造成慢性炎症长期刺激包皮内板和龟头，使上皮细胞间变，诱发癌肿发生。

二、肝经湿毒

本病发生，多由肝肾阴虚，忧思郁虑，相火内灼，水不涵木，肝经血燥，而肝之经脉络阴器，久之损者愈损，阴精消涸。络脉空虚，肝以湿毒下注，火邪郁结，灼津为痰，痰火郁结聚于阴茎而成肾岩。

【治疗】

一、辨证施治

本病临床经过可分为初期、中期及后期，结合病因，脏腑辨证，基本上可按初期（肝郁痰凝型）、中期（肝经湿热与阴虚火旺型）、后期（气血两虚型）论治。但本病古谓“四大绝症”之一，病势险恶，变化多端，则又非以上四证所能概括，仅言其大概而已。

1. 肝郁痰凝型

【主证】肾岩初起，阴茎头处有丘疹、结节、疣状物，逐渐增大，无痛或微痛，自觉局部痒，伴两胁胀满，郁闷不舒，少腹不适。舌苔薄白或白腻，脉弦或滑。

【分析】阴茎为宗筋所系，而肝主宗筋，前阴为肾之外窍。肾亏而水不涵木，悲怒忧思，令肝失疏泄，痰浊凝结，不仅阴器

局部出现硬结，渐见增大，且可出现肝郁不舒的症状。

【治则】疏肝解郁，软坚化痰。

【方药】散肿溃坚汤加减，常用柴胡 10g，白芍 25g，归尾 15g，龙胆草 10g，黄芩 15g，黄连 6g，黄柏 30g，三棱 10g，瓜蒌 30g，昆布 30g，桔梗 6g，葛根 10g，甘草 6g。

【方解】柴胡疏肝；胆草、三黄、葛根清热燥湿解毒；昆布、瓜蒌、三棱、归尾活血化瘀，软坚散结；白芍柔肝和阴；桔梗、木香合用宣通三焦气机；甘草解毒和诸药。

【加减】此方药物较多，临证可根据病邪轻重而化裁，并可酌加半枝莲、山豆根、土茯苓等。

2. 肝经湿热型

【主证】肾岩中期，状若翻花。肿胀疼痛，岩肿溃烂污秽，腐臭难闻，伴心烦口渴，小便不畅，涩痛短赤。舌质红，苔黄腻，脉弦数。

【分析】湿热蕴结，聚毒化火，血脉淤滞，皮肉腐坏，故肿块溃烂如翻花状；湿毒浸淫，则渗流血脓样分泌物，奇臭难闻；湿热侵扰膀胱，则小便涩痛短赤；循经上攻则口渴心烦。舌苔黄脉弦数为肝经湿热之征。

【治则】清热利湿，解毒消肿。

【方药】龙胆泻肝汤加味常用柴胡 10g，胆草 15g，山栀 20g，黄芩 15g，木通 10g，泽泻 20g，车前子 30g，当归 30g，生地 18g，半边莲 30g，藤梨根 20g，龙葵 10g，甘草 6g。

【方解】龙胆泻肝汤功能清肝泻火，利尿祛湿，善治肝胆湿热证。胆草、山栀、黄芩清泄肝火，柴胡疏肝泄热，木通、泽泻、车前子利尿泄湿，当归、生地养血柔肝，甘草解毒调诸药，加半边莲、藤梨根、龙葵以益解毒消肿之功，三味合用有抗癌之效。

【加减】正气不衰者，可加用夏枯草、蛇舌草、僵蚕；若虚火内炽，改用知柏地黄丸加味以滋阴降火。

3. 阴虚火旺型

【主证】肾岩中期，局部溃烂，痛若汤泼火灼，且有血性渗出物，腐臭难闻。伴腰酸疼痛，口渴咽干，神乏无力，胃纳不佳，全身消瘦，头晕失眠，耳鸣眼花。舌红少苔，脉细数。

【分析】肾阴亏损，水不涵木，相火内炽，又夹湿火邪毒，壅阻经脉，化腐溃烂。外损阴器，内害脏腑，损者愈损，阴津消涸，故见一派阴虚火旺之象。

【治则】滋阴降火，软坚解毒。

【方药】大补阴丸加味。常用生地 30g，玄参 30g，女贞子 15g，旱莲草 15g，知母 15g，黄柏 20g，白芍 15g，丹参 30g，白英 30g，龙葵 10g，白花蛇舌草 30g，藤梨树根 18g。

【方解】方中生地、玄参、女贞子、旱莲草等滋水涵木，知母、黄柏泻火，白芍柔肝，丹参活血，白芨、龙葵、蛇舌草、藤梨根解毒攻坚，合而用之，共奏滋肾养肝，生水涵木，泻火解毒之功，必要时可佐服鳖甲煎丸软坚散结。

4. 气血双虚型

【主证】肾岩晚期，阴茎溃烂脱落，疮面肉色淡红，或暗红无泽，或疮色紫暗，迟不长出新肉。身体瘦弱，饮食不思；或术后岩肿虽去，神疲乏力，少气懒言，面色㿠白，舌淡少苔，脉沉细弱。

【分析】病届晚期，肿块虽脱（或因手术，或由药物外蚀），而脏腑已衰，气血俱损，尤以放疗、化疗患者更为显著。气血衰败，新肉无滋生之源，故疮面淡白或暗红无华，甚则紫暗，迟不长新肉。气血不充，则神疲体弱，面色㿠白，舌淡少苔，脉沉细弱等接踵而至，令本病所发，正气已先告亏。

【治则】扶正固本，佐以解毒软坚。

【方药】人参养荣汤加味。常用党参 15g，黄芪 30g，白术 15g，云苓 10g，陈皮 10g，当归 30g，熟地 20g，白芍 20g，肉桂 10g，五味子 10g，远志 15g，夏枯草 30g，土茯苓 15g，半枝莲

30g, 大枣 10 枚, 甘草 10g。

【方解】党参、黄芪、白术、云苓、陈皮、大枣补脾益气, 以资生化之源; 当归、熟地、白芍、肉桂等, 养阴和营, 生化血液; 五味子、远志养肺阴而宁心神。综观本方, 立意于脾肺。盖脾为生化之源, 脾旺则气血充盈; 肺主一身之气, 肺气充足, 则一身气机旺盛。伍用夏枯草、土茯苓、半枝莲等, 既得其补虚之宗旨, 又有益于抑其癌毒之扩散, 事半功倍, 全在左右变通。

二、单方、验方、成方(药)

(一) 单方

1. 马齿苋 120g, 水煎服。
2. 土茯苓 120g, 水煎服。
3. 淡竹叶 60~100g, 水煎服。
4. 白花蛇舌草 60~100g, 水煎服。
5. 六方藤 50g, 水煎服。
6. 蟾蜍酒 10ml, 每日三次, 口服。
7. 菝葜 120g, 水煎服。
8. 猪脊髓 60g, 香油炸常服。
9. 冰片、田螺液局部涂抹, 每日 5~6 次。

(二) 验方

1. 红粉 10g, 轻粉 6g, 水银 3g, 红枣 10 枚, 共研末为丸, 每丸绿豆大小, 每日 1~2 丸。适于实证内服。

2. 血竭 10g, 白芍 10g, 象皮 15g, 枯矾 15g, 青黛 15g, 共为细末, 装入胶囊, 每日两次, 每次 2 粒。适于虚证内服。

3. 阴茎癌药粉: 生马钱子 6g, 枯矾 15g, 鸦胆子 10g, 生附子 6g, 硃砂 15g, 雄黄 15g, 密陀僧 6g, 青黛 10g, 轻粉 3g。共研细末, 撒于肿瘤局部, 周围用凡士林纱布保护正常组织, 每日换药一次, 连用五次, 观察局部, 若肿瘤未全消尽, 仍可再用。

(三) 成方(药) 主要用于阴茎癌的外治法, 分初、中、

后三期分而述之。

初期：局部外敷阴茎癌药粉，用凡士林纱布保护，日换一次，待肿块脱落后，改用生肌玉红膏纱布换药，直至愈合。

中期：1.阴茎癌药粉外敷肿块溃烂处，上盖黄连素纱布包扎，日换一次，促使肿块脱落。2.五虎丹糊剂涂于溃疡面上，或五虎丹钉剂插入瘤体中央，外用万应膏盖贴。前者适用于溃疡型，后者适用于菜花型。俟瘤体组织脱落，隔3天换药一次以万应膏覆盖；最后疮面平整，肉芽新鲜时，改用生肌散外敷疮面，外盖黄连素纱布，直至疮面愈合。

后期：本期肿块已经脱落，形成溃疡，若有脓腐者用银灰膏外涂疮面，外用黄连膏纱布覆盖包扎；若疮面洁净，重在生肌长肉，可选用九一丹、生肌散或康复新液外涂，日数次。

三、中西医结合治疗 阴茎癌早期，无论药物、放射线或手术均能治愈，治愈率可达90%。据有关文献报告，本病预后与临床分期、组织类型和分级有关。Ⅰ期阴茎癌手术后，患者约3/4存活5年；临床诊断为Ⅱ级者，5年生存率下降至1/2；对已有转移并行腹股沟淋巴结清除术者5年生存率仅约1/3。若同时加用中医药辨证论治，其5年生存率可提高35%~60%。本文仅以阴茎癌的发展过程分为四型论治，并不能将所有情况概括无遗，尤其是治疗方法上仍以综合治疗为佳。例如放射治疗用于小而表浅的Ⅰ期阴茎癌，可以保持完整的阴茎，特别适合于年轻的患者，再加上中医药治疗，其效果尤令人满意。对高年龄组的阴茎癌患者仍提倡手术切除为主，辅以放、化疗并加用中药治疗，可明显改善症状，提高患者5年存活率。此外，氨甲喋呤及顺铂全身化疗配合大补阴丸，龙胆泻肝汤等亦有满意效果。

第十七章 睾丸肿瘤

【概述】

睾丸肿瘤较少见，其中绝大多数为恶性肿瘤，世界各地均有发病，但以西欧和美洲发病率较高，据统计美国和英国发病率为 $2.1/10$ 万 $\sim 2.3/10$ 万；我国发病率较低，1972~1979 年上海为 $0.8/10$ 万，约占所有男性恶性肿瘤的 1%，死亡率为 $0.259/10$ 万男性，占男性恶性肿瘤死亡的 0.16%。近年来有些国家（如日本和丹麦）睾丸肿瘤有增加趋势。

睾丸肿瘤的病因尚未明确，目前认为隐睾的睾丸异位者与睾丸肿瘤的发生有密切关系。隐睾发生肿瘤的机会较正常人高 20~40 倍，李澄棣报告腹内型隐睾发生肿瘤率为 22.7%，腹股沟型隐睾发生率为 6.8%。其他可能与创伤、遗传因素、内分泌失调及长期炎症刺激因素有关。其患病年龄多在 20~40 岁。患者早期常无明显的自觉症状，易误诊，当睾丸肿块或转移瘤逐渐增大时才出现某些相应部位的症状。多数患者因睾丸明显增大，伴有腹股沟及下腹部坠胀感来就诊；少数患者因睾丸突发肿痛，伴高热、发冷而急诊；也有因腹痛，后腰痛，下腹部包块，咳嗽咯血，乳房胀痛而求治者。

睾丸肿瘤可分为生殖细胞肿瘤和非生殖细胞肿瘤两大类，前者占 95%，后者占 5%。生殖细胞肿瘤包括精原细胞瘤、胚胎瘤、畸胎瘤、畸胎癌和绒毛膜上皮癌（滋养叶细胞瘤）等，从治疗来看，生殖细胞瘤又可简单地分为精原细胞瘤和非精原细胞瘤两大类，前者甲胎蛋白（AFP）及绒毛膜促性腺激素（HCG）均为阴性。胚胎瘤与恶性畸胎瘤甲胎蛋白可为阳性，但 HCG 阴性，而滋养叶细胞瘤 HCG 阳性，AFP 阳性。非生殖细胞瘤发生自睾丸间质组织，包括间质细胞瘤、支持细胞瘤，常见于儿

童。由于睾丸肿瘤临床没有特异表现，在临床实践中须认真地与阴囊内其它病变如急性睾丸炎及附睾炎、睾丸鞘膜积液、精液囊肿、睾丸外伤性积血、睾丸结核等相鉴别。禁止对睾丸原发肿瘤进行穿刺活检，以免肿瘤扩散。其临床分期，目前国内通常使用Friedman分期方法，将睾丸肿瘤分为A、B、C三期，方法简单，临床易于掌握。

A期：肿瘤限于睾丸。

B期：伴有腹膜后淋巴结转移

{ B1期：腹膜后转移淋巴结少于5个。

{ B2期：腹膜后转移淋巴结多于5个。

{ B3期：腹膜后淋巴结成块或肾门上淋巴结阳性。

C期：转移超出膈肌，或有血行转移。

睾丸肿瘤的转移途径有二。淋巴道转移最先侵犯髂窝淋巴结，然后侵犯腹主动脉旁、下腔静脉和肾蒂附近、纵膈、锁骨上、腹膜后腔及腹股沟淋巴结；并可经血行播散，转移至肝、肺、脑、骨及其它器官出现转移灶症状。睾丸肿瘤若不经治疗，多数在二年内死亡。由于近年来治疗学的迅速进展，其预后转归取得了较大改观。精原细胞瘤采用根治性睾丸切除术和淋巴引流区放射治疗，5年生存率约为87.5%，其它生殖细胞肿瘤，采用根治性睾丸切除加腹膜后淋巴结清除术，5年生存率约为50%。由于有效化疗药物的不断发现和综合治疗的开展，晚期病人尤其是非精原细胞瘤性生殖细胞肿瘤的病人，疗效有了明显的提高。

睾丸肿瘤在古代中医文献中没有记载，近代中医学家根据其临证特点而撰名为“子岩”。

【病因病机】

古代中医学虽然对子岩病因病机没有记载，而近十年来不少中医学者对此作了不少的工作。其中，中医男科专家徐福松在

《实用中医泌尿生殖学》中对其病因病机的论述较为精当。

一、先天不足，天宦隐睾，热蕴化毒

肾为先天之本，睾丸为生精之源。肾气先天不足，睾丸下降，隐于腹壁或腹中，使之肾气不能充实，肝气不得滋养，年久又因肝脉不达，热蕴化毒，发为子岩。

二、睾丸外伤，血脉阻滞，瘀热酿毒

睾丸因跌仆损伤，瘀血不得及时消散，阻滞经脉，经脉不畅，睾丸失养，瘀血化热酿毒，热毒互结，聚而不散，病为子岩。

三、肝肾不足，睾丸失养

《内经·评热病论》说：“邪之所凑，其气必虚”，《外证医案汇编》说：“正气虚则成岩。”肝肾素亏不足，正气虚弱，邪气留滞而致气滞血瘀，痰凝毒聚。子岩多见于子痫、卵子瘟等病后，经脉不充，睾丸失养萎缩。西医学统计萎缩睾丸发生恶性变机会约1.5%~4%。

四、肝郁气滞，湿毒积聚，发为子岩

睾丸在祖国医学中又称为“外肾”，为足厥阴肝经循行路线经过之处。情志不畅或恼怒伤肝，致肝郁气滞，横逆犯脾胃，脾虚湿聚，留滞肝经，日久形成坚硬肿块而发为子岩。

【治疗】

一、辨证论治 子岩辨证治疗应始终以扶正为本。早期以祛邪治标为先，辅以扶正固本，晚期或术后以扶助正气，补益肝肾为主。

1. 痰瘀互结型（子岩早期）

【主证】偶然发现睾丸肿大沉重，或坠胀隐痛，无明显其它症状。舌质紫暗苔白厚，脉弦涩。

【分析】《奇效良方》说：“气塞不通，血壅不流，凝血蕴里，津液凝涩，渗着不去，而成痰”。先天不足，天宦隐睾或肝肾不足。睾丸失养，肝肾之脉失于条达；或因跌仆损伤，瘀血阻

滞经脉，或痰浊留滞，痰瘀互结，而发本证。

【治则】化瘀逐痰，软坚散结。

【方药】可选用少腹逐瘀汤化裁。常用川芎 15g，当归 30g，桃仁 10g，红花 10g，南星 10g，半夏 10g，姜虫 20g，瓜蒌 30g，茯苓 30g，官桂 3~9g，干姜 6~10g，昆布 30g，海藻 30g，荔枝核 30g。

【方解】芎、归、桃、红四味药活血祛瘀，并助昆布、海藻软坚散结；南星、半夏、姜虫、瓜蒌、茯苓化痰散结；干姜、官桂温寒止痛；荔枝核引药下行，直达睾丸，诸药同用，共奏化瘀逐痰软坚散结之功。

【加减】子岩偏于寒者，重用干姜、官桂，加小茴香；偏于热者，去官桂、干姜加入土茯苓、板兰根、半枝莲、蛇舌草、山豆根等清热解毒；瘀阻为主者，重用祛瘀之品，加用三棱、文术、水蛭、土鳖虫等。若体质较弱，酌情加入黄芪、党参、黄精、白术及左归丸之属。

2. 肝郁气滞型（亦见于子岩早期）

【主证】睾丸肿硬胀痛，患侧下肢浮肿，睾丸肿甚可使皮肤破溃流脓血水，腥臭不愈。伴烦躁易怒，胁肋胸脘胀痛，痛处不固定。舌体稍胖大，舌质暗红，苔厚腻，脉弦滑。

【分析】情志抑郁，或悲怒伤肝，肝失疏泄条达，气机郁滞不畅，下焦水液运化受阻而发诸证。

【治则】疏肝解郁，理气散结。

【方药】柴胡疏肝饮合导痰汤加减。常用柴胡 15g，白芍 15g，当归 15g，枳壳 10g，南星 10g，郁金 10g，瓦楞子 15g，鸡金 10g，桔核 10g，荔枝核 10g，夏枯草 30g，白芥子 15g，海藻 30g，昆布 30g，台乌药 10g。

【方解】方中柴胡、白芍、枳壳疏肝理气，郁金、鸡金、乌药健脾解郁化湿，南星、白芥子、海藻、昆布、瓦楞子、夏枯草化痰散结，荔枝核、桔核疏肝解郁，理气散结并可引药直达病所

而消子岩。

【加减】食欲不振，加入川朴花、焦三仙等；下肢软而无力加怀牛膝、龟板等；大便干去瓦楞子，加焦大白、大黄之属；若胁肋刺痛可加入延胡索、丹参、三棱、莪术等。

3. 肝肾阴虚型（子岩中、晚期）

【主证】睾丸肿大坚实，坠胀不适，且形体羸瘦，伴头晕耳鸣，失眠多梦，潮热盗汗，腰膝酸软，阳萎遗精，舌红少苔，脉沉细。

【分析】子岩中、晚期，精血耗劫，肝肾俱损，肝肾气机不利，精室不固，下焦气化无权。又肝主筋，肾主骨，故肝肾一虚，诸证均现。

【治则】滋补肝肾

【方药】宜选用左归丸。常用大熟地 30g，山药 15g，枸杞 12g，山茱萸 10g，菟丝子 15g，鹿角胶 10g，龟板胶 10g，牛膝 10g。

【方解】方中重用大熟地甘温补肾，辅以山药、枸杞、山茱萸、菟丝子滋肾养肝，鹿角胶、龟板胶补精血，潜肾阳；牛膝为使药，寓行于补，使补而不滞，且有引经作用。俟肝肾充，气血旺，则“正气存内，邪不可干”，而达到扶助正气，消除病证之目的。

【加减】术后邪热未尽者，可酌情加入半枝莲、蛇舌草、石上柏等祛邪热；岩肿未祛者，可加用山慈姑、昆布、海藻、牡蛎等。

4. 气血两伤型

【主证】此型见于子岩晚期或术后，证见面色㿯白倦怠乏力，少气懒言，头晕心悸等。舌淡苔白，脉细弱。

【分析】子岩发展迅速，邪毒嚣张，耗气伤血；或手术、化疗后，子岩虽遏，正气亦伤。“气为血之帅，血为气之母”，二者相互依存，一损皆损，故见气血俱损之象。

【治则】补益气血。

【方药】人参养荣汤加减。常用红参 15g，黄芪 30g，白术 20g，陈皮 10g，茯苓 15g，白芍 20g，当归 30g，熟地 15g，五味子 15g，远志 15g，官桂 10g，炙草 10g。

【方解】方中用四君子汤益气健脾，人参取其温热作用，四物汤去川芎养血生津而不燥，远志、五味子养血安神，官桂益阳固脱。全方调补气血，强调健脾，中土健运正常，胃纳旺盛，则“生化”之源不绝，以提高机体抗癌能力。

【加减】纳谷不香，饥不欲食，生地易熟地，加藿香、川朴花、川佛手；舌红则去红参，加西洋参、沙参、麦冬；大便稀薄加黄精、莲子肉、益智仁；四肢不温，冷汗出加制附子、干姜。

二、单方、验方、成方（药）

（一）单方

1. 薜荔果 60g，每日煎服一剂。
2. 棉花根 60~100g，每日煎服一剂。
3. 铁篱寨 30g，每日煎服一剂。
4. 土贝母 30g，每日煎服一剂。
5. 土茯苓 30g，每日煎服一剂。

（二）验方

1. 薜荔果 30g，棉花根 30g，王不留行 15g，小茴 9g。每日煎服一剂。

2. 棉花根 30g，桔梗 10~20g，乌药 9g，枳壳 10g。每日煎服一剂。

3. 菝葜 30g，棉花根 30g，荔枝核 30g，八月扎 30g，元胡 15g。每日煎服一剂。

4. 制香附 3g，制没药 3g，血竭 3g，儿茶 3g，炮山甲 3g，浙贝母 3g，元寸 3g，牛黄 3g，海蛤粉 3g。共为细面，装胶囊贮瓶内备用，每日三次，每次 5~6 个胶囊。

（三）成方（药）

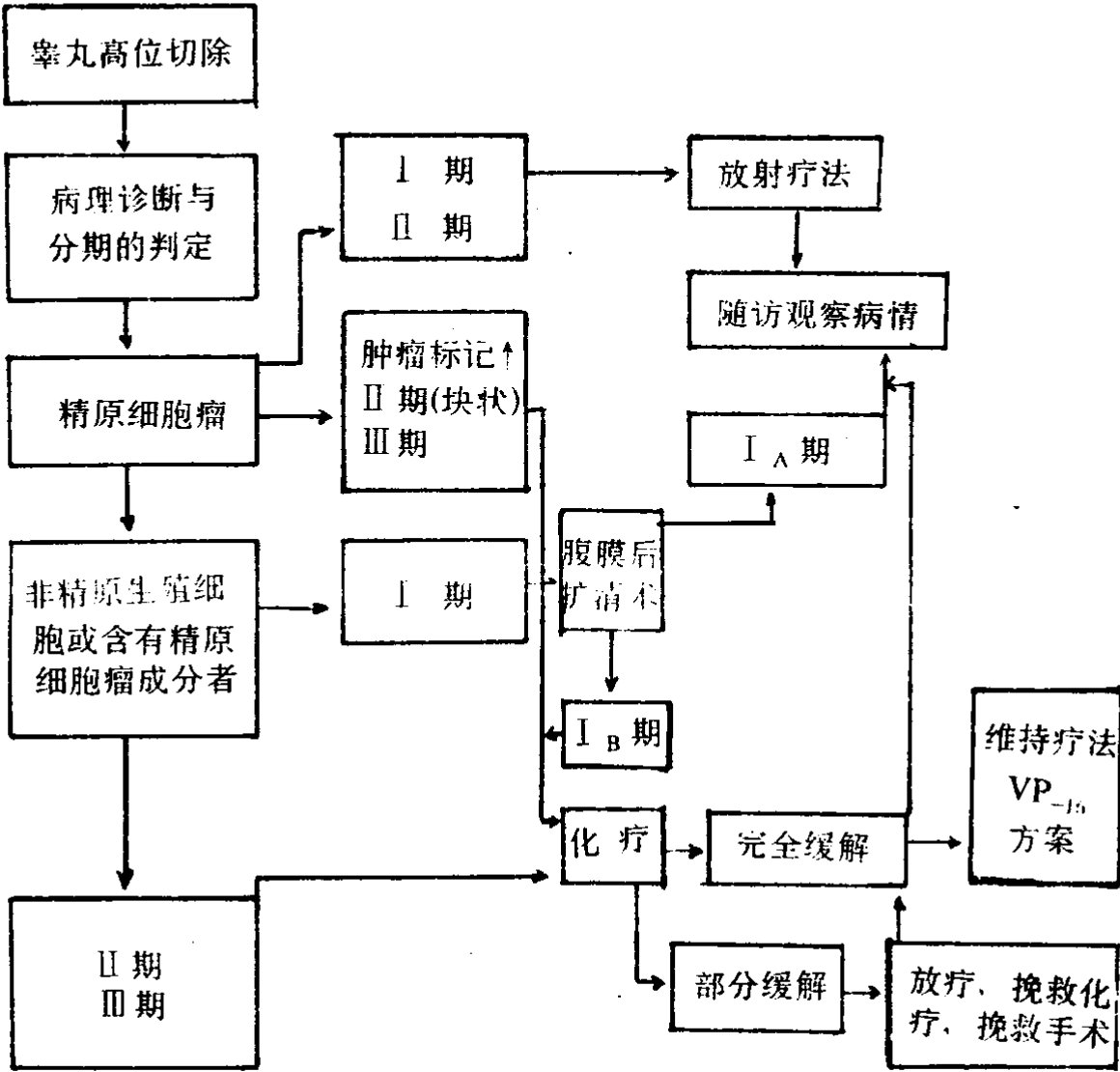
1. 巴腊丸，每日 2~3 次，每次 5~8 粒。
2. 通气散坚丸，每服 9g，每日二次。
3. 薏苡附子败酱散，每服 6g，每日二次。
4. 知柏地黄丸，每服 2 丸，日二次。

三、中西医结合治疗 由于睾丸肿瘤的病理极为复杂，目前的治疗方案以综合治疗为主，单纯睾丸切除只能作为睾丸肿瘤病理诊断的一个步骤。如精原细胞瘤在切除睾丸后对淋巴结引流区需进行放射治疗，而非精原细胞性生殖细胞肿瘤尚需在睾丸切除后再行腹膜后淋巴结大块切除，其治疗方案应根据每一患者的病理组织和临床分期来制定。而睾丸肿瘤以祖国医学观点来看，其病机多属肝肾不足，精血亏虚。因此，在术前、术后及放化疗期间，加服中药以滋补肝肾，填精益髓，能明显提高患者的生存质量。常用的药物有左归饮、大补阴丸及六味地黄丸等。预防化疗副作用呕吐症，可煎服中药威灵仙 30g，陈皮 15g，生地 15g，山萸肉 10g，半夏 10g，茯苓 15g，甘草 10g，大枣 10 枚，生姜 5 片。对放疗引起的口舌干燥，不思饮食等证可服用益气养阴之品，常用一贯煎化裁。从我们数年临床经验来看，能显著提高患者对化、放疗的适应能力和自身免疫功能，促进机体的抗瘤水平，提高存活率。

四、综合治疗 睾丸肿瘤的治疗是综合治疗措施。首先，高位切除睾丸，依肿瘤病理类型，临床分期拟订手术、化疗和/或放疗的综合治疗方案，其治疗方针如图示。

对精原细胞瘤病人，主张睾丸高位切除术后，对其淋巴引流途径包括纵膈淋巴结和锁骨上淋巴区域照射，I 期放疗治愈率达 95%，II 期达 75%~90%，III 期为 22.1%。对此类 I A~II 期病作腹膜后淋巴清扫术时，保护健侧腹主动脉旁的交感神经不受损伤，可防止术后以生殖性功能障碍。李振华对 40 例精原细胞瘤 I A 和 II 期病人，采用保护健侧交感神经链的腹膜后淋巴结清扫术，术后无一例发生性功能障碍。而腹膜后淋巴清扫术后加

PEB 方案化疗，其 5 年生存率可提高至 95.4%。



睾丸生殖细胞肿瘤的治疗方针

睾丸非精原性生殖肿瘤的化疗和手术的先后，一般认为 I ~ II 期可先行腹膜后淋巴清扫术，术后给两个疗程的 PEB 方案治疗。如腹膜后肿瘤不能全面切除则作减瘤细胞术，术后化疗。对 III 期病人以化疗为主，化疗后对 PR 者，依情况考虑手术。如术后病理证明为残余癌则再行化疗，若纤维化则进行观察，晚期病人仅实行化疗。

睾丸生殖细胞肿瘤放疗后的化疗问题，对 I ~ II 期睾丸精原

细胞瘤放疗后仍有 10% 以上复发者，这部分可行放疗后化疗，但此类病人易发生严重长时间的骨髓抑制，而纵膈的放疗使博莱霉素性肺炎的发生率增加，故化疗应慎重，注意并发症。

化疗期间应注意对病人的营养疗法，尤其对体质差、化疗期胃肠道反应严重者要及早采用周围浅静脉的高能营养疗法，及时运用中药调理脾胃，滋补肝肾。这是保证化疗如期完成及确保疗效的重要措施。对感染发热病人在给予大剂量有效抗生素同时，必须考虑及时输血，如有条件，根据病情，将病人送入无菌室。对白细胞恢复迟缓者可考虑骨髓移植。

第十八章 前列腺癌

【概述】

前列腺癌好发于老年。世界各国的发病率很不一致，在国外，以欧美发病率最高，特别是美国，其发病率高达 $14.3/10$ 万 $\sim 23/10$ 万男性，占男性恶性肿瘤的 10%，居男性恶性肿瘤发病率的第二位。随着年龄的增长，其发病率明显增加，而且具有家族倾向。由于前列腺癌中有一部分属隐匿性癌，尸体解剖检查时始能发现，所以，其实际发病率更高。有人估计，可高达男性恶性肿瘤的 26% $\sim$ 37%，为临床具有症状病例的 2 $\sim$ 5 倍，前列腺癌的死亡率随着年龄的增长不断增加，在 60 $\sim$ 64 岁人中间，为癌症死亡的第 5 位，65 $\sim$ 69 岁中占第 3 位，70 $\sim$ 79 岁中占第 2 位，80 岁以上占第 1 位。不过，在亚洲和非洲，前列腺癌的发病率较低。

在我国，前列腺癌并不多见。北京市 1964 年资料表明，前列腺癌占男性恶性肿瘤的 0.47%，居男性恶性肿瘤的第 29 位。上海市 1958 年统计的 14300 例资料表明，前列腺癌占男性恶性肿瘤的 0.32%，居男性恶性肿瘤发病率的第 29 位。上海市 1972 $\sim$ 1974 年统计，前列腺癌的调整发病率为 $0.482/10$ 万男性，占男性恶性肿瘤发病率的 0.28% $\sim$ 0.32%，排在第 35 位。近年来，有人统计了 35947 例泌尿外科住院病人中，有 243 例前列腺癌，占 0.68%，总的发病率有增高的趋势。

前列腺癌的病因，至今尚未明确。一般认为，发病机体内雄激素和雌激素之间的平衡紊乱有关。如阉割者不发生前列腺癌，睾丸摘除术和雌激素治疗对本病有显效，而给予雄激素能够使前列腺癌细胞增生活跃。因此推测雄激素可能促进前列腺癌的生长和发展。此外，据流行病学的资料报告，前列腺癌的发病因素与

种族遗传有关，如欧美发病率高，亚、非洲发病率低。和年龄亦有关系，随着年龄的增长，发病率明显增高。至于是否受环境条件的影响，有不同看法。

前列腺癌根据临床、X线、病理细胞学、内镜、CT检查来确定分期，临床分期如下：

1.A期：病变局限于前列腺组织中，临床上无发现，约1/10前列腺增生中有癌变，腺体内癌可呈局灶性或弥漫性，血清酸性磷酸酶和或前列腺酸性酶不高。

2.B期：病变局限于前列腺中，肛诊可触及前列腺硬结，酸性磷酸酶正常，约占前列腺癌的1/10。

3.C期：癌已超出被膜，但无远处转移，约占前列腺癌的2/5，附近淋巴结侵犯者占40%~60%，少数病例酸性磷酸酶升高。

4.D期：临床或病理证明已有远处转移，约占前列腺癌的2/5，70%的病人酸性磷酸酶升高，多数病人的癌分化不良。

实际上，临床随诊证明，A期病人中5%~10%已有淋巴结或骨转移，B、C期病人中45%有淋巴结转移和10%的骨转移。且病人病程的发展也不依次进行，病人可长期停留于A期，亦可直接进入C、D期。

此外，亦可根据国际惯例进行TNM分类，既T-原发肿瘤，N-局部淋巴结，M-远处转移。

早期前列腺癌症状和体征多不明显，某些病例癌瘤生长缓慢，长期处于潜伏状态，患者可无临床症状，常在因前列腺增生症而手术的标本中或因其它疾病而死亡的尸体解剖检查时发现，这种病例呈潜伏型。某些病例癌瘤呈隐匿状态，其原发癌灶很小，症状不显，但已有远处转移，这种病例呈隐匿型。另一些病例则有尿频（70%），排尿困难（43%），尿流变细，尿流偏歪或分叉，尿程延长，尿痛，尿潴留（3%）等与前列腺增生症相似的症状。有时虽然前列腺癌灶很小，但因伴发良性前列腺增生

病变，也可以有上述症状，这种病例呈临床型。单纯前列腺癌病人，临床上一旦出现上述症状并且进行性加剧，则病变多属晚期。

疼痛是前列腺癌的主要症状之一，约 31% 的病例有这一症状，乃系神经周围被癌细胞浸润或癌已转移到骨骼所致，也可能与并发肾积水，肾感染有关。疼痛多在腰骶部或腰背部，或骨盆，或下肢，可向会阴部放散，也可发生单侧或双侧坐骨神经痛，疼痛剧烈难忍，疼痛是前列腺癌的晚期症状。

血尿仅见于 3% 的病例，有肉眼血尿和显微镜下血尿两种。严重的出血症状常是伴有癌瘤转移的征象，系由于纤维蛋白溶解或继发低纤维蛋白血症所致。

前列腺癌晚期病人多发生骨及淋巴结转移，其中，淋巴结转移约占 41.5%~75%；多发生在髂内、髂外、腰部、腹股沟，下腔静脉旁，胸腔、左锁骨上及腋下淋巴结，可引起相应部位淋巴结肿大及下肢肿胀。骨骼转移多见，约占全部病例的 60%~70%，占前列腺癌致死病例的 97.6%，其转移部位以骨盆骨，腰椎，股骨，肋骨多见，偶也有转移至颅骨者。此外，内脏转移以肺居多，其次是肝，胸膜，肾，肾上腺，脑等器官，从而引起相应的症状。此外，由于疼痛影响饮食，睡眠和精神以及重要组织和器官的转移，全身状况日渐衰弱，消瘦，倦怠乏力，进行性贫血，恶病质或肾及重要脏器功能衰竭。

前列腺癌一般发展缓慢，尤其是高龄患者。隐匿性前列腺癌可多年无症状，而在死后尸检时才被发现。但前列腺癌出现明显症状后，多数发展迅速，有人统计，这种患者的自然生存期为 31 个月，而有转移的患者约 2/3 在 9 个月内死亡，但出现明显症状后也有约 10% 左右可生存 5 年以上，其个体差异很大。当癌灶局限于包膜内，行根治术后，约 50% 的病人可生存 5 年以上。即便是有转移的病例，经过手术及其它综合治疗，其 5 年生存率也会有很大提高。

前列腺癌可发生于前列腺的任何部位，但以腺体的后叶最为多见，其次是侧叶。前列腺癌多起自腺体的外组腺体组织，且多处于边缘部位（即腺体的被膜下区），癌瘤病变又常呈多中心性，并可于萎缩的腺泡中发病。据国外报道，50%的前列腺癌病例中同时伴有前列腺增生。前列腺增生病例中有14%~20%检查可发现前列腺癌灶。前列腺癌以腺癌居多，其中又以高分化腺癌为最，鳞癌约占3%左右，极少数为小细胞未分化癌。

前列腺癌的诊断大多靠直肠指诊检查，在早期无症状的病例，凡在前列腺体内触及硬度增加且有坚实边缘者都应进行详尽的其它检查。组织细胞学检查是诊断的唯一可靠依据，可通过取活组织或取前列腺液、尿液、骨髓等获得标本进行检查。物理检查则通过膀胱镜、X线尿道造影、精路造影、CT扫描、MRI等检查来确定原发病灶及转移病灶。生化检查作为辅助手段也不可忽视，其中血清酸性磷酸酶意义较大，它不但对诊断具有参考意义，而且对疗效判定以及预后判断都大有裨益。血清睾酮及前列腺液乳酸脱氢酶同功酶的测定对诊断和预后也有帮助。诊断前列腺癌时需与前列腺增生症，前列腺结核，前列腺结石，慢性前列腺炎，非特异性肉芽肿性前列腺炎等良性疾病相鉴别，以免误诊。

祖国医学对本病无专门的论述，其症状仅散见于某些著作中。早期出现短时尿频，夜尿，《诸病源候论·小便多候》谓：“小便白而多，甚至夜偏甚”继之出现尿频，尿流变细，尿程延长，尿意未尽，《诸病源候论》谓：“涩则小便不快，故令数起也。”《诸病源候论·气淋候》谓：“膀胱小便皆满，尿涩常有余沥。”或伴有排尿困难，尿痛引少腹，《医宗金鉴》谓：“闭则尿闭无滴出，少腹胀满难伸，癃即淋漓点滴出，茎中涩痛数而动。”或伴有血尿，《诸病源候论》谓：“小便如有小豆羹汁状者，蓄作有时也。”当病变侵犯附近组织而出现腰背疼痛时，祖国医学将其划入“腰痛”中。出现淋巴结转移时，在表浅者归入恶核，“失荣”等

病之中，在深部时出现下肢肿胀则归入“水肿”、“虚劳”病中。

【病因病机】

前列腺癌大致可属于祖国医学之“癃闭”、“淋证”、“虚劳”、“腰痛”、“瘀证”等病中，祖国医学认为本病病位在膀胱，但与三焦之气化，肺宣发肃降，脾之运化水湿，肾之开阖功能都有密切关系。病因不外外邪和内伤两大类，外邪多因外感六淫和饮食不节，内伤多因情志所伤，房劳过度，久病失治误治和禀赋不足几个方面，从而表现为湿热蕴结，瘀血内阻，肾气亏虚。

（一）湿热蕴结 若因下阴不洁，秽浊之侵入下焦，或因多食辛热肥甘之品，或嗜酒过度，致酿成湿热，湿热互结，阻滞膀胱，致使膀胱气化不利而发本病。或湿热互结，酿成痰浊，或热炼津液，瘀血内阻，经脉不通，而致疼痛。《金匱要略·五脏风寒积聚病脉证并治》谓：“热在下焦者，则溺尿血，亦令淋秘不通”。《丹溪心法·淋》篇谓：“淋有五，皆属于热”。《诸病源候论·淋病诸候》谓：“诸淋者，由肾虚而膀胱热故也”。又谓：“肾虚则小便数，膀胱热则水下墙，数而且墙，则淋漓不宣，故谓之淋”。《景岳全书·淋景》篇说：“淋之初病，则无不由乎热剧，无容辨矣”。可见，本病初发时多为湿热蕴结。

（二）瘀血内阻 七情伤致肺气郁结，疏泄失常，血为之凝墙或因久病失治误治，瘀血内停，或因年高体衰，血脉运行不畅而致瘀血内生，或因热炼津液，血为之凝积，皆可成瘀血之候。《素问·调经论》篇云：“五脏之道，皆出于经遂，以行血气，血气不和，百病乃变化而生”。瘀血内结，膀胱气化不利而成癃闭，淋浊之候。

（三）肾气亏虚 若因房劳过度，久淋不愈，湿热耗伤正气，或年高体弱，皆可导致肾阳亏损，命门火衰，致使膀胱气化无权，尿不得出。或下焦积热，津液耗伤“无阴则阳无以化”，也可形成癃闭。《金匱要略·血痹虚劳病脉证治》谓：“男子脉虚沉弦，无寒热，短气里急，小便不利，面色白，时目瞑，少腹

满，此为劳使之然”。又谓“虚劳腰痛，少腹拘急，小便不利者，八味肾气丸主之”。由此可见，肾气亏虚也是导致癃闭的重要原因。

从以上论述可以看出，前列腺癌的病因虽多，但病理转归不外湿、热、瘀、虚。内外邪作用于人体，首先引起湿热蕴结或瘀血内阻，病久而引起肾气亏虚或虚实夹杂。湿热瘀血一方面加重病情进展，从而出现一系列变化，如淋巴道转移或血道转移，另一方面，又影响了脏腑功能失调，气血亏损，体质衰弱，无力抵抗病邪，致病情日渐加重，因此，湿热、瘀血是本病致病之原，脏腑功能失调是本病发展恶化之本。

【治疗】

一、辨证施治

（一）湿热蕴结型

【主证】腰痛不适，小腹胀满，小便不利，口苦口粘，或口渴而不欲饮，大便不畅，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

【分析】本证辨证要点是湿热蕴结膀胱。“膀胱者，州都之官，气化则能出矣”。湿热蕴结膀胱，气化失调，故小便不利，甚或闭而不通。“腰为肾之府”，湿热蕴结，经脉受阻，气血运行不畅，故腰痛，湿热互结，气滞于下，故小腹胀满。湿热内盛故口苦口粘，或口渴不欲饮。舌质红，苔黄腻，脉滑数，大便不畅皆为湿热蕴结之象。

【治则】清利湿热，通利小便。

【方药】八正散加减。

【方解】八正散源于《和剂局方》，方中以木通、瞿麦、车前子、篇蓄、滑石通利小便，山栀清热化三焦湿热，大黄泄热降火，灯心草导热下行，甘草调和诸药。

【加减】若腰痛甚，小便带血者，加灵脂、蒲黄、白茅根、泽兰、丹参等。若口苦而粘，大便不爽较甚者酌加藿香、佩兰、秦皮等，此外，在辨证施治的基础上，为加强抗癌能力，可酌加

活血化瘀，软坚散结，清热解毒之品，如土元、丹参、泽兰、赤芍、忍冬藤、败酱草、土茯苓、龙葵、莨菪、苡仁等。

（二）瘀血内阻型

【主证】小便滴沥，或尿如细线，或癃闭不通，小腹胀满作痛，或少腹积块，尿血色紫暗有块，舌质紫暗，舌苔薄，脉涩或沉细。

【分析】本证辨证要点是血瘀少腹。瘀血内结下焦，膀胱气化失司，故小便滴沥，或尿如细线，或癃闭不通，或尿血色紫暗夹块。瘀血阻于经脉，气血运行不畅，故少腹胀满作痛。瘀结下焦，久之成积，故少腹积块。舌紫暗，苔薄，脉涩或沉细，皆为瘀阻下焦之候。

【治则】化瘀散结，通利小便。

【方药】桃红四物汤合桂枝茯苓丸合四苓散加减。

桃红四物汤源于《医宗金鉴》，桂枝茯苓丸源于《金匮要略》，四苓散源于《明医指掌》。桃红四物汤中桃仁、红花活血祛瘀，四物汤活血养血。桂枝茯苓丸中桂枝温通血脉，茯苓渗利下行以助行瘀，丹皮、赤芍、桃仁化瘀血，清瘀热。四苓散中泽泻利水渗湿，茯苓、猪苓淡渗利水，白术健脾而运化水湿。诸药合用，共奏化瘀散结，通利小便之功。

【加减】小便不利甚者，可加败酱草，瞿麦、马鞭草、猪苓、苡仁通利小便，如胀痛甚者可麝香、琥珀冲服，尿血者可选加三七参、小蓟、旱莲草、血余炭等。

（三）肾气亏虚型

【主证】小便不畅或滴沥不通，排泄无力，面色㿠白，神气怯弱，腰膝酸软，舌淡，苔薄，脉沉细。

【分析】小便不通或滴沥不通，排泄无力是肾气不足，气化无权。面色㿠白，神气怯弱，是元气衰惫之征，腰膝酸软，舌淡，脉沉细都是命门火衰，气化不及所致。

【治则】温阳益气，补肾利尿。

【方药】济生肾气丸加减。

【方解】济生肾气丸源于《济生方》，方中肉桂、附子补下焦元阳以鼓舞肾气，六味地黄丸补肾滋阴，牛膝、车前利水。

【加减】若年高元气大虚，肾督不振，可加仙茅、仙灵脾、鹿角片以壮肾阳，因本型虽肾虚为主，但仍有瘀血内著，可稍加化瘀之品以兼顾之，如穿山甲，内金，刺猥皮等。

【按语】 以上辨证分型只是一般情况，由于本病到后期广泛转移，病变涉及诸多脏腑，应根据临床表现进行辨证施治，才不失中医之精髓。此外，临床治疗中，还要加入抗癌中药以增强抗癌祛邪作用，常用治疗前列腺癌的中草药有：马鞭草 30~60g，瞿麦 60~120g，野菊花 30~60g，野葡萄根 30~60g，白花蛇舌草 30~60g，半枝莲 30~60g，败酱草 30~45g，半边莲 30~45g，土茯苓 30~45g，刺猥皮 15~20g，炮山甲 10~20g，海藻 30~60g，昆布 20~30g，三棱 10~15g，文术 10~15g，木通 9~12g，金钱草 30~45g，王不留行 20~30g，龙葵 30~60g，苡仁 30~60g，猪苓 30~60g，夏枯草 30~45g，牛膝 15~20g，菝葜 60~120g，急性子 10~30g 等等，临床可根据功效、性味，辨证加减用药。

二、单方、验方

(一) 单方

- 1.菝葜 60~120g，水煎分服。
- 2.马鞭草 30~60g，水煎分服。
- 4.瞿麦 60~120g，水煎分服。
- 5.野葡萄根 30~60g，水煎分服。

(二) 验方

1.野葡萄根 30g，白花蛇舌草 30~60g，半边莲 30~60g，土茯苓 30g，水煎分服。

2.夏枯草 30~60g，败酱草 30g，金钱草 30g，王不留行 30g，龙葵 30g，玉米根 60g。

3.黄柏 10g, 知母 10g, 木通 10g, 赤芍 15g, 牛膝 15g, 炮山甲 15g, 生牡蛎 30g, 刺猥皮 15g。

4.昆布 30g, 海藻 30g, 三棱 10g, 文术 10g, 知母 10g, 当归 15g, 丹参 30g, 郁金 10g, 猪苓 30g。

三、中西医结合治疗

(一) 中医药与手术治疗仍是目前首选治疗手段, 如能与中医药治疗相结合则可望提高切除率, 减轻并发症, 提高生存率和生存质量。术前给予扶正中药调理, 可改善患者一般营养状况, 有利于手术的进行。如王敏玉等报导, 应用中药黄芪注射液术前给予 7~10 天, 可见白细胞总数升高。Ⅱ级 T 淋巴细胞的总数及百分比均明显升高, 说明患者的细胞免疫功能得到了增强。术后给予调理脾胃, 益气固表, 养阴生津, 理气导滞等辨证方药, 可促进机体康复, 为以后的治疗创造条件, 同时, 观察发现患者的细胞免疫功能及淋巴母细胞转化率等都有较大的提高。

(二) 中医药与内分泌治疗相结合 前列腺癌是雄激素依赖性肿瘤, 内分泌治疗在内科治疗中占非常重要的地位, 但由于内分泌治疗特别是雌激素治疗具有恶心, 呕吐, 水钠潴留, 心功能不全, 栓塞性静脉炎等严重副反应, 有时限制了治疗的进展, 若能与中医药治疗相结合, 可很大程度地减少反应。中医药常根据辨证施治给予利水渗湿, 健脾益气, 活血化瘀等法则。

(三) 中医药与放疗结合 药理试验证明, 中药可增强肿瘤对放射线的敏感性, 又可防治放疗期间的副作用及合并症和后遗症对于治疗放射性膀胱炎, 放射性直肠炎等都有较好的疗效。此外中药还可预防复发和转移, 对于提高五年及十年生存率有所帮助。

(四) 中医药与化疗相结合 中医药与化疗相结合用具有增效作用, 前列腺癌属于化疗不敏感的实体瘤之一, 化疗增敏具有重要意义, 实验研究表明, 某些中药具有增强化疗药物的抗癌和抑瘤作用, 如丹参、黄芪、寄生、菟丝子等。此外中药还可有效

地减轻化疗副反应，从而保障化疗顺利进行。

（五）中医药与免疫治疗相结合 中医药具有很强的免疫调节及免疫增强作用。前列腺癌病人大多年老体衰，免疫功能降低，故免疫与中医药相结合可提高机体的抗病能力。实践证明，人参、黄芪、党参、白术等能增强 T 淋巴细胞的比值及活性，桑寄生、旱莲草、菟丝子、银耳等能促进淋巴细胞的转化率，可根据辨证论治原则合理选用。

中西医结合治疗是提高疗效和生存率，改善生存质量的有效途径，但前列腺癌的发病率较低，故有关该病的中医及中西医结合治疗报导甚少。但随着老龄化社会的到来，该病的发病人数会不断增加，为此，有必要加强该病的研究。

第十九章 乳腺癌

【概述】

乳腺癌是女性最好发的恶性肿瘤之一。世界卫生组织(WHO)统计,全球每年死于乳腺癌者约25万人。乳腺癌发病率的高低,一向与地域和种族的不同有关。据Fishet等报道,北欧和北美的乳癌发病率要比亚洲和非洲高5~6倍。在美国,白人妇女的乳癌发病率一直比黑人妇女高,根据官方报道,在1973年至1977年间,10万名白人妇女每年约86人发生乳癌,10万名黑人妇女每年约72人发生乳癌。另一个资料报道,每100万名白人男子每年约7人患乳癌,而每10万名黑人男子每年约1人发生乳癌。

与北欧和北美相比,我国属于乳癌低发区。但到目前为止,我国还没有全国性的乳癌发病率统计数字。据上海市区的统计,1978年到1980年间,女性乳腺癌世界人口标准化发病率为17.9/10万。北京市城郊区在1978至1981年间的标准化发病率为10.45/10万。这三个城市的统计数字,在时限上有差别,在地点和人群组方面各有不同,在统计方法上也不一样,因此颇难以比较。

乳腺的发病年龄约77.36%的病例在35~64岁之间(谢植元等报)。

乳腺癌15岁以前很少见。30岁以下占2%,死于本病的96%在35岁以后,大多发生在40~60岁及绝经期前后的妇女。男性少见,男女之比1:43.5。

乳腺癌的病因目前尚不十分清楚,从临床及实验中反应出来的因素有:雌激素分泌失调,遗传因素,膳食因素,乳房外伤,乳腺良性疾病恶化。

乳腺癌最常见的症状为乳房肿块，且 95% 左右的乳癌患者以此为首发症状。肿块常为单发，无痛，质地较硬，边缘不整齐，表面不光滑。少数病例的肿块伴疼痛。肿块通常位于乳头和乳房边缘之间，外上方最多（占 36.1%），内上方次之（约占 16.9%），再次为上方（12.4%），中央部（8.1%），外下方（6.1%），外侧（5.3%），内下（4.1%），内侧（2.8%），下方（2.7%），全乳受累（2.9%）。乳癌中期一般不痛，随着癌块的不断发展出现隐痛、牵拉痛、刺痛或钝痛，晚期疼痛加剧。同时出现乳房皮肤的改变、乳房轮廓的变形，乳头回缩，乳房溢液等症状。

乳腺癌的病理分型较复杂，有三型十大类，即非特殊型（单纯癌、硬癌、髓样癌、腺癌），特殊型（管内癌、乳头状癌、乳头湿疹样癌、髓样癌合并淋巴细胞浸润、粘液癌、囊性增生病癌变），罕见型（小叶癌、鳞状细胞癌、梭形细胞癌、癌内瘤、大汗腺癌、腺纤维瘤癌变）。

本病以淋巴结转移为主。腋窝淋巴结是乳腺癌最常见的转移区，约占 60%~70%，次为胸骨旁淋巴结，约占 30%，再次为锁骨上淋巴结，晚期可发生血行播散，常见部位为肺和胸膜及肝；骨骼（肋骨、盆骨、椎骨、股骨、颅骨、锁骨等多为溶骨性病变）卵巢、脑、对侧乳腺等。

乳腺癌是发展较为缓慢性的恶性肿瘤之一。如不治疗，平均自然生存期为 33.6~40.5 个月。发病后约 30% 生存至 3 年，20% 生存至 5 年，4% 以上可生存 10 年，个别患者可生存 20 年以上。未治乳腺癌的自然生存期，可作为各种治疗结果评价的依据。

中医对乳腺癌的记载较为详细，历代医家根据其临床表现多把此病算为“乳岩”、“女产乳”、“石奶”等。如隋·巢元方著《诸病源候论》提到乳石痈，他说：“乳石痈之状，微强大，甚大，不赤，微痛热……”。又言：“其肿结确实，至牢有根，核皮相亲，

不甚热，微痛，硬如石。”唐·孙思邈《千金要方》中记载：“妇人乳头生小浅热疮，痒搔之，黄汁出，浸淫为长，百种治疗不差者，动经年月，名为石乳。世谓苟抄乳是也。”明·陈实功在《外科正宗》中曰：“初如豆大，渐若棋子，半年一年，二载三载，不痛不痒，渐渐而大，始生疼痛，痛则无解，日后肿如堆粟，或如覆碗，色紫气秽，渐渐溃烂，深者如岩穴，凸者如泛涟，疼痛连心，出血则臭，其时五脏俱衰，四大不救，名曰乳岩”。总之，古代文献中对乳腺癌的记载很多，因其生于体表故观察亦具体细致，同时提出了许多内服外治的方药，如漏芦散，神效瓜蒌散，清肝解郁汤，犀黄丸，阳和汤，季芝鲫鱼膏等至今仍在临床上广泛应用，取得了较好的疗效。但限于当时的历史条件，治疗多有困难，故常延至晚期溃烂翻花。现今，采取中西医结合的方法，则治疗效果较好。

【病因病机】

中医对乳腺癌病因病机多从整体出发，根据脏腑经络学说进行辨证分析，认为乳头属足厥阴肝经，乳房属足阳明胃经，乳岩的形成多为外感邪毒和七情内伤，以七情失调为主要病因，忧郁伤肝，思虑伤脾，痰气郁结于乳房发为本病；或患难惊恐，房劳过度，耗伤肝肾，经络枯涩，亦可致成本病。

一、外感邪毒 风邪外客，风盛生热，风热壅盛，厥阴之气滞郁结，营卫不和，使乳房之经脉瘀阻而发为本病。另外乳头破损，毒邪直中乳络，以致乳汁瘀积，化热为患，亦可发为本病。

二、七情失调 长期的忧思郁怒不解，是导致乳腺癌的主要原因，历代医家对此论述较多。如明·陈实功《外科正宗》记载：“忧郁伤肝，思虑伤脾，积想在心，所愿不得志者，致经络痞涩，聚结成核。”清·冯兆张《冯氏锦囊秘录》中曰：“妇人忧怒抑郁朝夕积累，脾气消阻，肝气横逆，气血亏损，筋失荣养，郁滞与痰结成隐核。不赤不痛，积之渐大，数年而发，内溃深烂，名曰乳岩。其疮形似岩穴也，慎不可治。此乃七情所伤，肝经血

气枯槁之证。过度的忧思郁怒，可使肝脾两脏功能失调，肝郁不疏则气滞，脾虚不运则痰生，气滞、血瘀、痰凝互结于乳房而形成乳岩。另外，中医学认为与患难惊恐亦有关系。如清·王维德《外科证治全生集》中曰：“乳岩是阴寒结痰，此因哀忧愁，患难惊恐所致。”

外因是发病条件，决定性因素是内因，如正气不足，七情内伤，以致脏腑功能紊乱，经络痞涩，外邪就易乘虚而入。邪毒蕴内，气滞血瘀，痰浊交结滞于乳中而形成乳腺癌。

【治疗】

一、辨证施治

（一）肝气郁结型

【主证】乳房肿块、两胁胀痛，胸闷不适，精神抑郁，心烦易怒，口苦咽干，舌质红或稍暗，苔薄白，脉弦滑或弦。

【分析】本型多因情志失调，忧思郁怒，以致肝气郁结，疏泄失常，气机郁滞，经络痞涩，聚结成块故乳房出现肿块；肝经布两胁，肝郁不疏，气机不畅则见两胁胀痛，胸闷不适；肝郁则情志不畅故精神抑郁，心烦易怒，舌红、苔薄白，脉弦滑均为肝郁气滞之证。

【治则】疏肝解郁，软坚散结。

【方药】柴胡疏肝散化裁。

柴胡 12g，枳壳 9g，川芎 9g，香附 15g，芍药 12g，甘草 6g，郁金 10g，制乳香 12g，制没药 12g，川楝子 12g，王不留行 15g。

【方解】方中柴胡、枳壳疏肝解郁为主药；川芎、香附活血理气止痛，芍药疏肝柔肝止痛为辅药；郁金、川楝子疏肝解郁，制乳没活血止痛；王不留行软坚散结共为佐药；甘草为使调和诸药，全方合用，具有疏肝解郁，软坚散结的功效。

【加减】心烦不眠加酸枣仁 30g，川连 6g；腹胀食少者加莱菔子 15g，炒麦芽 12g；口燥咽干者，加石斛 15g，麦冬 15g，

玉竹 15g。

（二）冲任失调型

【主证】乳房肿块，每于月经来潮前胀痛增剧，腰腿酸软，烦劳体倦或乳房肿块坚硬如石，不红不痛，与周围分界不清，两胁作胀，有时窜痛，月经不调，舌质红，苔薄黄或苔少而有裂纹，脉沉弦或弦细。

【分析】冲任二脉均上行于乳房，内连于肝肾，下注于胞宫，故患难惊恐或房劳过度均可损及肝肾；精血不足，冲任失调，气滞痰凝而出现乳房结块，肝肾亏损，精血不足，腰膝酸软，月经不调，舌质红，苔少或有裂纹，脉弦细均为肝肾不足，冲任失调之象。

【治则】疏肝补肾，调理冲任。

【方药】逍遥散合香贝养荣汤化裁。

当归 15g，白芍 12g，柴胡 15g，白术 12g，茯苓 15g，川贝 12g，制香附 12g，川芎 12g，熟地 9g，甘草 6g。

【方解】方中当归、白芍、熟地养血疏肝，补益肝肾为主药；柴胡、香附、川芎疏肝理气调理冲任为辅药；白术、茯苓疏肝健脾；川贝祛痰散结为佐药；甘草为使，调和诸药。全方合用，具有疏肝解郁，养血补肾，调理冲任的功效。

【加减】乳房肿块痛甚者，上方加元胡 12g，炙獾皮 15g，神疲乏力、腰膝酸软者加川断 15g，杜仲炭 15g，桑寄生 30g。

（三）毒热蕴结型

【主证】乳房肿块增大，溃烂疼痛，血水淋漓，恶臭扬溢，面红目赤，头痛失眠，舌质红无苔，脉数有力。

【分析】毒热内盛，蕴结于乳房，则见乳房肿块日渐增大，热盛灼肉，则见肿块溃烂疼痛，血水淋漓，恶臭扬溢，火热炎上则面红目赤，上扰清窍则头痛，热扰心神则心烦失眠，舌红无苔，脉数有力，皆为毒热蕴结之征。

【治则】清热解毒，消瘤止痛。

【方药】黄连解毒汤合活血散瘀汤化裁。

黄连 9g, 黄芩 12g, 黄柏 9g, 栀子 12g, 当归 15g, 赤芍 15g, 丹皮 12g, 桃仁 9g, 枳壳 12g, 桔梗 30g, 大黄 6g, 川芎 12g, 甘草 6g。

【方解】方中黄连、黄柏、黄芩以清泻三焦实火为主药；当归、赤芍、桃仁、川芎以养血活瘀为辅药；丹皮、大黄清热通腑，引热下行，桔梗、枳壳理气止痛为佐药；甘草为使，调和诸药。全方合用，具有清热解毒，消瘤止痛之功效。

【加减】口渴咽干者，加元参 12g, 麦冬 12g, 石斛 15g, 肿块坚硬痛甚者，加僵蚕 12g, 石见穿 15g, 炒九香虫 15g；发热口苦者，加柴胡 30g, 青蒿 30g, 地骨皮 15g。

（四）气血两亏，毒邪内陷型

【主证】乳癌晚期，肿块持续增大，延及胸腋及锁骨上下，甚则肝、肺及骨骼转移，患者心悸、气短、面色苍白，疲乏无力，失眠盗汗，大便溏泄，小便清利，舌淡苔白腻，脉沉细无力。

【分析】乳癌晚期，正气大衰，毒邪乘虚内陷，随经络流注于各处出现全身广泛转移。气血亏损，心神失养，则出现心悸气短，面色苍白，神疲乏力，失眠盗汗，脾肾两虚，清阳不升则大便溏泄，小便清利，舌淡苔白腻脉沉细无力，均为气血大亏之象。

【治则】扶正祛邪，佐以化痰散结。

【方药】香贝养荣汤加减。

制香附 15g, 川贝母 12g, 人参 15g, 茯苓 30g, 白术 15g, 炙甘草 6g, 大熟地 15g, 当归身 15g, 川芎 15g, 大白芍 15g。

【方解】方中人参、茯苓、白芍、炙甘草以补气；当归、白芍、川芎、熟地以养血；气血得补，正气充盛，则能驱邪外出，香附疏肝理气，川贝以祛痰散结，诸药合用，具有扶正祛邪的功效。

【加减】肿块溃烂、血水淋漓者，蒲公英 15g，紫草 12g，凤尾草 30g；失眠者加远志 12g，茯神 15g，炒枣仁 15g；转移肿块坚硬增大者，加僵蚕 15g，白花蛇舌草 30g，石见穿 30g；流脓溢血者，加血余炭 12g，蜂房 15g，银花 30g，连翘 15g；流脓恶臭者，加土茯苓 30g，薏苡仁 30g，仙鹤草 30g。

二、单方、验方、成方治疗。

（一）单方

1. 薜荔果 30~60g，水煎服，日一次；
2. 毛冬瓜 30~60g，水煎服，日一次；
3. 天门冬（鲜品）30~60g，水煎服，日一次；
4. 夏枯草 30g，水煎服，日一次；
5. 生蟹壳砂锅内焙焦为末，每服 6g，黄酒送下。

（二）验方

1. 藤葡金星汤：藤梨根，野葡萄根各 30g，八角金盘 3g，生南星 3g，水煎服，日一剂。

2. 龙蛇羊泉汤：龙葵、蜀羊泉、蒲公英各 30g，蛇莓 15g，薜荔果 15g。溃烂者加忍冬藤 30g，胡桃夹 30g；剧痛加栋树果 15g，乌药 9g 或元胡 15g。

3. 山羊角散：山羊角（煨），川楝子（炒），露蜂房各 90g。共研细末，每服 6g，陈酒送下，每日一次。

3. 慈姑雄黄散：山慈姑 15g，雄黄 6g，露蜂房 15g，分别研末，再和均共研，每服 1.5g，每日二次，用胶囊装服。

5. 神效瓜蒌散：瓜蒌一个研烂，当归（酒洗）15g，生甘草 15g，乳香 3g，没药 3g。

6. 天漏汤：天葵子 30g，芸苔子（油菜子），白敛各 30g，漏芦 15g，八角莲 9g，地鳖虫 9g，木馒头 9g，露蜂房 9g，金莲花 9g，水煎服。

（三）成方（药）

1. 小金丹：消肿止痛。可用于乳腺癌各期，每日二次，每次

一丸。

2.犀黄丸：活血化瘀，解毒消痈。用于乳腺癌肿块未消的各期。日二次，每次3g。

3.醒消丸：和营通络，消肿止痛。日二次，每次10g。

4.活血消炎丸：是由犀黄丸加减而来。散结作用逊于犀黄丸。多用于炎性期。作用与醒消丸同。

5.散结灵：软坚散结，用于各期乳癌，每次2~3片，日三次。

6.平消片：软坚散结，活瘀止痛。每次4~8片，日三次。

7.鸦胆子油：解毒抗癌。每次5ml，日三次。

三、中西医结合治疗

(一) 中西药与手术治疗相结合 手术治疗仍是乳腺癌综合治疗的主要方法。如能与中医药相结合可提高手术疗效。。术前服用中药可改善一般情况，增强体质，调整机体内环境，有利于手术的进行。术后服用中药可补气养血，调理脏腑经络，减少复发率和转移率。可根据患者的证候、体质、病期等情况，进行辨证论治。

(二) 中医药与化疗相结合 乳腺癌的化学药物治疗除激素外种类繁多，但缺乏选择性的特效药物，每个疗程缓解期平均约4~8个月，若同时配合中医药治疗，常能减轻化疗的副作用，提高机体的免疫功能，延长缓解期。化疗期间中医治疗原则是健脾和胃，护肾益髓，常用中药有川朴、姜竹茹、砂仁、佩兰、黄芪、当归、女贞子、旱莲草、桑寄生等药。

(三) 中医药与放疗相结合 放疗是局部治疗手段之一，较手术应用范围广，适应于各期乳腺癌病人。但放射线在杀伤局部癌细胞的同时也可导致局部组织纤维化并对肺部有一定的损害。放疗期间，大多数患者出现心烦，口渴，咽干食少，局部皮肤色素沉着，干燥，白细胞及血小板减低，中医认为是热毒（放射线）内侵，耗伤阴液所致。故放疗期间若能同时服用清热

养阴的药物，可明显减轻放疗的损伤，并可提高放疗效果。常用药物为西洋参、太子参、沙参、麦冬、石斛、元参、知母、玉竹、鱼腥草、全瓜蒌、黄芩、栀子等。

【现代治疗进展】

一、外科治疗 乳腺癌手术切除有根治性手术及姑息性手术。近年扩大根治手术较少应用，因破坏性大，患者自身免疫力降低，疗效并不理想。现在许多单位使用改良根治手术，即保留胸大、小肌。据观察，五年生存率与根治手术相似，有人观察，根治手术和单纯全乳腺切除术后五年生存率分别为 58% 和 64%。目前国内肿瘤学者，正在进一步研究改进手术方法，使乳腺癌手术的疗效有明显的提高。

二、化学治疗 近年来，乳腺癌的化学药物治疗有一定的进展。常用的药物有 CTX、L-PAM、TSPA、MTX、5-Fu、长春新碱类和蒽环类抗生素等。ADM 用于乳腺癌后，疗效明显提高，EPI（表阿霉素）与 ADM 疗效相似，但减低了心脏毒性和其它副作用。二药合用比单药的效果好。如 Lolozza 等（1988）用小剂量 ADM 和 MMC 治疗 44 例晚期乳腺癌病人，结果 CR5 例，PR14 例，有效率 43%，中位缓解期 8 个月。Gohzdlcz 等用 DDP 每日 $15\text{mg}/\text{m}^2$ ，连用五天与 5-Fu 每日 $1000\text{mg}/\text{m}^2$ 连用五天，治疗 16 例，有效率为 68%。三种化疗药物联合应用进一步提高了疗效。Carbane 等报道用 CMF 方案治疗 354 例，有效率 35%，CMFP 方案治疗 218 例，有效率 44%；用 CMFVP 方案治疗 529 例，有效率为 47%。Holmes 等用 MXI+CTX+5-Fu 方案治疗 48 例，CR5 例，PR13 例，有效率 38%，CAF 方案（CTX+ADM+5-Fu）、CMF 方案（CTX+MTX+5-Fu）、CEF 方案（CTX+EPI+5-Fu）三个方案对乳腺癌均有较好的疗效，其中 CMF 方案对肺转移的效果较好。

三、内分泌药物治疗 本世纪七十年代以后，由于三苯氧

胺、氨苯哌酮等新型内分泌药物用于临床，已逐步代替了传统的性激素和内分泌和手术治疗方法，这些药物的疗效好，副作用小，可长期使用，因而被广泛运用。综合文献报道，三苯氧胺对晚期乳腺癌的有效率为 16%~52%，平均 32%。对 ER (+)，绝经后 50 岁以上及软组织病变的疗效好。Legha 认为三苯氧胺 (TAM) 已成为治疗绝经后转移乳腺癌及绝经后淋巴转移的Ⅱ期术后辅助内分泌治疗的道选药物。Furr 等将 TAM 与乙酚比较，TAM 的有效率为 31%、26%，即两者疗效相似，而 TAM 的副作用小。氨苯哌酮主要用于绝经后或卵巢切除后恶化的晚期乳腺癌。Studrt-Harris 等综合 19 名作者用氨苯哌酮治疗绝经晚期乳腺癌有效率为 31%，对 273 例有效病例的中位缓解期为 11 个月。还有报道用甲孕酮治疗绝经后晚期乳腺癌，可获得与三苯氧胺相似的效果。Tominaga 等用孕酮 1200mg，每日 3 次口服，治疗绝经后病，有效率为 40.4%，对骨转移有效率 31.6%，并可改善一般状况，促进代谢合成和保护骨髓的作用。

四、放射治疗 放射治疗适应于各期乳腺癌病人。主要有根治性单纯放疗，辅助性放疗，姑息性放疗三种。根治性单纯放疗，目前已很少使用，不仅放疗不佳而且合并症多。辅助性放疗，最常用的是手术前放疗和手术后放射治疗。术前放疗，目的是使肿瘤体积缩小，便于手术，使淋巴管部分或完全闭塞防止术中转移，使瘤细胞活力减少，便于彻底消灭。术后放疗的目的是消灭淋巴引流区未被消除的转移灶和消灭手术可能残留的癌细胞。姑息性放疗，主要适用于大部分Ⅲ期和Ⅳ期病人，目的是缓解症状，延长生命。

五、免疫治疗 免疫治疗是乳腺癌综合治疗中的一个组成部分。常用于手术、放疗及化疗以后，尤其体质差者更为适用。常用的免疫制剂有 4%海藻酸钠皮内注射，卡介苗、短棒菌苗、转移因子、干扰素、白细胞介素-Ⅱ、NK 细胞活化因子等。目前单用此类药物治疗乳腺癌的报道较少，多与其它治疗手段结合应

用。

六、综合治疗 根据乳腺癌病期、体质的不同采用综合治疗手段，可明显提高治疗效果，延长生存期。当前治疗乳腺癌的综合方法有以下几方面。

I 期乳腺癌：全乳腺切除及腋淋巴结清扫后放疗不化疗。

II 期乳腺癌：根治术+术中化疗+术后放疗、化疗+中医药治疗+内分泌治疗。

III 期乳腺癌：根治术+术中化疗+术后放疗+中药治疗+定期化疗 2~3 年+内分泌治疗。

IV 期乳腺癌：联合化疗+内分泌治疗+中医药治疗。

妊娠哺乳期腺癌：终止妊娠，停止哺乳+联合化疗+内分泌治疗+手术治疗+中医药治疗。

第二十章 子宫颈癌

【概述】

子宫颈癌是已婚妇女中最常见的恶性肿瘤之一，世界各国子宫颈癌的年发病率有很大差异，Setouahi 报道，哥伦比亚 180/10 万人口，北非、摩洛哥为 110/10 万人口，发病率最高，法国为 70/10 万人口，加拿大为 65/10 万人口，发病率居中。加州为 25/10 万人口，以色列为 12/10 万人口，发病率最低。

我国也是子宫癌发病率较高的国家之一，近年来，由于全国各地开展广泛的宫颈癌的普查普治工作，宫颈癌的患病率有逐渐降低的趋势。但与其它癌瘤相比，其发病率仍很高，1971 年在全国 17 个省市部分地区进行 1000 万人的普查中，安徽、山东、山西 3 省 1151389 名人口普查中，子宫颈癌发病率在各种恶性肿瘤中居第 1 位，四川、河北、辽宁、吉林等省市 559872 名人口普查中，子宫颈癌发病率占第 2 位；福建省 7121210 人口普查中子宫颈癌占第 3 位。宫颈癌的发病率一般随着年龄的增长而呈显著上升，35 岁以后明显增多，55~65 岁为发病高峰。北京市 1972~1976 年普查材料证明，40 岁以上为子宫颈癌的好发年龄，随着年龄的增长，患病率成倍递增，39 岁以下的患病率为 11.34/10 万人口，40 岁以下的患病率为 176.45/10 万人口，60 岁以上组最高达 694.63/10 万人口。

现在对宫颈癌发病原因尚无明确结论。但多数学者认为，与早婚（18 岁以前结婚）、早育（20 岁以下）、多产（5 胎以上）、宫颈糜烂、裂伤与外翻、性交过频（尤以乱交）、包皮垢及性激素失调有关。另外与病毒感染（如疱疹 2 型病毒，人乳头状病毒）和维生素 C 缺乏有关。其它与妇女卫生、生活经济状况及

精神刺激等也有关。

子宫颈癌的好发部位在宫颈外，鳞状上皮和柱状上皮交界处和转化带，根据其进展情况，可分为原位癌、早期浸润癌、浸润癌。原位癌是指宫颈全层都有不典型细胞增生，癌细胞局限于宫颈上皮层内，基底膜完整。早期浸润癌指癌细胞穿破基底膜向间质中浸蚀的深度不超过5毫米者。浸润癌指癌组织浸入间质的深度超过5毫米在淋巴管中发现癌栓。

子宫颈原位癌和早期浸润癌多无明确的症状或仅有似宫颈炎的症状，往往被忽略。当癌肿发展到相当程度时，其症状才易被注意。最常见的表现是阴道不规则流血，分泌物增多及疼痛，大约有80%以上的病人有阴道分泌物增多伴有恶臭，约有80~85%的病人有阴道出血，早期表现为接触性出血或点滴出血，晚期浸润大血管可引起大出血，并危及生命，当癌组织侵犯宫旁或闭孔神经、骶丛神经等可引起较严重的疼痛。

子宫颈癌在大体病理上主要分为菜花型、结节型及溃疡型三种，以菜花型居多，溃疡型次之，结节型又次之。根据肿瘤的组织来源，宫颈癌可分为鳞状细胞癌、腺癌及混合癌。鳞癌占95%以上，腺癌占5%以下，混合癌不超过1%，有少数宫癌由于细胞分化太差，不能辩论其组织来源，无法归入上述分类，一般标为未分化癌。子宫颈癌的主要扩散途径是直接扩展和沿淋巴转移，少数经血循环转移。

中医学中无宫颈癌病名，但类似宫颈癌症状的记载则散见于“崩漏”、“征瘕”、“带下”“阴菌”等病门中。早在《内经》中即有“任脉为病，女子带下瘕聚”的描述。《金匱要略·妇人杂病脉证并治》中曰：“妇人之病，因虚积冷结气，为循经水断绝，至有历年，血寒积结胞门，寒伤经络”。又言：“在下赤多，经候不匀，令阴掣痛，少腹恶寒，或引腰脊，下根气街，气冲急痛，膝胫痛烦，奄忽眩暈，状如厥癲，或有忧惨，悲伤多嗔，此皆带下，非有鬼神，久则羸瘦，脉虚多寒”。《千金要方》中记载：崩中漏

下，赤白青黑，腐臭不可近，令人面黑无颜色，皮骨相连，月经失度，往来无常，小腹弦急，或苦绞痛上至心，两胁肿胀，食不生肌肤，令人偏枯，气息乏少，腰背痛连胁，不能久立，每嗜卧困懒”。以上记载与中、晚期宫颈癌症状大致类同。

【病因病机】

子宫颈癌的病因很多，中医学将其分为两大类。外因以感受湿热毒邪为主，内因则主要是七情失调，房劳过度，脏腑虚损等几个方面。其中七情失调，外感湿毒是导致本病的主要原因。诸因相合，损伤冲任两脉而出现宫颈癌的症状。

一、湿毒下注 外感湿热毒邪或素体脾虚，湿蕴化热，湿热毒邪流注下焦，损伤冲任，堵塞胞门而致本病。

二、气郁湿困 长期忧思劳倦过度以致肝脾两脏功能失调，肝郁不疏则气滞，脾虚不运则湿生，湿浊与气蕴结于下焦，致冲任两脉损伤而发为本病。张璐在《张氏医通》中曰：“妇人阴疮，乃七情郁火损伤肝脾，湿热下注”。

三、下元虚损 房劳过度或早婚多产，或年近七七，天癸将竭，均易伤及肝肾两脏，致冲任失调，胞脉气血运行受阻，瘀毒内结而致。金元李东垣指出：“妇人崩中者，由脏腑损伤冲任二脉，气血俱虚故也；二脉为经脉之海，血气之行，外循经络，内荣脏腑，若气血失调适经下依时，若劳动过极脏腑俱伤，冲任之气虚不能制约其经血，故忽然而下，谓之崩中暴下”。

综上所述，中医认为子宫颈癌主要与冲任损伤有关，冲任两脉的功能正常与否和脏腑功能的盛衰有关，其中尤与肝肾关系密切。此病以七情所伤，气郁湿困，肝脾肾诸脏虚损为内因，外感湿热毒邪为外因。

总之，在子宫颈癌发生过程中，外感湿热瘀毒互结于胞门为病之标，而脏腑损伤，冲任失调，为病之本。

【治疗】

一、辨证论治

(一) 肝气郁结型

【主证】胸胁胀满或窜痛，胸闷不舒，情志抑郁或烦躁，白带多，阴道接触性出血，量不多有瘀血块，口苦咽痛，纳呆，脉弦涩，舌质微暗，薄黄苔。

【分析】七情失调，肝气郁结，气机不畅，肝之经脉布两胁，肝郁气滞则胸胁胀满或窜痛，胸闷不舒。肝郁失于调达则情志不畅，出现情绪抑郁或烦躁。肝气郁结影响中焦脾胃的升降功能，脾虚不运，湿邪注于下焦胞宫，则白带增多，并有少量出血，胃气不和则纳呆口苦。舌质微暗，脉弦涩为肝气郁结之征。

【治则】疏肝理气，解毒散结。

【方药】丹栀逍遥散化裁。

丹皮 15g，栀子 10g，柴胡 10g，当归 15g，白芍 15g，白术 15g，茯苓 30g，半枝莲 30g，蛇舌草 30g，郁金 15g。

【方解】方中柴胡疏肝理气为主药，丹皮栀子清解郁热，当归、白芍养血疏肝为辅药；白术、茯苓健脾渗湿，半枝莲、蛇舌草抗癌解毒，郁金疏肝解郁为佐使药。诸药合用，共奏疏肝理气，解毒散结之功效。

【加减】睡眠差者加炒枣仁 30g，合欢花 15g，纳呆者加莱菔子 15g，炒麦芽 15g。

(二) 湿毒下注型

【主证】带下量多，色黄质稠，其味腥臭，有时夹有瘀血块或腐肉，小腹胀痛或坠痛不适，小便黄赤，大便不调，发热口渴，舌质红苔黄脉滑数。

【分析】湿热蕴结，流注于下焦，损伤冲任，则出现带下量多，色黄腥臭等症状，湿热蕴结致下焦气机不通则小腹胀痛或坠痛不定，同时出现小便黄赤，大便不调；湿热内蕴则发热、口渴、舌质红，苔黄，脉滑数均为湿热内蕴之象。

【治则】清热利湿，解毒化瘀。

【方药】土茯苓 30g，败酱草 30g，黄柏 15g，龙葵 15g，蒲

公英 30g, 暮头回 30g, 瞿麦 30g, 赤芍 30g, 生苡仁 30g。

【方解】方中土茯苓、黄柏燥湿解毒为主药；败酱草、蒲公英、暮头回清热解毒；瞿麦、龙葵利湿解毒为辅药；赤芍活瘀清热，生苡仁渗湿健脾为佐使药。全方合用共凑清热利湿，解毒化瘀之功效。

【加减】小腹胀痛甚者加广木香 6g, 醋香附 15g, 瘀血块多时加三七 6g, 当归 30g, 桃仁 12g。

(三) 瘀血内阻型

【主证】小腹部持续性剧痛，入夜加重，赤白带下，恶臭难闻，面色晦暗，精神烦躁不安，舌质暗紫有瘀点，脉沉或涩。

【分析】瘀血阻滞下焦，损伤冲任二脉，经气不通则见小腹持续性刺痛，入夜加重，赤白带下，恶臭难闻。瘀血不祛，新血不生，机体失于濡养则见面色晦暗，精神烦躁不安。舌质暗紫，脉沉涩均为体内瘀血之征。

【治则】活血化瘀，理气止痛。

【方药】少腹逐瘀汤化裁。

当归 30g, 川芎 9g, 丹参 30g, 赤芍 15g, 元胡 15g, 五灵脂 15g, 蒲黄 15g, 桃仁 9g, 红花 12g, 枳壳 12g, 土茯苓 30g, 薏苡仁 30g。

【方解】方中当归、川芎、桃仁活血化瘀，养血通经为主药；五灵脂、蒲黄、元胡活瘀止痛；赤芍、丹参清热化瘀为辅药；红花、枳实理气活瘀，土茯苓、薏苡仁解毒清热利湿为佐使药。诸药合用，共凑活血化瘀，理气止痛之功效。

【加减】心烦不眠者加夜交藤 30g, 酸枣仁 30g, 栀子 12g; 大便秘结者加郁李仁 12g, 火麻仁 15g, 大黄 9g。腹胀纳呆者加莱菔子 15g, 炒麦芽 15g。

(四) 肝肾阴虚型

【主证】赤白带下，气味腥臭难闻，头晕耳鸣，口干咽燥，五心烦热，腰酸腿软，舌质红，少苔，脉弦或细数。

【分析】病久肝肾亏虚，冲任受损，经脉不调，则出现赤白带下，气味腥臭；肝肾亏虚，精血不足则头晕耳鸣，腰膝酸软，阴虚阳亢，虚热内生则五心烦热，咽干口燥，舌质红，少苔，脉细数，为肝肾阴虚之象。

【治则】滋养肝肾，解毒清热。

【方药】知柏地黄汤化裁。

知母 12g，黄柏 9g，生地 15g，山药 30g，山萸肉 30g，丹皮 12g，旱莲草 30g，女贞子 30g，桑寄生 30g，白花蛇舌草 30g，土茯苓 30g，暮头回 30g，刘寄奴 15g。

【方解】方中生地、山药、山萸肉滋补肝肾之阴为主药，知母、黄柏、丹皮清热解毒为辅药，旱莲草、女贞子、桑寄生养阴清热，白花蛇舌草、土茯苓、暮头回、刘寄奴解毒抗癌为佐使药。诸药相合，共奏滋肝养肾，解毒清热之效。

【加减】低热不退者，加地骨皮 15g，白薇 15g；小腹痛甚者加刺猬皮 15g，炒九香虫 15g，出血多者加紫珠草 30g，茜草 30g，仙鹤草 30g。

二、单方、验方、成方（药）

（一）单方

1.槐覃（又名槐耳，是槐树上生长的香蕈），每日 6g，水煎服。应长期应用。

2.鲜桃叶适量，洗净，捣烂，用纱布裹后纳入阴道深处，每日 3~4 次。

3.大麻药根适量，洗净，凉干后捣烂，敷贴患处，有缩块、消炎、止血作用。

4.生菱角肉 20~30 个，加足量水，文火煎成浓褐色的汤液，分 2~3 次，一日内饮完，可长期饮用。

5.泽漆 100g，鸡蛋 3 个，加水共煮，蛋熟后吃蛋喝汤，一日用完，应坚持服用。

6.苏铁叶 120g，红枣 12 枚，加水煎服，每日一剂。

(二) 验方

1. 复方石见穿煎：鲜石见穿 30g，鲜六月雪 30g，鲜暮头回 30g，鲜香附 15g，上药共煎，日一剂，分两次服用。

2. 剑英汤：开口剑（福氏量厥）30g，白英 15g，杜鹃根 15g，小叶飞杨 15g，金樱子根 15g，板兰根 15g，黄柏 15g。若全身浮肿，大便不适，消化不良加大黄、谷芽、党参、茯苓；疼痛加皂角根 30g，绣花针 30g，生狗骨灰 90~120g；出血不止用棉花籽、败棕、头发、荷叶蒂共烧灰存性，研末，用主方汤药冲服，每次 30g，日一次，同时，取老母鸡一只炖烂，以鸡汤和药汁同服，连服 15 天为一疗程（如无母鸡，亦可改为鸡蛋汤或蜂蜜）。

3. 藤苓汤：白毛藤 12g，土茯苓 12g，苦参 12g，坎无（干脐带）12g，半枝莲 12g，暮头回 12g。带下多者。加白槿花 6g，糯根皮 12g，白鸡冠花 12g，每日一剂，水煎服。

4. 皂刺饮：皂刺 9g，连翘 9g，花粉 9g，当归 9g，炙木鳖 1.5g，川连 9g，金银花 12g，生地 12g，黄芪 15g，赤芍 6g，甘草 6g，水煎服，日一剂。

5. 宫颈 I 号煎：鱼腥草 30g，丹参 15g，当归 9g，牡蛎 30g，白花蛇舌草 30g，茜草 9g，白茅根 30g，党参 15g，白术 9g，赤芍 9g，土茯苓 9g，日一剂，分两次服用。

6. 柴胡四物加味：柴胡 6g，当归 6g，川芎 6g，白芍 6g，熟地 6g，椿皮 6g，白果 6g。水煎服，日一剂，分 2 次服用。

(三) 成方（药）

1. 掌叶半夏片：每日服片剂约合生药 60g，外用栓剂及棒剂，每栓含生药 50g，棒含生药 5~7.5g。上海市治疗 175 例宫颈癌，I 期有效率 88.89%，II 期有效率 82.91%，III 期有效率 41.17%，原位癌及早期浸润癌均近期治愈，各期近期治愈率 38.8%。

2. 莪术制剂：1%莪术油加 5%葡萄糖，静脉滴注或 5%莪术

注射液，局部注射（沈阳药学院供药）治疗宫颈癌 220 例，总有效率为 70.8%，以早期及溃疡型效果较好。但疗程长，晚期疗效差。

3. 农吉利制剂：山东用农吉利甲素局部注射及静脉、肌肉注射。治疗 150 例宫颈癌总有效率 43.3%。

4. 治癌散及抑癌片：沈阳医科大学附属医院用治癌散外用，同时内服抑癌片，治疗 71 例宫颈癌近期治愈率为 50%，有效率 73%。治癌散组成：砒石 10g，枯矾 30g，碘仿 40g，硃砂 10g，冰片适量，共研成细末外敷，每日上药，敷以青黛、紫金锭等防腐、消炎。抑癌片组成：生马钱子、天花粉、重楼、甘草。马钱子去皮香油炸至酥脆，与其他三味药共研成细末，加淀粉打成片剂，每片 0.3g。每日 3 次，每次 3~5 片。

5. 制癌粉付号：北京中医医院外用制癌粉付号（蟾蜍 15g，雄黄 3g，白芨 12g，制砒 1.5g，五倍子 1.5g，明矾 60g，紫硃砂 0.3g，三七 3g，外加消炎粉 60g，共研成细末外用，隔日一次，同时内服辨证论治中药。1958~1968 年治疗 62 例宫颈癌，到 1972 年回访总结时，5 年治愈率为 53.2%，1977 年随访，10 年治愈率为 37.9%。

6. 中药三品一条枪：白砒 45g，明矾 60g，雄黄 7.2g，没药 3.6g。先将白砒及明矾分别研成粗粉，混合后煅制成白色疏松块状物，质轻易碎，检验合格后，研碎加雄黄，没药粉混合均匀，压制成饼成杆，紫外线消毒后备用。该药具有促使宫颈组织凝固、坏死、自溶脱落作用，经临床验证，对宫颈癌有显著疗效。

三、中西医结合治疗

（一）中医药与手术治疗相结合 对于早期宫颈癌仍以手术治疗为主。术后加配服中药，可以增强体质，调整脏腑功能，提高机体免疫力，缩短术后恢复期，减少并发症和后遗症，能明显提高生存率。

（二）中医药与放疗相结合 对于Ⅱb 期、Ⅲ期宫颈癌患

者、常用放疗为主。若同时服用中药可以提高放疗效果、减轻放疗的副作用。上海妇产医院应用天南星为主治疗宫颈癌 75 例，天南星加体外放疗治疗 89 例，二组有效率达 82% 左右，后者 89 例中有 50 例为Ⅲ期宫颈癌，说明天南星有治癌效果，与放疗同用，能提高放疗效果。放疗对胃肠道有一定损伤，甚至影响放疗的正常进行。可同时服用香砂六君子汤，以调整胃肠功能，对放射线直肠炎，按中医辨证分为四型：肝热下迫型以白头翁汤加减；湿热下注型以葛根芩连汤加减；肝热下迫兼湿热型用白头翁汤合葛根芩连汤加减；脾虚泻泄型用四君子汤加减。按以上方法治疗 104 例，治愈 68 例，好转 35 例，无效 1 例，总有效率 99%。

（三）中医药与化疗相结合 在中医治疗的同时，如病期较晚或瘤体较大，可以配合化疗药物局部注射、静脉注射或动脉插管灌注，以提高疗效。如上海、杭州报道用香葵精油栓剂局部上药综合化疗、放疗或手术治疗子宫颈癌 142 例（Ⅱa 期 78 例，Ⅲa 期 1 例，Ⅲb 期 55 例，Ⅳ期 2 例，放疗后复发 4 例，残端癌 2 例），其中 96 例获近期痊愈，近期治愈率 67.6%，而单纯中药香葵精油近期治愈率 4.4%，单纯化疗近期治愈率为 2.2%。可见中西药综合化疗、放疗或手术疗法是提高晚期宫颈癌近期治愈的有效途径。

第二十一章 子宫体癌

【概述】

子宫体癌发生在子宫内膜，故又称子宫内膜癌，是女性生殖系统较常见的恶性肿瘤之一。在欧美女性人口中平均年发病率为15/10万~23/10万人口。在我国子宫体癌平均年新发病例为1.59万人，与子宫颈癌新发病例之比为1:8。近年来，子宫体癌的发病率在国内外均有上升趋势。

子宫体癌多发生在50岁左右，基本上属于老年妇女的肿瘤。根据北京、天津、上海、广州的四所医院近600例的统计分析，50~60岁的患者占71.6%，高峰年龄为55~59岁。年龄在40岁以下和70岁以上者较少，各占6.1%和1.2%。年龄最小者为18岁，最大者76岁。

子宫体癌发病的真正原因尚不清楚，虽有雌激素分泌过多（患者的绝经期延迟，常合并子宫内膜增生症，子宫内膜息肉或并发女性化卵巢肿瘤）、胆固醇代谢障碍（好发于肥胖、高血压、糖尿病患者）、遗传（有家族癌症史）、放射线刺激（有因良性疾病行子宫放射治疗而发生子宫体癌者）等说法，但各家的统计观察不一，尚难得出肯定的结论。

子宫体癌主要表现为不规则的阴道出血和阴道排液量增多，出血量多为少量和中量，很少为大量出血。一般无接触性出血，晚期出血中可夹杂有烂肉样组织。阴道排液增多常为瘤体渗出或继发感染的结果，可表现为血性液体物、浆液性分泌物，有时有恶臭味。晚期可出现疼痛，疼痛呈顽固性和进行性加重。且多从腰骶部、下腹向大腿及膝部放射。

子宫体癌变开始多发生在子宫体上段的内膜，以子宫两角是多见，其次为子宫后壁。就病变的形态和范围而言，分为弥漫

型，局限型和息肉型三种。按组织细胞学分类，可分为内膜腺癌、棘腺癌和腺癌，以腺癌最多见。子宫体癌的扩散以直接蔓延和淋巴道转移为主，晚期发生血行播散。

中医学中无“子宫体癌”这一病名，但类似于“子宫体癌”的症状散见于古医籍中记载的“崩漏”、“五色杂带”、“症瘕”等病门中。如唐容川在《血证论》中曰：“崩漏者，非经期下血之谓也”。《医学入门》云：“凡非时血行，淋漓不断，谓之漏下；忽然暴下，若山崩然，谓之崩中”，《医宗金鉴·妇科心法要诀》曰：“……更审其带之淋漓沥物，或臭或腥秽，乃败血所化，是胞中病也；若是疮脓，则非瘀血所化，是内脓也”。以上描述与子宫体癌雷同。

【病因病机】

清·萧庚六《女科经论》中曰：“凡病先明虚实寒热，如崩漏症，有虚、有实、有寒、有热。虚者，主于血虚、气虚、阴虚、阳虚；实者，主于污淤恶血，痰涎瘀滞；虚则为寒为冷；实则火为热。此证之不可不先辨者也”。中医学认为，引起子宫体癌的病因很多，但不外于虚实两大类，实则以血热，血瘀为多见，虚则以气虚，肾虚为主。以上诸因致冲任二脉功能失调，邪毒聚于胞宫而发本病。

一、血热蕴结 平素体质阳盛，或嗜食肥甘辛辣助阳之品，或情绪过激，肝火内炽，以致阳气亢盛，热迫血行，冲任受损，阴血失守，而发为本病。如《女科经论》中曰：“妇人血崩，来如潮涌，明是热势妄行……宜清补兼升提，不可骤之”，又言：“妇人经血，终于七七之数，数外暴下，‘火主暴速’亦用暴喜暴怒，忧结惊恐所致然也，慎不可作冷病治之，用峻热之药则死”。

二、瘀血阻滞 经期产后，余血未尽即行房事，损伤冲任，致血瘀胞中，或月经期间，感受外邪，邪乘虚入于胞宫，邪阻经脉，瘀血阻滞，日久不通，瘀血不去，新血不得归经而发为本病。如宋·王怀隐在《太平圣惠方》中记载：“夫妇人崩中之病

也，是伤损任之脉。冲任之脉，皆起于胞内，为经脉之海，劳伤过度，冲任气虚，不能统制经血……内有瘀血，故时时淋漓不断……”。

三、气虚失摄 久病重病损耗机体，致宗气大伤；或思虑劳倦过度致中气虚衰，气虚则不能固摄，冲任受损，血海不藏，以致发为本病。宋·陈自明《新编妇人良方补遗大全》中曰：“……由脏腑伤损，冲脉任脉俱虚，冲任之脉为经脉之海，血气上行，外循经络，内荣脏腑，若无伤损，则阴阳和平而气血调适，经下依时。若劳动过度，致脏腑俱伤，而冲任之气虚不能制约其经血，故忽然暴下，谓之崩中”。

四、肾阴虚弱 先天禀赋不足，或后天失调，以致肾气不足，冲任不调，胞脉失养而发为本病。如张锡纯在《医学衷中参西录》中曰：“女子血崩，因肾脏气化不固，而冲任滑脱也”。

【治疗】

一、辨证论治

（一）血热蕴结型

【主证】阴道不规则出血，或突然出血量多，胸胁胀满，心烦易怒，口燥咽干，失眠多梦，舌红苔薄黄，脉弦数。

【分析】热盛入血，迫血妄行，血海不藏则见阴道不规则出血。或突然出血量多。肝郁化火，则见胸胁胀满，心烦易怒。火热伤津，机体失养，则见口燥咽干。火扰心神，则出现失眠多梦，舌红苔薄黄，脉弦数均为火热内盛之象。

【治则】清热泻火，凉血止血。

【方药】丹栀逍遥散化裁。

丹皮 6g，栀子 9g，当归 12g，白芍 15g，柴胡 12g，白术 12g，云苓 9g，薄荷 3g，甘草 3g，荆芥炭 9g，生地炭 12g。

【方解】方中当归、白芍、柴胡疏肝解郁，清热和血为主药；丹皮、栀子清热泻火，凉血生津，以增强主药之力为辅药；白术、茯苓健脾和胃，防凉血太过而伤胃。薄荷疏散热邪；荆芥

炭、生地炭以凉血止血，诸药共为佐药。甘草为使，调和诸药。全方共奏清热泻火，凉血止血之功效。对于子宫体癌辨证属于血热蕴结型的最为适宜。

【加减】若口燥咽干甚者，上方加知母 12g，麦冬 15g，玉竹 15g，石斛 15g；大便干结难行者，加大黄 9g，川朴 12g，芒硝 12g；心烦易怒，失眠多梦者，加酸枣仁 15g，夜交藤 15g，合欢花 15g。

（二）瘀血阻滞型

【主证】阴道不规则出血，夹有瘀血块，少腹疼痛拒按，阴道排液恶臭难闻，舌质紫暗，舌边有瘀点瘀斑，苔薄脉沉涩或弦细。

【分析】冲任受损，瘀血阻滞胞宫，则见阴道不规则出血，时夹有瘀血块。瘀血阻滞不通则出现少腹疼痛。因有实邪阻滞则痛而拒按。瘀久化热，瘀热腐肉，则排出物恶臭难闻。舌质紫暗，有瘀点瘀斑，脉沉涩，均为瘀血内阻之征。

【治则】活血化瘀理气止痛。

【方药】血府逐瘀汤化裁。

桃仁 6g，红花 6g，当归 6g，生地 6g，川芎 6g，赤芍 6g，柴胡 9g，延胡 6g，没药 6g，甘草 3g。

【方解】方中桃仁、红花、当归、川芎、活血化瘀为主药，柴胡疏肝理气，生地补血凉血，赤芍活瘀清热为辅药，元胡理气止痛，没药活瘀止痛为佐药，甘草为使，调和诸药。诸药合用，共奏活血化瘀，理气止痛之功效。

【加减】若小腹痛甚者，加五灵脂 9g，蒲黄 9g。纳呆不食者，加鸡内金 15g，莱菔子 15g。出血量多者，加血余炭 15g，紫珠草 15g。

（三）气虚失摄型

【主证】阴道不规则出血，量时多时少，色淡质稀，面色苍白，神疲肢倦，气短懒言，自汗心悸，舌质淡舌边有齿印，苔薄

白，脉缓弱无力。

【分析】气虚无力固摄冲任二脉，血海不藏则见阴道不规则出血，量时多时少，色淡质稀，气虚则无力推动血行，机体失养则见面色苍白，气血不足神失所养而出现神疲肢倦，气短懒言心悸；气虚无力固摄，津液外泄则自汗；舌质淡或边有齿痕，苔薄白，脉缓弱无力，均为气虚之象。

【治则】益气健脾，固摄止血。

【方药】举元煎化裁。

人参 12g，黄芪 15g，炙甘草 6g，白术 10g，升麻 6g，阿胶 9g，艾叶 12g。

【方解】方中人参、黄芪大补元气为主药。阿胶、艾叶养血止血为辅药，白术健脾益气，升麻益气升提为佐药。甘草为使，调和诸药，全方合用，共奏益气健脾，固摄止血之效。

【加减】出血量多者，加蒲黄炭 12g，仙鹤草 15g，白芨 12g，食后腹胀者加炒莱菔子 15g，焦曲 12g；腰膝酸软者，加杜仲炭 12g，川断 12g，桑寄生 15g。

（四）肾阴虚热型

【主证】阴道不规则出血，量多少不一，色鲜红，头晕目眩，耳鸣心悸，五心烦热，两颧红赤，腰膝酸软，舌红少苔，脉细数。

【分析】肾阴精亏虚，阴不制阳，虚热内生，热扰血海，冲任不固，则见阴道不规则出血，色鲜红，阴血不足，不能濡养于上，则见头晕目眩，耳鸣如潮；虚热内生则见五心烦热，两颧红赤，舌红少苔。热扰心神，则心悸不安；肾精亏虚，则见腰膝酸软无力；脉细数为阴虚有热之象。

【治则】育阴滋肾，固冲止血。

【方药】左归丸化裁。

熟地 15g，怀山药 12g，山茱萸 12g，菟丝子 12g，枸杞子 15g，龟板胶 12g，女贞子 9g，旱莲草 15g，甘草 6g。

【方解】方中熟地滋肾养阴为主药。山茱萸、枸杞子滋养肝肾、养阴益精，怀山药健脾滋肾为辅药。菟丝子、龟板胶养阴补肾；女贞子、旱莲草清虚热，滋肾水共为佐药；甘草为使，调和诸药。全方合用，共奏滋肾育阴，清热生津，固冲止血之效。

【加减】头晕耳鸣甚者，加杞果 12g，菊花 15g，蝉蜕 15g；心烦不眠者加酸枣仁 12g，合欢花 6g，黄连 3g；血量多者，加仙鹤草 30g，茜草 15g。

二、单方、验方

(一) 单方

1. 益母草茎叶 15g，加水 300 毫升煎煮，每日一剂，分三次服完。

2. 红苋菜 200g，用四碗水煎至一碗，温服每日 2~3 次。

3. 大小蓟各 18g，薄荷 9g，水煎内服，每日一剂。

4. 鲫鱼鳞用文火稍加水熬成鱼胶服，每服 30g，温酒兑水化服。

(二) 验方

1. 腾龙汤：大黄 2g，芒硝 3g，牡丹皮 4g，桃仁 4g，瓜子仁 4g，苍术 4g，薏苡仁 8g，甘草 1g。水煎服，每日一剂，分两次温服。

2. 三甲榆蜂汤：生黄芪 60g，党参 15g，龟板 15g，鳖甲 15g，牡蛎 15g，蜂房 9g，蛇蜕 9g，全蝎 9g，地榆 15g，荷叶 15g，仙鹤草 30g，茜草 15g。每剂药煎 2 次，合在一起，分两次服。每日一剂。

3. 仙蕊汤：黄芪 30g，当归 15g，党参 15g，生牡蛎 18g，大小蓟各 15g，龟板 15g，鳖甲 15g，白术 12g，仙鹤草 30g，贯众 15g，山豆根 9g，花蕊石 15g，紫石英 15g。每一剂药煎 2 次，合在一起，分两次服用，日一剂。

4. 参芪三甲汤：黄芪 60g，党参 30g，料姜石 30g，薏苡仁 30g，龟板 15g，丹参 30g，鳖甲 15g，牡蛎 15g，蛇蜕 9g，蜂房

9g, 天南星 9g。每剂药煎 2 次, 合在一起, 分两次服。一日一剂。

5. 椿甲丸: 蛇床子 60g, 椿根皮 30g, 鳖甲 60g, 蜂房 30g, 龟板 60g, 生牡蛎 60g, 仙鹤草 60g, 炒小茴香 30g, 蛇蜕 30g, 全蝎 30g。上药共研细粉, 水泛为丸, 如绿豆大小, 每次服 6~9 丸, 每日 3 次, 黄芪煎水送下, 或开水送下。

6. 三蛭丸: 鸡内金、水蛭、三七、土鳖虫、石矾、三棱、莪术、红丽参、炒干漆、蛇床子各等份。上药共研为细粉, 水泛为丸, 如绿豆大小。每次服 3g~6g, 日三次, 黄芪煎汤送下, 或开水送下。

7. 砂雄丸: 马钱子 0.018g, 雄黄 0.6g, 青黛 0.6g, 乌梅 0.6g, 硼砂 0.6g, 硃砂 0.6g。上药共研为细末, 每次服 1.5g, 每日 2 次, 黄芪煎水送下, 或开水送下。

8. 解毒除湿汤: 土茯苓 30g, 生米仁 15g, 防风 4.5g, 当归 5g, 党参 12g, 银花 9g, 皂角刺 4.5g, 木通 3g, 白藓皮 9g, 水红花子 9g。每日一剂, 水煎服。

9. 二虫昆藻汤: 蜈蚣 3 条, 全蝎 6g, 昆布 30g, 海藻 30g, 当归 15g, 续断 10g, 半枝莲 30g, 白花蛇舌草 30g, 白芍 15g, 香附 10g, 茯苓 15g, 柴胡 15g。每日一剂, 水煎服。上方治疗宫颈癌 13 例, 治后生存 2、8、13、20 年者分别为 5、4、3、1 例。

10. 搜风解毒汤: 土茯苓 30g, 米仁 20g, 木瓜 2g, 防风 2g, 银花 2g, 木通 2g, 白藓皮 2g, 皂角刺 2g。气虚者加人参 2.5g, 血虚者加当归 2.5g。水两大碗煎饮, 每日三次。

三、中西医结合治疗 子宫体癌不论病变发展到哪一期, 只要全身情况许可, 均应力争完全切除癌灶。术前或术后如果能配合中医药治疗则能明显提高手术效果。术前治疗以减轻症状, 缩小瘤体为主, 以增强体质, 提高切除率。术后用药以补气养血、调整脏腑功能为主, 提高机体的免疫功能, 缩短术后恢复期, 减

少术后并发症和后遗症。

化学药物治疗子宫体癌效果不如手术与放射治疗；目前仅作为辅助治疗。但对于晚期无法手术切除的患者则仍以化疗为主。化疗副反应较多，若在化疗期间同时服用中药则可提高化疗效果，减轻化疗的副作用，延长患者的生存期。化疗期间的中药治疗原则以和胃止呕、护肾解毒为主，常用川朴花、代代花、姜竹茹、砂仁、广木香、女贞子、旱莲草、黄精、桑寄生等药。

放射治疗子宫体癌其效果逊于手术而优于化疗。放射线对机体有一定的损害，常在短时间内伤气耗阴，使患者免疫力下降。放疗期间配合中药，不仅可以增强放射治疗效果，而且可明显减轻放射的副作用，提高放疗效果。增强体质，改善生存质量。

四、综合治疗 采用综合治疗的方法可明显提高子宫体癌的临床疗效和远期生存率。目前所采用的综合治疗方案大致如下：

I 期子宫体癌：一般主张行全子宫双附件切除，有条件时应争取行次广泛子宫切除。如术前探查宫腔大于8厘米或内膜活检细胞分化不良时，在术前先行腔内照射然后手术。如术后发现有深肌层浸润，则需补充体外照射，以减少复发，此期可不用化疗和激素治疗。

II 期子宫体癌：主张行根治性子宫切除及淋巴结切除，或先行腔内照射，然后行全子宫切除或根治性子宫切除及淋巴结切除，术后应作体外放射，可配合中药治疗。

III 期子宫体癌：仍以手术治疗为主，如属III期，子宫明显增大，术前应先腔内或体外照射，使肿瘤缩小后再手术。手术一般行次广泛式全子宫双附件切除，探查淋巴结，必要时切除，术后补充体外照射，由于肿瘤可以直接转移到主动脉旁淋巴结，放射治疗应尽可能把这一区域包括在内。可配合孕激素治疗及中药治疗。

IV 期子宫体癌：单纯放疗（先腔内，后腔后）+孕激素治疗+化学药物治疗+中医中药治疗。

第二十二章 卵巢癌

【概述】

卵巢癌是妇女生殖系统最常见的恶性肿瘤之一，近年来其发病率和死亡率有缓慢上升的趋势。据美国癌症协会统计，卵巢癌的发生占美国妇女常见癌症的第6位，其死亡率为女性癌瘤死亡率的第4位，仅次于肺癌、乳腺癌和胃肠道恶性肿瘤。

我国卵巢癌的发病率也较高，根据北京8个医院的材料统计，卵巢恶性肿瘤占女性生殖器恶性肿瘤的22.9%，有人报道，近40年增加了3倍，其原因可能有：①防癌普查广泛开展，发病率相应增加。②宫颈的癌前病变治疗，使宫颈癌逐渐减少，卵巢癌的发病率相应提高。③卵巢癌多发生于高龄，随着人民的生活及卫生条件和改善，人的寿命延长；因此发病率相应增加。

卵巢恶性肿瘤可以发生于少女至绝经期后的任何年龄，但多见于卵巢功能旺盛时期，次之由盛转衰的转变时期，在卵巢功能尚未开始的幼年时期发病率最低。根据国内外12所医院的统计资料，年龄分布最高在31~40岁(32%)，其次在21~30岁(27.6%)，再次为41~50岁(24.3%)，10岁以下者仅占0.2%。

卵巢癌的病因目前尚不十分清楚，根据长期的临床实践及大量的实验研究，认为卵巢癌的发生与外源性化学制品（滑石粉、石棉类）的长期刺激；病毒感染（腮腺炎病毒、风疹病毒）、长期高动物脂肪饮食等有密切关系。另外，本病的发生与家族遗传、晚婚、未育、肥胖和高血压等也有一定的关系。还有人认为脑力劳动高度紧张的阶层，卵巢癌的发病率高。

卵巢癌最常见的主诉症状是下腹部不适感，表现为小腹部或髂窝部充胀下坠，月经紊乱，出现不规则阴道出血，同时约有

60%以上的患者在一侧少腹部触及无痛性肿块。卵巢癌无并发症时较少发生疼痛。如果突然出现腹痛，常为瘤蒂扭转，或肿瘤破裂出血所致。随着肿瘤的不断发展浸润，大多数病人出现腹水，多为血性腹水，在腹水中可查到癌细胞。晚期病人极度消瘦，全身衰竭，出现恶病质。

由于卵巢在胚胎发生方面有其特殊性，因而它的组织结构与成份都很复杂，所发生的肿瘤种类也很繁多，居机体器官肿瘤首位，卵巢的恶性肿瘤在病理上可分为（1）普通上皮恶性肿瘤，包括①浆液性囊腺癌；②粘液性囊腺癌；③卵巢子宫内膜样癌；④卵巢透明细胞癌；⑤恶性勃勒氏瘤；⑥不能分类的卵巢腺癌。（2）性索间质性肿瘤，包括：①粒层细胞瘤；②卵泡肿瘤；③卵巢睾丸母细胞瘤；（3）生殖细胞来源的肿瘤，包括①无性细胞瘤；②内胚窦瘤；③胚胎性癌；④原发性绒毛膜癌；⑤不成熟畸胎瘤；⑥恶性混合性生殖细胞瘤。（4）性腺母细胞。（5）卵巢转移性肿瘤等。卵巢癌较常见的扩散途径是侵犯邻近器官、腹膜种植及腹主动脉旁与盆腔淋巴结的转移，最主要的扩散方式是腹膜直接播散。

祖国医学无卵巢癌的病名，以其临床表现来看与古代医籍中记载的“肠覃”、“症积”等病证相似。如《内经·灵枢·水胀篇》曰：“肠覃是寒气客于肠外，与卫气相搏，气不得荣，；大有所系，癖而内著，恶气乃起，息肉乃生，其始生也，大如鸡卵，稍以盖大，至其成如怀子之状……按之则坚，推之则移，月事以时下，此其候也”。《证治汇补》记载：“积之始生，因起居不时，忧虑过度，饮食失节，脾胃亏损，邪正相搏，结于腹中。积聚症瘕……名虽不同，大要不出痰与食积血，气则不能成形也”。以上论述均与卵巢癌症状、体征相似。

【病因病机】

中医认为卵巢癌的病因病机主要是由寒温失节。饮食不消或内伤七情，抑郁伤肝，内外合邪，以致脏腑功能失调，痰、湿、

瘀互结于少腹而成。

一、七情内伤，气滞血瘀 长期的忧郁恼怒必致肝气郁结，气郁则经络运行不畅，血行受阻，气滞血瘀，日久不解，凝结于少腹部而发为本病。

二、脾虚不运，痰湿凝聚 饮食不节或寒温不调或思虑劳倦过度均可导致脾运化失职，水湿内停，聚而成痰，痰湿流注于下焦，聚结成块，发为本病。

三、正虚邪陷，水湿泛滥 痰湿瘀血积于下腹部，邪之留不去，则损伤正气，肝、脾、肾三脏功能虚弱，水湿泛滥，而见腹大如臌。正如《诸病源候论》中指出：“若积引岁月，人皆柴瘦，腹转大，遂致死”。这和晚期卵巢癌患者的恶液质、腹水肿块及预后极相似。

【治疗】

一、辨证论治

（一）湿热蕴结型

【主证】在一侧少腹可触及肿块，腹胀痛，腹部臌隆，口渴而不欲饮，小便黄赤，大便干燥，舌质红，苔黄腻，脉滑。

【分析】湿热流注下焦，蕴结于少腹，阻滞气机的运行，故见少腹肿块，胀满作痛，湿热蕴结，津不上承，故口渴而不欲饮，阴津不足，大肠失其濡润则大便干燥，小便黄赤为阴津不足之象，舌质红，苔黄腻，脉弦滑均为湿热蕴结体内之征。

【治则】清热利湿，解毒散结。

【方药】黄柏 9g，车前草 15g，牛膝 9g，半枝莲 15g，龙葵 30g，蛇舌草 30g，白英 30g，土茯苓 30g，瞿麦 15g，败酱草 30g，鳖甲 30g，大腹皮 15g。

【方解】方中以黄柏清热燥湿，解毒为主药。半枝莲、车前草、龙葵、土茯苓清热解毒更增主药之力为辅药。蛇舌草、白英解毒抗癌，瞿麦、大腹皮利湿，败酱草清热，鳖甲软坚散结，共为佐药。牛膝引药下行为使药。诸药相合，共奏清热利湿，解毒

散结之功效。

【加减】腹水多者，加猪苓 30g，泽泻 30g，恶心欲吐者，加姜竹茹 30g，姜半夏 9g，大便干结甚者，加大黄 9g，芒硝 15g。

（二）气滞血瘀型

【主证】腹部包块坚硬固定，腹胀，二便不畅，腹块有时刺痛，夜间加重；面色晦暗无华，形体消瘦，神疲乏力，肌肤甲错，舌有瘀斑，脉细涩。

【分析】气滞则经络运行不畅，血瘀阻滞于腹部，则少腹部包块坚硬固定，时有刺痛，夜间加重，气血不能濡养于面部，则见面色晦暗无华；机体失养则见形体消瘦，神疲乏力，肌肤甲错，舌有瘀斑，脉细涩为瘀血内阻之象。

【治则】理气活瘀，软坚消积。

【方药】逍遥散合桃红四物汤化裁。

当归 15g，桃仁 9g，红花 10g，柴胡 15g，茯苓 15g，赤芍 12g，川芎 9g，三棱 15g，莪术 15g，穿山甲 15g，水蛭 9g，甘草 6g。

【方解】方中当归、柴胡、桃仁理气活瘀为主药。赤芍、红花、川芎活瘀止痛，三棱、莪术软坚散结，以增主药之力为辅药。穿山甲、水蛭破血散结，茯苓健脾渗湿为佐药。甘草为使，调和诸药。诸药相合，共奏理气活瘀、软坚散结之功效。

【加减】腹痛甚者加五灵脂 10g，蒲黄 15g，纳呆食少者加神曲 15g，炒麦芽 15g，鸡内金 15g，腹水多者，加抽葫芦 15g，天葵 30g。

（三）痰湿凝聚型

【主证】腹部肿大，可触及坚硬肿块，胃部胀满，恶心欲吐，面虚浮肿，身倦乏力，舌淡苔白腻，脉沉滑。

【分析】痰湿凝聚，腹中气机运行不畅，则见腹部胀大，肿块坚硬，痰湿阻滞，浊气上逆；则见胃部胀满，恶心欲呕；痰湿

内盛，泛滥肌肤则见面虚浮肿，机体失养则身倦乏力，舌质淡白，苔白腻，脉弦滑为痰湿内阻之象。

【治则】健脾利湿，化痰散结。

【方药】党参 15g，白术 12g，茯苓 15g，车前子 15g，夏枯草 30g，山慈菇 15g，海藻 15g，猪苓 30g，厚朴 12g，鸡内金 15g。

【方解】方中党参、白术健脾燥湿为主药，海藻、夏枯草祛痰散结；茯苓、车前子、猪苓渗湿利湿为辅药。山慈菇解毒抗癌；厚朴、鸡内金理气消积为佐使药。诸药相合，共奏健脾利湿，化痰散结之功效。

【加减】腹中肿块坚硬者加土鳖虫 6g，穿山甲 12g，腹胀甚者加木香 6g，槟榔 9g，大腹皮 9g，腹水量多者加水红花子 12g，冲天草 15g。

二、单方、验方、成方（药）

（一）单方

1.核桃枝煮鸡蛋：每日取 5 寸长青核桃枝 10 枚煮 3 个鸡蛋，煮 2 小时，吃鸡蛋，喝水日一付，连服 1~2 月。

2.斑螫煮鸡蛋：每日用一个斑螫去头足，压成面，蒸黄羹服，每日一个，连服一个月，如有尿频、尿急、尿痛、血尿症状，停药，并可服绿豆汤或茶叶水解毒。

（二）验方

1.穿山甲散：炒穿山甲 60g，醋炒莪术 15g，醋炒三棱 15g，醋炒五灵脂 15g，当归 30g，川芎 30g，醋炒大黄 15g，丹参 30g，炒黑丑 15g，醋元胡 15g，川牛膝 15g，肉桂 15g，元寸 0.06g，上药如法炮制，除元寸外，共焙干三成细粉末，再加入元寸和匀，用瓷瓶密封待用，也可炼蜜为丸，若缺元寸，也可不用，但疗效稍差。每服 6~9g，每日 3 次，饭前白开水送下。

2.慈菇莪术汤：山慈菇 20g，炒山甲 30g，防风 15g，元胡 12g，香附 12g，两头尖 12g，皂角刺 12g，莪术 12g，羌活 9g。

水煎服，每日一剂。

3.加味化坚汤：大黄 30g，桃仁 9g，杏仁 9g，橘皮 9g，丹皮 9g，桂枝 9g，甘草 6g。醋 30g，蜂蜜 30g（两者均冲服）水煎服，日一剂。

（三）中成药

1.乌头注射液：每次四毫升，每日二次，肌肉注射。

2.平消片：（由郁金、白矾、五灵脂、干漆、枳壳、马钱子、仙鹤草等 8 味药组成），每日服二次，每次四片。

3.平瘤丸（北京市中医院方）：蜂房、蛇蛻、地龙、血余炭、木鳖子等组成，每日早晚各服一丸。

4.化症丸（北京市中医院方）：水蛭、虻虫、王不留行、廑虫、草河车、生牡蛎、桃仁、薏仁、白芷、当归、郁金、陈皮、夏枯草、赤芍、红花等。以活血化瘀为主，每服一丸，每日 2 次。

5.化痰丸：有党参、熟地、紫河车、马钱子、甘草组成。用于晚期卵巢癌及各种肿瘤患者有虚寒现象者。早晚各服一丸。

三、中西医结合治疗

（一）中医药与手术治疗相结合 手术切除仍是卵巢癌的首选治疗方法。如能与中医药结合起来，则能明显提高手术效果。特别是手术后服用中药则能调整脏腑功能，增强体质，减少术后并发症及后遗症。提高远期生存率。

（二）中医药与化疗相结合 化疗对卵巢癌的效果较肯定，是综合治疗的重要手段，能明显地延长生存期。但目前所使用的化疗药物缺乏选择性，对胃肠、骨髓等正常组织器官有损害且较重，所以在化疗期间配服中药，以和胃止呕，益肾护髓，能减轻化疗药物的副作用，使化疗疗程顺利进行。

（三）中医药与放疗相结合 放疗亦是卵巢癌综合疗法之一，Ⅱ期卵巢癌手术后放疗，则五年生存率为 42%，而单纯手术者仅为 19%。但放射对人体的气阴损害较重，而且可引起放

射性膀胱炎，放射性直肠炎，以及出现各种不同的症状，在放疗期间若能服用益气养阴，清热解毒的中药则能大大减轻放疗的副作用，而且有些药物有放疗增效作用，可明显提高放疗效果。

五、综合治疗 卵巢癌应以综合治疗为主，其中手术切除为主要方法。但根据类型及分期进行术前，术中、术后配合化疗、放疗、免疫疗法及中医药的综合方法能明显提高治疗效果，延长存活期。

I 期：手术切除+免疫治疗+中医药。不用化疗及放疗。

II 期：手术切除+放疗或化疗+中医药治疗+免疫治疗。

III 期：手术切除（姑息手术）+腹腔化疗+中医药+免疫治疗。

IV 期：化疗+中医药治疗+免疫治疗（加强支持疗法）。

第二十三章 恶性黑色素瘤

【概述】

恶性黑色素瘤是一种能产生黑色素的高度恶性肿瘤之一，仅有少数患者为无色的恶性黑色素瘤。恶性黑色素瘤的发病率国外报道为全部恶性肿瘤的 1%~3%。在我国和日本的发病率较低，而世界上唯独澳大利亚年发病率高达 76/10 万人口以上。

恶性黑色素瘤多发生在中年或老年人，而很少发生在青春前期。在妊娠期，恶性黑色素瘤发展尤其迅速，这些现象提示该病可能与内分泌有关。罕见的儿童恶性黑色素瘤，称为幼年性恶性黑色素瘤，恶性程度低，手术切除后，预后良好。

上海市肿瘤医院 1956~1972 年，共收治恶性黑色素瘤患者 106 例，其中以足和外阴、肛门周围较多，占 51.2%。人体上有各种各样的黑痣，一般认为交界痣容易恶变为恶性黑色素瘤。交界痣光滑，无毛、色呈淡或深棕色、形扁平或稍隆起成斑点。位于足底、手掌和外阴的黑痣虽少，但多为交界痣。恶性黑色素瘤多发生在有磨擦的部位如足底、外阴、腰、头颈等处。106 例中有 79 例为皮肤恶性黑色素瘤，其中 41 例发生在黑痣的基础上 (52%)。外伤后出现黑斑或黑结节者 11 例 (14%)。

恶性黑色素瘤的病因因素为日光曝晒与反复损伤痣，此外有遗传因素、种族因素、激素以及宿主的免疫功能降低对黑色素瘤均有影响。黑色素瘤虽有自发性消退患者，但发生率很低。据报道在 1190 例中，仅有 0.08%，其比例实在甚微。

从黑痣恶变到恶性黑色素瘤的病程少则要 12 个月，多则要数年之久。当黑痣增大，色素加深，而隆起呈结节状时，要考虑恶变的可能性，一旦擦破后恶性黑色素瘤呈现黑色的肉芽组织，并在其四周皮下可能有色素沉着，不久其区域淋巴结即可肿大。

恶性黑色素瘤向区域淋巴结转移，首先沿浅淋巴管，在上肢则直达腋窝淋巴结，在下肢可达腹股沟淋巴结。当浅淋巴管被瘤细胞阻塞之后，播散的瘤细胞在原发灶四周形成卫星结节。

恶性黑色素瘤多发生于体表皮肤，肿瘤增大，可溃破，肿瘤周围出现卫星结节，尔后转移至淋巴结及血行播散。临床转移部位主要为皮肤，皮下淋巴结（42%~59%）、肺（18%~36%）、肝（14%~20%）、脑（12%~20%）及骨（11%~17%）等。经尸检可见到胃肠道、心脏、胰腺、肾上腺、肾和甲状腺等可见转移灶。

恶性黑色素瘤的转移病灶在原发灶切除之后有自行消退的现象，提示自体有免疫的功能。

恶性黑色素瘤诊断要点：

（一）根据黑痣（交界痣）情况和动态变化，如有恶变征象时，应立即切除后送病理检查，因本病恶性程度高，又易于转移，切不可直接在肿瘤部位做局部活检，而应将整个原发病灶切除为宜，因为只要有任何刺激均可促使肿瘤发展和播散。如证实为恶性患者，宜在24~48小时内行根治术。

（二）恶性黑色素瘤吸³²磷率较色痣为高，故静脉注射³²磷100~150微居里，即可鉴别。

恶性黑色素瘤的临床分期：

I 期：原发性肿瘤。

II 期：局部播散，有或无局部淋巴结侵犯。

III 期：远处淋巴结播散，包括皮肤，但不含内部器官在内。

IV 期：远处转移，包括内脏在内。

恶性黑色素瘤的病理分级：

I 级：瘤细胞浸润限于基底膜以上。

II 级：浸润至乳头状真皮的疏松结缔组织之内。

III 级：瘤细胞侵及真皮的乳头层和网状层的结合处（尚有争议）。

Ⅳ级：侵及真皮的网状层。

Ⅴ级：侵入皮下组织。

根据临床和恶性程度，恶性黑色素瘤可分为三个不同的类型，即恶性黑色斑、表面扩散型恶性黑色素瘤及结节型恶性黑色素瘤，前者多发生在老人的面部，其扁平，边缘不规则，而会逐渐扩大，形成深浅不一的棕黑色斑。表面扩散型恶性黑色素瘤为皮肤表面微隆起的多个不同程度的黑灰色结节。结节型恶性黑色素瘤呈黑色结节。

恶性黑色素瘤患者生存率在5年之上者为24%~42%。原发病变的浸润程度以及有无区域淋巴结转移与生存率关系至为密切。Ⅰ期，临床和病理检查淋巴结阴性患者，5年生存率大约30%。Ⅱ期，伴有显微镜可见到的淋巴结转移者，下降至15%。临床检查发现淋巴结肿大则在10%以下。

在祖国医学文献中，虽然未曾见到有“恶性黑色素瘤”的病名记载，但确有许多与恶性黑色素瘤临床表现相似的病证论述。

恶性黑色素瘤早期在临床上出现于体表皮肤上的交界痣，或外伤后皮肤上出现黑斑或黑结节等症状，祖国医学认为多属“黑痣”亦叫“黑子”等病证。《诸病源候论》中说：“黑痣者，风邪搏于血气，变化所生也。夫人血气充盛，则皮肤润悦，不生疵瑕；若虚损，则黑痣变生。然黑痣者，是风邪变其血气所生也。若生而有之者。非药可治。”《外科正宗·黑子》中说：“黑子，痣名也。引肾中浊气，混滞于阳，阳气收束，结成黑子，坚而不散。”《医宗金鉴》中说：“黑痣生面霉点斑，小如黍粒豆形圆，孙络之血阳束结，挑破水晶膏点痊。”这些论述与恶性黑色素瘤早期症状颇相一致。恶性黑色素瘤中期的临床表现除原有症状加重外，还可出现肿瘤增大，可溃破，肿瘤周围出现卫星结节，然后转移至淋巴结。在此阶段，可与“失荣”、“上石疽”、“瘰癧”、“横痃疽”、“石疽”、“结核”等病证相似。《医宗金鉴》中说：“失荣耳旁及项肩，起如痰核不动坚，皮色如常日渐大，忧思怒郁火凝然。日久气衰

形削瘦，愈溃愈硬现紫斑，腐烂浸淫流血水，疮口翻花治总难。”又说：“石疽生于颈项旁，坚硬如石色照常，肝郁凝结于经络，溃后法依瘰癧疮。”并说：“小瘰大癧三阳经，项前颈后侧旁生，痰湿气筋名虽异，总由恚忿郁热成，更审缠绵诸证治，成劳日久不收功。”《类证治裁》中说：“结核经年，不红不疼，坚而难移，久而肿痛者为痰检，多生耳、项、肘、腋等处。”这与恶性黑色素瘤发展到中晚期的症状较一致。恶性黑色素瘤晚期的临床表现除原有症状日渐加重外，同时伴有远处转移，内脏转移等表现。对此，中医将其归入“虚劳”、“久恶疮”、“恶核”、“积、聚、征瘕”、“鼓胀”、“水肿”等症证的范畴。

在祖国历代医学文献中，虽然可以全面详尽地把恶性黑色素瘤的各种临床表现包括在内，而且在病因、病机、治则、方药等方面也有许多极有参考价值的论述。但是，由于历史的原因，历代医学不可能对恶性黑色素瘤有一个系统、深入的认识。因此，上述病证中固然包括有恶性黑色素瘤，但也含有许多其他疾病之症，这说明两个问题。第一，说明祖国医学对该病早有认识。第二，说明在治疗时，应以辨证论治为准则，以现代医学检查和诊断作参考。

【病因病机】

恶性黑色素瘤的病因，在概述中已有详述，而祖国医学在概述中将该病归于外科皮肤病“黑痣”等病之列，是正确的。概述中引证《诸病源候论》中“黑痣”的成因，说明本病的致病因素，总括起来，可分为内因和外因两大类。

一、内因 内因之中又可分为内伤七情及饮食起居两方面。

1.内伤七情：凡因喜怒忧思悲恐惊七情的过度刺激，均可以影响内脏机能的紊乱，而发生病变。在外科疾病中尤以忧思郁怒最为多见。

2.饮食起居：如恣食膏粱厚味及辛辣刺激之品，可使肠胃机能失调，火毒内生，而发为疮疡。

二、外因 外因之中可分为外感六淫和外来伤害两方面。

1.外感六淫：在外感方面危害较多，如风伤于上，则面发疮疡；寒侵入骨，则附骨生疽；暑热郁于肌表，则发为疮疖；湿恋皮肤，则生湿疹；燥气侵袭，则手足皲裂等等。五气均能化火，故疮疡之中火因最多，故《外科心法》有：“痈疽原是火毒性”之说。

2.外来伤害：凡跌仆损伤、金刃创伤、水火烫伤、虫兽咬伤等都属于外来伤害的范畴，由这类病因而形成的外科疾患也不少。

以上各种致病因素，每每有连带关系，或单见，或兼见，所以在临证之时，必须活看，而本病兼见为多。

总之，不论内因和外因，都能使营卫不和，气血凝滞，经络阻隔，而引起各种疮疡病。但疮疡的发生和人体抵抗能力的强弱，有密切关系，如抵抗力强者，即使感受六淫，内伤七情，也不一定会发病，如抵抗力薄弱，那就很易发病。关于这一点，在洞末奥旨里说得已很透彻：“但天地之六气，无岁不有，人生之七情，何时不发，乃有病，有不病者何也？盖气血旺而外邪不能感，气血衰而正不能拒，此所以六气之伤，伤于气血之亏，而七情之伤，亦伤于气血之乏也”。由此可见，在外科病的转归方面，体质强弱也有很大的关系。例如患脑疽发背之人，气血充足者，就易脓易溃，溃后也易愈合，如正气不足，则每易造成内陷，而发生变端。

【治疗】

一、辨证施治

（一）早期

【主证】多发于面部等处，呈黑褐色扁平突起，小者如黍，大者如豆等，或呈斑片状突起，无痛痒，其他如常人，脉沉细较缓和，舌质略紫，舌苔薄白。

【分析】根据概述中经文《诸病源候论》中谈“黑痣”，和

《外科正宗·黑子》中说：“黑痣”的形成为风邪搏结于血气，在其血气虚损的基础上，变化而生。由肾中浊气，混滞于阳，阳气收束，结成“黑痣”。从中提示本病的形成，是由于外因风邪，内因气血虚弱。肾中浊气混滞于阳，致使营卫不和，气血凝滞，经络阻隔而产生痰、瘀、虚、火病邪互相搏结于体表某一虚处，阻滞经络，而形成皮肤上的黑褐色扁平突起，舌质略暗等候。

【治则】活血化瘀为主，佐以化痰软坚，清热、补虚。

【方药】

1.内服方

(1) 病变长在膈肌以上者，用血府逐瘀汤加减。

(2) 病变长在膈肌以下者，用桃红四物汤加减。

2.外用方：水晶膏点之。（配制方法略）

【方解】血府逐瘀汤源于《医林改错》。方中当归、桃仁、红花活血祛瘀为主药；川芎、赤芍协助主药以活血祛瘀为辅药；生地黄配当归养血和血，使祛瘀而不伤阴血，牛膝祛瘀而通血脉；柴胡、枳壳、桔梗舒畅胸中气滞，使气行则血行，均为佐药；甘草协调诸药为使。合而用之，均为佐药；甘草协调诸药为使。合而用之，使血行瘀去，诸症可愈。

桃红四物源于《和剂局方》的一个变方。方中当归、桃仁、红花活血祛瘀，为主药；川芎、赤芍协助主药以活血祛瘀为辅药；生地配当归养血和血，使祛瘀而不伤阴血。合而用之，使血行瘀去诸症可愈。

【加减】

1.在上两方内分别加入化痰散结的贝母等。加入消肿散结的穿山甲等，加入清热解毒的黄芩、土茯苓、鱼腥草等，加入理气健脾的陈皮等，加入消积和胃的鸡内金等。在其患者血虚的情况下，上两方内可去赤芍，改为白芍等。

2.根据外科皮肤病的发病原因与其发病部位具有一定的关系而进行加减。

(1) 凡发于上部（头面、颈项、上肢）的疮疡等，多因风湿风热所引起，因为风性上行，乘火毒而上炎。在上两方内可分别加入桑叶、菊花、薄荷、蔓荆子、牛膝等疏风清热之药。

(2) 凡发于中部（胸腹腰背）的疮疡，多因气郁火毒而引起，因为气火俱发于中，而及四末。在上两方内可分别加入香附、柴胡、郁金、丹皮、栀子、龙胆草等疏气、解郁、清热解毒之品，一味或两药不等。

(3) 凡发于下部（臀、腿、胫、足）的疮疡，多因湿热或寒湿所引起，因为湿性下趋，化热外敷，乘虚下凝。在上两方内可分别加入苍术、云苓、猪苓、泽泻、苡仁、滑石、木通、黄柏、茵陈等祛湿清热，两味以上不等即可。

(二) 中期

【主证】多发于面部等处，呈黑褐色扁平突起较早期渐渐增大或突然增大，呈斑片状，或因手术切除后而局部复发，呈褐色或紫兰色斑片，颈、鼠蹊部可触到皮里膜外结核，少则一、二枚，多至四、五枚以上，皮色不变，大小不一，按之坚硬，推之可动，并伴有两胁作痛，头痛目眩，口燥咽干，疲乏食少，或见寒热往来，或月经不调，乳房作胀，舌质紫，舌苔薄白腻，脉弦。

【分析】多因忧思郁怒，性情不畅，肝气挟痰火凝滞于肝胆两经，故在颈、鼠蹊部均可触到大小不等的结核，因病邪渐渐加重，故体表黑褐色扁平突起较前也增大。肝藏血，血虚则见头目眩晕；肝喜条达，肝郁则胁痛，寒热往来，或月经不调，乳房作胀，舌质紫，脉弦等症，肝郁不能疏泄脾土，以致脾失健运，故见其疲乏，食少，苔薄白腻等症。

【治则】疏肝养血，解郁化痰。

【方药】

1. 内服药

(1) 汤剂：逍遥散合二陈汤加减。

(2) 成药：小金丹、犀黄丸、内消瘰癧丸。

2. 外用药：用太乙膏掺红灵丹敷贴。

【方解】逍遥散和二陈汤均源于《和剂局方》。方中柴胡、陈皮疏肝解郁为主药；当归、白芍补血和营以养肝，为辅药；半夏、茯苓、白术、甘草健脾利湿为佐药；煨姜和中，与归、芍同用，并能调和气血助薄荷少许以增强柴胡疏肝解郁的作用，两药均为使药。各药合用，成为疏肝理脾，和营养血的常用方剂。

【加减】

1. 在上方内去甘草，加贝母、昆布、海藻等化痰散结。加蜈蚣、穿山甲等消肿散结。加夏枯草等清热散结。加桃仁、红花等活血祛瘀，加黄芩、土茯苓、鱼腥草清热解毒，加鸡内金等消积和胃。或加黄芪托毒外出。

2. 参着以上早期加减第2条即可。

(三) 晚期

【主证】体表黑褐色平突起和颈、鼠蹊部的结核较中期增大。甚至色现紫斑，腐烂浸淫，渗流血水，或疮口开大，胬肉高突，形似翻花瘤证，形气渐衰，肌肉消瘦，自汗，盗汗，下午发热，体倦，气短，纳差，口渴，小便色黄，大便不畅，舌质暗红少津，苔黄，脉沉细无力，或脉沉细而数。

【分析】患者由于久病耗气伤阴，在病因病机中曾谈及皮肤和内脏是互相联系而不能分割的，此时形成脏腑的气阴亏损，气虚则出现形气渐衰，自汗、气短、体倦、脉沉细无力。阴虚则生内热，故出现下午发烧，盗汗，口渴，小便色黄，大便不畅，舌质暗红少津，舌苔黄，脉沉细而数。

【治则】益气养阴，敛阴止汗为主。

【方药】

1. 内服方：生脉散合一贯煎加减。

2. 外用药：

(1) 体表结核未破溃时，外贴阿魏化坚膏。

(2) 体表结核已破时，涂鸡子黄油。

【方解】生脉散源于《内外伤辨惑论》，一贯煎源于《柳洲医话》。方中人参益气生津为主药；沙参、麦冬、生地、枸杞养阴生津为辅药；五味子生津敛汗，当归养血和肝，川楝子疏肝泄热，均为佐使药。各药合用，一补、一清、一敛，而且益气敛汗，养阴生津之用。

二、单方、验方、成方（药）

（一）单方

1. 农吉利：每日 30g，煎汤代开水饮用。
2. 土茯苓：每日 30g，煎汤代开水饮用。
3. 生苡仁：每日 60g，煎汤代茶饮。

（二）验方

1. 生草乌 10g，重楼 30g，用童便浸泡 72 小时，晒干研末，每日每次 2~5g，饭后温开水送服。

2. 同时予红参 10g，田七、水牛角（先煎）、生地、玄参、麦冬各 15g，鹿角胶（烊化）20g，日 1 剂，水煎，分 3 次饭前服。

3. 外用鱼腥草、石苇、骨碎补各 10g，浸泡于 75% 酒精 100ml 中，3 日后用棉签蘸药外擦局部，次数不限。

2. 加味犀黄散：犀角 3g，麝香 6g，真牛黄 10g，乳香、没药、三七、山慈菇、砂仁、苡仁、鸡内金、党参各 30g。研面装瓶，每次 2~3 次，每日 3 次，饭后服用。

（三）成方（药）

1. 皮癌净。外用。
2. 平消片。每日 3 次，每次 6 片。
3. 复方天仙胶囊。每口 3 次，每次 3~4 粒。

三、中西医结合治疗

（一）中医药与手术治疗相结合

恶性黑色素瘤的首选治疗，目前仍是手术治疗，但手术是一

种创伤性治疗，如能与中医药结合治疗，肯定疗效可提高。在有条件的情况下，术前、术后辨证服用中药，不仅可以提高疗效，而且可以减少并发症。

（二）中医药与化疗相结合

目前，在临床上不少恶性黑色素瘤患者体质较差，或病情较重，常常采用化疗，但化疗时，可有不同程度的毒副反应，配合中医辨证施治不仅能提高疗效，而且可减轻毒副反应。

简述治疗原则

一、局限性病变：主要以手术为主。

二、播散性病变：主要以联合化疗为主，化疗与免疫疗法交替应用有可能提高疗效。

第二十四章 恶性淋巴瘤

【概述】

恶性淋巴瘤是淋巴结和（或）结外部位淋巴组织的免疫细胞肿瘤，来源于淋巴细胞或组织细胞的恶变。祖国医学古籍中所记载的恶核、失荣、石疽、痰核等与本病相似，中医认为属于阴疽范畴。

恶性淋巴瘤的发病率世界各国差异很大，我国发病率较低，约为欧美的 $1/4 \sim 1/6$ ，日本的 $1/2$ 。根据我国恶性肿瘤死亡回顾调查资料，本病的年调整死亡率为 $2.31/10$ 万人，男性 1.35 ，女性 0.96 。在常见恶性肿瘤中占第九位（男性）和第十一位（女性）。我国每年实际发病总数在 14000 左右。本病常发生于青壮年，对劳动力影响较大，而且本病治疗效果比较满意，所以特别值得重视。中西医结合治疗，提高了恶性淋巴瘤的治疗效果，更显示了中西医结合的优越性。

我国传统医学认为，本病为寒痰凝滞，毒陷阴分或寒凝气结，或风热血燥而引起。而恶核、失荣、石疽、痰核等病证的内因乃是病发五脏，为里为阴，为冷为虚（《外科大成》）。王维德《阴疽治法篇》中指出：“夫色之不明而散漫者，乃气血两虚也，患之不痛而平塌者，毒痰凝结也”。说明此病之发生与脏腑亏弱、气血虚、阳气不足、气滞气郁有关。

现代医学研究认为此病与病毒感染有密切关系。动物实验证明，鸡、小鼠和猫的恶性淋巴瘤可由 C 型 RNA 病毒引起；非洲儿童伯基特氏淋巴瘤的组织培养中找到 EB 病毒，故认为可能是一种由蚊子传播的病毒性疾病。此外，机体免疫功能缺陷或损害、长期慢性感染、某些物理、化学物质的长期刺激等因素，在恶性淋巴瘤的发病上也有一定意义。

【分类】

一、组织病理学分类

(一) 何杰金病 (简称 HD) 分类的演进与临床意义: 见表 2。

表 2 何杰金病分类的演进与临床意义

Gall 与 Mallory (1942)	Jackson 与 Parker (1947)	Rye 会议 (1965)	相对发生率 (%)	相对预后
何杰金淋巴瘤	副肉芽肿型——	淋巴细胞为主型	10~15	最好
		—结节硬化型	30~70	良好
	肉芽肿型——	混合细胞型	20~40	不好
何杰金肉瘤——	肉瘤型——	淋巴细胞消减型	5~10	最差

(二) 非何杰金淋巴瘤 (简称 NHL) 的分类 40 年代以前, 非何杰金淋巴瘤分为淋巴肉瘤、网状细胞肉瘤与巨滤泡性淋巴瘤三类。40 年代开始, 不断提出新的分类方法, 表 3~5 所列三种分类法当前在国际上最受重视。表 7 是美国 NCI 提出的最新分类方法, 比较适合临床实际。皮肤 T 细胞淋巴瘤 (CTCL) 的 TNM 分类见表 8。

表 3 非何杰金淋巴瘤改进的 Rappaport 分类

结节性 (滤泡性)
高分化淋巴细胞型
低分化淋巴细胞型
淋巴细胞与组织细胞混合型
组织细胞型
弥漫性
高分化淋巴细胞型
低分化淋巴细胞型
淋巴细胞与组织细胞混合型
组织细胞型
未分化, Burkitt 型
未分化, 多形细胞型
原淋巴细胞型

表 4 非何杰淋巴瘤的 Lukes 与 Collins 分类

U 细胞 (非 T, 非 B)
T 细胞型
小淋巴细胞型
蕈样霉菌病与 Sezary 综合征
扭曲淋巴细胞型
原免疫细胞 (T) 肉瘤
B 细胞型
小淋巴细胞型 (慢性淋巴细胞白血病)
浆细胞样淋巴细胞型
滤泡中心细胞型 (滤泡性, 弥漫性, 滤泡与弥漫性, 硬化性)
小裂细胞
大裂细胞
小无裂细胞 (Burkitt)
大无裂细胞
原免疫细胞 (B) 肉瘤
组织细胞型
不能分类

表 5 国际工作分类

低度恶性
A.小淋巴细胞型
B.滤泡性小裂细胞为主型
C.滤泡性小裂与大细胞混合型
中度恶性
D.滤泡性大细胞为主型
E.弥漫性小裂细胞型
F.弥漫性大、小细胞混合型
G.弥漫性大细胞型
高度恶性
H.大细胞, 原免疫细胞型
I.原淋巴细胞型, 扭曲细胞与非扭曲细胞
J.小无裂细胞 (Burkitt) 型
杂类: 复合型, 蕈样霉菌病, 组织细胞型, 骨髓外浆细胞瘤, 不能分类, 其他

表 6 非何杰金淋巴瘤三种分类的比较

国际试用分类	Rappaport 分类相应类型	Lukec 与 Collins 分类相应类型
低度恶性		
A.小淋巴细胞型	高分化淋巴细胞型	小淋巴细胞型
B.滤泡性小裂细胞不主型	结节性低分化淋巴细胞型	滤泡性小裂滤泡中心细胞型
C.滤泡性小裂与大细胞混合型	结节性淋巴细胞、组织细胞混合型	滤泡性小裂与大裂滤泡中心细胞型
中度恶性		
D.滤泡性大细胞为主型	结节性组织细胞型	滤泡性大裂与/或无裂滤泡中心细胞型
E.弥漫性小裂细胞型	弥漫性低分化淋巴细胞型	小裂滤泡中心细胞型
F.弥漫性大、小细胞混合型	弥漫性淋巴细胞、组织细胞混合型	小裂、大裂或大无裂滤泡中心细胞型
G.弥漫性大细胞型	弥漫性组织细胞型	大裂或大无裂滤泡中心细胞型
高度恶性		
H.大细胞、原免疫细胞型	弥漫性组织细胞型	T或B细胞型原免疫细胞肉瘤
I.原免疫细胞型、扭曲细胞与/或非扭曲细胞	原淋巴细胞型	扭曲T细胞型
J.小无裂细胞型	未分化、Burkitt或多型细胞型	小无裂滤泡中心细胞型

表 7 根据未治疗或姑息治疗患者的自然病程，美国 NCI 对淋巴瘤淋巴瘤的临床分类（Devita VT, Jr.等, 1989）

缓慢型（indolent，中位生存期以年计）
小淋巴细胞型
滤泡性小裂细胞型
滤泡性混合细胞型
弥漫性小裂细胞型
弥漫性中分化细胞型
皮肤T细胞型
进展型（aggressive，中位生存期以月计）
滤泡性大细胞型
弥漫性混合细胞型
弥漫性大细胞型

弥漫性原始免疫细胞型▲

高度进展型（中位生存期以周计）

弥漫性小无裂细胞型（Burkitt's）

弥漫性小无裂细胞型（non-Burkitt's）

原始淋巴细胞型

成人 T 细胞白血病 / 淋巴瘤※

* 国际工作分类列为中度恶性，伴有缓慢型自然史。

※ 国际工作分类中省略。

▲ 国际工作分类列为高度恶性，伴有进展型自然史。

表 8 皮肤 T 细胞淋巴瘤（CTCL）的 TNM 分类
（Broder 与 Bunn, 1980）

分 类	特点描述
T. 皮肤*	
T ₀	临床上或组织病理学上可疑病损
T ₁	局限性斑块，丘疹或湿疹斑，占皮肤表面 10% 以下
T ₂	普遍性斑块，丘疹或湿疹斑，占皮肤表面 10% 以上
T ₃	肿瘤（>1）
T ₄	普遍性剥脱性红皮病
N. 淋巴结**	
N ₀	临床上无外周淋巴结异常，病理上不能诊断为 CTCL
N ₁	临床上出现外周淋巴结异常，病理上不能诊断为 CTCL
N ₂	临床上无外周淋巴结异常，病理上能诊断为 CTCL
N ₃	临床上出现外周淋巴结异常，病理上能诊断为 CTCL
B. 外周血象***	
B ₀	循环中无不典型细胞（Sexary 细胞 < 5%）
M. 内脏器官	
M ₀	无内脏器官侵犯
M ₁	出现内脏器官侵犯（必须有病理证实，注明所侵犯的器官）

* T₁₋₄ 的病理学检查对 CTCL 有诊断意义，如不止一项，则同时记录，而以最高者为分期之用，如 T₄ (3)。

** 记录异常淋巴结的部位，如颈（左+右）等。

*** 记录外周血中细胞总数，淋巴细胞总数不与典型淋巴细胞%。如在辨认时曾使用特殊技术，加以说明。

二、功能性分类 根据细胞发育过程与功能的不同，淋巴细胞可分为 B 细胞与 T 细胞两类。在体内，B 细胞承担体液免疫任务，T 细胞承担细胞免疫任务。淋巴瘤的细胞来源主要为淋巴细胞，少数为属于单核巨噬细胞系的组织细胞。表 9 是恶性淋巴瘤的功能性分类。

表 9 恶性淋巴瘤（与有关白血病）的功能性分类
(Devita VT, Jr 等, 1989)

B 细胞肿瘤	T 细胞肿瘤	组织细胞肿瘤
慢性淋巴细胞白血病 (98%)	慢性淋巴细胞白血病 (2%) 大颗粒淋巴细胞白血病 (Tr 淋巴细胞增殖性疾病)	单核细胞白血病
高分化小淋巴细胞淋巴瘤	蕁样肉芽肿 / Sezary 综合征	恶性组织细胞增殖病
淋巴细胞淋巴瘤，中与小 裂细胞型（外套区淋巴瘤）	成人弥漫性进展型淋巴瘤 (15%) 外周 T 细胞淋巴瘤混合细胞 型大细胞，原免疫细胞型	真正组织细胞淋巴瘤
滤泡性淋巴瘤	成人 T 细胞白血病 / 淋巴瘤	
成人弥漫性进展型淋巴瘤 (85%) 混合细胞型 大细胞型* 大细胞原免疫细胞型 小无裂细胞型* 伯基特（小无裂细胞）淋巴瘤	血管中心型淋巴瘤（淋巴瘤样 肉芽肿病）（多形性网状细胞 增多症）	树突状网状细胞肉瘤 指间网状 细胞瘤
急性淋巴细胞白血病 (75%)	急性淋巴细胞白血病 (25%)	
原始淋巴细胞淋巴瘤 (10%)	原始淋巴细胞淋巴瘤 (85%)	

* 大多数病例，95%。

※ 来源于干细胞，有不成熟表现型，但分别确定为 B 或 T 细胞分

化:

【分期】

一、一般类型的分期 根据 Ann Arbor 会议 (1971) 的修订, 恶性淋巴瘤的分期见表。

表 10 恶性淋巴瘤的国际分期
(Ann Arbor 会议, 1971)

1. 四期:	
I 期:	病变涉及一个淋巴结区 (I) 或一个淋巴系统以外的器官或部位的局部侵犯 (I E)
II 期:	病变涉及膈肌一侧的二个或更多的淋巴结区 (II) 或一个以上的淋巴结区伴发一个结外器官或组织的局部侵犯 (II E)
III 期:	病变涉及膈肌两侧的淋巴结区 (III), 或伴发结外器官或组织的局部侵犯 (III E), 或脾脏的侵犯 (III S) 或两者都受侵犯 (III ES)
IV 期:	在淋巴结、脾脏、咽淋巴环之外, 一个或多个结外器官或组织的广泛受侵, 如骨髓 (M)、肺实质 (L)、胸膜 (P)、肝脏 (H)、骨骼 (O)、皮肤 (D) 等, 分别以相应字母注明
2. 每期又再分为 A 或 B, 以表现未出现或出现以下全身症状: 6 个月内原因不明的体重减轻 10%; 38℃ 以上原因不明的发热、盗汗	
3. 根据解剖部位, 淋巴区确定如下:	
膈肌以上: 咽淋巴环、颈部、纵隔或肺门、锁骨下、腋或胸部、滑车上与臂部	
膈肌以下: 脾脏、主动脉旁、髂部、腹股沟与股部、肠系膜、咽窝	

表 11 Burkitt 淋巴瘤的临床分期 (Ziegler JL)

1973 年		1975 年	
期别	病变范围	期别	病变范围
I	单个面部肿瘤	A	单个腹腔外部位的侵犯
II	两个或多个不同部位的面部肿瘤	B	多个腹腔外部位的侵犯
III	胸腔内、腹腔内、脊髓旁或骨肿瘤 (面部骨肿瘤除外)	C	腹腔内肿瘤同时伴有单个腹腔外 (面部) 的侵犯
IV	中枢神经系统侵犯 (脑脊液内有 瘤细胞) 或广泛骨髓侵犯	D	同 C, 但同时伴有多处面部和 腹腔以外部位的侵犯
		AR	原发肿瘤的广泛 (>90%) 切除后

二、特殊类型的分期

(一) Burkitt 淋巴瘤的临床分期见表 11。

(二) 皮肤 T 细胞淋巴瘤 (包括蕈样霉菌病与 Sezary) 综合征) 的临床分期见表 12。

表 12 皮肤 T 细胞淋巴瘤的分期
(Broder 与 Bunn, 1980)

分 期	分 类		
	T	N	M
I _A	1	0	0
I _B	2	0	0
II _A	1-2	1	0
II _B	3	0.1	0
III	4	0.1	0
IV _A	1~4	2.3	0
IV _B	1~4	0~3	1

【临床表现】

恶性淋巴瘤临床上早期表现以表浅淋巴结肿大为主, 也可首发于鼻咽、扁桃腺、纵膈或腹腔淋巴结。约四分之一的患者就诊时已侵犯淋巴结以外器官, 其中以消化道为最常见。本病的临床表现比较复杂, 不规则的发热、盗汗、消瘦、皮肤瘙痒、皮肤的非特异性表现、进行性贫血等均可为其临床主要表现。

何杰金病多见于青少年患者, 男性明显多于女性, 无痛性浅表淋巴结肿大为其早期主要表现, 约三分之二发生于颈部, 发展较缓慢, 常被忽视或误诊。肿大的淋巴结起初多为单个, 活动, 无触痛, 继之周围出现卫星淋巴结, 逐渐增大融合成团块, 质硬, 固定, 多发生于颈两侧。若颈淋巴结肿大多年, 近来增大伴发热、出汗皮肤瘙痒或体重减轻应考虑本病。首发或单发于腋下或腹股沟者少见, 滑车上者更少见。约有 40% 伴发全身症

状，如发热、出汗、体重减轻、瘙痒等，发热常呈间歇性，即发热数天至数周，然后无热数天至数周，发热以午、晚间较高。深部淋巴结如纵膈、腹膜后或主动脉旁等淋巴结受累，全身症状更重，并可出现上腔静脉压迫综合征。淋巴结病变多呈向心性和轴状分布，与非何杰金淋巴瘤的离心性和常波及非相邻区迥然不同。骨髓侵犯约占 2%~10%，肝受侵少见，但晚期脾、腹膜后、肠系膜淋巴结波及时，肝脏常常受累。原发于胃肠道者少见，淋巴咽环者也不多见。

非何杰金淋巴瘤临床表现远较何杰金病复杂，结外型非常多见，可为首发症状，淋巴结受累常遍及全身，进行性无痛性浅表淋巴结肿大常为最早主诉，大多数为双侧性和多发性。与何杰金病不同的是易发于滑车上、颊车、耳后、枕后、腮腺等。发热出汗、体重减轻、皮疹、瘙痒、贫血、乏力等全身症状较何杰金病少见。约三分之一的非何杰金淋巴瘤以结外型表现为初诊时的主诉。常侵犯口咽环、眼球、甲状腺等，约占 8.7%。深部淋巴结受累可引起胸腔或心包积液，尸检资料心包积液发生率高达 25%。局部淋巴结肿大可压迫邻近脏器或组织引起声嘶、Hormer 氏综合征、臂丛神经痛、上腔静脉综合征、咳嗽、胸闷、气短等。胃肠道受侵犯者占 63% 左右，有时可为首发症状。如食欲不振、纳差、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、腹块、消化道出血、穿孔、梗阻等。脾肿大常见，占 30%~45%，约 1% 以下的非何杰金淋巴瘤脾肿大可为首发或唯一症状。尸检发现，本病有 69.2% 的患者脾受侵犯，66.7% 的患者死后发现肝脏浸润，原发于肾者极为罕见，腹膜后淋巴结肿大压迫输尿管导致肾盂积水，可见于单侧或双侧，极少侵犯膀胱。中枢或周围神经系统常可受侵，尤以淋巴母细胞型和弥漫性小无裂多见。骨髓侵犯率平均为 26%~53%，多伴有肝脏浸润，结节型淋巴细胞性非何杰金淋巴瘤至少有 40% 骨髓被侵，但周围血象仍正常。

【诊断要点】

1.详细询问病史：包括淋巴结肿大首次出现的时间与以后增长速度，有无全身症状。家族史、既往史。

2.全面体格检查：特别注意淋巴结肿大，肝脾肿大，皮肤损害。

3.病理检查：病理切片活检，针吸活检，皮肤活检，必要时骨髓、肝、脾穿刺活检，也可行痰及胸、腹水中查恶性淋巴瘤细胞。

4.影像学检查

(1) X线检查胸部正侧位片。

(2) CT扫描。

(3) 必要时作E-CT检查。

(4) 必要时作核磁共振检查。

(5) 超声波检查：腹部肿块，可用超声波探查其范围，性质及与周围脏器的关系。

5.实验室检查

(1) 血、尿、粪常规。

(2) 血流变、微循环检查。

(3) 血清学检查：尿素氮、尿酸、肌酐、碱性磷酸酶、乳酸脱氢酸、总蛋白（白蛋白、球蛋白）、胆红素、谷丙转氨酶、谷氨酸转氨酶、电解质、血清蛋白电泳与免疫球蛋白测定，血清酮、铜锌比值测定等。

(4) 免疫学检查：T淋巴细胞亚群，巨噬细胞吞噬试验，NK细胞等。

(5) 骨髓检查：血清碱性磷酸酶升高，难以解释的贫血。X线显示骨髓侵犯，可做骨髓检查或常规骨髓检查。

(6) 内腔镜检查：对食管、胃肠道、肺门及膀胱等原发或浸润性淋巴瘤的诊断有重要意义。

【鉴别诊断】

由于淋巴结肿大原因较多，临床上恶性淋巴瘤易被误诊，因

此应与以下疾病相鉴别。

1.慢性淋巴结炎

慢性淋巴结炎多有明显的感染灶，且常为局灶性淋巴结肿大，有疼痛和触痛，急性发作时有红、肿、热、痛，经抗炎治疗可明显好转。

2.淋巴结转移癌

淋巴结转移癌淋巴结常较硬，多个淋巴结转移时其质地软硬不一，可找到原发灶，很少全身淋巴结肿大。

3.结核性淋巴结炎

多见于青少年，淋巴结呈中轻度肿大，如黄豆、蚕豆大小，个别患者可较大，有时破溃创口难以愈合。质韧，活动性差，压痛不明显，边缘不很清楚，干酪化后有波动感，质较软，抗痨治疗有效。

4.巨大淋巴结增生

为一种原因不明的淋巴结肿大，主要侵犯胸腔及纵膈，也可出现发热，贫血与血浆蛋白增高等全身症状。又称为淋巴结错构瘤，滤泡性淋巴网状细胞瘤等。现在多趋向认为是感染引起的特殊反应的炎症，手术切除效果良好。

5.嗜酸性淋巴肉芽肿

有的患者多处表浅淋巴结肿大，在临床上酷似恶性淋巴瘤，对放射或化疗反应良好，预后佳。这种患者有时可有双侧腮腺肿大，血中嗜酸性白细胞数目增多，病理上也有明显的特点。

6.急性、慢性淋巴细胞性白血病

急、慢性淋巴细胞性白血病也常有淋巴结肿大，主要通过血液学及病理组织学检查鉴别。

7.传染性单核细胞增多症

多有发热及全身淋巴结肿大，但血象异常，嗜异性凝集反应阳性可资鉴别。

8.其它

血清病及结节病等都有淋巴结大，应注意与恶性淋巴瘤鉴别。

【治疗】

一、辨证施治

(一) 痰热蕴结型

【主证】颈部肿胀不适，不红，不痛，质硬，时有恶寒发热，舌红，苔白或黄腻，脉象弦数。

【治则】清化热痰，软坚散结。

【方药】

南星 10g，浙贝母 30g，天竺黄 15g，石上柏 30g，夏枯草 30g，土茯苓 20g，公英 30g，文术 15g，昆布 20g，皂刺 10g，山甲 10g，生牡蛎 30g，半枝莲 30g。

(二) 瘀血内阻型

【主证】表浅淋巴结肿大，腹胀不适，腹中可触及包块，肝脾肿大，或有腹痛。身体消瘦，纳呆，舌质紫暗，脉弦涩。

【治则】活血化瘀，消肿散结。

【方药】

丹参 30g，赤芍 18g，三棱 10g，文术 10g，土元 20g，白花蛇舌草 30g，生牡蛎 30g，夏枯草 30g，白蔹 20g。

(三) 痰瘀互结型

【主证】咳嗽咯痰，胸闷胸痛，心悸气短，甚或喘息，面颈浮肿，唇舌青紫，舌有瘀点或瘀斑，脉细数而滑。

【治则】宽胸化痰，活瘀散结。

【方药】

全瓜蒌 15g，薤白 10g，半夏 10g，猪苓 30g，茯苓皮 20g，浙贝母 20g，三棱 10g，文术 10g，夏枯草 30g。

(四) 气虚血瘀型

【主证】面色无华，浮肿，倦怠乏力，寡言懒语，动则心慌气短汗出，固定性疼痛。舌质暗，有瘀斑（点），脉沉细或弦

细。

【治则】益气活瘀。

【方药】

人参 10g, 黄芪 30g, 白术 20g, 茯苓 10g, 山药 20g, 薏苡仁 30g, 当归 30g, 坤草 30g, 水蛭 10g, 乳香 10g, 没药 10g, 鸡血藤 30g 等。

(五) 气血两虚型

【主证】面色㿔白, 心悸气短, 倦困乏力, 精神萎靡, 消瘦, 时或烦躁, 舌淡而胖, 苔薄白, 脉沉细无力。

【治则】健脾益肾, 养血生血。

【方药】人参 10g, 黄芪 30g, 白术 30g, 茯苓 30g, 甘草 10g, 当归 18g, 鸡血藤 30g, 补骨脂 30g, 山萸肉 30g, 杞果 20g, 山药 10g, 黄精 10g。

二、单方、验方、成方治疗

1. 猫爪草 120g, 煎服, 每日一剂, 黄酒适量送服。
2. 石上柏 60g, 煎服, 每日一剂。
3. 五叶参 60g, 半枝莲 60g, 煎服, 每日一剂。
4. 元参 30g, 生牡蛎 30g, 浙贝母 30g, 炒僵蚕 25g, 水煎服, 每日一剂。
5. 巴腊丸, 每日 3 次, 每次 2~8 粒。
6. 西黄丸, 每日 2 次, 每次 3g。
7. 加味犀黄丸, 每日 2 次, 每次 3g。
8. 加味逍遥丸, 每日 2 次, 每次 3g。

三、化学药物治疗

(一) 何杰金病的化疗

1. 单药化疗

氮芥, 完全缓解率 20%, 总有效率 61%; 环磷酰胺, 完全缓解率 20%, 总有效率 59%; 长春新碱, 完全缓解率 36%, 总有效率 58%; 氮烯咪胺, 完全缓解率 5%, 总有效率 56%; 阿

霉素，完全缓解率仅 6%，总有效率 36%；鬼臼乙叉甙，总有效率 61%；甲基苄肼，有效率 57%。

2. 联合化疗

MOPP 方案： HN_2 6mg / m^2 ，静冲，第 1、8 天；VCR 1.4mg / m^2 ，静冲，第 1、8 天；PCB 100mg / m^2 ，第 1~14 天，口服；PDN 40mg / m^2 ，第 1~14 天；口服。28 天为一周期，用 6~8 个周期。

ABVD 方案：ADM 40mg / m^2 ，静冲，第 1 天；BLM 10mg / 次，肌注，第 1、8 天；VCR 1.4mg / m^2 ，静冲，第 1、8 天；DTIC 150mg / m^2 ，静滴，第 1~5 天。28 天为一周期。

COPP 方案：以 CTX 代替 MOPP 中的 HN_2 ，CTX 600mg / m^2 ，静冲，第 1、8 天；其余同 MOPP。

B~MOPP 方案：BLM 10mg / m^2 ，肌注，第 1、8 天，其余同 MOPP 方案。

E-MOPP 方案：VP₁₆ 100mg / m^2 ，静滴，第 1~5 天，其余同 MOPP 方案。

I、II 期病人淋巴结直径超过 5 厘米，纵膈淋巴瘤均需先化疗后放疗。I、II 期病人病理为淋巴细胞消减型放疗后也需化疗。II b、III、IV 期病人均需先化疗。MOPP 为经典方案，达完全缓解率为 80% 以上，总有效率为 95% 左右，5 年生存率为 65%。MOPP 方案的改变，在 MOPP 方案的基础上加入第 5 种药物，如加博莱霉素或 B-MOPP；加 VP₁₆ 成 E-MOPP 等。这样可提高 5 年生存率及完全缓解率。ABVD 方案与 MOPP 方案无交叉耐药。近推荐将 MOPP 与 ABVD 二方案交替应用，疗效较佳。

(二) 非何杰金淋巴瘤的化疗

1. 单药化疗

氮芥，完全缓解率 40%，有效率为 45%~60%，疗效不如

环磷酰胺，环磷酰胺的完全缓解率为 57%~58%，有效率为 50%~70%；长春新碱，完全缓解率为 25%~27%，有效率为 40%~70%；亚硝脲类完全缓解率为 13%，有效率 23%~32%；博来霉素，完全缓解率 15%，总有效率 23%~59%；阿霉素，完全缓解率为 15%，总有效率 40%~50%。

2.联合化疗

COP 方案：CTX600mg / m²，静冲，第 1、8 天；VCR1.4mg / m²，静冲，第 1、8 天；PDN40mg / m²。顿服，每周 3 天，3 周为一周期。

A-COP 方案：ADM40mg / m²，静冲，第 1 天，其它同 COP 方案。3 周为一周期。

BA-COP 方案：BLM10mg / m²，肌注，第 1、8 天，其它同 A-COP 方案。

COP / ABP 方案：CTX600mg / m²，静冲，第 1、8 天；VCR1.4mg / m²，静冲，第 1、8 天；PDN100mg / m²，顿服，第 1~5 天，3 周交替。ADM40mg / m²，静冲，第 1 天；BLM10mg / m²，肌注，第 1、8 天；PDN100mg / m²，顿服，第 1~15 天，3 周交替。

M-BACOP 方案：MTX70mg / m²，静冲，第 14 天用，用 CF 解救。其它同 BA-COP 方案，3 周为一周期。

E-BACOP 方案：VP₁₆80mg / m²，静滴，第 1-5 天，其它同 BA-COP 方案。3 周为一周期。

AM-COA 方案：ADM40mg / m²，静冲，第 1 天；CTX800mg / m²，静冲，第 1 天；VCR1.4mg / m²，静冲，第 1、8 天；MTX100mg / m²，第 15 天静冲；Ara-c300mg / m²，静滴，第 15 天。3 周为一周期。

非何杰金淋巴瘤低度恶性Ⅱb、Ⅲ、Ⅳ期以化疗为主，选用多药联合方案，特别是初治病人，尽力争取达到完全缓解或部分缓解，再以放疗巩固，还要避免不必要的治疗以防止和减少远期

毒性或骨髓抑制。

中、高度恶性非何杰金淋巴瘤，虽然其恶性程度高，但对化疗也较敏感，采用多药联用的强烈化疗，且使用对骨髓毒性高、低的药物交替应用，可收到较好的疗效。初治失败的和复发率较高的生存期也短，常需要更积极、更强烈的化疗，宜采用多药联用方案，包括有效药物如异环磷酰胺、阿糖胞苷、甲氨喋呤、鬼臼乙叉甙及卡铂辅以大剂量的综合治疗。预防中枢神经系统复发可给 MTX10mg 鞘内注射，每周注射 1 次。或 Ara-c 鞘内注射，每周 1 次，每次 100mg，可给 3~5 次。

四、生物疗法 可酌情选用干扰素、白细胞介素Ⅱ等。

五、手术治疗

对于原发于胃、小肠、泌尿系、生殖系肿瘤、甲状腺、腮腺、乳腺等部位的局限性病灶，可考虑手术切除。

脾脏手术切除指征：原发于脾脏的淋巴瘤、脾脏有转移灶者；淋巴造影阳性，脾脏肿大者，尤其化疗后脾脏回缩者。发现脾脏切除术后，增加周围血象对以后放、化疗的耐受性，五年生存率提高 20%~30%。

六、放射治疗

(一) 何杰金病：Ⅰ、Ⅱ期至ⅢA 期一般情况较好，侵犯范围比较明确的首次治疗患者，化疗后残存局限性少数病灶的患者。用斗篷野（膈以上淋巴区）照射，倒丫野（膈以下淋巴区）照射，剂量 4,500~5,000rad。

(二) 非何杰金淋巴瘤：一般照射肿瘤所在区域及淋巴结引流区上下各一丫，或作大面积照射，剂量一般为 4,000~5,000rad。

第二十五章 白血病

【概述】

白血病是造血系统的一种恶性疾病，又称“血癌”。其特征是骨髓或其它造血组织中任一系列白细胞及其幼稚细胞呈肿瘤性增生，并进入外周血液，浸润全身各组织器官。由于白血病细胞呈进行性大量增殖，导致造血衰竭，引起红细胞、粒细胞和血小板减少。临床常有贫血、发热、出血以及肝、脾和淋巴结不同程度肿大等表现。急性白血病的自然病程约数月，死亡的主要原因为感染和出血。随着中西医结合治疗的进展，不少病人可长期无瘤存活。

白血病是常见的癌症之一。根据统计我国白血病发病率大致为 $2/10$ 万~ $4/10$ 万，占各种恶性肿瘤的第六位（男）和第八位（女），在 35 岁以下的人群占首位，和国外相比，我国与亚洲国家很接近。例如新加坡为 $2.7/10$ 万，日本为 $3.4/10$ 万，但明显低于欧美国家，例如美国为 $6.7/10$ 万，法国为 $7.7/10$ 万。

祖国医学无“白血病”这一病名，但历代文献中有很多有关类似本病主要临床表现如发热、贫血、出血、肝脾及淋巴结肿大等症状的记叙，分属于“温病”、“血证”、“急劳”、“血虚”、“热劳”、“症积”、“痰核”等病的范畴。如《明医杂著》中记叙：“男子二十前后，色欲过度，损伤精血，必生阴虚火动之病。睡中盗汗，午后发热，咯咯咳嗽，倦怠无力，饮食少进，甚则痰涎带血，咯吐出血，或咳血、吐血、衄血、身热、脉浮数、肌肉消瘦，此名劳瘵，最重，难治。”这里的发热、乏力、盗汗、出血等与白血病甚为相似，因提到了吐血，衄血，故与结核病的虚劳有别。又如《圣济总录》中记叙：“急劳者……缘禀受不足，忧思气结，荣卫

俱虚，心肺壅热，金火相型，藏气传克，或感受外邪，故烦躁作热赤心忪，头痛盗汗，咳嗽咽干，骨节酸痛，久则肌肤销铄，咯涎吐血者，皆其候也”。更明确地指出了本病病因、病机和症状。关于预后，《证治要决·诸失血门·鼻衄》也有记载：“诸失血而发热甚者，难治，十仅可一、二全者。”指出了出血伴有高热者，预后不良。

临床上，现代医学通常根据病程缓急以及细胞分化程度分为急性白血病（急白）和慢性白血病（慢白）。根据增生的白细胞类型不同分为粒细胞性、淋巴细胞性和单核细胞性三种类型。按周围血象白细胞总数和原幼细胞的多寡分类可分为白细胞增多性和白细胞不增多性，前者白细胞总数显著增高，常 >1.5 万/ mm^3 ，伴有大量异常原幼细胞，后者白细胞总数正常或甚至降低，血片中较难找到原幼细胞。

在我国急白多于慢白，急白中以急性粒细胞白血病（急粒）最多，急性淋巴细胞白血病次之，急性单核细胞白血病（急单）较少。慢性淋巴细胞白血病（慢淋）少见。在欧美则相反，急性与慢性约各占其半，慢淋多于慢粒。白血病可发于任何年龄，男多于女，成人以急粒最多，儿童以急淋最多，慢粒多见于成年，慢淋多见于老年。

【病因病机】

祖国医学认为，本病的发病原因，一是内伤，或先无不足，遗传缺陷或后天失调，正气内伤，抗病力低下，易受毒邪侵袭。二是毒邪侵扰，包括热毒、温毒、瘀毒、风毒及湿热之邪。邪气强盛，侵扰机体所致。

发病机理，一是认为先有体虚内伤，正气不足，外邪乘虚而入，如内经说：“邪之所凑，其气必虚”、“正气存内，邪不可干”，即正虚为本，无力抗邪。二是认为毒邪侵袭人体，损伤正气，邪毒亢盛，正气受损，累及脏腑骨髓而发病。早期、中期以实证为主，即标实本虚，后期表现为虚证，标本皆虚。

从临床实践总结，认为本病并非单纯实证或虚，而是虚实相兼，本虚标实，由实到虚，气血阴阳，寒热虚实互相夹杂不断发展变化。

现代医学认为本病的致病因素并非单一的，可能为多种因素相互作用的结果，已知的因素有病毒、电离辐射、化学物质及遗传因素等。

【诊断要点】

中医对本病的诊断主要是依据其临床症状审证求因，辨证论治。而本病的明确诊断则需依据临床症状体征及实验室检查。

(1) 症状体征：急白临床表现：多数起病急骤，高热、贫血、出血及关节疼为主，可有肝、脾、淋巴结肿大等。慢白起病缓慢，可有乏力、低热、多汗、体重减轻（加速期和急变期的症状如同急白），出血、肝脾淋巴结肿大明显，胸骨常有叩压痛。其他如皮肤粘膜病变，骨关节疼痛，中枢神经症状等，根据浸润部位不同，出现相应症状和体征。

(2) 血象和骨髓象检查：较典型的血象是贫血、血小板减少及白细胞质和量的变化，末梢血白细胞数可多也可正常或减少，关键是在周围血象中发现幼稚型白细胞。骨髓象是确诊的可靠依据。增生多呈明显至极度活跃，原始和早幼细胞的百分数超过正常值，各类型白血病各有其特征。

(3) 其他生化检查、免疫学检查有助于分型。

(4) 急白注意与类白血病反应、粒细胞缺乏症、急性再生障碍性贫血、儿童急性风湿热等病相鉴别。慢白要与类白血病反应、原发性血小板减少紫癜、多发性骨髓瘤、骨髓纤维化及引起肝脾淋巴结肿大的其它疾病相鉴别。

【治疗】

一、急性粒细胞白血病的治疗

(一) 辨证论治

1. 热毒型

【主证】高热，汗出，头痛，唇焦口干，心烦，倦怠，鼻衄，龈衄，皮肤瘀点，紫癜，小便短赤，大便秘结，舌质红，苔黄，脉数或洪数。

【治则】清热解毒，凉血止血。

【方药】犀角地黄汤合基本方加减。常用犀角 1g，丹皮 15g，生地 15~30g，元参 15~30g，赤芍 15~30g，紫草 30g，小蓟 30g，藕节 30g，板蓝根 30g，大青叶 30g，地丁 15~30g，土大黄 30~60g，甘草 10g。

附：基本方：蒲公英 30g，小蓟 30g，白茅根 120g，生地 15g，土大黄 30g。

2. 气虚血瘀型

【主证】发热，倦怠，乏力，全身及骨骼疼痛，肝、脾及淋巴结均肿大，肝区疼痛，皮肤瘀斑，尿血便血，舌体胖，舌质紫暗，脉涩或沉细数。

【治则】健脾益气，活血化瘀。

方药：膈下逐瘀汤合基本方加减。常用当归 10g，川芎 10g，桃仁 10g，赤芍 10g，丹参 24g，鸡血藤 30g，元胡 10g，枳壳 10g，刺猬皮 15g，鳖甲 30g，党参 10g，白术 10g，黄芪 15g，茯苓 15g，陈皮 10g。

3. 气血双亏型

【主证】面色㿔白，头晕心慌，倦怠乏力，腹胀纳差，龈衄，皮肤瘀点（瘀斑或块），舌质淡，脉细弱。

【治则】益气养血。

【方药】八珍汤加减。常用当归 10g，川芎 6g，白芍 21g，熟地 15g，党参 15g，白术 10g，黄芪 15g，鸡血藤 30g，女贞子 30g，黄精 30g，灵芝 30g。

（二）经验方

1. 白血汤：I 号：板蓝根 12g，黄精 12g，半枝莲 12g，天花粉 12g，生地 12g，熟地 12g，太子参 12g，石斛 12g，麦冬

9g, 白术 9g, 首乌 15g; II 号: 板蓝根 12g, 蚤休 12g, 生地 12g, 熟地 12g, 石斛 12g, 白术 9g, 人中黄 9g, 人中白 9g, 忍冬藤 15g, 马勃 4.5g, 半枝莲 12g, 猪殃殃 30g。水煎服, 每日 1 剂, 煎 2 次分服。I 号方配合化疗; II 号方缓解维持期; 治疗期间可予多种有力支持疗法。

2. 枝草乌翘汤: 核桃枝 60g, 白花蛇舌草 30g, 生首乌 30g, 连翘 30g, 紫草根 15g, 土大黄 15g, 水煎服, 每日 1 剂, 煎 2 次分服, 同时配合使用皮质激素类药物。

3. 猪狗龙蛇汤: 狗舌草 30g, 猪殃殃 30g, 白花蛇舌草 30g, 龙葵 30g, 仙鹤草 30g, 北沙参 30g, 金银花 18g, 丹参 18g, 白术 15g, 制黄芪 12g, 当归 12g, 补骨脂 12g。

4. 参芪鹿茸汤: 人参 50g, 黄芪 250g, 鹿茸 40g, 砂仁 10g, 白术 15g, 陈皮 15g, 半夏 15g。加减: 补血加首乌 30g; 破瘀滋阴加龟板 20g; 扶正常服胎盘粉 15g。

5. 蟾蜍方: 鸡蛋、蟾蜍。将蟾蜍洗净(不剥皮), 用剪刀从腹正中线剖开(不去内脏), 放入一个小鸡蛋至腹腔内, 用线缝合, 然后加水 300~400ml 沸 30~40 分钟, 至蟾蜍肉烂为宜, 吃蛋不喝汤, 每日 1 个。

6. 白血病方: 夏枯草 12~18g, 白花蛇舌草 20~30g, 重楼 9g, 金银花 15~24g, 土茯苓 30g, 山慈菇 9g, 生地 12~18g, 半边莲 18~24g, 紫草 12~18g, 山豆根 12~18g。

7. 抗白丹方: 雄黄 3g, 巴豆(去外皮) 3g, 生川乌 3g, 乳香 3g, 郁金 3g, 槟榔 3g, 朱砂 3g, 大枣 7 枚。将雄黄、生川乌、乳香、郁金、槟榔共研细末, 巴豆去皮置砂锅中文火炒至微黄色, 再去内外皮, 用双层纸包压碎, 微热半小时, 去油。将煮熟大枣去皮和核, 与上述药物混合, 捣研均匀, 合丸如黑豆大, 朱砂为衣。成人每天 4~8 丸, 小儿 1~4 丸。清晨 5 时开水 1 次送服, 连服 3~5 天, 休息 1 天。

8. 抗白合剂: I 号方: 金银花 10g, 漏芦 10g, 黄芩 10g,

黄连 3g, 蒲公英 10g, 地丁 10g, 鸡血藤 10g, 菟丝子 10g, 淫羊藿 6g, 丹参 7g; II 号方: (补血丸) 红人参 6g, 鹿茸 37.5g, 红花 4g, 当归 10g, 黄芪 10g, 白芍 6g, 生地 6g, 何首乌 6g, 杞果 6g, 淫羊藿 6g, 川芎 4g, 五味子 6g, 枣仁 6g, 丹参 6g, 雄黄 2g, 香油 10ml, 蜂蜜适量。I 号方加水煎煮, 共制 100ml。II 号方各药共研细末, 炼蜜为丸, 共制 1000 丸。口服, 煎剂每次 25ml, 每日 2 次; 丸剂每次 1 粒, 每日 2 次。I 号方适用于诱导缓解期。II 号方适用于维持缓解期。如病人体质较弱, 可将两方同时服用。

二、慢性粒细胞白血病的治疗

(一) 辨证论治

1. 瘀血内阻

【主证】形体消瘦, 面色不荣, 骨骼及胸、腹疼痛, 肋下块坚硬, 坠胀感, 肌肤甲错。伴有热者, 舌质红, 脉细数; 伴气虚者, 舌胖齿痕, 脉细。

【治则】活血化瘀。

【方药】膈下逐瘀汤加减, 常用当归 10g, 丹参 30g, 桃仁 10g, 红花 10g, 刘寄奴 30g, 八月扎 30g, 猪殃殃 30g, 半枝莲 30g, 猪苓 30g。气血虚者加党参 10g, 白术 10g, 黄芪 30g, 山药 3g, 鸡血藤 30g, 熟地 30g 等。

2. 血热毒盛

【主证】发热不退, 咽喉肿痛, 口腔糜烂, 头晕耳鸣, 口渴咽干, 盗汗, 腰酸, 全身骨节疼痛, 鼻衄, 齿衄; 内脏出血, 皮肤瘀斑, 舌质红无苔或花剥苔, 脉细数。

【治则】养阴清热, 凉血解毒。

【方药】青蒿鳖甲汤加减: 常用青蒿 10g, 沙参 30g, 犀角 1.5g, 生地 30g, 鳖甲 30g, 知母 10g, 丹皮 15g, 紫草 30g, 白毛藤 30g, 白薇 30g。

3. 肝肾阴虚

【主证】头晕眼花，目涩，视物不清，口干渴，心烦失眠，耳鸣耳聋，腰酸腿软，遗精，月经过少，五心烦热，全身粘膜及皮肤出血等，舌红无苔，脉弦细。

【治则】滋补肝肾

【方药】麦味地黄丸加减。常用杞果 30g，沙参 30g，麦冬 30g，生地 24g，丹皮 15g，山萸肉 10g，山药 30g，黄精 30g，赤芍 12g，小蓟 30g。

4.脾肾阳虚

【主证】形体消瘦，面色㿠白，面及肢体浮肿，倦怠乏力，手足不温，肝、脾、淋巴结肿大，皮肤有瘀点（斑），舌体胖，苔白润，脉弱无力。

【治则】温补脾肾。

【方药】金匮肾气丸或右归饮加减。常用附子 6g，肉桂 9g，苁蓉 30g，熟地 21g，山药 30g，山萸肉 15g，南星 9g，半夏 10g，陈皮 15g，山甲 15g，鳖甲 30g，刺猬皮 15g。

5.气血两亏

【主证】面色㿠白，倦怠无力，心慌，气短，踝肿，全身皮肤，粘膜及内脏出血，舌体胖，质淡红，苔薄白，脉濡或弱。

【治则】八珍汤合归脾汤加减，常用黄芪 15g，党参 15g，白术 10g，茯苓 15g，当归 15g，白芍 15g，熟地 24g，元肉 30g，小蓟 30g，仙鹤草 30g，阿胶 10g，鹿角胶 10g。

（二）经验方

1.当归芦荟丸。每日三次，每次 1~3 丸，有腹泻时服用红枣 5~6 个，每日二次（慢粒约 80%有效，有效成分为靛玉红）。

2 青黛片：每日 3 次，每次 2~4 片，口服。或靛玉红 150~300mg / 日。

4.洗碗叶根 30g，猪殃殃 60g，狗舌草 30g。

5.五生水王汤：水红花子 10g，皮硝 30g，樟脑 12g，桃仁

12g, 地鳖虫 12g, 生南星 15g, 生半夏 15g, 穿山甲 15g, 三棱 15g, 王不留行 15g, 白芥子 15g, 生川乌 15g, 生草乌 15g, 生白附子 9g, 延胡 9g, 研细末, 以蜜及醋调成泥, 加麝香 1.2g, 梅片 3g。外敷脾肿大处。

6. 壁虎枯矾散: 壁虎 60 条, 枯矾 80g, 朱砂 30g, 皂刺 30g, 蜈蚣 60 条, 青黛 100g, 三七 60g, 乌蛇 100g, 僵蚕 50g。共研细面, 每服 2g, 日服 2 次。

7. 舌草三参汤: 白花蛇舌草 30g, 沙参 20g, 党参 20g, 黄精 40g, 半枝莲 20g, 马齿苋 50g, 白芍 15g, 丹参 20g, 黄药子 20g, 重楼 20g, 紫草 20g, 阿胶 15g。

第二十六章 多发性骨髓瘤

【概述】

多发性骨髓瘤又称骨髓瘤病，因来源于骨髓内的浆细胞，故又称浆细胞性骨髓瘤。该病在我国并不常见，近二十多年来有逐渐增加的趋势。国外的报道在 $2/10$ 万 $\sim 4/10$ 万。高出国内 $6\sim 12$ 倍。据国内黄承达（1989）统计，在恶性骨肿瘤中，多发性骨髓瘤升至第 4 位，占全部恶性骨肿瘤病例的 6.0%，居骨肉瘤、软骨肉瘤和纤维肉瘤之后。骨髓瘤的发病年龄绝大多数在 40 岁以上，发病高峰在 50 ~ 70 岁之间，约占 70% 左右，30 岁以下罕见。但近年来的报导表明，发病年龄已趋于年青。如国外 Snapper 等（79 年）报导的文献中，发病年龄有从 16 个月到 19 岁之间的患者 13 例。而国内刘子军等（88 年）报道 48 例中，40 岁以下的 12 例，占 25%，40 岁以上的 36 例，占 75%；30 岁以下的 8 例，占 14.8%。可以看出，国内骨髓瘤的发病年龄已趋年青。男多于女，约为 2 倍，但也有人报导女性多于男性。

多发性骨髓瘤的发病原因尚未完全明了，据临床观察和研究表明，有些因素与本病关系密切。据报道：某些慢性感染、炎症，如慢性骨髓炎、肾盂肾炎、慢性肝炎、结核等可伴有浆细胞增多。这可能是由于炎症刺激网状内皮系统的结果。根据动物实验，发现本病可能直接因病毒感染而引起。也有人报导，本病与某些化学物质刺激电离辐射等因素有关。另有人发现，本病易在某同一家族中发生，很可能与某些遗传因素有关。

临床上一般将骨髓瘤分为单发和多发性两种，但多数认为：单发性骨髓瘤极为少见，或已存在于其他部位而未被发现，多数在日后均变为多发性；所以有人把单发性骨髓瘤看作是多发性骨髓瘤的前兆。多发性骨髓瘤病灶广泛，尤其是晚期，往往数目很

多。肿瘤主要分布在颅骨、脊椎、肋骨及骨盆等；四肢长骨一般仅累及股骨或肱骨的近侧端。Batts 根据 X 线检查发现病灶的分布比例为：颅骨 73%，椎骨 70%，肋骨 68%，盆骨 63%，股骨 48%，肱骨 43% 等。又 Willis 则指出这种统计无疑较实际被累及的部位为低，因轻度或弥漫的病变很易被忽略。

多发性骨髓瘤的早期症状并不典型，主要表现为逐渐加重的骨骼疼痛，起始多在腰背或胸部，初为间歇性，继为持续性，活动或压迫时疼痛较重，患部渐渐膨隆，多发于肋骨、胸骨、锁骨等部位，常发生病理性骨折；若发生在脊椎，易压迫神经和脊髓，而产生剧烈的放射性神经疼痛；或截瘫。晚期则出现贫血、出血、继发性感染的征象。病程发展快，一般在明确诊断后生存 2~3 年，甚或短期内死亡。

在治疗方面，早期发现单发性骨髓瘤，进行有效的根治是防止多发性骨髓瘤的一个重要环节，多发性骨髓瘤由于病灶广泛，治疗仍以化学药物为主，辅以中药、放射治疗等综合措施，预后较差。因此早期发现，特别是在骨髓瘤的前期，出现原因不明的蛋白尿，血浆球蛋白增高，易于反复的细菌感染等症候时，要提高警惕；一旦发现，争取早日根治，是提高疗效，延长生存期的重要步骤。

多发性骨髓瘤属于祖国医学“肿瘤”、“瘰癧”、“滑疽”的范畴。《内经》云：“肿大成块，积结不散留居在一处，日久则传舍于各处，形成瘰癧肿瘤之物，谓之肿瘤”。从临床表现来看与该病有相似之处。但鉴于历史的原因，古代医家不可能对本病有一个全面系统的认识，因此，必须结合现代医学以及必要的 X 线、理化检查才能全面了解、分析、研究本病的发生、发展、治疗以及预防，并采取积极的治疗措施以提高疗效，延长病人的生命。

【病因病机】

多发性骨髓瘤的病因为多种因素，祖国医学对其缺乏详尽的描述，但根据其原理，结合临床观察，概括以下两个方面。

一、邪毒侵袭 外感湿、热邪毒，侵入人体，致气血凝滞不散，痰瘀内生，邪毒蕴于骨骼而发病，毒邪有湿毒、毒热之分；湿毒凝滞经络，故为痛为肿，久郁化热，伤及血络则出血，贫血；转为毒热。故《诸病源候论》云：“肿之生也，皆由风邪寒热毒气，客于经络，使血涩不通，壅结皆成肿也”。

二、肾精亏虚 《内经》云：“正气存内，邪不可干，邪之所凑，其气必虚”。《外证医编》云：“正气所虚则成岩”。年老体衰、肾精不足，或先天禀赋不足，精血亏虚，机体机能低下，抗病力弱，易致邪毒侵袭留滞体内，导致气滞血瘀，痰凝毒聚，相互搏结，郁于骨骼，脏腑而发病。

综上所述，外感湿、热邪毒致故气血凝滞，痰瘀内生，邪毒凝滞经络，骨髓而发病，或故年老体衰，精气不足，抗病力低下复为邪毒侵袭，日积月累，耗气伤精，正气更虚，导致正越虚，毒越盛；痰、瘀、毒、热邪结更甚，正虚不能却邪外出，以致毒瘀难化，久之则正虚、邪毒、痰瘀相互持搏结终成绝疾。

【诊断要点及鉴别诊断】

（一）多发性骨髓瘤的诊断要点

1.年龄性别：多发于40岁以上的男性患者。50~70岁为发病高峰。

2.骨痛及骨骼肿物：因病灶广泛，骨痛及骨骼肿物多发生于颅骨、椎骨、胸骨、肋骨、盆骨等肿瘤好发部位，或合并病理性骨折。当早期出现原因不明的骨痛时，应提高警惕。

3.贫血及血沉增快：因瘤痛发生在骨髓，影响造血机构产生贫血，呈进行性加重。红细胞、血红蛋白、血小板计数减低，血沉降率明显增快。

4.血液生化，约半数病人血清蛋白增高，白蛋白正常或降低，使A/G倒置。血清钙增高，系肾功能损害所致。

5.骨髓象：骨髓涂片检查可发现大量骨瘤细胞，即畸形浆细胞。

7.尿与肾功能检查：多数病人有蛋白尿（少数病人有血尿及管型尿）。尿本周氏蛋白在60%以上出现阳性。晚期肾功能不全时，出现氮质血症。

8.X线表现：病灶的主要表现为多个溶骨性破坏及广泛的骨质疏松。溶骨性病灶，边缘清晰，周围无骨膜反应和新骨形成小的缺损呈弥漫性的斑点状，大的缺损可达4~5cm，骨皮质变薄，甚至形成软组织肿块；常发生病理性骨折。

9.不明原因的反复感染。

（二）老年性骨质疏松 X线征象与早期骨髓瘤的变化不易鉴别，二者均有骨质疏松及病理性骨折等；但老年性骨质疏松症患者尿液中一般无本周氏蛋白，血清中无球蛋白增多，骨髓象正常。

（三）骨内溶骨性转移瘤

1.病变的数目通常不及骨髓瘤多，病灶大小不一，不如骨髓瘤的均匀。

2.病灶边缘不及骨髓瘤的清楚锐利。

3.患者无骨质疏松、病灶间的骨质密度正常。

4.肺内常有转移灶。

5.可能有原发肿瘤发现。

6.无血浆球蛋白的增高，尿内通常无凝溶蛋白。

（四）巨细胞瘤

1.单发性骨髓瘤可与巨细胞瘤相似，但后者患病年龄轻。

2.病变常涉及骺部，肿瘤向横的方向发展，膨胀较显著。骨髓瘤的病变偏于骨干，膨胀不甚明显。

3.脊椎的病变常限于脊椎骨质内；而骨髓瘤则易伸展至附近的软组织内，形成软组织肿块影。

【临床分期】

I期：①血红蛋白 $>10\text{g}/100\text{ml}$ ；②血清钙正常或少于、等于 $12\text{gg}/100\text{ml}$ ；③骨髓瘤蛋白生成率低： $\text{IgG}<5\text{g}/100\text{mg}$ 。

IgA < 3g / 100ml; 尿轻链 < 4mg / 24 小时, X 线检查: 病骨正常或见轻微的孤立性病灶。

Ⅱ期: 介于Ⅰ期和Ⅲ期之间。

Ⅲ期: ①血红蛋白 < 8.5g / 100ml; ②血钙 > 12mg / 100ml; ③骨髓瘤蛋白生成率高, IgG > 7g / 100ml; IgA > 5g / 100mg, 尿轻链 > 12mg / 24 小时; ④X 线检查: 病骨可见溶骨性病灶。

【治疗】

一、辨证施治

(一) 邪毒瘀阻型

【主证】局部肿胀、疼痛, 多发于颅骨、椎骨、肋骨、胸骨、盆骨等肿瘤好发部位; 早期为间歇性隐痛, 逐渐加重, 后期则出现难以忍耐的持续性剧痛; 肿块质坚硬呈骨性, 有压痛、红肿、发热, 或伴有形瘦、乏力、头晕、心悸, 舌淡红或有瘀斑, 苔薄黄而腻, 脉细弦滑。

【分析】本型的辨证要点是邪毒瘀滞内阻, 脉络不通故为肿胀、疼痛, 邪毒内郁化热, 侵犯骨骼, 瘀邪流注, 产生骨髓瘤且为多发, 则肿块质硬呈骨性, 压痛、红肿、发热等, 邪毒留滞骨髓, 生血源乏则心悸、头晕、形瘦、乏力, 舌淡红有瘀斑, 苔薄黄而腻, 脉细弦滑, 为血虚, 瘀滞邪毒内阻之象。

【治则】解毒消肿, 祛瘀散结。

【方药】七叶一枝花 45g, 夏枯草 30g, 昆布 30g, 天龙 3~6g, 当归 12g, 虎杖 30g, 三棱 10g, 文术 10g, 云苓 30g, 甘草 5g, 元胡 12g。

【方解】此属经验方, 以清热解毒抗癌消肿为主。药用七叶一枝花、夏枯草、虎杖、天龙、昆布等以清热解毒, 消肿散结; 三棱、文术、当归养血祛瘀; 元胡理气止痛; 云苓、甘草健脾和中, 顾护胃气。

【加减】肿块发热, 疼痛较甚者乃邪毒炽盛之象, 于经方中入白花蛇舌草、半枝莲; 或制乳香、制没药等; 正气虚入黄芪、

黄精、生地等益气养血。

（二）精血亏虚型

【主证】面色萎黄或苍白，形体瘦弱，气短乏力，肿块增多增大，质硬如石，腰痛剧烈或伴有放射性神经痛，或截瘫，肝脾肿大或腹水，紫斑或出血，舌质暗，脉沉细。

【分析】本型病机重点是肾虚精血不足，邪毒留滞骨髓，造血源乏，则出现较严重的贫血，如面色苍白，形体瘦弱，肝脾肿大，气短乏力。肾藏精主骨生髓，髓弱骨空虚则易出现病理性骨折，当脊椎骨折压迫脊髓或神经根时则出现截瘫或剧烈的放射性神经痛；脾肾阳虚，运化失职水湿内停则出现腹水；邪毒内炽，络破血溢则产生紫斑或出血；舌质暗，脉沉细均为肾精亏虚，正虚邪恋之象。

【治则】补肾填精，壮骨生髓

【方药】党参 30g，旱莲草 30g，丹参 30g，鸡血藤 30g，制首乌 30g，麦冬 10g，桑寄生 30g，女贞子 15g，炒杜仲 15g，川断 15g，天麻 10g，土鳖虫 15g，五味子 10g，甘草 10g，川牛膝 15g。

【方解】此属李氏经验方，用于肾虚精亏骨弱合并病理性骨折者，有一定疗效，方中旱莲草、女贞子、制首乌、桑寄生、麦冬、川断、五味子补肾填精，固护真气，壮骨生髓；丹参、鸡血藤养血活血；川牛膝补肾通络；天麻、土鳖虫祛瘀散结通络止痛。甘草调和诸药。

【加减】阴虚内热，入生地、知母、丹皮；紫癜出血者，入仙鹤草、阿胶珠、茜草、三七粉；肝脾肿大入炙鳖甲、京三棱、文术。

病至后期，病灶广泛，症形复杂，正气虚极，邪毒凝滞，非一方一法能概括之，急当中西医结合抢救，庶几或延长生命。

二、中西医结合治疗

（一）中医药与化疗相结合：多发性骨髓瘤象其他恶性肿瘤

一样。目前仍无理想的治疗方法，单独中医药治疗效果难以肯定，因此，以化学治疗为主，辅以中药、放疗等综合疗法乃是提高疗效、延缓病人生命的有效措施。

化学药物治疗分单药化疗、联合化疗两种

1. 辅以单药化疗。

①环磷酰胺：为治疗本病较好的药物之一。口服，成人 200mg/d，5~7 天后改为维持量 50~100mg/d，长期服用。同时服强的松 50~100mg/d，服三天，停四天。间歇三周再重复治疗。

②N-甲酰溶瘤素：对本病疗效肯定，近期有效率达 89%。口服，150~200mg/d，6~8g 为一疗程，或 200mg，每日两次，连服 4 天，每两月重复一次。

另，左旋苯丙氨酸氮芥、阿霉素、卡氮芥、长春新碱等对本病也有较好的治疗作用，可酌情选用。

2. 辅以联合用药化疗。

(一) M₂ 化疗方案：

①强的松 10mg，1 日 3 次×7 天（第 1~7 天，亦可在 7 天后减为 5mg，1 日 3 次，维持到疗程结束）。②卡氮芥 100mg 口服（第一天）。③马法蓝 2mg，1 日 2 次×5 天（第 2~6 天）。④环磷酰胺 400mg，静脉推注（第 2 天）。⑤长春新碱 1mg，静脉推注（第 21 天）。21 天为一个疗程，休息两周后，再进行第二个疗程，休息期强的松可以停用或用维持量。

化疗期间，应密切注意血象变化，当白细胞下降至 $3.0 \times 10^9/L$ 以下时，要及时处理或暂停化疗，及早恢复其造血功能。如河南省肿瘤医院报道，用益肾护髓方治疗化疗引起的白细胞减少症有效率达 90%，北京中医院报道，化疗配合中药治疗，绝大多数患者，一般情况良好。所以中药具有防治化疗毒副作用，保护、调节机体内环境的作用。

(二) 中医药与放疗相结合 本病对放射治疗较敏感。如果

肿瘤局限于 1~2 处时，放射治疗可作为首选方法。对局限性病灶照射，一般肿瘤剂量在 40 天以内，给予 50~60 戈瑞。

对于病灶广泛的多发性骨髓瘤，可口服放射性同位素磷治疗。总剂量一般 15~18 毫居里；通常分四次口服，每次服 5 毫居里，每次间隔 12 天，第四次服药是在第三次服药后 30 天服 4 毫居里。

放射治疗不仅影响造血机能，且有一定的副作用。配合中药，补肾填精、壮骨生髓不仅对放疗引起的白细胞减少症有效，而且临床实践证明，部分中药具有放射增效作用，能够提高疗效。

【手术治疗】

对于单发性骨髓瘤可以局部切除加放射治疗。对多发性骨髓瘤合并病理性骨折，或压迫脊髓合并截瘫，可施行内固定术或椎板减压术；严重者可截肢。

综上所述，目前多发性骨髓瘤仍无理想的治疗方法，综合治疗可以提高疗效。据最新资料统计，临床经过合理、积极的综合治疗，多数生存期延长，治疗后生存 2 年以上者达 70%，个别病例，达 4 年左右，可见，综合治疗对多发性骨髓瘤确有提高疗效，延长病人生命，或缩小切除范围的优点，值得进一步研究、提高。

【预防】

多发性骨髓瘤的预防措施，由于本病的发生与临床所见的某些慢性炎症、感染有关，因此，对于老年男性患有某些慢性感染性疾病者应积极治疗，防患于未然。年老体衰，人体内的抗肿瘤生长的免疫功能日趋减低。通过锻炼，可以增强体质和提高机体的免疫能力，特别是抗肿瘤生长能力，减少病毒及其他有害因素的侵袭，积极做好癌症普查工作，本病初期有一个长短不一的无症状期，有的甚至可长达 20 年之久，在此期间唯一发现是红细胞沉降率升高，蛋白尿、血清蛋白改变等征象，应提高警惕，争

取早日发现，早日根治，以期提高治疗效果，延长患者的生命。

第二十七章 骨肿瘤

【概述】

骨肿瘤是发生于骨内肿瘤的统称。骨骼包括多种组织，除骨和软骨外，还包括纤维组织、脂肪组织、造血组织和未分化的网织内皮结构。这些组织都可以发生肿瘤，这些组织发生的肿瘤称为原发性肿瘤。另外还有原发于身体其他组织或器官的肿瘤，通过直接浸润、血运或淋巴系统的转移，而在骨组织形成的肿瘤，称为继发性骨肿瘤或转移性骨肿瘤。

原发性骨肿瘤的分类，主要是根据肿瘤组织的形态结构进行的，特别是根据肿瘤细胞所显示的分化类型及所产生的细胞间物质类型进行的。在此基础上结合肿瘤的生长特性，将骨肿瘤分为良性和恶性两大类。结合其发生学，分为多种骨肿瘤。

目前，我国各地较多应用的原发性骨肿瘤分类如下表。

近年来，因骨骼系统的各种肿瘤特别是恶性肿瘤而住院治疗的病例日见增多。七十年代初期，我国的一些学者统计我国骨肿瘤的年校正发病率为 $1/10$ 万。1989 年，中山医科大学黄承达等将全国第一、二届骨肿瘤学术会议资料合并统计，包括全国各地 40 多家大中型综合性医院的骨肿瘤病变 38959 例。该统计资料可反映我国骨肿瘤发病的基本情况。其中原发性良性骨肿瘤 21691 例，占 55.7%，原发性恶性骨肿瘤 10191 例，占 27.7%，瘤样病变 4369 例，占 11.3%，转移瘤 2108 例，占 5.4%。

在我国，良性骨肿瘤发病率明显高于其他骨肿瘤，在 21691 例良性骨肿瘤中，男女发病比率为 1.62: 1；骨软骨瘤发病率最高，占 38.5%，其次为骨巨细胞瘤（18.4%）；软骨瘤（14.6%），骨瘤（9.0%），大部分良性骨肿瘤发病年龄高峰在 11~20 岁，骨巨细胞瘤则好发于 21~40 岁年龄组，股骨和胫骨是

良性骨肿瘤好发部位，占 41.3%，其次是手骨、颌骨和肱骨，骨巨细胞瘤则以股骨下端和胫骨上端最为常见，软骨瘤好发于指骨。

表 13 原发性骨肿瘤分类

类 型	良 性	恶 性
成骨性肿瘤	骨瘤，骨样骨瘤，良性骨母细胞瘤，骨化性纤维瘤。	骨肉瘤，皮质旁骨肉瘤，恶性骨母细胞瘤
成软骨性肿瘤	骨软骨瘤，软骨瘤，软骨粘液样纤维瘤，软骨母细胞瘤	软骨肉瘤，退分化性软骨肉瘤，间胚叶性软骨肉瘤，恶性软骨母细胞瘤
骨髓源性肿瘤		骨髓瘤，尤文氏肉瘤，恶性淋巴瘤
纤维组织性肿瘤	韧带样纤维瘤，非骨化性纤维瘤	纤维肉瘤
脉管组织性肿瘤	血管瘤，淋巴管瘤，血管球瘤	血管内皮瘤，血管外皮瘤。
脂肪组织性肿瘤	脂肪瘤	脂肪肉瘤
神经组织性肿瘤	神经鞘瘤，神经纤维瘤	神经纤维肉瘤
脊索组织肿瘤		脊索瘤
间叶组织肿瘤		恶性间叶瘤
组织细胞性肿瘤		恶性纤维组织细胞瘤
来源未明肿瘤	巨细胞瘤	恶性巨细胞瘤，长骨造血干细胞瘤，原始多能性骨肉瘤。

10791例恶性骨肿瘤中，男女发病比率为2.3:1。骨肉瘤发病率最高。占44.6%，其余依次为软骨肉瘤（14.2%），纤维肉瘤（6.6%），骨髓瘤（6.0%），尤文肉瘤（4.6%），恶性骨巨细胞瘤（4.0%）。恶性骨肿瘤的好发年龄在11~30岁，占56.5%。在此年龄组的骨肉瘤发病率为77%，尤文肉瘤71.5%，软骨肉瘤为48%。恶性骨肿瘤最好发于股骨和胫骨，共占54.3%，其次是肱骨、骨盆、颌骨和脊柱骨。

按照总的发病率排列，在我国，最常见的骨肿瘤是骨软骨瘤，其次是骨肉瘤，软骨瘤，骨瘤，软骨肉瘤。

恶性骨肿瘤的死亡率是较高的，骨肉瘤几乎在半年左右发生转移，在1~2年内死亡，据英国皇家学会的统计，骨骼恶性肿瘤的死亡率出现在两个高峰，第一个高峰在15~20岁，以男性占多数，至30岁以后，又出现另一个高峰，一直到75岁以后。第一个高峰主要是由于骨肉瘤，第二个高峰是由于骨的转移性肿瘤。

对于骨肿瘤的认识，祖国医学早在两千多年前就有记载。《灵枢经·刺节真邪篇》中说：“虚邪之人于身也深，寒与热相搏，久留而内著，寒胜其热，则骨疼肉枯。”这里骨疼肉枯符合恶性骨肿瘤时的疼痛与消耗所致的恶病质。又说：“以手按之坚，有所结，深中骨，气因于骨，骨与气并，日以益大，则为骨疽”。在论及骨疽时提出：“热气淳盛，下陷肌肤，筋髓枯，内连五脏，血气竭，当其痈下，筋骨良肉皆无余，故命曰疽”。以后的历代医家根据临床实践又不断地作了补充。唐朝孙思邈《千金翼方》中提出了七种肿瘤，而骨肿瘤是其中之一。其提到：“陷脉散主二十、三十年癭瘤及骨瘤、石瘤……或大如杯盂，十年不差。致有癭溃，令人骨消肉尽，或坚或软或溃，令人惊惕寐卧不安”。巢源方《诸病源候论》中写道：“石癭者，……其肿结确实，至牢有根，皮核相亲”，“坚如石核者复大，色不变或作石癭，坚如石，不作脓。……”等等，清赵谦《医门补要》中记一病例。“一童周

身生骨瘤，坚硬贴骨，大小不一，肌肉日瘦，由母肾虚，与骨肉至戚苟合，胎感其气而成，久服肾气汤自消”。祖国医学文献浩如烟海，虽无现代骨肿瘤的名称，但所描述的症状包含了骨肿瘤的局部症状与性质。其所提到的骨疽、石疽就包括了恶性骨肿瘤及良性骨肿瘤。这些医学遗产，极大地丰富了对骨肿瘤的历史认识。但是，由于历史的原因，祖国医学不可能对骨肿瘤有详细和系统的分类和治疗。近年来，骨肿瘤和其他肿瘤一样，已经逐渐成为一种常见病，多发病，尤其是恶性骨肿瘤，对人类的危害性极大。因此，我们在临床上必须不断提高对骨肿瘤的认识，探索祖国医学治疗骨肿瘤的宝贵经验，在现代医学确诊的基础上，发挥祖国医学整体观念，辨证治疗的优势，开辟治疗肿瘤的新途径，不断提高防治肿瘤的有效措施，促进人民的健康。

【病因病机】

根据古代文献及中医理论，骨肿瘤的病因病理可分为内因、外因两大类。内因包括：先天禀赋不足，体质强弱因素，精神因素及年龄因素等。外因包括损伤、外感邪毒等。

一、内因

1.先天禀赋不足，即现代医学的遗传因素，中医学认为人的禀赋是有差异的，筋骨之强弱，肌肉之坚脆，皮肉之厚薄，腠理之疏密各不同……肠胃之厚薄坚脆亦不等。还指出有些疾病的发生往往与遗传有关。如清赵濂《医门补要》所记之骨瘤病例，即系近亲结合，其母肾虚，胎感其气而成。

2.体质因素：《素问·评热病论篇》指出：“邪之所凑，其气必虚”。体强者，脏腑坚实，精神振奋，腠理固密，人体机能活动正常，气血冲和，不易罹病。体弱者，脏腑脆弱，腠理疏松，精神萎靡，各器官机能活动失常，气虚血少，气血不和，邪气踞留，分化失常，气滞血瘀，结聚成瘤。

3.精神因素：祖国医学认为七情六志皆可致病，亦可致瘤。如情志波动激烈或持续时间过长，必然会引起阴阳失调，脏腑功

能紊乱，气血不随，经络受阻导致“骨与气并，日以增大，则为石疽”。

4.年龄因素：年龄对骨肿瘤的发生有密切的关系。如骨肉瘤好发于10~20岁的青少年，骨转移瘤则多为老年患者。青少年肾气始盛，骨骼不够坚实，老年人则肾气衰少，骨髓空虚，骨骼脆弱，易受邪气侵袭，罹患积聚肿瘤。

二、外因

1.损伤：损伤能否引起骨肿瘤，一直存在争论。从祖国医学的观点来看，损伤使组织破坏，引起出血，瘀血停聚，为肿瘤生长提供了条件。临床上见到骨巨细胞瘤的发生一般认为与损伤有一定的关系。而骨肉瘤的发生也多存在着外伤为诱因而出现疼痛后发病。

2.外感邪毒：祖国医学认为外感六淫或邪毒下陷肌肤，毒攻于内，伤筋蚀骨，或气血凝滞，经络受阻，日久结毒成瘤。现代医学所揭示的外源致癌因素，如化学致癌因素，感染、电离辐射、放射线损伤等都可包括在祖国医学的外感邪毒因素中。

综之，多种因素皆可导致骨肿瘤的发生，但气滞、血瘀、毒蕴为其主要病理变化，正气虚损则为其主要成因。

【诊断要点】

骨关节肿瘤尤其是恶性肿瘤，早期往往无明显症状，给早期诊断造成一定困难。但其又发病迅速，预后差，给我们提出了必须尽可能抓住一切细微因素，作出诊断，以提高疗效。以下我们就一些常见骨肿瘤的诊断要点作出叙述。

一、骨软骨瘤

骨软骨瘤，是发生于长管状骨干骺端的，带有软骨帽的外生骨疣。除长管状骨外，也可发生于任何由软骨化生而形成的骨。它是良性肿瘤中发病率较高的一种。有单发及多发两种，单发性骨软骨瘤较小，无遗传性，不影响骨骺的发育；多发性骨软骨瘤较大，有遗传性，常引起骨骺发育紊乱，肢体畸形。

临床表现：单发性骨软骨瘤的特征是带有软骨帽的骨性隆起物。多见于长管状骨的近骺区，病变多发生于 20 岁以下，约 50% 以上发生于股骨下端，胫骨上端和肱骨上端。少数病例见于脊柱、髌骨、锁骨和手足的小骨。早期一般无明显症状，肿块的出现是病员前来就诊的唯一因素。肿块有时会压迫周围组织，如肌肉、神经等，引起疼痛和不适。

X 线表现：其特点是在长管状骨的骨表面上有一骨性突起，与干骺相连，并有骨皮质及骨松质所组成。由于肿瘤基底部形状不同，常可分成有蒂（有一窄茎，顶部较宽）及无蒂（基底宽而扁）两种。骨软骨瘤常发生在干骺端肌腱韧带附着处，其生长常沿肌腱或韧带所产生的力的方向，其顶端有软骨覆盖，称为软骨帽，厚薄不一。如帽盖小、分界清楚、带有规则点状钙化，这种表现为良性表现。如帽盖大且厚，边界不清，会有不规则或不完全钙化，则应注意其恶性变的可能。

二、骨肉瘤

骨肉瘤是一种特殊的结缔组织肉瘤，起源于未分化的骨纤维组织，在发展过程中可以形成骨样组织和骨组织，所以也称成骨肉瘤。骨肉瘤可发生于骨的内部，也可发生于骨的表面，一般所称的骨肉瘤（Osteoscoma）是指发生于骨的内部和中央的肿瘤。发生于骨表面的则称为皮质旁骨肉瘤。

临床表现：骨肉瘤占原发性恶性骨肿瘤的第一位。男性病员较女性病员多，可发生于任何年龄，但以 10~20 岁占大多数，其次是 21~30 岁。好发部位为四肢长骨，其中以发生于膝关节上下者占半数以上，其次为肩关节下的肱骨上端，长骨的发病部位多在骨干的两端，很少波及骨骺，股骨以下端较多见，而胫骨和肱骨则以上端多见，其他部位如脊柱、肋骨也可发生，骨盆偶有所见。

疼痛，肿胀和活动障碍是本病的三大主要症状，局部疼痛往往是最早的症状，开始时，疼痛属隐痛、暂时性或间歇性，往往

被认为是劳累或损伤所致而被忽视。但不久即变为持续性，并逐渐加重，夜间较白天明显，甚至影响睡眠：最后发展为极难忍受的剧烈疼痛。在早期，局部可以没有肿胀或仅有轻度肿胀，经过一段时间后，随着肿瘤的增大，可形成偏心性纺锤状肿胀。肿瘤外面的皮肤有时紧张、光滑而发亮，浅静脉可呈怒张和扭曲。肢体功能障碍随不同的病例而异，邻近关节的骨肉瘤可使关节遭受不同程度的运动受限，下肢可出现跛行，但并不一定波及关节，事实上很少破坏关节。

咳嗽、胸疼和咯血是发生肺部转移的晚期症状，早期的肺转移除在 X 线片上发现病灶外，一般无临床症状。

X 线表现：普通 X 线片仍是诊断骨肉瘤的重要手段。早期骨肉瘤在 X 线片上的表现是隐蔽的，特别是位于骨松质内更难以发现。然而通常病人就诊时 X 线异常均已明显。下述特点是 X 线诊断的主要依据：

(1) 髓腔和松质骨：由髓内发生的骨肉瘤，以溶骨型占多数，其生长迅速地自内而外，故骨膜反应新生骨和 Codman 三角不易形成。而在松质骨内出现较大的囊状溶骨区，在囊内很少有肿瘤骨阴影，这种溶骨性骨肉瘤常合并病理性骨折。硬化型骨肉瘤可有大量瘤骨形成，在肿瘤两端的髓腔内，早期可见均匀的磨砂玻璃样的密度增高，继则呈絮状、片状或团块状阴影，若骨肉瘤在松质骨内也可出现反应性骨硬化。

(2) 皮质骨：骨质的破坏和肿瘤骨的形成常同时出现，故 X 线片上常显示纹理紊乱，密度致密的肿瘤骨阴影，重迭于破坏和疏松的骨质上。若系溶骨型，则以骨质破坏为主。

(3) 骨膜：在早期骨肉瘤将骨膜自骨面上剥离，其下产生反应性新骨，X 线片上的表现为日光放射状的骨纹。在肿瘤与骨干相连处，也即骨膜自皮质骨掀起，新生骨可形成三角形，即所谓 Codman 三角或骨膜套袖。随着肿瘤的继续发展，新生骨受挤压和破坏，形成如毛发蓬松的紊乱状态，最后新生骨逐渐消

失，或软组织内显示不规则的肿瘤阴影。X 线上所见到的各种骨膜反应都有两个特点：①骨膜反应的最外层比深层密度高；②骨膜反应和皮质骨之间都有一个透亮间隙。

(4) 软组织：当肿瘤穿破骨质而形成软组织肿块时，X 线片显示梭形、园形或界限不清的软组织肿胀阴影，在软组织内也可出现不规则的骨化区。

三、骨巨细胞瘤

骨巨细胞瘤是常见的原发性骨肿瘤之一。其来源尚不清楚，一般认为起始于骨髓内间叶组织。该瘤具有较强侵蚀性，对骨质有很大溶蚀破坏作用，极少有反应性新骨生成及自愈倾向；可穿过骨皮质形成较大的软组织包块；采用通常的刮除法复发率甚高，少数病例可出现局部恶性变或肺转移。基于上述特征，多数学者将其列为低度恶性或潜在恶性的肿瘤。

临床表现：骨巨细胞瘤的发病率在我国是较高的，仅次于骨软骨瘤，性别无差异，好发年龄为 20~40 岁，10 岁以下 50 岁以上少见。好发部位为长骨的骨端，多见于胫骨上端，股骨下端，桡骨远端，肱骨近端，尺骨远端和腓骨近端。少数发生于椎体、扁平骨或短骨。在早期即可侵袭骨髓和干骺端，骨髓的侵袭可偏于一侧或接近中央，也可波及骺端的全部。

在症状出现以前，病灶已存在相当时日。最早出现的症状是局部隐疼、酸疼或钝疼，疼痛性质有时是间歇性的，偶有剧痛或夜间疼，但一般不影响睡眠。继而出现包块，随着包块的增大，皮温可升高，静脉充盈，皮肤发亮，皮纹变浅，毗邻病变的关节活动受限。有时骨巨细胞瘤会被误诊为“关节疼”治疗，外敷药物后，疼痛和功能可有改善，但包块不为之减小。1/3 的病例出现病理性骨折。躯干骨发生肿瘤，可产生相应症状，如骶前肿块可压迫骶丛引起剧疼，压迫直肠引起排便困难。

X 线表现：X 线检查能较早地作出骨巨细胞瘤的诊断，主要 X 线表现为侵及骨髓的溶骨性病灶，而无反应性新骨生成；

病变骨皮质膨胀变薄，呈肥皂泡样改变；常有病理骨折，系溶骨破坏引起，一般无移位。过去曾把多囊性或肥皂泡样现象，强调为诊断依据，以致造成诊断上的混乱。较重要的依据应该是病灶的位置和骨皮质的变薄和扩大，尤其是偏于一侧的骨质变薄和扩大，在扩大一侧一般没有新生骨。

四、软骨瘤 软骨瘤也是一种常见的发生于骨体内部的良性肿瘤，含有透明的成熟软骨。它只发生于软骨起源的骨骼，可以是孤立的，也可以是多发的。如发生于髓腔内的软骨瘤，称内生软骨瘤；多个骨体内有软骨性新生物，且软骨发育障碍称多发性内生软骨瘤病（Olljer 病），后者有起自骨的内部，也有来自骨膜，并穿入骨体，50%易恶变。

临床表现

(1) 孤立性内生软骨瘤（单发性）：多发生于指骨、掌骨或跖骨等短管状骨，偶发于长管骨等。起源于骺端，从干骺端开始波及整个骨干，甚至侵入髓。软骨瘤生长缓慢，一般无明显症状，仅在摄片时偶然发现。浅表的软骨瘤可表现为局部肿块，表面平滑，质地坚硬，有轻度压疼，很少影响关节功能，往往受伤后，疼痛才变为明显。病理性骨折有时是最早体征，促使病人及时就医，若无病理性骨折，而肿瘤增长迅速和疼痛者，应警惕恶变可能。

X 线表现：在骨干内有一椭圆形骨疏松区阴影，病变处于骨干中央时，骨皮质膨胀不明显；若处于一侧则可使皮质变薄而明显膨胀。骨疏松但可呈云雾状，其间可出现间隔或点状密度加深，有钙化和骨化病灶。位于肩胛骨、骨盆、肋骨，可产生局限性溶骨性破坏，骨质有不同程度的扩张和膨胀，原有皮质变薄。

(2) 多发性内生软骨瘤病：主要症状为肿瘤部位变形及影响肢体发育而产生的畸形，Olljer 氏命名为“软骨发育障碍”故有人称为 Olljer 病。症状的出现根据病损的部位以及波及的范围而定。上肢的症状主要有手指逐渐肿胀，前臂呈弓形，手向尺侧倾

斜，前臂旋转受限。下肢的症状有呈骨隆起，膝外翻，跛行，主要由于股骨和胫骨发育障碍所致。除软骨瘤外还可出现骨骼外病变，即指内生软骨瘤病伴有血管瘤者，并有静脉扩张和静脉石，称为 Maffucci 综合征。

X 线表现：多发性内生软骨瘤病的 X 线表现与孤立性是相同的，只是较多的骨骼受累而已。

五、骨瘤 骨瘤是骨膜性成骨过程中异常，而引起组织过度增殖所形成的一种罕见的良性肿瘤。大多单发在颅骨或下颌骨，有时长入副鼻窦内。发生于长骨的应与带有表面软骨帽骨化的骨软骨瘤、外伤性骨化或骨疣作鉴别。它多发于 25 岁以前，性别无差异。

临床表现：常见的是颅骨表面有一体积小的块物，多数无任何症状，体积较大的可使头面部不对称。若向颅内发展，可构成占位性病变，产生头痛，甚至可引起灶性癫痫。若发生于眼眶可出现眼球突出，视力改变。若发生于鼻窦内，可影响引流，产生鼻窦炎。

检查时，可摸到硬如坚石的小丘样突起，无压痛，与头皮无粘连，头皮可在其表面滑动。

X 线表现：X 线片显示为骨的密度增深，呈圆形或椭圆形。周围无明显反应。用分层摄影额窦，可以清晰地看到骨瘤突入副鼻窦内。颅骨的骨瘤可用切线位片来显示，可以看到它起源于外板，向外方隆起。

六、软骨肉瘤 软骨肉瘤是起源于软骨细胞的恶性骨肿瘤，全身任何软骨内化骨的骨骼均可发病。在原发性恶性骨肿瘤中，发病率仅次于骨肉瘤。

多数软骨肉瘤始于正常骨骼，一开始就可有恶性特征，称为原发性软骨肉瘤，尚有些软骨肉瘤起于良性肿瘤或其他骨病，如软骨瘤、骨软骨瘤、畸形性骨炎等，这称为继发性软骨肉瘤。按肿瘤发生的部位，可分为中央型软骨肉瘤和周围型软骨肉瘤：前

者起自髓腔，为骨皮质所包裹，或穿破骨皮质而向周围软组织扩展；后者起自骨表层，然后侵及骨皮质和周围软组织。

临床表现：软骨肉瘤的发病率占原发性恶性骨肿瘤的14.2%，中央型多于周围型，男多于女，发病年龄的幅度较广，多在11~50岁之间，20岁以下者极少见。原发性软骨肉瘤的发病年龄较低，而继发者则偏高。好发部位位于股骨下端、胫骨上端、股骨上端、肱骨上端。其它如髌骨、肋骨、跟骨、肩胛骨、耻骨均可发生。而且可跨越关节，累及相邻骨。除多发性内生软骨瘤病的恶性变病灶外，软骨肉瘤很少发生于短管状骨。

局部疼痛为主要症状，早期可能为间歇性。患骨被扩张或穿破后，局部可摸到肿块，肿块质硬。表面皮肤很少发红，局部温度也不高。原发性软骨肉瘤的病程较短，症状较重，表现为局部剧烈疼痛和肿块。由于肿瘤生长迅速，病人可很快出现恶病质。继发性软骨肉瘤往往是由良性软骨肿瘤的演化而来，所以症状进程缓慢，较轻，往往被忽视，病程可达数年，甚至数十年。一旦恶变，症状较明显，肿瘤生长迅速，近关节的肿瘤常影响关节活动，髌骨或髌骨的巨大软骨肉瘤可压迫盆腔器官，引起相应症状。

X线表现：根据不同的病理变化，可有很大差异。发病过程的原发性中央软骨肉瘤，可见髓腔扩大，骨皮质破坏，骨膜反应及新骨生成，出现Codman三角，若病程短，进展速者，可见骨质明显破坏，并有软组织阴影。干骺端的肿瘤可破坏松质骨，发生囊性变，出现透亮的囊性破坏区。在囊变区内，有散在的钙化斑点或絮状斑片。

继发性软骨肉瘤，多有良性肿瘤的典型X线表现，即使恶变之后，仍可分辨出原有的典型变化。在良性病变基础上，可见溶骨性破坏，不规则的骨膜反应，明显的软组织肿块阴影或广泛不规则的钙化区。

【治疗】

一、辨证施治

(一) 阴寒凝滞型

【主证】骨瘤初起，酸楚轻痛，局部肿块，皮色不变，压痛不著，甚至不痛，病程较长。舌淡，脉细沉迟。

【分析】本型多为骨肿瘤初起或良性骨肿瘤，肿物逐渐增大，但并无热象，属于“骨疽”一类阴症。阴寒入骨，多因体虚之人，三阴不足，寒邪乘虚入骨阻络，凝滞为瘤。故见局部肿块皮色不变，压痛不著，舌淡，脉细沉等症。

【治则】温阳开凝，通络化滞。

【方药】阳和汤加减，常用熟地 30g，麻黄 1.5g，白芥子 6g，肉桂 3g，生甘草 3g，炮姜 1.5g，鹿角胶 10g，补骨脂 20g，路路通 10g，威灵仙 30g，透骨草 15g，川草乌 2g。

【方解】阳和汤源于《外科全生集》，方中鹿角胶、熟地滋阴补血，兼补阳气。配肉桂、姜炭入营血温阳散寒以通滞，生甘草解毒，白芥子祛除皮里膜外之痰；麻黄开发腠理，引导寒毒之邪外解。加川草乌以逐寒，补骨脂、透骨草入骨祛邪，路路通、威灵仙通络祛痰。诸药共奏和阳解凝散滞之功。

【加减】本型局部可外敷阳和解凝膏。尚可配合小金丹、犀黄丸内服。

(二) 毒热蕴结型

【主证】病变局部疼痛，肿胀，肿块迅速增大，局部温度较高，皮色正常或变青紫瘀暗，肢体活动障碍，精神倦怠，食纳不香，口干渴，便干结，尿短赤，舌质红，苔薄黄或厚黄，脉弦数或弦细数。

【分析】本型多见于骨肉瘤等恶性骨肿瘤，邪毒阻滞骨络，气滞血瘀，故见疼痛，肿胀和肿块，皮色青紫等。邪毒化火灼伤营血，耗伤阴液故见便干、尿短赤、舌质红脉弦数。邪毒郁滞影响气机运化使脾胃运化失常，而见精神倦怠，食纳不香等症。

【治则】清热凉血，解毒消肿，化瘀散结。

【方药】消毒化瘀汤加减。常用银花藤 30g，刘寄奴 15g，蒲公英 30g，黄柏 15g，肿节风 30g，徐长卿 20g，黄芩 10g，土鳖虫 10g，天花粉 20g，乳香、没药各 5g，当归 10g，透骨草 30g，赤芍 10g，生甘草 3g，龙葵 30g。

【方解】方中银花藤、公英、黄柏、肿节风、黄芩、天花粉、龙葵等大剂清热解毒凉血；徐长卿、刘寄奴、土鳖虫、乳香、没药、当归、赤芍活血化瘀止痛消肿；透骨草入骨搜毒威灵仙化瘀祛湿；生甘草调和诸药。

（三）湿毒留滞型

【主证】身困倦怠，四肢乏力，虚肿，病变局部肿胀疼痛，或破溃流液，便溏，舌体胖，舌质淡暗，苔白滑腻，脉滑。

【分析】本型亦为某些恶性肿瘤后期出现恶病质过程中，病久伤气耗血，阴阳俱虚，湿毒侵袭体内，阻滞气机运行，影响脾胃的运化，湿与痰互结，痰凝成核，成块或流注于体表，或流注于筋骨，流注筋骨则为骨疽。体内阳虚湿盛，故见身困乏力，倦怠、虚肿；邪毒化筋腐骨，正虚不能祛邪外出，故见肿块破溃流液。便溏、舌体胖，质淡暗，苔白滑腻脉滑均为湿毒不能外解之症。

【治则】益气健脾利湿，解毒止痛散结。

【方药】六君子汤加减。常用党参 15g，白术 10g，茯苓 15g，陈皮 15g，半夏 10g，南星 10g，白芥子 10g，当归 15g，苡仁 30g，制乳没各 10g，忍冬藤 30g。

【方解】六君子汤源于《和剂局方》，功主补气健脾。本方中党参补肺脾之气以助正气，白术、茯苓健脾除湿；陈皮、半夏行气燥湿。加苡仁以增强利湿之功，加南星、白芥子解毒化痰散结，当归、制乳、没行气活血消肿止痛，忍冬藤祛湿通络止痛。

（四）瘀血内阻型

【主证】面色晦暗，唇暗紫，肿瘤所在部位持续疼痛，肿块固定不移坚硬，表面肤色暗紫或血管曲张，舌质紫暗或有瘀斑

点、脉涩或弦细。

【分析】本证的辨证要点是血瘀所致积症，阻于骨。或气滞、或寒凝、或损伤均可致血瘀筋骨，结聚成瘤，故见面色晦暗，肿块疼痛而坚定不移，舌质暗，脉涩或弦细等症。

【治则】活血散瘀，软坚散结。

【方药】身疼逐瘀汤加减，常用桃仁 10g，红花 10g，当归 15g，川芎 10g，丹皮 10g，延胡 15g，制乳没各 10g，补骨脂 10g，赤芍 15g，土鳖虫 30g，香附 10g。

【方解】本方由《医林改错》血府逐瘀汤化裁而来，方中桃仁、红花、赤芍、川芎、当归、丹皮，功主活血化瘀，延胡、制乳没、香附行气导滞消肿止痛，土鳖虫软坚化瘀通络，补骨脂温阳补肾。诸药相合共奏活血化瘀，散结止痛之功。

（五）肾虚火郁型

【主证】局部肿块肿胀疼痛，皮色暗红，疼痛难忍，朝轻暮重，身热口干，咳嗽、贫血消瘦，行走不便，全身衰弱，舌质暗淡，苔少或干黑，脉涩或细数。

【分析】本型多见于恶性骨肿瘤晚期。病机要点是阴虚肾亏火毒郁结。久病不愈，耗阴伤血，肾阳亏损，正虚邪盛，故见肿块肿胀，皮色暗红，疼痛难忍，朝轻暮重，全身衰弱之象。

【治则】滋肾填髓，降火解毒。

【方药】寄生肾气丸加减。常用生地 20g，山萸肉 15g，女贞子 30g，桑寄生 30g，补骨脂 15g，骨碎补 15g，透骨草 20g，自然铜 10g，川断 15g，当归 15g，黄柏 10g，知母 10g，肿节风 30g，核桃树枝 30g，寻骨风 15g。

【方解】本方由肾气丸化裁而来，以生地、山萸肉、女贞子、丹皮、黄柏、知母滋阴降火解毒；桑寄生、骨碎补、自然铜、川断强肾续骨，加当归行血祛瘀养血补血。透骨草、肿节风、寻骨风、核桃树枝祛湿通络活血止痛。以减轻症状延以时日。

（六）气血双亏型

【主证】局部肿块漫肿，疼痛不休，面色苍白，神淡，消瘦乏力，心慌气短，动则自汗，胃纳不香，舌质淡红，脉沉细或虚弱。

【分析】本型亦为恶性骨肿瘤后期，病机要点是气血两亏，久病不愈，耗气伤血，邪盛与气虚血虚并见，病邪日盛，故见肿块漫肿不消，疼痛不休；气虚可见消瘦乏力，心慌气短，动则自汗，胃纳不香等症；血虚则面色苍白色淡，舌质淡红，脉沉细或虚弱之症。

【治则】益气养血，调补阴阳。

【方药】八珍汤加减，常用党参 10g，白术 10g，炙黄芪 10g，炙甘草 6g，陈皮 10g，肉桂心 10g，当归 10g，熟地 9g，五味子 9g，远志 8g，茯苓 9g，白芍 10g，生姜 10g，大枣 5 个。

【方解】八珍汤源于《正体类要》，方中以四君子汤补气健脾，以四物汤养血调血，加黄芪、大枣增强补养气血之功；肉桂心、五味子调阴补阳，陈皮、生姜、远志行气温中安神。炙甘草调和诸药，共达补气养血之效。

【按语】 我们根据临床征象，与参考文献资料，将骨肿瘤分为六个证型，以便从整体上把握骨肿瘤的辨证分型治疗。但是，由于骨肿瘤包括良性骨肿瘤、恶性骨肿瘤十数种，况且由于客观条件不同，患者个体差异较大，临床情况千变万化，以六个证型包括是不可能。因此，我们在临床上必须结合现代医学辨病，在诊断明确情况下，以辨证施治为原则，在以上证型的基础上，具体情况具体对待。

以上辨证分型治疗是一般常规用药，临床治疗时还要加入抗癌药物以增强抗癌祛邪作用。常用治疗骨肿瘤的抗癌中草药有：肿节风、半枝莲、凤尾草、马鞭草、土茯苓、白毛藤、徐长卿、七叶一枝花、乌头、鬼箭羽、鬼针草、桑枝、核桃树枝、独角

莲、补骨脂、全虫、蜈蚣、黄柏、山萸肉、土鳖虫、斑蝥。

在骨肿瘤的治疗过程中，恶性骨肿瘤的局部变化及全身影响是错综复杂的，治疗时必须把握好攻与补、扶正与祛邪的轻重关系。在良性肿瘤和某些恶性骨肿瘤的早期，肿瘤对全身影响较小，机体健壮，正与邪相比，好比敌强我弱，此期相当于阴寒凝滞型、血瘀内阻型或热毒蕴结型，对此期病人，应当综合各种抗癌疗法，集中优势兵力攻邪（瘤），但在治疗中针对病人存在着本虚的一面又要照顾到正气，故采取以攻为主，攻中有补的治疗原则。而湿毒留滞型，肾虚火郁型及气血双亏型则多见于恶性骨肿瘤的晚期，此期，肿瘤已发展到严重阶段，身体明显虚弱，呈邪盛正虚状态。因此，对于此期病人当以大补小攻，即扶正为主，攻邪为辅，借以增强病人体质，提高抗病能力。即便晚期病例，也可延长生命，因此，在临床中我们一定要从整体观念出发，以中医辨证为主，参合辨病，以取得更好的抗癌疗效。

二、验方、成方（药）

（一）验方

1.海藤丸：海藻 30g，昆布 30g，全蝎 10g，桂枝 30g，山豆根 30g，鸡血藤 60g，补骨脂 60g，威灵仙 60g，当归 60g。共研细粉，水泛为丸如绿豆大，开水送下。功主活血化瘀，软坚散结，消肿止痛。用于上肢各部位肿瘤。每次服 3~10g，一日三次。

2.藤枯汤：桂枝 12g，夏枯草 30g，姜黄 15g，三棱 12g，当归 15g，同蒺藜 12g，生牡蛎 30g，丹参 30g，丝瓜络 20g，鸡血藤 30g，料姜石 60g。功同海藤丸多用于上肢骨肿瘤。每日一剂水煎分两次服。

3.海豆丸：海藻 30g，昆布 30g，全蝎 10g，山豆根 30g，川牛膝 60g，补骨脂 60g，威灵仙 60g，焦杜仲 60g，鸡血藤 60g，乌蛇 30g。共为细粉，水泛为丸，如绿豆大，每次服 3~10g，一日三次，开水送下。功主补肾养血，活血化瘀，散结通络，消

肿止痛，多用于下肢各部位骨肿瘤。

4. 莪膝汤：山豆根 10g，同蒺藜 15g，生牡蛎 30g，全蝎 10g，川牛膝 12g，蓬莪术 15g，当归 15g，补骨脂 30g，丝瓜络 20g，乌蛇 10g，生甘草 3g，一剂药煎两遍，合在一起，分两次服。功同海豆丸，多用于下肢。

5. 灵骨汤：五灵脂 10g，地龙 12g，补骨脂 30g，骨碎补 15g，蜈蚣 2 条，川牛膝 15g，透骨草 30g，桂枝 12g，乌蛇 10g。煎服法同上。功主疏风通络，温阳解凝，补肾益精，解毒消肿，坚骨止痛，软坚散结。用于阴毒壅滞于下肢各部位肿瘤。

6. 透仙汤：红蓼子 10g，虻虫 10g，刘寄奴 30g，透骨草 30g，地龙 12g，柳枝 30g，蓬莪术 15g，威灵仙 30g，乌蛇 10g，料姜石 60g。煎服法同上。用于上肢之气滞血瘀，毒热蕴结型骨肿瘤。

7. 寄补汤：补骨脂 30g，骨碎补 15g，郁李仁 30g，透骨草 30g，猪苓 60g，生地 30g，桑寄生 15g，蜂房 10g，全蝎 10g，乌蛇 10g，薏苡仁 30g，功用补肾填髓，活血化瘀，扶正止痛，用于肾虚髓伤，火毒瘀结之骨肉瘤。

8. 逐血破瘀汤合散结灵：水蛭 6g，虻虫 6g，地龙 10g，虻虫 6g，黑丑 6g，紫草 10g，透骨草 20g，路路通、水红花子 10g，盘龙参 10g，莪术 10g，刘寄奴 10g，威灵仙 20g，血竭 10g，徐长卿 20g，上药煎汤送服散结灵，用于气滞血瘀，毒热蕴结于上肢之骨肉瘤。

9. 小金丹合三骨汤加减：草乌 10g，川乌 10g，五灵脂 10g，地龙 10g，乳香 6g，木鳖子 15g，没药 6g，骨碎补 30g，补骨脂 30g，透骨草 30g，蜈蚣 6g，干蟾皮 15g，白屈菜 20g，木瓜 10g，防己 10g，牛膝 10g。用于阴毒壅滞之骨肉瘤初期。

10. 治骨肉瘤验方：野牛腿骨 100g，虎骨 10g，龙骨 30g，猴骨 15g，骨碎补 15g，黄精 10g，煎汤服。

(二) 成方(药)

1.平消片：枳壳 30g，火硝 18g，五灵脂 15g，郁金 18g，白矾 18g，仙鹤草 18g，干漆 6g，制马钱子 12g。共为细粉，水泛为丸。每次服 1.5~6g，一日三次，开水送下。

2.金星散：郁金 20g，白矾 20g，火硝 20g，重楼 20g，蟾酥 3g，红砒砂 6g，鸡蛋壳 30g，料姜石 30g，仙鹤草 30g，天南星 30g，共为细粉，每次服 1~6g，一日三次，开水送下。

3.化瘀丸。每次 1 丸，每日两次，温开水送下。

4.云南白药：每次 1~2g，每日两次，温开水送下。

5.犀黄丸。每次 1 丸，每日两次，温开水送服。

6.小金丹。每次 1~2 丸每日早晚各一次。

7.六味地黄丸。每次 1 丸，每日两次，温开水送服。

8.肾气丸。每次 1 丸，每日两次，温开水送下。

9.喜树碱制剂。①喜树碱片：每次服 5~6 片，每日 3 次。②喜树碱注射液：每日一次，每次 10mg，肌肉注射。

10.核桃树枝注射液：尤其是青龙衣注射液适用于骨肿瘤。

11.癌敌注射液：肌肉注射，每日 2 次，每次 10~20ml。

12.三棱莪术注射液：肌肉注射，每次 2ml，每日二次。

【按语】验方和成方的应用，虽然其是古人或今人在临床上总结出来的有效方药，但是肿瘤病人，病情复杂，必须结合临床具体情况，辨证加减配合使用。

三、中西医结合治疗

(一) 中医药与手术治疗相结合 目前，骨肿瘤的治疗，仍以手术治疗为首要治疗手段，良性骨肿瘤以病灶刮除术、整块切除术以及合并植骨术为主达到根治。恶性骨肿瘤则以截肢术为主。如把手术疗法和中医药治疗结合起来，可明显提高疗效。例如某些良性骨肿瘤单纯利用中医药内服兼外敷就可起到消除肿瘤的效果，某些易复发的肿瘤，配合术后服中药可防止复发。恶性骨肿瘤术前运用中医药辨证治疗可改善症状，增强体质，提高病人的抗病能力，缩短术后恢复期，减少术后并发症和后遗症。术

后用药，可提高免疫功能，改善生存质量，减少复发率和转移率，提高远期生存率。

笔者在临床中曾运用中医辨证治疗配合手术治疗数例骨肉瘤病人。骨肉瘤患者一旦确诊即到中晚期，体质较差，术后极不易恢复，首先表现为刀口不愈合，其次为体质经手术创伤后越来越衰弱，给以后的化疗造成不利因素。而笔者术前运用中医药以益气活血，化瘀解毒为主以增强体质，改善瘤体的局部环境。术后早期以清热解毒利湿，佐以活血化瘀配合大剂量抗感染治疗，后期则以养血活血配合大剂量抗感染治疗，均获很好疗效，所有病人手术切口均一期愈合，况且后期体质恢复良好，为早日化疗打下了良好基础。

（二）中医药与化疗相结合 近年来，由于大剂量使用化学药物治疗恶性骨肿瘤，使骨肿瘤的治疗有了很大进展。但是，也带来了一些麻烦，化学药物不仅能杀死和抑制癌瘤组织，也能损伤正常机体组织，出现明显的毒副反应。致使一些体质较弱的患者不能承受化疗，而被癌瘤早日夺去生命。如果将化疗与中医药结合起来，就可明显提高疗效，减轻化疗毒副反应，改善生存质量。

（三）中医药与放疗相结合 骨肿瘤对放射线敏感性各有不同。尤文氏肉瘤、骨原发性网织细胞肉瘤、多发性骨髓瘤、嗜酸性肉芽肿、动脉瘤性骨囊肿等对放射线敏感性较高。而骨肉瘤、软骨肉瘤、纤维肉瘤等则不敏感。但有时亦可控制发展。放疗时配合中医药治疗是非常有益的，有初步研究证明部分中药有放射增敏作用。同时，中医药治疗可减轻放疗副反应，增强体质，改善生存质量。

六、综合治疗 综合治疗可大幅度地提高骨肿瘤的临床疗效。目前较为广泛应用的综合治疗方案如下：

1. 外科治疗+化疗（放疗）+中医药治疗。
2. 中医药治疗+化疗+外科治疗+化疗+中医药治疗。

3.对已不能手术者：中医药治疗+化疗+放疗+中医药治疗或生物治疗。

第二十八章 肿瘤常见症状的治疗

第一节 癌痛的治疗

一、中医学对癌痛的认识及治疗 中医学认为，疼痛作为一个自觉症状无论癌痛或是其他疾病引起的疼痛，其病机都有一定的共性。《素问·举痛论》云：“经脉流行不止，环周不休，寒气入经而稽迟，泣而不行，客于脉外则血少，客于脉中则气不通，故卒然而痛”。指出了邪气阻滞经脉，气血瘀阻不通，是导致包括癌痛在内的各种疼痛的基本病机，即所谓的“不通则痛”。《素问·脏气法时论说》：“虚则胸中痛，大腹小腹痛”。说明气血阴阳亏虚，不能濡养温煦脏腑、经络等组织器官，也可引起疼痛，可称之为“不养则痛”。现将导致癌痛常见的病因病机、治疗大法等归纳如下。

（一）癌痛的病因病机

1. 风寒侵袭 “风为百病之长”，古代医家认为风寒侵袭会导致癌痛。如《诸病源候论》在论述类似骨肿瘤的“贼风候”时说：“此风至能害于人……伤风痛则骨解痛深，按之乃应骨痛”。风寒侵袭引起癌痛，往往与机体正气亏虚，或素有痰饮、瘀血有密切关系。如《诸病源候论》在记述包括腹腔肿瘤在内的“积聚”时说：“积聚者，由阴阳不和，脏腑虚弱，受于风邪，搏于脏腑之气所为也”。《金匱翼》更明确指出：“积聚之病，非独痰、食、气血，即风寒外感，亦能成之。然痰、食、气、血，非得风寒未必成积；风寒之邪不遇痰、食、气、血亦未必成积。”

风寒侵袭人体某一部位，或直入脏腑，久留不去，导致气血津液淤阻不通，或与体内素有之瘀血、痰饮相搏结，瘀阻经络气血，从而引起癌痛。如风寒犯脑则头痛；侵及筋骨则肢体骨络

痛；直入脏腑则为胸痛，或为腹痛。

2. 火热蕴积 火热蕴积引起的癌痛，有外感火热所致者。如《素问·至真要大论》记述类似肺癌伴淋巴结转移时说：“少阴司天，热淫所胜……民病胸中烦热，嗌干，右胁胀满，皮肤痛，寒热，咳喘，唾血……肩背臂臑及缺盆中痛”。但最多见的则是因情志不遂，气郁化火，或嗜食辛辣厚味、热烫食物等内生火热所致。如《证治汇补》在论述噎膈（食管癌）病因时说：“有气滞者，有血瘀者，有火炎者，有痰凝者，有食积者，虽有五积，总归七情之变，由气郁化火”。《外科正宗》在论述类似直肠癌的“脏毒”病因时也说：“脏毒者，醇酒厚味……情性暴急，纵食膏粱，或兼补术，蕴毒结于脏腑，火热流注肛门”。

火热蕴积，壅遏气机，煎凝津血，腐灼脏腑经络，从而导致癌痛。火热上壅清窍则头痛；积于胸肺则胸痛；蕴于肝胆则胁痛；结于胃肠则脘痛；流注筋骨则肢体骨节痛。

3. 痰饮凝结 痰饮的生成与脾、肺、肾、肝诸脏功能失调有密切关系。饮食失节，劳倦过度，脾气损伤，健运失职则痰饮内停；外邪袭肺，或肺气亏虚，宣肃失职，水道不调，水津不布则聚为痰饮；禀赋不足，或房劳伤肾，肾气亏虚，蒸化无权，水不化气则停而为饮；情志不遂，肝郁气滞，津液流行受阻，亦可聚为痰饮。此外火热蕴积，也可灼津为痰。

痰饮生成之后，随气流行，无处不到，但必遇正虚之处而停聚。痰饮聚结则痹阻气机，瘀遏血行，痰气血相互搏结，从而导致癌痛。痰饮上逆于脑则头痛；停积胸膈则胸痛；结聚肠胃则脘腹痛；郁结肝胆经脉则胁肋、耳前后、缺盆中痛；流注筋骨则肢体关节骨节痛。

4. 气机郁结 气机郁结是导致癌痛的重要病机。正如《丹溪心法》所说：“气血冲和，万病不生，一有怫郁，诸病生焉。故人身诸病，多生于郁”。《灵枢·百病始生篇》在论述类似腹腔肿瘤疼痛的“积”证时也说：“若内伤于忧怒则气上逆，气上逆则六输不

能……而积皆成矣”。

气机郁结癌痛的病因，主要是情志刺激，怒则气逆，思则气结，恐则气下，惊则气乱，忧愁则气机闭塞。气机逆乱郁结则血为之停，津为之滞，经络为之不能，气血津液结聚而不行，日久则导致各种癌痛。此外，风寒、痰饮、瘀血、火热等邪的阻滞，也会使气机不畅而郁结。气结于心肺则胸痛；聚结于肝胆则胁痛；郁阻于胃肠则脘腹痛；流窜于筋骨则肢体骨络痛。

5.血行瘀阻 血瘀癌痛的成因，或为情志不畅，气滞而血瘀，或因寒邪侵袭，寒凝而血滞；或为火热内蕴，热灼而血结；或为痰饮内停，阻遏血行；或为气虚血不运；或为出血而留瘀等。瘀血停积，脉络不能，聚结成块，从而导致癌痛。此外，脉络瘀阻之处，血液不能正常濡养该处组织，也是导致疼痛的一个因素。血瘀于脑络则头痛，瘀阻于心肺则胸痛；结聚于肝胆则胁痛；瘀阻于胃、肠、胞宫则脘腹痛；停滞于筋骨脉络则肢体痛。

6.阳气亏虚 导致阳气亏虚癌痛的成因，或为禀赋不足，素体阳虚；或为饮食不节，损伤脾阳；或为疲劳过度，阳气耗伤；或为病程日久而过服祛邪或寒凉药物而损伤阳气。阳气亏虚则经络失煦阴寒内盛则寒凝气滞；日久则血津痹停，脉络不通，从而导致癌痛。肺气亏虚或寒结上焦则胸痛；脾气虚或寒聚中焦则腹痛；肾气亏虚或寒凝于骨则骨痛；肾气不足或清阳不达于脑则头痛。

7.阴血失养 阴血亏虚，包括阴虚和血虚。《薛氏医案》在论述骨癌疼痛病机时说：“劳伤肾水，不能荣骨而成”；《医案已任篇》在论述包括胃癌在内的胃痛时也说：“凡胃脘痛，大便燥结者，肝血虚也”。说明阴血亏虚亦可引起癌痛。

禀赋不足，素体阴虚；五志过极，化火伤阴；嗜食辛辣，损伤脾胃；癌肿出血而伤血；火热内蕴而耗阴；病程日久而过服辛香温燥，及化疗、放疗而伤津耗液等，均可导致阴血亏虚，脏腑经络失养，从而出现癌痛。此外，阴血不足则虚热内生，虚热扰

灼则会使疼痛加重。肾阳不足，脑髓骨骼失养则头痛；肝络失养则胁痛；肝阳上亢则头痛；脾胃阴虚，胃络失养则胃脘痛。

上述病因病机，往往相互影响，交互并见，虚实错杂，如风寒而伴阳虚；火热而伴阴伤；气滞则血瘀痰停；血瘀则气滞不畅；痰结则血瘀气滞等。此外，古代医家认为，导致癌痛的病邪，每兼“毒”性，如风毒、热毒、寒毒、火毒、痰毒等，这也是与引起一般疾病的同类病却有不同之处。

（二）中医治疗癌痛大法 中医学对癌痛的治疗，并非仅仅立足于局部的止痛，而是强调整体观念，注重病因病机，即“辨证施治”、“审因论治”。如《古今医鉴》论述包括胃癌腹痛在内的治法时说：“是寒则温之，是热则清之，是痰则化之，是血则散之，是气则顺之”。《医学真传》也说：“夫痛则不通，通也，但通之之法，各有不同。调气以和血，调血以和气，通气；上逆者使之下行，中结者使之旁达，亦通也；虚者助之使通，寒者温之使通，无非通之之法”。癌痛治疗大法，就是针对癌痛病因病机而设的治疗方法。

1.祛风散寒止痛法 本法是针对风寒犯脑侵骨或直入于里而引起癌痛的治疗方法。寒性凝滞收引，故见侵袭，脉络蹇缩而不通，从而出现癌痛。风寒外袭，治当祛风散寒，但风寒所致的癌痛，其病位不在肌肤，而是犯脑侵骨或直入胃肠，所以本法常由祛风通络、散寒止痛、强壮筋骨等作用的药物组成。常用药物为川乌、寻骨风、川芎、细辛、白芷、乌蛇、蜈蚣、僵蚕、乳香、没药、羌活、白附子、桂枝等。

2.清热解毒止痛法 本法是针对火热毒邪内蕴引起癌痛的治疗方法。火热毒邪蕴结，腐灼脏腑经络，壅遏气机，煎凝津血，从而导致多种部位的癌痛。《素问·至真要大论》云：“治热以寒”、“热者寒之”，故清热解毒止痛多用寒凉类药物，常用药物为半枝莲、半边莲、石上柏、白花蛇舌草、七叶一枝花、龙葵、石见穿、连翘、苦参、石膏、黄芩、黄连、黄柏、栀子、青黛、羚

羊角、龙胆草等。

3.化痰散结止痛法 本法是针对痰饮聚结癌痛的治疗方法。痰饮内停，阻遏气机，瘀阻血行，痰气血相互结，凝聚成块，从而引起癌痛。《素问·至真要大论》云：“结者散之”“坚者削之”，故化痰散结止痛法多由豁痰散结、软坚逐饮类药物组成。常用药为半夏、南星、天竺黄、皂荚、白芥子、葶苈子、橘红、贝母、瓜蒌、海浮石、海蛤、白矾、青礞石、雄黄、桔梗、大戟、甘遂、芫花、山慈菇、白附子、五倍子等。

4.理气止痛法 本法针对气机郁结癌痛的治法。气机郁结则血行滞涩，津停为痰，气血痰互相搏结，经络不通，从而引起多种癌痛。气结则疏之行之，本法常用理气行气类药物。常用药物为青皮、陈皮、郁金、沉香、木香、枳实、枳壳、香附、香橼、八月扎、乌药、川楝子、佛手、厚朴、姜黄等。

5.活血化瘀止痛法 本法是针对血行瘀阻癌痛的治疗方法。血行瘀阻，脉络不通，瘀结成块，从而引起各种癌痛。《素问·至真要大论》云：“留者攻之”“结者散之”，故活血化瘀止痛法常用化瘀散结、活血通络、逐瘀生新类药物。常用药物为桃仁、红花、丹参、赤芍、三七、当归、川芎、水蛭、虻虫、虻虫、穿山甲、三棱、丹皮、乳香、没药、灵脂、泽兰、干漆、血竭等。

6.温阳益气止痛法 本法包括温阳祛寒和补益元气两种方法，是针对阳虚寒盛或元气亏虚所致癌痛的治疗方法。《素问·至真要大论》说：“损者益之”；《素问·三部九候论》说：“虚则补之”。故温阳益气止痛法常用温阳祛寒、温补脾肾、补益脾肺、益气升清类药物。常用药物为人参、党参、白术、茯苓、山药、甘草、大枣、附子、干姜、川椒、吴茱萸、黄精、黄芪、丁香、鹿茸、巴戟天、仙茅、淫羊藿、蟾酥、干蟾皮、冬虫夏草、紫河车、肉桂、菟丝子、破故纸、肉苁蓉等。

7.滋阴养血止痛法 本法包括滋阴清热和养血补血两种治法，是针对阴虚内热或血虚癌痛的治疗方法。阴血亏虚，脏腑经

络失养，从而导致癌痛。滋阴养血止痛法常由滋阴补肾、育阴潜阳、清养肺胃、养血补血类药物所组成。常用药物为生地、玄参、熟地、麦冬、天冬、石斛、沙参、西洋参、当归、白芍、首乌、阿胶、生龙骨、生牡蛎、珍珠、玉竹、百合、桑椹子、旱莲草、女贞子、龟板、鳖甲、花粉、苇根等。

（三）癌痛的辨证论治

1. 风寒侵袭证

【症状】疼痛多呈冷痛，局部皮色不变，四肢不温，遇风寒或进冷食后加重，遇热则减轻，舌质淡暗，苔白，脉沉紧。

【治法】祛风散寒，理气止痛。

【方药】良附丸加减。高良姜 12g，香附 15g，川椒 6g，厚朴 15g，白术 30g，玄胡 15g。

2. 火热蕴结证

【症状】疼痛多呈灼痛、胀痛，局部肿胀，大便秘结，发热口渴，出血，舌质红，苔黄，脉数。

【治法】清热生津，解毒止痛。

【方药】当归龙荟丸加减。当归 15g，龙胆草 15g，芦荟 9g，栀子 9g，黄连 9g，黄柏 9g，黄芩 9g，大黄 12g，木香 6g，青黛 6g。

3. 痰饮互结证

【症状】疼痛重着，局部肿胀，日轻夜重，口渴不欲饮，舌体胖大，苔腻，脉滑。

【治法】化痰散结，理气止痛。

【方药】海藻玉壶汤加减。海藻 30g，海带 30g，陈皮 12g，青皮 12g，半夏 15g，贝母 15g，当归 30g，川芎 12g，夏枯草 15g。

4. 瘀血内阻证

【症状】疼痛如针刺，痛处不移，皮色晦暗，肌肤甲错，面色晦暗，口唇及舌质紫暗，有瘀点瘀斑，脉细涩。

【治法】活血化瘀，散结止痛。

【方药】桃红四物汤加减。桃仁 9g，红花 12g，当归 30g，川芎 9g，生地 15g，赤芍 30g，五灵脂 15g，蒲黄 15g，三棱 15g，莪术 15g。

5. 阳气亏虚证

【症状】疼痛多呈冷痛或隐痛，喜温喜按，遇寒遇劳疼痛加重，面色㿔白，四肢不温，舌体胖大，色淡，脉沉迟。

【治法】温阳益气，理气止痛。

【方药】乌头赤石脂丸加减。乌头 1~3g（先煎），川椒 9g，附子 9g，干姜 6g，赤石脂 12g，白术 30g，党参 30g，厚朴 15g。

6. 阴血失濡证

【症状】疼痛多呈持续性隐痛或灼痛，遇热痛甚，五心烦热，口干舌燥，盗汗，舌质红，苔少或无苔，舌面干燥，脉沉细数。

【治法】滋阴清热，养血止痛。

【方药】左归丸加减。生地 15g，山药 15g，山萸肉 15g，枸杞子 15g，菟丝子 15g，阿胶 12g，牛膝 15g，沙参 30g，丹皮 30g，地骨皮 30g。

（四）癌痛的中成药选用

1. 片仔癀片：本品具有较好的清热解毒、消肿止痛之效。对于癌痛患者表现为毒热壅盛者较为合适，本药为散剂。每块重 3g。每次服 0.6g。每日 3 次。

2. 犀黄丸：主要药物为牛黄、乳香、没药等。具有较好的清热活瘀、通经止痛的功效。对于癌痛表现的瘀热互结者较为适宜。本药为糊丸，每瓶装 3g，约 10 粒，每次服 3g，每日 2 次，温开水或黄酒送服。

3. 一粒止痛丹：方中有披麻草、独丁子、没药、乳香等。具有较好的活瘀止痛功效，用于瘀血阻滞的癌痛较为适宜。本药为水丸。每 10 粒重 1.6g，每次服 1 粒，每日 3 次。或癌时服 1 粒

(但 2 次服药间隔必须 4 小时以上)。孕妇忌用。

4. 小金丹：主要药物为制草乌、木鳖子、五灵脂、白胶香、地龙等。具有温经散寒，活瘀止痛之功效。对于寒温阻滞，瘀血阻络的疼痛较为适宜。本药为糊丸剂，每粒 0.6g，每次 1 粒，捣碎，温黄酒送下，每日 2 次。

5. 高乌甲素：本品是从毛茛科植物高乌头中提取的生物碱，有较好的镇痛作用。据实验室研究，其镇痛作用的强度相当于氨基比林的 7 倍，镇痛的起效时间较杜冷丁慢，但持续时间长。适用于各种疼痛。口服，每次 5mg，每日 3 次；肌注或静滴：每次 4~8mg，每日 1~2 次。

(五) 癌痛的中医外治法

1. 血竭膏

【药物组成】香油 150g，血竭 10g，松香 10g，羊胆 5 具，冰片 3g，麝香 3g，乳香 20g，没药 20g。

【制法】将香油煎沸，加松香溶后离火，均匀撒血竭粉于液面，以深赤色为度，再下羊胆汁，加至起黄色泡沫为止，待冷却加入冰片，麝香即成，摊在胶布上贴于痛处。

主治：上额窦癌痛（王佑民方）。

2. 癌痛散

【药物组成】山奈 2~g，乳香 20g，没药 20g，大黄 20g，姜黄 20g，栀子 20g，白芷 20g，黄芩 20g，小茴香 15g，公丁香 15g，赤芍 15g，木香 15g，黄柏 15g，蓖麻仁 20 粒。

【制法】诸药共为细末，用鸡蛋清调匀外敷。

【主治】癌痛散外敷乳根穴治疗肺癌痛；外敷期门穴治疗肝癌痛。（柯联才方）

3. 如意金黄散

【药物组成】大黄 50g，天花粉 100g，冰片 20g，黄柏 50g，生南星 20g，乳香 20g，没药 20g，姜黄 50g，皮硝 50g，芙蓉叶 50g，雄黄 30g。

【制法】上述诸药研为细末，加饴糖调成厚糊状，摊于油纸上，厚约3~5cm，略大于肿块，外敷癌痛处。

【主治】肝癌痛（方松韵报道）

4. 香松散

【药物组成】蜈蚣 10 条，生米壳 45g，陈橘皮 45g，硼砂 30g，蚤休 45g，全蝎 30g，乳香 30g，没药 30g，紫花地丁 45g，银珠 9g，麝香 1.5g。

【制法】上述药物各研细粉混匀。每次用乔麦面粉打成稀糊，调药粉，按疼痛部位大小，外敷于对侧（肝区部位的对侧）皮肤上，每敷 24 小时换药 1 次，或 2 日换药 1 次。

【主治】肝癌痛（贾坤方）。

5. 蟾酥膏

主要药物为蟾酥、生川乌、两面针、公丁香、肉桂、细辛、七叶一枝花、红花等 18 种中药制成中药橡皮膏。

【用法】外贴癌性疼痛区，每 24 小时换药 1 次，7 天为 1 疗程。

【主治】各种癌痛。（刘嘉湘报道）

6. 消岩膏

【药物组成】山慈菇 30g，土贝母 30g，五倍子 30g（瓦上炙透），独活 30g，生香附 30g，生南星 15g，生半夏 15g。

【制法】上述药物研为细末，用醋膏调成糊状，摊贴在肿块上，膏药摊贴范围略大于肿块，然后用胶布或橡皮膏贴上，每 24 小时换 1 次药。

【主治】乳腺癌痛。

7. 散结止痛膏

【药物组成】重楼、冰片、生川乌、夏枯草、生南星、白花蛇舌草。诸药加工制成膏药。

【主治】乳腺癌痛。

【用法】贴敷于乳房肿块处，每 1~2 天换 1 次药。

8.雄参膏

【药物组成】雄黄 15g, 白矾 15g, 硃砂 1g, 黄柏 30g, 乳香 15g, 没药 15g, 麝香 2g, 蟾酥 2g, 苦参 30g, 冰片 3g。

【制法】上述药物各研细粉混匀, 用蛋黄油调膏。

【主治】宫颈癌痛。

【用法】将药膏贴敷患处, 每日换药 1~2 次。(贾坤报道)

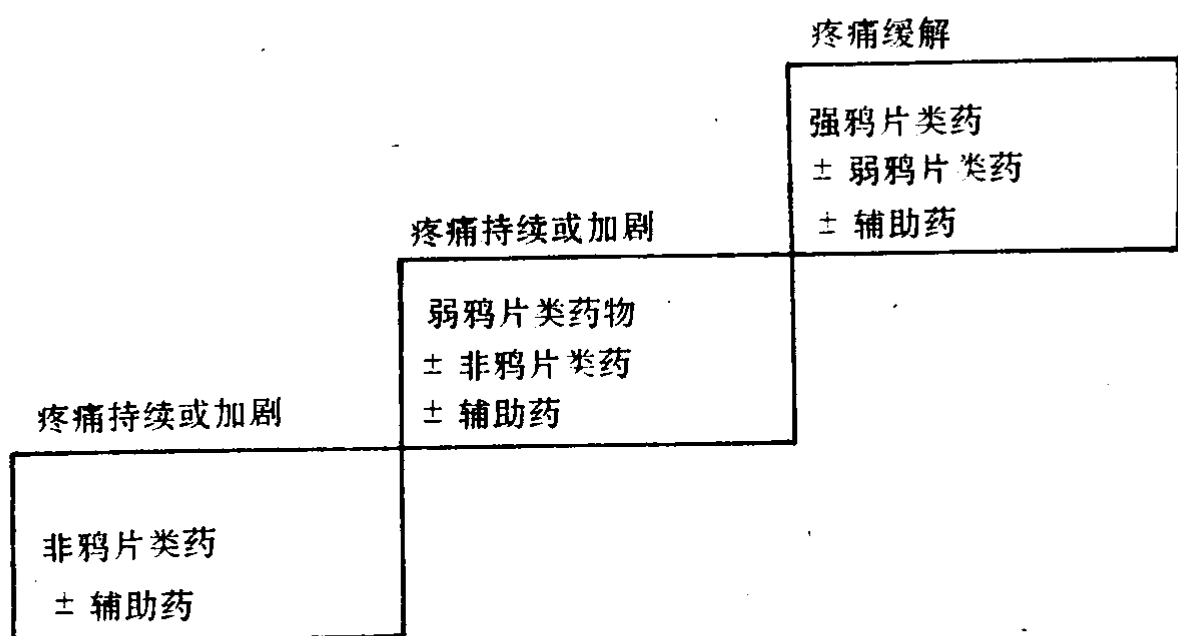
二、西医学对癌痛的认识及治疗

(一) 癌痛发生的机理 癌痛发生的机理主要有: ①癌本身引起。直接由癌肿压迫神经及邻近组织, 引起周围组织缺血、坏死; 癌细胞浸润到淋巴组织产生炎症和化学致痛物质。癌细胞转移到邻近骨组织导致病理性骨折。癌细胞侵入内脏和血管引起内脏梗阻、动脉闭塞、静脉瘀血、肿胀、刺激胸壁、腹壁、内脏包膜、血管壁层感受器而致痛。由癌本身生长扩展引起的疼痛占癌痛的 75%。②抗癌治疗引起。外科手术切除癌瘤时, 常切断或损伤神经而致疼痛; 化疗药物如长春新碱、长春花碱可导致末梢神经损伤, 出现手足麻木甚或疼痛; 放射治疗可使被放射区域的局部神经及神经周围连接组织发生纤维化, 使神经结构受到双重损伤而出现疼痛。此种疼痛占癌痛的 20%。③与癌瘤无关的其它伴发病引起的疼痛, 占癌痛的 5%。

(二) 癌痛的药物治疗 使用止痛药物是治疗癌症疼痛的主要手段, 如能使用正确的药物, 恰当的剂量, 并有恰当的间隔时间, 绝大多数患者都可获止痛效果。所用的主要药物是非鸦片类止痛剂、鸦片类止痛剂和辅助性药物。世界卫生组织提出的三阶梯疗法中的三个标准止痛剂主要是阿斯匹林、可待因和吗啡。医护人员还应熟悉一、两种可替代的药物以便用于那些不能忍受标准制剂的患者。同时, 还应了解如何应用辅助性药物。世界卫生组织提出癌痛治疗中两个重要的概念是“按时”、“按阶梯”用药。

按时用药: 根据所用止痛药物的药理作用及代谢时间, 有规律地按时给药 (而不是按需给药)。

按阶梯用药：将止痛药物从弱到强，配伍品种由少到多，逐渐向上，顺序用药，充分发挥药效相符作用，以缓解疼痛。



第1阶梯药物——非激素类消炎镇痛药。主要用于轻度或中度癌痛患者，代表药物是阿斯匹林，替代药物是扑热息痛（奈普生、消炎痛、布洛芬等同属此类）。

阿斯匹林

用法用量：250~1000mg，每4~6小时1次。

副作用及注意事项：可引起胃肠功能紊乱，甚至消化道出血，同时服用牛奶或抗酸药或饭后服，可减轻其副作用，每天剂量超过4g，只能增加副作用。

扑热息痛

如果患者不能耐受阿斯匹林，可用扑热息痛代替，每次500~1000mg，每4~6小时1次，总剂量每日2~6g。该药对肝脏有一定的影响。

第2阶梯药物——弱鸦片类止痛药。主要用于中、重度的癌痛。代表药物为可待因、右旋丙氧酚。

可待因

止痛效果强于阿斯匹林，次于吗啡。该药30mg相当于阿斯

匹林 650mg，约为吗啡的 $1/12 \sim 1/7$ 。

用法用量：口服 15~30mg/次，每日 3 次。极量：口服 100mg/次，每日 250mg。

右旋丙氧酚

每次 50~100mg，每日 2 次，口服。

第 3 阶梯药物——强鸦片类止痛药。用于重度癌痛病人，代表药是吗啡。本药的优点是使用得当，可使大多数癌痛患者缓解。缺点是用药后易产生依赖性，停药后出现戒断症状及耐药，重复用药时效果减低，只有增加剂量才能维持原来的止痛效果。

吗啡

用法用量：给药途径有皮下注射，口服，直肠给药，用量大小根据病人是否使用过鸦片类药物而定。如病人使用过弱鸦片类止痛药，首次剂量为 5~10mg，大多数需要 10mg，个别病人需要更多一些。若病人未使用过弱鸦片类止痛药，首次剂量为 5~30mg。

注意事项：①如果第 1 次给药后，病人处于极度嗜睡状态并已止痛，第 2 次用药应减少 50% 的剂量。如果给药后 24 小时仍未获得满意的止痛效果则应增加 50% 的剂量。②医生必须在给药 24 小时后重新检查病人，如果疼痛未获满意控制，或因给药引起不能耐受的症状，则应试用另一种强鸦片类药物，如果仍无效，则就考虑用非药物的方法治疗（放疗、神经阻滞术、神经外科手术）。

杜冷丁

作用机制：与可待因、吗啡相同，但比可待因强，比吗啡弱，约为吗啡的 $1/8 \sim 1/20$ ，止痛时间为 2~4 小时。

用法用量：口服、注射均可，每次 50~100mg。每 4 小时 1 次。最大量每日不超过 600mg。

强痛定

本药是近年来新推出的强力镇痛药，镇痛作用约为吗啡的

1/3，注射后 10 分钟见效，为速效镇痛药。对皮肤、粘膜和运动器官的疼痛有明显抑制作用，对内脏疼痛效果较差。

用法用量：口服，成人每次 60mg，每日 3~4 次；皮下注射，成人每次 50~100mg，每日 3~4 次，疼剧时用量酌增。

如果病人在癌痛的同时伴有忧郁过度或焦虑太甚，或出现闪电样或枪击样的疼痛，应加用辅助药，可加强止痛效果。

抗忧郁药：首选阿米替林。首次剂量 10~25mg，以后可增加到 50~75mg。

抗焦虑药：首选安定，每次 5~10mg，每日 3 次。

抗癫痫药：首先酰胺咪嗪，次选苯妥英钠。酰胺咪嗪：首次剂量每天 100mg，每 3~4 天增加 100mg。最大剂量为 400mg，偶可达 500~600mg。苯妥英钠：从每日 100mg 开始，以后逐渐增加 25~50mg，总剂量每日不超过 250~300mg。

（三）其它治疗方法

1.放射治疗止痛 主要用于局部或区域性原发癌或转移灶的治疗，如各种癌痛的骨转移，癌浸润或压迫神经引起的头颈痛、腰背痛等。癌广泛性转移，全身性疼痛不宜应用。

2.化疗止痛 用于对化疗药物比较敏感的肿瘤压迫痛，有时采用短疗程，大剂量的化疗药物，可使肿块缩小，解除压迫，使疼痛得以缓解。

3.神经阻滞治疗 应用神经阻滞治疗典型的癌痛和癌瘤的诊断及预后同样重要。应用局部麻醉药物或神经松解剂注入神经内或其周围或神经根部疼痛区域以止痛。常用于药物治疗无效的顽固性疼痛。

4.神经外科治疗 为了解决不能手术根治或复发癌症姑息疗法无效，癌瘤病人难以消除的癌痛，选用神经外科手术常能获得延长缓解疼痛的时间，使病人仍能正常生活，尽管这些方法都到最后采取，但也不应不适当地延缓实施这些形式的治疗方法，使病人遭受不必要的痛苦。

第二节 癌性发热

恶性肿瘤患者常伴有发热，有的为肿瘤疾病本身所致，有的为患者并发感染而引起。据统计，恶性肿瘤死亡的原因以感染占首位，可高达 70%。故对肿瘤患者的发热，必须严密观察，详细询问病史和进行体检，相应地采取一些特殊的检查方法，以期及时发现致热原因，并及时给予适当的处理，以提高抗肿瘤治疗效果。反之，如对这些患者的发热不及时鉴别、处理，轻则贻误治疗，重则危及生命，故发热虽是临床常见而普遍的症状，但对肿瘤的治疗及预后有重大意义。

一、癌性发热的原因

1. 癌症导致的发热 癌细胞能产生一些物质，如类癌产生 5-羟色胺、嗜铬细胞瘤产生儿茶酚胺、肝细胞癌产生甲胎蛋白，以及许多癌细胞能产生异位激素等等，它们对机体发生各种不同的反应，有些物质可引起发热，对这类发热的处理，最根本的方法是消灭这些癌细胞，如通过手术、放射治疗及化疗来达到这一目的。但如患者年老体衰，存在广泛转移，骨髓功能低下，不能耐受这些治疗时，有必要予以对症处理，以改善机体状况，给以后的治疗创造条件。对这类发热的对症处理又应因病而异。淋巴网状细胞瘤，在试管内也可生成致热样物质，与内源性致热源的性质相同，可引起发热，一般给予消炎痛、保泰松或皮质激素可予控制。此外，当癌症发展到一定程度时可发生无菌性坏死，坏死物质释放内源性致热原亦可引起发热，故除用上述药物对症处理外，尚需考虑继发感染的问题。嗜铬细胞瘤的发热是由于其排出儿茶酚胺引起血管收缩所致，并伴有明显的血压升高，对这类患者的发热处理是次要的，常投以血管扩张药或 α -肾上腺素受体阻滞剂降低血压，发热亦随之消退。另外，癌转移到中枢神经系的某部位也可引起发热。

2.感染性发热 肿瘤患者的发热，很多是由感染引起的，在肿瘤患者死亡原因中，感染约占 70%，这说明肿瘤患者易感染且感染往往不易控制，而发热常是感染首先发出的信息或是仅有的症状，如不及时积极处理，常导致不可挽救的局面。癌症患者的易感因素：

(1) 免疫机能抑制：肿瘤发展过程中，由于肿瘤细胞本身或通过肿瘤细胞所产生的免疫抑制因子的作用及肿瘤诱发的抑制细胞的作用。细胞免疫抑制及体液免疫抑制，可单独出现，也可二者同时存在。此外，肿瘤在治疗过程中使用的抗癌药物大都具有不同程度的抑制机体免疫功能的作用，如淋巴瘤患者在接受化疗后，可出现迟发超敏反应受损，特别是小剂量长疗程治疗时，使机体免疫系统得不到恢复的机会。

有些学者曾证明部分抗菌素对机体免疫系统有抑制作用，虽然对大多数病人的影响不大，但患者白细胞减少时，则有一定意义。

癌症患者长期使用肾上腺皮质激素治疗时，对免疫功能产生抑制是众所周知的，在探讨麻醉和手术对肿瘤患者免疫功能的影响时，应注意到手术时，常可在局部静脉和中心静脉中检出瘤细胞，这种因外科手术促使瘤细胞播散似与免疫无关，但手术和麻醉可使患者抵抗力降低，这两种因素结合可使某些患者术后病情恶化。有人用肿瘤特异性免疫反应来测定肿瘤患者术前及术后的免疫功能，在黑色素瘤或乳腺癌患者进行白细胞移动抑制试验，表明术后免疫抑制可达 22 天，乳腺癌患者作用白细胞管壁粘附试验，发现术后免疫抑制达 7~14 天。

(2) 中性粒细胞减少：中性粒细胞减少是癌症患者发生感染最重要的因素。急性白血病和慢性淋巴性白血病常造成骨髓功能衰竭。抗肿瘤药物绝大部分对骨髓有不同程度的抑制作用。除患者个体差异外，治疗方案的设计，药物使用不当等均可加剧中性粒细胞减少的程度。放射治疗引起的骨髓抑制与放射源，照射

部位、照射面积、剂量和疗程的安排等因素有关。目前对肿瘤的治疗趋向采用综合性措施，以提高疗效，但造成中性粒细胞降低的可能性也因之增加，故在增效的前提下要注意到出现危害性的一面。

中性粒细胞减少的程度与持续时间同感染的发生率有密切关系。医院环境易受微生物污染，且常具有耐药性，常是粒细胞减少的患者感染的外在因素。

(3) 营养不良：癌症系消耗性疾病，尤其在晚期癌症患者营养不良更为显著。肿瘤细胞可产生有害物质，引起食欲不振，发热等，在消化系统肿瘤患者常因摄入、消化、吸收不良而减少能力供应，此外还常伴有呕吐、腹泻等因素而加重营养不良的程度。

(4) 其他因素：精神状态与肿瘤患者的感染有一定关系。由于恶性肿瘤不易治愈，晚期患者死亡率高。思想负担沉重，情绪低落、紧张、焦虑、食欲不振以及失眠等，必然导致体质衰退。此外实体瘤发展到一定程度，可因占位性病变而使机体管道系统受压，造成血液循环障碍或肺不张，肠梗阻，胆道系统阻塞等，均可增加感染机会。放射治疗可引起局部炎症反应；甚或组织坏死引起脏器穿孔，导致严重的感染。如胃、肠穿孔引起腹膜炎。

肿瘤患者在诊治过程中，常行静脉穿刺，静脉留置插管导致细菌感染，发生血栓性静脉炎，甚或引起败血症。各种插管造影，纤维内窥镜检查均可引起感染，故对这类医源性感染应予重视，严格进行消毒灭菌制度，尽量避免感染的发生。

3. 药物热

临床所见之药物热大多是超敏反应所引起，肿瘤患者的药物热，常见于使用免疫促进剂治疗时，如转移因子、胸腺素、左旋咪唑、干扰素、白细胞介素Ⅱ、肿瘤坏死因子、集落刺激因子、短棒杆菌等，所引起的发热，大多不影响抗肿瘤的治疗。短棒杆

菌引起的发热可达 50% 以上。左旋咪唑引起的高热虽少见，但常伴有严重神经系统症状，如头痛、肢体痉挛、失语症等，可能与神经细胞酶的遗传缺陷有关。

在抗肿瘤药物中可能引起发热的以平阳霉素（或搏莱霉素）最常见，约有 1/3 的人发生，平阳霉素引起的中、低度发热，在用药前 2 小时给予消炎痛或皮质激素，可使其不发热或减轻发热的程度，大剂量环磷酰胺治疗 Burkitt's 淋巴瘤出现的发热属于药理作用所致，由于化疗药物对肿瘤细胞大量杀伤后释放出内源性致热原引起发热。阿霉素、柔红霉素、顺铂、门冬酰胺酶、链脲霉素等也可能引起发热。此外，其它原因有输血及血制品有关的致热原性反应，非化疗药引起的药物过敏。

二、癌性发热的诊断 仔细分析上述致病因素，则可发现非感染及非肿瘤性发热的诊断常无困难，与输血及化疗有关的发热持续时间短，发热常在 24 小时内消退，如考虑有药物热可能，则停可疑药物后发热可消退。癌转移至下视丘的体温调节中枢引起的发热是罕见的，可作 CT 确诊。由放射性肺炎及心包炎引起的发热可根据病史，体检及 X 线诊断。当缺乏上述致病因素并经相应细菌学及广泛临床检查未发现感染病因时，必须考虑癌性发热之可能性。

国外有资料证明甲氧萘丙酸有选择性抗肿瘤性发热的作用，可用来鉴别感染性与肿瘤性发热。只有肿瘤性发热用甲氧萘丙酸可使发热消退，持续服用时体温可正常。但非肿瘤性发热用药后则不退热，药物过敏、胶元性血管病及放疗引起的非肿瘤性发热对甲氧萘丙酸无效。

三、癌性发热的治疗 癌性发热常见于恶性淋巴瘤、白血病、肺癌、肝癌、骨肉瘤、胃癌、结肠癌、胰腺癌、肾癌、“恶网”等。根据患者具体情况，用中西医结合方法予以处理。

（一）病因治疗 力争尽快查明原因，进行病因治疗。

（二）辨证论治

1.肝经郁热

【主证】心烦，发急，易怒，喜叹息胸胁胀，全身串痛，口苦，发热，舌质红，苔黄，脉弦或弦数。

【治则】疏肝清热。

【方药】丹栀逍遥散加减。常用丹皮、栀子、当归、白芍、薄荷、柴胡、川楝子、郁金、胆草、黄芩。

2.瘀血内阻

【主证】午后或夜晚发热，身体常用肿块伴疼痛，面黄或黯黑，唇舌青紫或有紫斑，脉细涩。

【治则】活血祛瘀。退热除蒸。

【方药】血府逐瘀汤加减。常用桃仁、红花、赤芍、当归、川芎、土元、柴胡、枳壳、大黄、丹皮。或桂枝茯苓丸加减。常用桂枝、茯苓、丹皮、桃仁、泽泻、赤芍、白芍等。

3.湿热内蕴

【主证】发热缠绵，日晡较甚，忽高忽低，胸脘痞闷，身沉困，头重如裹，肌肤肿胀，舌体胖，苔黄腻，脉滑数或濡。

【治则】清热利湿。

【方药】甘露消毒丹加减。常用茵陈、薄荷、藿香、连翘、黄芩、白蔻、豆卷、滑石等。或用三仁汤加减。杏仁、苡仁、蔻仁、滑石、竹叶、木通、金银花等。

4.气血亏虚

【主证】少动则热，头晕眼花，面色不华，心悸怔忡，经少或不行，舌质淡，脉沉细。

【治则】益气养血。

【方药】参芪四物汤加减。常用黄芪、党参、白术、当归、白芍、熟地、鸡血藤、甘草、川芎等。

5.气虚阳浮

【主证】头痛恶寒，寡言，倦怠，面黄或成白，纳差，腹胀，舌淡苔白薄，脉弦。

【治则】补中益气，甘温除热。

【方药】补中益气汤加减。常用黄芪、党参、白术、陈皮、当归、柴胡、肉桂、升麻、甘草等。

6.食积发热

【主证】午后发热，脘满而痛，暖腐吞酸，恶心，欲吐，不欲食，使溏或干结，舌苔腻，脉滑数。

【治则】消食导滞，清热通便。

【方药】保和丸加减。常用焦三仙、莱菔子、白术、陈皮、枳壳、大白、泻叶、半夏、连翘、茯苓等。

7.阴虚发热

【主证】午后潮热，五心烦热，颧红，盗汗，腰酸腿软，心悸失眠，苔薄或黄，脉细数。

【治则】滋阴清热。

【方药】清骨散加减。常用鳖甲、知母、银柴胡、地骨皮、青蒿、胡黄连、秦艽、生地、元参、麦冬、柏子仁、枣仁等。

8.营血毒热复感外邪

【主证】高热烦燥，头昏乏力，骨节酸痛，或恶寒发热，衄血，皮下瘀斑，内脏出血，或神昏谵语，抽搐，舌红绛或红，苔黄燥，脉细数。

【治则】清营泄热，凉血解毒。

【方药】犀角地黄汤加减。常用犀角、生地、丹皮、板蓝根、赤芍、茜草、二花、连翘、栀子等。

(三) 中成药治疗

1.安宫牛黄丸（适用于实热证）：每次服一丸，每日2~3次。

2.紫雪丹（适用于实热证）：每次服0.3~0.5g 每日2~3次。

3.至宝丹（适用于实热证）：每次服一丸，散剂服0.5g，每日2~3次。

4.犀角粉或羚羊角粉：每服 1.5~3g，煎服或冲服。

(四) 物理降温：体温在 39.5℃ 以上时可用：

1.50%酒精擦浴；

2.温水擦浴，加入适量薄荷油；

3.冰冷降温：可用冰帽，冰块，室内或大血管部位，头部署冰；

4.荆芥、薄荷各 30g，煎水擦浴。

(五) 化学药物退热：体温超过 38.5~39℃ 时可选用。

1.阿斯匹林 0.3g 口服。

2.复方阿斯匹林 0.5g 口服。

3.去痛片 0.5g 口服。

4.消炎痛 25mg 口服。

5.扑热息痛 0.5g，加扑尔敏 4mg 加安定 5mg，1 次口服。

6.保泰松 0.1g 口服。

7.强筋松 0.2~0.4g 加扑尔敏 4mg，口服。

(六) 体温超过 40℃ 以上时可选用：

1.复方氨基比林 1 支肌注，老年人及儿童慎用。

2.安痛定 2ml 肌注，老年人及儿童慎用。

3.柴胡注射液 2~4ml 肌注，每日 3~4 次。

4.醒脑静 4~8ml 静滴，每日 3~4 次。

5.地塞米松 5~10mg 静滴。

(七) 合并感染者及时恰当地应用抗菌素：有条件可作细菌培养加药敏试验，有的放矢应用抗生素。

1.球菌感染可选用磺胺类，青霉素、新型青霉素、红霉素、先锋霉素、复达欣、菌必治等。

2.杆菌感染时可选用碘受类、氨苄青霉素、氟哌酸、链霉素、土霉素、庆大霉素、先锋霉素、菌必治、复达欣等。

3.病毒感时可选用病毒灵、金刚片、大青叶、板蓝根、白花蛇舌草、半枝莲、半边莲、抗炎灵片或冬凌草片等。

(八) 高热持续状态处理

1.醒脑静 4~8ml 加入 5% 葡萄糖液 500ml, 静滴, 每日 2~3 次。

2.在控制感染的先行条件下, 氢化可的松 100~200mg, 加入 5% 葡萄糖盐水 500ml, 静滴。

3.冬眠疗法: 顽固高热不退者可用冬眠或半冬眠疗法。冬眠合剂: 氯丙嗪、异丙嗪各 50mg, 杜冷丁 100mg, 5% 葡萄糖 250ml 配成, 静滴。或氯丙嗪、异丙嗪各 25mg 加杜冷丁 50mg 加 5% 葡萄糖液 250ml 静滴。

(九) 放血疗法: 针刺大椎、合谷、曲池、均为双侧, 中等刺激至强刺激, 用泻法。

(十) 新针疗法: 取大椎、十宣、尺泽、委中穴等用三棱针放血。

(十一) 新针疗法: 取穴一组: 安眠 2, 大椎。二组: 曲池、复溜。两组交替使用。

(十二) 支持疗法

1.多次糖盐水, 液体摄入总量在 4000ml 以上。

2.进易消化食物;

3.给予复合维生素 B 及大量维生素 C;

4.加强护理, 及时换去潮湿衣服等;

5.睡眠不佳时可给以镇静安眠剂 (安定 10mg 或鲁米那 0.06g)。

6.必要时补液, 纠正电解质紊乱, 纠正酸中毒, 有休克出现及时积极治疗休克。

第三节 癌性胸水

胸腔积液可分为漏出液和渗出液。恶性肿瘤一般不产生漏出液。癌性胸水一般占渗出性胸水的 40%~80%, 肺癌、乳腺

癌、淋巴瘤、胸膜间皮肉瘤、卵巢癌、胃癌等是侵犯胸膜的常见恶性肿瘤。约占15%的肺癌患者确诊时已有胸水，在相当多的情况下，胸水提示胸膜上有癌细胞种植，容易找到癌细胞，但是有时鳞癌可能阻塞支气管引起肺不张产生胸水，此种情况胸水中多无癌细胞。半数以上的乳癌累及胸膜时产生胸水，从胸水确诊后起，患者的中位生存期一般为22个月，80%乳癌患者的胸水为同侧，约半数需行局部处理以减轻症状，在有胸水的乳癌患者中仅9%在X线片上可以找到肺部病灶，有些病灶系淋巴道引起胸水，因而胸片上找不到病灶。约16%淋巴瘤（特别是大细胞型）产生胸水，这是晚期表现，往往提示肺门或纵膈淋巴结有转移，有时肺组织也可能有淋巴瘤样浸润。胸膜间皮肉瘤的发病率较低，但并发恶性胸腔积液的很多。

一、发病原因 恶性肿瘤患者的胸腔积液可继发于各种原因。有些胸水是由于癌细胞侵入脏层和壁层胸膜所引起；有些则是由于癌肿的间接影响结果所致。

脏层胸膜的被侵犯和种植可由下列因素造成：①原发性肺癌直接蔓延至脏层胸膜。②来自脏层和壁层胸膜的肿瘤，如间皮肉瘤。③胸膜下肺实质转移癌侵犯邻近的脏层胸膜。胸膜下的原发性或转移性肿瘤生长穿过脏层胸膜，癌细胞将脱落于胸腔，最终，癌细胞种植到壁层胸膜和脏层胸膜的其余部份。癌细胞的种植导致胸腔积液。这种积液为渗出液，常呈血性，细胞学检查可发现癌细胞。

癌性胸水的间接原因可分三类：①脏层和壁层胸膜的淋巴和/或静脉回流阻塞所引起的胸膜渗出液的积聚。这种胸水常见于淋巴瘤和转移性乳腺癌患者。胸水内可能有或无癌细胞。胸水常呈浆液性而不是浆液血性或血性。偶而可遇到淋巴瘤患者由于胸导管阻塞而引起的乳糜性胸水。如果淋巴或静脉阻塞能缓解，胸腔积液将不需进一步治疗。②胸腔漏出液见于有低蛋白血症的恶性肿瘤的虚弱患者。治疗包括尽可能给予肿瘤的全身性治疗和给

以合适饮食，静脉输入以纠正蛋白质缺乏。③原发癌或较少因转移癌而致支气管内阻塞，引起阻塞性肺炎和／或肺不张的胸水。这种胸腔积液无特殊治疗方法，治疗应针对支气管内阻塞性病变。

二、临床诊断

(一) 癌性胸水的症状：胸水患者的症状是多样的，很多病人即使有大量胸腔积液而无胸水的症状，有症状者其症状常见闷气、咳嗽、胸痛。闷气为最常见的症状，是大量肺组织受压所引起，胸痛可能是因为肺实质内和胸腔内压增加后刺激交感神经所引起。其它症状如心悸、体重减轻、食欲减退，发热、畏寒等，痰血较少见。

(二) X线表现：胸腔积液的X线表现是多样的，当胸腔积液在250ml以上时，在胸部后前位片上往往表现为肋膈角变钝。在侧位片上有时可以发现10ml游离液。

大量的胸腔积液可局限在肺与膈肌之间，其容量甚至可达1000ml，而在后前位胸片中无肋膈角改变，此种现象被称为肺下积液，在站立后前位X线胸片上，膈下胃泡影与肺的膈面间距增宽，可为重要诊断依据。

一侧胸腔阴影常提示大量积液全肺不张或整个胸腔被肿瘤充满，超声检查可分辨其为液体或实质性肿瘤。纵隔障的位置在胸水的诊断方面也十分重要，纵隔向对侧移位提示胸水生长十分活跃，最常见于恶性肿瘤患者。

(三) 癌性胸水的诊断：约53%患者胸腔一次穿刺所取胸液经细胞学检查明确诊断，反复多次穿刺细胞学检查时可获得73%的阳性率，虽然胸穿是简单而常用的诊断胸水的方法，但胸膜活检是必要的，两种方法结合可以达到90%的确诊率。上述两法均未能明确时，可根据情况行气管镜检查以明确气管阻塞范围，肺不张与胸水的关系；纵隔淋巴结转移阻塞淋巴而引起的胸水，可通过纵隔镜诊断。胸腔镜，剖胸探查可作为最后采取的诊

断方法。

癌性胸水多为渗出液，二种胸液的区别，主要根据液中的蛋白质含量而定，漏出液中的蛋白质量少于 3g/dl ，比重小于 1.015。渗出液的蛋白质含量高，这一简单试验可分辨 90% 的胸水为渗出液或漏出液。渗出液还有以下特征：胸水中蛋白与血清蛋白比值 >0.5 ；胸水中乳酸脱氢酶与血清的比 >0.6 ；胸水中乳酸脱氢酶 $>$ 血清中的 $2/3$ 。符合其中任何一条均可诊断为渗出液。

有很多检查胸水的方法可以帮助鉴别癌性胸水与其它胸水，如胸水中与血浆中免疫球蛋白的比例，电镜检查，流式细胞检查仪以及癌胚抗原，以上检查从理论上可以辨别是否是恶性胸水，但仍只能作为临床参考而不能确诊。

一些并不常见的情况，但却是临床上鉴别恶性胸水时必需考虑的，例如，胸膜间皮肉瘤常伴有胸水，且胸水中的间皮细胞常与胸膜转移性腺癌难以鉴别。间皮肉瘤的胸水中的癌胚抗原量一般低于 12mg/ml ，而 89% 以上的肺腺癌的胸水中癌胚抗原的含量超过 10ng/ml 。CT 虽不是常规检查手段，但可帮助了解肿瘤是来自胸膜或肺，并可显示病变的范围。

乳糜胸的胸水混浊或乳汁样，其中甘油三脂大于 110mg/dl 。50% 乳糜胸由恶性淋巴瘤引起。另有一种含胆固醇混浊的慢性胸腔积液，病程可长达五年以上，但不是癌性胸水，临床应与前者相鉴别。

三、治疗方法

（一）辨证论治

1. 邪犯胸肺：

【主证】寒热往来，胸肋闷痛，呼吸、转侧则疼痛加剧，口苦，咽干，心下痞硬，干呕，舌苔薄白或黄，脉弦数。

【治法】和解宣利。

【方药】柴枳半夏汤加减。常用柴胡、黄芩、半夏、瓜蒌、

枳壳、桔梗、赤芍、甘草、生姜、大枣。

2. 饮停胸胁证

【主证】咳唾引痛，呼吸困难，咳逆气喘，息促，不能平卧或仅能偏卧于停饮之一侧，病侧肋间胀满。舌苔白，脉沉弦。

【治法】泻肺祛饮。

【方药】椒目瓜蒌汤合十枣汤或控涎丹。常用药：桑皮、葶苈子、苏子、瓜蒌、半夏、刺蒺藜、橘红、川椒目、茯苓、甘遂、大戟、芫花、大枣、白芥子、生姜。

十枣汤和控涎丹两方均属攻逐水饮之剂。但前者力峻反应大，宜于体实证，积饮量多者，后者药力较缓，反应较轻。十枣汤和控涎丹之临床运用，均宜小量递增，一般使用十枣汤时可取甘遂、大戟、芫花各等份，研为细末，每服1~3g，可调成糊状也可装入胶囊，于早晨空腹时用大枣十枚煎汤送服，可连服3~5日，或每1~3日服一次。

3. 络气不和

【主证】胸胁疼痛，胸闷不舒，呼吸不畅或有闷咳，或感刺痛，脉弦，苔薄，质黯。

【治法】理气和络。

【方药】香附旋复花汤。常用药：旋复花、苏子、杏仁、苡仁、茯苓、香附、橘红、半夏。

4. 阴虚内热

【主证】咳呛时作，咯吐少量粘痰，口咽干燥，或午后潮红，颧红，心烦，手足心热，盗汗，和伴胸水胁间痛，病久不复，形体消瘦，舌红少苔，脉细数。

【治法】养阴清热。

【方药】沙参麦冬汤合泻白散。常用药：沙参、麦冬、玉竹、天花粉、桑叶、白扁豆、生甘草、桑白皮、地骨皮、粳米。

(二) 针刺治疗

【主穴】中脘、章门、脾俞、胃俞、阴陵泉、太渊。

【手法】泻法。

(三) 全身化疗 癌性胸水提示肿瘤已有扩散，因而从理论上说全身性治疗既可作用于原发灶又可控制胸水，但到目前为止，大量的抗癌药物均已试用，尚未见有显著的疗效。目前约30%乳癌和小细胞肺癌的胸水经化疗后可获得控制，此外恶性淋巴瘤的胸水用化疗亦有明显的疗效。全身性化疗时胸水的吸收量可视为肿瘤对药物敏感的征象，往往在用药初期可以见到，但以后则产生耐药性，胸水渐渐增多，有大量胸水的患者，先作胸穿使患者症状缓解，有助于化疗的应用。

(四) 放射治疗 治疗癌性胸水有两种放射疗法，标准的纵隔放射治疗可以控制淋巴瘤引起的胸腔渗出液或乳糜胸。超高压移动条放射对一小部份癌性胸水有疗效。但临床上放射治疗癌性胸水的效果不佳。

(五) 胸腔穿刺 单纯胸腔穿刺难以控制癌性胸水，因为胸水抽吸后一般在1~3天又出现。在等待化疗产生作用以前，胸穿可作为减轻患者症状的手段，同时胸水抽出后可以观察肺扩张情况。在病人机体情况允许时尽量抽放胸水，可同时送细胞学检查，寻找癌细胞，做胸水常规检查及胸水肿瘤标志物（如CEA等）检查。若有双侧胸腔积液可同时双侧胸腔穿刺抽胸水，胸穿亦可作为后期病人减轻症状的对症处理，多次反复胸穿作为治疗胸水的单一疗法是不可取的，因为穿刺后液体迅速生成，反复抽吸导致大量蛋白丢失对患者不利，而且容易感染甚至形成气胸。

(六) 胸管引流 胸管引流（闭合式胸腔引流术）比胸穿能较彻底地排出胸水，此法已被采用为治疗胸水的有效方法，若与全身性治疗结合则疗效较好。

(七) 胸膜粘连术 系采用硬化剂滴入胸膜腔内，使壁层和脏层胸膜粘连，从而消除液体在胸膜腔内积留。胸膜粘连术必须使相应部位的脏层和壁层胸膜发生炎症粘连。当闭合式胸腔引流将胸液排尽后肺即扩张，达到两层胸膜对合，胸片显示肺扩张良

好，胸管内液体每日量少于 100~200ml 时才能注射硬化剂。四环素是最常用的胸膜粘连剂，对全身性化疗无干扰，副作用比阿的平少且轻，比放射性同位素便宜且无防护问题，比滑石粉操作方便。由于本身是抗生素，故感染问题可少虑及。约 80% 的胸水可用四环素控制一般用 500~1000mg 四环素溶于 50~100ml 无菌生理盐水中，为减少胸痛，液体中可加入 200mg 利多卡因，注射前可服镇痛药。一般适应于症状较明显但化疗效果不佳的癌性胸水患者，但对终末期的患者如数日内将死亡者不宜施行。

(八) 胸腔内化疗 抽胸水后可胸腔内注射化疗药物，下列药物可单用或联合应用（二联或三联）。

氮芥 20~30mg；顺氯氨铂 60~200mg；卡铂 100~500mg；阿霉素 40~60mg，表阿霉素 60~120mg；丝裂霉素 10~30mg；消瘤芥 40~60mg；长春新碱 2~5mg；噻替哌 40~60mg；5-氟脲嘧啶 500~1000mg；短棒杆菌 4~8mg，还有假单胞菌苗及多抗甲素等胸内注射均有明显控制恶性胸水的作用。以上药物胸腔内注射，每周 1 次，若 2~3 次疗效不佳，可换白细胞介素 II 10 万~60 万单位，每周一次。榄香稀乳注射液 200mg/m²，每周一次。

在上述化疗药物应用同时可伍用：654-2 注射液 10~20mg，地塞米松注射液 20mg，复方丹参注射液，胸腔内注射，可以扩张血管，改善微循环，防止粘连，增加疗效。

胸腔内注射药物后注意变换体位，以防粘连形成包裹性积液并使药液弥散均匀。及时处理化疗药物引起的毒性反应，如用顺氯氨铂同时要水化碱化尿液，预防恶心呕吐等胃肠反应等。必要时可用硫代硫酸钠解救。另外，因抽胸水机体丢失大量蛋白，应及时给予补充等。

(九) 胸膜切除术 在其他治疗方法失败后，胸膜切除术仍然是十分有效的治疗胸水的方法，全麻下将壁层胸膜从胸壁及纵

隔剥脱，应注意勿损伤大血管和膈神经及喉返神经。约 50% 患者发生脓胸，肺炎、肺漏气或出血等并发症，手术死亡率约 10%，故应严格选择病例。乳癌或恶性黑色素瘤胸膜转移者如患者一般情况较好，其原发病灶已控制或生长很慢，估计术后生存期在一年以上。原发性肺癌伴胸水者愈后一般差，手术应慎重考虑。

第四节 癌性腹水

由于恶性肿瘤所继发引起的腹腔内游离液体的积聚，不论其发生机理或液体性质如何，均称为癌性腹水，其形成随原发肿瘤有所不同。

一、发生原因 癌性腹水形成的原因有二种，一是淋巴循环障碍，如肝癌可以引起肝脏淋巴液生成，引起肝淋巴循环障碍，以致形成腹水。引起淋巴循环障碍的环节大致有两个。第一，肿瘤机械性堵塞或压迫，引起淋巴液在肝细胞间隙的流动；第二，肝癌，尤其伴有肝硬化时，肝窦后的静脉压升高，血管内液体外渗，血管外液体增加，Bisse 氏腔扩大，其结果一方面压迫肝细胞，使肝细胞受损，另一方面使肝淋巴液生成过多，当超过肝淋巴管及胸导管的运送能力时，即可引起淋巴液淤滞，使含有丰富血浆蛋白的淋巴液由肝浆膜面及肝内淋巴管漏出，进入腹腔。

恶性肿瘤引起腹水的另一个原因是由于包膜破裂或被浸润，癌细胞蔓延到腹膜表面，呈弥散性的局部扩张，引起腹膜本身毛细血管床通透性的改变和再吸收功能的改变，促使腹水的生理分泌增加，再吸收功能受到破坏，失去平衡所造成的。胃癌，胰腺癌等形成腹水的主要原因也是如此。但其一部分腹水形成与肝癌者相似，而另部分病人则与横膈淋巴被癌栓塞有关。

二、癌性腹水的诊断 癌性腹水多见于肝癌、胃癌、肠癌、胰腺癌、卵巢癌、子宫癌、恶性淋巴瘤及腹膜间皮肉瘤等。主要

临床表现是原发癌的局部症状、恶病质与腹水。

有无移动性浊音是发现腹水的重要依据。腹腔内有大量游离液体时可有液波震颤。临床上必须与其它原因所致的腹部膨胀相区别，如巨大卵巢囊肿，其他巨大腹腔囊肿与巨大肾盂积水、肥胖、肠胀气等。

癌性腹水生长迅速，多为渗出液也可为漏出液，常为血性，穿刺排液后有迅速再行积聚倾向。其细胞计数增高，红细胞常占较大比例，由于细胞碎片的存在，腹水外观混浊，如反复作癌细胞检查，可找到癌细胞。间皮肉瘤患者的腹水中，见有幼稚的上皮细胞存在。肿瘤压迫门静脉引起的腹水，可为黄色漏出液与肝硬化产生的腹水甚为相似，但肝实质功能往往无明显损害，可资鉴别。

诊断时常需找寻原发肿瘤，必要时可适量放腹水，以便触摸肿块。其它手段如内镜、超声波、CT等。显著地提高了病因诊断水平。腹腔积液酶活性的测定。也有一定的参考价值。如癌性腹水中乳酸脱氢酶（LDH）活性较血清LDH活性为高，腹水LDH/血清LDH的比值常大于1。

三、治疗方法

（一）辨证论治

1. 气滞湿阻

【主证】腹大胀满，按之不坚，胁下痞胀，或疼痛，小便短少，纳食减少，食后作胀，暖气不爽，苔白腻，脉弦。

【治法】疏肝理气，运脾燥湿。

【方药】柴胡疏肝散合胃苓汤加减，药物：柴胡、川芎、白芍、香附、郁金、青陈皮、枳壳、苍术、厚朴、茯苓。

2. 寒湿困脾

【主证】腹大胀满，按之如囊裹水，胸脘胀满，得热稍舒，精神困倦，怯寒懒动，小便少，大便溏，苔白腻，脉细缓。

【治法】温运中阳，化湿行水。

【方药】实脾饮合胃苓汤加减。常用药物：厚朴、苍白术、陈皮、草果、木香、附子、干姜、茯苓皮、泽泻、甘草等。

3. 湿热蕴结

【主证】腹大坚满，脘腹撑急疼痛，烦热口苦，渴而不欲饮，小便赤涩，大便秘结或溏垢，舌尖边红，苔黄腻或兼灰黑，脉弦数，或有面目皮肤发黄之证。

【治法】清热利湿，健脾除满。

【方药】茵陈四苓汤合中满分消丸加减。常用药物：茵陈、山栀子、黄柏、金钱草、砂仁、厚朴、苍术、猪苓、泽泻、车前子、滑石。

4. 肝脾血瘀

【主证】腹大坚满，脉络怒张，胁腹攻痛，面色黧黑，头颈胸臂有血痣，呈丝纹状，手掌赤痕，唇色紫褐，口渴，饮水不能下，大便色黑，舌质紫红或紫斑，脉细涩或扎。

【治法】化瘀行气，通络散结。

【方药】膈下逐瘀汤加减。常用药物：当归、赤芍、桃仁、红花、五灵脂、三棱、莪术、鳖甲、大腹皮、乌药、泽兰、泽泻。

5. 脾肾阳虚

【主证】腹大胀满不舒，入暮尤甚，面色苍黄，脘闷纳呆，神倦怯寒，肢冷或下肢浮肿，小便短少不利，舌质胖淡紫，脉沉细而弦。

【治法】温补脾肾，化气行水。

【方药】附子理中汤加味。常用药物：附子、干姜、党参、白术、茯苓、泽泻、葫芦、鹿角、葫芦巴。

6. 肝肾阴虚

【主证】腹大胀满，甚则青筋暴露，面色晦滞，唇紫，口燥，心烦，齿鼻时或衄血，小便短少，舌质红绛少津，脉弦细数。

【治法】柔肝滋肾，养阴利水。

【方药】麦味地黄汤加味。药物：麦冬、五味子、生地、山茱萸、猪茯苓、泽泻、沙参、石斛、首乌、枸杞子、楮实等。

（二）古方、验方

1.二气散：治水气蛊胀满闷

黑白丑各六g，共为细末，外用大麦面四两同一处拌匀做烧饼，临卧用清茶一盏下，降气为验。

2.鲤鱼白矾粥：治水肿胀满。

赤尾鲤鱼一斤，破开不见水盐，以白矾15g，研末入腹内，绵纸包裹，加以黄土泥包，放灶内煨熟取出，去纸泥，为粥，食头者上消，食身尾者下消，一日用尽。

3.大戟甘遂散：治水蛊喘胀

甘遂、大戟各30g，慢火炙，研细面，每服一g，水半盏，煎三五沸服，不过十服。

4.马鞭草煎：治妇人血臌

马鞭草或刘寄奴草煎汤服或为末服。

5.青蛙蝼蛄葫芦散：治动摇有水声，皮肤黑色，干青蛙两个，以酥炒干蝼蛄七个，炒陈葫芦半两，共为末，空心温酒服六g。

6.鸡矢醴方

鸡矢八匙，研面炒焦，无灰酒三碗，上煮至一半许，用布滤取汁，五更热饮则腹鸣。辰巳时行二三次，皆黑水也，次日觉足面渐有皱纹，又饮一次，则渐皱至膝上而病愈矣。鸡矢咸苦下行苦降，消导一切水肿膨胀，无灰酒，可行经走络，通脉活血。

（三）中药贴敷疗法

1.十臌取水膏：治臌胀

【药物】大戟、甘遂、麻黄、乌梅、葫芦巴、葶苈、芫花、黑丑、细辛、汉防己、槟榔、海蛤、陈皮、桑皮、生姜、土狗。

【制法】麻油熬，黄丹收。

【用法】贴肚脐处。

2. 臌胀消满膏：治臌胀

【药物】苍术、白术、香附、当归、苏梗、黄连、栀子、枳实、山楂、木香、槟榔、赤苓、木通、泽泻、生姜。

【制法】麻油熬，黄丹收。

【用法】贴气海穴。

3. 外敷消腹水方：消腹水

【药物】甘遂适量研末，连头葱白5根。

【制法】共捣烂。

【用法】脐部先用醋涂擦，以防止感染和刺激皮肤，然后将药适量敷肚脐上，再用纱布复盖，固定即可。

（四）针灸治疗 辨证分型及主证同中医辨证

1. 气滞湿阻

【主穴】肝俞、脾俞、中脘、中极、阴陵泉、足三里。

【手法】泻法。脾俞、足三里补法。

2. 寒湿困脾

【主穴】神阙、关元、中脘、天枢、中极、三阴交。

【手法】神阙、关元灸。其余泻法。

3. 湿热蕴结

【主穴】肝俞、脾俞、水分、阴陵泉。

【手法】泻法。

4. 肝脾血瘀

【主穴】肝俞、膈俞、血海、三阴交、阴陵泉。

【手法】泻法。

5. 脾肾阳虚

【主穴】脾俞、肾俞、三焦俞、关元、三阴交、足三里。

【手法】补法加灸。

6. 肝肾阴虚

【主穴】肝俞、肾俞、三阴交、复溜、血海。

【手法】平补平泻。

(四) 腹腔穿刺和腹腔化疗

腹水出现时，腹腔穿刺抽放腹水有诊断和治疗的临床价值，是不可缺少的措施。抽放腹水一般每次不超过 5000~6000ml。抽水后送查癌细胞，腹水常规及肿瘤标志物（如 AFP、CEA、P₂-M、SF 等）。

腹腔内化疗基本原则和方法与治疗胸水相同。放腹水后应用多头绷带将腹部包扎，如遇到穿刺继续有腹水渗出，可压迫或涂上火棉胶封闭。一次大量放腹水，常可导致水盐代谢紊乱及大量蛋白丢失应及时给予补充。同时严密观察病情，防止肝昏迷发生。

(五) 全身化疗：基本原则和方法与治疗胸水相同。

第三篇 附 录

一、常用抗癌中草药简表

药名	别名	性味	功能	药理	应用	剂量(克)
白花蛇舌草	蛇舌草	甘、淡凉	清热解毒、利水消肿	1、对 U14 有抑制作用。 2、能刺激网状内皮,增强白细胞的吞噬能力。	广泛用于多种肿瘤,如胃癌、肝癌等。	15~60
半枝莲	半头草 狭叶韩信草	辛、寒	清热解毒、消肿	对小鼠 S ₁₈₀ 、艾氏腹水瘤、脑瘤 ₂₂ 有抑制作用。	广泛用于各种肿瘤	30~60
半边莲	半边花	辛、平	清热解毒、利尿消肿	对 S ₁₈₀ 有抑制作用。	肝癌、胃癌、肠癌	30~60
草河车	拳参 红蚤休	甘、寒	清热解毒	对肉瘤 ₁₈₀ 有抑制作用。	各种肿瘤	30~60
龙葵	老鸭眼睛草	苦、寒、有小毒	清热解毒、消肿利尿	复方龙葵对胃癌细胞有抑制作用。	各种肿瘤、癌性胸腹水	15~60

白英	蜀羊泉	甘、寒	清热解毒、 消肿利水	对人体肺癌细胞有抑制作用， 对 S_{180} 、 W_{256} 抑制。	各种肿瘤	15~30
蛇莓	蛇果草	甘、酸、 寒	清热解毒、 散瘀消肿	对艾氏腹水及 S_{180} 有抑制作用。	甲状腺癌、 肝癌、肺癌、 胃癌、声带癌 及良性肿瘤	15~30
猪殃殃	细叶茜草	辛、苦、 寒	清热解毒、 活血通络、 利尿消肿	对 S_{180} 有抑制作用。	乳腺癌、 淋巴肉癌、 白血病	15~60
芙蓉叶	木芙蓉	微辛、 凉	清热凉血、 消肿排脓	对胃癌细胞敏感。	胃癌、乳癌、 肺癌、皮肤癌	9~15
东风菜	土苍术 山白菜	甘、寒	清热解毒		各种肿瘤	9~15
香茶菜	冬凌草	苦、寒	清热、 利湿、 退黄	同冬凌草	黄疸、肝癌	20~40
鱼腥草	臭菜、 菹菜	辛、寒	清热、 解毒、 消痈	对晚期癌症并发感染有改善症状的效果。	肺癌、喉癌、 鼻咽癌、甲状腺癌、乳癌、 肝癌等	15~30

败酱草		辛、苦、微寒	清热解毒、活血消肿	有促进肝细胞再生,改善肝功能的作用。	各种肿瘤	30
鬼针草	一包针 婆婆针	甘、平	清热、解毒、消痰		食管癌等	15~30
马鞭草	铁马鞭 退血草	苦、微寒	清热解毒、活血化瘀、通经利水	对小鼠宫颈癌 ₁₄ 、肉瘤 ₁₈₀ 均有抑制作用。	肝癌、宫颈癌、癌性胸腹水等各种肿瘤	15~30
凤尾草	井口边草	苦、寒	清热、解毒、凉血止血	对 S ₁₈₀ 、S ₃₇ 有抑制作用。	肺癌、肠癌、肝癌、妇瘤	15~60
猫爪草	小毛茛	辛、寒	清热、解毒、消肿	对 S ₁₈₀ 、S ₃₇ 、艾氏腹水癌有抑制作用。	各种肿瘤	30
狗舌草	铜盘一枝香	苦、寒、有小毒	清热、解毒、利尿	对 L ₁₂₁₀ 有活性。	白血病、皮肤癌、网状细胞肉瘤	15~30
苍耳草	野茄树	甘、苦、湿、有小毒	祛风通窍、散结止痛	对 EAC 有抑制作用。	脑瘤、鼻咽癌、甲状腺癌、骨肉瘤等	15~30
翻白草	茯苓草	苦、寒	清热燥湿、凉血解毒		肠癌	15~30

喉笼草		苦、寒	清热解毒、利咽喉		喉癌	15
垂盆草	狗牙齿	甘、淡、凉、涩	清热、解毒、消肿		各种肿瘤，如肺癌	15~60
疔毒草		苦、寒	清热解毒、消痈肿		各种肿瘤	10~15
冬凌草	冰凌草	甘、苦、微寒	清热解毒、活血止痛	冬凌草素对Heal细胞及食管鳞癌细胞株有细胞毒作用。	食管癌、贲门癌、肝癌、乳腺癌等	30~120
蓼草	黑草	甘、寒	清热解毒利尿通淋		各种肿瘤	30~60
鹅不食草	球子草 石胡椒	辛、温	解毒利窍、散疮肿		鼻咽癌、肺癌	15~30
三白草	天竺草 三白叶	辛、甘、寒	清热利水、消肿解毒		肝癌、黄疸	10~30
佛甲草	铁指甲 尖甲草	酸、寒	清热泻火、解毒散瘀		乳腺癌、肝癌、胰腺癌	20~30
紫草	紫草根	甘、咸、寒	解毒透疹、清热凉血	对绒毛膜上皮癌及S ₁₀₀ 有抑制作用	绒癌、白血病、肝癌、肺癌等	15~30

山豆根	壮山豆根	苦、寒	清热解毒、利咽	对白血病细胞有抑制作用。	咽喉癌、肺癌、白血病、滋养叶细胞癌	9~15
藤梨根	阳桃根 野荔枝根	酸、凉	清热解毒、祛风除湿、止血消肿	对 S ₁₈₀ 、U ₁₄ 有抑制作用。	胃癌、肠癌、食管癌	3~60
野葡萄藤	山葡萄	甘、平	清热消肿、凉血止血	对 S ₁₈₀ 有抑制作用。	胃肠道癌、泌尿系癌、恶性淋巴瘤	30~60
水杨梅根	水石榴	苦、凉、涩	清热解毒、散瘀止痛	对宫、畸细胞、A ₁ 肉瘤、walker 肉瘤有抑制作用。	胃肠道癌、宫颈癌、淋巴肉瘤	30~60
羊蹄根	土大黄 野菠菜	苦、酸、寒、有小毒	清热解毒、止血通便	体外试验对急性单核细胞及急性淋巴细胞性白血病细胞有抑制作用。	白血病、恶性淋巴瘤等	15~30
臭椿树根		苦、涩、寒	收敛止血、清热燥湿	对 S ₁₈₀ 、S ₃₇ 、Hela 细胞有抑制作用。	宫颈癌、肠癌	30~60
山豆根	苦豆根 苦甘草	苦、寒	清热燥湿、止痛	对 Hea ₁ 、u ₁₄ 、S ₃₇ 、S ₁₈₀ 有抑制作用。	恶性葡萄胎、白血病	3~6

白茅根		甘、寒	凉血止血、 清热利水		膀胱肿瘤 及肺癌	30
蝉蜕	蝉衣 (退)	甘、 微咸、 寒	散热解痛	对 S_{180} 有 抑制作用。	各种肿瘤	15~24
漏芦	狼头花	咸、 苦寒	清热解毒、 消肿排脓	对皮肤真菌等 有抑制作用。	肝癌、胃癌、 乳癌	9~15
黄芩	子芩 条芩	苦、寒	清热、 解毒、 泻火	所含黄芩素有 抗肿瘤作用， 用于肿瘤具有 热症候者。	肺癌、胆囊癌、 喉癌、白血病	9~15
苦参	野槐	苦、寒	清热燥湿、 祛风杀虫	对 S_{180} 、 U_{14} 、 EAC 有抑制 作用。	消化道肿瘤、 肺癌、肝癌	9~30
青黛		咸、寒	清热解毒	对白血病细胞 有抑制作用。	白血病、 癌性发热	1.5~3.0
蒲公英		辛、 甘、寒	清热解毒	有抗人体肺癌 的作用。	肝癌、食管癌、 癌性发热	15~60
马勃	马屁包	辛、平	清热解毒、 利咽止血	马勃素是一种 抗癌物质。	舌癌、咽喉癌、 肺癌等	3~9 (勿煎)
射干	扁竹、 老君扇	苦、寒	清热解毒、 利咽消痰	对 S_{180} 有抑制 作用。	咽喉癌、肺癌	9~15

牛黄	犀黄、西黄	苦、甘、寒	清热解毒、祛痰开窍、镇惊	能增加红细胞、血色素,大剂量则有破坏作用。	脑肿瘤、肝癌、肺癌、白血病	0.3~0.6
小蓟	刺儿菜	甘、凉	凉血、止血	对EAC有抑制作用,能增强免疫功能。	胆囊癌、膀胱癌	15~30
大蓟	将军草 虎蓟	甘、凉	清热解毒	对U ₁₄ 细胞有抑制作用。	淋巴肉瘤、肺癌、甲状腺癌、肠癌、肝癌等	15~30
瞿麦	野麦 石竹	苦、寒	利水通淋、清热止血	体外试验对人体贲门癌及膀胱细胞有抑制作用。	泌尿系肿瘤、食管癌等	30~120
石燕		甘、凉	清热解毒、利水化湿		肝癌、肠癌、膀胱癌	30
莢蓟	金刚刺 铁制铃	甘、酸、涩	解毒消肿、活血止痛	对S ₁₈₀ 、S ₃₇ 、脑瘤 ₂₂ 有抑制作用。	肝、胆、胃、肠、胰腺癌,鼻咽癌	30~60、 100~150 (单用)
天花粉		甘、酸、寒	清热解毒、消肿排脓	对U ₁₄ 、S ₁₈₀ 、EAC有抑制作用并能抑制绒毛膜促性腺激素	宫颈癌、乳腺癌、绒癌、恶性葡萄胎	10~30

淡竹叶	竹叶 麦冬	甘、 淡、寒	清热利尿 除烦	对 S ₁₈₀ 及艾氏 腹水癌有抑制 作用,能提高 免疫力。	泌尿系肿瘤、 癌性发热	15~30
白头翁		苦、寒	清热解毒、 凉血止痢		肠癌	30
穿心莲		苦、寒	清热解毒、 消肿止痛	使人体滋养叶 肿瘤细胞出现 退行性改变, 增强机体免疫 功能。	恶性葡萄胎、 绒癌	10~15
墓头回	脚汗 草	苦、 涩、 寒、 奇臭	清热燥湿、 止血止带	对艾氏腹水瘤 有明显抑制 作用。	白血病、宫 颈癌、肝癌	9~15
马齿苋		酸、寒	清热解毒、 止痢疗疮		肠癌	30~60
七叶 一枝花	蚤体 重楼	苦、 微寒、 有小毒	清热解毒、 消肿止痛	对 S ₁₈₀ 、S ₃₇ 、 肝癌实体型有 抑制作用。	脑瘤、肝癌、 白血病、恶性 淋巴瘤及良性 肿瘤	15~30
美登木		苦、寒	清热解毒、 抗癌止痛	对 S ₁₈₀ 、Lewis、 肺癌、L ₁₂₁₀ 、 W ₂₅₆ 有显著的 抑制作用。	鼻咽癌	

野菊花	苦、寒 野山菊	辛、苦、凉	清热解毒、清肝明目	对人类宫颈癌细胞及小鼠艾氏腹水癌有明显抑制作用。	各种肿瘤	15~30
土茯苓		甘、平	清热、解毒、利湿	对JIC-26有抑制作用。	膀胱癌、肾癌、宫颈癌	20
肿节风	九节菜	辛、苦、平、有小毒	清热解毒、祛风通络	对S ₁₈₀ 、S _{p1} 、B ₂₂ U ₁₄ 等瘤株具有抑制作用。	消化道肿瘤	15~30
了哥王		苦、微辛、寒、有毒	清热利水、化痰散结	对小鼠淋巴瘤、S ₁₈₀ 、U ₁₄ 有抑制作用。	肺癌、乳腺癌、宫颈癌、恶性淋巴瘤、癌性胸水	9~15
石打穿	黄毛耳草	辛、苦、平	清热利水、散结	对U ₁₄ 有抑制作用。	食管癌、胃癌等各种肿瘤	15~30
石上柏	深绿卷柏	甘、平	清热解毒、活血	对S ₁₈₀ 、U ₁₄ 有抑制作用，增强机体代谢和网状内皮系统功能。	鼻咽癌、喉癌、肺癌、绒癌、恶性葡萄胎	30~60
农吉利		甘、淡、平	清热解毒	对S ₁₈₀ 有抑制作用。	皮肤癌、宫颈癌、食管癌	30~60

无花果		甘、 酸、平	清热、 润肺、 止咳	对艾氏肉瘤有 抑制作用。	肺癌、咽喉癌、 肠癌	30
丽江山 慈菇	毛慈菇	辛、 甘、 寒、 有小毒	消肿散结	主要为秋水 仙碱，对 ₁₉₇₅ 肝 癌实体型、 淋巴肉瘤、 大鼠S ₂₅₆ 有 抑制作用。	乳腺癌、淋巴 瘤、甲状腺癌、 皮肤癌、 良性肿瘤等。	9~12
山海螺	羊乳 四叶参	甘、平	清热解毒、 清肺祛痰、 消肿排脓	增加红细胞及 血红蛋白含量， 减少白细胞。	肺癌等	30~60
仙人掌	霸王树	苦、凉	清热解毒、 消肿止痛、 健胃	根部提取物有 防止癌细胞蔓 延之功。	腮腺癌、 肺癌、胃癌、 癌性疼痛	30
水红菱		甘、 涩、平	解毒消肿		乳腺癌、胃癌	30~45
马尾莲		甘、寒	清热燥湿 解毒	对W ₂₅₆ 、Lewis、 肺癌有效。	肝癌、肠癌、 肺癌	3~5
天葵子	千年 老鼠屎	甘、 凉、 有小毒	清热解毒、 利水消肿	对细菌等 有抑制作用。	肝癌、 乳腺癌、 淋巴肿瘤、 泌尿系瘤	3~9

鸦胆子		苦、平	化湿清热、 消积滞	对小鼠腹水型肝癌 细胞有明显杀伤作 用；有升高白细胞 的作用。	体表肿瘤	外用适量
-----	--	-----	--------------	--	------	------

(二) 活血化瘀类抗癌中草药

药名	别名	性味	功能	药理	应用	剂量(克)
铁树叶	苏铁	甘、 涩、微 温	活血止痛、 消肿化痰和 胃	体外碱对胃癌细胞 敏感。	肝癌、胃 癌、肺癌、 鼻咽癌等	15~30
白屈菜		苦、 涩、温	镇痛、止 咳、解毒、 消肿	对 S ₁₈₀ 、EAC 有 明显抑痛作用。	各种肿瘤	10~15
珍珠菜		辛、 涩、平	活血调经、 利水消肿	对 S ₁₈₀ 、S ₃₇ 、 U ₁₄ 、EAC 等有显 著抑制作用。	甲状腺癌、 宫颈癌、消 化道癌等多 种肿瘤	20~90
鬼箭羽	卫矛鬼 箭	苦、寒	破血行瘀	对小白鼠肉瘤 ₁₈₀ 、 大鼠克瓦癌 ₂₅₆ 有 抑制作用。	各种肿瘤	15~30

铁包金		苦、平	化瘀血、祛风湿、消肿毒		各种肿瘤	30~100
凌霄花		辛、微寒	活血祛风		各种肿瘤	3~9
石见穿	紫参	苦、辛、平	活血止痛	对 S_{180} 有抑制作用。	消化道肿瘤等各种肿瘤	30~60
老鹤草		微苦辛、平	活血通络		咽喉肿瘤	6~9
平地木	矮地茶 紫金牛	苦、平	活血祛瘀		消化道肿瘤、肝癌、肺癌	30~60
葵树子	蒲葵子	甘、涩、平	消肿、散瘀、止痛	对实验肿瘤、脑瘤 ₂₂ 有抑制作用。	脑瘤、鼻咽癌、食管癌、绒癌	30
急性子	凤仙花子	微苦、温、有小毒	软坚消症（积）、活血通经	体外试验对胃淋巴瘤细胞敏感。	食管癌、贲门癌、胃癌等	10~30
木鳖子		微苦、温、有小毒	散瘀解毒	鼻咽癌、胃癌	0.3~0.9	
地鳖虫	虻虫 土元	咸、寒、有小毒	活血散瘀	体外试验对白血病细胞有抑制作用。	肝癌、骨肉瘤、宫颈癌、多发性骨髓瘤	9~15

水红花子	酒药草	咸、微寒	散血消肿	有抗凝作用。	胃癌、肠癌、肺癌、胸腹水	9~30
穿山甲	岬片	咸、微寒	排脓解毒	有升高白细胞作用。	乳腺癌、宫颈癌、肝癌、恶性淋巴瘤及良性肿瘤	15~30
藏红花		甘、寒	活血祛瘀、凉血解毒		白血病、肝癌	0.9~3.0
威灵仙		辛、温	祛风除湿、通络止痉	对 S ₁₀₀ 有抑制作用。	喉癌、食管癌、肺癌、骨肉瘤	15~30
虎杖		苦、寒	活血止痛	虎杖根对 JIC-26 有抑制作用。	各种肿瘤及胸腹水	5~30
丹参		苦、微寒	活血祛瘀、凉血消痈、养血安神	有诱生干扰素的作用。	各种肿瘤	15~30
赤芍	京赤芍	辛苦微寒	祛瘀止痛、消肿散结		各种肿瘤	10~15
三棱	京三棱	苦、平	破瘀行气、软坚散积	对 S ₁₀₀ 有抑制作用。	肺癌、肝癌、胃癌、甲状腺癌、乳腺癌、宫颈癌、子宫良性瘤	9~15

莪术	文术	苦、 辛、温	同三棱	对 S_{18} 、 U_{14} 、 EAC 等均有 抑制作用。	宫颈癌等 多种肿瘤	9~15
郁金	玉金	辛、 苦、寒	行气止痛、 祛瘀利胆		肝癌、胆囊癌、 胰头癌	15~30
毛茛	老虎 脚迹草	辛、 温、 有毒	破冷气、 止痛	癌细胞广泛急 性坏死,可抑 制磷酸果糖 激酶。	肺癌、肠癌、 胃癌	外用适量
王不留行	留行子	苦、平	活血消肿、 通经下乳	对 EAC 人体 肺癌细胞有 抑制作用。	乳癌、肝癌、 软组织肿瘤、 泌尿系肿瘤等	15~20
姜黄		辛、温	破血行气、 通经止痛		肝、胆、 胰头癌	9~15
三七	参三七 田七	甘、 苦、温	化瘀止痛		各种肿瘤 (凝血型)	1~3.0
水蛭	蚂蝗	咸、 苦、平、 有毒	活血散瘀、 软坚消肿	水蛭素有抗 凝血作用。	卵巢癌、 食管癌、 肝癌、胃癌、 宫颈癌等	0.5~ 1.5 (吞服)、 3~9 (煎服)
麝香	当门子 元寸	辛、温	活血散瘀 止痛	对 Hela 细胞 及腹水癌细胞 有杀灭作用。	各种肿瘤	0.06~ 0.1 外用适量
蛭螂	铁甲 将军	咸、 寒、 有小毒	消瘀散结		鼻咽癌、 食管癌、 胃癌、肠癌 膀胱癌	3~15

柘木	柘桑	甘、温、无毒	化痰散结、消瘀止痛	对EAC、S ₁₈₀ 、u ₁₄ 有抑制作用,体外试验对食管癌细胞株有细胞毒作用。	消化道肿瘤	60~120
柘木	鸟不宿	微咸、温	散瘀止痛	对小鼠、AK肉瘤、实体型肝癌抑制作用。	胃癌、肠癌、胆管癌	15~30
柞木	红椴柞树	苦、涩、寒	散瘀、消肿、抗癌	对小鼠肉瘤有抑制作用。	胃癌、黄疸	15~30
娃儿藤	七层楼一见香	辛、温、有小毒	祛风化痰、解毒散瘀	对P ₃₈₈ 、L ₁₂₁₀ 、S ₁₈₀ 、W ₂₅₆ 、L ₆₁₅ 具抑制作用。	急性及慢性白血病、恶性淋巴瘤。	3~9
扛板归	河白草	酸、平	化瘀补血、清热解毒	对实验动物肿瘤有抑制作用。	食管癌、肝癌、胃癌、肠癌、前列腺癌、睾丸胚胎瘤	15~30
漆姑草	珍珠草、地松	苦、辛、凉	消痈肿瘰癧	对S ₁₈₀ 、W ₂₅₆ 、U ₁₄ 、L ₆₁₅ 有抑制作用。	恶性淋巴瘤、粒细胞性白血病	30~40

猕猴桃		酸、甘、寒	祛瘀清热	其根对 S ₁₈₀ 、U ₁₄ 有抑制作用。	各种肿瘤	30~60
-----	--	-------	------	--	------	-------

(三) 扶正固本类抗癌中草药

药名	别名	性味	功能	药理	应用	剂量(克)
人参		甘、苦、温	大补元气、生津宁神	能增强机体免疫功能，对某些移植性肿瘤亦有抑制作用。	各种肿瘤有气虚表现者	3~10
白术		苦、甘、温	健脾燥湿、利水止汗	对 S ₁₈₀ 、EAC 有抑制作用。	消化道肿瘤、肺癌、子宫颈癌等各种肿瘤	15~30
黄芪		甘、微温	补中益气、托里排脓	提高人、小鼠血浆 CAMP 含量，提高淋巴细胞功能，能升小鼠白细胞。	消化道肿瘤、肝癌、肺癌、妇科肿瘤等各种肿瘤。	10~30
棉花根	上黄芪	甘、温	补气、止咳、平喘	对 S ₁₈₀ 、EAC 有抑制作用，局部应用对溃疡型，黑色素瘤有明显抑制作用。	喉癌、食管癌、肺癌、肝癌、精原细胞瘤	15~30

扁豆		甘、 微温	健脾化湿	可刺激体内淋巴 细胞转化为 杀瘤细胞。	消化系肿瘤	30
刺五加	南五加 五加皮	辛、温	祛风强筋 活血止痛	对多种动物移 植性肿瘤有 抑制作用， 能提高机体非 特异性免疫 功能。	骨肉瘤及肿瘤 骨转移疼痛、 放化疗后的 白细胞减少	15~30
云芝	瓦菇	甘、平		对 S ₁₈₀ 、津白 一号小鼠宫颈 癌有一定的抑 制作用，增强宿 主的免疫性。	白血病、淋巴瘤 胃癌、乳腺癌、 宫颈癌等多种肿 瘤，多与化疗、 放疗手术合用	20~50
灵芝	云芝 紫芝	淡、温	滋养强壮	对 S ₁₈₀ 有抑制 作用，对细胞 免疫和体液 免疫均有增 强作用。	肺癌、食管癌、 胃癌等，与 其他抗癌药、 化疗、放疗合用	6~15
补骨脂	破故纸	辛、 苦、温	温肾壮阳	对 S ₁₈₀ 、EAC 有抑制作用， 有升高白细胞 作用和抑制 霉菌作用。	骨肉瘤、肿瘤 骨转移、肺癌、 肠癌、化疗、 放疗后的白细 胞减少	9~15

沙参	南沙参 三叶沙参	甘、寒	生津润肺 止咳养胃	内含花楸甙素， 对艾氏腹水癌 及肉瘤45抑制 作用较大。	各种肿瘤 虚证	15~30
天门冬	天冬 寸冬	甘、 微苦、 寒	养阴清肺	对 S ₁₈₀ 有 抑制作用。	乳腺癌及小叶 增生、肺癌、 白血病	10~15
百合		甘、 微温	润肺止咳 宁心安神	对 S ₁₈₀ 、U ₁₄ 有抑制作用。	肺癌、 淋巴肉瘤	30~60
旱莲草		甘、 酸、凉	止血排脓	妇科肿瘤	20~30	
甜菜		甘、平	补益生津	甜菜汁对白血 病细胞及实体 瘤有抑制作用。	膀胱癌、白血 病、淋巴肉瘤	30
鳖甲	上甲 甲鱼壳	咸寒	清热散结	药敏试验对肝 癌细胞有敏感 作用，并增强 免疫力。	各种肿瘤	15~30
龟板	下甲 乌龟壳	甘、 咸、寒	滋阴降火 益肾健胃	能提高机体抗 肿瘤及免疫 能力。	肺癌、肝癌、 肾癌、恶性 淋巴瘤	9~20

薏苡仁	米仁 苡仁	甘、 淡、 微寒	健脾利 湿排脓	对 S ₁₈₀ 、Yoshida 肉瘤有抑制作用， 薏苡仁酯有抑制 U ₁₄ 、EAC 的作 用。	肺癌、肠 癌、胃癌、 宫颈癌、绒 毛癌、扁平 疣	15~30
槲寄生		甘、 苦、平	槲寄生蛋白 质对恶性肿 瘤细胞有抑 制作用，其 提取物具有 增强机体免 疫功能。	被肝肾，强筋骨， 安胎下乳	乳腺癌、宫 颈癌、卵巢 癌、肺癌、 胃癌	30~60
薜荔果	木馒头 鬼球	甘、平	活血消肿 补肾通乳	有滋养强壮作用。	宫颈癌、乳 腺癌、前列 腺癌、睾丸 肿瘤	15~30
山核桃		甘、平	滋润补肾		肺癌及各种 虚证	30~60
核桃 树皮	胡桃枝	甘、 涩平	解毒消肿 补肾涩精	对 S ₃₇ 有抑制作 用，核桃青衣有升 白细胞及血小板作 用。	各种肿瘤	30~120 (枝) 10~15 (青衣)

岩白菜		甘、平	滋补、止血		肺癌咯血 胃癌吐血	10~15
韭菜籽		辛、 甘、温	温肾、壮 阳、固精		食道癌、胰腺癌	3~9

(四)以毒攻毒类抗癌中草药

药名	别名	性味	功能	药理	应用	剂量(克)
斑蝥	斑虻 花斑毛	辛、 寒、 有毒	破血、 攻毒、 散结	对 S_{180} 及网 织细胞肉瘤 有抑制作用。	食管癌、肺癌、 乳癌、肺癌、 肝癌、胃癌、 皮肤癌	0.3~ 0.6 (大者 一只、小 者两只)
马钱子	木鳖	苦、 寒、 大毒	通络、 消肿、 止痛	对 S_{180} 有 抑制作用。	食管癌、 胃癌、肠癌、 肺癌等	0.06~ 0.3 (炙吞) 1.0 (煎服)
八角莲	独叶 一枝花 鬼白	甘、微 苦、 凉、 有毒	清热解毒 活血散瘀	对各种动物 肿瘤细胞 均有抑制作用。	腮腺癌、乳癌、 肺癌、卵巢癌、 宫颈癌、 皮肤癌	3~9
独角莲	独叶 一枝花 八角莲	大温 有毒	镇痛祛寒	含鬼白毒素能 抑制细胞中期 的有丝分裂。	食管癌、 胃癌、喉癌	3~10 (外用)

全虫	全蝎 蝎子	辛、 平有毒	通络散瘀 解毒		各种肿瘤	0.9 (吞服) 9.0 (煎服)
蜈蚣	百脚	辛、 温有毒	祛风止痛 解毒消肿	对实验动物 肿瘤有抑 制作用。	脑瘤、软组织 肿瘤、脑瘤骨 转移、癌性疼痛	0.3~ 0.9 (吞服) 1~3条 (煎服)
壁虎	天龙 守宫	咸、 寒、 有小毒	祛风定惊 化瘀散结	体外抑制肝癌 细胞呼吸， 对细菌、真菌 有抑制作用。	脑肿瘤、神经 系统肿瘤， 食管癌、肺癌、 肝癌等	0.3~ 0.9~ 1.5 (吞服) 1~2条 (煎服)
露蜂房	蜂房 马蜂窝	甘、 平有毒	解毒消肿 活血	体外实验抑制 肝癌胃腺细胞。	舌、喉、喉、 肺癌、乳腺癌、 骨肉瘤等。	9~15
蜂酥		甘、辛 温有毒	解毒消肿 开窍	华蟾酥毒素和 华蟾酥次毒 均有明显抗 肿瘤作用。	食管癌、胃癌、 肠癌等	0.015~ 0.03

蟾皮	癩蛤蟆	辛、 凉微毒	清热解毒 利水消胀	蟾酥皮制剂 对 S_{180} 有 抑制作用。	各种肿瘤	3~9
玉簪 花根		甘、 辛、 寒、 有毒	拔脓解毒	对小鼠白血 病 ₄₁₅ 有一些 抑制作用。	乳癌、肝癌	3~9
巴豆		辛、 温大毒	泻下逐水 祛痰蚀疮	对 S_{180} 、 U_{14} EAC、 H_{22} 有 抑制作用。	肝癌、肠癌、 晚期癌淋 巴转移	制成巴 腊丸 2~3 次/日， 3~8 丸/次
砒霜		辛、 大热 有毒	蚀疮去腐	对小白鼠肉 瘤 ₁₈₀ 有 抑制作用。	皮肤癌	外用适量
石蒜		辛、 温有毒	消肿解毒、 催吐	石蒜碱对小白 鼠肉瘤 ₁₈₀ 有抑制作用， 对艾化腹水 癌、腹水肝癌 有抑制作用。	胃癌、宫颈癌、 体表肿瘤	外用适量 1.5~ 3.0
雄黄		辛、 温有毒	解毒杀虫	对 S_{180} 有抑制 作用。	脑肿瘤及各种 肿瘤疼痛、体 表肿瘤。	内服 0.3 外 用适量

断肠草	钩吻、野葛	辛、温大毒	攻毒拔毒 散瘀止痛		肝癌、皮肤癌、骨肉瘤	已制成片剂
八角金盘		苦、辛、凉有毒	清热解毒 消肿散结	鬼臼毒素能抑制细胞的有丝分裂。	乳腺癌、胃癌	6~9

(五)软坚散结类抗癌中草药

药名	别名	性味	功能	药理	应用	剂量(g)
海藻	海萝	咸、寒	消痰散结	提取物对肿瘤有抑制作用。	各种肿瘤	9~15
昆布	海昆布 鹅掌菜	咸、寒	消痰散结	内含琼胶酸有预防白血病的作用。	各种肿瘤	9~15
黄药子	黄独	苦、辛、寒	解毒消肿 化痰散结	对S ₁₈₀ 有抑制作用。 黄药子油对U ₁₄ 有抑制作用。	甲状腺癌、食管癌、胃癌、肠癌、甲状腺和乳腺的良性肿瘤	15~30
徐长卿	聚刁草	辛、温	消肿解毒	所含牡丹酚有镇痛的作用。	各种肿瘤	6~12
硼砂	白硼砂 紫硼砂	咸、寒	软坚消积 化痰散结	有细胞毒作用。	食管癌、贲门癌	0.3~0.6 (冲服)

夏枯草	灯笼头	辛、苦、寒	清热泻水 软坚散结	对 U_{14} 、 S_{180} 有抑制作用。	甲状腺癌、 乳腺癌、肝癌 及良性肿瘤	15~30
八月扎	预知子	苦、平	疏肝理气 散结	对 S_{180} 、 S_{37} 有抑制作用。	肝癌、乳腺癌、 肺癌、消化 系统肿瘤	6~30
皂角刺	皂刺 天丁	辛、温	托毒排脓 活血消癰	对 S_{180} 有抑制 作用。	乳腺癌、肺癌、 食管癌、肠癌、 宫颈癌及癌症 术后胸膜粘连	15~30
皂荚	皂角 牙皂	辛、温 有小毒	消痰破坚 通窍杀虫		喉癌	5~10
牡蛎	生牡蛎 煅牡蛎	咸、涩、 微寒	软坚散结 固涩制酸	体外试验对 肿瘤有抑制 作用。	甲状腺癌、 恶性淋巴瘤、 肺癌、肝癌、 胃癌、神经 系统肿瘤	30~60
海蛤壳	蛤壳 文蛤	苦、咸、平	清肺化痰 软坚散结	提取物能抑制 海拉细胞及小 鼠 S_{180} 、K—2 癌细胞生长。	甲状腺癌、 肺癌、胃癌	30
过路黄	对座草 路边黄	微咸、平	利尿通淋 清热消肿	对艾氏腹水癌 有抑制作用	肝、胆、 胰头癌、 膀胱癌	30~60

茵 陈	蛇六谷	辛、 寒、 有毒	消肿解毒 化痰散结	药敏试验对贲 门癌、结肠癌 细胞敏感。	脑肿瘤、 腮腺癌、 恶性淋巴瘤、 肺癌、乳癌	15~30
-----	-----	----------------	--------------	---------------------------	---------------------------------	-------

(六)化痰利湿类抗癌中草药

药名	别名	性味	功能	药理	应用	剂量(g)
天南星	南星	苦、辛、温有毒	化痰散结	鲜南星提取物对 S_{180} 有抑制作用。	食管癌、肺癌、宫颈癌、神经系统肿瘤等。	10 (内服) 外用适量
半夏		辛、温有毒	燥湿化痰	对实验动物肿瘤及子宫颈癌等有一定抑制作用。	食管癌、胃癌、舌癌、宫颈癌	9~15
桔萎	瓜萎	甘、寒	宽胸下气 化痰散结	对实验动物肿瘤有抑制作用,并有较强的抗菌作用。	肺癌、乳腺癌、胰腺癌、胃癌	9~30
僵蚕	姜虫 天虫	咸、辛、平	化痰散结 息风解痉	对 S_{180} 有抑制作用。	神经系统肿瘤、恶性淋巴瘤、喉癌、肺癌	9~15
紫苑		辛、苦、温	化痰止咳		肺癌	15~30
石菖蒲		辛、温芳香	芳香化湿 开窍祛痰	体外试验能杀死腹水癌细胞,对动物移植性肿瘤有抑制作用。	消化道肿瘤、脑瘤	10~15

泽漆	猫儿眼睛草	辛、苦、微寒	利水消肿 化痰散结	对 S_3 、 S_{180} 等有抑制作用。	淋巴肉瘤、 肝癌、肺癌	15~30
泽泻	水泽泻	甘、寒	利水渗湿 泻热	对实体肿瘤 细胞有抑制 作用。	膀胱癌、胃癌	30~60
猪苓		甘、平	利水渗湿、 抗癌	对小鼠移植性 肿瘤腹水型肉 瘤 S_{180} 有明显 抑制作用。	肺癌	30~60
石韦	肺心草 小石韦	苦、 微寒	利水通淋	有提升白细胞 的作用。	肺癌,膀胱癌, 放疗、化疗 后白细胞减少	15~30

(七)其他抗癌中草药

药名	别名	性味	功能	药理	应用	剂量(g)
金剪刀	河边威 灵仙	辛、 咸微苦 、温	消肿止痛		脑肿瘤	30~120 (外敷)
寻骨风	白毛藤	苦、平	祛风化湿 通络止痛	对 S ₃₇ 有 抑制作用。	肺癌、骨肿瘤、 宫颈癌	15~30
猫人参	痛草	苦	清热解毒 消肿止痛 杀菌		肝癌等	69~90
天胡荽	滴滴 金满天星	辛、平	消肿止痛	体外试验对 白血病细胞 有抑制作用。	肝癌等	15
毛冬瓜		微辛、 苦、寒	清热利湿 活血消肿、 解毒		乳癌、胃癌、 鼻咽癌	30~60
乌梅		酸、平	敛肺、 涩肠、 生津、 安蛔	对 S ₁₈₀ 有 抑制作用。	肠癌、肺癌	9~15
诃子		苦、 酸、 涩平	涩肠止泻 敛肺利咽	对 EAC、S ₁₈₀ 、 EC 有抑制 作用。	肠癌、 咽喉癌、 肺癌	9~15
蛇蜕		甘、温	祛风止痛		各种肿瘤	3~9

木瓜		酸、温	舒筋活络 和骨化湿	对小鼠 EC 癌细胞、EAC 有明显的抑制作用。	胃癌、骨肉瘤、 癌性浮肿	9~15
木通		苦、寒	降火利尿、 通乳	能抑制肿瘤 细胞生长	膀胱癌、 乳腺癌、 舌癌	9~15
大蒜		辛、温	健胃止痢 止嘔杀菌	对精原细胞 瘤、U ₁₄ 、ARS、 S ₁₈₀ 、CSN ₃ 、 CSN ₇ 肝癌 有抑制作用。	肺癌、肠癌、 宫颈癌	9~15
防己		粉防己 汉防己 米防己	利水消肿 祛风止痛	对大鼠 W ₂₅₆ 有显著的 抑制作用。	肾癌、膀胱癌、 骨肿瘤、肺癌	9~15
竹黄			镇咳化痰	有免疫刺激 作用,减少胸 水和减轻化 疗药副反应。	各种肿瘤与 化疗药合用。	
紫树				对 W ₂₅₆ 、S ₃₇ S ₁₈₀ 、U ₁₄ 有效。	对头部肿瘤、 肺癌、胃癌 有一定疗效。	
蝮蛇		甘、 温有毒	祛风、攻毒	对 S ₃₇ 、S ₁₈₀ 肝肉瘤、EAC 等 均有抑制作用。	胃癌、食管癌 及癌症疼痛	粉: 5~10

闹羊花					对食管癌有一定疗效。	20
燕山参	马陆	辛、 温有毒	破积、解毒	对 U ₁₄ 、Lewis 肺癌、S ₁₈₀ 、 EAC 有较显著抑制作用， 毒性小。	对乳腺癌、 食道癌 有一定疗效。	外用适量
两面针	人地金 牛山椒	辛、 苦微温	散瘀止痛 解瘀消肿、 祛风活络	体外对 S ₁₈₀ 、 腹水癌细胞有 抑制作用。	对慢性粒细胞 白血病、肝癌 有一定疗效。	
大茶药				对 S ₁₈₀ 有 抑制作用。	消化道肿瘤、 淋巴肉瘤、 神经纤维瘤等	0.1~ 1.0
香叶 天竺葵				对 S ₃₇ 、S ₁₈₀ 、 W ₂₅₆ 有抑制 作用。	对宫颈癌、 直肠淋巴肿瘤 有一定疗效。	

类别	药物品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
烷化剂	2. 环磷酰胺 (癌得星, 安道生) Cyclophosphamide, Endoxan, Cytoxan, CTX, CYT, CPA, BS18 白色结晶, 易溶于水避光, 免高热、光照, 32℃以下保存, 配液必须于2~3小时内用完。	片剂 50 毫克 针剂 100 毫克、200 毫克。	静注	60~120 毫克/平方米, 每日或隔日一次, 8~10 克为一疗程	恶性淋巴瘤、“急淋”、肺癌、乳腺癌、卵巢癌、绒毛膜癌、多发性骨髓瘤、睾丸瘤、神经母细胞瘤、膀胱癌、横纹肌肉瘤、霍乱样霍乱病、非肿瘤性疾病(如肾实质、顽固性哮喘等)	同氮芥。	同氮芥。
			动脉灌注	200~400 毫克/次, 每日一次			
			口服	50~100 毫克/次, 2次/日			
			冲击量	静注量的 4~5 倍, 一次静注(严密观察)			

类别	药物品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
烷化剂	3. 消瘤芥 Nitrocaphane, AT—1258 淡黄色固体, 见光易变色, 溶于水呈淡黑色或淡棕色, 避光、热	片剂 10 毫克、针剂 20 毫克、40 毫克	静注	成人 20~40 毫克/次, 每日或隔日一次, 总量 200~300 毫克	肺癌、喉癌、鼻咽癌、头颈部肿瘤、乳腺癌、瘤性胸腹水、恶性淋巴瘤、食管癌、胃癌、肝癌、绒毛膜癌、软组织肿瘤、急性白血病	同氮芥	同氮芥
			动脉注射	剂量同静注			
			胸腔腔注射	40~80 毫克/次, 每周 1~2 次			
			瘤内注射	20 毫克/次, 每日一次, 分点注射			
			口服	60 毫克/日, 10~14 天为一疗程			

类别	药物品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
烷化剂	4. 异环磷酰胺 (和乐生) Ifosfamide IFO	针剂400毫克	静注	1. 2~2.4克/平方米/日, 每周1~2次	肺癌、乳腺癌、卵巢肿瘤、恶性淋巴瘤、头颈部癌肉瘤	骨髓抑制较环磷酰胺轻, 消化道反应、肾脏毒性较重。	同氮芥
	5. 左旋苯丙氨酸氮芥(米兰法兰, 马法兰, 左旋海狗肉瘤素) Melfalan, Alkeran, MEL, LPAM	片剂0.5毫克、1毫克	口服	0.05~0.25毫克/公斤/日, 或10毫克/平方米/日, 或0.75毫克/公斤/周或2~10毫克/平方米共4~7日口服。	1. 同溶肉瘤素。 2. 动脉瘤注治疗恶性黑色素瘤、骨肉瘤。 3. “慢淋”。	1. 同氮芥但较轻。 2. 用生理盐水稀释。	CCNSA
	6. N-甲基硫内瘤素(氮甲, N-甲) N-Formylsarcosine	片剂500毫克	口服	50毫克/次, 3次/日, 总量6~8克	1. 同溶肉瘤素。 2. 肺癌。	同上	CCNSA

类别	药品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
烷化剂	7. 苯丁酸氮芥(瘤片剂 2 毫克纸型片 2 毫克) Aminophenylbutyric, Chlorambucil, Leukeran, CB-1348		口服	2~4 毫克/次, 3 次/日, 总量 300~600 毫克。维持量 0.03~0.1 毫克/公斤/日。	慢淋、恶性淋巴瘤、多发性骨髓瘤、乳腺癌、卵巢瘤、神经母细胞瘤、红细胞增多症	1. 同氮芥但较轻。 2. 骨髓反应主要为淋巴细胞下降, 对粒细胞和血小板影响较轻。 3. 大剂量损伤肝功能。	同氮芥。
	8. 抗黑瘤: (三氮唑啉胺、氮芥、氮烯啉胺) Dacarbazine, DTIC, DIC	200 毫克 针剂	静注	每天 250 毫克/平方米, 共 5 天, 每周重复给药, 单次剂量每次 650~1450 毫克/平方米, 每 4~6 周一次。	恶性黑色素瘤、恶性淋巴瘤、骨软组织肉瘤、脑瘤、肾癌、肝癌、睾丸瘤、平滑骨肉瘤、横纹肌肉瘤、神经母细胞瘤。	1. 骨髓抑制 2~4 周后出现胃、肠道反应、流感样症状、发烧寒战。 2. 肝肾损伤。 3. 局部刺激性疼痛。	CCNSA, 各期 (G ₁ , S 期), CCSA: G ₂ 期 (本药对细胞周期的作用有两种认识)

类别	药物品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
烷化剂	9. 顺氯氨铂 (顺粉针剂 10—双氯双氨络毫克, 20 铂, 氯氨铂) Cisplatinelotide PDD, DDP		静注	20 毫克 / 平方米 / 日, 用 5 天间隔 2—4 周可用 4—5 个疗程。	鼻咽癌、头颈部鳞癌、肺癌、胚胎性腺癌、卵巢癌、甲状腺癌、纤维肉瘤、横纹肌肉瘤、恶性淋巴瘤	1. 胃肠道反应重。 2. 骨髓抑制轻。 3. 肾功能损伤较重。	CCNSA, 抑制 DNA、RNA 蛋白质合成。
			动脉注射	20—40 毫克 / 日, 间隔 2 周, 可重复第二疗程。			
	10. 卡铂 (碳铂) Carboplatin, ParaplatinCBP, JM-8	100 毫克 针剂		100 毫克 / 次 / 日, 连用 5 天, 4 周重复或 300 毫克 / 平方米 / 次, 4 周一次。	同顺铂	消化道反应及肾毒性低于顺铂, 骨髓抑制较顺铂重; 耳毒性、神经毒性	同顺铂

类别	药物品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
烷化剂	11. 噻啶亚硝脲 Nimustine ACNU, NIDRAN	针剂 25 毫克、50 毫克	静注	2~3 毫克/公斤/次 6 周重复, 总量 300~500 毫克, 或 2 毫克/公斤/次, 每周一次, 给 2~3 次。	胃癌、食管癌、结肠癌、肺小细胞癌、转移性肺癌、恶性淋巴瘤、慢性粒细胞性白血病。	延缓性骨髓抑制, 轻度胃肠反应及一时性转氨酶上升。	CCNSA
	12. 卡氮芥(双氮乙亚硝脲) Carmustinum, BCNU	针剂或粉针剂 125 毫克	静滴	75~100 毫克/平方米, 连用 2 日, 或 200 毫克/平方米, 一次静滴, 重复给药不应少于 6~8 周的间隔。	脑瘤、恶性淋巴瘤、白血病脑浸润、肺癌、恶性黑色素瘤、多发性骨髓瘤、尤文氏瘤、胃肠道瘤、前列腺瘤、睾丸肿瘤。	同氮芥, 但骨髓抑制出现较晚, 分别于 8~10 天、28~32 天二次降低。大剂量对肝肾功能损伤, 具高脂溶性, 能通过血脑屏障。	CCNSA。主要作用于 G ₁ 期, G ₁ /S 边界期, M 期, 对 G ₂ 期有延缓作用。对 G ₀ 期也有作用。

类别	药物品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
烷化剂	13. 环己亚硝脲 (氮乙环己亚硝脲) Lomustin, CCNU	胶囊 40 毫克, 100 毫克	口服	130 毫克/平方米/次, 6~8 周一次, 或 75 毫克/平方米/次, 每 3 周一次。	同 BCNU	同 BCNU	同 BCNU
	14. 甲环亚硝脲 (甲基氮乙环己亚硝脲) Semustium, MeCCNU	胶囊 50 毫克, 100 毫克	口服	150~200 毫克/平方米/次, 6~8 周一次, 2~3 次为一疗程。	同 BCNU, 但毒性较低, 口服吸收迅速	同 BCNU	同 BCNU
	15. 马利安 (白消安, 麦里福浪, 白血福恩, 二甲磺酸丁酯) Myleran, Busulfan, CB-2401, BUS	片剂 2 毫克	口服	4~8 毫克/日, 维持量 0.3~3 毫克/日, 或每周 2 次。	1. 抑制骨髓 2. 肺纤维化 3. 消化道反应 4. 色素沉着、脱发、疹、睾丸萎缩等。	CCNSA	

类别	药品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
烷化剂	16. 噻替派(三肢针剂 5 毫克、10 毫克) ThioTEPA Tespamin, TSPA 避光 湿, 限期一年, 变黄、混浊停用。		静注或肌注	6 毫克 / 平方米, 连续用 4 日, 间隔 2~7 周重复注射。总量 200~300 毫克。	卵巢癌、乳腺癌、消化道癌、肝癌、胰腺癌、甲状腺癌、肺癌、恶性淋巴瘤、恶性黑色素瘤、宫颈癌、膀胱癌。	同氮芥	CCNSA
			胸腔注射	开始 60 毫克, 控制成人恶性胸腔积液, 间隔一周或以上, 只有在血象从最低点恢复后方能重复给药。			
			动脉灌注	10~20 毫克 / 次 / 日			
			膀胱灌注	50~100 毫克 / 次, 1~2 次 / 周, 10 次为一疗程。			
			鞘内注射	1~10 毫克 / 平方米, 每周一次。			

类别	药品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
烷化剂	17. 二溴卫矛醇 DIBROMOD- ULCITOL, DBDDibromod- ucitolum, DBD	片剂125毫克, 250毫克	口服	3~5毫克/公斤/日, 连用42天为一疗程。	1. 慢粒 2. 乳腺癌 3. 何杰金氏病 4. 恶性黑色素瘤 5. 头颈部肿瘤 6. 肾癌、胃癌、皮肤癌	同马利兰	CCNSA
	18. 二溴甘露醇 Dibromoman- nitol, Myelo- bromol, DBM	胶囊250毫克, 片剂50毫克	口服	5毫克/公斤/日, 总量10~15克, 维持量5~10毫克/公斤/周	1. 慢粒 2. 真性红细胞增多症	同马利兰	CCNSA

类别	药物品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用部位
烷 化 剂	19. 抗癌新芥 (邻脂苯芥, 邻 丙氨酸氮芥) Ocapahanum, AT-581	片剂 10 毫克, 粉 针剂 10 毫克	静注	10 毫克/次/日, 150~250 毫克为 一疗程。	癌性胸腹水、肺 癌、头颈部恶性肿 瘤、乳腺癌、绒毛 膜癌、恶性淋巴 瘤、肝癌	同氮芥。	同氮芥。
			动脉注	剂量同静注			
			腹腔注	20~30 毫克/次, 每周 1~2 次。			
			胸腔注				
			射				
	20. 苯丙氨酸 氮芥(倍肉瘤 素) Sarcolysin, Phenylalanine, Mustardum	片剂 10 毫克, 针 剂 20 毫 克、40 毫克	半身 阻断	10 毫克/次/日, 或隔日。	多发性骨髓瘤、精 原细胞瘤、恶性淋 巴瘤、尤文氏瘤、 恶性黑色素瘤、卵 巢瘤、乳腺癌、红 细胞增多症、恶性 血管内皮瘤	1. 同氮芥但较 重。 2. 用生理盐水稀 释。	CCNSA
			口服	20~30 毫克/日, 10~14 天为一疗 程。			
			口服	8~10 毫克/日或 40~50 毫克/次, 1 次/周, 总量 180 ~200 毫克			
			静注	同口服剂量			
			胸腔注	20 毫克+生理盐 水 10 毫升			
			射				
			注射	同口服剂量。			
			射				
			射				
			射				

类别	药品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应 及注意事项	作用于细胞 周期
烷化剂	21. 甲氧基溶 肉瘤素(甲氧芳 芥, 3P) Methoxysar- colysinum	片剂 25 毫克	口服	25 毫克/日, 总量 500 ~ 1,000 毫 克。维持量每周 1 ~ 2 次, 每次 25 毫 克。	1. “慢粒” 2. 恶性淋巴瘤 3. 骨转移癌止痛 4. 肺癌、乳腺癌、 多发性骨髓瘤	同溶肉瘤素	CCNSA
	22. 噻啉苯芥 (原噻啉芳芥, 合-520)	片剂 2.5 毫克	口服	2.5 毫克/次, 2 ~ 3 次/日, 或 2.5 毫 克/次, 3 次/日, 服 2 ~ 5 天, 停 2 ~ 5 天, 总量 100 ~ 150 毫克。	1. “慢粒” 2. 恶性淋巴瘤 3. 精原细胞瘤 4. 乳腺癌、鼻咽 癌 5. 蕈样霉菌病	同氮芥	CCNSA
	23. 异氨基溶 肉瘤素(抗瘤氨 酸, 合-14, β - 溶肉瘤素, 异位 溶肉瘤素, Lsoscareolysinum	片剂 25 毫克	口服	25 毫克/日, 总量 500 ~ 1,000 毫 克。	1. 同甲氧芳芥 2. 精原细胞瘤 3. 蕈样霉菌病	1. 同氮芥。 2. 偶有皮肤搔痒 及黄疽。 3. 本品有蓄积作 用, 不能大量久 服。	CCNSA

类别	药品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
烷化剂	24. 胸腺嘧啶氮芥(63-2) Thyminalkylaminium	粉针剂1毫克, 5毫克	静注	1毫克/次/日 4毫克/次/日或隔日, 总量40~80毫克.	1. 成骨肉瘤 2. 卵巢癌 3. 宫颈癌 4. 恶性淋巴瘤 5. 鼻咽癌 6. 乳腺癌	同氮芥	CCNSA
	25. 亚胺醌(癌抑散) Ethylenimin-oquinonum, A-139	粉针剂10毫克	静注	10毫克/日, 总量200~400毫克.	1. 恶性淋巴瘤 2. “急粒” 3. 乳腺癌 4. 肺癌 5. 胃腺癌	1. 同氮芥 2. 用生理盐水稀释	同氮芥
	26. 苯丙氨酸芥肽 Peptichemio (PTC) 使用时避光.	粉针剂1毫克	静滴	每日1~1.5毫克, 30~45分钟滴完, 3~5日为一疗程.	神经母细胞瘤及儿科肿瘤疗效较好, 何杰金氏病, 非何杰金淋巴瘤、肺癌、膀胱癌	胃肠道反应, 偶有暂时性休克.	

类别	药品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应 及注意事项	作用于细胞 周期
烷 化 剂	27. 甲磺亚胺丙醇粉针剂 1 (吉雄 864) Yoshi864	毫克	静注	每日 2 毫克 / 公斤 / 日 分 6 次, 隔 6 小时 周重复给药。	慢性粒细胞性白血病, 淋巴瘤, 卵巢癌, 膀胱癌。	骨髓毒性及胃肠道反应轻微。	
	28. 甘露醇氮芥 Mannitolmustard, BCM	针剂 50 毫克	静注	1-2 毫克 / 公斤 / 日 或隔日, 总量 600-800 毫克。	1. 慢性白血病。2. 恶性淋巴瘤。3. 浆细胞肉瘤。	同氮芥	CCNSA
	29. 多潘甲氧嗪 氮芥 Dopanum	片剂 1 毫克、2 毫克、5 毫克	口服	10 毫克 / 次, 每日 一次, 总量 50-70 毫克	1. 慢粒。2. 何杰金氏病。3. 浆细胞肉瘤	同氮芥	CCNSA
	30. 癌宁 (三乙 烯聚氧胺) Tretamine (TEM)	片剂 2.5 毫克	口服	2.5-5 毫克与碳酸氢 钠 2 克同服每日 一次, 服三天后改为 每周 2.5 毫克, 总量 20-40 毫克。	1. 恶性淋巴瘤。2. 神经母细胞瘤。3. 视网膜母细胞瘤。4. 卵巢癌	同氮芥	同氮芥

类别	药品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
抗代谢类	1. 氨甲喋呤 (氨基叶酸) Methotrexate, Aminopterin, MTX	片剂 2.5 毫克, 5 毫克, 粉剂 5 毫克, 10 毫克	口服	5~10 毫克/日, 总量 10~15 克。	1. 绒毛膜上皮癌、恶性葡萄胎。 2. 急性白血病。 3. 恶性淋巴瘤 4. 其它: 头颈部肿瘤、肺癌、卵巢癌、乳腺癌、骨肉瘤、肝癌、神经母细胞瘤、消化道肿瘤	骨髓抑制、胃肠道反应、皮疹、色素沉着、脱发、致畸胎。肝肾功能不全禁用。	CCSA, 主要作用于 S 期, G ₁ /S 期交界, 并对 G ₁ /S 期边界有延缓作用。
			肌注 静注	20~30 毫克/次, 2 次/周			
			动脉灌注	15~25 毫克/日, 同时肌注甲酰四氢叶酸钙解毒			
			鞘内注射	10 毫克/次, 1 次/周, 5 次为一疗程。			
	2. 氨喋呤(氨基叶酸, 白血宁, 癌得宁) Aminopterin, AGPA	片剂 0.5 毫克	口服	0.25~0.75 毫克/日, 一般服 3~4 周始见效。	1. 急性白血病。 2. 绒毛膜上皮癌 3. 乳腺癌 4. 卵巢癌	因毒性较 MTX 大, 现已少用。	CCSA (即细胞周期特异性药物)

类别	药品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
叶酸拮抗类 抗代谢类	3,5-氟尿嘧啶	片剂 50 毫克, 针剂 250 毫克, 软膏 5%~10%	静注	500 毫克/次, 2 次/周, 或 750 毫克/次, 1 次/周, 总量 8~12 克	绒毛膜上皮癌、恶性葡萄胎、消化道癌、肝癌、胰腺癌、肺癌、乳腺癌、肾癌、膀胱癌、卵巢癌	1. 骨髓抑制。 2. 胃肠道反应。 3. 脱发、皮疹 其它: 色素沉着、局部刺激, 暂时性小脑运动失调、偶有心脏影响。	CCSA, 对增殖细胞 S 期有杀伤作用, 并对 G ₁ /S 期边界有延缓作用。
	Fluorouracil 5-FU		动脉灌注	250~500 毫克/H, 总量 5~10 克			
			腔内注射	750~1,000 毫克 1 次, 5~7 人次。			
			口服	150~300 毫克 H, 总量 10~15 克。			
			外用	5~10% 软膏, 1~2 次/日			

类别	药品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
抗代谢类	4. 呋喃氟尿嘧啶 Florafurum FT-207	片剂 50 毫克, 针剂 400 毫克	静滴	800 毫克/日, 总量 20~40 克	1. 胃癌、直肠癌 2. 胰腺癌 3. 肝癌 4. 乳腺癌	同 5-FU 但较轻	
	5. 双呋喃氟尿嘧啶 (双呋喃嘧啶、双四氢呋喃嘧啶) FD-1	片剂 50 毫克	口服	600~1000 毫克/日, 总量 20~40 毫克	胃癌、肠癌、贛门癌、食管癌、乳腺癌、肝癌、肺癌	消化道反应, 头晕、心悸、骨髓抑制, 个别病例有运动失调。	
	6. 优福定 UFT	片剂 162 毫克, 每盒 50 毫克 片剂 FT-207 50 毫克	口服	2~4 片/次, 每日 3~4 次, 4~8 周为一疗程	消化道癌、乳腺癌	消化道反应, 骨髓抑制, 口腔炎, 皮疹。	

类别	药物品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
抗代谢类	7.5-氟脲嘧啶脱氧核苷 5-FLUOROURACIL 5-Fluorouracil oxyriboside, Floxuridine, 5-FUDR	粉针剂 500毫克	静滴	500毫克/日, 10天为一疗程。	1.肝癌 2.胃肠道癌 3.乳腺癌 4.头颈部癌	同5-FU	CCSA, 主要作用于G ₁ 、S、G ₂ 期, 并对G ₁ 期, 及对G ₁ /S边界及S期有延缓作用。
	8.阿糖胞苷(胞嘧啶阿拉伯糖苷) Cytosine arabinoside, Cytara, Ara-C, CA	针剂 50毫克、100毫克	静注	2~4毫克/公斤/日, 连用10天。维持量1毫克/公斤, 每周1~2次, 皮下注射。	1.各类急性白血病。 2.脑膜白血病。 3.与其它抗癌药合用治实体瘤。	骨髓抑制, 胃肠道反应, 局部刺激, 损伤肝功能偶见。	CCSA, 主要作用于S期, 并对G ₁ /S、S/G ₂ 边界有延缓作用。
				鞘内注射	25~75毫克/次, 1次/日, 连用1次。预防: 6周一次。		

类别	药物品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
抗代谢类	9. 环胞苷(环胞啶) Cycloctidinvn. Antitabine, Cyclo--C,CC	粉针剂 100 毫克、200 毫克、片剂 100 毫克	静注	200~600 毫克/次, 1 次/日, 用 10 天休息 7~14 天	1. 各类急性白血病。 2. 脑膜白血病。 3. 同 CA。	同 CA, 但较轻, 可引起腮腺肿胀, 体位性低血压。	CCSA, 同 CA。
			肌注 口服	同静注量			
			鞘内注射	50~100 毫克/日或隔日, 预防: 六周一次			
抗肿瘤类	10. 六甲密胺(六甲三聚氰胺) Hexamethylmelamine (HMM)	片剂 50 毫克、100 毫克	口服	一般 10~12 毫克/公斤/日, 分 4 次服, 21 天为一疗程, 或 8 毫克/公斤/日, 90 天为一疗程。	1. 主要用于肺小细胞癌、肺腺癌。 2. 慢性粒细胞白血病。 3. 乳癌、晚期宫颈癌、恶性淋巴瘤、头颈部癌、消化道癌。	1. 消化道症状。 2. 骨髓抑制。 3. 神经系统毒性, 偶见迟发的外周神经症状	

类别	药品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
抗肿瘤药	11. 氮杂胞苷 (5-氮杂胞嘧啶核苷) 5-Azacytidine AzGR	针剂 10 毫克	静注	1.0~2.2 毫克/公斤。	1. 乳癌、黑色素瘤、结肠癌 2. 小儿急性淋巴细胞性白血病。	胃肠道反应、骨髓抑制、偶见谷草转氨酶升高	CCSA
	12. 洛噻呤 (6 巯基嘌呤磷酸钠) Tisuprinum, AT-1438	粉剂 200 毫克、400 毫克	静注、动脉注射	绒癌、恶性葡萄胎: 8~10 毫克/公斤/日, 10 次为一疗程, 实体瘤同上。 白血病: 4~5 毫克/公斤/日, 10~14 次为一疗程。	绒癌、恶性葡萄胎、急性白血病、“慢粒”急性变、头颈部癌、肺癌、乳腺癌、脑膜白血病	1. 骨髓抑制。 2. 胃肠道反应。 3. 稀释后立即用, 不能久放。	CCSA, 主要作用于 S 期, 并对 G ₁ 期有延缓作用。
抗肿瘤药			肌注	400 毫克, 隔日一次, 六次为一疗程。			
			胸腔内注射	1.200 毫克/次, 1~2 次/周, 5 次为一疗程。			

类别	药品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
嘧啶拮抗类 抗代谢类	13. 6-巯基嘌呤, (6-巯基乐疾宁) 6-Mercaptopurine 6-MP, MP	片剂, 25毫克, 50毫克	口服	2~6毫克/公斤/日, 维持量 25~30毫克, 每日或三日一次。	1.“绒癌”、恶性葡萄胎。2.急性白血病。3.“慢粒”4.恶性淋巴瘤。5.浆细胞肉瘤。	1.骨髓反应及胃肠道反应。2.加别嘌呤醇 300 毫克/日, 可增效或减少用量, 并防止高尿酸血症。	同 AT-1438
	14. 6-巯代鸟嘌呤 6-Thioguaninum 6-TG	片剂 25毫克	口服	2~2.5毫克/公斤/日, 联合用药, 一般用 5~10天, 休息 7~14天, 单用可适当延长。	1.急性白血病。2.“慢粒”急性变。	1.同 6-MP 但较轻。2.与阿糖胞苷合用毒性减低, 疗效提高。	CCSA 6-MP 同
	15. 癌敌 Yandi, AZM	粉针剂 35毫克, 38毫克	肌注	38~76毫克/日或隔日, 1~2个月为一疗程。	宫颈癌、乳腺癌、胃癌、结肠癌、白血病、恶性淋巴瘤	同 6-MP	CCSA 6-MP 同

类别	药物品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
嘌呤拮抗类	16. 癌散 8-Azaguanine, Azan	针剂 35 毫克、40 毫克、80 毫克	肌注	40~160 毫克 / 日 总量 2000 毫克	同癌敌。	同 6-MP	CCSA, 同 6-MP
			静注	25~100 毫克 / 日 总量 2000~3500 毫克			
	17. 硫唑嘌呤 (依木兰) Azathiopurine Imuran, AZP	片剂 100 毫克	口服	2~2.5 毫克 / 公斤 / 日 或 100 毫克 / 日、肾移植: 2~3 毫克 / 公斤 / 日。	1. 自家免疫性疾病。 2. 肾移植。 3. 急性白血病	1. 同 6-MP 2. 具有强大的致畸胎作用, 孕妇禁用。	CCSA 同 6-MP
抗代谢类	18. 偶氮丝氨酸 Azoserine	片剂 50 毫克 针剂 25 毫克	口服	3~12 毫克 / 公斤 / 日, 总量 50~100 毫克 / 公斤	1. 急性白血病。 2. 何杰金氏病。	胃肠道反应, 骨髓抑制, 肝损伤。	CCSA
			静注	剂量同口服			

类别	药物品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
抗代谢类	19.腺苷二醛 (腺核苷二醛) Adenosindialdehydi, ADA	50 毫克, 胶囊	静注	50 毫克 / 日, 用 5 天停 5 天, 20 次为一疗程。	肝癌、胃癌、胰腺癌、肺癌、乳腺癌、恶性淋巴瘤	1. 一般无明显副作用。 2. 勿与碱性药物配伍。	
			肌注	剂量同静注			
			口服	50 毫克 / 日			
嘌呤拮抗类	20. 肌苷二醛核 (次黄嘌呤核) Idenosindialdehydi, IDA	200 毫克, 针剂	静注	200 毫克 / 日, 用 5 天停 2 天, 20 天为一疗程。	1. 肝癌 2. 其它实体瘤	无明显副作用	

类别	药品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
核苷酸类	21. 羟基脲 Hydroxyurea (Hydrea, Hydroxycarbamide, HU)		口服	60~80毫克/公斤, 每周2次, 以6周为一疗程, 或每3日用药80毫克/公斤, 用药4~6周为一疗程。 剂量调整法: 60毫克/公斤, 每8小时给药一次, 或100毫克/公斤, 每6小时给药一次, 24小时为一疗程, 剂量4~7次。 静注: 0.25~0.5克/次, 或次/日, 10次为一疗程。 口服: 0.5~1.0克/次, 11~0.25~0.4克/次, 3次/日。 灌肠: 0.5~1.0克/次, 溶于20~40毫升注射用水中, 每日一次。 瘤体: 0.5克溶于3~6毫升注射用水中, 每日注射或隔日一次。	1. 慢性粒细胞性白血病。 2. 恶性黑色素瘤。 3. 其它: 胃癌、肠癌、乳腺癌、膀胱癌、头颈部癌、原发性肝癌等。 4. 还有报道与放射治疗并用治疗坏死性咽癌。	1. 骨髓抑制 2. 消化系统症状。 3. 其它: 脱发、眩晕、皮疹、紫癜、水肿及致畸等。 4. 大剂量静注可致高铁血红蛋白血症, 孕妇禁用, 肾功能不良者慎用。	
	22. 羟基脲(硫酸羟脲) Hydroxyguanidine Sulfate (HG)		静注 口服 灌肠	0.25~0.5克/次, 或次/日, 10次为一疗程。 口服: 0.5~1.0克/次, 11~0.25~0.4克/次, 3次/日。 灌肠: 0.5~1.0克/次, 溶于20~40毫升注射用水中, 每日一次。	1. 粒细胞性白血病。 2. 恶性淋巴瘤 3. 癌性腹膜炎 4. 消化系统肿瘤: 贲门癌、胃癌、肝癌、直肠癌等。	毒性很低, 有恶心、呕吐、腹泻、头昏及白细胞减少等。本品应放置于密闭、干燥、避光处保存。	

类别	药物品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
蒽环类 抗生素类	1. 正定霉素(红比 霉素、柔红霉素) Rubidomycin, Daunomycin, Daunorubicinum NSC~82181, DRN, DNR, DRB	针剂 10 毫克、20 毫克	静注	0.8~1 毫克/次, 每日或隔日一次, 4~6 天为一疗程 或 30~60 毫克/ 平方米/日	1. 急性白血病。 2. 神经母细胞 瘤。 3. 横纹肌肉瘤。 4. 恶性淋巴瘤。 5. 尤文氏瘤。	1. 心脏毒性(心动 过速、心力衰竭)。 2. 骨髓抑制。 3. 胃肠反应。 4. 局部刺激。 5. 不宜和碱性药 物混合。	CCNSA 主要作 用于 G ₂ 期、S 期。
	2. 阿霉素 Adriamycinum, Doxorubicin, ADM, ADR	针剂 10 毫克	静注	儿童: 0.4 毫克/ 公斤/日, 成人 0.6 毫克/公斤/ 日, 用 3 天休息 4 天, 共用 2~ 3 周或 30 毫克/ 次, 每周一次, 6 周为一疗程或 40~60 毫克/平方 米每 3 周一次或分 三次给药, 每周一 次, 总剂量 450 毫 克。	急性白血病、恶 性淋巴瘤、肺 癌、甲状腺癌、 乳腺癌、消化道 癌、肝癌、胰腺 癌、“绒癌”、软 组织肉瘤、神经 母细胞瘤、肾肉 细胞瘤、骨肉 瘤、多发性骨髓 瘤、泌尿生殖系 肿瘤、宫颈癌、卵 巢癌	同红比霉素。	CCNSA 对 S 期(早)、M 期最敏 感, 对 G ₁ 期及 S 期(晚)最不敏 感, 对 G ₁ 、S、 G ₂ 期有延缓作 用。

类别	药品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
抗肿瘤药类	3. 表阿霉素 Epirubicin, Pharmorubic ar- morubicin, 4 -- epiAdriamycin E-ADM	针剂 10 毫克、50 毫克	静注	75~90 毫克/平方 米, 三周一 次。 40~50 毫克/平方 米, 连用二天、 三周给一次药, 总 剂量 800 毫克/平方 米以下。	恶性淋巴瘤、急性 淋巴细胞白血病、 肺癌、乳腺癌、绒 毛膜上皮癌、卵巢 癌、胃癌、肝癌、大 肠癌	消化道反应, 骨髓 抑制, 心脏毒性明 显低于阿霉素。	
			胸腔腔注射	100 毫克~140 毫 克/次, 每三周一 次。			
	4. 阿克拉霉素 B(安乐霉素) Aclacinomyc inBACM---B	针剂 6 毫克	静注	5~10 毫克/日, 7 ~10 天为一疗 程。总剂量不超过 300 毫克	肺癌、乳腺癌和消 化道癌	胃肠道反应, 白血 细胞减少。	

类别	药物品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
抗肿瘤药类	5. 自力霉素 (丝裂霉素C) Mitomycin- eMMC, MC	针剂 2 毫克, 片剂 1 毫克	静注	2 毫克/日, 总量: 40~60 毫克, 或 10 毫克/次, 5~7 天一次, 6 次为一疗程, 或 25~40 毫克/次, 3 周一	肺癌、乳腺癌、恶性淋巴瘤、消化道癌、胰腺癌、肝癌、“绒癌”、卵巢癌、宫颈癌、“慢粒”	1. 骨髓抑制出现晚, 多于疗程结束后下降。 2. 胃肠反应轻。 3. 勿与胱氨酸或半胱氨酸合用。	CCNSA 使 DNA 解聚, 阻碍 DNA 复制。
			腔内注射	6~8 毫克/次, 5~7 天一次, 4~6 次为一疗程。			
			口服	4~6 毫克/日, 总量 100~150 毫克。			
	6. 链脲霉素 (链氮霉素) Streptozotoin STZ	针剂 500 毫克	静注	500 毫克/平方米/日, 连用 5 天, 每 2~4 周为一疗程或 1000 毫克/平方米, 每周一次, 连用 4 周	胰岛β细胞癌、恶性淋巴瘤、白血病、恶性黑色素瘤、横纹肌肉瘤、纤维肉瘤	胃肠反应、肝功能损伤、蛋白尿、血糖升高。	CCNSA

类别	药品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
抗肿瘤药类	7. 博莱霉素 Bleomycin, BLED, BLM	针剂 15 毫克, 30 毫克	肌注	10 ~ 20U/平方 米, 1~2次/周	头颈、皮肤、肺、食管、宫颈、阴茎等部位的鳞癌、恶性淋巴瘤、恶性黑色素瘤、睾丸瘤、脑瘤、甲状腺瘤、纤维肉瘤	发烧, 肺纤维化, 胃肠反应, 皮肤色素沉着, 角质化, 偶有过敏反应。	CCSA 抑制胸腺嘧啶掺入DNA, 并与DNA结合使之破坏分解, 主要作用于M ₂ 期及S/G ₂ 期, 并对S/G ₂ 期有延缓作用。
			静脉注				
			动脉灌注	10~15U, 10平方米/日, 共3~7天			
			瘤内注射	2毫克/次			
	8. 平阳霉素 (争光霉素 As) Pingyanmycin	针剂 10 毫克 8 毫克	肌注	10 毫克/隔日一次, 总量 200~300 毫克。	同博莱霉素	同博莱霉素	同博莱霉素
			静注	剂量同肌注。			
			瘤内注射	2 毫克/次			

类别	药物品名	规格	用法	剂 量	适 应 症	主要毒副反应 及注意事项	作用于细胞 周 期
抗生素类	9.色霉素 ChromomycinA Toyomycin 东洋霉素	针 剂 0.5 毫 克	静 注 胸腹腔内注射	0.5 毫克 / 次, 或隔日一次, 总量 10~15 毫克 每 总 0.5~1 毫克 / 次, 1~2 周	肺 食 恶性淋巴瘤、 乳腺癌、胃癌、 食管癌	力 毒性反应与自较 毒素相似, 但较 小。	CCNSA
	10.匹来霉素、培 来霉素) Pe- pleomycinPEP PLM	针 剂 10 毫 克、5 毫 克	肌注或静注 胸腔注射、局部 注射、注射、局部 注射、注射、局部 注射	每次 10 毫克 (初次 5 毫克), 每周 2~ 5 次, 总量 150~200 毫克。 每次 20 毫克。	1. 皮肤癌 2. 头颈部癌 3. 肺癌 4. 恶性淋巴瘤 5. 其它: 前列腺 癌、黑色素瘤 等。	化 热、脱发及其他 道: 皮肤、指甲、 如: 全身、纤维、 变性、纤维、间 敏等。	
	糖 肽 类						

类别	药品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
抗生素类 色肽类	11.放线菌素D针剂 (更生霉素) Dactinomycin, ActinomycinD DACT	200 微克	静注	5-8 微克 / 公斤 / 日, 或 300-400 微克 / 日, 10-14 天 为一疗程, 疗程间隔 10-14 天, 总量 4-6 毫克.	"绒线", 恶性葡萄 胎、肾母细胞瘤、 神经母细胞瘤、 神经纤维肉瘤、 乳腺癌、宫颈癌、 恶性淋巴瘤、黑色 素瘤、消化道瘤、 横纹肌肉瘤	1.骨髓抑制, 但较 6MP、MTX 轻。 2.胃肠道反应。 3.局部刺激。 4.其它: 皮炎、脱 发肝功损伤。 5.口服维生素、C 预防消化道粘膜反 应。	小剂量为细胞 周期特异性药 物, 主要作用 于 S 期, 并对 G1/S 边界有 延缓作用, 较 大剂量为 CCNSA, 作 用于细胞周期 各期, 特别是 G ₁ 期。
	12.放线菌素 CActinomycin C, Sanamycin	200 针剂 微克	静注	100-200 微克 / 日, 总量 8-12 毫克.	1.癌性发热。 2.恶性淋巴瘤。 3.慢淋。	同放线菌素 D。	同放线菌素 D。

类别	药品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
抗肿瘤药类	13. 光神霉素 (光辉霉素) Mithramycin, Mithracin, Mitocin, MTH.PA-144 (684)	针剂 2 毫克	静注	2~6 毫克/H, 10 ~14 天为一疗程。	1. 脑肿瘤。 2. 睾丸胚胎性 癌。 3. 恶性淋巴瘤。 4. 其它: 胃癌、鼻咽癌、乳腺癌、卵巢癌、癌性高血钙症。	1. 胃肠反应。 2. 骨髓抑制轻。 3. 其它: 乏力、视力模糊、肢体麻木。	CCNSA
			腔内注射	2~4 毫克/次, 1 ~2 次/周			
				高血钙症 25 微克 /公斤/H, 连用 1 ~4 天。			
抗肿瘤药类	14. 橄榄霉素 Olivomycinum	针剂 5 毫克	静注	首次 5 毫克, 无反应改为 5~10 毫克/平方米, 隔日一次连用 2~3 周	睾丸肿瘤、卵巢肿瘤、肺癌、恶性淋巴瘤	1. 毒性比色霉素 A ₃ 低。 2. 不抑制骨髓	CCNSA 和放 线菌素相同
			外用	0.05%~0.3% 软膏, 治癌性溃疡			

类别	药物品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
抗微生物药类	15. 链黑霉素 (链褐霉素, 褐霉素) Streptonigrin, 72-2583, STN	片剂 50 微克、 100 微克、200 微克	口服	200 ~ 400 微克/日, 儿童: 5 ~ 7 毫克/公斤/日	白血病、恶性淋巴瘤、恶性黑色素瘤、胃癌、结肠癌、直肠癌、头颈部癌、乳腺癌、宫颈癌、“慢淋”、“慢粒”、真性红细胞增多症、原发性血小板增多症	毒性较更生霉素大 2 倍, 较自力霉素大 25 倍	CCNSA 主要作用于 S 期
	16. 素道霉素 Soedomycin	针剂 30 毫克	皮下或静注	1 ~ 2 毫克/公斤/日, 连用 20 天为一疗程, 总量 4000 毫克。	骨恶性肿瘤、胃癌、结肠癌	毒性小、不引起骨髓抑制。	CCNSA

类别	药品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
植物类	1. 长春花碱 Vin- calceukoblastine, Vinblastine, VLB	粉针剂 10毫克	静注	0.1~0.2毫克/ 公斤,每周一次或 二周一次,总量60 ~80毫克为一疗 程	恶性淋巴瘤、绒毛 膜癌、乳癌、肺癌、 卵巢癌、肾母细胞 瘤、急性白血病	1. 周围神经炎、 体位性低血压、精 神抑郁、脱发。 2. 骨髓抑制。 3. 胃肠反应。	CCSA, 主要 作用于 G ₁ 、 S、M 期,并对 M 期有延缓 作用。
	2. 长春新碱 Vincristine, Oncovin, Levis- tine, VCR	针剂 1 毫克	静注 (或冲入)	1~2毫克/次,每 周一,总量6~8 毫克	急性的白血病(急 淋更好)、恶性淋 巴瘤、神经母细胞 瘤、视网膜母细胞 瘤、胚胎瘤、乳腺 癌、肾母细胞瘤、 肺癌、平滑肌肉 瘤、宫颈癌、尤文 氏瘤	同上,勿与谷氨 酸、辅酶 A 合用。 本品系同步化剂。	CCSA, 小剂 量对 M 期有 延缓作用,剂 量增大可杀 伤 S 期细胞。

类别	药物品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
植物类	3. 长春花碱碱 Vindesine De- sacetylvinblast- ineAmideELDISE, VDS	针剂 10 毫克	静注	3 毫克/平方米/ 次,每周一次,4~ 6 次为一疗程或 1.3 毫克/平方米 /日,连用 5~7 天,3 周后重复。	白血病、恶性淋巴 瘤、乳腺癌、非小 细胞肺癌、恶性黑 色素瘤、食管癌、 头颈部癌、卵巢 癌、肾母细胞瘤、 肾癌	骨髓抑制,神经毒 性,末梢神经感觉 异常,肌肉无力, 深肌腱反射减弱, 音哑,便秘,胃肠 道反应,脱发,口 腔炎,静脉炎	
	4. 秋水仙碱 (争光 81) Clchicine, COLC	针剂 1 毫克	静注	1~2 毫克/日,总 量 40~80 毫克	乳腺癌、涎腺癌、 食道癌、胃癌、鼻 咽癌、肺癌、何杰 金氏病、白血病	1. 胃肠反应。 2. 骨髓抑制。 3. 四肢酸痛全身 不适。 4. 心电图改变。	CCSA, 主要 作用于 S 期, 对 M 期有延 缓作用。
			动脉注射	1~2 毫克/次,总 量 20~40 毫克			
			瘤内注射	每日一次,每次 1 毫克。			

类别	药物品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应 及注意事项	作用于细胞 周期
植物类	5. 秋水仙酰胺 (秋酰胺, 争光 81-ACOLM)	针剂 10 毫克, 片 剂 2.5 毫克	静注口服	10~20 毫克/日, 总量 200~400 毫 克, 5 毫克, 4 次/ 日 总量 400~800 毫克	乳腺癌、宫颈癌、 皮肤癌、鼻咽癌、 慢性粒细胞性白 血病急性变。	同争光霉素, 但较 小。	CCSA, 主要 作用于 M 期。
	6. 喜树碱 Camp- tothecinum, CPT	针剂 5 毫克、10 毫克, 片 剂 5 毫 克	静注	15~20 毫克/隔 日或 30 毫克/次, 每周 1~2 次, 总 量 200~300 毫克	慢性粒细胞性及急性 白血病、肝癌、胃 癌、结直肠癌、绒 癌、恶性葡萄胎、 肺腺癌、膀胱癌	1. 血尿、膀胱炎。 2. 骨髓抑制。 3. 胃肠反应。	CCSA, 主要 作用于 S 期, 但对 G ₁ 、G ₂ 、 M 期也有作 用, 并对 G ₂ / M 边界有延 缓作用。
			胸腹腔注	10~20 毫克/次, 每周一次			
			膀胱内注	20 毫克/日, 3 天 为一疗程			
			口服	5 毫克/次, 2 次/ 日, 总量 500 毫克			
			混悬剂	5 毫克			

类别	药物品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应 及注意事项	作用于细胞 周期
植物类	7. 羟基喜树碱 Hydroxy- camptothecin, OPT	针剂 2 毫克	静注	4~6 毫克, 每日 或隔日一次, 总量 60~120 毫克	试用于肝癌、胃 癌、头颈部癌	同喜树碱。	CCSA, 同喜 树碱。
	8. 三尖杉酯碱 Harringtonine, Homohar- ringtonine, HRT	针剂 1 毫克、2 毫克	静滴	1~4 毫克/日, 40 ~60 次为一疗程 或 4 毫克/次, 每 日一次, 用 4~6 次停药两周再重 复使用。	急性单核性白血 病、急性粒细胞性白血 病、恶性淋巴瘤	1. 胃肠反应。 2. 骨髓抑制。 3. 心脏毒性。	
	9. 高三尖杉酯 碱 HHRT	同上	同上	同上	同上	同上	

类别	药物品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
植物类	10. VP-16(表鬼臼毒甲噻糖甙、鬼臼乙叉甙) Etoposide EPEPTG	针剂 100 毫克, 胶囊 100 毫克	静注	60~100 毫克/平方米, 每日一次, 共 5 次。	试用于急性单核细胞性白血病, 急性粒性白血病, 网状细胞肉瘤、乳腺癌、膀胱癌、肾癌、甲状腺癌、肺小细胞癌	骨髓抑制, 恶心呕吐, 脱发	有丝分裂抑制剂。
	11. VM-26(表鬼臼毒噻吩糖甙, Teniposide, EPT	针剂 50 毫克	口服	120 毫克/平方米, 每日一次, 共 5 天。	试用于恶性淋巴瘤、膀胱癌、脑瘤	骨髓抑制, 恶心呕吐, 腹泻, 脱发	同 VP-16。
			静滴	30 毫克/平方米, 1/2~1 小时内滴完, 每日一次, 共 5 天; 70 毫克/平方米, 每周一次或 40~110 毫克/平方米, 每 2 周一次。			

类别	药物品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
植物类	12. 莪术注射液	莪术油 针(5%、 10%)及 复方莪 术针	静注	复方莪术注射液 每日一次,每次20 ~40毫克,5%莪 术油注射液瘤体 注射,每日一次, 每次5毫升。	子宫颈癌	1. 静脉炎。 2. 局部疼痛。 3. 偶有一过性呼 吸困难。	
	13. 冬凌草	每冬凌草 剂含草25 克;混注每 剂含草30 毫克;注射 液含草30 毫克;片剂 含草50毫 克;糖浆含 草1克	静滴	70~100毫克/ 日,每日一次,3, 000毫克左右为 一疗程。	食道癌、肝癌、胰 腺癌等	无明显副作用。	
			静注	30毫克/日,每日 一次,2,000毫克 为一疗程。			
			口服	糖浆:30毫升/ 次,每日3次,2~ 3个月为一疗程。 片剂:5~10片/ 次,每日3次,2~ 3个月为一疗程。			

类别	药物品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
植物类	14. 黄药子 (714--2)		肌注	2 毫升/次, 2 次/ H	食管癌、贲门癌、 乳腺癌	食欲不振, 胃部不适, 纳差。	
			静脉	10~20 毫升加入 5% 葡萄糖 500 毫 升			
	15. 猴菇菌 (片)	片 剂 0.25 克	口服	3~4 片/次, 3 次/ H	胃癌、食管癌及其 它消化道肿瘤	无明显副作用。	
	16. 鸦胆子油 乳剂		静滴	每次 10~20 毫 升, 加入 5% 葡萄 糖或生理盐水 500 毫升内滴入每日 或隔日一次, 一个 月为一疗程。	消化道癌、肺癌	消化道反应, 静脉 炎, 配制后立即使 用, 室温暗处保 存, 不得放入低温 冷冻处。	

类别	药物品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
植物类	17. 肿节风(草珊瑚、九节兰、九节风、九节茶、接骨莲、抗肿1号) Sarcandra glaber		口服	每次3~4片(最多8~10片),可连服数月。	胰腺癌、胃癌、直肠癌、肝癌、食管癌	轻微胃肠道反应和局部刺激症状。	
			肌注或静滴	每日1~2支,(每支2毫升,相当于生药20克)。			
	18. 野百合碱(农吉利碱、农吉利甲素、大叶猪屎膏碱,可洛他林) Monocrotaline (Crotaline)		肌注	每次15~30毫克,每日一次,600毫克为一疗程。	皮肤鳞状细胞癌、基底细胞癌、宫颈瘤、阴茎癌、白血病	全身给药:骨髓抑制,进行性肝功损害,胃肠道反应及泌尿系刺激症状。	
			外敷粉剂	每日15~80毫克,总量750~1,500毫克。			

类别	药物品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
杂类	1. 羟基脲(羟脲) Hydroxyurea, HU	片(胶囊)剂 400毫克、500毫克	口服	20~30毫克/公斤/日或60~80毫克/公斤,每周2次,6~7周为一疗程。	恶性黑色素瘤、乳腺癌、肺癌、头颈部癌、膀胱癌	1. 胃肠、骨髓反应。 2. 皮肤过敏、脱发、眩晕、定向力障碍。 3. 系同步化剂。	CCSA, 主要作用S期G ₁ 期, 并对G ₁ /S也有延缓作用, 使周期中其它细胞聚集在G ₁ /S边界, 导致部分同步化。
	2. 左旋门冬酰胺酶(天门冬酰胺酶) L-Asparaginase Crasnitin	每瓶含 1,000单位 2,000单位	静注	200~800国际单位/公斤/日, 14天为一疗程, 单独用每日或隔日一次。	急性淋巴细胞白血病、急性粒细胞性白血病、恶性淋巴瘤	1. 发烧。 2. 体重减轻。 3. 过敏反应, 用药前作皮试, 用药10~15单位/0.1毫升作皮内试验, 观察3小时有红肿斑块者为阳性要禁用。 4. 孕妇、肝、肾功能有损伤者禁用。	本品可使门冬酰胺水解, 导致门冬酰胺缺乏, 影响DNA合成细胞蛋白质及导致死亡。

类别	药品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
杂类	3. 硫酸胍 Hydrazine-sulfate	片剂 60 毫克	口服	60 毫克/次, 3 次/日	用于各晚期肿瘤病。	1. 胃肠反应。 2. 神经症状如: 感觉异常、头晕、头痛、视力障碍、皮肤干燥。	为能量抑制剂。
	4. 靛玉红 Indirubinm	片剂 60 毫克	口服	180 ~ 300 毫克/日	慢性粒细胞白血病、急性粒细胞白血病	无明显毒副反应。	变性坏死的细胞多呈肿胀溶解性坏死。
	5. 甲基苄胍 Procarbazine, PCZ	片剂 50 毫克	口服	每日剂量先以 50 ~ 100 毫克/平方米开始, 一周后渐增至 150 ~ 200 毫克/平方米, 分 3 次服用, 连用 2 ~ 3 周, 停 2 周可重复, 或减至 100 毫克/平方米维持量, 至出现毒性反应时停用。	何杰金氏病、淋巴瘤、网状细胞肉瘤、肝癌、转移性腺瘤、恶性间皮瘤、恶性黑色素瘤、多发性骨髓瘤。	1. 胃肠道反应。 2. 骨髓抑制较轻。	CCNSA, 主要作用 G ₁ /S 边界, 并对 S 期有延缓作用。

类别	药物品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
杂类	6. 斑蝥素 Cantharidinum, CTD	片剂 0.25 毫克	口服	初 0.5 毫克/日, 渐增至 2~4 毫克/日, 240 毫克为一疗程。	肝癌、胃癌、食道癌、乳腺癌、结肠癌	1. 泌尿道刺激症状。 2. 心跳过速。 3. 多饮水加野艾片服。	本品可抑制蛋白质和核酸合成。
		针剂 0.5 毫克	静注	0.25 ~ 0.5 毫克 ~ 2 毫克/日, 1 ~ 3 个月为一疗程。			
	7. 羟基斑蝥胺 N-Hydroxycantharidin, OTD	针剂 80 毫克 片剂 25 毫克	口服	50 ~ 100 毫克/次, 3 次/日	原发性肝癌、贲门癌、胃癌、肠癌	副作用轻微。	
			静注	80 ~ 140 毫克/次, 每日或隔日一次。			
			动脉灌注	剂量同静注。			

类别	药物品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
杂类	8. 丙亚胺(丙二胺亚胺) ICRF-159, A.T.-173	片剂 25 毫克, 50 毫克	口服	25 毫克/次, 3 次/ 日, 2~4 周为一 疗程, 或 150~300 毫克/日, 4~6 天 为一疗程。预防转 移 50 毫克/次, 2 次/周。	恶性网织细胞增 多症, 急性白血 病、肺癌、肝癌、胃 癌、乳腺癌	骨髓抑制, 胃肠道 反应	CCNSA, 本 品能改变瘤 组织附近的 血管使之正 常化, 并抑制 DNA、RNA 及蛋白质合 成。
	9. 丙腈胍(丙 酮双腈胍) Methylglyox- aisguanyldhydr- azone, MGAG	针剂 100 毫克	静注	2~4 毫克/公斤/ 日总量; 3~6 克。	急性粒细胞白血 病、恶性淋巴瘤、 食管癌、胃癌	1. 血小板抑制 小。 2. 胃肠反应。	CCNSA, 药 理作用机制 不明, 可能抑 制糖原产生, 使肿瘤获得干 扰有关。
	10. 抗癌锑(锑 胺羧螯合物, 三 乙酸锑)Sb-71	针剂 50 毫克	静注	50 毫克/日, 总 量, 500~1500 毫 克。	纤维肉瘤、滑膜肉 瘤、头颈部恶性肿 瘤、胃肠道癌、乳 腺癌	1. 心脏损伤。 2. 胃肠反应。 3. 骨髓抑制。	抑制核分裂。

类别	药品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
杂类	11. 左旋多巴 (左多巴, L-多巴) Lerodopa, LDOPA, DOPA	片剂 250 毫克	口服	250 ~ 750 毫克/日。癌性疼痛用: 250 ~ 500 毫克/次, 5 ~ 6 次/日, 服 2 日无效加倍量, 用氨茶碱 0.1/次, 2 ~ 3 次/日, 可以增效。	乳腺癌、晚期癌性疼痛	1. 胃肠反应, 心律不齐。 2. 不能与单胺氧化酶抑制剂、氯丙嗪、维生素 B ₆ 合用, 与丝羟苯胍合用可减少剂量。	CCNSA, 本品可透过血脑屏障进入脑组织。
	12. 维丙胍 Hydrezini- ascorbas	片剂 50 毫克, 针剂 20 毫克	口服 肌注	50 毫克/次 20 ~ 40 毫克/日	食道癌、胃癌、直肠癌、肺癌、乳腺癌	无明显副作用。	CCNSA 抑制肝、肾的糖原异生, 阻止向瘤组织供应葡萄糖而抑制肿瘤生长。
	13. 乙双吗啉 Bimolane, AT-1727	胶囊 200 毫克	口服	0.4 克, 每日 3 ~ 4 次, 10 ~ 14 天一疗程。	恶性淋巴瘤、肺癌、卵巢癌、外阴癌、乳腺癌	胃肠道反应, 白细胞下降	

类 别	药物品名	规 格	用 法	剂 量	适 应 症	主要毒副反应 及注意事项	作用于细胞 周期
激 素 类	1. 强的松(泼 尼松) Prednisone	片 剂 5 毫克	口 服	10~20 毫克/次, 3 次/日。维持量 10 毫克,每日或 隔日一次。	常用于联合化疗。 急性白血病、恶性 淋巴瘤、多发性骨 髓瘤、乳腺癌、前 列腺癌、癌性发热	长期服用可引起 溃疡病出血、血压 增高、糖尿病、骨 与电解质紊乱、骨 折、精神症状、痤 疮等。应间断用 ATCH,较氢化考 的松强,对电解质 紊乱影响不大。	免疫抑制。
	2. 氢化可的松 Hydrocortisone; Cortisol	针 剂 25 毫克、50 毫 克、 100 毫 克	静 注	100~300 毫克/ 日	1. 适用于联合化 疗。 2. 恶性淋巴瘤。 3. 淋巴性白血病 (急)。 4. 多发性骨髓 瘤、乳腺癌、前列 腺癌。 5. 癌性发热。	同强的松。	免疫抑制。
			肌 注	须用氢化可的松 琥珀酸钠 100~ 200 毫克/日			

类别	药品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
激素类	3. 强的松龙 (氢化泼的松) Prednisolone	片剂 5 毫克, 针剂 10 毫克	静注	10~25 毫克/次	同上	同上	
			口服	10~20 毫克/次, 3 次/日.			
	4. 地塞米松 (氟美松) Dexamethasone, DXM	片剂 0.75 毫克, 针剂 5 毫克	口服	0.75~4.5 毫克/日	同上	同上	较氢化可的松强 35 倍
			肌注	5 毫克/次, 1~2 次/日			
			静注	5~20 毫克/次/日			
	5. 倍他米松 Betamethasone, Bethelan	片剂 0.5 毫克	口服	0.5~3 毫克/日	同地塞米松	同地塞米松	

类别	药品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
激素类	6. 促皮质激素 (促肾上腺皮质激素) Adrenocorticotrophicum, ACTH	针剂 25 单位	静滴	12.5~25 单位/日	1. 常用于合并化疗。 2. 急性白血病。 3. 前列腺癌、乳腺癌。	1. 同强的松可引起过敏。 2. 不能与电解质及碱性药物合用。	
			肌注	25~50 单位/日, 分 2~4 次			
	7. 甲状腺片 Thyroidum	片剂 30 毫克, 40 毫克, 60 毫克	口服	30~60 毫克/次, 3 次/日	1. 甲状腺癌、乳腺癌。 2. 卵巢癌。 3. 预防术后复发。	1. 心率增快。 2. 心脏病慎用。	
	8. 丙酸睾酮 (丙酸睾酮丸) Testosterone, Propionas	油剂 25 毫克, 50 毫克	肌注	50~100 毫克/日或隔天一次, 可连用 2~3 个月。 子宫癌、卵巢癌、前列腺癌、多发性骨髓瘤 2 次/周, 25 毫克/次	1. 乳腺癌骨转移。 2. 乳腺癌(未绝经或绝经后 5 年以内者)。 3. 卵巢癌、子宫癌、多发性骨髓瘤、肾癌等。	1. 女性常服可致男性化。 2. 水钠潴留。 3. 前列腺肥大及孕妇忌用。 4. 肾功能不全者慎用。	

类别	药物品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
激素类	9. 甲基睾酮 Methyl-testosterone	片剂 5 毫克, 10 毫克, 25 毫克	口服	300 毫克/日, 可用 2~3 月。	同上	同上, 并可引起胆汁郁积, 谷丙转氨酶升高。	
	10. 黄体酮(孕酮) Progesteronum, Prolutin, Luton	油针剂 50 毫克, 100 毫克	肌注	100 毫克/次, 1~2 次/日	子宫体癌、乳腺癌、肾癌	副作用小, 可长期应用。	为人工合成孕激素, 抑制垂体促卵泡激素分泌。
	11. 甲地孕酮	片剂 4 毫克, 10 毫克	口服	4 毫克/日, 渐增至 30 毫克/日, 连服 6~8 周, 休息 6~8 周重复。	子宫体癌、乳腺癌、肾癌、肝癌	消化道反应, 肝肾功能不佳者慎用。	本品为高效黄体激素, 比黄体酮强 25 倍, 但无雌激素和蛋白同化作用。

类别	药物品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
激素类	12. 己烯雌酚 (乙菟酚) Diethylstilbestrol	片剂 0.5 毫克, 1 毫克, 针剂 1 毫克, 5 毫克	口服 肌注	5~15 毫克/日, 分 3~4 次。 1~5 毫克/次, 每 2~3 天一次, 用 2~3 个月或长期应用。	前列腺癌、乳腺癌	1. 男性长期用引起女性化。 2. 胃肠反应, 水肿滞留。 3. 停药应逐渐减量, 以防子宫出血。 4. 心、肝、肾功能不佳者慎用。	
	13. 溴乙酰己烷雌酚 HL-286	片剂 10 毫克	口服	30 毫克/日, 分 3 次服, 可长期服用。	1. 前列腺癌。 2. 肝癌、膀胱癌。 3. 各种白细胞减少症。	恶心、乳房肿胀、月经不调等副作用。	本品有较明显的升高白细胞作用。
	14. 三苯氧胺 Tamoxifen- Nolvadex Zilazonium TX	片剂 10 毫克	口服	10~20 毫克, 一日 2 次, 2~3 个月为一疗程, 也可连续使用。	乳腺癌、卵巢癌	消化道反应, 月经失调, 停经, 阴道出血, 颜面潮红, 脱发, 皮疹, 头痛, 眩晕, 浮肿, 骨痛等。	

类别	药物品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
激素类	15. 氨基导眠能(氨基苯嘧啶酮、氨格鲁米特) Aminoglutethimide	片剂 250 毫克	口服	250 毫克/次, 一日 2 次, 两周后改为每日 3~4 次, 但每日剂量不超过 1 克。	绝经后晚期乳腺癌、骨转移、前列腺癌	嗜睡、困倦、头晕、运动失调、皮疹、胃肠道反应。	
	Elipten Orimeten AG						
免疫制剂类	1. 卡介苗(结核活菌苗) BCG2~10℃暗处保存。液体菌苗有效期 4~6 月, 干燥菌苗有效期 1~2 年	针剂, 75 毫克/毫升	皮肤划痕法	每次 75~150 毫克, 每月 1~2 次, 一个月为一疗程。视瘤灶大小而定, 一般为 75 毫克/支的 0.05~0.15 毫升。每次 75~150 毫克, 每周一次。	恶性黑色素瘤、肺癌、急性白血病、恶性淋巴瘤等化疗后作为辅助治疗。	发热等全身反应	非特异性免疫
			瘤内注射法				
			口服法				

类别	药品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
免疫制剂类	2. 短棒杆菌苗 (短棒状杆菌苗) Corynebacterium parvum, CP	针剂 4 毫克	皮内注射	最好注于淋巴结引流区, 每点 0.5 毫克, 共 8 点, 点距 1~2 厘米, 每周 1~2 次。	恶性黑色素瘤、乳腺癌、肺小细胞型未分化癌、瘤性胸、腹水	发热、局部红肿、热、痛、气急、恶心头、呕吐等, 年老、肺心病、血小板减少性紫癜, 肝功能受损者不用, 用药期间, 禁用巴比妥类药物。	非特异性免疫
			皮下或肌注	上臂三角肌处每次 3.5~4 毫克, 每周 2 次。			
			静滴	4~10 毫克, 加于 250~500 毫升生理盐水中 1~4 小时滴完, 一般 2~4 周为一疗程, 有效可长期应用。			
			胸腔注	4~8 毫克/次, 1 次/周			
			腹腔注	2~4 毫克/次, 1 次/周			

类别	药品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
免疫制剂类	3. 转移因子 Transfer-factor TF	针剂每支2毫升(相当于 1×10^9 至 5×10^9 白细胞提取物)	皮下注射	上臂或大腿内侧, 2毫升/次, 1~2次/周, 一个月后改为每周1次, 一般1~2个月为一疗程。	恶性肿瘤的辅助治疗	局部红、肿、疼痛、个别发热、皮疹、痒疹等。	非特异性免疫, 以健康人取的白细细胞类物质, 可使细胞免疫活性转移给受试者的细胞免疫功能(没有抗原性)。
	4. 胸腺素 Thymosine	针剂4毫克	肌注	8毫克/次, 1~2次/周	恶性肿瘤的辅助治疗。	局部红肿硬结、瘙痒、发热、寒战、头晕、头痛、肌痛、过敏反应等, 用前最好做过敏试验。	非特异性免疫, 从新生小牛胸腺中提取。
			皮下注射	1毫克/日, 7~21天为一疗程, 休息10天再用。			

类别	药物品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
免疫制剂类	5. 免疫核糖核酸(免疫核酸) Immune RNA, iRNA	针剂 3 毫克	皮下注射	引流淋巴区皮下每周 3~5 次, 连用 1~3 个月, 休息 7~14 天, 可重复。	目前主要用于恶性肿瘤的辅助治疗(肾癌、肺癌、消化道癌、神经母细胞瘤、骨肉瘤等)。	无明显副作用。	非特异性免疫, 本品存在于淋巴细胞中, 可用人肿瘤组织免疫。羊和其它动物的脾脏淋巴结提取(还可从健康人的白细胞中提取)。
			静滴	1 支溶于 5% 葡萄糖液中。			
	6. 瘤苗注射液(瘤苗与佐剂按 1:1 制备)		皮内、皮下、肌肉注射均可	每次 0.2 毫升左右, 7~10 天一次, 三次为一疗程, 休息 14 天重复。	恶性肿瘤辅助治疗。	局部红、肿、热、痛, 少数有发热等。	

类别	药物品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
免疫制剂类	7. 干扰素 Interferon IFN	针剂 每 毫克蛋 白质含 干扰素4 $\times 10^6$ U	肌注或皮下注射	1~3 $\times 10^6$ U, 每日 一次, 或一一周三 次。	毛细胞白血病, 多 发性骨髓瘤、肾 癌、何杰金氏病、 非何杰金氏淋巴 瘤、白血病、乳腺 癌、黑色素瘤。	骨髓抑制, 发热, 脱发, 强直, 头痛, 皮疹。	
	8. 白细胞介素 IL-2 Interleukin 2,	每支 1 万单位, 2 万单 位, 5 万 单位, 10 万单位, 20 万单 位	瘤内注射, 肌注静滴	每次 1~20 万单 位	主要用于肾癌和 黑色素瘤等。	寒战、发热、恶心、 呕吐及水滞留等。	
	9. 猪苓多糖 (757 注射液)	针剂 40 毫克	肌注	40 毫克, 2 次/日, 连用 1~3 个月。	目前主要用于恶 性肿瘤的辅助治 疗。	无明显副作用。	对多种动物 实验性肿瘤 有抑制作用, 能提高细胞 免疫功能。

类别	药品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
免疫制剂类	10. 植物血凝素(植物血球凝集素) P-Hytoemagglutininum, PHA	针剂每只含冻干粉10毫克	静滴	20~24毫克/日, 加入5%葡萄糖液中	恶性肿瘤的辅助治疗, 可用于手术、化疗、放疗前后。	少数病人出现一过性过敏反应, 偶见过敏性休克。	本品为低聚糖与蛋白质的复合物, 属于高分子糖蛋白, 存于某些豆类种子中, 对红细胞有一定凝集作用故名。
			静注	20~40毫克/日			
			肌注	20~40毫克/日, 化疗、放疗、手术前、后, 连用5~10天为一疗程, 一般用2~3个疗程。			
	11. 辅酶Q ₁₀ Ubiquinone 10	片剂5毫克, 针剂10毫克	口服	每次10~15毫克, 每日3次, 2~4周为一疗程, 适当加量可望提高疗效。	恶性肿瘤的辅助治疗	可有恶心、食欲不振、胃部不适, 偶尔有荨麻疹及过性心悸。	
			肌注	每次10毫克, 每日一次, 2~4周为一疗程。			

类别	药物品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
免疫制剂类	12. 溶链菌 Picibanil, OK—432		皮内、皮下、肌肉、静脉、腔内注射	一般用量为每次0.5~1mg,每周一次,每次0.5~2mg	用于食管癌、胃癌、肺癌、白血病等。	主要有寒战、热及注射部位疼痛等。	
	13. 维生素C VitC	片剂100毫克,针剂100毫克、250毫克、500毫克	口服	6克/日,用3天停11天。	恶性肿瘤的辅助治疗。	无明显副作用。	
			静滴	6~10克/次,加入5%葡萄糖液中,每日一次,用3天停11天。			

类别	药物品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
免疫制剂类	14. 香菇多糖 (1270 注射液)	针剂 2 毫克	肌注	2~4 毫克/日, 边 用 10~20 天。	同猪苓多糖。	同猪苓多糖。	同猪苓多糖。
	15. 左旋咪唑 Levamisole, LMS	片剂 25 毫克	口服	150 毫克/日, 连 服 3 天, 休息 11 天, 重复治疗。	用于放疗、化疗间 隔期, 日前试用于 肺癌、乳腺癌术后 或急性淋巴瘤化 疗后作为辅助治 疗。	偶有头晕、恶心、 呕吐、腹痛、发热、 嗜睡、乏力、皮疹。	非特异性免 疫刺激剂
	16. 胎盘球蛋白 Globulinumplacentae	针剂	肌注	成人 6~9 毫升/ 次, 儿童: 0.2~ 0.8 毫升/次/公 斤	恶性肿瘤的辅助 治疗	无明显副作用。	本品有增强 免疫功能作 用, 为健康人 胎盘中提取。

类别	药品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
免疫制剂类	17. 丙种球蛋白 R-Globulinvm	针剂每支3毫升含0.3	肌注	5~6毫升/次,6天一次,6次为一疗程。	恶性肿瘤的辅助治疗。	无明显副作用。	本品有增强免疫功能作用,为健康人血中提取。
	18. 刺五加片		口服	3片/次,3次/日	恶性肿瘤的辅助治疗	无明显副作用	本品为免疫增强剂
	19. 淋巴因子激活的杀伤细胞(LAK)	10×10^{10} - 200 毫升	静滴	10×10^{10} - 200 毫升,每周一次。	用于黑色素瘤、肾上腺肿瘤和胃肠道肿瘤等,与IL-2同用可提高疗效。	寒战、发热、水瀰留等。	

类别	药品名	规格	用法	剂量	适应症	主要毒副反应及注意事项	作用于细胞周期
免疫制剂类	20. 聚肌胞(聚肌酐酸胞嘧啶核酐酸, 聚肌酐酸) Poly, I, C		肌注	1~2 毫克/次, 2 次/周, 2~3 个月为一疗程。	肿瘤辅助治疗	无明显副作用。	本品为一种高效干扰素诱导剂, 在体内可诱导干扰素产生。
	21. 云芝多糖 K, Krestin, PS-K	胶囊 每粒 0.5 克	口服	每次 0.5 ~ 1.0 克, 一天三次。	用于各种肿瘤的辅助治疗。	未见毒副作用。	
	22. 肿瘤坏死因子 Tumornecrosis-factor, TNF	针剂 每支 50 万 ^u	肌肉瘤内腔内注射	10~50 ^u /次, 每日 1 次, 十天为一疗程。	具有广谱抗肿瘤作用。	可有寒战、发热、恶心、呕吐、乏力等。	

三、实体瘤的疗效标准

1.可测量的病变

CR 可见的病变完全消失，超过一个月。

PR 肿块缩小 50% 以上，时间不少于 4 周。测量可采用双径测量或单径测量：

(1) 双径测量：a. 单个病变：肿瘤面积（指肿块两个最大垂径的乘积）缩小 $\geq 50\%$ 。b. 多个病变：多个病变最大垂径乘积之和减少 50% 以上。

(2) 单径测量：线状肿块测得数值减少 50% 以上。

NC 肿块缩小不及 50% 或增大未超过 25%。

PD 一个或多个病变增大 25% 以上或出现新病变。

2.不可测量的病变

CR 所有症状、体征完全消失至少 4 周。

PR 肿瘤大小估计减少 $\geq 50\%$ 至少 4 周。

NC 病情无明显变化至少四周，肿瘤大小估计增大不到 25%，减少不足 50%。

3.骨转移

CR X 线及扫描等检查，原有病变完全消失，至少 4 周。

PR 溶骨性病灶部分缩小，钙化或成骨病变密度减低，至少 4 周。

NC 病变无明显变化，由于骨病变往往变化缓慢，判定 NC 至少应在开始治疗的第 8 周后。

PD 原有病灶扩大及 / 或新病灶出现。

注：CR (Complete response) 完全缓解

PR (Partial response) 部分缓解

NC (no change) 无变化

PD (Progressive disease) 进展

判为 PR 时病人应无新病变出现，任何病变无进展。

骨折，压缩骨折及其愈合情况，不作为评价骨转移疗效的单一指标。

四、中草药治疗恶性肿瘤的疗效判断标准

(一) 治愈：症状、客观检查阳性体征完全消失，恢复一定劳动能力，连续观察三年以上无复发者。

(二) 临床治愈：症状及客观检查阳性征象消失，恢复一定劳动能力；

1 级：连续观察一年以上无复发者；

2 级：连续观察半年至一年无复发者；

3 级：连续观察 2~6 个月无复发者。

(三) 显效：症状基本消失，癌灶缩小一半以上，其它客观检查有明显好转。

1 级：观察半年以上不再发展者；

2 级：观察 2~6 个月不再发展者。

(四) 有效：症状有所改善，病灶基本稳定，观察在一个月以上者；

(五) 无效：症状及客观检查无改善，或仅有短期改善，而又迅速恶化者。

表 14 Zubroid-ECOG-WHO 的标准

分 级	行为状态
0	从事正常活动
I	无肿瘤症状，可以在家里生活
II	病人衰弱，有肿瘤症状，但每天卧床时间 < 50%
III	病人严重衰弱，每天有 50% 以上时间卧床，但能站立
IV	病人危重，卧床不起
V	死 亡

五、行为状态的评定标准

- (一) Zubroid-ECOG-WHO 的标准 (见表 14)
- (二) karnofsky 的标准 (见表 15)

表 15 karnofsky 的标准

分 数	行为状态
100	正常，无主诉，无疾病征象
90	能进行正常活动，轻微的疾病症状或体征
80	要经过努力才进行正常活动，有一些疾病的症状或体征
70	能照顾自己的生活，不能进行正常活动或做活跃的工作
60	偶而需要帮助，但能照顾自己生活中的大部分需要
50	在日常生活上需要相当的帮助，经常需要医药照顾
40	不能照顾自己，需要特殊照顾与帮助
30	失去生活能力，死亡尚未迫近，有住院的适应症
20	重病，必须住院治疗，接受有效的支持疗法
10	病危，迫近死亡
0	死 亡

此法自 1949 年用于临床评价癌症患者健康状况和疗效，经过长期实践，许多学者认为此法作为临床检测指标，具有简便易行，有效可靠的特点，并可作为一种质量检测指标，用于各种癌症及其他疾病患者的评估。

参考文献

- 1.《黄帝内经·素问》
- 2.《黄帝内经·灵枢》
- 3.《金匱要略》汉·张机
- 4.《太平圣惠方》宋·王怀隐等
- 5.《千金要方》唐·孙思邈
- 6.《诸病源候论》隋·巢元方

- 7.《儒门事亲》金·张从正
- 8.《妇人良方》宋·陈自明
- 9.《济生方》宋·严用和
- 10.《丹溪心法》元·朱震亨
- 11.《医学正传》明·虞抟
- 12.《女科撮要》明·朱棣等
- 14.《寿世保元》明·龚延贤
- 15.《证治准绳》明·王肯堂
- 16.《医学入门》明·李梴
- 17.《外科正宗》明·陈实功
- 18.《明医指掌》明·皇甫中
- 19.《医贯》明·周之干
- 20.《临床指南医案》清·叶桂
- 21.《杂病源流犀烛》清·沈金
- 22.《医宗金鉴》清·吴谦等
- 23.《外科图说》清·高文晋
- 24.《本草纲目》明·李时珍
- 25.《临床肿瘤学手册》(第五版)孙燕等译北京医科大学,中国协和医科大学联合出版社,1992年8月第一版
- 26.《肿瘤化学预防及药治疗》韩锐主编,北京医科大学中国协和医科大学联合出版社,1991年12月第一版
- 27.《实用肿瘤学》《实用肿瘤学》编辑委员会编,人民卫生出版社,1979年5月第一版
- 28.《中西医结合临床肿瘤内科学》邵梦杨王守章郭秀梅主编天津科技翻译出版公司,1994年2月第一版
- 29.《中医肿瘤学》郁仁存科学出版社1991年第一版
- 30.《中药药理毒理与临床》李广勋主编天津科技翻译出版公司1992年12月第一版
- 31.《治癌方》邵梦杨等河南科学技术出版社,1994年4月第一版

32. 《中药学》成都中医学院主编, 上海科技出版社, 1978 年 12 月第一版
 33. 《中药临床手册》上海中医学院方药教研组, 上海人民出版社, 1977 年 6 月第一版
 34. 《中西医结合常用肿瘤临床手册》张洪基邵梦扬王瑞林河南科学技术出版社, 1984 年第一版
 35. 《中西医结合肿瘤学》陈义文主编, 新华出版社, 1989 年第一版
 36. 《肿瘤方向治疗治疗学》谷铎之, 等, 人民卫生出版社, 1983 年 8 月第一版
 37. 《脾胃学》吴以令王其飞主编, 科学技术出版社, 1989 年 6 月第一版
 38. 《肿瘤方向治疗回顾》刘永生董鸿年, 科学技术出版社, 1989 年 12 月第一版
 39. 《肿瘤研究》郁仁存等主编上海科技出版社, 1991 年 12 月第一版
 40. 《肺癌》谢大业许立功主编, 上海科学技术文献出版社, 1989 年 7 月第一版
 41. 《癌症效方 240 首》柯新桥等编著, 北京医科大学中国协和医科大学联合出版社, 1993 年 4 月第一版
 42. 《中医成功治疗肿瘤一百例》谢文伟编著, 科学普及出版社, 1993 年 10 月第一版
 43. 《抗癌中药一千方》郎伟君孟立春编著, 1991 年 10 月第一版
 44. 《中草药有效成份的研究》中国科学院药物研究所, 人民卫生出版社, 1972
 45. 《中药方剂免疫药理研究》马振亚编, 陕西科学技术出版社, 1986 年 9 月第一版
- 期刊杂志从略

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

```
{
  "before_pdg2pic_conversion": {
    "filename": "MTA3ODk5OTguemlw",
    "filename_decoded": "10789998.zip",
    "filesize": 20209701,
    "md5": "787c17671cc197935fc75ec187ec203e",
    "header_md5": "8c0c18cf909b4ea2e15ee7b0bfa1e3a5",
    "sha1": "4f464a227925c205fa716f66c29261781d48dfe6",
    "sha256": "552a43725ff1e9be7596903d980ba4acb9262fcd3b5649dd73f9ef616e2816e1",
    "crc32": 886260560,
    "zip_password": "",
    "uncompressed_size": 20104923,
    "pdg_dir_name": "\u2553\u2568\u2565\u255c\u2553\u256b\u2534\u00f7\u2553\u256c\u2534\u255e\u2564\u00ba_10789998",
    "pdg_main_pages_found": 570,
    "pdg_main_pages_max": 570,
    "total_pages": 579,
    "total_pixels": 0
  },
  "after_pdg2pic_conversion": {
    "filename": "MTA3ODk5OTguemlw",
    "filename_decoded": "10789998.zip",
    "filesize": 36279955,
    "md5": "05bf3b02396cca057548f5ca11e68652",
    "header_md5": "ffcfd738f35126b6697a9e62d56f4650",
    "sha1": "e3fc0bb5ad12b8a70534e7e907e2e10cecd5fd1c",
    "sha256": "4d1edfdbe63166e8af9d7b288a809b5fa2335a95492ee1ce4efc5f960a436f95",
    "crc32": 4065312413,
    "zip_password": "",
    "uncompressed_size": 37168187,
    "pdg_dir_name": "",
    "pdg_main_pages_found": 570,
    "pdg_main_pages_max": 570,
    "total_pages": 579,
    "total_pixels": 2277222340
  },
  "pdf_generation_missing_pages": false
}
```